

تعارفِ خصوصی تعلیم

بی ایڈ

کورس کوڈ: 8631 یونٹس: 9-11

فیکلٹی آف ایجوکیشن

شعبہ خصوصی تعلیم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

اشاعتی تفصیلات

پہلی طباعت 2018

تعداد

قیمت

مطبع اے آئی اوپرنٹنگ پریس، ایچ-8، اسلام آباد۔

ناشر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

کورس ٹیم

عہدہ	نام
کورس ٹیم چیئرمین:	ڈاکٹر تنزیلہ نبیل
کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر:	ڈاکٹر شائستہ ماجد
مصنفین:	ڈاکٹر تنزیلہ نبیل ڈاکٹر شائستہ ماجد ڈاکٹر حنا نور جناب شریف اللہ محترمہ انیلہ انعم جناب محمد عمران نذیر

نظر ثانی کنندگان:	ڈاکٹر شاہدہ سجاد ڈاکٹر شگفتہ شہزادی ڈاکٹر تنزیلہ نبیل ڈاکٹر شائستہ ماجد ڈاکٹر زاہد مجید محترمہ صدف نوین
ارکان:	1- پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ شہزادی شعبہ خصوصی تعلیم، جامعہ کراچی۔ 2- پروفیسر ڈاکٹر ناصر سلمان شعبہ خصوصی تعلیم، جامعہ کراچی۔ 3- پروفیسر ڈاکٹر نصیر الدین (مرحوم) پروفیسر، شعبہ خصوصی تعلیم، جامعہ پنجاب، لاہور۔ 4- پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید ڈین، اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومنس سائنسز، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور۔ 5- ڈاکٹر زاہد مجید اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ خصوصی تعلیم، اے آئی او، اسلام آباد۔
کورس کو آرڈینیٹر:	ڈاکٹر شائستہ ماجد
ایڈیٹر:	جناب فضل کریم
کمپوزنگ و لے آؤٹ:	جناب ملک متین اسحاق

پیش لفظ

معاشرے میں ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز کی بڑی اہمیت ہے۔ ان پروگرامز کا مشن یہ ہے کہ جدید علم اور مہارتوں سے آراستہ کر کے اہل اور باصلاحیت اساتذہ تیار کیے جائیں تاکہ وہ مؤثر انداز میں پڑھا سکیں۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن ملک بھر میں اہل اور باصلاحیت اساتذہ تیار کر رہی ہے۔ فیکلٹی اور منتظمین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مشن کی مسلسل حمایت اور مضبوطی کے لیے مصروف ہیں۔ ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز کی تشکیل، بہتری اور کامیاب نفاذ بھی فیکلٹی آف ایجوکیشن کی توجہ کا مرکز ہیں۔

تدریسی تعلیم کے عمل میں استاد مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ کل وقتی استاد بننے سے پہلے استاد کو کسی نہ کسی قسم کی ٹیچر ایجوکیشن مکمل کرنا ضروری ہے۔ طلبہ کی کامیابی کا معیار براہ راست تدریس کے معیار سے جڑا ہے۔ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصاب کی توقعات کے حصول کے لیے طلبہ کی صلاحیتوں سے قطع نظر انہیں

سہولت پہنچانے کے لیے مناسب تدریسی حکمت عملیاں تیار کریں۔ اساتذہ طلبہ کی تعلیم کے جائزے اور تشخیص کے لیے بھی مناسب طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اساتذہ طلبہ کو حوصلہ دیتے ہیں اور کلاس روم میں تدریس اور جائزے کے متنوع طریقے اپناتے ہیں، ہر طالب علم کی انفرادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں اور ہر طالب علم کے لیے سیکھنے کے مضبوط موقع یقینی بناتے ہیں۔

مطالعے کے تمام شعبوں میں علم کے دھماکے کے ساتھ تدریسی حکمت عملیوں، تدریس فن اور جائزے کی تکنیکوں کے حوالے سے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا ایک عالمی گاؤں بنتی جا رہی ہے۔ عالمگیریت کا یہ عمل اور اس سے جڑے سماجی تغیرات تعلیمی نظاموں میں مستقل تبدیلیوں اور اصلاحات کے تعارف کا تقاضا کرتے ہیں۔ استاد کا نیا کردار بہت اہم ہے۔ اپنے نئے کردار میں اساتذہ کو طلبہ، والدین اور معاشرے سب کی حمایت کرنی چاہیے۔ اساتذہ کو اپنے طلبہ کے لیے رہنما کا کردار ادا کرنا چاہیے اور عالمگیریت کے عمل کے چیلنجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی انفرادی ترقی میں سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی زندگی اور سیکھنے کے بارے میں طلبہ کے خیالات کو شکل دینے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی وسیع تر سماجی اور معاشی پس منظر میں موجود ہیں اور بدلے میں معاشرے اور ماحول پر نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔ اساتذہ کو طلبہ کو نئے تصورات سیکھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے مواقع فراہم کرنے چاہئیں۔ انہیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ طلبہ روزمرہ کی تعلیمی سرگرمیوں میں فعال شرکت کے لیے درکار علم اور مہارتیں حاصل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ خصوصی ضروریات کے حامل طلبہ کی تدریس کے حوالے سے جدید علم اور مہارتوں سے آراستہ ہوں تاکہ وہ جدید اسکول پروگراموں کے چیلنجوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے چیلنجوں کا بھی کامیابی سے مقابلہ کر سکیں۔

پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم
وائس چانسلر

کورس کا تعارف

تعارف خصوصی تعلیم بی ایڈ سطح پر خصوصی تعلیم اور انکلو سو تعلیم کے شعبوں کا بنیادی کورس ہے۔ یہ خصوصی تعلیم کے ترقیاتی نقطہ نظر، خصوصی بچوں کی اقسام اور بنیادی ضروریات، اور خصوصی خدمات کی فراہمی سے بحث کرتا ہے۔ یہ ابتدائی کورس طلبہ کو خصوصی تعلیم اور انکلو سو تعلیم کے بی ایڈ ڈگری پروگرام کے اعلیٰ کورسز کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اس کورس کا تدریسی طریقہ کار فاصلاتی تدریس کے ساتھ خصوصی اسکولوں کے دورے بھی ہیں۔

تدریسی مقاصد

یہ کورس اس لیے مرتب کیا گیا ہے کہ:

- 1۔ خصوصی تعلیم کی اصطلاحات واضح کی جائیں
- 2۔ خصوصی تعلیم کے تاریخی اور قانونی پس منظر کے بارے میں طلبہ کو مکمل آگاہی دی جائے
- 3۔ طلبہ کو غیر معمولیات کی بڑی اقسام کو سمجھنے میں سہولت فراہم کی جائے
- 4۔ معذوری کے بارے میں رویے کا مطالعہ کیا جائے اور اسکولوں کی خصوصی ضروریات کو منظم اور سنبھالا جائے۔
- 5۔ انہیں خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی جلد شناخت، جائزے اور جلد مداخلت کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔
- 6۔ خصوصی تعلیم کے مختلف رجحانات اور مسائل پر بحث کی جائے

مشمولات

یونٹ-1: تعارفِ خصوصی تعلیم 1

- تعارف 2
- مقاصد 2
- 1.1 خصوصی تعلیم کا بنیادی تصور اور اصطلاحات 3
- 1.2 معذور شخص کی حیثیت میں ارتقا 7
- 1.3 خصوصی تعلیم کے لیے نفسیاتی پیتھالوجیکل اور معاشرتی نقطہ نظر 13
- 1.4 پاکستان میں خصوصی تعلیم کا نظام 15
- 1.5 پالیسی اور قانون سازی 16
- 1.5.1 بین الاقوامی قوانین 17
- 1.5.2 پاکستان میں قانون سازی 18
- 1.5.3 خصوصی تعلیم کی قومی پالیسیاں 20
- 1.6 خود احتسابی سوالات 25

1.7 حوالہ جات 26

یونٹ-2: غیر معمولیات کی اقسام-29 I

تعارف 30

مقاصد 30

2.1 غیر معمولیات کا درجہ بندی نظام 31

2.2 قسم 1: بصری معذوری 35

2.2.1 بصری معذوری کے اسباب اور مضمرات 35

2.2.2 بصری معذوری کا جائزہ 48

2.2.3 تعلیم و تربیت 51

2.3 قسم 2: سماعتی معذوری 65

2.3.1 سماعتی نقصان کے اسباب اور اقسام 67

2.3.2 تعلیمی مضمرات 68

2.3.3 تدریس و تعلم کے طریقے 71

2.4 مشقیں 74

2.5 سرگرمی 75

2.6 خود احتسابی سوالات 75

2.7 حوالہ جات 76

یونٹ-3: غیر معمولیات کی اقسام-77 II

تعارفات 78

مقاصد 78

3.1 قسم 3: جسمانی اور صحتی معذوری 79

3.1.1 اقسام 79

3.1.2 جائزہ 85

- 3.1.3 نصاب، تدریس اور جائزے میں موافقت 86
- 3.2 قسم 4: جذباتی اور رویائی عوارض 88
- 3.2.1 جذباتی اور رویائی عوارض کی اقسام 89
- 3.2.2 رویے کی خصوصیات 97
- 3.2.3 جذباتی اور رویائی عوارض کے حامل طلبہ کی تدریس کے لیے حکمتِ عملیاں 97
- 3.2.4 مثبت رویے کی حمایت کے لیے تعلیمی مضمرات اور مداخلتی تکنیکیں 98
- 3.2.5 چیلنجز اور مسائل 99
- 3.3 خود احتسابی سوالات 99
- 3.4 حوالہ جات 101

یونٹ-4: غیر معمولیات کی اقسام-103 III

- تعارف 104
- مقاصد 104
- 4.1 قسم 5: ابلاغی عوارض 106
- 4.1.1 عام انسانی ابلاغی عمل اور زبان کی نشوونما 106
- 4.1.1.1 زبان کے بنیادی عناصر 106
- 4.1.1.2 گفتار اور زبان کی نشوونما 109
- 4.1.2 گفتار، آواز اور زبان کے عوارض 110
- 4.1.2.1 گفتار کے عوارض 111
- 4.1.2.2 زبان کے عوارض 112
- 4.1.3 کلاس روم میں زبانی تنوع اور اصلاحی تدریس 114
- 4.1.3.1 اسکول جانے کی عمر کے دوران زبان کی نشوونما کے شعبے 115
- 4.1.3.2 کلاس روم اساتذہ کے لیے متبادل حکمتِ عملیاں 117
- 4.1.3.3 مداخلت کے اصول 118

- 4.2. قسم 6: مخصوص تعلیمی معذوریاں 119
- 4.2.1. تعلیمی معذوریوں کی اقسام 121
- 4.2.1.1. تعلیمی معذوریوں کی عام اقسام 122
- 4.2.2. اسباب، تشخیص اور جائزے کی تکنیکیں 122
- 4.2.3. تدریس میں موافقت 126
- 4.2.3.1. جائزے / تشخیص کے عمل کی موافقت 128
- 4.2.3.2. نصاب کے اندر اصلاحی ہدایات 129
- 4.3. خود احتسابی سوالات 131
- 4.4. حوالہ جات 133

یونٹ-5: غیر معمولیات کی اقسام-135 IV

- تعارف 136
- مقاصد 136
- 5.1. قسم 7: ذہنی اور نشوونمائی معذوریاں 137
- 5.1.1. درجہ بندی اور جائزہ 140
- 5.1.2. ذہنی اور نشوونمائی معذوریوں کے مضمرات 143
- 5.1.3. تدریسی طریقے 144
- 5.2. قسم 8: ذہین اور باصلاحیت 145
- 5.2.1. متعدد ذہانتوں کی تعریف 146
- 5.2.2. تنوع کی شناخت اور موافقت 147
- 5.2.3. گیگن کا ذہانت کا نمونہ 150
- 5.3. تعلیمی مہارتوں، عملی مہارتوں اور سماجی صلاحیتوں کے لیے تدریسی حکمت عملیاں 157
- 5.4. خود احتسابی سوالات 161
- 5.5. حوالہ جات 163

یونٹ-6: خصوصی بچوں کی جلد شناخت، جائزہ اور جلد مداخلت 165

- تعارف 166
- مقاصد 167
- 6.1 مداخلت کے بنیادی مفروضے اور اصول 168
- 6.2 جلد شناخت، جلد جائزے اور جلد مداخلت پر تحقیق کا جائزہ 172
- 6.3 جلد مداخلت کے نمونے 182
- 6.4 کثیر الشعبہ طریق کار کے تصورات اور اہمیت 190
- 6.5 خود احتسابی سوالات 194
- 6.6 ویب لنکس 194

یونٹ-7: معذوری کے بارے میں رویہ: فرد، خاندان اور برادری 195

- تعارف 196
- مقاصد 197
- 7.1 مثبت اور منفی رویے 198
- 7.2 معذوروں کے رویے اور سماجی نفسیات 202
- 7.3 لیبلنگ 205
- 7.4 گوفمن کا داغ (سٹگما) کا نظریہ 206
- 7.5 خاندان اور برادری میں معذور افراد 209
- 7.6 خود احتسابی سوالات 214
- 7.7 حوالہ جات 215

یونٹ-8: اسکول میں خصوصی ضروریات کی تنظیم و انتظام 217

- تعارف 218
- مقاصد 219
- 8.1 خصوصی تعلیمی ضروریات 220
- 8.2 خصوصی تعلیمی ضروریات کے لیے نصاب کی ترتیب 221
- 8.3 تعیناتی اور انتظام: 224
- 8.3.1 رہائشی اسکول / ڈے اسکول 225
- 8.3.2 سفری استاد / دورہ کرنے والا استاد 226
- 8.3.3 خصوصی تعلیم کے مشیر 228
- 8.3.4 وسیلہ کرہ (ریسورس روم) 230
- 8.4 خصوصی تعلیم کے استاد کی صلاحیتیں 232
- 8.5 کلاس روم کی تنظیم و انتظام 234
- 8.5.1 کلاس روم کی تنظیم 234
- 8.5.2 کلاس روم کا انتظام 238
- 8.6 منتقلی اور پیشہ ورانہ بحالی خدمات 241
- 8.7 خود احتسابی سوالات 243

یونٹ-9: خصوصی تعلیم میں موجودہ رجحانات اور مسائل 244

- تعارف 246
- مقاصد 246
- 9.1 شناخت، تشخیص، جائزے اور تعیناتی کے مسائل 247
- 9.2 علیحدگی، مقابلہ انضمام، مقابلہ شمولیت 249

- 9.3 • خصوصی تعلیم بمقابلہ باقاعدہ تعلیم 252
- 9.4 • خصوصی نصاب بمقابلہ باقاعدہ نصاب 254
- 9.5 • نصاب، ہدایات اور جائزے میں موافقت 255
- 9.6 • انفرادی تعلیمی پروگرام 258
- 9.7 • سرگرمی 260
- 9.8 • خود احتسابی سوالات 260
- 9.9 • حوالہ جات 261

اردو ترجمہ

یہ کتاب طاہر ڈوگر (Dogar Books) کی جانب سے اردو میں ترجمہ کر کے بالکل مفت فراہم کی گئی ہے۔

مزید مفت اردو کتب کے لیے ملاحظہ کریں:

dogarshaib267.github.io/dogar-books

رابطہ (واٹس ایپ): 03038962177

یونٹ 1: تعارف خصوصی تعلیم

تعارف

کسی ملک کی تعلیمی ترقی کی بہترین نشاندہی اس کی خصوصی تعلیم کے معیار سے ہوتی ہے، جو تعلیمی مواقع کی برابری کے احساس پر مبنی ہے۔ خصوصی تعلیم معذور یا پسماندہ اور ہونہار افراد کی تعلیم سے متعلق ہے۔ معذوروں کی تعلیم انصاف سے جڑی ہے جبکہ ہونہاروں کی تعلیم کسی فرد کی استعداد کی تکمیل سے متعلق ہے۔ حالیہ برسوں میں حکومت کا تعلیمی ایجنڈا پسماندہ طبقوں کی دیکھ بھال اور صلاحیتوں کی پرورش کرنا، اور قومی مسابقتی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کے طور پر خصوصی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔

خصوصی تعلیم کی تاریخ چار حصوں پر مشتمل بیانیہ پیش کرتی ہے جو 16 ویں صدی کے سپین میں اس کے ابھرنے کی دلچسپ بنیاد سے لے کر 17 ویں صدی کے فرانس اور انگلینڈ میں دورِ روشن خیالی، اور 18 ویں صدی میں یورپ اور شمالی امریکہ میں جگہ (placing)، نصاب اور ابتدائی مداخلت کے مسائل تک کا سراغ لگاتی ہے۔ اس میں 19 ویں صدی میں اساتذہ کی حیثیت اور سماجی رجحانات اور 20 ویں صدی کے پروگراموں میں انضمام (integration) کی طرف تحریک کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔

خصوصی تعلیم انسانی ہمدردی کی پیداوار ہے اور سماجی و معاشی مسائل کو کم کرنے کی ضرورت اسے زندہ رکھتی ہے۔ جمہوری نظریات خصوصی تعلیم کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہیں اور معذوروں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کا قانون اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس یونٹ کا مقصد قارئین کو یہ اہل بنانا ہے کہ وہ خصوصی تعلیم سے متعلق معلومات عوام تک پہنچائیں اور حکومت کی پالیسی کی وضاحت کریں، خصوصی تعلیم کی تاریخ، انتظام، موجودہ حیثیت، کلیدی اقدامات اور مستقبل کے امکانات کی تشریح کریں۔

سیکھنے کے نتائج

مزید خاص طور پر امید ہے کہ اس یونٹ کے مطالعے سے طلبہ درج ذیل کے قابل ہو جائیں گے:

1. خصوصی تعلیم میں جدید رجحانات اور پھر انہیں خصوصی تعلیم کے شعبے میں مستقبل کی ممکنات سے جوڑیں۔

2. خصوصی تعلیم کے ایک مضمون مطالعہ کے طور پر ابھرنے کی وجوہات کی نشاندہی کریں اور آنے والی نسل کے لیے اس کی اہمیت کا مظاہرہ کریں۔

3. خصوصی تعلیم کے شعبے میں ہونے والی نمایاں تبدیلیوں اور اس طریقے کی وضاحت کریں جس سے وہ نظام تعلیم پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔

1.1 خصوصی تعلیم کا بنیادی تصور اور اصطلاحات

یہ اس قسم کی تعلیم ہے جو خصوصی تعلیمی ضروریات والے بچے کو دی جاتی ہے۔ یہ خصوصی اس لیے ہے کیونکہ اس کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

- فطرت کے لحاظ سے معیاری اور مہنگی
- خصوصی تربیت یافتہ عملے کا استعمال کرتی ہے
- خصوصی تدریسی و تعلیمی مواد/آلات کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے
- خصوصی تدریسی طریقے استعمال کرتی ہے
- طالب علم کی انفرادیت پر زور دیتی ہے وغیرہ

جب آپ خصوصی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ معذور بچے مختلف اقسام کی جماعتوں میں، اپنی عمر کے زیادہ تر بچوں سے الگ، دن بھر الگ تھلگ بیٹھے ہیں۔ آج بھی خصوصی تعلیم معذور بچوں کو سیکھنے میں مدد دینے پر مرکوز ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو دن بھر خصوصی جماعت میں بٹھا دیا جائے۔ درحقیقت وفاقی قانون کا تقاضا ہے کہ خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے والے طلبہ کو جہاں تک ممکن ہو ان کے غیر معذور ہم عمر طلبہ کے ساتھ پڑھایا جائے۔ مثال کے طور پر ڈسکسیا (dyslexia) کے شکار کچھ طلبہ دن کا زیادہ تر حصہ عمومی تعلیمی جماعت میں گزار سکتے ہیں۔ وہ ریسورس روم میں محض ایک یا دو گھنٹے کسی ماہر کے ساتھ پڑھنے اور دیگر مہارتوں پر کام کرنے میں گزار سکتے ہیں۔ ایسے طلبہ کو اس سے زیادہ معاونت کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا انہیں کسی مختلف اسکول میں جانے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے جو سیکھنے کی معذوری والے بچوں کو پڑھانے میں مہارت رکھتا ہو۔

خصوصی تعلیم کے لیے کوئی "ایک سائز سب کے لیے" (one size fits all) والا نقطہ نظر نہیں ہے۔ یہ ہر طالب علم کی ضروریات کے مطابق ڈھالی جاتی ہے۔ خصوصی تعلیم خدمات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو مختلف طریقوں سے اور مختلف ماحول میں فراہم کی جاسکتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ خصوصی تعلیم کا اہل قرار پائے تو اسے بغیر کسی خرچ کے انفرادی تدریس اور دیگر کلیدی وسائل ملیں گے۔ جو ماہرین بچے کے ساتھ کام کریں گے وہ اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی مشکلات پر بھی توجہ دیں گے۔ والدین اس ٹیم کے اہم رکن ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتی ہے کہ اسکول میں ترقی کے لیے اسے کیا چاہیے۔

1.1.1 خصوصی تعلیم کی اصطلاحات

خصوصی تعلیم کی دنیا اس شعبے کے ماہرین کے لیے اتنی مشکل ہے کہ وہ اس کی اصطلاحات سے واقف رہ سکیں۔

خصوصی تعلیم (جسے خصوصی ضروریات کی تعلیم، امدادی تعلیم یا غیر معمولی تعلیم بھی کہا جاتا ہے) خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کو تعلیم دینے کا عمل ہے جو ان کے انفرادی اختلافات اور ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے۔ مثالی طور پر اس عمل میں تدریسی طریقوں کی انفرادی منصوبہ بندی اور منظم نگرانی، موافقت شدہ آلات و مواد، اور قابل رسائی ماحول کا انتظام شامل ہوتا ہے۔ یہ مداخلتیں خصوصی ضروریات والے افراد کو ذاتی خود کفالت اور اسکول اور اپنی کمیونٹی میں کامیابی کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے بنائی گئی ہیں، جو شاید دستیاب نہ ہوں اگر طلبہ کو صرف عام جماعت کی تعلیم تک رسائی دی جائے۔

عام خصوصی ضروریات میں سیکھنے کی معذوریاں، مواصلاتی عوارض، جذباتی اور رویے کے عوارض (جیسے ADD اور ADHD)، جسمانی معذوریاں (جیسے Brittle Bone Disease، Cerebral Palsy، Muscular Dystrophy، Spinal Bifida اور Frederick's Ataxia وغیرہ)، اور نشوونمائی معذوریاں شامل ہیں۔ اس قسم کی خصوصی ضروریات والے طلبہ ممکنہ طور پر اضافی تعلیمی خدمات سے فائدہ اٹھائیں گے جیسے تدریس کے مختلف نقطہ نظر، ٹیکنالوجی کا استعمال، خاص طور پر موافقت شدہ تدریسی علاقہ، یا ریسورس روم۔ ذہنی ہونہاری سیکھنے میں ایک فرق ہے اور خصوصی تدریسی تکنیکوں یا مختلف تعلیمی پروگراموں سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن "خصوصی تعلیم" کی اصطلاح عام طور پر خاص طور پر معذور طلبہ کی تعلیم کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خصوصی تعلیم خاص طور پر خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ اصلاحی تعلیم (remedial education) کسی بھی طالب علم کے لیے بنائی جا سکتی ہے، چاہے اسے خصوصی ضروریات ہوں یا نہ ہوں۔ زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں اساتذہ تدریسی طریقوں اور ماحول کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ عمومی تعلیمی ماحول میں خدمات حاصل کریں۔ اس لیے ترقی یافتہ ممالک میں خصوصی تعلیم اکثر کسی جگہ کی بجائے ایک خدمت سمجھی جاتی ہے۔ انضمام (integration) سماجی بدنامی کو کم کر سکتا ہے اور بہت سے طلبہ کی تعلیمی کامیابی کو بہتر بنا سکتا ہے۔

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) وفاقی قانون ہے جو خصوصی تعلیم کی تعریف اور ضابطہ کاری کرتا ہے۔ یہ قانون سرکاری اسکولوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ 3 سے 21 سال کی عمر کے ان بچوں کو خصوصی تعلیمی خدمات فراہم کریں جو کچھ معیارات پر پورا اترتے ہوں۔ (3 سال سے کم عمر

کے بچے IDEA کی ابتدائی مداخلتی خدمات کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔) خصوصی تعلیمی خدمات کا اہل ہونے کے لیے طالب علم کو لازماً:

- IDEA کے تحت آنے والی کوئی دستاویزی معذوری رکھتا ہو، اور
- عمومی تعلیمی نصاب تک رسائی کے لیے خصوصی تعلیم کی ضرورت ہو

"رسائی" (Access) تعلیم میں ایک اہم اصطلاح ہے۔ نصاب معذور طلبہ کے لیے قابل رسائی بنایا جائے گا۔ سیکھنے میں مشکلات، جیسے پڑھنے میں مشکل، کی صورت میں اسکول کو بچے کے لیے پڑھنے کے مواد تک رسائی ممکن بنانی ہوتی ہے۔ ایک مقررہ عمل ہے جو طے کرتا ہے کہ کون سے طلبہ خصوصی تعلیم کے اہل ہیں۔ اس عمل میں بچے کی جامع تشخیص (comprehensive evaluation) شامل ہوتی ہے۔ یہ اس کی نشوونما کے دیگر پہلوؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ والدین اپنے بچے کی تشخیص کی درخواست کر سکتے ہیں۔ بچے کی جانچ خصوصی تعلیم میں والدین کے لیے بغیر کسی خرچ کے کی جاتی ہے۔

وفاقی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ سیکھنے کی معذوری والے طلبہ کو ان کے غیر معذور ہم عمر طلبہ کے ساتھ "زیادہ سے زیادہ حد تک ممکن" تعلیم دی جانی چاہیے۔ اسکول بہت سی حکمت عملیاں استعمال کرتے ہیں تاکہ خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے والے طلبہ کو عمومی تعلیمی ماحول میں کامیاب ہونے میں مدد ملے۔ ان حکمت عملیوں میں شامل ہیں:

- معاون ٹیکنالوجی (assistive technology) جیسے لکھنے کی معذوری والے طالب علم کو جماعت میں نوٹس لینے میں مدد کے لیے لیپ ٹاپ فراہم کرنا
- سہولتیں (accommodations) جیسے طالب علم کو استاد کے قریب (اور خلل انداز چیزوں سے دور) بٹھانا یا اسے مضمون لکھنے کی بجائے زبانی رپورٹ دینے کی اجازت دینا
- ترامیم (modifications) جیسے طالب علم کو دیے جانے والے گھر کے کام کی مقدار کم کرنا
- پیرا پروفیشنلز جو اساتذہ کے معاون کے طور پر کام کرتے ہیں اور طلبہ کی مختلف کاموں میں مدد کرتے ہیں جیسے نوٹس لینا اور اہم معلومات کو نمایاں کرنا

جماعت یا جگہ کے دیگر اقسام کو صرف تب زیر غور لانا چاہیے جب آپ اور اسکول یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ عمومی تعلیمی جماعت میں کامیابی کا تجربہ نہیں کر سکے گا۔ بچے کی جگہ بدلنے سے پہلے کچھ اہم باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اسکول سہولتیں اور خدمات فراہم کرنے سے انکار کی وجہ کے طور پر بجٹ کے مسائل کو استعمال نہیں کر سکتے۔

کبھی کبھی معاونت اور خدمات کے باوجود کچھ طلبہ عمومی تعلیمی جماعت کی رفتار کے ساتھ نہیں چل پاتے۔ ذیل میں متبادل جگہوں کے کچھ دیگر ممکنہ آپشن ذکر کیے گئے ہیں:

• سیلف کنٹینڈ جماعت (Self-contained classroom): کچھ طلبہ اس جماعت میں زیادہ ترقی کر سکتے ہیں جو صرف خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ہو۔ سیلف کنٹینڈ جماعت کو خصوصی تعلیم کا استاد پڑھاتا ہے اور اس میں عام طور پر عمومی تعلیمی جماعت سے بہت کم طلبہ ہوتے ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ کا کم تناسب ہونے کی وجہ سے سیلف کنٹینڈ جماعت زیادہ انفرادی تدریس پیش کر سکتی ہے جو ہر طالب علم کے اہداف اور مقاصد کے مطابق ہو۔ سیلف کنٹینڈ جماعتوں کو کبھی کبھی خصوصی جماعتیں بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ طلبہ سارا دن سیلف کنٹینڈ جماعتوں میں گزار سکتے ہیں۔ دیگر طلبہ دن کا کچھ حصہ "مین اسٹریم" (mainstreamed) عمومی تعلیمی جماعتوں میں گزار سکتے ہیں جیسے آرٹ اور P.E. کے لیے۔

• انکلوژن جماعت (Inclusion classroom): تیسرا آپشن جو بہت سے اسکولوں میں مقبول ہے انکلوژن جماعت کہلاتا ہے۔ اس قسم کی جماعت میں ایسے طلبہ کا امتزاج ہوتا ہے جو خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ خصوصی تعلیم کا استاد اور عمومی تعلیم کا استاد جماعت کو پڑھانے کی برابر ذمہ داری بانٹتے ہیں۔ وہ مختلف سیکھنے کے انداز اور مہارت کی سطحوں والے طلبہ کی مدد کے لیے بہت سی سیکھنے کی معاونتوں کو آپس میں بن دیتے ہیں۔

• ضلع سے باہر جگہ (Out-of-district placement): کچھ طلبہ کو ان کے مقامی اسکول ضلع کی فراہم کردہ سے زیادہ خصوصی تدریس یا معاونت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر بچہ مناسب ترقی نہیں کر رہا تو ضلع آؤٹ آف ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ پر رضامند ہو سکتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جب ضلع بچے کی تعلیم کا خرچ کسی اور جگہ برداشت کرتا ہے، جیسے:

- کسی دوسرے ضلع کا سرکاری اسکول
- ایسا نجی ڈے اسکول جو مخصوص قسم کی معذوری والے بچوں کو پڑھانے میں مہارت رکھتا ہو
- ایسا بورڈنگ اسکول جہاں طلبہ پورا وقت رہتے ہوں

کبھی کبھی اسکول اضلاع آؤٹ آف ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی خاندانوں کو یہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی حکمت عملیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔

سہولتیں (accommodations) خصوصی تعلیم کا ایک کلیدی جزو ہیں۔ جس طرح وہیل چیئر ریسمپ زیادہ لوگوں کو عمارت تک رسائی دیتا ہے، اسی طرح جماعت کی سہولتیں زیادہ طلبہ کو عمومی نصاب تک رسائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو ڈسٹیکسیٹی ٹو ایسیج سافٹ ویئر جو کمپیوٹر اسکرین پر الفاظ کو

زور سے پڑھتا ہے اسے ایسے مواد تک رسائی میں مدد دے سکتا ہے جو اس سطح سے اعلیٰ ہو جسے وہ خود پڑھ سکتا ہے۔ ٹیسٹ دینے کے لیے بھی سہولتیں ہوتی ہیں۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ وہی مواد سیکھیں۔ لیکن وہ جو جانتے ہیں اسے مختلف طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو پڑھنے کی معذوری ہے تو استاد ٹیسٹ کے سوالات زور سے پوچھ سکتا ہے۔ کچھ طلبہ کو معیاری ٹیسٹوں پر بھی سہولتیں ملتی ہیں، جیسے جماعت کے ٹیسٹوں میں۔ ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت حاصل کرنا ایک عام سہولت ہے۔

جب لوگ سہولتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اکثر ترامیم (modifications) کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سہولتوں اور ترامیم میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سہولتیں اس بات کو کہتی ہیں کہ طالب علم کیسے سیکھتا ہے۔ ترامیم اس بات کو کہتی ہیں کہ طالب علم سے کتنا کرنے یا سیکھنے کی توقع ہے۔ مثال کے طور پر کچھ طلبہ کو چھوٹے لکھنے کے کام یا کم ریاضی کے مسائل دیے جاسکتے ہیں۔ دیگر طلبہ کو ان کے غیر معذور ہم عمر طلبہ کو دی گئی کتابوں کی نسبت کم پڑھنے کی سطح کی کتابیں دی جاسکتی ہیں۔ یہ عام ہے کہ طالب علم کو ترامیم اور سہولتیں دونوں ملیں۔ کچھ طلبہ کو ایک قسم کی معاونت مل سکتی ہے لیکن دوسری نہیں۔ اور کچھ طلبہ کو شاید کسی کی بھی ضرورت نہ ہو۔ یہاں عام سہولتوں اور ترامیم کی مثالیں دی گئی ہیں۔

وفاقی قانون اسکولوں کو کچھ ایسی خدمات فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو سختی سے تعلیمی نہیں ہیں لیکن ضروری ہیں تاکہ طلبہ خصوصی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہیں متعلقہ خدمات (related services) کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈسگریفیا یا ڈسپرکسیا والے بچے کو لکھائی کی مہارت بہتر بنانے کے لیے پیشہ ورانہ معالج (occupational therapist) کے ساتھ انفرادی سیشنز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ متعلقہ خدمات کی دیگر مثالوں میں شامل ہیں:

- بچوں اور والدین کے لیے ذہنی صحت کی مشاورت
- سماجی کام (social work) تاکہ بچوں اور خاندانوں کو معاونت فراہم کی جائے اور مثبت رویے کی مدد خلتوں کی تیاری میں مدد دی جائے
- مواصلاتی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے گفتگو و زبان کی تھراپی (speech-language therapy) جو سیکھنے پر اثر انداز ہوتی ہیں
- اسکول آنے جانے کی نقل و حمل اور کچھ صورتوں میں نصابی سرگرمیوں تک آنے جانے کی نقل و حمل

ایک اور اصطلاح جو آپ سن سکتے ہیں "ضمنی امداد و خدمات" (supplementary aids and services) ہے۔ ان میں موافقت شدہ آلات شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی خاص کیشن جو توجہ یا حسی پروسیسنگ کے مسائل والے بچوں کو زیادہ دیر تک بیٹھنے اور توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دے۔ ضمنی معاونت کی دیگر مثالوں میں معاون ٹیکنالوجی اور عملی، طلبہ اور والدین کے لیے تربیت شامل ہے۔

IEP کو اکثر خصوصی تعلیم کی بنیاد (cornerstone) قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانونی طور پر پابند دستاویز طالب علم کے سالانہ سیکھنے کے اہداف کے ساتھ ساتھ ان خصوصی خدمات اور معاونتوں کی تفصیل بیان کرتی ہے جو اسکول اسے ان اہداف کو پورا کرنے میں مدد کے لیے فراہم کرے گا۔ آپ کے بچے کو خصوصی تعلیمی خدمات ملنے سے پہلے آپ اور اسکول کو کئی مراحل مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ عمل عام طور پر اس طرح کام کرتا ہے:

1. تشخیص کے لیے ریفرل: جب آپ کا بچہ جدوجہد کر رہا ہو اور سیکھنے یا توجہ کے مسئلے کا شبہ ہو، آپ یا اسکول تشخیص کی درخواست کر سکتے ہیں۔ آپ کی درخواست قبول یا مسترد ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اسکول کو اپنے فیصلے کی وضاحت آپ کو کرنی ہوگی۔ اسکول آپ کی تحریری اجازت کے بغیر آپ کے بچے کی تشخیص نہیں کر سکتا۔
2. تشخیص: اگر اسکول آپ کے بچے کی تشخیص پر رضامند ہو جائے تو اسکول کا نفسیات دان اور دیگر ماہرین آپ کے بچے کو مختلف ٹیسٹ دیں گے۔ وہ جماعت میں اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تشخیص اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ کیا آپ کے بچے کو IDEA کے تحت آنے والی 13 معذوریوں میں سے کوئی ہے۔ تشخیص اس کی تعلیمی ضروریات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرے گی۔ ADHD جیسی طبی حالتوں کی تشخیص کوئی معالج یا دیگر طبی پیشہ ور کرتا ہے۔ تاہم وفاقی قانون لازمی طور پر کسی بچے کی ADHD کے طور پر نشاندہی کے لیے طبی تشخیص کا تقاضا نہیں کرتا۔ کچھ اسکول اضلاع کی ایسی پالیسیاں ہیں جو اسکول کے نفسیات دانوں کو خصوصی تعلیمی تشخیص کے حصے کے طور پر ADHD کی تشخیص کی اجازت دیتی ہیں۔ اسکول کے نفسیات دانوں کو ایسا کرنے کے لیے مناسب تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
3. اہلیت کا تعین: تشخیص کے بعد اسکول کی ایک خصوصی ٹیم آپ کے ساتھ ملتی ہے تاکہ اس بات پر تبادلہ خیال کیا جاسکے کہ کیا آپ کے بچے کو کوئی معذوری ہے اور کیا یہ اس کی سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ (اگر آپ کا بچہ IEP کی ضروریات پر پورا نہیں اترتا تو وہ 504 پلان کا اہل ہو سکتا ہے، جو بہت سی وہی سہولتیں اور خدمات فراہم کر سکتا ہے۔)
4. IEP کی تیاری: اگر آپ کا بچہ خصوصی تعلیم کا اہل ہے تو اس کی IEP ٹیم اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ بناتی ہے۔ آپ اس ٹیم کے برابر کے رکن ہیں اور بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو ٹیم کے کسی بھی دوسرے رکن سے بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ کی بصیرت یہ یقینی بنانے میں مدد دے سکتی ہے کہ آپ کے بچے کو اسکول میں کامیاب ہونے کے لیے درکار خدمات اور معاونت ملیں۔

سرکاری اسکولوں میں ایک عام کہاوت ہے: "خصوصی تعلیم کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک خدمت ہے۔" ان وسائل سے فائدہ اٹھائیں جو آپ کے بچے کے لیے دستیاب ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ان میں سے بہت سے وسائل آپ کے بچے کے لیے عمومی تعلیمی جماعت میں دستیاب ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ کیا اپنے بچے کی خصوصی تعلیم کے لیے تشخیص کروانی چاہیے، تو کچھ کلیدی سوالات پر غور کرنے سے آپ کو اپنا ذہن بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ اس کی کوشش کا فیصلہ کرتے ہیں تو Understood آپ کی تشخیص کی تیاری اور IEP کی تیاری میں مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ تشخیص نہ کروانے کا انتخاب کرتے ہیں، یا آپ کے بچے کو خصوصی تعلیمی خدمات سے انکار کر دیا جاتا ہے، تو اس سائٹ کے پاس دیگر تجاویز ہیں کہ آپ اپنے بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔

سرگرمی

1. جب آپ خصوصی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کیا تصور کرتے ہیں؟
2. متعلقہ خدمات (related services) آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟
3. I.E.P. ٹیم میں ماہرین کی ٹیم کے نام بتائیے؟
4. سہولت (accommodation) اور ترمیم (modification) میں فرق کریں۔
5. خصوصی تعلیم، عمومی تعلیم، مین اسٹریمنگ اور انکلو سیو تعلیم کی اصطلاحات کی تعریف کریں۔

1.2 معذور افراد کی حیثیت کا ارتقا

"The Evolution of Disability Policy" معذور افراد کی پالیسی اور عمل کی ابتدائی تاریخ اور ارتقا کا ایک مختصر جائزہ پیش کرتی ہے، جس میں خصوصی تعلیم، رسائی کے معیارات اور روزگار کی حکمت عملیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ابتدائی طب میں معذوریوں کی تعریف جسم کی سطح پر خرابیوں یا خلل کے طور پر محدود تھی؛ طبی مسائل جنہیں یا تو روکا جائے یا درست کیا جائے۔ اس لیے معذوری کے بارے میں ابتدائی سائنسی تحقیقات مخصوص طبی حالتوں کے معذور کن نتائج کے بارے میں الگ الگ تحقیق پر مشتمل تھیں۔ معذوری کی اس سائنسی علیحدگی نے معذوری کے لیے الگ الگ ادارہ جاتی جوابات میں حصہ ڈالا جس سے ہر قسم کی معذوری کے لیے الگ وکالت اور خود ادائی تنظیموں کی تشکیل ہوئی۔

اس طرح دو پائیدار رجحانات قائم ہوئے جنہوں نے تقریباً دو صدیوں سے معذور افراد کے حالات پر طاقتور اثر ڈالا ہے؛ ایک معذوری کو طبی نقطہ نظر سے دیکھنے کی طرف، اور دوسرا معذوری کی قسم کے مطابق معذور افراد کی ادارہ جاتی علیحدگی کی طرف۔

اٹھارویں صدی کی اس دریافت کہ معذور افراد سیکھ سکتے ہیں، نے بصارت اور سماعت سے محروم افراد کے لیے خصوصی اسکولوں اور نگہداشت کے اداروں کے ابھرنے کو جنم دیا۔ ایسے ادارے جسمانی معذوری والے افراد کے لیے بہت بعد میں ابھرے، اور ان میں سے زیادہ تر اسپتالوں سے وابستہ تھے۔ مختلف معذور کمیونٹیز کے لیے ادارہ جاتی جوابات میں اس فرق کے نتیجے میں ان کمیونٹیز کی صلاحیتوں میں فرق پیدا ہوا جو بصارت اور سماعت سے محروم افراد کے حق میں تھے۔ 1960 اور 70 کی دہائی کی معذوری کے حقوق کی تحریکوں کے ابھرنے تک، معذور افراد کی زیادہ تر تعلیم گرجا گھروں اور فلاحی تنظیموں کی مدد سے الگ سہولیات میں ہوئی۔ اس دور میں خصوصی تعلیم میں حکومت کی شمولیت معمولی رہی اور وزارت اور محکمہ سماجی بہبود کے ذریعے کی گئی، تعلیم کے ذریعے نہیں۔

معذور افراد کے لیے روزگار کی حکمت عملیاں 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں ابھریں۔ اس ابتدائی دور میں یورپ کے زیادہ تر حصے نے کوٹے اور کوٹہ لیوی نظاموں کو ترجیح دی جبکہ ریاستہائے متحدہ، کینیڈا، سویڈن، فن لینڈ اور ڈنمارک میں زور پیشہ ورانہ بحالی اور تربیتی حکمت عملیوں پر رہا۔ سوویت یونین نے محفوظ روزگار کی اسکیموں اور ریاست کی منظور شدہ معذوروں کے زیر انتظام اداروں کا ایک منفرد نظام استعمال کیا۔ اگرچہ تینوں نقطہ نظر کے عناصر مختلف شکلوں میں اب بھی موجود ہیں، پیشہ ورانہ بحالی کو سب سے وسیع قبولیت حاصل ہوئی ہے، اور اب بھی بہت سی قومی معذور پالیسیوں کا مرکزی حصہ ہے۔ اگرچہ یہ ان سے پہلے کی نگہداشت کی حکمت عملیوں کے مقابلے میں واضح طور پر بہتر ہے، روایتی پیشہ ورانہ بحالی کی حکمت عملیوں نے معذور افراد کو موجودہ بازاروں کے مطابق ڈھالنے پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور بازاروں کو خود زیادہ قابل رسائی اور سہولت بخش بنانے کی ضرورت پر بہت کم توجہ دی ہے۔ انہوں نے مہنگے، نتیجہ خیز نہ ہونے والے اور سماجی طور پر الگ تھلگ کرنے والے الگ ادارہ جاتی نظاموں پر وسائل ضائع کرنے کا بھی رجحان رکھا ہے۔ تعمیراتی اور ڈیزائن کی رکاوٹوں کو کم کرنے کی پالیسیاں نسبتاً نئی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں تعمیر شدہ ماحول عام طور پر ایسی خصوصیات کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں جو "عام" سے کم کارکردگی کی صلاحیتوں والے افراد کی سرگرمیوں کو غیر ضروری طور پر محدود کرتے ہیں۔ ان غیر ضروری تعمیراتی رکاوٹوں کی طرف سے معذور افراد پر عائد پابندیوں کے اعتراف میں، رسائی کے معیارات 1961 میں ریاستہائے متحدہ اور 1965 میں برطانیہ میں ظاہر ہوئے۔ قانونی تقاضے بعد میں 1960 کی دہائی میں سویڈن اور ڈنمارک میں ابھرے۔ پہلے تعمیلی میکانزم 1981 میں ریاستہائے متحدہ اور 1985 میں برطانیہ میں ظاہر ہوئے۔

1.2.1 معذور افراد کے انسانی حقوق کا ارتقا

1940 اور 1950 کی دہائیوں میں اقوام متحدہ سماجی بہبود کے مختلف نقطہ نظروں کے ذریعے جسمانی معذوری والے افراد کی فلاح و بہبود اور حقوق کو فروغ دینے میں سرگرم رہی۔ اقوام متحدہ نے مشاورتی مشنوں، تکنیکی عملے کی تربیت کے لیے ورکشاپس اور بحالی مراکز کے قیام کے ذریعے حکومتوں کو معذوری کی روک تھام اور

معذور افراد کی بحالی میں مدد فراہم کی۔ معذوری کے ماہرین کے درمیان معلومات اور تجربے کے تبادلے کے لیے سیمینار اور مطالعاتی گروپ ذرائع تھے۔ تربیت کاروں کے لیے فیلوشپس اور اسکالرشپس دی گئیں۔ معذور افراد کی کمیونٹی کے اندر سے آنے والی پہلوؤں کے نتیجے میں 1960 کی دہائی میں پالیسی کی بنیادی ازسرنو جانچ ہوئی اور معاشرے میں معذور افراد کی مکمل شمولیت کی بنیاد رکھی گئی۔

1970 کی دہائی میں اقوام متحدہ کی پہلوؤں نے معذور افراد کے انسانی حقوق اور ان کے لیے مواقع کی برابری کے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی تصور کو اپنایا۔ 1971 میں جنرل اسمبلی نے "Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons" (ذہنی پسماندہ افراد کے حقوق کا اعلامیہ) اپنایا۔ یہ اعلامیہ مقرر کرتا ہے کہ ذہنی پسماندہ افراد کو دیگر انسانوں کے برابر حقوق دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی طبی، تعلیمی اور سماجی شعبوں میں ان کی ضروریات کے مطابق مخصوص حقوق بھی۔ معذور افراد کو استحصال سے بچانے اور انہیں مناسب قانونی طریقہ کار فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ 1975 میں جنرل اسمبلی نے "Declaration on the Rights of Disabled Persons" (معذور افراد کے حقوق کا اعلامیہ) اپنایا، جو معذور افراد کے برابر شہری اور سیاسی حقوق کا اعلان کرتا ہے۔ یہ اعلامیہ مساوی سلوک اور ان خدمات تک رسائی کا معیار مقرر کرتا ہے جو معذور افراد کی صلاحیتوں کی نشوونما اور ان کے سماجی انضمام کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

1.2.2 معذور افراد کی حیثیت سے متعلق کمیشن 'برابری کی حکمت عملی' (1996)

معذور افراد کی حیثیت سے متعلق کمیشن نومبر 1993 میں وزیر برائے برابری اور قانون اصلاحات کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ کمیشن کی رپورٹ ایک برابری کی حکمت عملی پیش کرتی ہے جو اگر نافذ کی جائے تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گی جو معذور افراد کے راستے میں حائل ہیں جو مکمل اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جو معذور افراد کے والدین اور نگہداشت کاروں کو بھی بہت فائدہ پہنچائے گی۔ کمیشن کی حکمت عملی میں قانونی حل، نئی پالیسی پہلوؤں کے لیے تجاویز اور حقوق کے فریم ورک کے اندر برابری کی خدمات کی فراہمی کے لیے نئے ڈھانچے شامل ہیں، خیرات کے نہیں۔

کمیشن نے مختلف مسائل (تعلیم، فنون/ثقافت، کام/تربیت، خاندانی معاونت/ذاتی معاونت، رہائش، صحت، نقل و حمل، معذور افراد کے حقوق، جنسیت اور تعلقات، ٹیکنالوجی/مواصلات، اور مشاورتی عمل) پر تجاویز کا جائزہ لینے اور تیار کرنے کے لیے متعدد ورکنگ گروپ اور افراد مقرر کیے۔

معذور افراد کی حیثیت سے متعلق کمیشن کی رپورٹ معذور افراد، ان کے خاندانوں اور نگہداشت کاروں کے ساتھ طویل مشاورت اور شرکت کا نتیجہ ہے جن کے خیالات ملک بھر میں 'سننے کی نشستوں' (Listening Meetings) میں اور کمیشن کو کیے گئے تحریری جمع کروائے گئے مواد میں ظاہر ہوئے۔

کمیشن کی رپورٹ میں درج ذیل عنوانات کے تحت 402 سفارشات کا سلسلہ شامل ہے:

1. پالیسی اور ساختی تبدیلیاں

1. معذور افراد کی قانونی حیثیت

2. پالیسی کی تیاری اور نفاذ

3. ضروری خدمات کی فراہمی

4. اخراجات: برابری کے لیے بجٹ سازی

2. معاشی حقوق

1. آمدنی اور معذوری

2. کام اور تربیت

3. انشورنس

3. سماجی اور شہری حقوق

1. رسائی

2. صحت

3. تعلیم

4. رہائش

5. نقل و حمل اور نقل پذیری

6. ٹیکنالوجی اور مواصلات

7. قانون اور قانونی نظام

8. سیاسی حقوق

9. معذور خواتین کی شمولیت

10. جنسیت اور تعلقات

11. مذہبی عمل

12. فنون اور ثقافت

13. میڈیا

14. کھیل، تفریح اور سرگرمیاں

1.2.3 معذور افراد کی حیثیت سے متعلق کمیشن کی وراثت (1993)

Americans with Disabilities Act (ADA) جولائی 1990 میں امریکی قانون میں دستخط کیا گیا تھا۔ ADA بل پر کانگریس غور کر رہی تھی۔ اس وقت کی توانائی اور جوش میں ہے بغیر رہنا ناممکن تھا جو قانون سازی کے امکان کے بارے میں تھی، جس کا بنیادی مقصد 'انتیاز کے خاتمے کے لیے واضح اور جامع قومی مینڈیٹ' اور معذوری کے انتیاز کے حوالے سے 'واضح، مضبوط، مستقل، قابل نفاذ معیارات' فراہم کرنا تھا۔ اب چھ مڑ کر دیکھیں تو انتیازی قانون ایک اچھا لیکن کچھ حد تک محدود ہدف لگ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ انقلابی اور حوصلہ افزا تھا۔

National Rehabilitation Board (NRB) اس وقت اپنے کردار کا ایک بڑا جائزہ لے رہا تھا۔ اور ایک کلیدی مسئلہ جسے ہم حل کرنا چاہتے تھے وہ معذوری کے حقوق کا سوال تھا۔ جب NRB نے 1991 میں ایک اسٹریٹجک منصوبہ شروع کیا تو اس نے کہا کہ اس کا مشن 'ریاست کی طرف سے اور معذور افراد سے مشاورت میں، معذور افراد کو اپنی پسند کی زندگی اپنی مکمل استعداد کے مطابق گزارنے کے قابل اور باختیار بنانا ہے۔' منصوبے نے دعویٰ کیا کہ اس مشن کو پورا کرنے کا ایک طریقہ حقوق کی پہچان اور مواقع کی برابری کو فروغ دینا تھا، بشمول نئے قانون کی حوصلہ افزائی۔

اس آخری مقصد کی تکمیل کے لیے NRB نے خزاں 1992 میں UCG کی فیکلٹی آف لاء کے ڈاکٹر Gerard Quinn سے کہا کہ وہ آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ میں معذوری کے قانون کا جائزہ لیں تاکہ آئرلینڈ میں اس بحث کو آگاہ کرنے میں مدد مل سکے کہ موقع کی برابری اور معاشرے میں معذور افراد کی مکمل شمولیت کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے کون سا قانون درکار ہے۔ جب یہ کام جاری تھا تو حکومت نے اعلان کیا کہ برابری اور قانون اصلاحات کے لیے ایک کابینہ وزیر مقرر کیا جائے گا جس کی 'ذمہ داری ہوگی کہ ادارہ جاتی، انتظامی اور قانونی اصلاحات کے ذریعے برابری کو حقیقت بنایا جائے۔' اس عہدے پر مقرر کردہ شخص Mervyn Taylor TD تھے۔ نومبر 1993 میں معذور افراد کی حیثیت سے متعلق کمیشن وزیر Taylor کی طرف سے قائم کیا گیا۔ کمیشن کو دیا گیا ترجیحی کام 'حکومت کو عملی اقدامات پر مشورہ دینا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ معذور افراد معاشی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں، اپنی استعداد کی مکمل حد تک، حصہ لینے کے اپنے حقوق استعمال کر سکیں'، جو پہلے مذکور NRB کے مشن بیان کی بازگشت ہے۔

کمیشن نے اپنی رپورٹ نومبر 1996 میں حکومت کو پیش کی۔ تقریباً 600 تحریری جمع کروائے گئے مواد موصول ہوئے، جن میں سے 327 معذور افراد سے، 111 والدین اور معذور افراد کے قریبی دیگر افراد سے اور 162 تنظیموں سے آئے۔ کمیشن نے ملک بھر میں 30 اچھی طرح سے شرکت کی گئی 'سننے کی نشستیں' منعقد

کیس ساتھ ہی Dublin کے اندر اور ارد گرد بھی کئی۔ کمیشن نے بڑی تعداد میں ورکنگ گروپ (مجموعی طور پر 150 سے زائد ارکان) کے ساتھ مشیروں کا ایک پینل مقرر کیا۔ شرکت کی سطح، وسعت اور معیار کو دیکھتے ہوئے یہ حیران کن نہ تھا کہ حکومت کو کمیشن کی رپورٹ 'A Strategy for Equality' میں 402 سفارشات شامل تھیں۔ کمیشن اس وقت کی واحد اہم واقعہ نہیں تھا۔ کمیشن کی رپورٹ ریکارڈ کرتی ہے: 'برسوں کے مختلف رکنے اور شروع ہونے کے بعد، آئرش معذوری کی تحریک UN Decade of Disabled Persons (1981-1990) کے اختتام کی طرف دوبارہ شروع ہوئی۔ جیسے جیسے معذور افراد کی یورپی تحریک بڑھی، زیادہ آئرش معذور افراد اس سے واقف ہوئے اور اس کا حصہ بننا چاہے۔ اس سے معذور افراد کے زیر انتظام تنظیموں کے قیام اور ترقی کا باعث بنا۔ سیاسی طور پر سرگرم گروپوں جیسے Advocacy Forum of People with Disabilities، Centre for Independent Living اور Ireland Movement کا بنیادی پیغام میڈیا اور پالیسی سازوں دونوں کی طرف سے سنا گیا اور سنا جاتا رہتا ہے۔

سرگرمی

1. 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں معذور افراد کے لیے روزگار کی کون سی حکمت عملیاں ابھریں؟
2. 1960 کی دہائی میں سویڈن اور ڈنمارک میں بعد میں کس قسم کے تقاضے ابھرے؟
3. 1971 میں جنرل اسمبلی کے "Declaration on the Rights of Mentally Retarded" کی سفارشات کیا ہیں؟

1.2.4 جدید دور

عام طور پر تعلیم اور خاص طور پر خصوصی تعلیم تیز اور ڈرامائی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، اور متعدد موجودہ رجحانات مستقبل کی پالیسی اور عمل کے لیے مضمرات پیش کرتے ہیں۔ یہ واضح ہو رہا ہے کہ خصوصی تعلیم کے اصول تمام تعلیم کے مستقبل کو شکل دے رہے ہیں۔ جیسے جیسے اسکول زیادہ انکلوژیو ہوتے جاتے ہیں، توجہ طلبہ کے تنوع کو موافقت دینے، علم کی تخلیق میں سیکھنے والے کے کردار پر زور دینے، اور انفرادی تدریس و تشخیص کی معاونت پر مرکوز ہو رہی ہے۔ ابتدائی تعلیم بڑھ رہی ہے، جس کا بڑا مقصد سیکھنے کے مسائل کو روکنا ہے۔ جیسے جیسے عام اور خصوصی تعلیم ضم ہوتی ہے، انفرادی پروگرام اور تعاونی طریقے تمام طلبہ کے لیے دستیاب ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے اسکول کے ڈھانچے بدلتے ہیں، اسی طرح تعلیمی عملے کو تیار کرنے والے پری سروس اور ان سروس پروگرام بھی بدل جائیں گے۔ پیشہ ورانہ تعلیم میں ابھرتے رجحانات میں باقاعدہ اور خصوصی اساتذہ، سماجی کارکنوں، معالجوں اور دیگر عملے کی مشترکہ تیاری کے لیے مربوط بین الشعبہ ماڈل شامل ہیں؛ جدید تر سیلی نظام جیسے فیلڈ بیسڈ ماڈل، فاصلاتی تعلیم، اور متبادل سند؛ اور ریاستوں میں

تربیت اور لائسنسنگ میں مستقل مزاجی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہوتے قومی معیارات۔ ٹیکنالوجی کی ترقیات خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں، خاص طور پر معاون آلات، ملٹی میڈیا تدریس، اور فاصلاتی تعلیم کے شعبوں میں۔ عمل میں تبدیلیاں وسیع پیمانے پر تعلیمی پالیسی میں تبدیلیوں کا باعث بنیں گی۔ انکلوژن کی تحریک ایک متحد تعلیمی نظام کی طرف لے جائے گی جو ہر بچے کو شناخت شدہ ضروریات کی بنیاد پر خصوصی خدمات فراہم کرے گا۔ ابتدائی مداخلت اور ہائی اسکول کی منتقلی کی خدمات عام ہو جائیں گی۔

1.2.5 اکیسویں صدی کے لیے خصوصی تعلیم

20 ویں صدی کے آخر میں، سرکاری خصوصی تعلیم پر خصوصی ضروریات والے طلبہ کی اصلاح اور شمولیت کے مطالبات کی ایک سونامی نما لہر چھا گئی۔ ان موضوعات کو آج نافذ کرنے کے حوالے سے موجودہ مباحث کو اس مکمل جلد میں 19 ممتاز اسکالرز نے مستند انداز میں خطاب کیا ہے۔ تین مربوط حصوں میں منظم، یہ تعلیمی اصلاح کے مسائل اور انکلوژن تحریک میں معذوری اور انضمام کے ابھرتے مباحث سے شروع ہوتی ہے۔ متعلقہ ابواب شمولیت کے لیے مخصوص دلائل اور خصوصی تعلیم کے ارد گرد اور اس کی حمایت کرنے والے وفاقی قانون اور مقدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔

دوسرے حصے میں تشخیص کا پیچیدہ مسئلہ، خصوصی تعلیم میں ٹیکنالوجی کا انقلاب، اور اساتذہ کی تربیت کی صورت حال شامل ہے۔ تیسرا حصہ غیر معمولی ضروریات والے طلبہ کی مختلف آبادیوں کی شمولیت کا باریکی سے جائزہ لیتا ہے، خاص طور پر کہ اساتذہ نظریے سے تعلیمی عمل تک آسان منتقلی کیسے کر سکتے ہیں۔

Special Education in the 21st Century مختلف گروپوں کے لیے جماعت کے طریقوں اور وسائل، انتظام، سماجی گروپنگ، تدریسی ڈیزائن کے تکنیکی مسائل، اور اس مفروضے کو عقلمندی سے تول کر مستقبل کی سمتوں کا اخذ کرنے کا معیار مقرر کرتی ہے کہ اساتذہ خود بخود سیکھنے والوں کے اور بھی بڑے تنوع کو موافقت دینے کے لیے بدل جائیں گے۔ حالیہ برسوں میں آج کے طلبہ کو ان ذاتی اور پیشہ ورانہ چیلنجوں کے لیے بہترین طریقے سے تیار کرنے کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے جن کا انہیں 21 ویں صدی کی ہمیشہ بدلتی دنیا میں داخل ہوتے وقت سامنا کرنے کا امکان ہے۔ زیادہ تر کے لیے یہ مانا جاتا ہے کہ پڑھنے، لکھنے، ریاضی، سماجی علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے تعلیمی مضامین میں مضبوط بنیاد زندگی اور ہر قسم کے روزگار کے لیے ضروری ہوگی۔ مزید برآں طلبہ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ روایتی اور تکنیکی ذرائع سے نئی معلومات کیسے جمع کریں، تخلیقی مسائل حل کرنے والے ہوں اور دوسروں کے ساتھ اچھی طرح کام کریں۔ پچھلے چند برسوں میں وفاقی اور ریاستی تعلیمی معیارات اور جانچ کے تقاضوں پر اس نیت سے نظر ثانی کی گئی

ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ، مین اسٹریم اور خصوصی ضروریات والے دونوں، ایسی مضبوط تعلیمی بنیاد کے ساتھ اسکول چھوڑیں۔

پھر بھی خصوصی تعلیم میں، جہاں طلبہ کی صلاحیتوں اور ضروریات کا دائرہ وسیع ہے اور مستقبل کے اہداف اور منصوبے کبھی کبھی معذوریوں کی طرف سے طے کیے جاسکتے ہیں، "ایک سائز" والے تعلیمی معیارات ضروری نہیں کہ زیادہ تر کے لیے فٹ ہوں۔ اس حقیقت کی بنیاد پر، BOCES کے خصوصی تعلیم کے اساتذہ اور سپروائزر اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی، معیارات پر مبنی تعلیم کو بہترین طریقے سے کیسے فراہم کیا جائے جو ان کے طلبہ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھے گی۔ "جس طرح مین اسٹریم میں ہمارے ساتھی ان مہارتوں اور رویوں پر غور کر رہے ہیں جن کی ان کے طلبہ کو گریجویشن کے بعد کامیاب ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، ہم اس بات کا سوچ سمجھ کر جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم اپنے پروگراموں اور تدریس کو ان طریقوں سے بالکل کیسے ڈھال سکتے ہیں جو ہمارے طلبہ کو 21 ویں صدی کے لیے بہترین طریقے سے تیار کریں گے،" BOCES Special Education Division کی ڈائریکٹر Inge Jacobs کہتی ہیں۔

سرگرمی

1. جیسے جیسے اسکول زیادہ انکلوسیو ہوتے جاتے ہیں، طلبہ کی توجہ پر حتیٰ اثر کیا ہوگا؟
2. خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے ٹیکنالوجی کی ترقیات کی خاص اہمیت کیا ہے؟

1.3 خصوصی تعلیم کے مریضاتی اور سماجیاتی نظریات

خصوصی تعلیمی تشخیص کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ کیا طالب علم کو ایک یا زیادہ معذوریاں ہیں؛ طالب علم کی کارکردگی کی موجودہ سطح اور تعلیمی ضروریات؛ کیا طالب علم کو خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی ضرورت ہے؛ اور کیا طالب علم کو IEP میں قابل پیمائش سالانہ اہداف پورا کرنے اور، مناسب طور پر، عمومی تعلیمی نصاب میں حصہ لینے کے قابل بنانے کے لیے خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات میں کوئی اضافے یا ترامیم کی ضرورت ہے (Virginia Special Education Regulations, 8 VAC 20-81-70) - VDOE کی اشاعت، Guidance for Evaluation and Eligibility for the Special Education Process، ریفرل، تشخیص، اور اہلیت کے فیصلے پر مخصوص معلومات فراہم کرتی ہے۔

تشخیص کے لیے ریفرل پر، ایک ٹیم، جس کی ترکیب IEP ٹیم جیسی ہی ہو اور مناسب طور پر دیگر اہل افراد، موجودہ ڈیٹا کا جائزہ لیتی ہے اور طے کرتی ہے کہ آیا اہلیت کا تعین کرنے کے لیے اضافی ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ ٹیم جائزہ لیتی ہے: طالب علم کے والدین کی طرف سے فراہم کردہ تشخیصات اور معلومات؛ موجودہ جماعت

پر بنی اور ریاستی تشخیصات، اور مشاہدات؛ اور اساتذہ اور متعلقہ خدمات کے عملے کے مشاہدات (Virginia Special Education Regulations, 8 VAC 20-81-70 B)۔ اگر ٹیم فیصلہ کرتی ہے کہ مواصلاتی عارضے کے امکان کی وجہ سے طالب علم کی خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے لیے اہلیت کا تعین کرنے کے لیے اضافی ڈیٹا کی ضرورت ہے، تو مواصلاتی صلاحیتوں کی مکمل اور جامع تشخیص SLP کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ ٹیم کی درخواست پر اسکول ڈویژن کے دیگر پیشہ ور یا مقامی طبی کمیونٹی دیگر تشخیصات مکمل کر سکتے ہیں۔

طالب علم کی تشخیص یہ طے کرنے کے لیے کہ کیا اسے گفتگو و زبان کی خرابی ہے، کثیر الجہتی ہونی چاہیے اور اس میں متعدد ڈیٹا ذرائع (اساتذہ، والدین، طلبہ، دیگر خدمات فراہم کرنے والے)، ڈیٹا کی اقسام (مقداری اور معیاری)، پیمائشوں اور طریقہ کار کی مختلف اقسام (مستند تشخیصی حکمت عملیاں، معیار پر بنی پیمانے، معیار پر بنی (norm-referenced) ٹیسٹ، متحرک تشخیصی طریقے وغیرہ)، اور ہر بچے کے لیے مناسب کئی ماحول (جماعت، کھیل کا میدان، گھر) شامل ہونے چاہئیں۔ تشخیص کے نتیجے میں، اہلیت کی ٹیم کے پاس طالب علم کی مواصلاتی صلاحیتوں اور ضروریات کی مکمل تصویر ہوگی۔ نتیجہ خیز گفتگو و زبان کی تشخیصی رپورٹ کو چاہیے کہ:

1. طالب علم کی مواصلاتی مہارتوں کی جامع تشخیص فراہم کرے،
2. خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرے، اور
3. یہ طے کرنے کے لیے معلومات پیش کرے کہ کیا طالب علم کو گفتگو و زبان کی خرابی ہے جو تعلیمی کارکردگی کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔

گفتگو و زبان کے پیتھالوجسٹ زبان میں مہارت رکھتے ہیں اور انہیں یقینی بنانا چاہیے کہ تشخیص کے تمام اجزا زبان کے اختلافات اور بولی کے استعمال پر غور کریں۔ تشخیصی ڈیٹا جو بولی کے استعمال یا زبان کے فرق کا ثبوت فراہم کرتا ہے دستاویزی ہونا چاہیے اور اسے معذوری نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب زبان کے اختلافات یا بولیوں کو غلط طور پر غلطیاں سمجھا جاتا ہے تو طلبہ کو غلط طور پر معذور قرار دیا جا سکتا ہے۔ Virginia کے ضابطے واضح طور پر کہتے ہیں کہ "طالب علم کی تشخیص کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ اور دیگر تشخیصی مواد نسلی یا ثقافتی بنیاد پر امتیازی نہیں ہونے چاہئیں۔" (8VAC 20-81-70) زبان کے تنوع پر اضافی معلومات خصوصی موضوعات کے سیکشن میں فراہم کی گئی ہیں۔ گفتگو و زبان کی تشخیص کے دوران، تمام

طریقہ کار، ٹیسٹ اور مواد کو مخصوص شرائط پوری کرنی چاہئیں (Virginia Special Education Regulations, 8 VAC 20-81-70 C)۔ ان شرائط کی مثالوں میں شامل ہیں:

- تشخیصی پیمانے طالب علم کی مادری زبان یا مواصلات کے دیگر طریقے میں فراہم کیے جانے چاہئیں جب تک کہ ایسا کرنا واضح طور پر ممکن نہ ہو۔
- طالب علم کے بارے میں متعلقہ کارکردگی اور نشوونما کی معلومات جمع کرنے کے لیے مختلف تشخیصی آلات اور حکمت عملیاں استعمال کی جانی چاہئیں؛ اس میں طالب علم کو عمومی تعلیمی نصاب میں شامل ہونے اور ترقی کرنے کے قابل بنانے سے متعلق معلومات شامل ہونی چاہئیں، یا پری اسکولر کی صورت میں، نشوونما کے لیے مناسب سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے۔ تشخیصی مواد، بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں، کوئی بھی معیار پر مبنی ٹیسٹ جو دیے گئے تھے، کو یہ طے کرنے میں مدد دینی چاہیے کہ کیا طالب علم کو معذوری ہے اور، اگر اہل ہے، IEP کے مندرجات۔
- تشخیصی آلات کو اس مقصد کے لیے درست ثابت ہونا چاہیے جس کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں اور تربیت یافتہ عملے کی طرف سے ان کے تیار کنندہ کی طرف سے فراہم کردہ ہدایات کے مطابق دیے جانے چاہئیں اور مناسب حساسیت اور خصوصیت کا ثبوت فراہم کرنے کے قابل ہونے چاہئیں۔
- کوئی بھی پیمانہ (معیار پر مبنی، معیار پر مبنی حوالہ، یا منظم مشاہدہ)، اہل عملے کی طرف سے دیا گیا، اس بات کا تعین کرنے میں مدد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے کہ کیا طالب علم یہ طے کرنے کے معیار پر پورا اترتا ہے کہ طالب علم۔

1.3.1 حکمت عملیاں

بہت سی حکمت عملیوں میں سے، ہمارے پاس یہ ہیں:

- یقینی بنائیں کہ اسکول، نصاب، تشخیصی طریقہ کار اور تدریسی و تعلیمی مواد سب کے لیے قابل رسائی اور منصفانہ ہوں۔
- متعلقہ پیشہ ور افراد کی دستیابی اور تربیت کے ساتھ ساتھ طبی تشخیص؛ تعلیمی تشخیص، سماجی مہارتوں کی تربیت، نفسیاتی تشخیص، پیشہ ورانہ تھراپی، اور گفتگو/زبان کی تشخیص کے لیے سہولیات کو فروغ دیں۔
- نیز، معذور بچوں کی ابتدائی شناخت اور تحریک اور معذور بچوں کے خاندانوں کے لیے مربوط معاونتی خدمات کو یقینی بنائیں۔

- لچکدار امتحانی ڈھانچے کے نظام کو فروغ دیں جو شاگردوں / طلبہ کو مختلف شکلوں میں امتحان دینے کی اجازت دیتا ہے (مثلاً زبانی سننے / زبانی امتحانات، تصویری تبادلے کی مواصلات کا استعمال، تحریری وغیرہ) تاکہ متنوع تعلیمی ضروریات پوری ہوں۔
- یقینی بنائیں کہ موجودہ اسکولوں کے جسمانی انفراسٹرکچر ڈیزائن کو SEN والے افراد کے لیے مواقع بڑھانے کے لیے تبدیل کیا جائے۔
- یقینی بنائیں کہ موجودہ اسکولوں کے جسمانی انفراسٹرکچر ڈیزائن کو SEN والے افراد کے لیے مواقع بڑھانے کے لیے تبدیل کیا جائے۔
- یقینی بنائیں کہ تمام نئے اسکولوں کے جسمانی انفراسٹرکچر ڈیزائن اور تعمیرات (تمام نئے اسکولوں کے لیے) SEN والے افراد کے لیے مواقع بڑھائیں۔

سرگرمی

1. خصوصی تعلیمی تشخیص کا مقصد کیا ہے؟
2. نتیجہ خیز گفتگو و زبان کی تشخیصی رپورٹ میں کیا شامل ہونا چاہیے؟

1.4 پاکستان میں خصوصی تعلیم کا نظام

ہر شخص کے ساتھ ساتھ ہر قوم کے لیے تعلیم کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جاسکتا۔ معذور افراد کی صورت میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ تعلیم انہیں معاشرے میں ڈھلنے میں مدد دے سکتی ہے۔ خصوصی تعلیم میں معذور بچوں کی منفرد ضروریات اور صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کردہ ہدایات ہوتی ہیں۔ معذور بچوں کی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جو روایتی تعلیمی پروگراموں میں ان کی ترقی کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں۔ ہونہار بچے وہ ہیں جو ذہنی، تخلیقی، یا فنی شعبوں میں اعلیٰ صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ تعلیمی پروگراموں میں ناقص کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ خصوصی تعلیمی خدمات معذور اور ہونہار دونوں بچوں کو تعلیمی پروگراموں میں ترقی کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ تاہم پاکستان میں خصوصی تعلیمی پروگراموں میں صرف معذور بچے لیے جاتے ہیں۔

حکومت پاکستان نے پہلی بار Commission on National Education کی رپورٹ، 1959 میں پسماندہ شاگردوں کو تعلیم دینے کی اپنی ذمہ داری کو تسلیم کیا۔ لیکن ان بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کی تجویز تعلیمی پالیسی 1972-1980 تک نہیں بنائی گئی، اور پانچویں پانچ سالہ منصوبے (Pakistan Planning Commission، 1978) میں خصوصی تعلیم کے لیے معمولی رقم مختص کی گئی۔ 1980 کی دہائی میں حکومت کی بہت زیادہ شمولیت دیکھی گئی اور خصوصی تعلیم کے لیے بڑھی ہوئی بجٹ فراہمی، اگرچہ اب بھی ناکافی

تھی، کی گئی۔ چھٹے پانچ سالہ منصوبے (1983-1988) کے دوران، سماجی بہبود کا پروگرام سماجی بہبود اور خصوصی تعلیم کے موجودہ اداروں کو مضبوط بنانے پر مرکوز رہا۔ تنظیمی ناکامیوں پر قابو پانے کے لیے 1985 میں Federal Directorate General of Special Education صوبائی ہم منصبوں کے ساتھ قائم کیا گیا۔ آج صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں مختلف معذوریوں والے بچوں کے لیے خصوصی تعلیم کے اداروں کی کافی تعداد کام کر رہی ہے۔ حال ہی میں، وفاقی حکومت کے زیر انتظام خصوصی تعلیمی ادارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں 18 ویں ترمیم کے نفاذ کے نتیجے میں متعلقہ صوبائی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔

اگرچہ ملک میں معذوری کی ضرورت اور مسئلے کے مقابلے میں معذور بچوں کے لیے خدمات کی صورت میں کامیابی معمولی رہی ہے، پھر بھی مستقبل کے لیے کچھ امید ہے، اور تعلیم خصوصی بچوں کو اپنی تقدیر خود سنبھالنے کے قابل بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ موجودہ مقالہ تعلیمی پالیسیوں اور منصوبوں کے تناظر میں پاکستان میں خصوصی تعلیم کے جائزے پر مرکوز ہے۔ موجودہ مطالعے کا مقصد معذور افراد کے لیے خدمات کے تعارف اور توسیع میں حکومت پاکستان کی کوششوں کا جائزہ لینا تھا۔ اس کے لیے تعلیمی پالیسیوں اور پانچ سالہ ترقیاتی منصوبوں میں خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کا تجزیہ کیا گیا۔

1.4.1 پانچ سالہ منصوبوں میں خصوصی تعلیم

تاریخی طور پر، پاکستان میں تعلیمی پالیسی اور عمل انگریزوں کی وراثت (1757-1947) سے متاثر رہا ہے (Fontana and Lari, 2006)۔ معذور افراد کے لیے "Services for the Physically Handicapped" نام کا ایک مخصوص پروگرام قومی ترقی کے پہلے ہی منصوبے (1955-60) میں شامل کیا گیا تھا۔ تاہم یہ پروگرام انتظامی معاونت، فنڈز، تربیت یافتہ عملے وغیرہ کی کمی کی وجہ سے مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ یہ پروگرام اس کے بعد کے چار منصوبوں 1960 سے 1983 میں دہرایا گیا۔ پانچویں پانچ سالہ منصوبے میں، پہلے منصوبے میں فراہم کردہ 2 ملین کے مقابلے میں 26 ملین کی قابل ذکر رقم اس مقصد کے لیے مختص کی گئی۔ پانچویں منصوبے (1978-83) کی کامیابی وزارت صحت اور سماجی بہبود کے تحت اسلام آباد میں معذور بچوں کے لیے چار ماڈل خصوصی تعلیمی اداروں کا قیام تھی۔

1980 کی دہائی میں حکومت کی بہت زیادہ شمولیت دیکھی گئی اور خصوصی تعلیم کے لیے بڑھی ہوئی بجٹ فراہمی (اگرچہ اب بھی ناکافی) کی گئی (Lari, 2006)۔ چھٹے منصوبے (1983-1988) کے دوران، سماجی بہبود کے پروگرام نے خصوصی تعلیم اور سماجی بہبود کے موجودہ اداروں، سرکاری اور غیر سرکاری دونوں، کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ تنظیمی ناکامیوں پر قابو پانے کے لیے 1985 میں صوبائی ہم منصبوں کے ساتھ

Federal Directorate General of Special Education قائم کیا گیا اور 1986 میں معذوروں کی بحالی کی پہلی قومی پالیسی مرتب کی گئی (Lari, 2006)۔

معذوری کے لیے WHO کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے (آبادی کا 10 سے 15b)، اور خصوصی اسکولنگ اور بحالی کی خدمات کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، ساتویں پانچ سالہ منصوبے (Pakistan Planning Commission 1988) نے نوٹ کیا کہ موجودہ سہولیات کم اور ناکافی تھیں۔ سہولیات وزارت سماجی بہبود اور خصوصی تعلیم (حال ہی میں منتقل) کے تحت آئیں، جو معذور بچوں کو خصوصی اسکولنگ اور مربوط و جامع بحالی کی خدمات دونوں فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔

1.5 خصوصی تعلیم میں پالیسی اور قانون سازی

Education for All (EFA) کی تحریک جو 1990 میں Jomtien، تھائی لینڈ میں Education for All پر عالمی کانفرنس میں شروع ہوئی، نے تمام بچوں، نوجوانوں اور بڑوں کے تعلیم کے حقوق کا اعلان کیا۔ 1994 میں Salamanca میں خصوصی ضروریات کی تعلیم پر عالمی کانفرنس نے انکلوژن (Inclusion) کے اصول کو Jomtien میں پیش کردہ Education for All کے حصول کے اہم ذریعے کے طور پر اپنایا۔ Jomtien اعلامیے کے ایک دہائی بعد، اس کے وژن اور مشن کی 2000 میں Dakar میں عالمی تعلیمی فورم کی میٹنگ میں توثیق کی گئی۔ اس فورم نے پسماندہ گروپوں کو درپیش تعلیمی تجربے میں مسلسل رکاوٹوں کو اجاگر کیا اور ان پر قابو پانے کے لیے مثبت اقدام کا مطالبہ کیا۔ کلیدی بین الاقوامی معاہدات، پالیسیاں وغیرہ شامل ہیں:

1. United Nations (UN) Universal Declaration on Human Rights 1948،

2. UN Convention on the rights of the child 1989،

3. UNESCO Salamanca Statement and framework on Special Needs 1994،

Education،

4. World Forum on Special Needs Education in Dakar، Senegal 2000۔

1.5.1 بین الاقوامی قانون سازی

خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کے لیے تعلیم تک رسائی ایک عالمی مظہر ہے۔ خصوصی تعلیم کو چلانے والے بنیادی مفروضات، تعلیمی حکمت عملیاں، اور قانون سازی کی اجازت قوموں میں مختلف ہوتی ہیں، اور مقامی سیاق، سماجی اقدار، اور تعلیم اور معذوری کے بارے میں عقائد سے لازماً جڑی ہوتی ہیں۔

1.5.1.1 تعلیمی فلسفے

تین بڑے فلسفوں نے یہ چلایا ہے کہ کوئی قوم خصوصی ضروریات والے بچوں کی نشاندہی اور تعلیم کیسے کرتی ہے۔ تاریخی طور پر طبی ماڈل (medical model) سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور معذور بچوں کی تشخیص اور تعلیمی علاج دونوں میں استعمال ہوا ہے۔ بچوں کو منتخب شعبوں میں نفسیاتی اور جسمانی خرابیوں کی بنیاد پر طبی تشخیص ملتی ہے اور تعلیم و تربیت کے لیے خوبیوں اور کمزوریوں دونوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تدریسی مقاصد کے لیے اسی طرح کی تشخیص اور کارکردگی کی سطح والے بچوں کو اکٹھا گروپ کیا جاتا ہے۔ معیاری جانچ اکثر معذوری کے لیے تشخیصی نام فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ Thomas Oakland اور Sherman Hu کے مطابق، تشخیصوں کی درستگی مشکوک ہے کیونکہ معیاری ٹیسٹ اکثر مناسب طور پر معیاری نہیں ہوتے، اور قابل اعتماد اور صداقت کے تخمینے اکثر دستیاب نہیں ہوتے، جس سے بین الاقوامی موازنہ مشکل ہو جاتا ہے۔

ماحولیاتی ماڈل (environmental model) میں، معذوریوں فرد اور ماحول کے درمیان تعامل کے ایک فعل کے طور پر تجربہ کی جاتی ہیں۔ ماحول کی تعریف نفسیاتی اور سماجی ماحول کے ساتھ جسمانی ماحول کے لحاظ سے کی جا سکتی ہے۔ ماحولیاتی رکاوٹوں میں تعمیراتی رکاوٹیں، معاون ٹیکنالوجی کی کمی، اور/یا محدود نقل و حمل شامل ہیں۔ تدریسی تکنیکوں اور سیکھنے کے مواقع کو ماحولیاتی خامیوں کی تلافی کے لیے ڈھانچہ دیا جا سکتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ بچے موافق زندگی کی مہارتیں سیکھیں اور حاصل کریں۔ ماحول کے کردار کو معذور افراد کے لیے World Health Organization کی درجہ بندی تسلیم کیا گیا ہے۔

انکلوژن ماڈل (inclusion model) ماحولیاتی ماڈل کے پہلوؤں کو شامل کرتا ہے اور بچوں کو ان کے غیر معذور ہم عمر طلبہ کے ساتھ اور ان کے شانہ بشانہ تعلیم کا حق رکھنے والا سمجھتا ہے۔ اسکولوں کو اس طرح منظم کیا جاتا ہے کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ہر طالب علم، معذور یا غیر معذور، عمر کے مطابق، انفرادی توجہ، سہولتیں، اور معاونت حاصل کرے تاکہ عمومی تعلیمی نصاب تک رسائی فراہم ہو۔ معاون ٹیکنالوجی اکثر استاد اور طالب علم دونوں کے لیے انکلوژیو اسکولنگ کے عمل کو سہل بناتی ہے۔

1.5.1.2 درجہ بندی

طلبہ اور معذور بچوں کے لیے تدریسی معاونتوں اور پروگراموں کے درمیان معنی خیز بین الاقوامی موازنہ کرنے کی کوششیں انتہائی مشکل ہیں، کیونکہ تعریفیں اور اہلیت کے معیار مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) یس ترقی یافتہ ممالک میں پرائمری اور لوئر سیکنڈری تعلیمی آبادی کے 1 فیصد سے 35 فیصد کے درمیان کی حد رپورٹ کرتی ہے جو خصوصی ضروریات کے اضافی وسائل حاصل کر رہی ہے، بشمول خصوصی اساتذہ، معاون ٹیکنالوجی،

جماعت کی موافقت، اور خصوصی تدریسی مواد۔ اضافی وسائل عام طور پر خواتین کے مقابلے میں مردوں کے زیادہ تناسب کو فراہم کیے جاتے ہیں (بالترتیب اوسطاً 63 فیصد سے 37 فیصد)۔

OECD نے یہ بھی تحقیق کی کہ قوموں نے عمومی تعلیمی نصاب میں معاونت کی ضرورت والے طلبہ کی ضروریات کو کیسے پورا کیا اور معذوری، سیکھنے کی مشکلات، اور سماجی و معاشی پسماندگیوں والے طلبہ کے تناسب کا موازنہ کرنے کے لیے بنائے گئے اپنے اشارے کو بڑھایا۔ تین زمرے ابھرے۔ زمرہ A ان طلبہ کو کہتے ہیں جن کی تشخیص شدہ معذوریاں ہیں جن کے بارے میں خاطر خواہ بین الاقوامی اتفاق ہے (مثلاً نابینا/جزوی بینائی، بہرے/سننے میں مشکل، آئزم، علمی معذوریاں، یا متعدد معذوریاں)۔ زمرہ B ایک درمیانی درجہ بندی ہے اور ان طلبہ کو کہتے ہیں جنہیں سیکھنے میں مشکل ہے اور انہیں آسانی سے نہ زمرہ A میں اور نہ زمرہ C میں زمرہ بندی کیا جاسکتا ہے۔ زمرہ C ان طلبہ کو کہتے ہیں جنہیں سماجی و معاشی، ثقافتی، اور/یا لسانی عوامل کی وجہ سے سیکھنے میں مشکل ہے۔ خصوصی تعلیم کے فلسفوں اور نقطہ نظروں کے جائزے سے درج ذیل ظاہر ہوتا ہے:

• خصوصی تعلیم اکثر فنڈنگ اور خدمات کی فراہمی میں قومی اور مقامی حکومتی شمولیت پر مشتمل ہوتی ہے جس کی غیر سرکاری خدماتی تنظیموں کے کام سے تکمیل ہوتی ہے۔ ان پروگراموں کی حکومتی نگرانی میں بڑا فرق ہے۔

• طبی ماڈل ترقی پذیر ممالک اور بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں غالب فلسفہ ہے۔ ماحولیاتی اور انکلو سیو ماڈل ابھر رہے ہیں اور بنیادی طور پر مغربی ترقی یافتہ ممالک میں منصوبہ بندی اور نفاذ کے مختلف مراحل میں ہیں۔

• خصوصی تعلیم میں عالمی ترقی کی نگرانی کرنے والی کوئی مربوط بین الاقوامی ایجنسیاں نہیں ہیں، لیکن

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO) اور United Nations Children's Fund (UNICEF) نے معذور بچوں کو شامل کرنے کے لیے "Education for All" پہل کو وسیع کرنے کی کوشش میں اساتذہ کی تعلیمی مواد تیار کیا ہے۔

• تعلیم کے لیے بین الاقوامی فنڈنگ ذرائع (مثلاً World Bank، Inter-American Development Bank وغیرہ)، خصوصی ضروریات کی تعلیم کے لیے زیادہ انکلو سیو نقطہ نظر تجویز کر رہے ہیں۔

• تمام قومی اساتذہ کی بہتر تعلیم کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہیں، خاص طور پر باقاعدہ جماعتوں میں خصوصی ضروریات والے بچوں کو پڑھانے میں۔

• خصوصی تعلیم کی بڑی ضروریات والی قویں، عام طور پر ترقی پذیر ممالک، خاندان یا گاؤں پر مرکوز پروگرام تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جنہیں کمیونٹی بیسڈ خصوصی تعلیم کہا جاتا ہے۔ یہ پروگرام کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔

• اسکول-یونیورسٹی شراکت داری کی طرف تحریک اساتذہ کی تیاری کو اسکولنگ کے عمل میں زمینی کرنے میں امید افزا نظر آتی ہے۔

1.5.2 پاکستان میں قانون سازی

1981 کا Disabled Persons Employment and Rehabilitation Ordinance معذور افراد کے روزگار، بحالی اور فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا۔ آرڈیننس کی بنیادی خصوصیت تمام ایجنسیوں میں ملازمتوں میں ایک فیصد کوٹہ مقرر کرنا ہے۔ موجودہ آرڈیننس تعلیمی اور پیشہ ورانہ اداروں میں داخلے میں بھی معذور افراد کے لیے ایک فیصد کوٹہ مختص کرتا ہے۔ 1985 کا خواندگی کا آرڈیننس 1987 میں پارلیمنٹ نے منظور کیا جس میں زور دیا گیا کہ تمام پاکستانی شہریوں کو بنیادی خواندگی کی مہارتیں حاصل کرنی چاہئیں، بشمول وہ جو پسماندہ ہیں۔

ذمہ داری اور تنظیم

آرڈیننس معذور افراد کی بحالی کے لیے قومی کونسل (National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons) کے قیام کا انتظام کرتا ہے۔ کونسل کی صدارت وزارت سماجی بہبود اور خصوصی تعلیم کے سیکرٹری کرتے ہیں، اور یہ مسلح افواج کی تینوں شاخوں میں سے ہر ایک کے ایک نمائندے، وزارت افرادی قوت، محنت، صحت، تعلیم، مواصلات، پانی و بجلی، پٹرولیم اور قدرتی وسائل، صنعتوں، منصوبہ بندی، ایڈمنسٹریٹریٹر جنرل Central Zakat Organisation، ٹریڈ یونینز NCSW، اور معذور افراد کی فلاح سے متعلق NGOs کے چار افراد پر مشتمل ہے۔ قومی کونسل کو چاہیے کہ:

- معذور افراد کے روزگار، بحالی اور فلاح و بہبود کے لیے پالیسی مرتب کرے؛
- صوبائی کونسلوں کی طرف سے اپنی پالیسی کے نفاذ کا جائزہ، تشخیص اور ہم آہنگی کرے؛ اور
- آرڈیننس کے مقاصد کے حصول کی مجموعی ذمہ داری رکھے۔

ہر صوبائی حکومت ایک کونسل قائم کرے گی جسے Provincial Council for the Rehabilitation of Disabled Persons کہا جائے گا۔ کونسل کی ترکیب قومی کونسل جیسی ہے۔ ایک Directorate General of Special Education ہے۔ اس ڈائریکٹوریٹ نے پسماندہ افراد کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے۔

شناخت، تشخیص اور سمت نمائی

National Institute of Handicapped (NIH) قائم کیا گیا ہے تاکہ؛ - معذوریوں کی روک تھام کے لیے قومی کوششوں کو مربوط کرے اور ملک بھر میں ایک مربوط ریفرل نظام تیار کرے، - ابتدائی شناخت کا نظام منصوبہ بندی اور تیار کرے اور متعلقہ افراد کو رہنما اصولوں کی صورت میں معلومات پھیلائے، - معذور افراد کی روک تھام، دیکھ بھال، تربیت اور بحالی کے لیے تمام سطحوں پر کثیر پیشہ ورانہ تشخیص اور تشخیصی نظام کی منصوبہ بندی اور تیار کرے، - مختلف اداروں کی طرف سے معذوروں کے علاج کو مربوط کرے اور معاونت دے، - کثیر پیشہ ورانہ ماہرین کے ذریعے معذوریوں کا علاج فراہم کرے۔ یہ شدید معذوری کے کیسز کے لیے بڑے اسپتالوں اور Post Graduate Medical Centres کے ساتھ مؤثر ہم آہنگی کے ذریعے موجودہ سہولیات کو بھی استعمال کرے گا، - معذوری کے مختلف شعبوں میں تحقیق کرے، - اسپتال کی سہولیات فراہم کرے، ابتدائی طور پر 50 معذور افراد کے لیے، دوسرے مرحلے میں 10 معذور افراد تک بڑھائی جائے گی۔

قانون سازی کے تحت آنے والی عمر کی حد

عمر کی حد قانون سازی کے ذریعے احاطہ نہیں کی گئی۔ پرائمری سطح کے اسکولوں میں عمر کی حد 5-12 سال ہے۔

انضمام

معذوروں کی تعلیم اور بحالی کی قومی پالیسی (1985 اور 1988 میں نظر ثانی شدہ) میں باقاعدہ اسکولوں میں معذور بچوں کے انضمام کا خاص ذکر ہے۔ مقصد اسے تعلیمی نظام کی باقاعدہ خصوصیت بنانا ہے۔ مربوط ماحول میں خصوصی ضروریات والے طلبہ کی تعلیم کے انتظام میں تجربہ کار عملے کی کمی اس عمل میں بنیادی رکاوٹ ہے۔

خصوصی ضروریات کے لیے تعلیم کی مالی معاونت

Directorate General of Special Education وفاقی حکومت سے اپنا باقاعدہ بجٹ حاصل کرتا ہے۔ آرڈیننس ایک Disabled Persons Rehabilitation Fund قائم کرتا ہے جو وفاقی حکومت اور نجی اداروں سے گرانٹس جمع کرتا ہے۔

نصاب

استحقاق معذور بچوں کے لیے تعلیم کے مقاصد وہی ہیں جو دیگر بچوں کے لیے۔ تاہم معذور بچوں کے لیے سیکھنے میں ترجیحات اور ترقی کی رفتار مختلف ہے۔ نصابی رہنما اصول جو نصاب کی تیاری کی بنیاد بناتے ہیں NISE نے تیار کیے ہیں اور اساتذہ کے لیے دستیاب ہیں۔ وہ معذور طلبہ جو عام تعلیمی نصاب کی پیروی کے

قابل ہیں انہیں کچھ ایڈجسٹمنٹ اور ترمیم کے ساتھ وہی باقاعدہ نصابی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شدید سیکھنے کے مسائل والے شاگردوں کو خود مدد اور روزمرہ زندگی کی مہارتوں کی تربیت دی جاتی ہے۔

16 سال کے بعد - پیشہ ورانہ تعلیم

وفاقی اور صوبائی سطحوں پر معتدل اور شدید معذور افراد کے لیے منتخب مہارتوں میں خصوصی تربیتی پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں National Training Centre for Disabled (NTCD) قائم کیا گیا ہے۔

اساتذہ کی تربیت

اساتذہ اور دیگر پیشہ ور افراد کی تربیت National Institute of Special Education کا بنیادی کردار ہے۔ بڑے مقاصد ہیں؛ - وفاقی یا صوبائی مراکز یا غیر سرکاری تنظیموں میں پیشہ ور افراد کے روزگار کے لیے خصوصی تعلیم میں افرادی قوت کی تربیت کے لیے پروگرام تیار کرنا۔ - خصوصی تعلیم میں سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ اور ڈگریوں کی طرف لے جانے والے قلیل مدتی کے ساتھ ساتھ طویل مدتی کورسز منظم کرنا۔ - خصوصی تعلیم کے اساتذہ اور والدین، اور عام عوام کی رہنمائی کے لیے مواد تیار اور شائع کرنا۔ - مراکز کو ان کے شاگردوں کی ضروریات کے لیے نصابی جوابات تیار کرنے میں مدد دینا۔ وہ قلیل مدتی کورسز بھی منظم کرتے ہیں جو خصوصی شعبوں میں خصوصی علم اور مہارتیں فراہم کرتے ہیں۔ خصوصی تعلیم اور معذوری کے مختلف شعبوں میں پوسٹ گریجویٹ سطح کے ڈگری کورسز Allama Iqbal Open University، Karachi اور Punjab University کے مخصوص تعلیمی شعبہ جات کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔

1.5.3 خصوصی تعلیم کی قومی پالیسیاں

1.5.3.1 پاکستان کی خصوصی تعلیم پالیسیاں

پاکستان کی تخلیق کے فوراً بعد نئے ملک کی ضروریات کے مطابق تعلیمی نظام کو منظم کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اپنے پسماندہ شاگردوں کو تعلیم دینے کی حکومت کی ذمہ داری کو commission on national education (Pakistan Ministry of Education، 1959) میں تسلیم کیا گیا۔ لیکن ان بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کی تجویز 1972-1980 Education Policy تک نہیں بنائی گئی۔

1.5.3.2 قومی تعلیمی کمیشن کی رپورٹ (1959)

قومی تعلیم سے متعلق یہ کمیشن حکومت پاکستان کی طرف سے 30 دسمبر 1958 کو اپنائی گئی ایک قرارداد کے ذریعے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ "0 ممتاز ماہرین تعلیم" پر مشتمل تھا، تعلیم سے متعلق مختلف محکموں کے H ماہرین۔ صدر پاکستان نے کمیشن کا افتتاح کیا۔ کمیشن نے 15 جنوری 1959 کو افتتاحی خطبے کے ساتھ اپنا کام شروع کیا اور 26 اگست 1959 کو صدر کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ کمیشن نے پایا کہ حکومت کو ان اساتذہ کی تربیت کی ذمہ دار ہونا چاہیے جو نجی مخیر حضرات کے زیر انتظام پسماندہ افراد کے اداروں میں خدمات انجام دیں گے۔ کمیشن نے درج ذیل بڑے شعبوں پر توجہ دی؛

• خصوصی بچوں کی تعلیم اور بحالی کے لیے یہ محسوس کیا گیا کہ ڈاکٹر، نفسیات دان، فزیوتھراپسٹ وغیرہ جیسے پیشہ ور افراد کو استاد کے ساتھ ان بچوں کو کم از کم کچھ حد تک پیداواری سرگرمی اور معاشرے میں تسلی بخش ڈھالنے میں مدد دینے کی ذمہ داری باٹنی چاہیے۔

• یہ سفارش کی گئی کہ تقریباً تمام قسم کی معذوریوں کے لیے عمومی تعلیم کو پیشہ ورانہ تعلیم کے ساتھ ملایا جائے تاکہ فرد اپنی روزی کمانے کے لیے تیار ہو اور اپنی معذوری کی حدود میں خوشگوار زندگی گزارنے کی تربیت پائے۔

• کمیشن کی رپورٹ میں ان بچوں کی تعلیم اور دیگر دیکھ بھال کے لیے معاشرے کی ذمہ داری کو اجاگر کیا گیا۔ ہمارے محدود وسائل کی وجہ سے، کمیونٹی کو متحرک کرنے کی تجویز دی گئی تاکہ وہ پسماندہ افراد کی تعلیم کی اپنی ذمہ داری قبول کرے۔

• چونکہ دیگر ممالک کے تجربے سے ظاہر ہوا کہ پسماندہ بچوں کی اصل دیکھ بھال نجی مخیر تنظیموں کی زیادہ ذاتی طبی اور تعلیمی خدمات کے ذریعے مناسب اور مؤثر طریقے سے کی گئی، اس لیے ایسی تنظیموں سے فائدہ اٹھانے کی سفارش کی گئی۔ وسائل کی حدود پر قابو پانے اور نجی تنظیموں کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجویز دی گئی کہ حکومت اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے درمیان شراکت داری ہونی چاہیے، تاکہ مختلف قسم کے پسماندہ افراد کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر ایجنسیاں قائم کی جائیں۔

• حکومت نے اپنے خرچ اور ذمہ داری پر پسماندہ افراد کے اداروں میں خدمات انجام دینے والے اساتذہ کی انتہائی خصوصی تربیت فراہم کرنے کی تجویز دی۔ ابتدائی طور پر، ہمارے ملک میں نابینا افراد کے اساتذہ کی تربیت کے لیے کم از کم ایک مرکز اور بہرے اور گونگے افراد کے اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک اور مرکز ہونا چاہیے۔ ایسے پروگرام کو سنبھالنے کے لیے، ہمارے عملے کو تربیت اور مہارت کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی تجویز دی گئی۔ (Education Policy (1972-80 میں، پسماندہ بچوں کے لیے خصوصی

تعلیم کے انتظامات نئے ادارے کھول کر اور موجودہ کو مضبوط کر کے کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، تاکہ پسماندہ بچوں کو ملک کے پیداواری اور خود کفیل شہری بننے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تعلیمی ادارے، عام طور پر پبلک اسکولوں کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جن میں Aitchison college، Lahore جیسے ادارے شامل ہیں، مکمل یا جزوی طور پر حکومت کی طرف سے مالی معاونت یافتہ تھے، ہونہار اور ذہین بچوں کی تعلیم کے لیے غریب طلبہ کے لیے ناقابل رسائی تھے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس زمرے میں آنے والے تمام پبلک اسکول اور ادارے حکومت سنبھال لے گی اور انہیں ہونہار طلبہ کے اسکولوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ ہونہار طلبہ کو مکمل مفت، ملک بھر سے ان کی مالی حیثیت یا سماجی پس منظر کی پرواہ کیے بغیر، ایک بھرپور پروگرام فراہم کیا جائے۔ National Education Policy and Implementation Program (1979) 1979 میں اعلان کیا گیا۔ اپنے پیش لفظ میں، نئی پالیسی کا بنیادی مقصد ملک میں تعلیم کی از سر نو تعمیر کے لیے جرات مندانہ نئی کوشش کی سفارش کرنا قرار دیا گیا۔

پالیسی کے بڑے توجہ کے شعبے درج ذیل تھے۔

1.5.3.3 پالیسی بیان

پالیسی بیان میں، پسماندہ افراد کی تعلیم، علاج، ادارہ جاتی دیکھ بھال اور بحالی کو ایک قوم کے طور پر اہم اخلاقی اور مذہبی ذمہ داریاں قرار دیا گیا۔ پالیسی کے مطابق، پسماندہ شہری کی بحالی اس طرح کی جانی چاہیے کہ وہ قومی زندگی کے مرکزی دھارے میں داخل ہو سکیں۔

1.5.3.4 جواز

پالیسی دستاویز نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ ملک میں خصوصی تعلیم کے شعبے میں ہونے والی ترقی کے لیے مخیر تنظیموں کی بڑی کوششیں تھیں۔ چونکہ نجی تنظیمیں وسائل اور صلاحیت میں محدود تھیں، اس لیے اسی طرح کی تنظیموں کے درمیان ہم آہنگی آسان نہیں تھی۔ حکومت کی طرف سے قائم کردہ خصوصی بچوں کے ادارے اساتذہ، آلات، کتابوں اور دیگر جسمانی سہولیات کے لحاظ سے ناکافی تھے۔ پالیسی نے تسلیم کیا کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہوگی اگر وہ پسماندہ افراد کی تعلیم اور بحالی کا براہ راست چارج نہ سنبھالے۔

1.5.3.5 پروگرام

پالیسی میں پسماندہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے درج ذیل پروگرام تجویز کیے گئے۔

- چاروں صوبوں میں پسماندہ افراد کی تعلیم کے لیے موجودہ سہولیات کا سروے۔
- ان اداروں کی نشاندہی جن میں قومی ادارے بننے کی صلاحیت تھی۔

- معذور اور پسماندہ افراد کی تعلیم کے لیے قومی مظاہرتی پائلٹ منصوبوں کی تیاری۔
- معذور افراد کے لیے موجودہ اداروں کو مضبوط بنانے کی ضروریات کی نشاندہی کے لیے منصوبوں کی تیاری۔ یہ تجویز کیا گیا کہ پسماندہ بچوں کے لیے تعلیمی پروگراموں میں صحیح قسم کی پیشہ ورانہ تعلیم کے ساتھ عمومی تعلیم کی فراہمی شامل ہوگی تاکہ پسماندہ افراد قوم کے وسائل پر بوجھ بن کر نہ بڑھیں بلکہ انہیں پیداواری سرگرمیوں کی طرف موڑا جاسکے۔ چونکہ پاکستان میں بہرے اور گونگے اسکولوں کے اساتذہ کو تربیت دینے کا صرف ایک اسکول تھا، اس لیے پسماندہ افراد کے لیے ایسے ادارے حکومت کے خرچ پر فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ بہرے اور گونگے افراد کے لیے ایک اساتذہ تربیتی ادارہ! ind میں اور ایک ناپینا افراد کے لیے Punjab میں کھولا جائے گا۔ مخیر تنظیموں کی کوششوں کی حمایت، تکمیل اور ہم آہنگی کی تجویز حکومت کی طرف سے کمیونٹیز میں مزید خصوصی اسکول کھولنے اور موجودہ کو مضبوط بنانے میں کی گئی۔ پسماندہ افراد کے لیے مربوط پروگرام تیار اور شروع کرنے کے لیے صحت، سماجی بہبود اور صنعت کی فعال شمولیت حاصل کی جائے گی۔ خصوصی تعلیم کے نصاب اور سلیبس بھی معذور افراد کی ضروریات اور تقاضوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مطابق بنائے جائیں گے۔

1.5.3.6 تعلیم و تربیت

پاکستان نے اسی کی دہائی میں وفاقی سطح پر Directorate General of Special Education (DGSE) اور National Trust for the Disabled (NTD) کے قیام کے بعد سے تمام متعلقہ شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ صوبائی حکومتوں اور NGOs نے تحریک میں شمولیت اختیار کی اور خصوصی منصوبے شروع کیے۔ بین الاقوامی سطح پر، خصوصی تعلیم کو تعلیم کا لازمی حصہ بنانے کی تحریک قبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اس لیے معذور بچوں کا تعلیم کے عام نظام میں انضمام اور مین اسٹریمنگ کو تمام سطحوں پر فروغ دیا جانا چاہیے۔ ہدف حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے گئے۔

- خصوصی امداد اور آلات کی فراہمی، متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی سطح پر وفاقی، صوبائی اور ضلعی حکومتوں کے درمیان پالیسیوں کی ہم آہنگی، متعلقہ محکموں / ایجنسیوں کے تعاون سے نصاب میں تبدیلیاں، اور خصوصی امداد اور آلات کی فراہمی۔
- یونیورسٹی سطح پر خصوصی تعلیم میں پوسٹ گریجویٹ تربیت کے موجودہ نظام کو مزید مضبوط بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔

• تربیتی اداروں جیسے National Institute of Special Education (NISE) کو خصوصی تعلیمی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی تربیت اور تحقیق کے اپنے پروگرام کو مزید مضبوط بنانے کی تجویز دی گئی۔ اسی طرح، پیشہ ورانہ تھراپی اور فزیو تھراپی کے لیے دستیاب تربیتی اداروں کی تعداد بڑھانے کا

منصوبہ بنایا گیا ساتھ ہی گفتگو کے معالجوں (speech therapists) اور دیگر متعلقہ پیشہ ور افراد کے لیے تربیتی مراکز۔

1.5.3.7 پیشہ ورانہ تربیت و روزگار اور بحالی

معذور افراد کی پیشہ ورانہ تربیت، روزگار اور بحالی National Policy for Persons with disabilities (2002) کے بنیادی توجہ کے شعبے تھے۔ ہدف حاصل کرنے کے لیے، پالیسی نے معلوماتی اور معاونتی ٹیکنالوجی، خود روزگار کے استعمال پر توجہ دی۔ معذور / خصوصی افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے آجروں کو مراعات دینے کا منصوبہ بنایا گیا۔

1.5.3.8 تحقیق و ترقی

معذور افراد کے فائدے کے لیے وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر تعلیمی اور اطلاقی تحقیق دونوں کی حوصلہ افزائی کا منصوبہ بنایا گیا۔ کوششیں کی جائیں گی کہ یونیورسٹیوں اور دیگر تنظیموں کی دلچسپی اور معاونت حاصل کی جائے خاص طور پر طب، سماجی کام، نفسیات، پیشہ ورانہ تربیت، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں۔

1.5.3.9 وکالت و عوامی آگاہی

معذور افراد کے تئیں مثبت عوامی رویہ پیدا کرنے کے لیے، ماس میڈیا کے ذریعے ان کی کامیابی کی کہانیوں کی پیش کش کے ذریعے معذور افراد کی مثبت تصاویر کو اجاگر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ میڈیا کی سطح پر بھی تمام ممکنہ چینلز کو معذوریوں کی نوعیت اور اقسام اور ان کی شناخت کے ساتھ ساتھ بحالی کے لیے کمیونٹی کی معاونت کی ضرورت کے بارے میں عوامی آگاہی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔

1.5.3.10 کھیل و تفریح

معذور بچوں اور بڑوں کے لیے مناسب طور پر ڈیزائن کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ تمام سرکاری اور نجی حکام کے تعاون سے شروع کرنے کا بنایا گیا۔ ہر ضلعی / مقامی اتھارٹی سے توقع کی گئی کہ وہ بجٹ کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ معذور افراد کے گروپ کھیلوں اور تفریح کے لیے کلب قائم کر سکیں اور مناسب مفت احاطے فراہم کیے جائیں۔

1.5.3.11 عمارتوں، پارکوں اور عوامی مقامات کا ڈیزائن

عوامی مقامات / عمارتوں میں معذور افراد کی محفوظ اور آسان رسائی کو یقینی بنانے کا منصوبہ نئی عوامی عمارتوں کے ڈیزائن کے لیے عمل کے ضابطوں اور موجودہ احاطوں کی موافقت کے لیے متعارف کروا کر بنایا گیا۔ اس کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ عوامی عمارتوں کے ڈیزائن وزارت سماجی بہبود، خصوصی تعلیم سے مشاورت کے ساتھ تیار کیے جائیں گے، جو ان عمارتوں کے ان پہلوؤں کی وضاحتیں فراہم کرتی ہے جو معذور افراد استعمال کرتے ہیں جیسے ریمپ، لفٹ، بیت الخلاء وغیرہ۔ عوامی استعمال کی دیگر عمارتوں تک رسائی کے لیے بھی معذور افراد کے لیے آسان رسائی کو سہل بنانے کے لیے خصوصی ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

1.5.3.12 ادارتی انتظام / طریقہ کار

پالیسی نے اپنے کامیاب نفاذ کے لیے درج ذیل ادارتی انتظامات تجویز کیے:

- چونکہ قومی سطح پر معذور افراد کی ضروریات کو پورا کرنے میں وفاقی حکومت کا کردار بہت اہم ہے، اس لیے معذور افراد کی تعلیم اور بحالی کے شعبے میں کوششوں کے لیے وفاقی حکومت کی موجودہ معاونتی سطح کو بڑھانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس مقصد کے لیے، وزارت سماجی بہبود اور خصوصی تعلیم کے علاوہ متعلقہ وزارتوں کی مشترکہ کوششوں کی تجویز اس پالیسی میں طے شدہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دی گئی۔
- معذور افراد کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو تمام مطلوبہ سہولیات فراہم کرنے میں صوبائی حکومتوں کا کردار اہم ہے۔ ضروریات کی تشخیص کی بنیاد پر، صوبائی حکومتوں سے توقع ہے کہ وہ سرکاری اور نجی شعبوں کے لیے عملی منصوبے بنائیں۔ وفاقی حکومت نصاب کی تیاری اور تحقیق کے شعبوں میں بھی معاونت فراہم کرے گی۔
- ضلعی حکومتوں سے توقع ہے کہ وہ معذور افراد کے لیے پروگراموں کا دائرہ بڑھائیں۔ ضلعی کونسلوں اور یونین کونسلوں کے دائرہ اختیار میں مقامی حکومتوں کے نظام میں عام اسکولوں میں معذور بچوں کے انضمام کے نظام کے تعارف کو شامل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔
- کمیونٹی کی شمولیت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے لیے رضاکارانہ تنظیموں کے قیام کی حوصلہ افزائی کا منصوبہ بنایا گیا۔ کمیونٹی سماجی کام کے شعبے میں NGOs کے وسائل کو معذور افراد کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی سمت میں لگانے کا منصوبہ بنایا گیا۔

• مؤثر ہونے کے لیے، بحالی کو پیشہ ور افراد، تنظیموں اور بڑے پیمانے پر کمیونٹی کی وسیع اقسام کی شمولیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ "خصوصی دوستوں" (Special friends) اور رضاکارانہ معاونتی گروپوں کی شمولیت کو یقینی بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔

1.6 خود احتسابی سوالات

1. خصوصی تعلیم کیا ہے؟ خصوصی تعلیم میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کی تعریف کریں۔ خصوصی تعلیم کے تصور پر بھی بحث کریں۔
2. خصوصی تعلیم کے تاریخی اور قانونی پس منظر کے بارے میں ایک مختصر بحث لکھیں۔
3. غیر معمولیات (exceptionalities) کے بڑے زمروں، ان کی خصوصیات اور وجوہات پر بحث کریں۔
4. خصوصی تعلیم میں قانون سازی اور پاکستان کے خصوصی تعلیمی نظام کے بارے میں مختصراً لکھیں۔
5. خصوصی تعلیم کے موجودہ مسائل اور رجحانات کیا ہیں؟ خصوصی تعلیم کے ان رجحانات اور مسائل کے حل کے لیے اپنی سفارشات دیں۔

1.7 حوالہ جات

- Benz, M. R., Lindstrom, L., & Yovanoff, P. (2000). Improving Graduation and Employment Outcomes of Students with Disabilities: Predictive Factors and Student Perspectives. Exceptional Children
- Bateman, D., & Bateman, C. F. (2001). A principal's guide to special education. Arlington, VA: Council for Exceptional Children
- Billingsley, B. S. (1993). Teacher retention and attrition in special education: A critical review of the literature. Journal of Special Education
- Billingsley, B. S., & Cross, L. H. (1991). Teachers' decisions to transfer from special to general education. Journal of Special Education
- Brownell, M. T., & Smith, S. W. (1993). Understanding special education attrition: A conceptual model and implications for teacher education. Teacher Education and Special Education

- Burrello, L. C., & Lashley, C. (1992). On organizing the future: The destiny of special education. In K. Waldron, A. Riester, & J. Moore (Eds.), Special education: The challenge for the future, (pp. 64-95). San Francisco: Edwin Mellen Press
- Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press
- Cook, B. G., Semmel, M. I., & Gerber, M. M. (1999). Attitudes of principals and special education teachers toward the inclusion of students with mild disabilities: Critical differences of opinion. Remedial and Special Education
- Cazden, C. B. (2001). Classroom discourse: The language of teaching and learning
- Educational Researcher, A. & Mallinson, C (2011) Understanding English Language Variation in U.S. Schools. New York, NY: Teachers College Press
- Embich, J. L. (2001). The relationship of secondary special education teachers' roles and factors that lead to professional burnout. Teacher Education and Special Education
- Gersten, R., Keating, T., Yovanoff, P., & Harniss, M. K. (2001). Working in special education: Factors that enhance special educators' intent to stay
- Exceptional Children
- Gonzalez, P. (1996). Causes and cures of teacher attrition: A selected bibliography focusing on special educators. Alexandria VA: National Association of Directors of Special Education, (ERIC Document
- Reproduction Service
- Katsiyannis, A., Conderman, G., & Franks, D. J. (1996). State practices on inclusion: A national review. Remedial and Special Education

- In J. I. Goodlad & T. C. Lovitt (Eds.), Integrating general and special •
.education. New York: Macmillan
- Kauffman, J. M., & Hallahan, D. P. (Eds.). (1995). The illusion of full •
inclusion: A comprehensive critique of a current special education
.bandwagon. Austin
- Kearns, J. F., Kleinert, H. L., & Clayton, J. (1998). Principal supports for •
.inclusive assessment: A Kentucky story. Teaching Exceptional Children
- Lipp, M. (1992). An emerging perspective on special education: A •
.development agenda for the 1990s. Special Education Leadership Review
- :Lipsky, D. K., & Gartner, A. (1997). Inclusion and school reform •
.Transforming America's classrooms. Baltimore: Brookes
- Loucks-Horsley, S., & Roody, D. S. (1990). Using what is known about •
change to inform the regular education initiative. Remedial and Special
.Education
- LYNCH, JAMES. 1994. Provision for Children with Special Educational •
Needs in the Asia Region. World Bank Technical Paper Number 261, Asia
.Technical Series. Washington, DC: The World Bank
- MAZUREK, KAS, and WINZER, MARGRET A. 1994. Comparative Studies in •
.Special Education. Washington, DC: Gallaudet University Press
- Monteith, D. S. (2000). Professional development for administrators in •
special education: Evaluation of a program for underrepresented
.personnel. Teacher Education and Special Education
- OAKLAND, THOMAS, and HU, SHERMAN. 1994. "International •
Perspectives on Tests Used with Children and Youth." Journal of School
.Psychology
- Oetting, J. & McDonald, J. (2002), Methods for Characterizing Participants •
.Nonmainstream Dialect Use in Child Language Research, JSLHR

- Oetting, J., Cantrell, J., and Horohov, J. (1999) A Study in Specific Language •
Impairment (SLI) in the Context of Non-standard Dialect, Clinical
.Linguistics and Phonetics
- .Organisation For Economic Co-Operation And Development. 1995 •
:Integrating Students with Special Needs into Mainstream Schools. Paris
.Organisation for Economic Co-operation and Development
- .Organisation For Economic Co-Operation And Development. 2000 •
Education at a Glance; OECD Indicators. Paris: Organisation for Economic
.Co-operation and Development
- Portsmouth, NH: Heinemann. Craig, H. et al., (2003) Phonological Features •
,.of Child African American English, JSLHR, v 46 623-635 Godley, A
,.Sweetland, J
- .REYNOLDS, CECIL R., and FLETCHER-JANZEN, ELAINE. 2000 •
.Encyclopedia of Special Education, 2nd edition. New York: Wiley
- Spaulding, T., Plante, E., and Farinella, K. (2006) Eligibility Criteria for •
?Language Impairment - Is the Low End of Normal Always Appropriate
.Language, Speech, and Hearing Services in Schools
- Tabbert, Russell, (1994) Linguistic Diversity in America: Will We All Speak •
”?General American “
- :Virginia Department of Education (2007) FOR CULTURAL COMPETENCE •
.Knowledge, Skills, and Dispositions Needed to Embrace Diversity
.Richmond, VA
- Wheeler, S., Minnici, A., & Carpenter, B. (2006). Preparing teachers for •
.dialectally diverse classrooms
- Wheeler, R., Swords, R. (2006) Code-switching: Teaching Standard English •
in Urban Classrooms (Theory & Research Into Practice) National Council of
.State University

- 1. [http://education.stateuniversity.com/pages/2437/Special](http://education.stateuniversity.com/pages/2437/Special-Education.International-Context.html#ixzz4ZSzyM9C6)
- 2. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini
- 3. http://www.mcpherson.com/418/special_ed/terms_defintions.html
- 4. Special Education Dictionary: Parentpals.com Special Education Guide
- 5. <http://www.parentpals.com/2.0dictionary/dictnewsindex.html>
- 6. Special Education in Plain Language
- 7. <http://www.csea7.k12.wi.us/sped/Parents/plintro.htm>
- 8. [/http://www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/Schools](http://www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/Schools)
- Special.[http://www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/adhd/adhd](http://www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/adhd/adhd-identifying_pg3.html)
.identifying_pg3.html

یونٹ 2: غیر معمولیات کی اقسام-I

تعارف

بصارتی معذوری (visual impairment) وہ ہر بصارتی حالت ہے جو کسی فرد کی روزمرہ زندگی کی سرگرمیاں کامیابی سے مکمل کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ بصارتی معذوری والے طلبہ وہ شیرخوار، چھوٹے بچے، بچے اور نوجوان ہیں جو بصارتی نظام کی معذوریوں کا سامنا کرتے ہیں جو ان کی سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔ بچے کی نشوونما پر بصارتی مسائل کا اثر شدت، نقصان کی قسم، اس عمر جس میں یہ حالت ظاہر ہو، اور بچے کی مجموعی فعال سطح پر منحصر ہوتا ہے۔ بہت سے بچے جن کی متعدد معذوریاں ہوتی ہیں، ان کی بصارتی معذوری بھی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں حرکی، ادراکی اور/یا سماجی نشوونما تاخیر ہو سکتی ہے۔

بصارتی معذوری والا چھوٹا بچہ ماحول میں دلچسپ چیزوں کو تلاش کرنے کی بہت کم وجہ رکھتا ہے، اوریوں تجربات حاصل کرنے اور سیکھنے کے مواقع سے محروم ہو سکتا ہے۔ تلاش کی یہ کمی اس وقت تک جاری رہ سکتی ہے جب تک سیکھنا حوصلہ افزانہ ہو جائے یا مداخلت نہ شروع ہو جائے۔

بصارتی طور پر معذور بچہ والدین یا ساتھیوں کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ سماجی رویے کی نقل کرنے یا غیر زبانی اشاروں کو سمجھنے سے قاصر ہو سکتا ہے۔ بصارتی معذوریاں بڑھتے ہوئے بچے کی خود مختاری کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ یونٹ بصارتی معذوریوں کا تفصیل سے احاطہ کرتا ہے۔ یہ بصارتی معذوری کی وجوہات اور مختلف اقسام کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ بصارتی نقصان کے اندازوں پر زور دیتا ہے اور ساتھ ہی بصارتی طور پر معذور بچوں کے لیے تدریس و تعلیم کے حالات پر بھی بحث کرتا ہے۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کی کامیاب تکمیل کے بعد آپ قابل ہوں گے کہ:

1. بصارتی معذوری کے معنی اور فطرت کو سمجھیں
2. بصارتی معذوری کی وجوہات اور اقسام کو جانیں
3. بصارتی معذوری کے فعلی مضمرات پر بحث کریں
4. بصارتی معذوری کے تعلیمی مضمرات کو بیان کریں
5. فعلی بینائی، کمزور نظر اور کم بینائی (low vision) کا اندازہ لگائیں

6. بصارتی معذوری والے طلبہ کو پڑھائیں
7. بصارتی معذور بچوں کے مراکز میں خصوصی معلمین کے کردار کی وضاحت کریں
8. بصارتی معذور بچوں کے لیے تدریسی و تعلیمی ماحول کا انتظام کریں۔

2.1 غیر معمولیات کا درجہ بندی نظام

پبلک لاء 94-142 کہتا ہے کہ تمام معذور بچوں کو، چاہے ان کی حالت کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، مفت عوامی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس میں خصوصی تعلیم اور ان کی منفرد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کردہ متعلقہ خدمات پر زور دیا گیا ہو۔ یہ زور ضروریات پر ہے نہ کہ زمروں پر۔ لیکن غیر معمولیات کے مختلف زمروں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی خصوصی تعلیمی ضروریات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تمام خصوصی بچوں کو ان کی خصوصی تعلیمی ضروریات کے مطابق توجہ پانے کا حق ہے۔ آئیے غیر معمولیات کے تمام زمروں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

ایک بچہ اسے خصوصی تعلیمی ضروریات والا یا غیر معمولی بچہ کہنے کے لیے تشخیص و شناخت کے باضابطہ عمل سے گزرتا ہے۔ مختلف پیشوں کے ماہرین کی ٹیم جس میں والدین بھی شامل ہوتے ہیں، جانچتی ہے کہ آیا طالب علم غیر معمولی ہے اور اس کا تعین کرتی ہے کہ وہ جگہ کہاں ہوگی جو طالب علم کی ضروریات کو بہترین طریقے سے پورا کرے۔ ٹیم مشاہدات، ٹیسٹ کے نتائج اور تشخیص سے حاصل معلومات استعمال کرتی ہے تاکہ یہ طے کر سکے کہ آیا طالب علم غیر معمولی کے طور پر شناخت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ آیا طالب علم غیر معمولی ہے اور غیر معمولیات کا کون سا زمرہ طالب علم کی ضروریات کو بہترین طور پر بیان کرتا ہے۔

ہم دوبارہ پبلک لاء 94-142 کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ معذور کرنے والی حالتوں والے بچوں اور نوجوانوں کے زمرے دیکھیں۔ یہ زمرے کو درج ذیل طور پر نمایاں کرتا ہے:

1. سیکھنے سے معذور (Learning disabled)
2. بولنے میں معذور (Speech impaired)
3. کم سماعت والے اور بہرے (Hard of hearing and deaf)
4. ذہنی معذور (Mentally retarded)
5. جذباتی طور پر پریشان (Emotionally disturbed)
6. ہڈیوں سے معذور (Orthopedically impaired)

7. صحت سے معذور (health impaired)

8. بصارتی طور پر معذور (Visually handicapped)

9. بہرے - اندھے (Deaf-blind)

10. متعدد معذور (Multi-handicapped)

پبلک لاء 94-142 کے نمایاں کردہ زمروں کو درج ذیل طور پر زیادہ جامع انداز میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے:

1. حسی معذوریات جن میں سماعت اور بصارت کی معذوریات شامل ہیں

2. ذہنی انحرافات، جن میں تحفہ شدہ (gifted) کے ساتھ ساتھ ذہنی معذوری بھی شامل ہے

3. مواصلاتی عوارض، جیسے بولنے اور زبان کی خرابی

4. سیکھنے کی معذوریات / معمولی دماغی خرابی (minimal brain dysfunction)

5. رویے کے عوارض، جن میں شدید جذباتی پریشانیاں شامل ہیں

6. جسمانی معذوریات اور صحت کی معذوریات، جن میں اعصابی نقائص، ہڈیوں کی حالتیں شامل ہیں

آپ کو غیر معمولیات کے زمروں اور تعریفوں کی فہرست اور ہر زمرے کی تعریف کے لیے "Categories of Exceptionality and Definitions Section III January, 2001 (retrieved from

[/http://www.peelschools.org/parents/specialed/sep/documents](http://www.peelschools.org/parents/specialed/sep/documents/B7categories.pdf)

(B7categories.pdf) کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وزارت تعلیم نے غیر معمولیات کے پانچ زمرے اور دس ذیلی زمرے بیان کیے ہیں۔ غیر معمولیات کے زمرے یہ ہیں:

زمرہ	ذیلی زمرے
1. رویہ (Behaviour)	—
2. مواصلات (Communication)	سیکھنے سے معذور • آٹسٹک (Autistic) • زبان کی معذوری (Language Impairment) • بولنے کی معذوری (Speech Impairment) • کم سماعت والے (Hard of Hearing)
3. ذہنی (Intellectual)	تحفہ شدہ (Gifted) • ہلکی ذہنی معذوری (Mild Intellectual Disability) • نشوونما کی معذوری (Developmental Disability)
4. جسمانی (Physical)	اندھا - کم بینائی (Blind-Low Vision) • جسمانی معذوری (Physical Disability)

5. متعدد (Multiple)	—
---------------------	---

آئیے زمروں کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔

1. رویہ (Behaviour)

ایک سیکھنے کا عارضہ جو ایسے مخصوص رویے کے مسائل سے نمایاں ہوتا ہے جو اتنی مدت تک، اتنی نمایاں حد تک، اور ایسی فطرت کے ہوں کہ تعلیمی کارکردگی پر منفی اثر ڈالیں اور جن کے ساتھ درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں:

1. باہمی تعلقات بنانے یا برقرار رکھنے میں ناکامی
 2. ضرورت سے زیادہ خوف یا بے چینی
 3. مجبور کن رد عمل کا رجحان
 4. سیکھنے میں ناکامی جو ذہنی، حسی یا دیگر صحت کے عوامل، یا ان کے کسی امتزاج سے پتہ نہ لگائی جاسکے
- وزارت کا زمرہ اور تعریف: (وزارت تعلیم - جنوری 1999)

2. مواصلات (Communication)

سیکھنے سے معذور (Learning disabled)

سیکھنے کی معذوریوں ایک عمومی اصطلاح ہے جو عوارض کے ایک متنوع گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے، استدلال کرنے یا ریاضی کی صلاحیتوں کے حصول اور استعمال میں نمایاں مشکلات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ عوارض فرد کے اندرونی ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ مرکزی اعصابی نظام کی خرابی کی وجہ سے ہیں۔ اگرچہ سیکھنے کی معذوری دیگر معذور کرنے والی حالتوں (مثلاً حسی معذوری، ذہنی معذوری، سماجی اور جذباتی پریشانی) یا ماحولیاتی اثرات (ثقافتی اختلافات، ناکافی / نامناسب تعلیم، نفسیاتی عوامل) کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان حالتوں یا اثرات کا براہ راست نتیجہ نہیں ہوتی۔ (Hammill, Leigh, McNutt, & Larsen, 1981, p. 336)

سیکھنے کی معذوریوں کی شناخت ایک ٹیم کرتی ہے۔ ٹیم یہ طے کر سکتی ہے کہ کسی بچے کو مخصوص سیکھنے کی معذوری ہے اگر بچہ اپنی عمر اور صلاحیت کی سطح کے لیے مناسب سیکھنے کے تجربات فراہم کیے جانے کے باوجود درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ شعبوں میں اپنی عمر اور صلاحیت کی سطح کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کرتا: زبانی اظہار، سننے کی فہم، تحریری اظہار، بنیادی پڑھنے کی مہارت، پڑھنے کی فہم، ریاضی کی حساب

کتاب، یا ریاضیاتی استدلال اور اگر ٹیم کو معلوم ہو کہ بچے کی کامیابی اور ذہنی صلاحیت کے درمیان ایک یا زیادہ انہی شعبوں میں شدید فرق ہے: سننا، سوچنا، بولنا، پڑھنا، لکھنا یا ریاضی کی صلاحیتیں۔

ایک سیکھنے کا عارضہ جو تعلیمی اور سماجی دونوں صورتحال میں ظاہر ہوتا ہے جس میں بولی ہوئی زبان یا مواصلات کی علامات کے درست استعمال کے لیے ضروری ایک یا زیادہ عمل شامل ہوتے ہیں، اور جو ایسی حالت سے نمایاں ہوتا ہے کہ:

1. بنیادی طور پر اس کا نتیجہ نہ ہو:

◦ بصارت کی معذوری؛

◦ سماعت کی معذوری؛

◦ جسمانی معذوری؛

◦ بنیادی جذباتی پریشانی؛

◦ ثقافتی اختلاف؛

◦ نشوونمائی معذوری اور

2. تعلیمی کامیابی اور جانچی گئی ذہنی صلاحیت کے درمیان نمایاں فرق کا نتیجہ ہو، جس میں درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ میں کمی ہو:

◦ وصولی زبان (سننا، پڑھنا)؛

◦ زبان کی پروسیسنگ (سوچنا، تصور کرنا، مربوط کرنا)؛

◦ اظہاری زبان (بولنا، سمجھنا، لکھنا)؛

◦ ریاضی کی حساب کتاب؛

3. درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ تشخیص شدہ حالتوں سے منسلک ہو سکتا ہے:

◦ ادراکی معذوری؛

◦ دماغی چوٹ؛

◦ معمولی دماغی خرابی؛

◦ ڈسلیکسیا (dyslexia)؛

◦ نشوونمائی افیزیا (developmental aphasia)؛

وزارت کا زمرہ اور تعریف: (وزارت تعلیم - جنوری 1999)

آٹزم (Autism)

ایک شدید سیکھنے کا عارضہ جو درج ذیل سے نمایاں ہوتا ہے:

1. تعلیمی نشوونما کی شرح، ماحول سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت، حرکت پذیری، ادراک، بولنے اور زبان میں خرابیاں

2. نمائندہ علامتی رویے کی کمی جو زبان سے پہلے ہوتا ہے

وزارت کا زمرہ اور تعریف: (وزارت تعلیم - جنوری 1999)

زبان کی معذوری (Language Impairment)

ایک سیکھنے کا عارضہ جو زبانی مواصلات یا تحریری یا مواصلات کے دیگر علامتی نظام کی فہم اور/یا استعمال میں معذوری سے نمایاں ہوتا ہے، جو اعصابی، نفسیاتی، جسمانی یا حسی عوامل سے منسلک ہو سکتا ہے، اور جو:

1. مواصلات میں زبان کی شکل، مواد اور فعل میں سے ایک یا زیادہ شامل ہو اور

2. درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ شامل ہو:

◦ زبان میں تاخیر

◦ ڈس فلوئنسی (Dysfluency)

◦ آواز اور تلفظ کی نشوونما جو نامیاتی یا فعلی طور پر مبنی ہو یا نہ ہو

وزارت کا زمرہ اور تعریف: (وزارت تعلیم - جنوری 1999)

بولنے کی معذوری (Speech Impairment)

زبان کی تشکیل میں ایک عارضہ جو اعصابی، نفسیاتی، جسمانی یا حسی عوامل سے منسلک ہو سکتا ہے، جو زبانی پیغامات منتقل کرنے کے ادراک کی حرکی پہلوؤں کو شامل کرتا ہے، اور جو تلفظ، لے (rhythm) اور زور (stress) میں معذوری سے نمایاں ہو سکتا ہے۔

وزارت کا زمرہ اور تعریف: (وزارت تعلیم - جنوری 1999)

بہرے اور کم سماعت والے (Deaf and Hard of Hearing)

ایک معذوری جو زبان اور بولنے کی نشوونما میں کمی سے نمایاں ہوتی ہے کیونکہ آواز کے لیے سماعتی رد عمل کم یا بالکل غیر موجود ہوتا ہے۔

(وزارت کا زمرہ اور تعریف: وزارت تعلیم - جنوری 1999)

3. ذہنی (Intellectual)

تحفہ شدہ ہونا (Giftedness)

عمومی ذہنی صلاحیت کی غیر معمولی طور پر اعلیٰ درجے کی پیش رفت جو باقاعدہ اسکول پروگرام میں عام طور پر فراہم کردہ تجربات سے گہری اور وسیع تر مختلف سیکھنے کے تجربات کا تقاضا کرتی ہے تاکہ اشارہ کردہ تعلیمی صلاحیت کی سطح کو پورا کیا جاسکے۔

(وزارت کا زمرہ اور تعریف: وزارت تعلیم - جنوری 1999)

ہلکی ذہنی معذوری (Mild Intellectual Disability)

ایک سیکھنے کا عارضہ جو درج ذیل سے نمایاں ہوتا ہے:

1. نصاب میں خاطر خواہ تبدیلی اور معاون خدمات کی مدد سے باقاعدہ جماعت میں تعلیمی طور پر فائدہ اٹھانے کی صلاحیت؛

2. سست ذہنی نشوونما کی وجہ سے باقاعدہ جماعت میں تعلیمی طور پر فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ناکامی؛

3. تعلیمی سیکھنے، آزاد سماجی ایڈجسٹمنٹ اور معاشی خود کفالت کی صلاحیت۔

(وزارت کا زمرہ اور تعریف: وزارت تعلیم - جنوری 1999)

نشوونما کی معذوری (Developmental Disability)

ایک شدید سیکھنے کا عارضہ جو درج ذیل سے نمایاں ہوتا ہے:

1. سست ذہنی نشوونما کی وجہ سے ہلکی ذہنی معذوری والے طلبہ کے لیے خصوصی تعلیمی پروگرام سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ناکامی

2. سست ذہنی نشوونما کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کردہ خصوصی تعلیمی پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت

3. تعلیمی سیکھنے، آزاد سماجی ایڈجسٹمنٹ اور معاشی خود کفالت کی محدود صلاحیت

(وزارت کا زمرہ اور تعریف: وزارت تعلیم - جنوری 1999)

4. جسمانی (Physical)

اندھے اور کم بینائی والے (Blind and Low Vision) دیکھنے یا بصارت کی جزوی یا مکمل معذوری کی حالت جو اصلاح کے باوجود بھی تعلیمی کارکردگی کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔

وزارت کا زمرہ اور تعریف: (وزارت تعلیم - جنوری 1999)

جسمانی معذوری (Physical Disability)

ایسے شدید جسمانی محدودیت یا کمی کی حالت کہ سیکھنے کی صورتحال میں خصوصی مدد درکار ہو تاکہ اسی عمر یا نشوونما کے سطح کے غیر معمولیات کے بغیر شاگردوں کے برابر تعلیمی کامیابی کا موقع فراہم ہو۔

وزارت کا زمرہ اور تعریف: (وزارت تعلیم - جنوری 1999)

5. متعدد غیر معمولیات (Multiple Exceptionalities)

سیکھنے یا دیگر عوارض، معذوریوں یا جسمانی معذوریوں کا امتزاج، جو ایسے نوعیت کا ہو کہ تعلیمی کامیابی کے لیے خصوصی تعلیم میں اہلیت رکھنے والے ایک یا زیادہ اساتذہ کی خدمات اور ایسے عوارض، معذوریوں یا معذوریوں کے لیے مناسب معاون خدمات کی فراہمی درکار ہو۔

وزارت کا زمرہ اور تعریف: (وزارت تعلیم - جنوری 1999)

2.2 قسم 1: بصارتی معذوری (Type 1-Visual Impairment)

بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت بصارت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ لمبی دوری پر چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوسروں کو چھوٹا پرنٹ پڑھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ ان قسم کی حالتوں کا علاج اکثر عینک یا کانٹیکٹ لینز سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔

لیکن جب آنکھ یا دماغ کے ایک یا زیادہ حصے جو تصویروں کی پروسیسنگ کے لیے ضروری ہیں بیمار یا نقصان زدہ ہو جاتے ہیں، تو بصارت کا شدید یا مکمل نقصان ہو سکتا ہے۔ ان صورتوں میں طبی علاج، سرجری یا عینک یا کانٹیکٹ لینز جیسے اصلاحی لینز سے بصارت کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا جاسکتا۔

2.2.1 بصارتی معذوری کی وجوہات (Causes of Visual Impairments)

اصطلاحات و تعریف (Terminology and Definition)

درج ذیل اصطلاحات عام طور پر استعمال ہوتی ہیں:

- بصارتی طور پر معذور (Visually impaired): ان لوگوں کے لیے ایک چھتری اصطلاح جن کی بینائی کا ناقابل واپسی نقصان ہوا ہو۔
 - اندھا (Blind): کوئی شخص اندھے کے طور پر رجسٹر ہو سکتا ہے اگر وہ عینک والے کے آنکھوں کے چارٹ کی صرف اوپر والی لائن تین میٹر یا اس سے کم فاصلے سے پڑھ سکتا ہو۔
 - جزوی طور پر دیکھنے والا (Partially sighted): کوئی جو عینک والے کے آنکھوں کے چارٹ کی اوپر والی لائن چھ میٹر یا اس سے کم فاصلے سے پڑھ سکتا ہو۔
- بصارتی معذوری ایک اصطلاح ہے جو کسی بھی قسم کے بینائی کے نقصان کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی ہو جو بالکل دیکھ نہیں سکتا یا کوئی جس کی جزوی بینائی کا نقصان ہوا ہو۔
- یہ اصطلاح ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جن کی مستقل بینائی کا نقصان ہوا ہو اور مختلف معذوریوں کے وسیع دائرے کو شامل کرتی ہے۔ اس میں وہ شامل نہیں جن کے بینائی کے مسائل عینک یا کانٹیکٹ لینز سے درست ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس میں وہ شامل ہیں جن کی بینائی طبی مداخلت سے بہتر ہو سکتی ہو۔
- کچھ لوگ مکمل طور پر اندھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے دوسروں کے پاس وہ ہوتا ہے جسے قانونی اندھا پن (legal blindness) کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی بینائی مکمل طور پر نہیں کھوئی ہوتی لیکن انہوں نے اتنی بینائی کھو دی ہوتی ہے کہ انہیں کسی چیز کو اتنی ہی اچھی طرح دیکھنے کے لیے 20 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا پڑے جتنی اچھی طرح کامل بینائی والا کوئی شخص 200 فٹ کے فاصلے سے دیکھ سکتا ہے۔
- اصطلاحات جزوی طور پر دیکھنے والا، کم بینائی (low vision)، قانونی طور پر اندھا (legally blind) اور مکمل طور پر اندھا بصارتی معذوری والے طلبہ کو بیان کرنے کے لیے تعلیمی سیاق میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی تعریف درج ذیل ہے:

- "جزوی طور پر دیکھنے والا (Partially sighted)" اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی قسم کے بصارتی مسئلے کے نتیجے میں خصوصی تعلیم کی ضرورت پڑی ہے؛
- "کم بینائی (Low vision)" عام طور پر شدید بصارتی معذوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ضروری نہیں کہ دور کی بینائی تک محدود ہو۔ کم بینائی ان تمام افراد پر لاگو ہوتی ہے جن کی بینائی ہو لیکن وہ عینک یا کانٹیکٹ

لینز کی مدد سے بھی عام دیکھنے کے فاصلے پر اخبار نہیں پڑھ سکتے۔ وہ سیکھنے کے لیے بینائی اور دیگر حواس کے امتزاج کا استعمال کرتے ہیں، اگرچہ انہیں روشنی یا پرنٹ کے سائز میں تبدیلیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی بریل (braille) کی؛

• "قانونی طور پر اندھا (Legally blind)" اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی شخص کی بہتر آنکھ میں 20/200 سے کم بینائی ہے یا بہت محدود بصارتی میدان (اپنے وسیع ترین مقام پر 20 ڈگری) ہے؛ اور مکمل طور پر اندھے طلبہ بریل یا دیگر غیر بصارتی ذرائع سے سیکھتے ہیں۔

بیماریوں کی بین الاقوامی درجہ بندی-10 کے مطابق، بصارتی فعل کی چار سطحیں ہیں، (WHO-fact sheets, Update and Revision 2006):

• عام بینائی (normal vision)

• معتدل بصارتی معذوری (moderate visual impairment)

• شدید بصارتی معذوری (severe visual impairment)

• اندھا پن (blindness)۔

معتدل بصارتی معذوری کو شدید بصارتی معذوری کے ساتھ ملا کر "کم بینائی (low vision)" کی اصطلاح کے تحت گروہ بند کیا جاتا ہے اور کم بینائی کو اندھے پن کے ساتھ ملا کر تمام بصارتی معذوری کی نمائندگی کرتا ہے۔

2.2.1.1 وجوہات (The Causes)

لوگ شاذ و نادر ہی اپنی نوجوانی کے سالوں میں اپنی بینائی کھوتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے، تو عام طور پر چوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے آنکھ یا سر پر نیس بال لگنا یا آٹو موبائل یا موٹر سائیکل کا حادثہ ہونا۔

بصارتی معذوریوں کے عالمی اندازوں - 2010 کے مطابق "بصارتی معذوری کی بنیادی وجوہات غیر اصلاح شدہ اضطرابی خامیاں (uncorrected refractive errors) اور موتیا (cataract) ہیں، بالترتیب 43% اور 33%۔ دیگر وجوہات گلوکوما (glaucoma)، 2%، عمر سے متعلق میکولر تنزل (age related macular degeneration - AMD)، ذیابیطی ریٹینوپیتھی (diabetic retinopathy)، ٹریخوما (trachoma) اور قرینہ کی دھندلاہٹ (corneal opacities)، سب تقریباً 1% ہیں۔ وجوہات کا بڑا حصہ، 18%، غیر متعین ہے۔ اندھے پن کی وجوہات موتیا، 51%، گلوکوما، 8%، AMD، 5%، بچپن کا اندھا پن اور قرینہ کی دھندلاہٹ، 4%، غیر اصلاح شدہ اضطرابی خامیاں اور ٹریخوما، 3%، اور ذیابیطی ریٹینوپیتھی 1% ہیں، غیر متعین وجوہات 21% ہیں" (Pascolini, & Mariotti, 2010)۔

کچھ بچے پیدائشی اندھے پن (congenital blindness) کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ پیدائش کے وقت بصارتی طور پر معذور ہوتے ہیں۔ پیدائشی اندھا پن کئی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ وراثتی ہو سکتا ہے، مثلاً، یا کسی انفیکشن (جیسے جرمن خسرہ) کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو حمل کے دوران ماں سے نشوونما پاتے جنین کو منتقل ہو۔

پیدائش کے بعد بینائی کے نقصان کا باعث بننے والی حالتوں میں شامل ہیں:

ایمبلیوپیا (Amblyopia) (تلفظ: am-blee-oh-pee-uh) ابتدائی بچپن میں اس آنکھ کے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے آنکھ کی کم بینائی ہے۔ کچھ حالتیں بچے کی آنکھوں کو دماغ کو مختلف پیغامات بھیجنے کا سبب بنتی ہیں (مثلاً، ایک آنکھ دوسری کی نسبت بہتر فوکس کر سکتی ہے)۔ دماغ پھر کمزور آنکھ سے آنے والی تصاویر کو بند یا دبا سکتا ہے اور اس آنکھ کی بینائی پھر عام طور پر نشوونما پانا بند کر دیتی ہے۔ اسے "سست آنکھ (lazy eye)" بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹرابزمس (Strabismus) (غیر متوازی یا کراس آنکھیں) ایمبلیوپیا کی ایک عام وجہ ہے، کیونکہ دماغ غیر متوازی آنکھوں میں سے ایک کے بھیجے گئے پیغامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دے گا۔

موتیا (Cataracts) آنکھ کے لینز کے کسی حصے یا تمام میں دھندلے علاقے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو موتیا نہیں ہوتا ان میں لینز کرسٹل صاف ہوتا ہے اور روشنی کو گزرنے اور ریٹینا پر فوکس ہونے دیتا ہے۔ موتیا روشنی کو لینز سے آسانی سے گزرنے سے روکتا ہے، اور یہ بینائی کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ موتیا اکثر آہستہ بنتا ہے اور عام طور پر 60 اور 70 کی دہائی کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی بچے پیدائشی موتیا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ علامات میں دوہری بینائی، دھندلی یا غیر واضح بینائی، کم روشنی والی جگہوں میں دیکھنے میں دشواری، اور رنگ جو مدھم لگتے ہیں شامل ہیں۔

ذیابیطس ریٹینوپیتھی (Diabetic retinopathy) (تلفظ: reh-ton-ah-pa-thee) اس وقت ہوتی ہے جب ذیابیطس کی وجہ سے ریٹینا میں چھوٹی خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ریٹینوپیتھی والے لوگوں کو شروع میں دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر حالت بگڑ جائے، تو وہ اندھے ہو سکتے ہیں۔ ذیابیطس والے نوجوانوں کو آنکھوں کے باقاعدہ معائنے ضرور کروانے چاہئیں کیونکہ اس حالت کی کوئی ابتدائی انتباہی علامات نہیں ہوتیں۔ ریٹینوپیتھی سے بچنے میں مدد کے لیے، ذیابیطس والے لوگوں کو سگریٹ نوشی سے بھی بچنا چاہیے، اپنے بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی خون کی شکر کو ایک برابر سطح پر رکھنا چاہیے۔

گلوکوما (Glaucoma) آنکھ کے اندر دباؤ میں اضافہ ہے۔ بڑھا ہوا دباؤ آپٹک نرو کو نقصان پہنچا کر بینائی کو خراب کرتا ہے۔ گلوکوما زیادہ تر بڑی عمر کے بالغوں میں دیکھا جاتا ہے، اگرچہ بچے اس حالت کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں اور بچے اور نوجوان بھی کبھی کبھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔

میکولر تنزل (Macular degeneration) (تلفظ: mah-kyoo-lur dih-jeh-nuh-ray) -shun) میکولہ، ریٹینا کا سب سے حساس علاقہ، کا بتدریج اور ترقی پذیر بگاڑ ہے۔ یہ حالت مرکزی بینائی (براہ راست سامنے باریک تفصیلات دیکھنے کی صلاحیت) کے ترقی پذیر نقصان کا باعث بنتی ہے۔ میکولر تنزل اکثر عمر سے متعلق ہوتا ہے (یہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر 60 سے بڑی عمر میں)، لیکن کبھی کبھی یہ نوجوان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ سورج کی روشنی کے ضرورت سے زیادہ سامنا اور سگریٹ نوشی عمر سے متعلق میکولر تنزل کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ علامات میں پڑھنے یا ٹی وی دیکھنے میں بڑھتی دشواری، یا مسخ شدہ بینائی شامل ہو سکتی ہے جس میں سیدھی لکیریں لہراتی نظر آتی ہیں یا چیزیں عام سے بڑی یا چھوٹی لگتی ہیں۔

ٹریخوما (Trachoma) (تلفظ: truh-ko-muh) اس وقت ہوتا ہے جب Chlamydia trachomatis نامی ایک بہت متعدی جرثومہ آنکھ میں سوزش پیدا کرتا ہے۔ یہ اکثر غریب دیہی ممالک میں پایا جاتا ہے جن میں بھیڑ بھاڑ والی رہائشی حالتیں اور پانی اور صفائی تک محدود رسائی ہوتی ہے۔ ٹریخوما کی وجہ سے اندھا پن امریکہ سے تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔

2.2.1.2 بصارتی معذوری کے مضمرات (Implications of Visual)

(Impairments)

بصارتی معذور بچوں کی اپنے ماحول سے اتفاقی طور پر سیکھنے کی محدود صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ بینائی کے ذریعے حاصل اور پروسیس ہوتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ 80% تک سیکھنا بصارتی اشاروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ چھونے اور سننے جیسے دیگر حواس بینائی کے نقصان کا مکمل معاوضہ نہیں کرتے۔

بینائی کے نقصان کے نتیجے میں ماحول کی تلاش، سماجی تعامل شروع کرنے اور چیزوں کو جوڑ توڑ کرنے کی کم حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ماحول کی تلاش کی محدود صلاحیت ابتدائی حرکی نشوونما کو متاثر کر سکتی ہے۔

بصارتی معذور طلبہ اپنے دیکھنے والے ساتھیوں کے ساتھ مشترکہ بصارتی تجربات نہیں بانٹ سکتے، اور اس لیے بینائی کا نقصان مناسب سماجی مہارتوں کی نشوونما کو منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے۔

(i) تعلیمی مضمرات (Educational Implications)

سیکھنے کی اکثریت عام طور پر بینائی کے ذریعے ہوتی ہے۔ بینائی کی معذوری والے طالب علم کی مشاہدے اور بصارتی مظاہروں کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی محدود صلاحیت ہو سکتی ہے۔ طالب علم کو نئی

مہارتیں سیکھنے کے لیے دیگر خصوصی حکمت عملیاں استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اس لیے، بینائی کی معذوری طالب علم کی تعلیم کے تمام پہلوؤں کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے، بشمول:

• تعلیمی شعبے

• مواصلات

• نقل و حرکت (mobility)

• آزاد زندگی کی مہارتیں

• سماجی تعاملات۔

انہیں اکثر طالب علم کو واضح طور پر سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، ان طلبہ کو نئے کام سیکھنے کے لیے وقت کی تقسیم میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

بینائی کی معذوری والے طالب علم کے لیے نصاب اور سیکھنے کے ماحول تک رسائی کے لیے، درج ذیل کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ پر غور کرنا پڑ سکتا ہے:

• متبادل فارمیٹ میں سیکھنے کے مواد کی پیشکش

• جماعتی سرگرمیوں اور تشخیصی اشیاء کے لیے متبادل فارمیٹ

• خصوصی آلات بشمول کم بینائی کے معاون آلات یا بریل کا سامان

• معاون ٹیکنالوجی

• کام مکمل کرنے کے لیے دیا گیا وقت

• محفوظ اور آزاد رسائی اور نقل و حرکت کے لیے سیکھنے کے ماحول کے اندر قابل رسائی

• آڈیو ویڈیو مواد کا پیش نظر اور جائزہ لینے کے لیے اضافی وقت اور موقع

• ماحولیاتی حالات جیسے روشنی اور چمک (glare)۔

لکھنے کا مواد (Writing materials)

اندھے بچے بریل لکھنے کے لیے پرکنز بریلر (Perkins Brailier) استعمال کرتے ہیں اور حالیہ برسوں میں نئی ٹیکنالوجی کی ایک ریج متعارف کرائی گئی ہے تاکہ بریل ان پٹ سے تقریر اور پرنٹ آؤٹ پٹ فراہم کیا جاسکے۔ ان بچوں کے لیے جن کی کچھ مفید باقی ماندہ بینائی ہو، سفید یا پیلے کاغذ پر گہرا فیلٹ ٹپ پن ضروری تضاد (contrast) فراہم کرے گا، اگر ممکن ہو تو بعد میں گہری نرم سیسے والی پنسل استعمال کرنے کی طرف بڑھتے

ہوئے۔ بڑے بچے کو کاغذ کی ترجیح کے بارے میں اپنا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہونا چاہیے، لیکن چھوٹے بچے کو موٹی لکیروں والے یا مربع خانوں والے کاغذ استعمال کرنے سے مدد مل سکتی ہے۔

پڑھنے کا مواد (Reading materials)

پرنٹ کے سائز کے علاوہ، استعمال شدہ پرنٹ کی کوالٹی اور مقدار پر غور کرنا ضروری ہے۔ کاغذ پر پرنٹ کا سائز، رنگ اور تضاد کوالٹی کا تعین کرتے ہیں اور بنیادی غور ہونا چاہیے۔ پرنٹ کو کم بینائی کے معاون آلے کا استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی میکنیفیکیشن سے بڑا کیا جاسکتا ہے، یا بڑے کرنے والے فوٹو کاپیئر سے لیکن ناقص کوالٹی کی کاپیوں کو بڑا کرنا الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ خامیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میکنیفیکیشن ہمیشہ جواب نہیں ہے کیونکہ میکنیفیکیشن جتنی زیادہ ہوگی، میدان اتنا ہی چھوٹا ہوگا؛ ان بچوں کو جن کے بصارتی میدان محدود ہیں، سب سے چھوٹا ممکن پرنٹ استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ باقی ماندہ بصارتی میدان کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملیں۔

تضاد اور وضاحت ضروری ہیں، ان کتابوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنا ضروری ہے جن میں تصاویر کے اوپر پرنٹ ہو، جو غیر ضروری الجھن پیدا کرتی ہیں۔ کچھ بچے پڑھتے ہوئے اس لائن کے نیچے کارڈ یا رولر رکھنا بھی پسند کر سکتے ہیں اور "پڑھنے کی کھڑکیاں" (reading windows) اس بچے کے لیے خاص طور پر مفید ہو سکتی ہیں جسے کسی لفظ یا پرنٹ کی لائن پر فوکس کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔

ہمیشہ یقینی بنائیں کہ بصارتی معذور بچے کے پاس کام کے مواد کا واحد استعمال ہو، چاہے وہ کتابیں، ڈایا گرام، نقشے وغیرہ ہوں، بانٹنے کی ضرورت سے بچتے ہوئے۔ اسے بصارتی طور پر مشکل کام مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت کی بھی ضرورت ہوگی اور یہاں تک کہ دیگر شاگردوں کے برابر وقت میں آپ واقعی جتنا پڑھنے / لکھنے کی توقع کر سکتے ہیں اس کی مقدار کم کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔

جیسے جیسے بچہ اسکول میں اوپر جاتا ہے، تدریسی معاون کو اپنے طریقوں کو اپنانا پڑ سکتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ بچے کی نصاب تک رسائی برقرار رہے۔ مثلاً، اگر وسیع نوٹ لینے کی ضرورت ہو، چاہے بلیک بورڈ سے، ڈکٹیٹ کیے گئے یا دیگر ذرائع سے، آپ کو درج ذیل میں سے ایک کرنا پڑ سکتا ہے:

1. استاد سے کہیں کہ وہ نوٹس کو بلند آواز میں کہے جیسے وہ انہیں بلیک بورڈ پر لگاتا ہے؛ پھر ضرورت پڑنے پر انہیں ٹیپ ریکارڈ کیا جاسکتا ہے۔

2. استاد سے کہیں کہ وہ آپ کو نوٹس پہلے سے دے دے تاکہ آپ مناسب پرنٹ یا بریل کاپی بنانے کے انتظامات کر سکیں۔

3. بچے کے دوستوں میں سے ایک، ترجیحاً جو صاف ستھرا لکھنے والا ہو، سے کاربن کاپی بنانے کا انتظام کریں یا اس کے نوٹس کی فوٹو کاپی کرانے کا انتظام کریں۔

خصوصی آلات (Specialised Equipment)

بصارتی معذور بچے کو کسی بھی کم بینائی کے معاون آلے (Low Vision Aid - LVA) تک مفت رسائی ہونی چاہیے جو اس کی فعلی بینائی کو بہتر بنائے۔ LVA میں ہاتھ سے پکڑے یا کھڑے میگنیفائر، روشن میگنیفائر، دوربین (binoculars) اور ہاتھ سے پکڑی دوربینیں، عینک، بشمول خصوصی طور پر تجویز کردہ ٹیلی اسکوپک ایڈجمنٹ والی، اور کلوزڈ سرکٹ ٹی وی (CCTV) شامل ہیں جو بلیک / وائٹ اور رنگین ماڈلز میں دستیاب ہے۔ LVA بصارتی معذوروں کے لیے تعلیمی سروس فراہم کرتی ہے (کتابچے کے آغاز میں پتہ دیکھیں) اور CCTVs کے علاوہ بہت سے LVA LVA کلینک سے منسلک آپتھلمک آپٹیشن کے ساتھ مل کر کنسلٹنٹ آپتھلمولوجسٹ مفت تجویز کر سکتا ہے۔ ESVI کی طرف سے قرضے پر دیے گئے CCTV خاص طور پر موافق اور پڑھنے، نقشہ کاری اور یہاں تک کہ مظاہروں کے لیے مفید ہیں۔ CCTV الیکٹرانک طور پر مواد کو ٹی وی اسکرین پر بڑا کرتے ہیں اور زیادہ تر ماڈل ٹائپ رائٹر کو بھی جگہ دے سکتے ہیں۔ اگر تدریسی معاون کو بچے کو اپنے خصوصی LVA کے مؤثر استعمال میں مدد کرنی ہے، تو معاون کو پیری پیٹنٹک سپورٹ ٹیچر سے مشورہ کرنا چاہیے جو مشورہ دے گا کہ بچے کو LVA مؤثر طریقے سے استعمال کرنا کیسے سکھایا جائے۔

استعمال ہونے والے دیگر آلات (Other Equipment Used)

استعمال شدہ آلات کی قسم ظاہر ہے بچے کی بصارتی معذوری کی فطرت اور شدت پر منحصر ہوتی ہے۔ تاہم دیگر آلات جو استعمال ہو سکتے ہیں ان میں درج ذیل میں سے ایک یا کئی شامل ہو سکتے ہیں: ان لوگوں کے لیے پرکنز بریلر جو پرنٹ کے ذریعے بات چیت نہیں کر سکتے، ٹیپ ریکارڈر (شاید متغیر تقریر ایڈجمنٹ یا اسپید کمپرسر کے ساتھ تاکہ سننے کی رفتار تیز کی جا سکے)، بولنے والا کیلکولیٹر، بولنے والا تھرمائیٹر، بریل رولر، بڑے پرنٹ کا ٹائپ رائٹر، چند کے نام لینے کے لیے کیونکہ الیکٹرانک آلات میں حالیہ پیش رفت اتنی متعدد ہیں کہ یہاں بیان نہیں کی جا سکتیں۔

نصاب تک رسائی (Access to the Curriculum)

اسکول میں کام بڑی حد تک بصارتی معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ تحریریں، ڈرائنگ، تصویریں، نقشے، ڈایاگرام، پوسٹر، مظاہرے، ٹی وی اور ویڈیو، تجربات وغیرہ۔ تاہم بصارتی معذور سیکھنے والے کے لیے نصاب تک رسائی صرف چھپے لفظ اور دیگر بصارتی معلومات تک رسائی کے بارے میں نہیں ہے، اگرچہ یہ اہم ہے۔ یہ ان کے تعلیمی تجربات کی کوالٹی کے بارے میں بھی ہے۔

تھوڑی سی مدد، اگر مناسب طریقے سے استعمال کی جائے، تو یہ یقینی بنانے میں بہت دور تک جا سکتی ہے کہ ان کے سیکھنے کے تجربے کی کوالٹی ان کے عام طور پر دیکھنے والے ساتھیوں کے مقابلے میں متاثر نہ ہو۔ اس حصے میں ہم سیکھنے کے مضمرات اور اس قسم کی مدد کو دیکھیں گے جس کی بصارتی معذور بچے کو عام مین اسٹریم نصاب تک رسائی کی کوشش میں ضرورت ہو سکتی ہے۔

پڑھنا (Reading)

ظاہر ہے کہ بصارتی معذور بچے ایک نظر میں عام طور پر دیکھنے والے بچے کی طرح اچھی طرح یا اتنا زیادہ نہیں دیکھتا۔ پرنٹ کی کوالٹی اور سائز چھوٹے بچے کی پڑھنے کی حوصلہ افزائی میں تمام فرق ڈالے گا اور ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ تمام بچے ان کتابوں کے ساتھ بصارتی طور پر آرام دہ ہوں جو ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ہماری سروس بصارتی مشکلات والے انفرادی بچوں کے لیے بہترین پرنٹ سائز پر مشورہ دینے میں خوش ہوگی۔

یہ بچے بڑے ہوتے ہوئے پڑھنے میں زیادہ مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں جب ان سے پرنٹ کے کم ہوتے سائز کے ساتھ بڑھتی مقدار میں متن پڑھنے کی توقع کی جاتی ہے۔

ٹاپ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے طلبہ کے لیے بہت اچھی طرح تیار کردہ بڑے پرنٹ کے فلکشن کی بڑھتی رینج موجود ہے۔ ہماری سروس کے پاس قرضے کے لیے ایسی کتابوں کی رینج ہے یا درخواست پر دیگر عنوانات کو اسی طرح دوبارہ تیار کرنے کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔

آرام دہ سائز کے پرنٹ کے باوجود، ان کی بصارتی معذوری ان بچوں پر عام صورت سے سست پڑھنے کی رفتار عائد کر سکتی ہے۔ زیادہ جسمانی کوشش کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور یہ بدلے میں توجہ اور فہم کی سطحوں کو متاثر کر سکتا ہے۔

پڑھنے کے طویل مسلسل ادوار الٹا نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے مرکوز "دھماکے" بہتر نتائج دے سکتے ہیں۔

"خواندگی کے گھنٹے (Literacy Hour)" میں یہ بہت مددگار ہے اگر ہمارا طالب علم "بڑی" کتاب کی انفرادی کاپی تک رسائی حاصل کر سکے۔ چھوٹے بچے اپنی پڑھنے کی کتابوں کے ٹیپ شدہ ورژن سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ خاص طور پر اگر ان کے "پسنیدہ" استاد یا معاون معاون نے تیار کیا ہو۔

اگر آپ بہت سارا بورڈ کا کام کر رہے ہیں تو ڈیسک کاپیوں کی فراہمی پر غور کریں اور چھوٹے متن، ڈایا گرام یا گرافک تفصیل شامل کسی بھی سیکھنے کے مواد، اینڈ آؤٹس وغیرہ کی بڑھائی پر بھی غور کریں۔ بصارتی معذور شاگردوں کے لیے سیکھنے کے مواد کو مختلف بنانے پر مزید رہنمائی اس کتابچے کے اگلے "تدریسی حکمت عملی" حصے میں شامل ہے۔

میگنیفیکیشن کے معاون آلات متن کے چھوٹے ٹکڑوں یا مشکل بصارتی تفصیل کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں لیکن انہیں طویل پڑھنے کے کاموں کے لیے بنیادی معاون آلات نہیں سمجھنا چاہیے۔

لکھنا (Writing)

بصارتی معذور بچے اکثر اپنے حروف کی تشکیل سیکھتے وقت بری عادتیں پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ قدرتی طور پر بصارتی طور پر اشارہ پانا پسند کریں گے اور تمام حروف لائن سے شروع کرنے کا رجحان رکھیں گے (اگر آپ لائنیں استعمال کر رہے ہیں)۔

اس لیے لائن کے اوپر شروع ہونے والے حروف کے لیے ایک نظر آنے والا نقطہ آغاز مددگار ہو سکتا ہے۔ کاغذ کا خالی ٹکڑا ان بچوں کے لیے کافی چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے لائنیں (کافی گہری) بچے کی تحریر کو صفحے پر رہنمائی کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔

حاشیہ بھی تحریر کی ہر نئی لائن کے لیے مفید نقطہ آغاز دیتے ہیں۔

ٹیپ (Tape)

ناقص بینائی والے بچے کے لیے لکھنا بہت تھکا دینے والا عمل ہو سکتا ہے۔ اپنی تحریر پڑھنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہو سکتا ہے! یہ افسوس کی بات ہے کہ بچے کی تخلیقی صلاحیت اس کی لکھنے کی صلاحیت (یا بصورت دیگر) سے محدود ہو۔ ان بچوں کے لیے جنہیں واقعی "کاغذ پر اتارنے" میں مسئلہ ہو تو شاید معاون معاون کے ساتھ مل کر ٹیپ ریکارڈنگ استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ نتیجے کو "لکھا" اور/یا ورڈ پروسیس کیا جاسکے۔ ڈکٹافون اب کافی سستے خریدے جاسکتے ہیں۔

ورڈ پروسیسنگ (Word Processing)

ورڈ پروسیسنگ بصارتی معذور بچے کے لیے اپنا کام ریکارڈ کرنے اور اعلیٰ کوالٹی کی پیشکش حاصل کرنے (اور درست سچے!) کا بہت مفید طریقہ ہو سکتا ہے۔ اچھی ٹیچ ٹائپنگ کی مہارتیں ظاہر ہے لکھنے کے بصارتی تقاضوں کو کم کر دیں گی اور پرائمری مرحلے میں کی بورڈ اور ٹیچ ٹائپنگ کی مہارتوں کے تعارف پر غور کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ ناقص بینائی اور اچھی کی بورڈ مہارتوں والے کچھ طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کیا جاسکتا ہے جب انہیں تیار سمجھا جائے۔ یہ انہیں اپنا کام اچھی طرح پیش کردہ شکل میں ریکارڈ کرنے کے قابل بناتا ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔

اگر کسی طالب علم کے پاس ذاتی لیپ ٹاپ ہو تو کام کی اسائنمنٹس بھی ان کے لیے کی بورڈ سے داخل کی جا سکتی ہیں (استاد یا معاون عملے کے ذریعے) ان کی پسند کے پرنٹ سائز میں۔

کمپیوٹر تک رسائی (Computer Access)

بصارتی معذور بچے کے لیے کمپیوٹر تک رسائی کو بہتر بنانے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے بڑے ہائی کنٹراسٹ کی اسٹیکرز، بڑا کی بورڈ، کانسیپٹ کی بورڈ اور ورڈ پروسیسنگ کے لیے بڑے پرنٹ کا استعمال۔

کر سز کو بھی زیادہ نظر آنے والا بنایا جاسکتا ہے اور اسکرین پر میگنیفیکیشن یا تقریر آؤٹ پٹ فراہم کرنے کے لیے خصوصی سافٹ ویئر بھی دستیاب ہے۔

کمپیوٹر پر کام کرتے وقت مانیٹر اسکرین میں کھڑکیوں یا چھت کی روشنیوں کی وجہ سے ہونے والی ناگوار عکاسیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان مسائل کو بڑی حد تک ختم کیا جاسکتا ہے اگر، پہلے تو کلاس روم میں موثر پردے ہوں، اور دوسرے اگر بچہ اسکرین کو آنکھ کی سطح پر رکھے۔ اگر شک ہو تو شاگرد کی سطح پر نیچے جائیں اور دیکھیں کہ ان کے لیے یہ کیسا ہے۔

ہجے (Spelling)

ہم میں سے بہت سے لوگ بصارتی طور پر جانچنا پسند کرتے ہیں اگر ہمیں کسی ہجے کے بارے میں یقین نہ ہو۔ یہ VI طلبہ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ بصارتی جانچ اتنی آسان یا درست نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے پاس اچھے بصارتی ہجے کے "ماڈل" ہوں۔

ریاضی (Maths)

ریاضی بصارتی معذور شاگردوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں تفصیلی اور عملی کام شامل ہوتا ہے۔ مثالیں اکثر بورڈ پر حل کر کے دکھائی جاتی ہیں اور ان پیشکشوں اور مثالوں کو انفرادی ڈیسک کاپی کے طور پر دہرانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

ریاضی میں شامل بہت سے موضوعات تسلسل وار سیکھنے (یعنی کچھ علم پر مبنی نئی سیکھ) پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا تصورات مکمل طور پر سمجھے گئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کچھ اضافی 1:1 وقت کمک کے لیے درکار ہو سکتا ہے۔

پرائمری سطح پر متعدد "ٹھوس" سیکھنے کے معاون آلات ہیں جو مددگار ہو سکتے ہیں۔ مثلاً Cuisenaire راڈز، unifix کیوبز، میگ بورڈز، نمبر سیٹس، ہنڈرڈ اسکوائرز۔

کچھ خصوصی وسائل کچھ شاگردوں کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں۔ ان میں بولنے والے اور بڑے ڈسپلے والے کیلکولیٹر، چھونے والے رولر اور پروٹریکٹر شامل ہوں گے۔ گراف ورک اور جیومیٹری جیسے موضوعات درکار تفصیل کی وجہ سے بہت مشکل ہو سکتے ہیں۔ رولر یا پروٹریکٹر جیسے چھوٹے پیمانوں کو پڑھنے کے لیے میگنیفیکیشن کے معاون آلات مددگار ہو سکتے ہیں۔ گہرے مربع خانوں والی مشق کی کاپیاں اور زیادہ نظر آنے والا گراف پیپر خصوصی سپلائرز سے خریدا جاسکتا ہے۔

سائنس (Science)

ریاضی پر جو کچھ لاگو ہوتا ہے اس میں سے زیادہ تر یہاں بھی لاگو ہوگا۔ سائنس کے اسباق زیادہ مسئلہ خیز ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں عملی کام کی نمایاں مقدار شامل ہوتی ہے۔

کم بصارتی تیزیت یا گہرائی کے ادراک سے منسلک مسائل سائنس میں عملی کام کو کافی مشکل بنا سکتے ہیں خاص طور پر کیونکہ کنٹینر وغیرہ اکثر بے رنگ شیشے یا پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں اور تجربات میں چھوٹے آلات کو جوڑ توڑ کرنے اور کافی تفصیلی بصارتی فیصلوں کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔

بصارتی معذور طلبہ کے لیے عملی کام میں مکمل طور پر شامل ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے ہم جماعتوں جیسا سیکھنے کا تجربہ ہو۔ بد قسمتی سے، حقیقت میں، یہ غیر معمولی نہیں ہے کہ وہ لفظی طور پر پچھلی نشست لے لیں اور دوسروں کو آگے بڑھنے دیں جب جوڑوں یا چھوٹے گروہوں میں تجربہ کیا جا رہا ہو۔

چند تجاویز:

• تھرمایٹر یا پیمائشی فلاسک کے سچھے رکھا گیا متضاد کارڈ کا ٹکڑا تضاد بڑھا سکتا ہے اور پڑھنے کو آسان بنا سکتا ہے۔

• تقریر آؤٹ پٹ اسکیلز اور بڑے ڈسپلے والے تھرمایٹر دستیاب ہیں۔

• پانی میں نظر بڑھانے کے لیے فوڈ کلرنگ شامل کی جا سکتی ہے۔

• Blu-tack چیزوں کو نیچے پکڑنے یا چھونے والے نشان کے طور پر کام کرنے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔

• حادثات سے بچا جا سکتا ہے پیمائشی فلاسکس کے اوپری حصوں کو نمایاں کر کے (پینٹ یا ٹیپ)۔ خاص طور پر لمبے والوں کے۔

• اگر چشمے پہننے ہوں، تو بصارتی دشواری والے کسی بھی طالب علم کے لیے اچھی خراش سے پاک جوڑی محفوظ رکھیں۔

ڈیزائن اور ٹیکنالوجی (Design and Technology)

عملی کام کے حوالے سے مذکورہ بالا کا زیادہ تر حصہ DT اسباق پر بھی لاگو ہوگا۔

استعمال شدہ آلات کی رینج اور فطرت کی وجہ سے یہاں صحت اور حفاظت کا ایک اضافی مسئلہ شاید ہو۔ ہمارے طالب علم کو قریبی نگرانی میں تربیت پانے کے لیے مزید وقت درکار ہو سکتا ہے، تاکہ وہ اس آلات سے واقف ہو سکے۔

کچھ الیکٹرانک آلات اب بڑے ڈسپلے یا تقریر ریڈ آؤٹ میں دستیاب ہیں۔
کچھ تفصیلی بصارتی کاموں کے لیے، مثلاً سولڈ رنگ، پلگ یا سرکٹ بورڈ کی وائرنگ، میکنیفیکیشن کے معاون آلات مفید ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایسے معاون آلات جو عینکوں پر "کلیپ آن" ہوتے ہیں ("wantelmakers" "glass") خاص طور پر کیونکہ اس قسم کا معاون آلہ اکثر ورکشاپ کی صورتحال میں عام کلاس روم کی نسبت (طلبہ کے ادراک میں) زیادہ قابل قبول ہوگا۔

انسانیات (Humanities)

جغرافیہ اور تاریخ دونوں پڑھنے اور بصارت پر مبنی مضامین ہیں۔ وہ تصورات اور تجربات پر بھی انحصار کرتے ہیں جنہیں کلاس روم میں لانا مشکل ہے اور یہ ان طلبہ کے لیے مشکل بنا سکتا ہے جنہیں پہلے ہاتھ کے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے۔

کسی بھی قسم کے فیلڈ ٹرپ بصارتی معذوری والے شاگردوں کے لیے انمول ہونے والے ہیں۔ ان موقع پر معاون معاون کی مدد بہت ضروری ہوگی۔ نہ صرف غیر مانوس ماحول میں حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بلکہ ایسی معلومات کی وضاحت، تشریح اور کمک کے لیے بھی جو بصورت دیگر بصارتی معذور شاگرد سے آسانی سے چھوٹ سکتی ہیں۔

نقشے کا کام ہمیشہ مشکل ہونے والا ہے۔ نقشے کو بڑا کرنا ہمیشہ مدد نہیں کرے گا۔ تمام اسکولوں کے پاس رنگین فوٹو کاپیئر نہیں ہوتا! سوال میں مخصوص تفصیل کو بڑا کرنے کے لیے چھوٹا ڈوم میکنیفائر استعمال کرنا شاید بہتر ہوگا۔

تاریخ میں، میوزیم کے دورے یا نوادرات کا استعمال قیمتی ہاتھوں سے تجربات دے سکتا ہے۔ تاریخی مآخذ مواد اکثر غیر واضح اور بصارتی طور پر تشریح کرنا مشکل ہو سکتا ہے (عام طور پر بلیک اینڈ وائٹ)۔ نقشوں کی طرح وہ اکثر بڑے کرنے کی بجائے اپنی اصل شکل میں بہتر ہوں گے بجائے اس کے کہ اچھے میکنیفیکیشن معاون آلے کے استعمال سے دیکھے جائیں۔ ان اسباق میں ویڈیو مواد اکثر دیکھا جاتا ہے اور یہ ہمارے طلبہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ انہیں مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک سے زیادہ بار دیکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

جسمانی تعلیم اور کھیل (Physical Education and Games)

واضح طور پر PE اور کھیلوں کے نصاب کے ایسے عناصر ہوں گے جو بصارتی معذور شاگرد کے لیے مشکل ثابت ہوں گے۔

بہت سی انفرادی سرگرمیاں (جمناسٹکس، تیراکی، ایتھلیٹکس، کراس کنٹری رینگ، سرکٹ ٹریننگ وغیرہ) دیگر گروہی یا ٹیم سرگرمیوں جیسے ٹینس، باسکٹ بال، ہاکی، فٹ بال وغیرہ کے مقابلے میں بہت آسان ہوں گی، جن میں نہ صرف اچھی بینائی بلکہ موثر ہاتھ آنکھ کو آرڈینیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

PE اساتذہ کو اپنے گروہوں میں انفرادی شاگردوں کے مضمرات سے آگاہ ہونا چاہیے جو بصارتی طور پر معذور ہیں اور جو رعایت کر سکتے ہیں کریں۔ یہ بچے کی بصارتی معذوری کی مخصوص فطرت پر منحصر ہو سکتا ہے اور اس بارے میں مشورہ ویژن سپورٹ ٹیم سے دستیاب ہوگا۔

عام طور پر، ہدایات واضح ہونی چاہئیں اور دی گئی کسی بھی مظاہرے کے دوران بچہ قریب ہو۔

سیکنڈری اسکولوں میں گیند کے کھیلوں پر بڑھا ہوا زور ہوتا ہے۔ یہ اکثر ہمارے شاگردوں کے لیے مشکل پیش کرتے ہیں۔ ان کھیلوں کے لیے ہائی کنٹراسٹ گیندیں استعمال کرنا ہمیشہ مددگار ہوتا ہے۔ بہترین رنگ اس پر منحصر ہو سکتا ہے کہ کھیل اندر ہے (جم یا اسپورٹس ہال کا ماحول) یا باہر، جس میں مختلف رنگ کی سطحیں (آل ویدر، گھاس، ٹارمیک وغیرہ) اور "آسمان" کے پس منظر کا بڑا حصہ شامل ہو سکتا ہے۔

عام طور پر جم کے لیے سفید گیند اور باہر کے لیے نارنجی گیند انگوٹھے کا اچھا اصول ہے۔

سماجی مہارتیں (Social Skills)

بصارتی معذور بچے اکثر اچھے ساتھی گروہ تعلقات بنانے کے لیے درکار سماجی مہارتوں سے بے خبر (سمجھ پیدا کرنے میں سست) ہو سکتے ہیں۔

وہ اکثر وجہ اور اثر کے تعلقات یا اچھے اور نامناسب رویے کے درمیان فرق کا مشاہدہ کرنے میں اچھے نہیں ہوتے۔ یہی ان کی اپنی ذاتی دیکھ بھال اور حفظان صحت پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ انہیں ان تمام معاملات میں اپنے مکمل دیکھنے والے ساتھیوں سے زیادہ مدد اور رہنمائی کی جائز ضرورت ہو سکتی ہے۔

آزاد نقل و حرکت اور روزمرہ زندگی کی مہارتیں (Independent Mobility and Daily Living Skills)

یہ امکان ہے کہ اگر آپ نوجوان بصارتی معذور بچوں کو پڑھاتے ہیں تو انہیں اپنی عمر اور صلاحیت کے مناسب آزادی اور زندگی کی مہارتیں پیدا کرنے میں کچھ مدد دے گا ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ ان طلبہ کی خود کی مدد کرنے میں مدد کی جائے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جتنا ممکن ہو (محفوظ طریقے سے) آزاد بنیں۔

اندھے بچوں یا شدید بصارتی معذوری والوں کے لیے ہماری ٹیم میں نقل و حرکت کا ماہر شامل ہے جس کا کردار ان بچوں کو ایسی مہارتیں پیدا کرنے کے قابل بنانا ہے جو انہیں محفوظ آزاد مسافر بننے کے قابل بنائیں گی۔

اسکول کا ماحول (The School Environment)

تمام شاگردوں کے لیے زندگی کو جتنا ممکن ہو بصارتی طور پر آرام دہ بنانے کے حوالے سے وسیع تر اسکول ماحول پر غور کرنا ضروری ہے۔

کچھ عام موضوعات ہیں جو اسکول کے تمام علاقوں پر لاگو ہوں گے اور یہ ضروری ہے کہ بصارتی ماحول پر غور کرتے وقت اپنی توجہ صرف کلاس روم تک محدود نہ رکھیں۔ اسکول کے تمام مختلف حصوں میں حفاظت، قابل رسائی اور موقع کی برابری کے مسائل ہوں گے۔

سیڑھیاں اور زینے (Steps and Stairs)

یہ شاید بصارتی معذور شاگرد کے لیے اسکول کی سب سے ممکنہ طور پر خطرناک خصوصیات ہیں۔ خاص طور پر کنکریٹ کی باہر کی سیڑھیاں ممکنہ طور پر اینڈریل کے بغیر۔ تقسیم شدہ سائٹ یا بڑے کیپس اسکولوں میں، یہ سیڑھیاں اسباق کے درمیان اکثر بہت مصروف گزرگاہیں بن سکتی ہیں۔

بصارتی معذور شاگردوں کے لیے یہ بہت مددگار ہوگا اگر ان سیڑھیوں کو ہر سیڑھی کے اگلے کناروں پر تقریباً دو انچ سفید یا پیلے پینٹ سے نمایاں کیا جائے۔ کم از کم ایک طرف اینڈریل بھی ہونی چاہیے۔

اندرونی زینے کو مستقل طور پر نمایاں کرنا اتنا آسان نہیں لیکن یہ ہائی کنٹراسٹ چمکنے والی ٹیپ سے کیا جاسکتا ہے۔ مصروف زینوں کو وقتاً فوقتاً دوبارہ ٹیپ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس قسم کی نمایاں کاری کو برقرار رکھنا ضروری ہے کیونکہ جزوی طور پر نمایاں زینے کافی خطرناک ہو سکتے ہیں۔

نشانات اور لیبل (Signs and Labels)

کسی بھی اسکول کے ارد گرد مختلف کمروں اور شعبوں کی شناخت کے لیے اور ان کے استعمال کی نشاندہی کے لیے بہت سے مختلف نشانات اور لیبل ہوں گے۔ دوبارہ وضاحت اور تضاد کے وہی اصول لاگو ہوں گے۔ گہرا پس منظر عام طور پر نظر کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ نشانات اور لیبلز کی جگہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ آنکھ کی سطح پر بصارتی طور پر قابل رسائی ہوں۔ واضح لیبل کو دروازے کے اوپر لگا کر اس کی نظر کو خراب کرنا افسوس کی بات ہوگی۔

سیکھنے کا ماحول - کلاس روم (The Learning Environment - the classroom)

ذیل میں ان اساتذہ کے لیے کچھ عمومی غور و فکر ہیں جو اپنے کلاس روم کے ماحول کو بصارتی معذور شاگردوں کے لیے "صارف دوست" بنانا چاہتے ہیں۔

آپ کے کلاس روم کا بصارتی ماحول ایک اہم عنصر ہے جو آپ کے تمام بچوں کی سیکھنے میں مدد یا رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔

آپ کے کلاس روم کی بہت سی خصوصیات ہوں گی جن کے ساتھ آپ پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً مقام، رخ، شکل اور سائز، دروازوں اور کھڑکیوں کی پوزیشن، چھت کی اونچائی۔

تاہم کلاس روم کے بصارتی ماحول کی دیگر خصوصیات ہو سکتی ہیں جنہیں بہتر بنایا جاسکتا ہے اور یہ اچھا خیال ہو سکتا ہے کہ اپنے کمرے کا فوری آڈٹ کریں تاکہ دیکھیں کہ وہ درج ذیل رہنما خطوط کے مقابلے میں کیسا ہے۔

روشنی (Lighting)

زیادہ تر اسکولوں میں روشنی کی سطح کافی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ اکثر مصروف ترین علاقے ہیں۔ راہداریاں، کلوک روم اور نازک طور پر، زینے (اوپر اور نیچے) جن میں اکثر روشنی کی سب سے ناقص سطح ہوتی ہے جو اکثر انہیں کلاس رومز سے کہیں زیادہ "تناؤ والے" علاقے بناتی ہے۔

بصارتی معذوری کی ایک عام علامت روشن عکاسی شدہ روشنی یا چمک کے لیے حساسیت ہے اور اس سے متعلق شکایات ہمارے بصارتی معذور طلبہ سے ہمیں ملنے والی سب سے عام شکایات میں شامل ہیں۔ تو... آپ کے کلاس روم میں:

- کیا سورج کبھی کھڑکی میں چمک پیدا کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے؟
- کیا روشنی کی سطح مختلف کی جاسکتی ہے۔ کیا آپ کے کلاس روم کی لائٹیں الگ الگ سوچتی ہیں یا یہ سب یا کچھ نہیں ہے؟
- کیا کھڑکیوں پر پردے یا کرٹن ہیں۔ کیا وہ کام کرتے ہیں۔ کیا وہ مؤثر طریقے سے استعمال ہوتے ہیں؟
- کیا آپ کے کلاس روم میں غیر روشن علاقوں کے تالاب ہیں جو کبھی کبھی کافی تاریک لگ سکتے ہیں؟
- کیا کمرہ اچھی طرح روشن ہے جو اسے اچھی مجموعی روشنی دیتا ہے؟ اگر آپ کے پاس فلوروسینٹ لائٹنگ ہے تو کیا یہ مؤثر طریقے سے پھیلی ہوئی ہے؟

اگرچہ بصارتی معذور بچے چمک کو ناپسند کرتے ہیں انہیں پھیلی ہوئی مصنوعی روشنی کی اچھی مجموعی سطح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ننگی فلوروسینٹ ٹیوبیں اکثر براہ راست سورج کی روشنی کی طرح تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔

آپ کے کلاس روم میں چمک اور عکاسی شدہ روشنی کی مقدار کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو چمکدار سطحوں (فرش سمیت) سے بچیں اور کھڑکیوں پر پردے لگائیں جو کام کریں۔ بد قسمتی سے بہت کم

پردے (خاص طور پر بہترین والے) "بچوں کے ثبوت" لگتے ہیں - سب سے کامیاب شاید رولر قسم کے ہیں جو دیگر اقسام سے تھوڑے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔

پھیلی ہوئی اوپر کی روشنی کی اچھی سطح آپ کے کلاس روم میں تمام بصارتی مواد اور پیشکشوں (دور اور قریب) کی وضاحت اور تضاد میں بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ ناقص بینائی والے بچوں کی درخواستوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں کہ کلاس روم کی لائٹیں اس سے بہت پہلے جلا دی جائیں جب دوسرے ضروری سمجھیں۔

سجاوٹ (Decor)

سجاوٹ روشنی سے بہت زیادہ باہمی متعلق ہے۔ سجاوٹ میں دیواریں، فرش، چھتیں، فرنیچر، ڈسپلے اور لوگ جیسی خصوصیات شامل ہوں گی۔ اسکول کے ارد گرد بہت سے علاقوں میں ایک بڑا مسئلہ دیواروں اور چمکدار سطحوں سے عکاسی شدہ روشنی سے پیدا ہونے والی چمک کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے کلاس روم میں روشنی کو جذب کرنے کے لیے رنگ کا استعمال آپ کے شاگردوں کے بصارتی آرام میں بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ اور بہت مہنگا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی دیواروں کے لیے پیسٹل شیڈز - عالمگیر میگنولیا کی بجائے - بہت "پرسکون" ماحول پیدا کریں گے۔ دوسری طرف بولڈ رنگ اکثر استعمال ہونے والے اسٹوریج علاقوں کی شناخت میں مدد کر سکتے ہیں۔ وہ دروازوں، نوٹس بورڈز، لائٹ سوئچز وغیرہ کو "فریم" کرنے کے لیے بھی مفید ہو سکتے ہیں۔

بصارتی ڈسپلے (Visual Displays)

تمام بصارتی ڈسپلے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اگر وہ اچھی طرح فاصلے پر ہوں اور مضبوط متضاد پس منظر پر لگے ہوں۔ گہرے رنگ بہترین ہیں۔ یقینی بنائیں کہ اہم معلومات (خاص طور پر اگر اسے پڑھنے کی ضرورت ہو) آنکھ کی سطح پر لگی ہو اور ایسی پوزیشن میں ہو جس تک قریب سے رسائی ہو سکے۔ بچہ ضرورت پڑنے پر انگلی سے اشارہ کرنے کے قابل ہو۔

اسٹوریج کے علاقے (Storage Areas)

بصارتی معذور بچوں کو آپ کے کلاس روم میں آزادانہ طور پر کام کرنے اور خود کو منظم کرنے میں مدد کے لیے یہ مددگار ہوگا اگر تمام اسٹوریج کے علاقے (پنسل، رولر، قینچی وغیرہ وغیرہ) آسانی سے قابل رسائی، مستقل طور پر استعمال شدہ اور واضح طور پر لیبل شدہ ہوں۔

لاکرز اور پیگز (Lockers and Pegs)

بصارتی معذور بچے کے ٹرے لاکر یا کلوک روم پیگ کے لیے بہترین پوزیشن کے بارے میں سوچنا بھی ضروری ہے تاکہ انہیں بھیڑ والے علاقوں میں الجھن سے بچنے اور جتنا ممکن ہو آزاد بننے میں مدد ملے۔ اکثر بہترین جگہ واضح ہوگی جیسے ٹرے کے لیے اوپر کا کونایا بچے کے کوٹ کے لیے دروازے کے قریب "آخری" پیگ۔

ایک سمجھدار "یگنز اور کوٹس" پالیسی - خاص طور پر سیکنڈری اسکول میں زمینی سطح پر بے ترتیبی سے بچنے اور آپ کے VI طلبہ کے لیے کم ممکنہ مشکلات پیدا کرنے میں مدد کرے گی جو زمینی سطح پر رکاوٹوں سے ٹھوکر کھانے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گے۔

صوتی ماحول (Acoustic Environment)

یاد رکھیں کہ بصارتی معذور شاگرد سماعتی ان پٹ پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو کلاس اور اسکول کے صوتی ماحول کو بہتر بناتی ہے وہ سماعت اور بصارتی معذور دونوں شاگردوں کے لیے مددگار ہوگی۔ قالین، کرٹن، کیشن یا نرم فرنشنگ کا استعمال اور ہموار عکاسی شدہ سطحوں کی مقدار میں کمی تمام فرق ڈال سکتی ہے۔

(ii) فعلی مضمرات (Functional implications)

ایک متعدد معذور طالب علم جو آنکھ کی حرکتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نشانات چھوٹ دے گا، آنکھ سے آنکھ کا رابطہ نہیں کرے گا، اور بصارتی مقامی معلومات اتنی آسانی سے جمع نہیں کرے گا جتنی عام طور پر دیکھنے والا بچہ (اور اس لیے کم درست مقامی تصورات ہوں گے)۔ ان تمام مضمرات کا مطلب ہے کہ متعدد معذور بچے کو خلا میں سفر کرنے میں دشواری ہوگی۔ نسٹاگمس (nystagmus) والا بصارتی معذور بچہ زیادہ معذور لگتا ہے (صرف اوکو لوموٹر مہارتوں پر غور کرتے ہوئے) جتنا وہ واقعی ہے۔ نسٹاگمس میکولر نقصان والے طالب علم کے لیے ضروری آنکھ کی حرکت ہے۔ اسٹرابزمس کے زیادہ سنگین مضمرات ہیں۔ یہ مستقل ایمبلیوپیا کا باعث بنتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مڑی ہوئی آنکھ میں فعلی (یعنی تمام عملی مقاصد کے لیے "حقیقی") اندھا پن ہوگا۔ ایمبلیوپک آنکھ تقریباً 20/200 تیزیت کے ساتھ کام کرے گی جب اچھی آنکھ کوپٹی باندھی جائے، لیکن جب دونوں آنکھیں کھلی ہوں تو وہ "اندھی" ہوگی۔ مضمر یہ ہے کہ بصارتی معذور بچہ جسم کے ایمبلیوپک طرف پیش آنے والی تمام چیزوں کے لیے اندھا ہوگا (کلاس روم کے کام کے لیے اچھا نہیں، اور سڑکیں پار کرنے کے لیے اچھا نہیں)۔

بصارتی نظام کو متاثر کرنے والی معذوریوں (Impairments Affecting the Optical System)

آئرس (iris) آنکھ کا رنگین حصہ ہے۔ یہ ایک اسفنکٹر پٹھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب یہ آرام کرتا ہے تو کھلتا ہے، اور جب یہ سکڑتا ہے تو بند ہوتا ہے۔ آئرس میں وہ سوراخ جو بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے پتلی (pupil) کہلاتا ہے۔ آئرس کو نقصان کے نتیجے میں پٹھے کی سرگرمی کم ہو جاتی ہے؛ یا تو یہ سست رد عمل کرتا ہے (آہستہ کھلتا اور بند ہوتا ہے)، یا بالکل رد عمل نہیں کرتا۔

آنکھ میں لینز کو نقصان غیر ملکی کیمیکلز، عمر بڑھنے اور صدمے سے ہو سکتا ہے۔ جب نقصان سفید، ڈی نیچرڈ پروٹین کو لینز پر دھبے کا سبب بنتا ہے، تو ڈاکٹر رپورٹ کرتے ہیں کہ مریض کو موتیا ہے (ڈی نیچرڈ پروٹین کے لیے ان کا نام)۔ موتیا، خاص طور پر اگر وہ لینز کے مرکز میں ہوں، روشنی (اور بصارتی معلومات) کی آنکھ سے ترسیل میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ پرانے لینز والی آنکھیں (45 سے بڑی عمر کے لوگ) یا موتیا والی، کمزور فوکس بدلتی ہیں یا بالکل نہیں بدلتیں۔

وٹریس (vitreous) کا آنکھ کی اضطراری حالت پر تھوڑا اثر ہوتا ہے، لیکن لینز اور قرنیہ کے مقابلے میں اتنا نہیں کہ نمایاں ہو۔ جب ریٹینل نالیاں ٹوٹتی ہیں تو وٹریس خون سے بھر سکتا ہے۔ یہ ٹشو کے ٹکڑوں سے بھی آلودہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر کچھ عوارض میں۔ خون اور ملبہ وٹریس سے دھویا جاسکتا ہے کیونکہ سیال تازہ ہوتا ہے، یا سنگین صورتوں میں سرجیکل تبدیلی کی جاسکتی ہے۔

پیدائشی اسامانیاتیں آنکھوں کی ساخت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ کبھی کبھی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں (micro-ophthalmia) اور کبھی کبھی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور ابھری ہوئی لگتی ہیں (یہ اکثر تھائرائیڈ کے مسئلے سے متعلق ہوتا ہے)۔ اگر آنکھ کی ساخت متاثر ہو، تو ایکوئس (aqueous) اور وٹریس کے لیے نکاسی کے نظام بند ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں گلوکوما ہوتا ہے۔ گلوکوما آنکھ میں سیال کا جمع ہونا ہے جو یا تو نکاسی کے نظام کی رکاوٹ سے ہوتا ہے، یا ان آنکھوں سے جو پرانے سیال کو فلٹر کرنے سے تیز یا سیال پیدا کرتی ہیں۔ ساختی نقصان پتلی یا لینز کے عمل کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔

قرنیہ کے داغ، موتیا، وٹریس اور ایکوئس میں خون یا ملبہ، سب آنکھ میں آنے والی بصارتی معلومات کے گزرنے کو روکتے ہیں۔ اگر عکاسی شدہ روشنی کے نمونے ریٹینا کو مکمل اور بغیر مسخ کے نہ ماریں، تو بصارتی معلومات کو درست طریقے سے پروسیس نہیں کیا جاسکتا۔

گلوکوما سیال کے دباؤ کو آنکھ کے پچھلے حصے کے خلاف دھکیلنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے، تو ریٹینل خلیے ایک نمایاں انداز میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بصارتی میدان کے نقصانات کے نتیجے میں ابتدائی طور پر اندھے دھبے ہوتے ہیں، جو ٹنل ویژن کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اندھا پن۔

موتیا سیال میڈیم میں تیرتا ہوا سخت مادہ ہے۔ جب موتیا موجود ہو، تو فوکس کرنے کی کم صلاحیت کی توقع کریں۔ موتیا بینائی کو سب سے زیادہ اس وقت روکے گا جب وہ براہ راست آنکھ کے محور کے ساتھ واقع ہو۔

اگر وہ لینز کے کنارے پر ہو، تو شاید بینائی کو نمایاں طور پر متاثر نہیں کرے گا۔ آئرس کو نقصان چمک کو منظم کرنے کی صلاحیت میں خلل کا سبب بنتا ہے۔

Retinal Impairments Affecting the Visual System (System)

غذائی کمی ریٹینل سطح پر منتخب طور پر مرکزی بینائی کو تباہ کر سکتی ہے۔ دیگر عوارض بنیادی طور پر پردی پروسیسنگ نظام پر اثر ڈالتے ہیں۔ ریٹینائٹس پگمنٹوسا (Retinitis pigmentosa) ابتدائی طور پر پردی خلیوں کو تباہ کرتا ہے۔ قبل از وقت پیدائش کی ریٹینوپیتھی (retinopathy of prematurity) جیسی حالتیں اکثر پردی ریٹینا کے حصوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور مرکزی بینائی کو بچا لیتی ہیں۔

Optic Nerve Impairments Affecting the Visual System (Tracts)

ٹیومر جو آپٹک ٹریکٹس پر دباؤ ڈالتے ہیں خون کی فراہمی کو کاٹ دیتے ہیں اور اسکیمیا (ischemia) کا باعث بنتے ہیں، اس طرح بینائی کو متاثر کرتے ہیں۔ پیوٹری گلیڈ آپٹک کیا زم (optic chiasm) کے قریب واقع ہے اور اکثر ملوث ہوتا ہے جب مخصوص ریٹینل سطح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں (ایک آنکھ میں پیپلیڈیما (papilledema) اور دوسری میں آپٹک ایٹروفی (optic atrophy))۔ نروز ریٹینا چھوڑنے اور آپٹک ٹریکٹس میں داخل ہونے کے بعد وہ فعلی طور پر مخصوص بندلوں میں الگ ہو جاتی ہیں۔ اگر ٹیومر کسی مخصوص نروبندل پر دباؤ ڈالے، تو کچھ بہت مخصوص تشخیصی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے عام طور پر بہت تیز حد بندی والے میدان کے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے دو طرفہ ہیمیانوپسیاز (bilateral hemianopsias)، یا کوآڈرنٹ نقصانات۔ اکثر دونوں آنکھیں شامل ہوتی ہیں۔ ان سنگین عوارض کا اکثر پیری میٹری (بصارتی میدان کی جانچ) استعمال کرتے ہوئے پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

2.2.2 Assessment of Visual Impairment (Impairment)

بصارتی معذوری والے بچوں کا جلد اندازہ لگایا جانا چاہیے تاکہ دستیاب ابتدائی مداخلت کے پروگراموں سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ ایک طبی ڈاکٹر جو آنکھوں اور آنکھوں کی بیماریوں کے معائنے، تشخیص اور علاج میں مہارت رکھتا ہے وہ آپتھلمولوجسٹ (ophthalmologist) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب کوئی معائنے

کے لیے جاتا ہے، تو آپتھلمولوجسٹ اس شخص کی آنکھ کی ساخت کو دیکھے گا۔ دیگر سادہ ٹیسٹ جو آپتھلمولوجسٹ کر سکتا ہے ان میں شامل ہیں:

• بصارتی تیزیت کا ٹیسٹ (Visual acuity test): ایک شخص آنکھوں کا چارٹ پڑھتا ہے تاکہ ماپا جاسکے کہ وہ مختلف فاصلوں پر کتنی اچھی طرح دیکھتا ہے۔

• بصارتی میدان کا ٹیسٹ (Visual field test): آپتھلمولوجسٹ اس ٹیسٹ کو سائیڈ، یا پردی، بینائی ماپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

• ٹونومیٹری ٹیسٹ (Tonometry test): یہ ٹیسٹ گلوکوما کا جائزہ لینے کے لیے آنکھ کے اندر سیال کے دباؤ کا تعین کرتا ہے۔

بصارتی معذوری والے طلبہ کو آپتھلمولوجسٹ اور/یا آپٹومیٹرسٹ (optometrist) سے معائنہ کروانے چاہئیں تاکہ بصارتی معذوری کی فطرت اور درجے کا تعین ہو سکے۔ آنکھ کے ماہر سے آنکھ کی رپورٹ مانگنی چاہیے اور مجموعی ریکارڈ میں شامل کرنی چاہیے۔ بصارتی معذوری والے طلبہ کے لیے تعلیمی مشیر اسکول کے عملے کے لیے طبی رپورٹ کی تشریح کرے گا اور تعلیمی مضمرات کی نشاندہی کرے گا۔

بصارتی معذوری والے طلبہ کے لیے ضروری اندازے (Essential Assessments for Students with Visual Impairments)

ضروری اندازے میں درج ذیل شامل ہیں؛

1. فعلی بینائی کا اندازہ (Functional Vision Assessment)

2. سیکھنے کے ذرائع کا اندازہ (Learning Media Assessment)

3. توسیعی بنیادی نصاب کی ضروریات کا اندازہ (Expanded Core Curriculum Needs)

(Assessment)

i. فعلی بینائی (Functional vision) ماپتی ہے کہ طالب علم مختلف ماحول میں مختلف کام انجام دینے کے لیے بصارتی معلومات کو کتنی اچھی طرح استعمال کرتا ہے۔ فعلی بینائی کا اندازہ انٹرویوز، مشاہدات اور اندازوں کے ذریعے طالب علم کی فعلی بینائی کی سطح کا تعین کرنے کا جاری عمل ہے۔ کچھ ذیل میں مذکور ہیں:

• ریکارڈز اور آنکھوں کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد کی رپورٹس کا جائزہ

• انٹرویوز

• مشاہدات

• آنکھوں کی ظاہری شکل

• بصارتی اضطراب (Visual reflexes)

• روشنی کے لیے بصارتی رد عمل

• چیزوں کے لیے بصارتی رد عمل

• پٹھوں کا عدم توازن

• آنکھ کی ترجیح

فعلی بینائی کا اندازہ ہمیشہ سیکھنے کے ذرائع کے اندازے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے (بصارتی معذوری کے شعبے میں اکثر ایک اندازہ سمجھا جاتا ہے)۔

ii. سیکھنے کے ذرائع کا اندازہ (The learning media assessment – LMA) کی تعریف "سیکھنے اور خواندگی کے ذرائع کے منظم انتخاب کا معروضی عمل" (Koenig and Holbrook) کے طور پر کی گئی ہے۔ LMA ہر طالب علم پر تین قسم کی معلومات جمع کرتا ہے:

• وہ کارکردگی جس کے ساتھ طالب علم مختلف حسی چینلز سے معلومات جمع کرتا ہے: بصارتی، چھونے والا، اور سماعتی

• عمومی سیکھنے کے ذرائع کی اقسام جو طالب علم سیکھنے کے کام مکمل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا کرے گا

• خواندگی کے ذرائع جو طالب علم پڑھنے اور لکھنے کے لیے استعمال کرے گا

iii. توسیعی بنیادی نصاب (The Expanded Core Curriculum – ECC) ان علم و مہارتوں کا جسم ہے جن کی بینائی کے نقصان والے طلبہ کو اسکول میں اور پوسٹ گریجویٹ کوششوں میں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے جو منفرد، معذوری مخصوص ضروریات کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی نصاب کی جگہ نہیں لیتا، یہ ایک ضمیمہ ہے۔

توسیعی بنیادی نصاب (ECC) کی ضروریات کے اندازے میں درج ذیل شامل ہیں؛

• معاوضی / فعلی تعلیمی مہارتیں، بشمول مواصلاتی طریقے

• اورینٹیشن اور نقل و حرکت (Orientation and Mobility)

• سماجی تعامل

- آزاد زندگی
- تفریح اور فرصت
- کیریئر کی تعلیم
- معاون ٹیکنالوجی
- حسی کارکردگی

• خود ارادیت (Self-determination)

بینائی کا اندازہ (Assessment of Vision)

زیادہ تر بصارتی اسکریننگ کے طریقہ کار سنیلن چارٹ (Snellen Chart) کے استعمال کے علاوہ کلاس روم میں آنکھ کی تکلیف کی علامات کے محتاط مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں۔ Hermann Swollen، آپتھلمولوجی کے ایک ڈچ پروفیسر، نے 1862 میں اپنا چارٹ تیار کیا۔ سنیلن چارٹ دور، مرکزی میدان کی تیزیت کی پیمائش کے لیے سب سے عام استعمال شدہ چارٹ ہے۔ معیاری حروف کا چارٹ خواندہ بچوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن E علامت کا چارٹ چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر موزوں ہے۔

بصارتی تیزیت (Visual Acuity): بصارتی تیزیت کی تعریف بصارتی میدانوں کے حصوں کے درمیان چھوٹی علیحدگیوں کو دیکھنے یا پہچاننے کی صلاحیت کے طور پر کی گئی ہے۔ دور کی بصارتی تیزیت کے لیے جانچ کا فاصلہ عام طور پر بیس فٹ یا چھ میٹر پر مقرر کیا جاتا ہے، کیونکہ روشنی کی کرنیں اس فاصلے پر عملی طور پر متوازی ہوتی ہیں، اور عام آنکھ میں لینز کی شکل کو کنٹرول کرنے والا پٹھا اس فاصلے پر چیزوں کو دیکھتے وقت آرام کی حالت میں مانا جاتا ہے۔

بصارتی تیزیت کسر (fraction) کی شکل میں ریکارڈ کی جاتی ہے جس میں ٹیسٹ کا فاصلہ، عام طور پر بیس فٹ، بطور شمار کنندہ (numerator) ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ مخرج (denominator) اس فاصلے کی نمائندگی کرتا ہے جس پر دیکھی گئی سب سے چھوٹی حروف کو عام آنکھ کو پڑھنا چاہیے۔ 20/200 کی بصارتی تیزیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بچہ بیس فٹ پر وہ لائن پڑھتا ہے جسے عام طور پر دیکھنے والی آنکھ کو 200 فٹ کے فاصلے پر پڑھنا چاہیے۔ سنیلن E اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پورا حرف پانچ منٹ کا زاویہ بناتا ہے اور بارز کے درمیان جگہیں مقررہ فاصلے پر ایک منٹ کے زاویے بناتی ہیں۔ 200 فٹ پر سنیلن E 3.48 انچ مربع مپتا ہے۔

سنیلن کسر یہ ہے:

وہ فاصلہ جس پر علامت واضح طور پر دیکھی گئی
بصارتی تیزیت = وہ فاصلہ جس پر پڑھی گئی سب سے چھوٹی علامت پانچ منٹ کا زاویہ بناتی ہے۔

خصوصی اسکریننگ ٹیسٹ (Special Screening Tests)

کچھ اسکریننگ کے طریقہ کار سنیلن چارٹ کے علاوہ دیگر ٹیسٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عوامل، جیسے والدین کا رویہ، کمیونٹی کے وسائل، اور بنیادی سنیلن کی کارکردگی، کو دیگر خصوصی اسکریننگ ٹیسٹ شامل کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے۔ خصوصی ٹیسٹ جو اکثر سنیلن چارٹ کی تکمیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں دور اندیشی (farsightedness) کے لیے کنوئیکس (پلس) لینز فاصلہ بینائی کا ٹیسٹ، عمودی اور افقی پٹھوں کے توازن کے ٹیسٹ، اور جب پیشہ ورانہ جگہ کے لیے ضرورت ہو تو گہرائی کے ادراک کا ٹیسٹ شامل ہیں۔ میساچوسٹس ویٹرن ٹیسٹ ٹیسٹوں کی بیٹری کی مثال ہے جس میں کنوئیکس لینز کے ساتھ بصارتی تیزیت کا ٹیسٹ اور پٹھوں کے توازن کے ضمنی ٹیسٹ شامل ہیں۔

پلس لینز ٹیسٹ (The Plus Lens Test) ہائپر وپیا (hyperopia) کا پتہ لگانے کا زیادہ قابل اعتماد ٹیسٹ ہے۔ بچے کی بینائی سنیلن چارٹ پر یا دو نایینی آلات (binocular instruments) میں سے ایک پر جانچی جاتی ہے جب وہ چھوٹے، سستے فریم میں لگے پلس لینز پہنے ہوتا ہے۔ پلس لینز تمام عمروں کے لیے 2.25 ڈائیوپٹرز (diopters) کے ہوتے ہیں (National Society to Prevent Blindness, 1982)۔ اگر بچہ لینز پہنے ہوئے چارٹ سے یس فٹ کے فاصلے پر دونوں آنکھوں سے 20 فٹ کی لائن دیکھ سکتا ہے، تو اسے بھیجنا چاہیے۔ پلس لینز ٹیسٹ میساچوسٹس ویٹرن ٹیسٹ کا حصہ ہے۔ کئی دو نایینی آلات اپنے حوالہ معیار کے ساتھ پلس لینز ٹیسٹوں کے استعمال کی فراہمی کرتے ہیں۔

کم فعل بچوں کی بصارتی اسکریننگ (Visual Screening of Low Functioning Children)

بہت چھوٹے بچوں یا کم فعل بچوں کی بصارتی اسکریننگ کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے۔ عوامل جیسے مختصر توجہ کا دورانیہ، ٹیسٹ میں دلچسپی کی کمی، دیکھنے والوں کے سامنے کارکردگی دکھانے میں بے چینی، تھکاوٹ، اور ٹیسٹر کے ساتھ مواصلات میں دشواری اسکریننگ کے عمل میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔

ٹیسٹ کے نتائج کو متاثر کرنے والے متغیرات بچے کی ذہنی نشوونما پر بہت زیادہ منحصر ہوتے ہیں۔ اس کا شکل کا احساس، دورانیہ، اور بصارتی یادداشت، ٹیسٹ چارٹ پر تصویری چیزوں کے ساتھ اس کے پچھلے تجربے کے ساتھ مل کر، ٹیسٹ کے نتائج کو بہت متاثر کرے گا۔ معائنہ کار جانچ کے طریقہ کار کے شروع ہونے سے پہلے صبر دکھا کر اور بچے کے ساتھ ربط پیدا کر کے کچھ جذباتی مشکلات پر قابو پانے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ بہت کم اظہاری زبان کی صلاحیت والے بچوں کے ساتھ مواصلاتی نظام تیار کرنے میں مدد کر سکتا

ہے۔ کچھ صورتوں میں معائنہ کار کو بچے کو نمونہ ٹیسٹ اشیاء کے لیے مناسب غیر زبانی رد عمل دینے کی تربیت دینی پڑ سکتی ہے۔

کم فعل بچوں کے لیے دشاتنی علامتوں کے ٹیسٹ (Directional Symbols Tests for Low Functioning Children)

E-Test کو پری اسکولرز کے لیے E کے اطراف میں پھول، خرگوش، آسمان اور زمین لگا کر تبدیل کیا گیا۔ بچہ اشارہ کرنے کی بجائے حوالہ تصویر کا نام لے کر سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس اسکریننگ آلے کو Michigan Junior Vision Screener کہا جاتا ہے۔

غیر زبانی بچوں کے لیے بصارتی تیزیت کی آپرینٹ ہیمنش کے لیے ایک موضوعی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سنیلن E کی بصارتی امتیاز کی نشاندہی کے لیے لیور پریس استعمال کیا گیا۔ شدید معذور مضامین کو سیدھے حرف E کے جواب میں لیور دبانے اور الٹے E کو نظر انداز کرنے کے لیے مک اور سزا کے ذریعے مشروط کیا گیا۔ تیزیت محرک کے سائز اور مضمون سے فاصلے کو مختلف کر کے پالی گئی۔

کم فعل بچوں کے لیے کھلونا ٹیسٹ (Toy Test for Low Functioning Children)

بچے کو مانوس چیزوں پر مشتمل دس کھلونوں کا سیٹ دکھایا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو تین میٹر یا دس فٹ کے فاصلے سے ان کے نام لے۔ ان میں ایک کار، ہوائی جہاز، گڑیا، دو چھریاں، دو کانٹے اور دو چمچ شامل ہیں۔

کم فعل بچوں کے لیے جیومیٹرک اور علامتی تصویری ٹیسٹ (Geometric and Symbol Picture Tests For Low Functioning Children)

تصویری چارٹ کا استعمال بھی بہت چھوٹے بچوں کی بینائی کی اسکریننگ کا کامیاب ذریعہ پایا گیا ہے۔ تصویری چارٹ زیادہ سمجھنے میں آسان ہیں لیکن E-چارٹ تین سال کی عمر سے بچوں کے لیے زیادہ درست ہے۔ کھلونا ٹیسٹ بصارتی تیزیت کا بہت درست پیمانہ نہیں دیتا، اور بچے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔

معروضی تکنیکیں (Objective Techniques)

بینائی کا ٹیسٹ شیرخواری کے دوران ماہر اطفال کر سکتا ہے۔ آنکھ میں چمکائی گئی روشنی کا جواب نہ دینا، جب کوئی چیز آنکھ کے قریب آئے تو حفاظتی پلک جھپکنے کی غیر موجودگی اور متحرک چیزوں کو جوابدہ آنکھ یا سر کی حرکتوں سے پیچھا کرنے کی ناکامی عارضی یا مستقل بصارتی نقصان کی علامات ہیں۔ مکمل اندھے پن یا کم معمول بینائی کی اضافی نشاندہیوں میں درج ذیل شامل ہیں: دو ہفتوں اور چھ ماہ کے درمیان شیرخوار کی روشنی کو مستقل طور پر گھورنے میں ناکامی اور چھ ماہ سے بڑے شیرخوار کی اپنی آنکھوں کے سامنے متحرک روشنی

کا پیچھا کرنے میں ناکامی۔ نساگس، یا اسٹرا بسمس، یا دونوں آنکھوں کے یکساں انحراف کی موجودگی کم معمول بینائی کی نشاندہی ہے۔

رنگ امتیاز کے ٹیسٹ (Color Discrimination Tests)

رنگ بینائی کی جانچ کے سب سے عام استعمال شدہ طریقے رنگین نقطوں کے نمونوں کا امتیاز اور رنگوں کا ملاپ ہیں۔ رنگ بینائی کے ٹیسٹ کی سب سے سادہ قسم ان بچوں کا پتہ لگانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جن کی سرخ-سبز اور پیلے-نیلے رنگ کی بینائی ناقص ہو۔ اگرچہ ایسے ٹیسٹ کی عام بینائی اسکریننگ پروگرام میں دینے کی سفارش نہیں کی جاتی، لیکن سفارش کی جاتی ہے کہ بچے کے اسکول کے تجربے کے دوران کم از کم ایک بار رنگ بینائی کا ٹیسٹ دیا جائے۔

2.2.3 تعلیم و تربیت (Education and Training)

کلاس روم کا استاد مؤثر تعلیمی پروگرام کی منصوبہ بندی اور نفاذ کی کلید ہے۔ کلاس روم کا استاد:

- معلومات جمع کرنے کے مرحلے کے دوران جمع کی گئی معلومات بانٹتا ہے؛
- اپنے بچے کے پروگرام کے لیے والدین یا سرپرستوں کی توقعات سے آگاہ ہوتا ہے؛
- بصارتی معذوری والے طالب علم کی ضروریات سے آگاہ ہوتا ہے؛
- تدریسی پروگراموں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل کرتا ہے؛
- تدریسی طریقوں اور مواد میں تبدیلی کرتا ہے اور موافق وسائل کی تیاری کے لیے خاطر خواہ وقت دیتا ہے؛
- طالب علم کی پیش رفت کا اندازہ لگانے اور بتانے کے لیے حکمت عملیاں تیار کرتا ہے؛ اور
- طالب علم، والدین اور دیگر اساتذہ کے ساتھ جاری مواصلات برقرار رکھتا ہے۔

خصوصی تعلیم / وسائل کا استاد (Special Education/Resource Teacher)

وسائل کا استاد عام طور پر وہ استاد ہوتا ہے جسے طالب علم کے پروگرام کو مربوط کرنے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وسائل کا استاد:

- طالب علم کی طاقتوں اور ضرورت کے شعبوں کا تعین کرنے کے لیے تشخیصی اندازہ فراہم کرتا ہے؛
- پروگرام میں تبدیلی اور/یا موافقت کے لیے خیالات اور تجاویز پیدا کرتا ہے؛
- مواد اور وسائل کے بارے میں مشورہ فراہم کرتا ہے؛

- Saskatchewan Learning Resource Centre سے مواد منگواتا ہے اور اسکول اور وسائل مرکز کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے؛
- تدریسی پروگراموں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل کرتا ہے؛
- طالب علم کی پیش رفت کا اندازہ لگانے اور بتانے کے لیے حکمت عملیاں تیار کرتا ہے؛
- والدین اور دیگر اساتذہ کے ساتھ جاری مواصلات برقرار رکھتا ہے؛ اور
- سپورٹ ٹیم کی میٹنگز شروع اور منظم کرتا ہے۔

2.2.3.1 اندھے طلبہ کے لیے حکمت عملیاں (Strategies for Blind Students)

کلاس روم کی موافقتیں کافی مختلف ہوں گی اور طالب علم کی مخصوص ضروریات کے مطابق انفرادی ہونی چاہئیں۔ تاہم، کچھ بنیادی بہترین طریقے ہیں جو سب سے مؤثر موافقتوں کی تیاری کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔

ایک چیز جس پر ہمیشہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ان طلبہ کے لیے اتنا مکمل طور پر آزاد بننا مشکل ہوتا ہے جتنا وہ ہونے کے قابل ہیں۔ کلاس روم کے استاد کو جتنا ممکن ہو آزادی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ "سیکھی ہوئی بے بسی (learned helplessness)" کے جال سے بچا جاسکے۔ طالب علم کو کلاس روم میں آزادانہ طور پر حرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کریں، اور اپنا کلاس روم اسی کے مطابق منظم کریں۔ کلاس روم میں مواد، ڈیسک اور دیگر چیزوں کو مستقل مقامات پر برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ یقینی بنانا کہ الماریاں مکمل طور پر بند ہوں، کرسیاں اندر دھکیلی گئی ہوں، اور دروازے آدھے کھلے نہ چھوڑے جائیں کلاس روم میں سفر میں حفاظت میں مدد کرے گا۔ بصارتی معذوری والے طلبہ کے لیے آزاد بننے کا حصہ یہ سیکھنا ہے کہ مدد کے لیے کب وکالت کرنی ہے۔ تمام تدریسی کام بصارتی معذوری والے طالب علم کے لیے فوراً ممکن نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ موافقتوں کے ساتھ بھی۔ کلیدیہ ہے کہ اپنی تدریس اس طرح ڈیزائن کریں کہ طالب علم کو آزادانہ طور پر عمل کرنے کا سب سے زیادہ موقع ملے۔ طالب علم کا اور نیٹیشن اور نقل و حرکت کا ماہر اور بصارتی معذوری والے طلبہ کا استاد کمرے کے انتظامات اور کمرے سے واقفیت میں مدد کر سکتا ہے۔

بصارتی معذوری والے طالب علم کو جگہ دینے کے لیے اپنے کلاس روم کو اپنا نسبتاً آسان کام ہے۔ اسے صرف طالب علم کی بصارتی فعالیت کی سطح (طالب علم کیسے دیکھتا ہے) اور طالب علم کیسے کام اور سیکھتا ہے اس سے آگاہی درکار ہوتی ہے۔ مثلاً، کم بینائی والے طالب علم کے لیے، یقینی بنائیں کہ وہ کمرے کے سامنے ہو جہاں وہ بلیک بورڈ دیکھ سکتا ہے۔ ان طلبہ کو سیکھنے کا مواد پیش کرتے وقت روشنی کے متغیرات کو کنٹرول کریں جو روشنی اور چمک کے لیے حساس ہیں۔ ان طلبہ کے ساتھ زبانی اشارے استعمال کریں جو جسم کی حرکتوں یا جسمانی اشاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ بصارتی معذوری والے طلبہ کا تربیت یافتہ استاد کلاس

روم ڈیزائن میں چند سادہ تبدیلیاں کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے جو بصارتی معذوری والے طالب علم کی تعلیم میں تمام فرق ڈال سکتی ہیں۔

ایک کلیدی موافقت جو بالکل ضروری ہے وہ مناسب ذرائع میں نصابی کتابوں اور تدریسی مواد تک رسائی ہے اور اپنے دیکھنے والے ساتھیوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں۔ اندھے طلبہ کے لیے اس کا مطلب بریل اور/یا ریکارڈ شدہ ذرائع ہو سکتا ہے۔ کم بینائی والے طالب علم کے لیے، اس کا مطلب بڑے پرنٹ کا متن یا متن تک رسائی کے لیے آپٹیکل آلات کا استعمال اور/یا کلاس میں ریکارڈ شدہ ذرائع ہو سکتا ہے۔ پہلے سے بصارتی معذوری والے طلبہ کے طالب علم کے استاد کے ساتھ قریبی کام کرنا قابل رسائی مواد اور ان مواد کی بروقت دستیابی کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔

معاون ٹیکنالوجی (Assistive Technology)

پرنٹ معلومات تک رسائی کے لیے، بصارتی معذوری والے طلبہ کو متعدد موافق آلات، طریقوں اور سامان کے استعمال میں تربیت دینی چاہیے جنہیں اجتماعی طور پر معاون ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ ٹیکنالوجی کمپیوٹر پر پیش کردہ معلومات تک رسائی کی اجازت دیتی ہے جبکہ دیگر آزادانہ طور پر استعمال ہونے والے آلات ہیں۔ کمپیوٹر ہارڈویئر اور سافٹ ویئر مسلسل ترقی کر رہے ہیں، جو پہلے سے زیادہ معلومات تک رسائی کی اجازت دیتے ہیں۔ کچھ مثالیں:

کمپیوٹر کی موافقتیں (Computer adaptations)

- بریل ترجمہ سافٹ ویئر اور سامان: پرنٹ کو بریل میں اور بریل کو پرنٹ میں تبدیل کرتا ہے۔
- بریل پرنٹر: کمپیوٹر سے جڑتا ہے اور کاغذ پر بریل ابھارتا ہے۔
- اسکرین ریڈر: کمپیوٹر اسکرین پر متن کو سنائی دینے والی تقریر میں تبدیل کرتا ہے۔
- اسکرین بڑھانے والا سافٹ ویئر: کمپیوٹر اسکرین پر متن اور تصاویر کے سائز کو بڑھاتا ہے۔
- ریفریش ایبل بریل ڈسپلے: کمپیوٹر پر متن کو کمپیوٹر سے جڑے آؤٹ پٹ آلے کے ذریعے بریل میں تبدیل کرتا ہے۔

موافق آلات (Adaptive devices)

- بریل نوٹ ٹیکرز: ہلکا پھلکا الیکٹرانک نوٹ لینے والا آلہ جو پرنٹ یا بریل ایمبوسر سے جڑ سکتا ہے تاکہ چھپی یا بریل شدہ کاپی تیار کی جاسکے۔

- آپٹیکل کریکٹر ریڈر: چھپے متن کو کمپیوٹر پر فائلوں میں تبدیل کرتا ہے جنہیں مناسب سامان اور سافٹ ویئر کے ساتھ سنائی دینے والی تقریر یا بریل میں ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔
- الیکٹرانک بریل رائٹر: بریل تیار کرتا ہے، بریل کو متن یا مصنوعی تقریر میں ترجمہ کرتا ہے۔
- بولنے والے کیلکولیٹر: آواز آؤٹ پٹ کے ساتھ حساب کرتا ہے۔

آپٹیکل آلات (Optical devices)

- کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن (CCTV): تصویر کو بڑے سائز میں بڑا کرتا ہے اور اسے اسکرین پر پیش کرتا ہے
- میگنیفائرز: تصاویر کو بڑا کرتے ہیں
- ٹیلی اسکوپس: دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں

بصارتی معذوری والے طلبہ کا خصوصی تربیت یافتہ استاد ان میں سے بہت سے آلات فراہم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اور طالب علم کو معاون ٹیکنالوجی کے استعمال میں آزاد اور ماہر بننے کی تربیت فراہم کر سکتا ہے۔

2.2.3.2 کم بینائی والے طلبہ کے لیے حکمت عملیاں (Strategies for the students with low vision)

کم بینائی والے طلبہ کے پاس روزمرہ کا کام کرنے کے لیے کچھ بینائی ہوتی ہے۔ استاد کو ان سے مختلف طریقے سے نمٹنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہیں گرم جوش استقبال سے حوصلہ مل سکتا ہے۔ استاد درج ذیل مراحل استعمال کر سکتا ہے:

تعارف (Introduction)

- طالب علم کو دیگر طلبہ کی طرف سے آنکھ کی حالت کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کا جواب دینے کی حوصلہ افزائی کریں۔
- تعریف اور ناراضگی کو زبانی بیان کریں یا کندھے پر ہاتھ جیسے اشارے استعمال کریں۔
- کم بینائی والے طلبہ چہرے کے تاثرات اور جسمانی زبان سے بھیجے گئے پیغام سے محروم ہو سکتے ہیں۔
- کسی شخص یا چیز کے مقام کی وضاحت کرتے وقت وضاحتی زبان کے ساتھ مخصوص رہیں۔
- براہ راست طالب علم سے بات کریں، براہ راست آنکھ سے رابطہ استعمال کرتے ہوئے۔ طالب علم کو حوصلہ دیں کہ جب اسے مخاطب کیا جائے یا جب وہ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کو دیکھے۔

- طالب علم کو حوصلہ دیں کہ جب وہ ان سے بات چیت کر رہا ہو تو لوگوں کو براہِ راست دیکھے۔
- آواز کا عام لہجہ استعمال کریں۔
- "دیکھو" اور "دیکھنا" جیسی اصطلاحات استعمال کرنے میں آرام محسوس کریں۔ یہ طالب علم کے ذخیرہ الفاظ کا حصہ ہوں گی۔
- طالب علم کو دروازے کے قریب ترین کوٹ ہک یا لاکر فراہم کریں تاکہ اسے تلاش کرنا آسان ہو۔

حفاظت (Safety)

بصارتی معذوری والے طلبہ کو اسکول کی عمارت میں سفر کرتے وقت اضافی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے۔ اسکول کے زیادہ تر علاقے ممکنہ مسائل پیش کرتے ہیں۔ فائر ڈرزن، کلاسیں بدلنا، لائبریری جانا اور اسمبلیوں جیسے طریقہ کار کے لیے ضروری ہے کہ عمل کا منصوبہ موجود ہو۔ ہر کمرے کا جائزہ لیں جسے طالب علم ممکنہ خطرات کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ تجاویز محفوظ ماحول فراہم کرنے میں مدد کریں گی۔

- طالب علم کو جتنی جلدی ممکن ہو اسکول کی عمارت سے واقف کرائیں۔
- راہداریوں، زینوں اور کلاس رومز میں بے ترتیبی کو محدود کریں جنہیں طالب علم استعمال کرے گا۔
- کم بینائی والے طلبہ کو کمرے میں تمام فرنیچر اور فکسچر کے مقام سے واقف ہونا چاہیے۔
- اگر فرنیچر کو منتقل کرنا ضروری ہو، تو طالب علم کو مطلع کرنا یقینی بنائیں۔
- متضاد رنگ کی ٹیپ یا پینٹ سے زینوں اور سیڑھیوں کے کناروں کو نمایاں کریں۔
- تمام الماری یا کوٹھری کے دروازے بند رکھیں۔
- اساتذہ اور دیگر طلبہ کو دیکھنے والے گائیڈ تکنیک میں تربیت دیں۔
- فیلڈ ٹرپ پر جاتے وقت یا غیر مانوس ماحول میں سفر کرتے وقت، ساتھی کا انتظام کریں۔
- جب تک طالب علم آپ کی آواز سے واقف نہ ہو، ان سے بات چیت کرتے وقت اپنی شناخت بتائیں۔ دیگر طلبہ سے بھی ایسا ہی کروائیں۔ ہمیشہ طالب علم کو بتائیں جب آپ انہیں چھوڑ رہے ہوں۔

بیٹھنا (Seating)

- کلاس روم میں بیٹھنا طالب علم کی فعلی بینائی پر منحصر ہوگا۔
- عام طور پر بصارتی معذوری والا طالب علم کلاس روم کے سامنے بیٹھے گا تاکہ استاد اور بورڈ کے قریب ہو۔

- اگر دائیں آنکھ مضبوط ہو، تو کلاس روم کے بائیں طرف ہونا بہترین ہے اور اس کے برعکس۔
- روشنی کے ماخذ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بصارتی معذوری والے طالب علم کو کھڑکیوں یا روشنی سے براہ راست روشنی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کو پڑھاتے وقت کھڑکی یا روشنی کے ماخذ کے براہ راست سامنے کھڑے ہونے سے بچنا چاہیے۔
- اگر طالب علم پڑھنے کا اسٹینڈ یا جھکا ہوا ڈیسک استعمال کرتا ہے، تو یقینی بنائیں کہ ڈیسک تھکاوٹ کم کرنے کے لیے اچھی کرنسی فراہم کرے۔ طالب علم کے پاؤں فرش پر چپے ہونے چاہئیں اور پڑھنے کا اسٹینڈ اس طرح جھکا ہو کہ طالب علم کو اپنی گردن کو تکلیف دہ انداز میں جھکانا نہ پڑے۔
- گروہی سرگرمیوں جیسے کہانی کے وقت یا ویڈیوز کے لیے، طالب علم کو ترجیحی بیٹھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- استاد کی آواز کی تقویت اور غیر متعلقہ شور میں کمی کے لیے ساؤنڈ فیلڈ سسٹم پر غور کیا جاسکتا ہے۔

تدریسی تجاویز (Teaching Tips)

- پروگرام کا منصوبہ عام طور پر طالب علم کی سپورٹ ٹیم کی طرف سے سالانہ بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے اور باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔
- پہلے سے منصوبہ بنائیں۔ اگر کم بینائی والے طالب علم کو بڑے متن، آڈیو کیسٹس یا چھپے مواد کی ضرورت ہو، تو انہیں پہلے سے منگوانا یا تیار کرنا چاہیے۔
- پڑھاتے وقت بولیں۔ طالب علم بصارتی اشارے اور تحریری ہدایات سے محروم ہو سکتا ہے۔
- مظاہرے کرتے وقت یا بصارتی معاون آلات استعمال کرتے وقت طالب علم کے قریب پڑھائیں۔
- بورڈ پر لکھتے وقت نوٹس کو زبانی بیان کریں۔ اگر طالب علم بورڈ کا کام دیکھ یا اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو اسے بڑے پرنٹ کی کاپی یا نوٹس لکھنے کے لیے (NCR (no carbon required کاغذ استعمال کرنے والا کاتب فراہم کریں۔ پرنٹ جڑے ہوئے لکھنے (cursive writing) سے پڑھنا آسان ہو سکتا ہے۔
- طالب علم کو مواد دیکھنے یا نقل کرنے کے لیے بورڈ تک جانے یا ڈیسک کو قریب کرنے کی اجازت دیں۔
- باقاعدگی سے جانچیں کہ طالب علم درست نوٹس بنا رہا ہے۔
- طالب علم کو اضافی وقت دیں۔ وہ زیادہ تر کام مکمل کرنے میں زیادہ وقت لے گا۔ درکار کام کی مقدار کم کی جاسکتی ہے۔
- زبانی امتحانات یا امتحانی جوابات لکھنے کے لیے کاتب پر غور کریں۔

- جتنا ممکن ہو چھونے والے، ٹھوس اور حقیقی زندگی کے مواد کا استعمال کریں۔ یہ حرکی اور چھونے والی سیکھ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔
- خصوصی مواد کو جگہ دینے کے لیے کافی ڈیسک ٹاپ اور شیلف کی جگہ درکار ہے۔ طالب علم کو اپنے نوٹس، ڈیسک، شیلف اور لاکر کو منظم کرنا سیکھنا ہوگا۔ نوٹ بکس اور فائلوں کو رنگ کوڈ کرنا مدد کر سکتا ہے۔ تنظیم کو برقرار رکھنا طالب علم کی ذمہ داری بننا چاہیے۔
- آنکھ کی تھکاوٹ سے بچنے کے لیے بصارتی کاموں کو غیر بصارتی کاموں کے ساتھ باری باری کریں۔
- کم بینائی والے طالب علم کو دیگر طلبہ جیسے ہی نظم و ضبط اور رویے کی توقعات درکار ہوتی ہیں۔
- جب یہ جانچ رہے ہوں کہ طالب علم مخصوص بصارتی مواد دیکھ سکتا ہے تو "کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟" کی بجائے "مجھے بتائیں آپ کیا دیکھتے ہیں" کہیں۔
- نئی سیکھ کو طالب علم کے تجربات اور علم سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ سیکھ میں خلا کو پالنے میں مدد کرے گا۔
- اگر بڑی مقدار میں پڑھنے کی ضرورت ہو، تو تدریسی معاون یا کسی دوسرے طالب علم سے مواد طالب علم کو پڑھ کر سنانے پر غور کریں، یا اسے آڈیو ٹیپ پر حاصل کریں۔
- غیر ضروری چیزیں چھوڑ دیں۔ بڑے طلبہ پرنٹ مواد میں اہم معلومات کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ متن کے ان حصوں کی نشاندہی کریں جنہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔
- تھکاوٹ اور مایوسی سے بچنے میں مدد کے لیے خاکے، نقطہ صورت نوٹس فراہم کریں، کلیدی تصورات کی نشاندہی کریں۔
- کم بینائی والے طالب علم کو کچھ مواد کی اضافی وضاحت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- ہاتھ پر ہاتھ کی تکنیکیں مخصوص مہارتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اچھی طرح کام کرتی ہیں۔
- طالب علم کو پر اعتماد ہونے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسے سیکھنا ہوگا کہ کب اور کیسے مدد کی درخواست اور انکار کرنا ہے اور اپنی ضروریات کو کیسے بتانا ہے۔
- آزاد کوشش کی حوصلہ افزائی کریں اور طالب علم کے دوسروں پر منحصر ہونے کے امکان کو کم کرنے کے لیے فعال اقدامات شامل کریں۔
- طالب علم کی مخصوص سرگرمیوں جیسے جسمانی تعلیم، سائنس لیبر اور بصارتی فنون میں شرکت کی صلاحیت اس کی فعلی بینائی سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تبدیلی درکار ہو سکتی ہے۔

اسائنمنٹس اور امتحانات (Assignments and Examinations)

اسائنمنٹس اور امتحانات کم بینائی والے طالب علم کے لیے خاطر خواہ دشواری پیش کر سکتے ہیں۔ امتحانی نتائج کو طالب علم کے مضمون کے مواد کے علم کی عکاسی کرنی چاہیے۔ ہر طالب علم کی انفرادی ضروریات پر غور درکار ہے۔ طالب علم کو اسائنمنٹ یا امتحان مکمل کرنے میں دیگر طلبہ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ہوم ورک دیتے وقت طالب علم کی بھلائی پر غور کریں، خاص طور پر اگر اس میں وسیع پڑھنے یا لکھنے کی ضرورت ہو۔ کم بینائی والا طالب علم اکثر اسکول کے دن کے اختتام تک تھکا ہوتا ہے اور کام کی کوالٹی کم ہو سکتی ہے۔ کام کی کوالٹی بڑھانے کے لیے درج ذیل میں سے کچھ حکمت عملیاں استعمال کی جاسکتی ہیں۔

- اسائنمنٹس اور امتحانات مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت دیں۔
- اگر ضروری ہو تو طالب علم کو ایک سے زیادہ نشستوں میں امتحان مکمل کرنے کی اجازت دیں۔
- طالب علم کی کسی تصویر یا ریاضی کے عمل کی سمجھ کو ظاہر کرنے کے لیے درکار مثالوں کی تعداد کم کریں۔
- جواب دینے والے سوالات کی تعداد کم کریں۔
- طالب علم کے علم کی جانچ کا متبادل طریقہ فراہم کریں۔
- کاتب فراہم کریں۔
- امتحان زبانی دیں۔ کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ یا آڈیو کیسٹ پر ریکارڈ شدہ جوابات قبول کریں۔
- کمپیوٹر جواب شیٹس کے استعمال سے بچیں۔
- صوبائی جانچ کے لیے خصوصی انتظامات کے لیے درخواست دینے کے طریقہ کار ضمیمہ 5 میں شامل ہیں۔
- امتحان سے 8 سے 12 ماہ پہلے درخواست دینی چاہیے۔

روشنی (Lighting)

• جتنا ممکن ہو چمک ختم کریں۔ یہ بصارتی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ چمکدار ڈیسک ٹاپس اور چمکدار کاغذ روشنی کو عکاسی کریں گے اور ان سے بچنا چاہیے۔ ڈیسک یا ٹیبل ٹاپ پر سیاہ یا گہرا میٹ کاغذ رکھنے سے چمک کو کم کرنے اور تضاد فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ طالب علم کے کام کے لیے میٹ فٹش کاغذ کی سفارش کی جاتی ہے۔

• درکار روشنی کی سطح طالب علم کی بصارتی معذوری پر منحصر ہوگی۔ کچھ طلبہ انتہائی روشنی حساس ہو سکتے ہیں۔ قدرتی، مصنوعی، دن اور رات کی روشنی مختلف فعلی مسائل پیش کرتی ہے اور ہر طالب علم کے لیے مختلف حل درکار ہوتے ہیں۔ بہترین روشنی کا تعین کرنے کے لیے، طالب علم اور استاد کو روشنی کے حالات کے ساتھ تجربہ کرنا چاہیے۔

- اندر روشنی کو کنٹرول کرنے کے معاون آلات میں تضاد بہتر بنانے اور چمک روکنے کے لیے آکلوڈرز، روشنی کی شدت اور چمک کو کنٹرول کرنے کے لیے وائزرز، جذب کرنے والے لینز اور فلٹرز اور تاپڈپٹ لیمپ شامل ہیں۔ تاپڈپٹ لیمپ پیلے۔ سرخ روشنی پر زور دیتے ہیں اور چمک کو کم کرنے اور / یا روشنی کی سطح بڑھانے میں مدد کے لیے عکاس شیڈز اور اسپرنگ آرمز رکھتے ہیں۔ ہائی انٹینسٹی لیمپ بھی مفید ہو سکتے ہیں۔ اگر لیمپ استعمال کیے جائیں، تو روشنی براہ راست طالب علم کی آنکھوں میں نہیں چمکنی چاہیے۔ چمک اور سائے ختم کرنے کے لیے روشنی رکھیں۔
- اوور ہیڈ پروجیکٹرز میں اکثر چمک ہوتی ہے۔ کم بینائی والے طالب علم کو اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسی کی ذاتی پرنٹ کاپی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- جب طالب علم کمپیوٹر استعمال کرتا ہے، تو اینٹی گلیئر فلٹر اسکرین کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- باہر، وائزر یا چوڑے کنارے والی ٹوپیاں روشنی کی شدت کو کنٹرول کر سکتی ہیں، اور جذب کرنے والے لینز اور فلٹرز چمک اور عکاسی کو کم کر سکتے ہیں۔

تضاد (Contrast)

استاد تضاد کو زیادہ سے زیادہ کر کے طالب علم کو دستیاب معلومات کی مقدار بڑھا سکتا ہے۔ کسی چیز اور اس کے پس منظر کے درمیان تیز تضاد چیز کو طالب علم کے لیے زیادہ نظر آنے والا بناتا ہے۔ یہ پڑھنے، لکھنے، ڈرائنگ، کاٹنے، چکانے اور جسمانی تعلیم میں ضروری ہے۔

سیاہ اور سفید یا سیاہ اور بیلا بہترین تضاد فراہم کرتے ہیں۔ اگر چمک مسئلہ ہو تو بلف یا ملکے پیلے پس منظر پر گہرا نیلا، سبز یا جامنی ترجیح ہو سکتا ہے۔ طالب علم کی پسند کے کاغذ کے رنگ کے ساتھ تجربہ کریں۔

- چاک بورڈ کو جتنا ممکن ہو صاف رکھیں۔ طالب علم کو پیلے یا سفید چاک کی ترجیح ہو سکتی ہے۔ بڑا چاک خرید جا سکتا ہے۔ وائٹ بورڈ اچھا تضاد فراہم کرتا ہے اگر چمک ختم کی جاسکے اور گہرا مارکر استعمال کیا جائے۔

• کسی چیز کے ارد گرد بصارتی خلل کم کریں۔

• الجھانے والے نمونوں والے مواد کے استعمال سے بچیں۔

• ڈایا گرام کو تیز، بولڈ اور سادہ رکھیں۔ بہت زیادہ تفصیلات الجھانے والی ہوتی ہیں۔

• بولڈ، تیز پرنٹ اچھا تضاد فراہم کرتا ہے۔ پرنٹ کاپیوں کو بڑا کرتے وقت، واضح، غیر دھندلی کاپیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

• بولڈ لائنوں والا کاغذ، لائنوں کے درمیان مختلف مقدار میں جگہ کے ساتھ، مددگار ہو سکتا ہے۔

• طالب علم بڑے پوائنٹس اور گہری سیسہ اور سیاہی والی پنسلیں اور پین استعمال کرنا پسند کر سکتا ہے۔

کم بینائی والے طلبہ کو پڑھانے کے لیے نصابی تجاویز (Curriculum Suggestions for Teaching Students with Low Vision)

ریاضی (Mathematics)

• کم بینائی والے طلبہ کو ریاضی کے بنیادی تصورات پر عبور حاصل کرنے کے لیے ٹھوس مواد کو جسمانی طور پر جوڑ توڑ کرنا چاہیے۔

• اباکس (abacus) یا بولنے والے کیلکولیٹر پر مشق کرنے سے پہلے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے بنیادی تصورات اچھی طرح سمجھے جانے چاہئیں۔

• ذہنی ریاضی کی مہارتوں کی مشق کریں۔

• گنتی اور ملاپ کے لیے چیزیں رکھنے کے لیے خانوں والی ٹرے فراہم کریں۔

• نوجوان طلبہ کے لیے تصویری ہدایات مددگار ہوتی ہیں۔

• کم بینائی والے طلبہ کو پیمائشی آلات انفرادی طور پر ظاہر کریں۔

• پیمائش شامل سرگرمیاں کرتے وقت، استعمال شدہ اکائیاں اتنی بڑی ہونی چاہئیں کہ طالب علم بغیر مدد کے کام کر سکے۔

• طالب علم سے بورڈ سے نقل کرانے کی بجائے ورک شیٹ فراہم کریں۔

• پیسے پڑھاتے وقت اصلی سکے استعمال کریں۔

• وقت پڑھانے کے لیے ڈیجیٹل بولنے والی گھڑیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔

• اعلیٰ شدہ جیومیٹرک پزلز کسر (fractions) پڑھانے کے لیے مفید ہیں۔

• سیاہ لائن والا گراف پیپر استعمال کریں۔

• بڑے پرنٹ کی تحریریں یا کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن کا استعمال چارٹس، ڈایاگرامز، کسروں کی بڑی تصاویر فراہم کرنے اور جیومیٹری پڑھاتے وقت خاص طور پر مددگار ہو سکتا ہے۔

زبان کے فنون (Language Arts)

• کمرے میں لیبل شدہ چیزیں طالب علم کی آنکھ کی سطح پر ہونی چاہئیں۔

• فہم میں مدد کے لیے تصویروں میں تفصیلات کی نشاندہی کریں۔

- طالب علم کو پڑھنے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کے لیے ٹیمپلیٹ یا لائن گائیڈ استعمال کریں۔
- ایڈجسٹ ایبل پڑھنے کے اسٹینڈ اچھی پڑھنے کی کرنسی کو فروغ دے سکتے ہیں اور گردن اور کمر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔
- زبان کی تعمیر، لفظ حملے کی مہارتوں اور فہم پر زور دینا چاہیے بجائے رفتار کے۔ کم بینائی والے طلبہ آہستہ پڑھیں گے۔
- بڑا پرنٹ کم بینائی والے تمام طلبہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اکثر آنکھوں کے قریب رکھا عام پرنٹ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ بولڈ، واضح پرنٹ بہترین ہے۔
- زبانی مشقیں طالب علم کے سچے بہتر بنانے میں مدد کریں گی۔
- اچھی طرح فاصلے والی بولڈ سیاہ لائنوں والا کاغذ چھاپنے اور ہاتھ کی تحریر کے لیے مفید ہے۔
- چھوٹے طالب علم کے پاس اپنے ڈیسک پر حروف تہجی کی تحریری مثال ہونی چاہیے۔
- طالب علم کو ہاتھ کی تحریر پڑھنے کی مشق کا وقت دینا چاہیے۔
- گریڈ 3 یا 4 تک کی بورڈنگ کی مہارتیں متعارف کرائیں۔

فنون کی تعلیم (Arts Education)

- جب تحریری موسیقی استعمال کی جائے، تو بڑا فارمیٹ اور گہری اسٹاف لائنیں ضروری ہو سکتی ہیں۔
- طالب علم کو آلہ بجانے میں دلچسپی پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔
- طالب علم کی موسیقی کی قدر دانی پیدا کریں۔
- کم بینائی والے طالب علم کو دیگر طلبہ جیسی بصارتی فنون کی سرگرمیاں کرنے کی کوشش کی حوصلہ افزائی کریں۔
- ابھری لائن ڈرائنگ یا سیاہ لائن ڈرائنگ والا کاغذ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ طالب علم کو کہاں رنگ بھرنا چاہیے۔
- مٹی اور کاغذ کا مجسمہ، ٹیکسٹائل فنون، 3 جہتی شکلیں، انگلیوں سے پینٹنگ اور کولاج فنون کی شکلیں اور سرگرمیاں ہیں جن سے بصارتی معذوری والے طلبہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
- ڈرامے میں شرکت روزمرہ کے اشاروں اور حرکات کو سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے جو کم بینائی والا طالب علم بصارتی مشاہدے کے ذریعے نہیں سیکھ سکتا۔

• فرش پر بھاری ڈوری یا ٹیپ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ طالب علم کو ڈرامے میں اسٹیج پر کہاں چلنا اور حرکت کرنا چاہیے۔

سائنس (Science)

- ابھری لائن، بڑے پرنٹ یا بولڈ لائن ڈایا گرام استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ تفصیل سے بچیں۔
- تبدیلیوں کو بیان کرنے اور پیمائش میں مدد کے لیے لیب میں مددگار ہو سکتی ہے۔
- طالب علم کو تجربے سے پہلے آلات اور مواد کا معائنہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کچھ سائنس کا سامان چھونے والے نشانات کے ساتھ دستیاب ہے۔
- طالب علم کو مظاہرے کے جتنا ممکن ہو قریب ہونا چاہیے۔
- اگر ممکن ہو تو حقیقی زندگی کی چیزیں یا ماڈل استعمال کریں۔

معاشرتی علوم (Social Studies)

- ابھری لائن، بڑے پرنٹ یا بولڈ لائن نقشے اور اٹلس استعمال کرنے چاہئیں۔ بہت زیادہ تفصیل الجھانے والی ہو سکتی ہے۔
- بڑے پرنٹ کی نصابی کتابیں Saskatchewan Learning Resource Centre سے دستیاب ہیں۔
- درکار پڑھنے کی مقدار کم کرنے کے لیے حوالہ مواد کو اسکین کیا جاسکتا ہے اور آواز کی رسائی والے کمپیوٹر پر سنا جاسکتا ہے۔

صنعتی فنون (Industrial Arts)

- مدت شروع ہونے سے پہلے کرے کی اور نیٹیشن ہونی چاہیے۔
- طالب علم کو یہ سکھانے کے لیے ایک سے ایک ہدایت درکار ہو سکتی ہے کہ اوزار کیا ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔
- طالب علم کو بجلی کے اوزاروں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہاتھ کے اوزاروں میں ماہر ہونا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ کی ہدایت ضروری ہو سکتی ہے۔
- کم بینائی والے طلبہ کو آلات اس طرح استعمال کرنا سکھایا جانا چاہیے جیسے ان کی کوئی بینائی نہ ہو۔ اس طرح کام کرنے سے وہ اپنے چہروں کو آلات کے خطرناک حد تک قریب رکھنے سے بچیں گے۔

کم بینائی والے طلبہ کے لیے منفرد نصابی ضروریات (Unique Curriculum Needs for Students with Low Vision)

کم بینائی والا طالب علم ضرورت کے مطابق موافقت کے ساتھ باقاعدہ اسکول پروگرام میں حصہ لے گا۔ اسے عام بینائی والے بچے سے درج ذیل شعبوں میں زیادہ ہدایت شدہ تعلیم کی ضرورت ہوگی:

- بصارتی کارکردگی؛
- تصور کی نشوونما؛
- سننے کی مہارتیں؛
- آنکھ کی حالت کا علم؛
- حسی-حرکی مہارتیں / جسمانی تعلیم؛
- بصارتی معاون آلات اور موافقتیں؛
- مواصلات؛
- اورینٹیشن اور نقل و حرکت؛
- خود تصور اور سماجی کاری؛
- روزمرہ زندگی کی مہارتیں؛
- کیریئر کی تعلیم؛
- تفریح اور فرصت؛ اور
- جنسیت کی تعلیم۔

طالب علم کے پروگرام کے منصوبے کی تیاری اور نفاذ وسائل اور کلاس روم کے اساتذہ مربوط کرتے ہیں۔ پروگرام کے منصوبے میں طالب علم کی منفرد نصابی ضروریات شامل ہوں گی۔ سپورٹ ٹیم کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز کرنا ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو طالب علم کے ساتھ براہ راست کام کریں گے۔ یہ روزانہ، ہفتہ واریا طویل مدتی پروگرام کے منصوبوں پر بحث کا موقع فراہم کرتا ہے۔

کم بینائی والے بچے اسکول ڈویژن کی طرف سے فراہم کردہ پری اسکول خدمات کے اہل ہیں۔

بصارتی کارکردگی (Visual Efficiency)

بصارتی کارکردگی بصارتی تیزیت اور ادراک کا امتزاج ہے اور ہدایت کے ذریعے اسے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ کم بینائی والے طلبہ کو دیکھنا سکھانے سے ان کی بصارتی تیزیت نہیں بدلے گی، لیکن یہ انہیں اپنی بینائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بصارتی کارکردگی کی مہارتیں استعمال کریں تاکہ:

- مقامی تصورات اور ذخیرۃ الفاظ استعمال کریں؛
- چھونے والے ذرائع سے امتیاز کریں (بصارتی کام پر توجہ دیتے ہوئے)؛
- بصری امتیاز کریں؛
- سائز، رنگ، رنگ کے شیڈز،
- شکلیں، علامات اور صورتیں،
- چیزیں،
- مشابہ چیزوں کی اندرونی تفصیلات اور شکلوں میں مماثلتیں اور فرق دیکھیں؛
- ملانے اور چھانٹنے کے قابل ہوں؛
- بصارتی محرکات پر توجہ مرکوز کریں اور ان کا جواب دیں؛
- الگ الگ حصوں سے پورے کو بصارتی طور پر منظم کریں (مثلاً پزلز)؛
- تصویریں پہچانیں؛
- جانوروں اور گھریلو چیزوں کی سیاہ خاکے والی ڈرائنگز میں امتیاز کریں اور پہچانیں؛
- بصارتی تکمیل کی مہارتیں پیدا کریں؛
- معمولی ساختی تبدیلیوں کے باوجود عام چیزوں کی شناخت کریں،
- جزوی طور پر چھپی عام چیزوں کی شناخت کریں؛
- درست طریقے سے ٹریس اور نقل کریں (آنکھ-ہاتھ کو آرڈینیشن)؛
- سامنے اور پس منظر میں چیزوں کو پہچانیں؛
- بصارتی طور پر ٹریک کریں؛
- مجموعی حرکی حرکت کو آسان بنانے کے لیے بینائی استعمال کریں؛
- کسی شخص یا چیز کو تلاش کرنے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بینائی استعمال کریں؛
- باریک حرکی کاموں کو آسان بنانے کے لیے بینائی استعمال کریں؛

- بصارتی یادداشت استعمال کریں:
- مانوس ماحول میں تبدیلی کو پہچانیں،
- چیز کو وہاں سے نکالیں جہاں اسے آخری بار دیکھا گیا تھا،
- غائب چیز کی شناخت کریں؛
- اسکین کریں؛ اور
- قریب، درمیانی، دور اور پردہ بصراتی مہارتیں پیدا کریں۔

تصور کی نشوونما (Concept Development)

تصور کسی چیز کا ذہنی نمائندہ، تصویر یا خیال ہے جو ہونا چاہیے۔ کم بینائی والے طلبہ کو ذخیرۃ الفاظ اور حقیقی چیزوں، جسمانی حرکات اور تجریدی خیالات کے درمیان تعلق بنانے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اکثر بینائی کے ذریعے دستیاب اتفاقی سیکھ میں سے بہت کچھ چھوٹ دیتے ہیں اور اکثر غلط تصورات پیدا کر لیتے ہیں۔ تصور کی نشوونما میں مدد کے لیے درج ذیل مفید حکمت عملیاں ہیں۔

• نصاب سے متعلق ذخیرۃ الفاظ اور کلیدی تصورات کو زبانی وضاحتوں اور کثیر حسی نقطۂ نظر استعمال کرتے ہوئے ٹھوس تجربات کے ذریعے پہلے سے پڑھائیں۔ مثلاً، لائبریری کے وقت سے پہلے طالب علم کو لائبریری سے واقف کرائیں۔

• پہلے سے پڑھانا استاد کے علاوہ کسی اور کے ذریعے فراہم کیا جاسکتا ہے، جیسے ساتھی، بڑا طالب علم، تدریسی معاون یا والدین۔

• طالب علم کے پہلے سے پڑھانے اور کلاس روم کی ہدایت میں حصہ لینے کے بعد، تصورات اور ذخیرۃ الفاظ کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ کہیں، "بیان کریں کہ آپ اس اصطلاح سے کیا سمجھتے ہیں۔"

• تصورات کو مختلف ماحول میں بار بار تجربہ کرنا چاہیے تاکہ معلومات کو عام کیا جاسکے اور طالب علم مہارت حاصل کر سکے۔

سننے کی مہارتیں (Listening Skills)

بصارتی معذوری والے طلبہ اپنی زیادہ تر سیکھ سننے کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل شعبوں میں سننے کی مہارتیں پیدا کریں:

• سماعتی ادراک؛

• آواز کا امتیاز؛

- آواز کا مقام؛
- آوازوں اور چیزوں یا صورتحال کا تعلق؛
- سماعتی معلومات کی تشریح؛
- تسلسل کے لیے سننا؛
- تفصیل کے لیے سننا؛
- اہم خیالات کے لیے سننا؛
- نیا ذخیرہ الفاظ؛
- ہدایات پر عمل کرنے کے لیے سننا؛
- آڈیو کیسٹس سننا سیکھنا؛
- خلل کو کم کرنے کے لیے ایئر فون استعمال کرنا؛
- معلومات سننے سے پہلے جواب دینے والے سوالات پڑھنا؛
- ٹیپ کے چھوٹے حصے چلانا اور نوٹس بنانے کے لیے روکنا؛ اور
- ٹیپ پلیئر کی رفتار کو ایڈجسٹ کرنا۔

آنکھ کی حالت کا علم (Knowledge of the Eye Condition)

طالب علم کو سمجھنے اور دوسروں کو آرام سے اپنی بصارتی معذوری کی وجہ کے بارے میں بتانے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھ قبولیت اور بصارتی معذوری سے نمٹنے کی صلاحیت کی طرف لے جاتی ہے۔ طالب علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے:

- آنکھ کی ساخت اور فعل؛
- آنکھ کی دیکھ بھال اور خدمت؛
- طالب علم کی آنکھ کی حالت کی تشخیص، وجہ، مضمرات اور تشخیص مرض (prognosis)؛
- بینائی بڑھانے کے لیے ماحول کی موافقتیں؛ اور
- اگر ضرورت ہو تو بصارتی مشقیں۔

حسی-حرکی مہارتیں / جسمانی تعلیم (Sensory-Motor Skills/Physical Education)

کم بینائی بنیادی حرکی مہارتیں سیکھنے کی حوصلہ افزائی کو کم کر سکتی ہے اور ان مہارتوں کی مشق کا موقع کم کر سکتی ہے۔ جسمانی تندرستی کم بینائی والے طالب علم کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی دیکھنے والے بچے کے لیے۔ حسی-حرکی مہارتیں اچھے تصور کی نشوونما، جسمانی کنڈیشننگ اور اورینٹیشن اور نقل و حرکت کی مہارتوں کے لیے ضروری ہیں۔

کم بینائی والے طالب علم کو باقاعدہ جسمانی تعلیم پروگرام میں حصہ لینا چاہیے۔ طالب علم کی فعلی بینائی پر منحصر موافقتیں درکار ہو سکتی ہیں۔ وہ تمام سرگرمیوں اور ٹیم کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ متوازی جسمانی سرگرمی فراہم کی جانی چاہیے۔

بصارتی معاون آلات اور موافقتیں (Visual Aids and Adaptations)

کم بینائی والا طالب علم آنکھوں کی دیکھ بھال کے ماہر کی طرف سے تجویز کردہ آپٹیکل اور غیر آپٹیکل معاون آلات اور موافقتوں کے استعمال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ طالب علم کے بصارتی تجربے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے دور بین جیسے معاون آلات اور روشنی جیسی موافقتوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ان میں شامل کریں:

- آپٹیکل معاون آلات کے استعمال کی تربیت؛
- مناسب روشنی (آنکھ کی حالت پر منحصر، روشنی کی ضروریات مختلف ہوں گی)؛ اور
- ماحولیاتی موافقتیں:
- چمک سے بچیں،
- ہائی کنٹراسٹ فراہم کریں، اور
- بہترین بینائی کے لیے بچے کو بٹھائیں۔ بصارتی معاون آلہ استعمال کرتے وقت طالب علم کو کلاس روم میں مزید پیچھے بیٹھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

مواصلات (Communication)

کم بینائی والا طالب علم پڑھنے، سننے اور لکھنے کی اسائنمنٹس میں درج ذیل غور و فکر کے ساتھ باقاعدہ زبان کے فنون پروگرام میں شامل ہوگا۔

پڑھنے کی مہارتیں (Reading Skills)

کم بینائی والے طالب علم کو ایسے سائز کا پرنٹ چاہیے جو وہ دیکھ سکتا ہو۔ مناسب پرنٹ کا سائز فعلی بینائی کے اندازے سے طے ہوتا ہے۔ نوجوان بچوں کے لیے زیادہ تر کہانیوں کی کتابیں بڑے پرنٹ میں ہوتی ہیں۔ ایسی کتابیں منتخب کریں جن میں پرنٹ اور صفحے کے درمیان اچھا تضاد ہو۔

پڑھنے کے لیے بصارتی مہارتوں کا مؤثر استعمال درکار ہوتا ہے جیسے ٹریکنگ، اسکیننگ، فلکنگ اور نگاہ بدلنا۔ کم بینائی والے طلبہ کو روانی سے پڑھنے اور طویل مدت تک پڑھنے کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ توانائی صرف کرنی چاہیے۔ مختلف عمر کی سطحوں پر مختلف موافقتیں درکار ہو سکتی ہیں۔

• حروف تہجی پڑھاتے وقت کثیر حسی نقطہ نظر استعمال کریں۔ الفاظ کی ابتدائی آوازوں کو واضح کرنے کے لیے حقیقی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں۔

• پڑھنے کی مقدار میں تبدیلی کریں اور اگر ضروری ہو تو آڈیو کیسٹس فراہم کریں یا کسی سے طالب علم کو پڑھ کر سنوائیں۔

• اگر طالب علم کو ٹریک کرنے اور/یا متن میں جگہ تلاش کرنے میں دشواری ہو تو لائن مارکر استعمال کریں۔

• طالب علم کو پڑھتے وقت اہم معلومات کو نمایاں کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔

• اگلی لائن تلاش کرنے کے لیے پرنٹ کے صفحے پر ٹائپو سکوپ یا ٹیمپلیٹ استعمال کریں۔

• طالب علم کو صفحے کو آنکھوں کے جتنا قریب ضروری ہو پکڑنے کی اجازت دیں تاکہ پرنٹ پڑھ سکے۔

• طالب علم کو بصارتی کاموں سے وقفے لینے کی اجازت دیں۔ طلبہ تھک سکتے ہیں اگر وہ طویل مدت تک بصارتی کاموں میں مصروف ہوں۔

• طالب علم کو ضرورت پڑنے پر وقفے کی درخواست کی ذمہ داری لینے کی حوصلہ افزائی کریں۔

• بصارتی سرگرمیوں کو غیر بصارتی سرگرمیوں کے ساتھ ملائیں۔

• بولڈ، اچھی طرح فاصلے والے حروف اکثر بڑے حروف سے دیکھنے میں آسان ہوتے ہیں۔

• پرنٹ کو پڑھنے میں آسان بنانے کے لیے انتہائی متضاد حروف استعمال کریں۔

• بڑے پرنٹ کی کتابیں Learning Resource Centrelibraries سے دستیاب ہیں۔

سننے کی مہارتیں (Listening Skills)

• جیسا کہ پہلے حصے میں بحث ہوئی، معذور بینائی والا طالب علم سننے کی مہارتوں پر زیادہ انحصار کرے گا۔

ان مہارتوں کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔

- جب آپ بات کر رہے ہوں تو براہِ راست طالب علم کو دیکھیں اور اسے نام سے مخاطب کریں۔
- واضح، قدرتی آوازیں بات کریں۔ یقینی بنائیں کہ طالب علم بھی براہِ راست آپ کو دیکھ رہا ہے۔
- تمام ہدایات زبانی دیں۔ نوٹ کریں کہ طالب علم ایک وقت میں کتنے مراحل پر عمل کر سکتا ہے۔
- سننے کی مہارتوں کی نشوونما کی حوصلہ افزائی کے لیے آڈیو کیسٹس، ریکارڈز، ریڈیو اور ٹی وی سے واقفیت فراہم کریں۔

لکھنے کی مہارتیں (Writing Skills)

- طالب علم کو اس پرنٹ کے سائز میں لکھنے کی اجازت دیں جو اسے پڑھنے میں آسان ہو۔ طالب علم کو صفحے کو آنکھوں کے جتنا قریب ضروری ہو پکڑنے کی اجازت دیں تاکہ پڑھ سکے۔
- پڑھنے کے قابل ہونا اندازِ رفتار سے زیادہ مطلوب ہے۔ طالب علم جڑے ہوئے لکھنے (cursive writing) کی بجائے چھاپنے (printing) کو ترجیح دے سکتا ہے۔
- طالب علم کی تحریر کو زیادہ پڑھنے کے قابل بنانے اور طالب علم کے لیے لکھنا آسان بنانے کے لیے فیلٹ پین، پرائمری پنسل، ابھری اور بولڈ لائنوں والا کاغذ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- طالب علم کو ابتدائی عمر میں کمپیوٹر تک رسائی فراہم کریں، خاص طور پر اگر طالب علم لکھنے کی مہارتوں میں دشواری کا مظاہرہ جاری رکھے۔ اسکرین بڑھانے والا سافٹ ویئر خرید جاسکتا ہے۔
- کم بینائی والے طالب علم کے لیے کی بورڈنگ کی مہارتیں اہم ہیں۔ کئی کی بورڈنگ سافٹ ویئر پروگرام دستیاب ہیں جن میں تقریر شامل ہے۔ بڑے پرنٹ کے حروف کے اوپر لے کی بورڈنگ کے لیے Resource Center سے دستیاب ہیں۔

اورینٹیشن اور نقل و حرکت (Orientation and Mobility)

کم بینائی والے بچوں کو ایسی تکنیکیں سیکھنے کی ضرورت ہے جو ابتدائی عمر سے محفوظ اور مؤثر سفر کو ممکن بنائیں اگر انہیں اپنے ماحول میں آزادانہ طور پر کام کرنا ہے اور اس کے بارے میں جانتا ہے۔

خود تصور اور سماجی کاری (Self Concept and Socialization)

بصارتی معذوری طالب علم کی مناسب سماجی رویوں کا مشاہدہ کرنے اور بنیادی زندگی کی مہارتیں سیکھنے کی صلاحیت میں مداخلت کر سکتی ہے۔ سماجی اور زندگی کی مہارتیں جو دیگر طلبہ قدرتی طور پر دوسروں کا مشاہدہ کر

کے اور نقل کر کے سیکھتے ہیں، کم بینائی والے طالب علم کو خاص طور پر سکھانی چاہئیں۔ طالب علم کو درج ذیل مہارتیں سکھائیں اور حوصلہ دیں۔

- بولنے والے کی طرف مڑیں اور اس کا سامنا کریں۔ کچھ طلبہ کی غیر مرکزی دیکھنے (eccentric viewing) ہوتی ہے اور انہیں سر جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس شخص کو دیکھ سکیں جس سے وہ بات کر رہے ہیں۔
- کم بینائی والے طلبہ میں عام رویوں جیسے ہلنا اور بار بار آنکھیں ملنا میں تبدیلی کریں۔
- گفتگو یا کھیل کی سرگرمی شروع کریں۔ طالب علم اکثر خاموشی سے انتظار کرے گا جب تک کوئی اور پہل نہ کرے۔ طالب علم کے ساتھ مناسب گفتگو شروع کرنے والے سکھائیں اور مشق کریں۔
- دوسروں کے ساتھ گفتگو میں حصہ لیں۔ اسے عمر کے مناسب ذخیرہ الفاظ اور موضوعات استعمال کرنے چاہئیں۔
- دوسروں کی ذاتی جگہ کو سمجھیں اور اس کا احترام کریں۔ طالب علم کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ دوسروں سے، شائستہ انداز میں، اس کی ذاتی جگہ کا احترام کرنے کے لیے کیسے کہنا ہے۔
- معلومات حاصل کرنے اور درست تصورات بنانے کے لیے چیزوں کو چھو کر تلاش کریں۔ تاہم، طالب علم کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ چھونا کب قابل قبول ہے، خاص طور پر جب یہ مناسب اور نامناسب جسمانی رابطے سے متعلق ہو۔
- اپنی ضروریات بتائیں۔
- مختلف گروہی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔
- غیر زبانی مواصلاتی مہارتیں سیکھیں۔ چہرے کے تاثرات، جسمانی زبان اور اشاروں کی تشریح میں مدد دیں۔
- شائستہ رویہ سیکھیں اور ظاہر کریں۔
- جذبات کو پہچانیں اور انہیں سماجی طور پر قابل قبول طریقوں سے ظاہر کریں۔
- مسئلہ حل کرنے اور فیصلہ سازی میں مہارتیں پیدا کریں۔
- مثبت اور درست خود تصویر پیدا کریں۔
- اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو پہچانیں۔
- اپنی بصارتی معذوری کے بارے میں احساسات کو پہچانیں اور بائیں۔
- ساتھی دباؤ سے آگاہ ہوں اور اس کا جواب دیں۔

• نوجوانوں کے لیے مشاورت اور مدد تک رسائی حاصل کریں۔ یہ خدمت اسکول کونسلر، ماہر نفسیات، یا تعلیمی مشیر سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب طلبہ بلوغت کا تجربہ کریں گے، تعلقات اور ڈیٹنگ کے بارے میں سیکھیں گے اور گاڑی چلانے کے قابل نہ ہونے کے امکان سے نمٹنا ہوگا۔ طالب علم کے لیے اس وقت مضبوط خود تصویر پیدا کرنا خاص طور پر اہم ہے جب ساتھی قبولیت ظاہری شکل اور رویے سے متاثر ہوتی ہے۔

روزمرہ زندگی کی مہارتیں (Daily Living Skills)

تمام بچوں، دیکھنے والے اور بصارتی معذور دونوں، کو خود دیکھ بھال کی مہارتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کم بینائی والے بچوں کے ساتھ، اس میں کام کے تجزیے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ براہ راست پڑھانا لگ سکتا ہے۔ تمام بچوں کے لیے خاندانی کاموں میں حصہ ڈالنے کے قابل ہونا ضروری ہے، خود اعتمادی پیدا کرنے اور آزادانہ طور پر کام کرنا سیکھنے دونوں مقاصد کے لیے۔ طالب علم کو درج ذیل میں مہارتوں کی ضرورت ہے:

- ذاتی حفظان صحت؛
- کپڑے پہننا، تنظیم اور کپڑوں کی دیکھ بھال؛
- میز کے آداب اور کھانا؛
- باہر کھانا؛
- پیسے کا انتظام؛
- کھانا تیار کرنا؛
- گھر کی دیکھ بھال؛
- خریداری؛
- ٹیلی فون اور دیگر مواصلاتی ٹیکنالوجی کا استعمال؛
- صحت اور حفاظت؛
- وقت کے تصورات؛
- خود وکالت؛
- مسئلہ حل کرنا اور فیصلہ سازی؛ اور

- ذاتی جائیداد اور وقت کی تنظیم:
- کتابیں، مواد اور سامان منظم کریں۔ جب ان کی ضرورت ہو تو مطلوبہ چیزیں تلاش کریں اور جب ان سے فارغ ہوں تو انہیں رکھ دیں،
- وقت پر کام مکمل کرنے کی سمجھپیدا کریں،
- وقت کے استعمال کی منصوبہ بندی اور کاموں کے درمیان وقت کو متوازن کرنے کا طریقہ سیکھنے کے قابل ہوں،
- مواد اور سامان کی ذمہ داری لیں،
- ایڈریس بکس، کیلنڈر، جرنل اور دیگر ذاتی تنظیمی اوزار استعمال کریں،
- ٹائم ٹیبل پر عمل کرنے کے قابل ہوں، اور
- اسائنمنٹس، گریڈز اور شیڈول کی تبدیلیوں کا حساب رکھیں۔

کیریئر کی تعلیم (Career Education)

کم بینائی والے بالغوں کی بے روزگاری اور کم روزگاری ایک مسلسل تشویش ہے۔ بصارتی معذوری والے بالغوں کی ملازمت کے قابل ہونے کے لیے کیریئر کی تعلیم ضروری ہے۔ کم بینائی والے طلبہ کو جان بوجھ کر اور براہ راست کیریئر کے وسیع اقسام کے اختیارات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

کیریئر کے تعلیمی نصاب جو دیکھنے والے بچوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں انہیں بصارتی معذوری والے طلبہ کے ساتھ کام کرنے والے استاد کی طرف سے ضمنی ہدایت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ چھوٹے طلبہ کے لیے تلاش کی سطح پر کیریئر کی تعلیم کا مطلب کمیونٹی میں بہت سے فیلڈ ٹرپ ہو سکتے ہیں تاکہ کم بینائی والے طالب علم کو لوگوں اور کام کی صورتحال سے واقفیت ہو۔ طالب علم کو اپنی حدود اور صلاحیت کی حقیقت پسندانہ سمجھپیدا کرنی چاہیے۔ درج ذیل پر زور دیں:

- خود آگاہی؛
- طاقتیں؛
- کمزوریاں؛
- دلچسپیاں / صلاحیتیں؛
- اقدار؛
- اہداف؛

- پیشہ ورانہ مہارتیں؛
 - کیریئر سے آگاہی؛
 - کیریئر کی تلاش؛
 - ملازمت کی تیاری؛
 - انٹرویو کی مہارتیں؛
 - ریزیوے لکھنا؛
 - درخواست فارم؛
 - ملازمت تلاش کرنے کی مہارتیں؛
 - معذور افراد کے لیے ملازمت امداد کے لیے فنڈنگ کے ذرائع سے آگاہی؛
 - آگاہی کہ بہت سے پوسٹ سیکنڈری اداروں میں معذوری والے طلبہ کے لیے سپورٹ خدمات ہوتی ہیں؛
- اور
- بصارتی معذوری سے متعلق ملازمت کے مسائل (ممکنہ آجروں کو مطلع کرنا، کام کی جگہ میں موافقتیں)۔

تفریح اور فرصت (Recreation and Leisure)

تفریح اور فرصت کی سرگرمیاں طالب علم کی عمر اور فعلی بینائی کے ساتھ مختلف ہوں گی۔ یہ سرگرمیاں کھلونوں سے دکھاوے اور کھیلنے سے لے کر فنی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی، سامان اور اوزار کے استعمال تک ہو سکتی ہیں۔ تفریح اور فرصت طلبہ کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے، فعال ہونے، خود قدر محسوس کرنے، تناؤ چھوڑنے، دوسروں کو دکھانے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور پہچان یا انعامات حاصل کرنے کے موقع فراہم کرتی ہیں۔ بہت سی تفریح اور فرصت کی سرگرمیاں عمر بھر کی مہارتوں کو فروغ دیتی ہیں جو تسلی بخش زندگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تفریح اور فرصت کی سرگرمیاں طلبہ کو بہت سے نصابی شعبوں میں حاصل کردہ مہارتوں کو مربوط کرنے اور لاگو کرنے کے موقع فراہم کرتی ہیں۔ اندھے پن اور کم بینائی والے طلبہ کو ان سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اضافی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ طالب علم کو پیدا کرنا چاہیے:

- فرصت کی سرگرمیوں سے آگاہی اور فرصت کے وقت کو اچھی طرح منظم کرنے کا طریقہ؛
- تنہا کھیل اور تنہا فرصت کی سرگرمیوں کے لیے مہارتیں؛
- سماجی کھیل اور سماجی فرصت کی سرگرمیوں کے لیے مہارتیں؛

- کمیونٹی کلب یا گروہ کے بارے میں سیکھنے یا اس میں شامل ہونے میں دلچسپی؛
- جسمانی کھیل، جسمانی کھیلوں، جسمانی تندرستی اور کھیلوں میں دلچسپی؛
- پالتو جانوروں اور فطرت سے لطف اندوزی؛
- موسیقی اور رقص سے لطف اندوزی؛
- شوق میں دلچسپی؛
- فرصت کی سرگرمیوں کے طور پر پڑھنے، لکھنے، بولنے اور ڈرامے کے لیے مہارتیں؛
- فرصت کے مقاصد کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے مہارتیں؛
- سبق لینے میں دلچسپی (موسیقی، جم، ڈرامہ، تیراکی، رقص)؛ اور
- بصارتی معذوروں کے لیے دستیاب کیمرہ میں شرکت میں دلچسپی۔

2.3 دوسری قسم: سماعت کی معذوری (Hearing Impairment)

سماعت وہ راستہ ہے جس کے ذریعے زبانی گفتگو (verbal communication) فروغ پاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مکمل طور پر نہیں سنتا تو غالباً وہ غلط بولے گا۔ سماعت تعلیم و تدریس اور تعلیمی ترقی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ سماعت کے نقائص کی بروقت تشخیص بچے کی مجموعی نشوونما کے لیے اہم ہے۔ سماعت کے نظام میں نقص معلومات کے ادراک میں مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ سماعت کی معذوری ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں ہمارے علم کو کم کر دیتی ہے۔

سماعت کے نقصان کے شکار بچوں کو ایک یا دونوں کانوں سے سننے میں مشکل ہو سکتی ہے یا ان میں سننے کی صلاحیت بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کی معذوری کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، مثلاً 'deaf', 'partially deaf', 'deaf mute', 'hard of hearing' اور 'partial hearing' وغیرہ۔ اس معذوری کی کثیر الجہت نوعیت کو سمجھنے کے لیے کچھ اہم متغیرات درکار ہیں جن کی بنیاد پر اس قسم کی درست درجہ بندی پر سوالات اٹھتے ہیں۔ کچھ اہم متغیرات یہ ہیں: سماعت کے نقصان کی شدت (degree)، آغاز کی عمر (age of onset) اور سماعت کے نقصان کی نوعیت۔ اسی طرح وہ بچے جن کی شمولیت کان کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے ہوتی ہے انہیں 'بہرے بچے' (deaf children) کہا جاتا ہے۔ وہ بچے جو بہرے پیدا ہوتے ہیں انہیں پیدائشی بہرے (congenitally deaf) کہا جاتا ہے جبکہ وہ بچے جنہوں نے پیدائش کے بعد سننے کی صلاحیت کھو دی انہیں 'adventitiously deaf' کہا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام اصطلاحات کے علاوہ ماہرین نے سماعت کی معذوری کو دو ذیلی گروہوں میں تقسیم کیا ہے: (i) pre-lingual deaf - سماعت کی معذوری تقریر اور زبان کے نمونوں کی نشوونما سے پہلے واضح ہوتی ہے، اور (ii) post-lingual deaf - سماعت کی معذوری تقریر اور زبان کے نمونوں کے حصول کے بعد واضح ہوتی ہے۔

سماعت کی معذوری کو عام طور پر slight, mild, moderate, severe اور profound کی اصطلاحات سے بیان کیا جاتا ہے، جو فریکوئنسیوں (500 سے 2,000Hz) کے دوران ڈیسی بل (decibel) میں ناپی گئی اوسط سماعت کی سطح پر منحصر ہوتا ہے۔

کان (The Ear)

انسانی کان کے بہت سے حصے ہوتے ہیں۔ یہ حصے بیرونی، درمیانی اور اندرونی کان - ہمیں آوازیں سننے میں مدد دیتے ہیں۔ بیرونی کان بیرونی کان (pinna) اور سماعت کی نالی (auditory canal) - ایک انچ لمبا اور 1/4 انچ چوڑا راستہ) پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیرونی کان کان کے پردے (eardrum / tympanic)

membrane) پر ختم ہوتا ہے۔ بیرونی کان آوازیں وصول کرتا ہے اور انہیں درمیانی کان تک پہنچاتا ہے۔ درمیانی کان ہوا سے بھرا ہوتا ہے اور اس میں تین نہایت چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں - ossicles: maleus - incus اور stapes (جنہیں ossicular chain کہا جاتا ہے)۔ ossicular chain کان کے پردے اور اندرونی کان کے داخلے کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔

آوازی کی لہریں کان کے پردے اور ossicular chain (درمیانی کان کی ہڈیاں یا درمیانی کان کی جگہ / سیال) سے گزرنے کے بعد اندرونی کان میں داخل ہوتی ہیں۔ اندرونی کان میں نیم دائرے نما نالیاں - cochlea - ہوتی ہیں جو گھونگھے کے خول جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ حصہ ایسے سیال سے بھرا ہوتا ہے جس میں اعصابی سرے (nerve-endings) ہوتے ہیں۔ یہ درمیانی کان سے ارتعاشی تحریکات (stimuli) وصول کرتا ہے اور انہیں سماعت کی عصب (auditory nerve) تک منتقل کرتا ہے۔ سماعت کی عصب تحریکات (پیغام) کو دماغ تک پہنچاتی ہے تاکہ ان کی تشریح کر کے کوئی عمل کیا جاسکے۔

اندرونی کان آوازی کی لہروں کو برقی تحریکات (electric impulses / currents) میں تبدیل کرتا ہے اور آواز کے پیغامات کو سماعت کی عصب کے ذریعے سگنلز کی صورت میں دماغ تک پہنچاتا ہے۔ انسانی کان کی ساخت درج ذیل خاکے میں دی گئی ہے۔

ماخذ: Harvard Medical School Centre for Hereditary Deafness (2004). Common: Causes of Hearing Loss for Parents and Families, (p.1)

سماعت کے نقصان کی نوعیت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ کان کا کون سا حصہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔

سماعت کے نقصان کی اقسام (Types of the Hearing Loss)

سماعت کے نقصان کی دو اہم اقسام ہیں: conductive hearing loss اور sensorineural hearing loss۔ بعض اوقات مخلوط (mixed) سماعت کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔

Conductive hearing loss: بچوں کی سماعت کی معذوریوں میں conductive hearing loss عام ہے۔ یہ بیرونی کان اور درمیانی کان کے ذریعے آواز کی لہروں کی ترسیل کے نظام (sound conduction) میں نقص کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیرونی اور / یا درمیانی کان میں کوئی عارضی یا مستقل رکاوٹ یا غیر معمولی حالت conductive hearing loss کا باعث بنتی ہے۔ conductive hearing loss کی ایک اور عام وجہ درمیانی کان کی سوزش یا انفیکشن ہے جسے otitis media کہا جاتا ہے۔

Sensori-neural hearing loss: sensori-neural hearing loss (genetic) اصل کی ہو سکتی ہے یا بیماری یا چوٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ اصل اعصابی سروں کے نقصان یا عدم موجودگی

کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا اگر آواز کو محسوس نہ کیا جاسکے تاہم بلند تحریک بھی ہو سکتی ہے۔ اس حالت کو کبھی کبھی perceptive loss بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مداوا صرف بچے کو دیگر مواصلاتی مہارتیں سکھا کر کیا جاسکتا ہے۔

Mixed hearing loss: بعض اوقات بچوں میں conductive اور sensori-neural دونوں قسم کے سماعت کے نقصان ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔

2.3.1 سماعت کی معذوری کے اسباب (Causes of Hearing Impairments)

اب تک سماعت کی معذوری کے کئی اسباب معلوم ہو چکے ہیں۔ سماعت کی معذوری کے اسباب کو عام طور پر دو پہلوؤں سے درجہ بندی کیا جاتا ہے: exogenous یا endogenous - Exogenous کا مطلب ہے کہ سبب بننے والا عامل / عنصر جسم کے باہر سے آتا ہے، جیسے بیماری، زہریلا پن یا چوٹ، اور سماعت کے نظام کی آوازیں وصول کرنے اور منتقل کرنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد ہونے والے سماعت کی معذوری کے اسباب کو 'adventitious' اسباب بھی کہا جاتا ہے۔ Endogenous سماعت کی معذوری پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہے۔ یہ یا تو والدین کے جینز سے منتقل (وراثتی) ہوتی ہے یا جنین کی نشوونما کے دوران کوئی غیر معمولی حالت ہوتی ہے۔ بہرے پن کے اسباب کو وقوع کے وقت کی بنیاد پر بھی گروہ بند کیا جاتا ہے: pre-natal (پیدائش سے پہلے)، peri-natal (پیدائش کے دوران)، اور post-natal (پیدائش کے بعد)۔

آئیے بچوں میں بہرے پن اور شدید سماعت کی معذوری کے درج ذیل عام اسباب پڑھتے ہیں:

i. وائرس کا انفیکشن (Virus Infection)

بعض اوقات بہرے پن کا pre-natal سبب وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے۔ سب سے عام maternal rubella ہے جسے German measles بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ حاملہ عورت کو متاثر کرتا ہے تو نشوونما پاتے بچے میں بہرے پن، بصری معذوری، دل کے امراض اور دیگر کئی سنگین معذوریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ Maternal rubella سماعت کی معذوری کا ایک اہم سبب بنا ہوا ہے، لیکن rubella کی مؤثر ویکسین دستیاب ہے اور بچپیدا کرنے کی عمر کی خواتین کو یہ لگوانی چاہیے۔

میننجائٹس (Meningitis) adventitious سماعت کی معذوری (post-natal یا acquired) کا اہم سبب ہے۔ یہ بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہونے والا انفیکشن ہے۔ یہ بیماری اندرونی کان کے حساس صوتی آلات کو تباہ کر دیتی ہے۔ دیگر اثرات کے ساتھ ساتھ جسم کے توازن میں مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ وہ بچے

جو مینجائٹس کی وجہ سے اپنی سماعت کھو دیتے ہیں انہیں گہرا (profound) سماعت کا نقصان ہوتا ہے لیکن ان میں دیگر اضافی معذوریوں ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔

ii. وراثت (Heredity)

وراثت (Heredity) سماعت کی معذوری کا ایک اور اہم سبب ہے۔ اسے پیدائشی (congenital) سماعت کی معذوری بھی کہا جاتا ہے (پیدائش کے وقت موجود)۔ اس بات کے مضبوط شواہد ہیں کہ پیدائشی سماعت کی معذوری خاندانوں میں چلتی ہے۔

iii. قبل از وقت پیدائش اور (Prematurity And Anoxia)

بچے کی قبل از وقت پیدائش اور حمل کی دیگر پیچیدگیاں بہرے پن اور دیگر معذوریوں کے خطرے کو بڑھاتی دکھائی دیتی ہیں۔ Anoxia (آکسیجن کی کمی) سماعت کی معذوری کا ایک اور peri-natal سبب ہے۔ دونوں صورتوں میں بہرے پن کی نوعیت sensori-neural ہو سکتی ہے۔

iv. Otitis Media

سماعت کی معذوری کا ایک اور اہم سبب otitis media ہے۔ یہ درمیانی کان کا انفیکشن یا سوزش ہے۔ Otitis media کی وجہ سے کان میں سیال جمع ہو سکتا ہے اور اگر علاج نہ کیا جائے تو کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے۔

v. ادویات (Drugs)

حمل کے دوران ماں کی طرف سے لی جانے والی بعض ادویات بھی بچے میں سماعت کی معذوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر دوا 'Thalidomide' اگر لی جائے تو کان کی بناوٹ میں نقص پیدا کر سکتی ہے۔ دیگر مثالوں میں quinine اور streptomycin شامل ہیں۔

vi. دیگر اسباب (Other Causes)

دیگر اسباب جن میں طبی علاج / ترقی کی وجہ سے کمی آئی ہے ان میں ماں اور بچے کے درمیان خون (Rh) کی عدم مطابقت، مپس (mumps)، خسرہ (measles) یا چوٹ شامل ہیں۔ متعدد معذوریوں والے بچوں میں بھی نمایاں سماعت کی معذوری ہوتی ہے۔

کچھ ماحولیاتی عوامل جیسے شور کی آلودگی، بلند آوازوں یا صنعتی شور کی بار بار نمائش، جیٹ طیارے، بندوقیں، بڑھائی گئی موسیقی، زیادہ آواز پر پورٹبل ہیڈ فون سیٹس کا وسیع استعمال اور گہرے سمندر میں بار بار غوطہ خوری سماعت کی معذوری کے اسباب کے طور پر بڑھ رہے ہیں۔

2.3.2 تعلیمی مضمرات (Educational Implications)

سماعت کا نقصان چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو زبان سیکھنے کو متاثر کر سکتا ہے اور تعلیمی ترقی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مشکل کی حد کا انحصار ان باتوں پر ہوتا ہے:

• نقصان کی نوعیت (sensory-neural یا conductive)،

• نقصان کی شدت،

• آغاز کی عمر،

• تشخیص کا وقت،

• مداخلت (intervention) کا وقت،

• گھریلو ماحول، اور

• دیگر معذوریوں کی موجودگی۔

بنیادی اہمیت کے چند نکات ذیل میں بیان کیے گئے ہیں:

سماعت کے نقصان کی شدت (Degree of hearing loss)

سماعت کے نقصان کی مختلف سطحیں ہیں جو mild سے profound تک ہوتی ہیں۔ نقصان کی شدت ڈیسی بلز (decibels) میں بیان کی جاتی ہے۔ بڑا عدد زیادہ شدید نقصان ظاہر کرتا ہے کیونکہ بچہ شناخت شدہ سطح سے نیچے کچھ بھی سننے سے قاصر ہوتا ہے۔ فرد کی تقریر اور زبان شامل فریکوئنسیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر نقصان تقریر کی فریکوئنسیوں (500، 1000، 2000 Hz) میں زیادہ ہے تو معذوری شدید ہوگی۔ سماعت کا نقصان ایک کان (unilateral) یا دونوں کانوں (bilateral) میں ہو سکتا ہے۔ ایک کان کے نقصان والے افراد معمول کے مطابق کام کر سکتے ہیں سوائے آوازوں کا مقام معلوم کرنے میں مشکلات کے۔ mild سے moderate دو طرفہ نقصان والے افراد amplification سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آواز کی شدت بڑھا کر اسے طاقتور بنانا۔ 60 سے 90 db کے شدید نقصان والے افراد کو amplification کے ساتھ اپنی بچی ہوئی سماعت استعمال کرنے کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ گہرے گہرے افراد (90 db سے زیادہ دو

طرفہ نقصان) بات چیت کے لیے دستی زبان (manual language) اور ہونٹ پڑھنے (speech reading) پر انحصار کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی amplification سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سماعت سے محروم بچے زبان کے فہم اور استعمال میں سچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ زبان کے نظام کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ قدم ملا کر چلنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔

آغاز کی عمر (Age of Onset)

بعض اوقات سماعت کا نقصان زبان سیکھنے کی عمر (prelingual age) سے پہلے یا پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ چونکہ بچہ اس عرصے میں زبان نہیں سیکھتا اس لیے تقریر متاثر ہوتی ہے۔ زبان کی نشوونما کا 80 فیصد عام طور پر 3 سال کی عمر تک ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جس کی سماعت کا نقصان زبان سیکھنے کی عمر (post lingual age) کے بعد ہوا اسے اس بچے کے مقابلے میں شدید تعلیمی مسائل کا امکان کم ہوتا ہے جسے prelingual سماعت کا نقصان ہوا۔ چونکہ سماعت کا نظام معمول کی زبان سیکھنے کا اہم ذریعہ ہے، اس لیے prelingual سماعت کے نقصان والے بچے اپنے ارد گرد سے آنے والی مسلسل زبانی معلومات سے معمول کی زبان کی نشوونما کے لیے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس لیے انہیں عام زبان کی معمولی نمائش کے بجائے واضح تدریس کی ضرورت ہوتی ہے۔

شناخت اور مداخلت کا وقت (Time of Identification and Intervention)

مداخلت کے لیے بچے کی شناخت جلد از جلد ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر وہ زبان سیکھنے کے مراحل گزار لے تو اس کے لیے معمول کے مطابق بات چیت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بچوں کی شناخت جلد از جلد ہونی چاہیے تاکہ انہیں پیچیدہ لسانیات کے بعد سماعت میں تمیز کے مواقع دیے جاسکیں۔ انہیں اپنی بچی ہوئی سماعت استعمال کرنے کی تربیت / تدریس دی جانی چاہیے تاکہ وہ زبان کی مہارتیں سیکھنے کے لیے ضروری بنیادی عناصر اسی ترتیب میں حاصل کریں جیسے سننے والے بچے حاصل کرتے ہیں۔

ذہانت (Intelligence)

روایتی طور پر ذہانت کا اندازہ معیاری ذہانت کے ٹیسٹوں سے لگایا جاتا ہے جن کے نتائج IQ اسکور میں ملتے ہیں۔ تحقیقی مطالعات سے ظاہر ہوا کہ سماعت سے محروم بچوں کی ذہانت کی سطحیں اپنے غیر معذور عام سننے والے ہم عمر بچوں کے برابر ہوتی ہیں جب انہیں زبانی ذہانت کے پیمانوں کے بجائے عملی ٹیسٹوں (performance tests) سے جانچا جائے۔ اس طرح کارکردگی کے ذہانت کے ٹیسٹوں سے باہر کئی ذہانت پر سماعت کے نقصان کا اثر نظر نہیں آتا۔

زبان (Language)

سماعت سے محروم بچوں کی زبان سماعت کے نقصان سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ اتنی بھرپور نہیں ہوتی جتنی عام سننے والے فرد کی ہوتی ہے۔ عام طور پر شدید اور گہرے سماعت کے نقصان والے بچوں کا ذخیرہ الفاظ بہت کم اور ٹھوس ہوتا ہے۔ ان کے جملے چھوٹے اور کم پیچیدہ ہوتے ہیں۔ سماعت سے محروم طلبہ کو گرامر کی ساخت میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ جمع، زمانے (tenses)، اضافت (possessives)، حروف جار (prepositions) اور دیگر چھوٹے الفاظ جیسے 'a' اور 'the' چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طلبہ بہت سادہ فاعل - فعل - مفعول (subject-verb-object) کی ترتیب استعمال کرتے ہیں۔ محققین نے سماعت سے محروم بچوں کو زبان سکھانے کے لیے total communication - تقریر کے ساتھ غیر زبانی اشاروں / اشاروں کی زبان (sign language) کا استعمال - کے بھرپور استعمال کی سفارش کی ہے۔

تقریر (Speech)

سماعت سے محروم بچے آوازیں صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ تلفظ (articulation) صرف مسئلے کا ایک حصہ ہے جو انہیں چھپے رکھتا ہے۔ دیگر عوامل خراب ٹائمنگ اور ردھم ہیں۔ سماعت سے محروم بچوں میں زور دار اور بے زور دونوں ہجوں (syllables) کو لمبا کرنے اور ضرورت سے زیادہ اور لمبے وقفے ڈالنے کا رجحان ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ سست تقریر ہوتی ہے۔ سر (pitch) میں تغیر غیر معمولی ہوتا ہے اور اس میں لسانی مواد کی کمی ہوتی ہے۔ ناک سے بولنا (nasality) بھی ایک عام مسئلہ ہے۔ ایک آواز کی جگہ دوسری آواز رکھنا اور ایک آواز کی آواز داری کو لمبا کرنا دیگر رویے ہیں جو سماعت سے محروم بچوں کی تقریر کی ناقابل فہمی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اس طرح ناقابل فہم تقریر انہیں اسکولوں میں کارکردگی میں چھپے رکھتی ہے۔

تعلیمی کامیابی (Academic achievement)

سماعت سے محروم بچے اپنی سیکھنے کی صلاحیت کے مقابلے میں کمزور تعلیمی کامیابی دکھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ شعبہ مطالعہ (reading) ہے کیونکہ یہ زبان کے علم پر مبنی ہے۔ تصور سازی (concept formation) وہ شعبہ ہے جہاں اساتذہ کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک بار تصورات بن جائیں تو سماعت سے محروم بچوں کی ترقی میں کوئی مشکل نہیں۔ سماعت کے نقصان کے تعلیمی مضمرات کو ان ذرائع سے بھی حل کرنا چاہیے:

- اضافی معذوریوں کو کم سے کم کرنا
- سماعت کے نقصان کی جلد شناخت اور مداخلت
- اسکولنگ جلد شروع کرنا

• مطالعہ کی اچھی عادات

Total communication •

تشخیص (Assessment)

Audiological: سماعت کے نقصان کی پیمائش تکنیکی طور پر audiologist کے ذریعے ہونی چاہیے۔ تعلیمی اصطلاحات میں لکھی گئی آلے کی تشخیص کی رپورٹیں سماعت سے محروم بچوں کو تعلیمی طور پر ترقی کرنے میں بڑی مددگار ہوتی ہیں۔ سماعت ناپنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے audiometer کہا جاتا ہے۔ یہ احتیاط سے ایڈجسٹ شدہ سروں (tones) کی ایک سیریز دکھاتا ہے جو فریکوئنسی (pitch) اور شدت (loudness) میں مختلف ہوتے ہیں۔ جانچ خاص طور پر تیار کردہ ساؤنڈ پروف کمرے / بوتھ میں کی جاتی ہے۔ اس جانچ کے نتائج ایک گراف پر دکھائے جاتے ہیں جسے audiogram کہا جاتا ہے۔

Speech: تقریر کی تشخیص کو speech audiometry کہا جاتا ہے۔ تقریر کے فہم کی جانچ صرف اس وقت کی جاتی ہے جب بچے کی کچھ زبان نشوونما پا چکی ہو۔ طبی جانچ کے معمول کے طریقہ کار نوزائیدہ یا چھوٹے سماعت سے محروم بچوں کے لیے استعمال نہیں کیے جاسکتے جن کی زبان نشوونما نہیں پا چکی۔

ایسے مختلف طریقے ہیں جو یہ تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں:

• بچہ کس سطح پر تقریر سنتا ہے؟

• تقریر کتنی اچھی طرح سمجھی جاتی ہے؟

تشخیص کار اسپیکر یا ہیڈ فون اور مختلف قسم کے مواد استعمال کر سکتا ہے۔ بچے تقریر کے ماخذ (لاؤڈ اسپیکر) کی طرف دیکھ کر، تصویروں کی طرف اشارہ کر کے، یا واقعی وہ الفاظ دہرا کر جواب دیتے ہیں جو وہ سنتے ہیں۔

بہترین سننے کی حالت میں تقریر سمجھنے کی فرد کی صلاحیت کا تعین کرنے کے لیے، ایک بچے والے الفاظ کی فہرستیں کان کے فون یا لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں۔ نتائج ان الفاظ کے فیصد کے طور پر رپورٹ کیے جاتے ہیں جنہیں بچہ صحیح طور پر شناخت کرتا ہے۔ شدید سے گہرے سماعت کے نقصان والے بچوں کو اکثر ایک لفظ کو دوسرے سے ممتاز کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔

Objective: فرد کے سماعت کے نظام کے بارے میں اضافی معلومات objective audiometry کے ذریعے جمع کی جاتی ہیں۔ اس جانچ میں کوئی رویے والا جواب شامل نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والا ایک طریقہ impedance audiometry کہلاتا ہے۔ یہ conductive سماعت کے نقصان کی شناخت کرتا ہے۔ ایک اور objective ٹیسٹ ذہنی پسماندہ بچوں یا نشوونما میں تاخیر والے بچوں کے لیے

استعمال ہوتا ہے جو رویے والے جواب نہیں دے سکتے۔ اس ٹیسٹ میں سماعت کے تحریکات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے کھوپڑی پر الیکٹروڈ لگائے جاتے ہیں۔ نتائج ایک چارٹ پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ محیطی سماعت کا نظام (peripheral auditory system) اونچی فریکوئنسی کی آواز کو کیسے محسوس کرتا ہے۔

والدین کا رویہ (Parental attitude)

والدین کے رویے کا تعلیمی عمل پر نمایاں اثر ہوتا ہے۔ سماعت سے محروم والدین سننے والے والدین کے مقابلے میں سماعت سے محروم بچے کو زیادہ قبولیت دکھائیں گے۔ وہ سماعت کے نقصان کے تعلیمی مضمرات کو آسانی سے سمجھیں گے اور بچے کی سیکھنے میں مدد کریں گے۔ سننے والے والدین کو سیکھنے میں اصل مسئلہ سمجھنے اور اس کا پتہ لگانے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ ایک بار جب والدین مواصلاتی نظام (انداز) بنالیں تو بچہ دوسروں کے ساتھ کامیابی سے بات چیت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ حد سے زیادہ حفاظت بچوں کو خود مختار طریقے سے سیکھنے میں سچھے رکھتی ہے۔ والدین صورتحال کی غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے جذباتی مسائل کو کم کرنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔

2.3.3 تدریسی و یادگیری کے طریقے (Teaching and Learning Approaches)

بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے مداخلت تشخیص حاصل کرنے کے فوراً بعد یا اگر کوئی طبی / جراحی علاج ہو تو اس کے بعد شروع ہونی چاہیے۔ بچے کے ساتھ سب سے پہلے سماعت کے آلے (hearing aid) کی فراہمی ہونی چاہیے۔ سماعت کے آلے کا مائیکروفون آواز کی لہریں پکڑتا ہے اور انہیں برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ سماعت کے آلے کا ایمپلیفائر طاقت (شدت) بڑھاتا ہے اور رسیور برقی توانائی کو واپس بلند آواز میں تبدیل کرتا ہے۔ بیٹری سماعت کے آلے کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ کلاس روم میں استاد گروپ سماعت کا آلہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ پس منظر کا شور ختم کرتا ہے اور استاد طلبہ سے براہ راست بات کرتا ہے۔ تمام سماعت سے محروم بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے لیے بچی ہوئی سماعت کی صلاحیت استعمال کرنا سیکھنا ضروری ہے۔

1. مواصلات کے طریقے (Modes of Communication)

سماعت سے محروم بچوں اور نوجوانوں کو عام معاشرے میں رہنے اور ان کے ارد گرد کی بات چیت میں حصہ لینے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سماعت کی معذوری والے بچے بولنا، ہونٹ پڑھنا اور بچی ہوئی

سماعت سیکھیں۔ سماعت سے محروم طلبہ کو زبان کے تین پہلوؤں - مواد (content)، نحو (syntax) اور فعل (function) - میں ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔

i. سمعی-زبانی طریقہ (The Aural-Oral Approach)

یہ طریقہ amplification کے ذریعے بچی ہوئی سماعت کے استعمال پر زور دیتا ہے۔ اس سماعت کی صلاحیت اگر مناسب طور پر بہتر کی جائے تو تقریر وصول کرنے اور پیدا کرنے میں معاون کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔ طلبہ کو بولنا یا آواز بنانا سکھایا جاتا ہے۔ پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں زبان حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے اضافی طریقوں کے طور پر متعارف کرائی جاتی ہیں۔ صرف شدید اور گہرے سماعت کے نقصان والے بچے سماعت کے ذریعے دی گئی تمام ضروری معلومات وصول نہیں کر سکتے؛ ہونٹ پڑھنا (lipreading / speech reading) - تقریر پڑھنے کے دوران کچھ معلومات چھوٹ سکتی ہیں۔ یہ بولنے والے کی حرکات کو محسوس کر کے (بولنے والے کے گالوں اور ناک کو چھو کر) حاصل کی جاسکتی ہیں۔

تمام سماعت سے محروم بچوں کو سماعت کی تربیت (auditory training) فراہم کی جانی چاہیے۔ شدید اور گہرے سماعت سے محروم بچوں کو نہ صرف زبان کی آوازیں سکھائی جانی چاہیں جیسا کہ وہ مسلسل تقریر میں آتی ہیں بلکہ مناسب جملہ بندی اور سر کے نمونے بھی سکھائے جائیں۔

ii. دستی مواصلات کے طریقے (Manual Communication Modes)

اس طریقے میں انگلیوں، بازوؤں اور اوپری دھڑ (trunk/chest) کو حرکت دے کر پیغامات بھیجے جاتے ہیں اور انہیں بصری طور پر وصول کیا جاتا ہے۔ American Sign Language (ASL) دستی مواصلات کا نظام ہے۔ اس میں ہزاروں اشارے ہیں۔ امریکہ میں انگلیوں سے ہجے (finger spelling) انگریزی حروف تہجی کے ہر حرف، ترتیبی اعداد اور کچھ اوقاف کے لیے ایک ہاتھ سے بنائے گئے دستی علامات کے کوڈ پر مبنی ہے۔ انگلیوں کی مخصوص پوزیشنیں بچے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو لکھا جاسکتا ہے۔

پچھلے چند سالوں میں انگریزی زبان کو دستی طریقے میں پہنچانے کے لیے کئی نئے، ترمیم شدہ اشاروں کے نظام بنائے گئے ہیں۔ Manual English بہت سے ASL اشارے استعمال کرتی ہے لیکن ضمیروں، مضامین (articles) اور دیگر ساختی عناصر کے لیے نئے اشارے شامل کیے ہیں۔ ASL اور Manual English میں مختلف خیالات کے لیے مختلف اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ تمام زبان کے نظاموں میں اشاروں کو ہاتھ (ہاتھوں) کی انگلیوں سے ہجے کی پوزیشن سے ترمیم کیا جاتا ہے تاکہ مترادفات کا اظہار دیا جاسکے۔

iii. مکمل مواصلات (Total Communication)

سمعی-زبانی اور دستی مواصلات کے طریقوں کے امتزاج کو total communication کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی ابتدا 1960 کی دہائی کے آخر میں ہوئی لیکن اب اس کے استعمال میں مقبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ سماعت سے محروم افراد کو وہ مواصلاتی مہارتیں دی جانی چاہیں جن کی انہیں ضرورت ہو، کسی بھی ممکنہ شکل میں - سمعی-زبانی، دستی اور تحریری۔ ان مہارتوں کے ساتھ سماعت سے محروم آزاد زندگی گزار سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ - نہ صرف اپنے جیسے افراد بلکہ عام معاشرے کے ساتھ بھی - میل جول کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مواصلات کے تمام ذرائع کا جلد استعمال بنیادی مواصلاتی راستے اتنی مؤثر طریقے سے قائم کرتا ہے جتنا ممکن ہو، اس کے بعد مخصوص زبان کے نظام کا قیام ہوتا ہے۔ اس طریقے میں بہترین فہم اور مواصلاتی صورتحال میں مکمل سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے مختلف مشقیں جیسے سماعت کی تربیت، تقریر پڑھنا، انگلیوں سے ہچے، اشاروں کا نظام، پڑھنا اور لکھنا سب ایک ساتھ بار بار استعمال کی جاتی ہیں۔ total communication زبانی پروگرام کے تمام اجزا اور اشاروں کی زبان استعمال کرتی ہے۔

2. زبان سکھانے کے طریقے (Methods of Teaching Language)

شدید یا گہرے سماعت کے نقصان والے pre-lingual بچوں کے لیے زبان سیکھنا ایک مسئلہ ہے۔ رسمی زبان کی ہدایات کے بہت عین مطابق پروگرام تیار کیے گئے ہیں اور خصوصی اساتذہ نے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے ان پروگراموں کے ذریعے زبان کے تقاضے کا مداوا کرنے کی کوشش کی۔ بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے دو طریقے استعمال کیے گئے ہیں:

i. گرامر کا طریقہ (The grammatical method)

ii. قدرتی طریقہ (The natural method)

گرامر کا طریقہ جملوں کی تعمیر کی رہنمائی کے لیے مخصوص گرامر کے اصول پیش کرتا ہے۔ قدرتی طریقے میں لسانی مفروضے بنائے اور جانچے جاتے ہیں۔ اس پروگرام پر بنی طریقے میں زبان کی تعمیر اور نئے ذخیرہ الفاظ کے تعارف کے لیے قدرتی اور بامعنی صورتحوالوں میں وسیع استعمال کیا جاتا ہے۔

سماعت سے محروم بچوں کو منظم تدریس کے ذریعے زبان سیکھنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ دو طریقوں کے امتزاج میں بچے کی فعلی سطح کے مطابق ذخیرہ الفاظ اور گرامر کے اصول سیکھنے کے لیے روزمرہ کے تجربات کا استعمال شامل ہوتا ہے۔

3. نصاب میں ترامیم (Curriculum Modifications)

سماعت سے محروم طلبہ کے لیے کئی نصاب تیار کیے گئے ہیں۔ اکثر نصاب بچے کی سماعت کی ضروریات / حالات سے متعلق مخصوص شعبوں کو شامل کرتے ہیں؛ مثال کے طور پر سماعت کی تربیت اور تقریر۔ عام طور پر ان نصابوں کا بنیادی مفروضہ معمول کی نشوونمائی عمل ہے۔ یہ نصاب مناسب تدریسی مواد کی شناخت یا تیاری کے لیے ایک اچھا ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ عام سننے والے طلبہ کے لیے معیاری مواد اکثر استعمال کیا جاسکتا ہے سوائے اس موضوع کے جسے ترمیم شدہ شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ اساتذہ کو کورس کے مواد کو متعارف کرانے سے پہلے مخصوص زبان کی مہارتوں (لسانی ساخت) پر مواد کو دوبارہ لکھنا چاہیے۔

ثانوی اور بعد از ثانوی سطح پر سماعت سے محروم طلبہ کو تحریری مواد کی بڑی مقدار کو تیزی سے ہضم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہیں سماعتی میڈیا تک کم رسائی ہوتی ہے۔ اس لیے ثانوی سطح کے نصاب میں کافی آسان کردہ تنی مواد ہونا چاہیے اور مطالعہ کے رہنماؤں، کمپیوٹر کی مدد سے ہدایات اور دیگر بصری میڈیا جیسے کمپشن والی فلموں اور فلم اسٹرپس سے اس کی تکمیل ہونی چاہیے۔

4. سیکھنے کا ماحول (The Learning Environment)

بچوں کی سیکھنے کا انحصار ان موقع پر ہوتا ہے جو سیکھنے کا ماحول انہیں ان کی ضروریات کے مطابق فراہم کرتا ہے۔ وہ ماحول جو دیگر سننے والے یا عام سننے والے ہم عمر بچوں کے ساتھ میل جول کے موقع فراہم کرتا ہے اسے سماعت سے محروم بچوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں بات چیت کے موقع ہوتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ سماعت سے محروم بچوں کو معاون باقاعدہ تعلیمی کلاسوں میں رکھنا ان کے لیے تعلیمی اور سماجی طور پر فائدہ مند ہے۔ لیکن باقاعدہ تعلیمی ترتیب میں سماعت سے محروم طالب علم کو بہترین سطح کی کارکردگی تک پہنچانے کے لیے انفرادی تعلیمی پروگرام تجویز کیا جانا چاہیے۔ ماحول کو مناسب معاون خدمات جیسے نوٹ لینے والے، ترجمان اور ریوٹرز کی بھی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ بصری طور پر بہتر بنائی گئی حکمت عملیاں بھی تصورات کو واضح کرنے میں مدد کریں گی۔ اس کے علاوہ اسکول کو تشخیص، تعین اور جائزے کے لیے والدین، خصوصی تعلیم کے عملے اور دیگر پیشہ ور افراد کو شامل کرنا چاہیے۔ ملکہ سماعت کے نقصان والے بچوں کے لیے تقریری تھراپی کے سیشنز کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔ گہرے سماعت کے نقصان والے بچوں کو کچھ مخصوص تعلیمی مضامین یا سماجی مہارتوں کے لیے ضم کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ بنیادی طور پر خصوصی کلاس یا ریسورس روم میں داخل ہوں۔

5. تکنیکی جدتیں (Technological Innovations)

کمپیوٹر کی مدد سے ہدایات (Computer-assisted Instructions): سماعت سے محروم بچوں کے اساتذہ کو جدید حکمت عملیاں تلاش کرنی اور استعمال کرنی چاہیں؛ کمپیوٹر کی ہدایات۔ مائیکرو کمپیوٹرز کا استعمال سماعت سے محروم بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کو بہتر بنا رہا ہے۔ کمپیوٹر ان کے لیے بہت اچھا بصری ذریعہ ہیں۔ اس طرح کمپیوٹرز کے ساتھ صرف ایک مواصلاتی طریقہ استعمال کرنے سے تھوڑے وقت میں تعلیمی سیکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سماعت سے محروم بچوں کو بہت سی تکنیکوں کے ذریعے ایک متعامل سیکھنے کے عمل میں مصروف کیا جا سکتا ہے؛ وہ سافٹ ویئر جس کے ذریعے فوری تقویت اور غلطی کی اصلاح ممکن ہو۔ کمپیوٹرز کو بہروں کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن آلات (TDDs) کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے الیکٹرانک میل، بلیٹن بورڈز، صارفین کی خدمات اور سماعت سے محروم بچوں اور نوجوانوں کے لیے دستیاب دیگر فوائد کی تیز دنیا تک رسائی ممکن بنا سکتا ہے۔ اساتذہ کو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ مناسب مواصلاتی مہارتوں اور تعلیمی سیکھنے اور جائزے کی ترقی کے لیے اس نئے اور طاقتور آلے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔

کوکلیر امپلانٹس (Cochlear Implants): یہ ایک آلہ ہے جو جراحی کے ذریعے کان میں لگایا جاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ جسے 'magnetic coil' کہا جاتا ہے کان کے چھچھے جلد کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ ایک اور 'external coil' لگائے گئے مقناطیس کی مدد سے اپنی جگہ پر رکھی جاتی ہے۔ لگائی گئی کوائل سے نکلنے والی اور cochlea (اندرونی کان) کے سیال میں الیکٹروڈ پر ختم ہونے والی تار رکھی جاتی ہے۔ external coil ایک برقی پیک سے جڑی ہوتی ہے جو جسم پر پہنے جانے والے سماعت کے آلے جیسی دکھائی دیتی ہے۔ یہ پیک جیب میں، یا بیلٹ پر یا تھیلی میں پہنا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک نہایت چھوٹا مائیکروفون بھی ہوتا ہے جو کان پر لگایا جا سکتا ہے یا قمیض کے کالر پر کلپ کیا جا سکتا ہے، یا barrette پر پہنا جا سکتا ہے۔ مائیکروفون آوازیں پکڑتا ہے جو اس پیک یا سگنل پروسیسر تک پہنچائی جاتی ہیں۔ پروسیسر آوازوں کو برقی سگنلز میں تبدیل کرتا ہے جو پھر لگائی گئی کوائلوں کے ذریعے cochlea میں الیکٹروڈ تک منتقل ہوتے ہیں۔ اس طرح سماعت کی عصب میں برقی تحریکات متحرک ہوتی ہیں۔ یہ تحریکات پھر سماعت کے راستوں کے ذریعے دماغ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ کوکلیر امپلانٹ برقی تحریکات کو براہ راست نظام کے ذریعے دماغ تک پہنچاتا ہے۔ کوکلیر امپلانٹ کے ذریعے سنی گئی آواز سماعت کے آلے سے سنی گئی آوازوں سے مختلف ہوتی ہے۔ امپلانٹ کی جراحی میں mastoid (کھوپڑی کے اندر ایک ساخت جو درمیانی کان کی طرف جاتی ہے) اور درمیانی کان کو کھولنا شامل ہوتا ہے۔

2.4 مشق

- Q. conductive hearing loss اور sensorineural hearing loss میں کیا فرق ہے؟
- Q. sensorineural hearing loss کے کچھ pre-natal، peri-natal اور post-natal اسباب کی فہرست بنائیں۔
- Q. total communication کے اجزا کیا ہیں؟ مواصلات کے اس طریقے کو استعمال کرنے کی معقولیت پر بحث کریں۔
- Q. سماعت سے محروم طلبہ کے لیے باقاعدہ نصاب میں کیسے ترمیم کی جا سکتی ہے؟
- آئیے حاصل کردہ علم کے اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔

2.5 سرگرمی

- بصری معذور بچوں کے مرکز کا ایک دن کے لیے دورہ کریں اور درج ذیل کا مشاہدہ کریں:
- i. ان بچوں کی شناخت کریں جو مکمل طور پر نابینا ہیں اور جن کی بصارت کم ہے
 - ii. ان کی نقل و حرکت کی مہارتوں اور آواز کی شناخت کی طرف ان کی توجہ کا مشاہدہ کریں
 - iii. ان کے کلاس روم کے انتظام اور روشنی کی حالتوں وغیرہ کا مشاہدہ کریں۔

2.6 خود احتسابی سوالات

1. بصری معذوری کی تعریف کریں، اس قسم کی معذوری کے اسباب پر بحث کریں۔
2. ان مضمرات کی وضاحت کریں جو بصری معذوری بچوں پر ڈالتی ہے۔
3. بصری معذوری کی تشخیص کیوں ضروری ہے؟
4. مکمل نابینا اور کم بصارت والے بچوں کے لیے کلاس روم میں موافقت میں استاد کے کردار کی وضاحت کریں؟
5. کم بصارت والے بچوں کے لیے تعلیمی مضمرات کو منظم کریں۔
6. بصری معذور طلبہ کے لیے نصابی شعبوں پر بحث کریں۔
7. سماعت کی معذوری کیا ہے؟ اس کے اسباب اور مختلف اقسام کی وضاحت کریں۔

8. سماعت کی معذوری کے تدریسی ویادگیری کے طریقوں پر بحث کریں۔

2.7 حوالہ جات

American Foundation for the Blind (n.d.). Statistics and Sources for /Professionals. Retrieved December 1, 2007 from <http://www.afb.org/Section.asp?SectionID=15&DocumentID=1367>

Huebner, K. M., Merk-Adams, B., Stryker, D., & Wolffe, K. (2004). The national ,agenda for the education of children and youths with visual impairments .including those with multiple disabilities. New York: AFB Press

National Dissemination Center for Children with Disabilities (2004). Fact Sheet /Retrieved December 1, 2007 from www.nichcy.org/pubs/factshe .13.fs13txt.html

Spungin, S. (2002). When you have a visually impaired student in your .classroom: A guide for teachers. New York: AFB Press

Turnbull, A., Turnbull, R. & Wehmeyer, M. L. (2007). Exceptional lives. Special education in today's schools. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice .Hall

یونٹ 3: غیر معمولیات کی اقسام-II

تحریر: ڈاکٹر تنزیلہ نبیل
نظر ثانی: ڈاکٹر شگفتہ شہزادی

تعارف

جسمانی معذوری (Physical Disability) کسی شخص کی جسمانی کارکردگی، وضع جسم (postures)، نقل و حرکت اور برداشت (stamina) کی ایک حد بندی ہے۔

جسمانی معذوری کے اسباب پیدائشی (congenital) بھی ہو سکتے ہیں اور حاصل شدہ (acquired) بھی۔ پیدائشی جسمانی معذوری والے افراد یا تو جسمانی مشکلات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا پیدائش کے فوراً بعد ان میں یہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حاصل شدہ معذوریاں وہ ہیں جو چوٹ یا بیماری کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ جس عمر میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے اثرات کا تعین کرتی ہے۔ جسمانی معذوریاں پیدائشی نقائص، حادثاتی چوٹ یا بیماری کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کے مقاصد یہ ہیں کہ طلبہ اس قابل ہو سکیں کہ:

1. جسمانی معذوریوں اور صحت کی خرابیوں کی درجہ بندی کر سکیں۔
2. ہر قسم کی جسمانی معذوری کی ذیلی اقسام کو سمجھ سکیں جو بچوں کی روزمرہ زندگی کی مہارتوں اور تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
3. بچوں میں جذباتی مسائل کی معلومات رکھیں۔
4. نفسیاتی امراض اور طرز عمل کی معذوریوں کے درمیان فرق کر سکیں۔
5. جسمانی معذوریوں کے لیے تدریسی اسالیب سیکھیں۔
6. نفسیاتی امراض اور طرز عمل کی معذوریوں والے طلبہ کے لیے مقابلے اور تدریس کے اسالیب پر عمل کریں۔

3.1 قسم 3: جسمانی اور صحت کی خرابیاں (Physical and Health Impairments)

3.1.1 اقسام

جسمانی معذوریوں کے دو بڑے زمرے ہیں:

الف - عضلاتی-ہڈیوں کی معذوریاں (Musculo-Skeletal Disabilities)

ب - اعصابی-ہڈیوں کی معذوریاں (Neuro-Skeletal Disabilities)

الف - عضلاتی-ہڈیوں کی معذوریاں

اس کی تعریف یوں کی گئی ہے: پٹھوں، ہڈیوں اور جوڑوں کی خرابی کی وجہ سے جسم کی حرکت سے وابستہ سرگرمیاں انجام دینے میں ناکامی۔ عضلاتی-ہڈیوں کی معذوری کے زمرے میں آنے والی معذوریاں یہ ہیں:

1. اعضا کا نقصان یا خرابی (Loss or Deformity of Limbs)

2. اوسٹیو جینیسیس امپرفیکٹا (Osteogenesis Imperfecta)

3. عضلاتی ڈسٹروفی (Muscular Dystrophy)

الف - اعضا کا نقصان یا خرابی

یہ پیدا نشی نقص، بیماری یا حادثات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ شخص کو سرگرمیوں کی فعلی نقصان کی تلافی کے لیے مصنوعی عضو (artificial limb) کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

ب - اوسٹیو جینیسیس امپرفیکٹا (Osteogenesis Imperfecta)

اوسٹیو جینیسیس امپرفیکٹا (OI) ایک جینیاتی عارضہ ہے جس میں ہڈیاں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہڈیاں بغیر کسی معلوم وجہ کے ٹوٹ جاتی ہیں۔ OI کمزور پٹھے، نازک دانت، خمدار ریڑھ کی ہڈی اور سماعت کی کمی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ OI کئی جینوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے جو ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ جب یہ جین کام نہیں کرتے تو یہ کولاجن (collagen) کی تیاری پر اثر انداز ہوتا ہے، جو ایک پروٹین ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ OI ملکہ سے شدید تک ہو سکتا ہے، اور علامات ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتی ہیں۔ OI کی شدت ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتی ہے، بلکہ قسم سے لے کر شدید قسم تک جو پیدائش سے پہلے یا فوراً بعد موت کا سبب بنتی ہے۔ فریکچر کے

علاوہ، OI والے افراد کو دانتوں کے مسائل (dentinogenesis imperfecta) اور جوانی میں سماعت کی کمی بھی ہوتی ہے۔ جن افراد کو OI ہوتا ہے ان میں پٹھوں کی کمزوری، ڈھیلے جوڑ (joint laxity) اور ہڈیوں کی بگاڑ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کو زندگی بھر میں محض چند یا کئی سو تک فریکچر ہو سکتے ہیں۔ بڑھنے کی عمر میں مربوط بافتوں (connective tissues) کی ناقص نشوونما ہڈیوں کے نرم ہونے کا سبب بنتی ہے اور متاثرہ شخص کی وضع جسم بگڑ جاتی ہے۔ ایسے شخص کی ہڈیاں نازک ہوتی ہیں۔

اوسٹیو جینیسیس امپرفیکٹا (OI) کی اقسام

OI کی چار معروف اقسام ہیں۔ یہ اقسام بنیادی طور پر فریکچر کی تعداد اور شدت اور نمایاں خصوصیات سے ممتاز کی جاتی ہیں۔ OI کی تین مزید اقسام (پانچویں، چھٹی اور ساتویں) بھی دریافت ہوئی ہیں۔

• پہلی قسم (Type I OI) اس مرض کی ہلکی ترین شکل ہے۔ جن افراد کو پہلی قسم کی OI ہوتی ہے، ان کے بچپن اور نوجوانی میں معمولی چوٹ سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، اور جب یہ افراد جوانی کو پہنچتے ہیں تو ان میں فریکچر کم ہو جاتے ہیں۔

• دوسری قسم (Type II OI) کی سب سے شدید شکل ہے۔ دوسری قسم والے شیرخوار بچوں کی ہڈیاں خمیدہ یا چرمائی ہوئی نظر آتی ہیں اور پیدائش سے پہلے ہی ٹوٹی ہوتی ہیں۔ ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور پسلیاں ٹوٹی اور بگڑی ہوئی اور پھیپھڑے ناقص طور پر نشوونما یافتہ ہوتے ہیں۔ ان شیرخوار بچوں کے بازو اور ٹانگیں چھوٹی اور خمیدہ ہوتی ہیں؛ ان کے کولھے باہر کی طرف مڑے ہوتے ہیں؛ اور کھوپڑی کی ہڈیاں غیر معمولی طور پر نرم ہوتی ہیں۔ دوسری قسم کی OI والے زیادہ تر شیرخوار بچے مرد پیدا ہوتے ہیں یا پیدائش کے فوراً بعد مر جاتے ہیں، عام طور پر سانس کی ناکامی سے۔

• تیسری قسم (Type III OI) میں بھی نسبتاً شدید علامات ہوتی ہیں۔ تیسری قسم کی OI والے شیرخوار بچوں کی ہڈیاں بہت نرم اور نازک ہوتی ہیں جو پیدائش سے پہلے یا ابتدائی شیرخواری میں ٹوٹنا شروع ہو سکتی ہیں۔ کچھ شیرخوار بچوں کی پسلیوں میں فریکچر ہوتے ہیں جو سانس کے ساتھ جان لیوا مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہڈیوں کی خرابیاں وقت کے ساتھ بگڑتی جاتی ہیں اور اکثر چلنے کی صلاحیت میں خلل ڈالتی ہیں۔

• چوتھی قسم (Type IV OI) کی سب سے زیادہ متغیر شکل ہے۔ چوتھی قسم کی OI کی علامات ہلکی سے شدید تک ہو سکتی ہیں۔ چوتھی قسم کی OI والے تقریباً 25 فیصد شیرخوار بچے ہڈیوں کے فریکچر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسروں کی ہڈیاں بعد میں بچپن یا جوانی تک نہیں ٹوٹتیں۔ چوتھی قسم کی OI والے شیرخوار بچوں کی ٹانگوں کی ہڈیاں پیدائش کے وقت خمیدہ ہوتی ہیں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ خمیدگی عام طور پر کم ہو جاتی ہے۔

OI کی کچھ اقسام ترقی پذیر سماعت کی کمی، آنکھ کے اس حصے میں نیلے یا سرمئی رنگ (sclera) جو عام طور پر سفید ہوتا ہے، دانتوں کے مسائل (dentinogenesis imperfecta)، ریڑھ کی ہڈی کا غیر معمولی خم (scoliosis) اور ڈھیلے جوڑوں سے بھی وابستہ ہیں۔ اس حالت والے افراد میں ہڈیوں کی دیگر خرابیاں ہو سکتی ہیں اور وہ اکثر اوسط سے قد میں چھوٹے ہوتے ہیں۔

ج۔ عضلاتی ڈسٹروفی (Muscular Dystrophy)

عضلاتی ڈسٹروفی عوارض کا ایک گروپ ہے جس کی خصوصیت پٹھوں کے بافت کی ترقی پذیر کمی ہے جس کے نتیجے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ عضلاتی ڈسٹروفی کی سب سے عام شکل ڈوشن عضلاتی ڈسٹروفی (Duchenne Muscular Dystrophy) کہلاتی ہے جو عام طور پر چھوٹے لڑکوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری جینیاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندان میں عضلاتی ڈسٹروفی کی تاریخ کسی فرد کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے امکان کو بڑھا دیتی ہے۔

عضلاتی ڈسٹروفی کی متعدد اقسام ہیں جن میں درج ذیل شامل ہیں:

• ڈوشن عضلاتی ڈسٹروفی (Duchenne muscular dystrophy) - بیماری کی سب سے عام شکل۔ علامات عام طور پر بچے کی تیسری سالگرہ سے پہلے شروع ہوتی ہیں؛ وہ عام طور پر 12 سال کی عمر تک وہیل چیئر پر آجاتے ہیں اور بیس کے عشرے کے شروع تا وسط میں سانس کی ناکامی سے مر جاتے ہیں۔

• بیکر عضلاتی ڈسٹروفی (Becker muscular dystrophy) - ڈوشن جیسی علامات لیکن دیر سے آغاز اور سست رفتار کے ساتھ؛ موت عام طور پر چالیس کے عشرے کے وسط میں ہوتی ہے۔

• مائیوٹونک (اسٹائنرٹ کی بیماری) (Myotonic - Steinert's disease) - مائیوٹونک شکل بالغوں میں شروع ہونے والی سب سے عام شکل ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک بار سکڑنے کے بعد پٹھے کو ڈھیلا کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ چہرے اور گردن کے پٹھے اکثر پہلے متاثر ہوتے ہیں۔ علامات میں موتیا (cataracts)، غنودگی اور دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی (arrhythmia) بھی شامل ہیں۔

• پیدائشی (Congenital) - یہ قسم پیدائش سے یا 2 سال کی عمر سے پہلے ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ کچھ شکلیں آہستہ بڑھتی ہیں جبکہ دوسری تیزی سے بڑھ کر نمایاں خرابی پیدا کر سکتی ہیں۔

عضلاتی ڈسٹروفی کی علامات

ابتدائی علامات

- لڑکھڑا کر چلنا (waddling gait)
- پٹھوں میں درد اور اکڑن
- دوڑنے اور کودنے میں دشواری
- پنچوں پر چلنا
- بیٹھنے یا کھڑے ہونے میں دشواری
- سیکھنے کی معذوریات، مثلاً معمول سے دیر میں بولنا سیکھنا
- بار بار گرنا

بعد کی علامات

- چلنے میں ناکامی
- پٹھوں اور نسوں (tendons) کا سکڑنا، جس سے حرکت مزید محدود ہو جاتی ہے
- سانس کے مسائل اتنے شدید ہو سکتے ہیں کہ مصنوعی سانس کی ضرورت پڑے
- اگر پٹھے اس کی ساخت کو سہارا دینے کے لیے کافی مضبوط نہ ہوں تو ریڑھ کی ہڈی کا خم ہو سکتا ہے
- دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، جس سے دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں
- نکلنے میں دشواری - اس سے خوراک کا پھیپھڑوں میں جانا (aspiration pneumonia) ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات خوراک کی نالی (feeding tube) کی ضرورت پڑتی ہے

عضلاتی ڈسٹروفی کے اسباب

عضلاتی ڈسٹروفی X کروموسوم پر تغیرات (mutations) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عضلاتی ڈسٹروفی کی ہر قسم مختلف تغیرات کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن سب جسم کو ڈسٹروفن (dystrophin) پیدا کرنے سے روکتی ہیں۔ ڈسٹروفن پٹھوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے ضروری پروٹین ہے۔

ڈوشن عضلاتی ڈسٹروفی اس جین میں مخصوص تغیرات کی وجہ سے ہوتی ہے جو سائٹو سکلیٹل پروٹین ڈسٹروفن کو انکوڈ کرتا ہے۔ ڈسٹروفن مخططے (striated muscle) میں کل پروٹینز کا محض 0.002 فیصد بناتا ہے، لیکن یہ پٹھوں کے عمومی کام کے لیے ایک ضروری مالیکیول ہے۔

ڈسٹروفن پروٹینز کے ایک انتہائی پیچیدہ گروپ کا حصہ ہے جو پٹھوں کو درست طریقے سے کام کرنے دیتا ہے۔ یہ پروٹین پٹھوں کے خلیوں کے اندر مختلف اجزاء کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں مدد کرتا ہے اور ان سب کو سرکولیم (sarcolemma) - بیرونی جھلی - سے منسلک کرتا ہے۔ اگر ڈسٹروفن غائب یا بگڑا ہوا ہو تو یہ عمل درست طریقے سے کام نہیں کرتا، اور بیرونی جھلی میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں اور پٹھوں کے خلیوں کو بھی فعال طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔

دو شش عضلاتی ڈسٹروفنی میں ڈسٹروفن تقریباً مکمل طور پر غائب ہوتا ہے؛ جتنا کم ڈسٹروفن پیدا ہوگا، علامات اور بیماری کی ایٹالوجی (etiology) اتنی ہی بدتر ہوگی۔ بیکر عضلاتی ڈسٹروفنی میں ڈسٹروفن پروٹین کی مقدار یا سائز میں کمی ہوتی ہے۔

فی الحال عضلاتی ڈسٹروفنی کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن بعض جسمانی اور طبی علاج علامات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بیماری کی رفتار کو سست کر سکتے ہیں۔

ب۔ اعصابی-ہڈیوں کی معذوریات (Neuro-Skeletal Disabilities)

ان معذوریوں کی خصوصیت یہ ہے کہ متاثرہ اعضا کنٹرول شدہ حرکات کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ یہ ناکامی کسی بیماری یا پٹھوں کے انحطاط (degeneration) کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

1. دماغی فالج (Cerebral Palsy)

2. سپائنا بائفیدا (Spina Bifida)

3. پولیو (Polio)

4. فالج (Paralysis)

5. ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ (Spinal Cord Injury)

الف۔ دماغی فالج (Cerebral Palsy)

دماغی فالج کی اقسام

دماغی فالج کی درجہ بندی کی بنیاد یہ ہے:

- شدت کی سطح
- مسئلے کی جسمانی تقسیم (topographical distribution)
- حرکی فعل (motor function)

شدت کی سطح کی بنیاد پر درجہ بندی

دماغی فالج کو اکثر شدت کی سطح کے لحاظ سے ہلکا، درمیانہ، شدید، یا بغیر دماغی فالج کے طور پر درجہ بند کیا جاتا ہے۔ یہ وسیع عمومیات ہیں جن کے معیارات کا کوئی مخصوص مجموعہ نہیں ہے۔

• ہلکا (Mild) - دماغی فالج کا مطلب ہے کہ بچہ بغیر مدد کے حرکت کر سکتا ہے؛ اس کی روزمرہ سرگرمیاں محدود نہیں ہوتیں۔

• درمیانہ (Moderate) - درمیانے دماغی فالج کا مطلب ہے کہ بچے کو روزمرہ سرگرمیاں انجام دینے کے لیے بریسز، ادویات اور انطباقی ٹیکنالوجی (adaptive technology) کی ضرورت ہوگی۔

• شدید (Severe) - شدید دماغی فالج کا مطلب ہے کہ بچے کو وہیل چیئر کی ضرورت ہوگی اور روزمرہ سرگرمیاں انجام دینے میں اسے نمایاں چیلنجوں کا سامنا ہوگا۔

جسمانی تقسیم (Topographical Distribution) کی بنیاد پر درجہ بندی

جسمانی تقسیم کی درجہ بندی جسم کے حصوں پر اثرات بیان کرتی ہے۔

• مونو پلیجیا / مونو پییریز (Monoplegia/monoparesis) کا مطلب ہے کہ صرف ایک عضو متاثر ہے۔

• ڈائپلیجیا / ڈائپ پییریز (Diplegia/diparesis) کا مطلب ہے کہ دو اعضا متاثر ہیں۔ بنیادی طور پر نچلے اعضا۔

• ہیملیجیا / ہیملی پییریز (Hemiplegia/hemiparesis) اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جسم کے ایک طرف کا بازو اور ٹانگ متاثر ہیں۔

• پیرو پلیجیا / پیرو پییریز (Paraplegia/paraparesis) کا مطلب ہے کہ جسم کا نچلا نصف حصہ، بشمول دونوں ٹانگیں، متاثر ہے۔

• ٹرائپلیجیا / ٹرائپ پییریز (Triplegia/triparesis) اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تین اعضا متاثر ہیں۔ یہ دونوں بازو اور ایک ٹانگ، یا دونوں ٹانگیں اور ایک بازو ہو سکتے ہیں۔ یا اس سے مراد ایک اوپری اور ایک نچلا انتہا اور چہرہ ہو سکتا ہے۔

• کوآڈرپلیجیا / کوآڈرپ پییریز (Quadriplegia/quadruparesis) کا مطلب ہے کہ چاروں اعضا متاثر ہیں۔

ہینٹا پلیجیا/ہینٹا پیریز (Pentaplegia/pentaparesis) کا مطلب ہے کہ چاروں اعضا متاثر ہیں، ساتھ میں گردن اور سر کا فالج ہوتا ہے جس کے ساتھ اکثر کھانے اور سانس کی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔

حرکی فعل (Motor Function) کی بنیاد پر درجہ بندی

اس قسم کی درجہ بندی پٹھوں اور جوڑوں سے متاثر ہونے والی حرکت کی قسم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔

• اٹیکسیا (Ataxia): افراد میں پٹھوں کی ٹون (muscle tone) کم ہوتی ہے جس سے ڈھیلا پن اور کم تناؤ ہوتا ہے۔ چلتے وقت جسم کا توازن متاثر ہوتا ہے۔ حرکی مہارتیں جیسے لکھنا، ٹائپنگ یا قینچی کا استعمال مشکل ہوتا ہے۔

• اسپاسٹیسٹیٹی (Spasticity): اسپاسٹک دماغی فالج کی خصوصیت پٹھوں اور جوڑوں کی اکڑن کے ساتھ جھٹکے دار حرکات ہیں۔ یہ حالت حرکی فعل کی معمول کی نشوونما کو روکتی ہے۔ اسپاسٹک دماغی فالج اکثر سادہ کاموں کو مشکل بنا دیتا ہے، جیسے چلنا اور چھوٹی چیزیں اٹھانا۔ اسپاسٹک دماغی فالج کی علامات ہر بچے میں مختلف ہوتی ہیں۔ علامات میں فرق بچے کے دماغی نقصان کی شدت اور ساتھ موجود کسی عارضے پر منحصر ہوتا ہے۔

• ایتھیٹوئیڈ (Athetoid): ایتھیٹوئیڈ دماغی فالج، یا ڈسکائینٹک (dyskinetic) دماغی فالج، بڑھتے ہوئے دماغ کو نقصان کی وجہ سے ہونے والا حرکت کا عارضہ ہے۔ اس قسم کے دماغی فالج کی خصوصیت غیر معمولی، غیر ارادی حرکت ہے۔ انہیں ہاتھوں، بازوؤں، پیروں اور ٹانگوں میں حرکت کو کنٹرول کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جس سے چلنا اور چیزیں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔

پٹھوں کی ٹون کی اقسام

• ہائپرٹونیا/ہائپرٹونک (Hypertonia/Hypertonic) — پٹھوں کی ٹون میں اضافہ، جس کے نتیجے میں اکثر اعضا بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ ہائپرٹونیا اسپاسٹک دماغی فالج سے وابستہ ہے۔

• ہائپوٹونیا/ہائپوٹونک (Hypotonia/Hypotonic) — پٹھوں کی ٹون میں کمی، جس کے نتیجے میں اکثر اعضا ڈھیلے اور نرم ہو جاتے ہیں۔ ہائپوٹونیا غیر اسپاسٹک دماغی فالج سے وابستہ ہے۔

ب۔ سپائنا بانفڈا (Spina Bifida):

سپائنا بانفڈا کی چار اقسام ہیں: اوکلٹا (Occulta)، بند اعصابی نالی کے نقائص (closed neural tube defects)، میننگو سل (meningocele)، اور مائیلو میننگو سل (myelomeningocele)۔

• اوکلٹا سب سے ہلکی اور سب سے عام شکل ہے۔ اوکلٹا میں ایک یا زیادہ مہرے (vertebrae) ہڈیاں جو ریڑھ کی ہڈی بناتی ہیں) درست طور پر نہیں بنے ہوتے۔ نام "اوکلٹا" کا مطلب "چھپا ہوا" ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی میں خرابی یا سوراخ جلد کی ایک تہہ سے ڈھکا ہوتا ہے۔ سپائنا بانفڈا کی یہ شکل عام طور پر معذوری یا علامات پیدا نہیں کرتی۔

• بند اعصابی نالی کے نقائص سپائنا بانفڈا کی دوسری قسم ہیں۔ یہ شکل ریڑھ کی ہڈی کے نقائص کے ایک گروپ پر مشتمل ہوتی ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی چربی، ہڈی یا جھلیوں کی خرابی سے متاثر ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں میں علامات کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں؛ دوسروں میں خرابی پیشاب اور آنتوں کے مسائل کے ساتھ جزوی فلج کا سبب بنتی ہے۔

• میننگو سل میں (ریڑھ کی ہڈی کے گرد حفاظتی غلاف) ریڑھ کی ہڈی کے سوراخ سے باہر نکل آتے ہیں، اور جلد کی ایک تہہ سے ڈھکے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ میننگو سل والے کچھ مریضوں میں علامات کم یا نہ ہونے کے برابر ہو سکتی ہیں۔ دوسروں میں بند اعصابی نالی کے نقائص جیسی علامات ہو سکتی ہیں۔

• مائیلو میننگو سل، چوتھی شکل، سب سے شدید ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ریڑھ کی ہڈی ریڑھ کے سوراخ سے باہر نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں ریڑھ کے سوراخ سے نیچے جسم کے حصوں کا جزوی یا مکمل فلج ہو جاتا ہے۔ فلج اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے سپائنا بانفڈا کا مریض چلنے سے قاصر ہو اور اسے پیشاب اور آنتوں کی خرابی ہو۔

ج۔ پولیو (Polio)

پولیو مائلائٹس (Poliomyelitis) ایک انتہائی متعدی وائرل بیماری ہے، جو بنیادی طور پر چھوٹے بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ وائرس شخص سے شخص تک بنیادی طور پر فضلاتی-منہ کے راستے (faecal-oral route) یا کم کثرت سے کسی مشترکہ ذریعے (مثلاً آلودہ پانی یا خوراک) سے منتقل ہوتا ہے اور آنت میں بڑھتا ہے، جہاں سے یہ اعصابی نظام پر حملہ کر سکتا ہے اور فلج کا سبب بن سکتا ہے۔

پولیو کی ابتدائی علامات میں بخار، تھکاوٹ، سردرد، قے، گردن میں اکڑن اور اعضا میں درد شامل ہیں۔ کم تعداد میں کیسز میں بیماری فلج کا سبب بنتی ہے، جو اکثر مستقل ہوتا ہے۔ پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے، اسے صرف حفاظتی ٹیکہ کاری (immunization) سے روکا جاسکتا ہے۔

علامات اور نشانیاں

پولیو ایک وائرل بیماری ہے جو تقریباً 95 فیصد کیسز میں بالکل کوئی علامات پیدا نہیں کرتی (جسے غیر علامتی پولیو کہا جاتا ہے)۔ 4 سے 8 فیصد کیسز میں جن میں علامات ہوتی ہیں (جسے علامتی پولیو کہا جاتا ہے)، بیماری تین شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے:

• ہلکی شکل جسے abortive polio کہا جاتا ہے (اس قسم والے زیادہ تر لوگوں کو شک بھی نہیں ہوتا کہ انہیں یہ ہے کیونکہ ان کی بیماری ہلکی فلو جیسی علامات تک محدود رہتی ہے جیسے ہلکی اوپری سانس کی نالی کا انفیکشن، اسہال، بخار، گلے میں خراش اور بیماری کا عمومی احساس)

• زیادہ سنگین شکل جو aseptic meningitis سے وابستہ ہے جسے nonparalytic polio کہا جاتا ہے (1 سے 5 فیصد میں اعصابی علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے روشنی کے لیے حساسیت اور گردن کی اکڑن)

• شدید، معذور کرنے والی شکل جسے paralytic polio کہا جاتا ہے (یہ 0.1 سے 2 فیصد کیسز میں ہوتی ہے)

جن لوگوں کو abortive polio یا nonparalytic polio ہوتا ہے وہ عام طور پر مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تاہم، paralytic polio، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، پٹھوں کے فالج کا سبب بنتا ہے — اور موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ paralytic polio میں وائرس آنتوں کے راستے خون میں داخل ہوتا ہے۔ پھر یہ وائرس ان اعصاب پر حملہ کرتا ہے جو اعضا کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس طرح فالج کا سبب بنتے ہیں۔ اگرچہ بیماری چند دن رہتی ہے لیکن اعصاب کو پہنچنے والا نقصان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔

د۔ فالج (Paralysis)

فالج کے سب سے عام اسباب یہ ہیں:

- اسٹروک (Stroke)
- سر کی چوٹ (Head Injury)
- ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ (Spinal Cord Injury)
- ملٹیپل اسکلروسیس (Multiple Sclerosis)

اسٹروک

ہمارے جسم کے تمام اعضا کو درست کارکردگی کے لیے آکسیجن والا خون درکار ہوتا ہے۔ اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ دماغی خلیوں کی موت کا سبب بنتی ہے جس کے نتیجے میں اسٹروک ہوتا ہے اور اس طرح فلج ہوتا ہے۔

سر کی چوٹ

سر کی شدید چوٹ خون کی نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچا کر دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فلج اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر شدید سر کی چوٹ کے دوران دماغ کا وہ حصہ نقصان پہنچے جو مخصوص پٹھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کے بائیں جانب کا نقصان جسم کے دائیں جانب فلج کا سبب بن سکتا ہے، اور دماغ کے دائیں جانب کا نقصان جسم کے بائیں جانب فلج کا سبب بن سکتا ہے۔

ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ

ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں موٹر حادثے، بلندی سے گرنے یا ریڑھ کی ہڈی پر کسی بھی ضرب سے ہو سکتی ہیں جو ان اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو مہروں کی نالی کے اندر دماغ سے گردن اور ریڑھ کے ذریعے گزرتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر کے اعصاب دماغ اور جسم کے درمیان اشارے منتقل کرتے ہیں۔ اگر گردن یا ریڑھ زخمی ہو جائے تو ریڑھ کی ہڈی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ اب پٹھوں کو اشارے منتقل کرنے کے قابل نہیں رہ سکتا، جس سے فلج ہو جاتا ہے۔

ریڑھ کی چوٹ کی درست جگہ اس بات پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے کہ فلج کتنا شدید اور کتنا وسیع ہوگا۔

ملٹیپل اسکلروسس

اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی میں اعصابی ریشے مدافعتی نظام کے ہاتھوں نقصان پہنچتے ہیں۔ مائلین (Myelin) نامی مادہ اعصابی ریشوں کو گھیرے رکھتا ہے جو اعصابی اشاروں کی ترسیل میں مدد کرتا ہے۔ ملٹیپل اسکلروسس کی حالت میں اعصابی ریشے کے گرد مائلین جسم کے اپنے مدافعتی نظام کے ہاتھوں نقصان پہنچتی ہے۔ اس سے دماغ کو آنے اور جانے والے پیغامات متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح فلج ہو سکتا ہے۔

3.1.2 تشخیص (Assessment)

جسمانی خرابیوں کے نتیجے میں عارضی، مستقل یا وقفے وقفے والی حالتیں ہو سکتی ہیں۔ دماغی فلج، عضلاتی ڈسٹروفی، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں مستقل معذوریوں کا سبب بنتی ہیں جبکہ اسٹروک کی کچھ اقسام، پٹھوں کے کھچاؤ، الرجی، صحت کی خرابی جس سے برداشت متاثر ہوتا ہے، کے عارضی اثرات ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی حالت سے ہم آہنگی اور توازن ملے یا شدید طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ جسمانی یا صحت کی معذوریوں والے طلبہ کی خصوصیات اتنی ہی منفرد ہوتی ہیں جتنی وہ حالات جو ان کی خصوصی ضروریات کا سبب بنے۔

جسمانی معذوریوں والے طلبہ کو جسمانی ماحول میں نمایاں تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ دیگر کے لیے صحت کی صورت حال شدید خصوصی سہولتوں کا تقاضا کرتی ہے۔ تشخیصی طریقہ کار اور اسالیب ہر طالب علم کے لیے اس کی قسم اور شدت کی سطح کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔

ابتدائی تشخیص کا مقصد شخص کی قوتوں اور کمزوریوں کا پتہ لگانا، اسے درکار مداخلتوں کی اقسام، روزمرہ کے معمول، پڑھائی/کام اور کسی بھی دیگر فعلی مقصد کے لیے معاون ٹیکنالوجی کے حوالے سے درکار معاونت کا تعین کرنا ہے۔ جامع تشخیص کو جسمانی خرابی سے متعلق طالب علم کی تعلیمی ضروریات اور اس کی سیکھنے کی مہارتوں کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ تشخیص میں حرکی اور حسی مہارتوں کی تلافی کے لیے روایتی تشخیصی اوزاروں میں مطابقت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کثیر شعبہ جاتی تشخیصی ٹیم میں اساتذہ اور دیگر ماہرین شامل ہوں گے جنھیں مشتبہ تعلیمی ضروریات کے شعبوں کا علم ہو۔

ٹیم کے ارکان

جسمانی اور صحت کی معذوریوں کا استاد (IEP (Physical and Health Disabilities Teacher) ٹیم کا رکن ہونا ضروری ہے۔ یہ شخص پری-کنڈرگارٹن سے 22 سال کی عمر تک جسمانی خرابیوں والے طلبہ کے لیے تشخیص / ازسرنو تشخیص کی منصوبہ بندی اور تکمیل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جسمانی / صحت کی معذوری کے استاد کا کردار جسمانی معذوری سے منفرد تعلیمی مضمرات اور اسالیب کے تعین میں مہارت فراہم کرنا؛ مناسب اہداف اور مقاصد، نصابی ترمیمات، مطابقتوں، سہولتوں اور نصاب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے معاون ٹیکنالوجی کے استعمال کی تیاری میں مدد کرنا، اور معذوری سے مخصوص خدمات پیش کرنا ہے۔

اس کے علاوہ، درج ذیل ٹیم ارکان میں سے ایک یا زیادہ کی طرف سے خدمات فراہم کی جاسکتی ہیں:

- جسمانی معالج (Physical Therapist)
- پیشہ ورانہ معالج (Occupational Therapist)
- نرس (Nurse)
- ڈاکٹر (Doctor)
- خصوصی معلم (Special Educator)
- گفتگو-زبان معالج (Speech Language Therapist)

کثرت سے درکار تعلیمی ضروریات

- حرکی اور ادراکی مہارتوں کے لیے مطابقتوں، ترمیمات، ٹیکنالوجی اور آلات کے ذریعے تلافی کی مہارتوں کی فراہمی
- تنظیمی، توجہی اور یادداشت کی مہارتوں کے لیے تعلیمی اسالیب کی فراہمی
- جسمانی خرابی سے متعلق طالب علم کی ضروریات کے حوالے سے خود وکالت (self-advocacy) کی مہارتوں کی نشوونما
- انخلا کے منصوبوں، حفاظتی امور، نقل و حرکت، صحت کے منصوبوں کی تیاری
- تمام نصابی اور تعلیمی تجربات تک رسائی کا موقع، بشمول لیب یا عملی کام والے کورسز، فیلڈ ٹریپس، موسیقی کے پروگراموں اور غیر نصابی سرگرمیوں میں شرکت

3.1.3 نصاب، تدریس اور تشخیص میں مطابقت (Adaptation in Curriculum, Instruction and Evaluation)

خصوصی ضروریات والے بچوں کے لیے نصاب کی مطابقت اس مفروضے پر مبنی ہے کہ ہر بچہ انفرادیت کے ساتھ قوتوں اور حدود کے منفرد امتزاج کا حامل ہے۔ مطابقت اس یقین کے ساتھ کی جانی چاہیے کہ یہ فرد کی صلاحیتوں، دلچسپیوں، سیکھنے کے اسالیب اور نشوونما کی رفتار کی حمایت کرے گی۔

ادبی جائزہ معذوری والے بچوں کے لیے نصاب میں سات قسم کی ترمیمات اور مطابقتوں کی تجویز کرتا ہے (Sandall, Schwartz, & Joseph; Hemmeter et al. 2001; Wolery & Wilburs 1994)۔ (Sandall et al. 2002; 2001)۔

- ماحول میں تبدیلی: بچے کی شرکت، مشغولیت اور سیکھنے کو فروغ دینے کے لیے جسمانی اور سماجی ماحول اور سرگرمیوں کے وقت میں تبدیلی۔
- مواد کی مطابقت: مواد میں ترمیم کرنا تاکہ بچہ زیادہ سے زیادہ خود مختاری کے ساتھ شرکت کر سکے۔
- سرگرمیوں میں ترمیم: پیچیدہ کام کو چھوٹے حصوں میں توڑ کر یا مراحل کی تعداد کم کر کے آسان بنانا۔
- بچے کی ترجیحات کے ساتھ کام کرنا: مواد یا سرگرمیوں کے لیے بچے کی ترجیحات کی نشاندہی اور ان کا انضمام کرنا تاکہ بچہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھائے۔
- ہم عمر ساتھیوں کی معاونت کا انتظام: بچے کی شرکت بڑھانے کے لیے ہم عمر ساتھیوں کا استعمال۔

• غیر محسوس معاونت فراہم کرنا: سرگرمی کے اندر قدرتی طور پر ہونے والے واقعات کا مقصد کے ساتھ انتظام۔

• بالغ کی معاونت فراہم کرنا: بچے کی شرکت کی سطح کی حمایت کے لیے کسی بالغ کا مداخلت کرنا یا سرگرمی میں شامل ہونا۔

جسمانی معذوریوں والے طلبہ کے لیے تدریسی اسالیب

• SLANT (سیدھے بیٹھو، آگے جھکو، سوالات پوچھو، سر ہلاؤ، استاد کا پیچھا کرو) جیسے یادداشت کے اسالیب (mnemonics) استعمال کریں۔

• ماحولیاتی امور پر غور کریں: جماعت میں بیٹھنے کی جگہ، کام کی جگہ خلل سے پاک ہو، قریبی نشست، اور طالب علم جگہ سے تمام غیر متعلقہ مواد ہٹا دے۔

• ورک شیٹس اور مواد کے نیچے بناوٹ والی چٹائیاں (textured mats) استعمال کریں تاکہ کام کا علاقہ مستحکم ہو۔

• کاغذ کو مستحکم کرنے والی چیز فراہم کریں (clipboard، غیر پھسلنے والی لکھنے کی سطح)۔

• اہم معلومات کی طرف توجہ دلانے کے لیے رنگین ہائی لائٹر استعمال کریں۔

• کام کرتے وقت طالب علم کی رفتار کا تعین کرنے میں مدد کے لیے ڈیجیٹل ٹائمز استعمال کریں۔

• ایک لکیر یا جگہ کا نشان (place-marker) استعمال کریں۔

• مطابق بنایا گیا کاغذ فراہم کریں (موٹی لکیر، ابھری ہوئی لکیر، بڑا فاصلہ)۔

• توجہ دلانے یا اہم معلومات واضح کرنے کے لیے رنگین چپکنے والے نوٹس استعمال کریں۔

• بڑی پنسلیں اور/یا پنسل گرفت / وزنی پنسلیں استعمال کریں۔

• وضع جسم کے لیے انطباقی آلات استعمال کریں: بوسٹر سیٹیں، بازو کے سہارے وغیرہ۔

• ٹچ اسکرین کی صلاحیتوں والے کمپیوٹر استعمال کریں۔

• تمام تصورات مواد (manipulatives) سے واضح کریں۔

• طلبہ کے لیے "نقل" کم کرنے کے لیے بورڈ یا نصابی کتاب پر پیش کیے گئے کام کی نقلیں فراہم کریں۔

• تدریس کے لیے گروپ کے سائز میں تنوع لائیں۔

• متن کے بڑے پرنٹ والے ہینڈ آؤٹس فراہم کریں۔

• کتابوں اور اسائنمنٹ کے صفحات کے لیے کتاب کا اسٹینڈ فراہم کریں۔

- خصوصی طور پر لکھیروں والا / سمت والا کاغذ فراہم کریں۔
- کمپیوٹر کی آواز سے بہتر کردہ متن اور اسباق دستیاب کرائیں۔
- ڈرائنگ اور حقیقی زندگی کی مثالیں استعمال کریں جیسے لنچ کی گنتی اور جماعت کی فہرستیں۔

تشخیص (Evaluation)

نقل و حرکت کی معذوری والے طلبہ کو تشخیصی کاموں میں خاص ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب آپ کو واضح تصویر مل جائے کہ معذوری کارکردگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے تو آپ متبادل تشخیصی اسالیب پر غور کر سکتے ہیں، جیسے درج ذیل تجویز کردہ:

- ایک قاری یا زبانی امتحان (یا تو ٹیپ پر جوابات پیش کرنا یا viva میں شرکت) روایتی تحریری پرچے کے متبادل ہیں۔ زبانی امتحان طلبہ کے لیے آسان آپشن نہیں ہے۔ زبانی امتحان کے لیے وہی وقت دیں جو تحریری امتحان کے لیے، لیکن طالب علم کو سننے اور جوابات کو بہتر یا ایڈٹ کرنے کے لیے اضافی وقت دیں۔ آپ کی تشخیص میں اس بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ بولی گئی جوابات کے تحریری جوابات سے کم مربوط ہونے کا امکان ہے۔

- کچھ طلبہ کے لیے تحریری اور زبانی امتحان کا امتزاج سب سے موزوں ہوگا۔ طلبہ کو جوابی منصوبے لکھنے یا خاکے کے نوٹس بنانے کی اجازت دیں، لیکن پھر سوال کا جواب زبانی طور پر دیں۔ آپ کی تشخیص نوٹس اور بولی گئی پیشکش دونوں پر مبنی ہونی چاہیے۔

- طلبہ کو امتحان میں ذاتی کمپیوٹر یا ذاتی معاون استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آلات کے لیے اضافی جگہ یا الگ امتحانی مقام فراہم کرنا ضروری ہو سکتا ہے اگر آلات سے شور (مثلاً آواز کی ترکیب کرنے والا) دوسرے طلبہ کے لیے خلل کا باعث بننے کا امکان ہو۔

- کم لکھنے کی رفتار والے طلبہ کے لیے امتحانات میں اضافی وقت فراہم کریں۔ نقل و حرکت کی معذوری والے کچھ طلبہ کو آرام کے وقفے درکار ہو سکتے ہیں۔ گھر لے جانے والے امتحانات اور تقسیم شدہ پرچے آپشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ طلبہ کو امتحانات مکمل کرنے کے لیے دوگنا وقت درکار ہو سکتا ہے۔

- اگر وسیع تحقیق درکار ہو جس میں جسمانی سرگرمی شامل ہو (مثلاً لائبریری کے بار بار دورے یا بکھری جگہوں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا) تو اساتذہ کی آخری تاریخوں میں توسیع کی اجازت دیں۔

3.2 قسم 4: جذباتی اور طرز عمل کی خرابیاں (Emotional and Behavior Disorders)

جذباتی اور طرز عمل کی خرابیاں ایک چھتری اصطلاح (umbrella term) ہے جس کے تحت ایسے مسائل آتے ہیں جو جسمانی طور پر ظاہر نہیں ہوتے لیکن تدریس اور سیکھنے کے عمل میں ترمیم کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایسے افراد جذباتی طور پر پریشان یا جذباتی طور پر چیلنجڈ ہوتے ہیں اور ایسے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جو سماجی یا ثقافتی طور پر سرکش ہوتے ہیں۔ جذباتی خلل (emotional disturbance) والے بچوں میں دیکھی جانے والی کچھ خصوصیات اور طرز عمل یہ ہیں:

- ہائپر ایکٹیویٹی (کم توجہ کا دورانیہ، بے صبری)؛
 - جارحیت یا خود کو نقصان پہنچانے والا طرز عمل (بے قابو ہونا، لڑنا)؛
 - کنارہ کشی (دوسروں سے سماجی طور پر میل جول نہ رکھنا، ضرورت سے زیادہ خوف یا بے چینی)؛
 - ناپختگی (نامناسب رونا، غصے کے دورے، ناقص مقابلے کی مہارتیں)؛ اور
 - سیکھنے کی مشکلات (تعلیمی طور پر درجے سے نیچے کارکردگی)۔
 - ہم عمر گروپ کے ساتھ تسلی بخش سطح کا باہمی تعلق برقرار نہ رکھنا۔
 - اپنی عمر کے مناسب سطح تک سیکھنے سے قاصر رہنا بغیر کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کے۔
 - عام حالات میں ناقابل وضاحت دائمی ناخوشی یا افسردگی کی کیفیت میں رہنا۔
 - عام حالات میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے خوف اور نامناسب طرز عمل پیدا کرنا۔
- بہت سے بچے جنہیں جذباتی خلل نہیں ہوتا وہ اپنی نشوونما کے دوران مختلف اوقات میں انہی میں سے کچھ طرز عمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تاہم، جب بچوں کو جذباتی خلل ہوتا ہے تو یہ طرز عمل طویل عرصے تک جاری رہتے ہیں۔ ان کا طرز عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنے ماحول یا ہم عمروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہے۔

سب سے سنگین جذباتی خلل والے بچے بگڑی ہوئی سوچ، ضرورت سے زیادہ بے چینی، عجیب حرکی اعمال اور غیر معمولی مزاج کے اتار چڑھاؤ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔

3.2.1 جذباتی اور طرز عمل کی خرابیوں کی اقسام

جذباتی اور طرز عمل کی خرابیوں کی چھتری اصطلاح کے تحت دو زمرے ہیں: نفسیاتی امراض (Psychiatric Disorders) اور طرز عمل کی معذوریات (Behavioral Disabilities)۔

الف۔ نفسیاتی امراض

یہ زمرہ وسیع پیمانے کے حالات کا احاطہ کرتا ہے۔ نفسیاتی امراض کی تعریف ذہنی، طرز عمل یا ادراکی نمونوں یا بے قاعدگیوں کے طور پر کی گئی ہے جو روزمرہ کی کارکردگی کو خراب کرتے ہیں اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔

DSM ذہنی امراض کی درجہ بندی کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے نظاموں میں سے ایک ہے اور معیاری تشخیصی معیارات فراہم کرتا ہے۔ تشخیصی دستی کا تازہ ترین ایڈیشن DSM-5 ہے اور مئی 2013 میں جاری ہوا تھا۔ نفسیاتی امراض کی یہ فہرست دستی کے پہلے ایڈیشن اور تازہ ترین ورژن کے درمیان کی گئی بہت سی تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہے۔

عارضے کے کچھ بڑے زمرے درج ذیل ہیں:

- بے چینی کے امراض (Anxiety Disorders)
- بائی پولر اور متعلقہ عارضے (Bipolar and Related Disorders)
- خلل انداز، تسلسل کنٹرول اور طرز عمل کے امراض (Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders)
- خوراک اور کھانے کے امراض (Feeding and Eating Disorders)
- وسواسی-اجباری عارضہ (Obsessive-Compulsive Disorder)
- اعصابی ادراکی امراض (Neurocognitive Disorders)
- انفصالی امراض (Dissociative Disorders)
- اعصابی نشوونمائی امراض (Neurodevelopmental Disorders)
- شخصیت کے امراض (Personality Disorders)
- نیند-جاگنے کے امراض (Sleep-Wake Disorders)
- مادہ سے متعلقہ اور نشہ آور امراض (Substance-Related and Addictive Disorders)
- صدمے اور دباؤ سے متعلقہ عارضے (Trauma and Stressor-Related Disorders)

اس حصے میں ہم بہت سے نفسیاتی امراض میں سے چند پر بحث کریں گے۔

1- بے چینی کے امراض (Anxiety Disorders)

وہ شخص جو اندرونی انتشار سے گزر رہا ہو، مغلوب ہو اور گھبراہٹ اور بے چینی کی حالت میں نظر آئے، کہا جاتا ہے کہ اسے بے چینی (Anxiety) ہے۔ یہ حالت سنگین بیماری کا سبب بن سکتی ہے جو روزمرہ کی زندگی میں خلل ڈالے گی۔ اس حالت والے لوگوں کو دہشت، پسینے، دل کی دھڑکن یا دل کی بے قاعدہ دھڑکن کے احساسات ہو سکتے ہیں۔

عام علامات یہ ہیں:

• گھبراہٹ، خوف اور بے چینی کے احساسات

• سونے میں مسائل

• ٹھنڈے یا پسینے والے ہاتھ یا پاؤں

• سانس کی قلت

• دل کی دھڑکن

• پرسکون اور بے حرکت نہ رہ پانا

• منہ کا خشک ہونا

• ہاتھوں یا پیروں میں سنسناہٹ یا جھنجھناہٹ

• متلی

• پٹھوں میں تناؤ

• چکر آنا

بے چینی کے امراض کے اسباب

بے چینی وجوہات کے امتزاج کی وجہ سے ہوتی ہے جن میں دماغی کارکردگی میں تبدیلیاں اور ماحولیاتی دباؤ شامل ہیں۔ دماغ میں تبدیلیاں دماغ کے سرکٹ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہیں جو خوف اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ مطالعات سے ظاہر ہوا ہے کہ شدید یا دیرپا دباؤ ان سرکٹس کے اندر اعصابی خلیوں کے معلومات کو دماغ کے ایک خطے سے دوسرے خطے تک منتقل کرنے کے طریقے کو بدل سکتا ہے۔ بعض ماحولیاتی عوامل -

جیسے صدمہ یا اہم واقعہ - ان لوگوں میں بے چینی کا عارضہ پیدا کر سکتے ہیں جن میں اس عارضے کی نشوونما کی موروثی حساسیت ہو۔

بے چینی کے امراض کا علاج:

زیادہ تر بے چینی کے امراض کے لیے درج ذیل علاجوں میں سے ایک یا ان کا امتزاج استعمال کیا جا سکتا ہے:

• ادویات: بے چینی کے امراض کی علامات کم کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ادویات میں بہت سے اینٹی ڈپریشنس، بعض اینٹی کنولسنٹ ادویات اور کم خوراک والی اینٹی سائکلوٹک ادویات، اور بے چینی کم کرنے والی دیگر ادویات شامل ہیں۔

• نفسیاتی علاج (Psychotherapy): نفسیاتی علاج (مشاورت کی ایک قسم) ذہنی بیماری کے لیے جذباتی رد عمل کو حل کرتا ہے۔ یہ ایک عمل ہے جس میں تربیت یافتہ ذہنی صحت کے پیشہ ور افراد لوگوں کو ان کے عارضے کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملیوں پر بات چیت کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔

• اوراکی۔ طرز عمل علاج (Cognitive-behavioral therapy): یہ نفسیاتی علاج کی ایک خاص قسم ہے جس میں شخص سوچ کے نمونوں اور طرز عمل کو پہچاننا اور بدلنا سیکھتا ہے جو پریشان کن احساسات کا سبب بنتے ہیں۔

• خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیاں

• آرام کا علاج (Relaxation therapy)

نفسیاتی امراض کے لیے سب سے مؤثر علاج جامع ہوتے ہیں، جن میں مناسب ادویات، ذہنی صحت کی تعلیم، اور نفسیات کے مریض اور اس کے عزیزوں کے لیے نفسیاتی علاج شامل ہوتے ہیں۔ جب ضرورت ہو تو اس میں کمیونٹی سپورٹ سروسز کی شمولیت بھی ہوگی۔

2۔ بائی پولر اور متعلقہ امراض (Bipolar and Related Disorders)

بائی پولر عارضہ، جسے مینک-ڈپریشنو بیماری (manic-depressive illness) بھی کہا جاتا ہے، دماغ کا عارضہ ہے جو مزاج، توانائی، سرگرمی کی سطح اور روزمرہ کے کام انجام دینے کی صلاحیت میں غیر معمولی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔

بائی پولر عارضے کی چار بنیادی اقسام ہیں؛ ان سب میں مزاج، توانائی اور سرگرمی کی سطح میں واضح تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ مزاج انتہائی "اوپر"، خوش اور توانائی سے بھرپور طرز عمل کے ادوار (جنہیں مینک اقساط

کہا جاتا ہے) سے لے کر بہت اداس، "نیچے" یا ناامید ادوار (جنہیں افسردہ اقساط کہا جاتا ہے) تک ہوتے ہیں۔ کم شدید بینک ادوار کو ہائپو بینک اقساط (hypomanic episodes) کہا جاتا ہے۔

• **بائی پولر I عارضہ** - اس کی تعریف بینک اقساط سے ہوتی ہے جو کم از کم 7 دن رہتی ہیں، یا بینک علامات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ شخص کو فوری اسپتال کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر افسردہ اقساط بھی ہوتی ہیں، جو عام طور پر کم از کم 2 مہینے رہتی ہیں۔ مخلوط خصوصیات والی افسردگی کی اقساط (ایک ہی وقت میں افسردگی اور بینک علامات ہونا) بھی ممکن ہیں۔

• **بائی پولر II عارضہ** - اس کی تعریف افسردہ اقساط اور ہائپو بینک اقساط کے نمونے سے ہوتی ہے، لیکن اوپر بیان کردہ مکمل بینک اقساط نہیں ہوتیں۔

• **سائکلو تھائیمک عارضہ (Cyclothymic Disorder)**، جسے سائکلو تھائیمیا بھی کہا جاتا ہے) - اس کی تعریف ہائپو بینک علامات کے متعدد ادوار کے ساتھ افسردہ علامات کے متعدد ادوار سے ہوتی ہے جو کم از کم 2 سال (بچوں اور نوجوانوں میں 1 سال) تک رہتے ہیں۔ تاہم، علامات ہائپو بینک قسط اور افسردہ قسط کے تشخیصی تقاضوں کو پورا نہیں کرتیں۔

• **دیگر مخصوص اور غیر مخصوص بائی پولر اور متعلقہ امراض** - اس کی تعریف بائی پولر عارضے کی علامات سے ہوتی ہے جو اوپر درج تین زمروں سے مطابقت نہیں رکھتیں۔

3۔ خلل انداز اور تسلسل کنٹرول کے امراض (Disruptive and Impulse Control Disorders)

تسلسل کنٹرول کے امراض حالات کا ڈھیلا ڈھالا گروپ ہے جن میں یہ مشترک ہے کہ سب میں مرکزی طور پر ایسا طرز عمل نمایاں ہوتا ہے جو بے قابو اور تسلسلی انداز میں ادا کیا جاتا ہے جس کے اکثر خود تباہ کن نتائج ہوتے ہیں۔ DSM درج ذیل تسلسل کنٹرول کے امراض درج کرتا ہے:

کلپٹومینیا (Kleptomania) کی خصوصیت ذاتی استعمال کے لیے درکار نہ ہونے والی اشیاء کی بار بار، بے قابو چوری ہے۔

ٹرائیکوٹیلومینیا (Trichotillomania) کی خصوصیت بار بار بال نوچنا ہے جس سے نمایاں بالوں کا نقصان ہوتا ہے اور طبی طور پر نمایاں پریشانی یا فعلی خرابی پیدا ہوتی ہے (American Psychiatric Association, 2000)۔

وقفے وقفے کا دھماکہ خیز عارضہ (Intermittent explosive disorder) کی خصوصیت جارحیت کے بار بار، نمایاں دھماکے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں یا جائیداد کے خلاف حملے کے اعمال ہوتے ہیں، جو بیرونی دباؤ

کے مقابلے میں غیر متناسب ہوتے ہیں، اور کسی دوسری نفسیاتی حالت سے بہتر طور پر واضح نہیں ہوتے
(American Psychiatric Association, 2000)۔

پائرومینیا (Pyromania) کی خصوصیت ایک سے زیادہ مواقع پر جان بوجھ کر اور مقصد کے ساتھ آگ لگانا
ہے (American Psychiatric Association, 2000)۔

4۔ کھانے کے امراض (Eating Disorders):

کھانے کے امراض سنگین طرز عمل کے مسائل ہیں۔ ان میں شدید زیادہ کھانا یا صحت مندر بننے کے لیے کافی
خوراک نہ کھانا شامل ہو سکتا ہے۔ ان میں آپ کی شکل یا وزن کے بارے میں انتہائی فکر بھی شامل ہوتی
ہے۔

کھانے کے امراض کی اقسام یہ ہیں:

- اینوریکسیا نروسا (Anorexia nervosa)، جس میں آپ بہت پتلے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کافی
نہیں کھاتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ موٹے ہیں
- بولیمیا نروسا (Bulimia nervosa)، جس میں زیادہ کھانے کے ادوار کے بعد صفائی (purging)
ہوتی ہے، بعض اوقات خود سے قے لا کر یا جلاب استعمال کر کے
- بینج ایننگ (Binge-eating)، جو بے قابو کھانا ہے

5۔ وسواسی-اجباری عارضہ (Obsessive-Compulsive Disorder):

وسواسی-اجباری عارضہ (OCD)، جسے پہلے بے چینی کے عارضے کی ایک قسم سمجھا جاتا تھا، اب ایک منفرد
حالت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ممکنہ طور پر معذور کرنے والی بیماری ہے جو لوگوں کو بار بار آنے والے خیالات
اور طرز عمل کے لامتناہی چکروں میں پھنسا دیتی ہے۔ OCD والے لوگ بار بار آنے والے اور پریشان کن
خیالات، خوف یا تصاویر (وسوسے) سے دوچار ہوتے ہیں جنہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ان خیالات سے پیدا
ہونے والی بے چینی (گھبراہٹ) بعض رسومات یا معمولات (اجبار) ادا کرنے کی فوری ضرورت کا سبب بنتی
ہے۔ اجباری رسومات وسواسی خیالات کو روکنے یا انہیں دور کرنے کی کوشش میں ادا کی جاتی ہیں۔

OCD کے اسباب کیا ہیں؟

اگرچہ OCD کی درست وجہ مکمل طور پر سمجھی نہیں گئی ہے، مطالعات سے ظاہر ہوا ہے کہ حیاتیاتی اور
ماحولیاتی عوامل کا امتزاج ملوث ہو سکتا ہے۔

حیاتیاتی عوامل

دماغ ایک بہت پیچیدہ ساخت ہے۔ اس میں اربوں اعصابی خلیے ہوتے ہیں۔ جنہیں نیورونز کہا جاتا ہے۔ جنہیں جسم کے معمول کے کام کے لیے بات چیت اور مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ نیورونز نیوروٹرانسمیٹرز (neurotransmitters) نامی کیمیکلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں جو ایک اعصابی خلیے سے اگلے تک معلومات کے بہاؤ کو متحرک کرتے ہیں۔ ایک وقت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ نیوروٹرانسمیٹر سیروٹونن کی کم سطح OCD کی نشوونما کی ذمہ دار ہے۔ اب، تاہم، سائنسدان سمجھتے ہیں کہ OCD دماغ کے ان راستوں میں مسائل سے پیدا ہوتا ہے جو فیصلے اور منصوبہ بندی سے نمٹنے والے علاقوں کو اس دوسرے علاقے سے جوڑتے ہیں جو جسم کی حرکات سے متعلق پیغامات کو فلٹر کرتا ہے۔

OCD کی علامات

OCD کی علامات، جو دوسرے اور اجبار ہیں، مختلف ہو سکتی ہیں۔ عام دوسووں میں شامل ہیں:

- گندگی یا جراثیم سے آلودگی کا خوف
- کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا خوف
- غلطی کرنے کا خوف
- شرمندہ ہونے یا سماجی طور پر ناقابل قبول انداز میں برتاؤ کرنے کا خوف
- برے یا گناہ آلود خیالات سوچنے کا خوف
- ترتیب، ہم آہنگی یا درستگی کی ضرورت
- ضرورت سے زیادہ شک اور مسلسل یقین دہانی کی ضرورت

عام اجباروں میں شامل ہیں:

- بار بار نہانا، شاور لینا یا ہاتھ دھونا
- ہاتھ ملانے یا دروازے کے دستے چھونے سے انکار
- بار بار چیزوں کی جانچ، جیسے تالے یا چوہلے
- معمول کے کام کرتے وقت ذہنی یا بلند آواز میں مسلسل گنتی
- چیزوں کو مسلسل ایک خاص انداز میں ترتیب دینا
- خاص ترتیب میں کھانا کھانا
- الفاظ، تصاویر یا خیالات پر اٹک جانا، عام طور پر پریشان کن، جو دور نہیں ہوتے اور نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں

- مخصوص الفاظ، جملے یا دعائیں دہرانا
- کاموں کو ایک خاص تعداد میں کرنے کی ضرورت
- بغیر ظاہری قیمت والی اشیاء جمع کرنا یا ذخیرہ کرنا

6- اعصابی-ادراکی امراض (Neuro-Cognitive Disorders)

تمام اعصابی-ادراکی امراض (NCDs) کی بنیادی خصوصیت ایک یا زیادہ ادراکی شعبوں میں حاصل شدہ ادراکی کمی ہے۔ NCDs وہ ہیں جن میں خراب ادراک پیدائش یا بہت ابتدائی زندگی سے موجود نہیں رہا، اور اس طرح پہلے سے حاصل کردہ کارکردگی کی سطح سے کمی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اعصابی-ادراکی امراض یادداشت، توجہ، سیکھنے، زبان اور خود مختاری کو متاثر کر سکتے ہیں۔

DSM-IV میں اعصابی-ادراکی امراض کی فہرست میں ڈیمینشیا (Dementia)، ڈیلیریم (Delirium) اور ایمینیشیا (Amnesia) شامل ہیں۔ NCDs میں الزائمر کی بیماری، پارکنسن کی بیماری یا تکلیف دہ دماغی چوٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والے ادراکی مسائل بھی شامل ہیں۔ اگرچہ بہت سے ذہنی امراض میں ادراکی کمی موجود ہوتی ہے لیکن NCDs میں صرف وہ امراض شامل ہیں جن کی بنیادی خصوصیات ادراکی ہوں۔ (حوالہ: American Psychiatric Association)

7- انفصالی امراض (Dissociative Disorders)

انفصالی امراض کی خصوصیت حقیقت سے غیر ارادی فرار ہے جس کی خصوصیت خیالات، شناخت، شعور اور یادداشت کے درمیان رابطے کی کمی ہے۔ انفصالی امراض عام طور پر پہلے ایک صدماتی واقعے کے رد عمل کے طور پر نشوونما پاتے ہیں تاکہ ان یادوں کو قابو میں رکھا جاسکے۔ دباؤ والی صورتحال علامات کو بگاڑ سکتی ہے اور روزمرہ سرگرمیوں میں کام کرنے میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ تاہم، شخص جو علامات کا تجربہ کرتا ہے وہ انفصالی عارضے کی قسم پر منحصر ہوں گی جس کا وہ تجربہ کر رہا ہے۔

انفصالی امراض والے لوگوں کی کل آبادی کا تخمینہ 2 فیصد ہے، خواتین میں مردوں سے زیادہ تشخیص کا امکان ہوتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں تقریباً نصف بالغ اپنی زندگی میں کم از کم ایک depersonalization/derealization قسط کا تجربہ کرتے ہیں، صرف 2 فیصد دائمی اقساط کے مکمل معیارات پر پورا اترتے ہیں۔

علامات

انفصالی امراض کی علامات اور نشانیاں یہ ہیں:

- مخصوص اوقات، لوگوں اور واقعات کی نمایاں یادداشت کا نقصان

- جسم سے باہر کے تجربات
- افسردگی، بے چینی اور/یا خودکشی کے خیالات
- اپنے جذبات سے لا تعلقی کا احساس یا جذباتی بے حسی
- خود شناخت کے احساس کی کمی

اسباب

انفصالی امراض عام طور پر صدمے سے نمٹنے کے طریقے کے طور پر نشوونما پاتے ہیں۔ انفصالی امراض اکثر طویل مدتی جسمانی، جنسی یا جذباتی بدسلوکی کا شکار بچوں میں بنتے ہیں۔ قدرتی آفات اور جنگ بھی انفصالی امراض کا سبب بن سکتی ہیں۔

تشخیص

ڈاکٹر علامات اور ذاتی تاریخ کے جائزے کی بنیاد پر انفصالی امراض کی تشخیص کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جسمانی حالات کو خارج کرنے کے لیے ٹیسٹ کر سکتا ہے جو علامات پیدا کر سکتے ہیں جیسے یادداشت کا نقصان اور غیر حقیقی کا احساس (مثلاً سر کی چوٹ، دماغی زخم یا رسولی، نیند کی کمی یا نشہ)۔ اگر جسمانی اسباب خارج کر دیے جائیں تو تشخیص کے لیے اکثر ذہنی صحت کے ماہر سے مشورہ کیا جاتا ہے۔

علاج

انفصالی امراض کا انتظام مختلف علاجوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جن میں شامل ہیں:

- نفسیاتی علاج جیسے ادراکی طرز عمل علاج (CBT) اور جدلیاتی طرز عمل علاج (DBT)
- آنکھ کی حرکت سے غیر حساسیت اور دوبارہ عمل کاری (EMDR)
- ادویات جیسے اینٹی ڈپریشن متعلقہ حالات کی علامات کا علاج کر سکتی ہیں
- انفصالی امراض کے علاج کے اہداف مریض کو تکلیف دہ یادوں کو محفوظ طریقے سے یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے، مقابلے کی مہارتیں پیدا کرنے، اور انفصالی شناخت کے عارضے کی صورت میں مختلف شناختوں کو ایک فعلی شخص میں ضم کرنے میں مدد کرنا ہیں۔ کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو براہ راست انفصال کے علاج سے نمٹے۔ بلکہ، ادویات اضافی علامات کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو عام طور پر انفصالی امراض کے ساتھ ہوتی ہیں۔

8- اعصابی نشوونمائی امراض (Neurodevelopmental Disorders)

اعصابی نشوونمائی امراض بنیادی طور پر اعصابی نظام اور دماغ کی کارکردگی سے وابستہ معذوریات ہیں۔ بچوں میں اعصابی نشوونمائی امراض کی مثالوں میں توجہ کی کمی/ہائپر ایکٹیویٹی عارضہ (ADHD)، آٹزم، سیکھنے کی معذوریات، ذہنی معذوری (جسے mental retardation بھی کہا جاتا ہے)، طرز عمل کے امراض، دماغی فالج، اور بصارت اور سماعت میں خرابیاں شامل ہیں۔ اعصابی نشوونمائی امراض والے بچے زبان اور گفتگو، حرکی مہارتوں، طرز عمل، یادداشت، سیکھنے یا دیگر اعصابی افعال میں مشکلات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اعصابی نشوونمائی معذوریوں کی علامات اور طرز عمل اکثر بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ بدلتے یا ارتقا پذیر ہوتے ہیں، کچھ معذوریات مستقل ہوتی ہیں۔ ان امراض کی تشخیص اور علاج مشکل ہو سکتا ہے؛ علاج میں اکثر پیشہ ورانہ علاج، ادویات، اور گھر اور اسکول پر مبنی پروگراموں کا امتزاج شامل ہوتا ہے۔

9- شخصیت کا عارضہ (Personality Disorder)

شخصیت کے امراض شخصیت کی دیرپا، جڑ پکڑی بگاڑیں ہیں جو تعلقات بنانے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت میں خلل ڈالتی ہیں۔ تعلقاتی کارکردگی میں خرابی شخصیت کے عارضے کی پائیدار خصوصیت ہے (Skodol et al. 2005)۔

10- نیند-جاگنے کے امراض (Sleep-Wake Disorders)

سرکیڈین ریتمز (Circadian Rhythms) جسم میں جسمانی اور طرز عمل کی تبدیلیاں ہیں جو تقریباً 24 گھنٹے کے چکر پر ہوتی ہیں، بعض اوقات جسمانی گھڑی کہلاتی ہیں۔ سرکیڈین ریتم نیند کے امراض (CRSDs) یا سرکیڈین نیند کے امراض (CSDs) دن-رات کے چکر کے مقابلے میں نیند-جاگنے کے چکر کی لمبائی، وقت اور/یا سختی میں بے قاعدگیاں ہیں۔

علامات

- نیند شروع کرنے میں دشواری۔
- نیند برقرار رکھنے میں دشواری۔
- غیر بحال کن نیند۔
- دن میں غنودگی۔
- ناقص توجہ۔
- خراب کارکردگی، بشمول ادراکی مہارتوں میں کمی۔

11- مادہ سے متعلقہ اور نشہ آور امراض (Substance Related and Addictive Disorders)

نشہ آور امراض، جیسے مادے کا غلط استعمال اور انحصار، عام امراض ہیں جن میں الکحل یا منشیات کا زیادہ استعمال شامل ہوتا ہے۔ نشہ وقت کے ساتھ نشوونما پاتا ہے اور ایک دائمی اور دوبارہ ہونے والی بیماری ہے۔ (Wolery, M., Ault, M., & Doyle, P.M. (1992))۔ مادہ سے متعلقہ نشہ آور امراض کی تعریف کے لیے تین مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں: مادے کا غلط استعمال (Substance abuse)۔

12- صدمے اور دباؤ سے متعلقہ عارضہ (Trauma and Stressor-Related Disorder)

کسی ایسے شخص کے ذریعے ظاہر کردہ طرز عمل کا پریشان کن نمونہ جس نے صدماتی واقعے کا تجربہ کیا، دیکھا، یا اس کا سامنا کیا ہو۔ وہ کسی ایسے واقعے سے متاثر ہوا ہو جس میں حقیقی یا خطرے والی موت یا سنگین چوٹ ہو اور شدید خوف، بے بسی یا دہشت کے ساتھ جواب دیا ہو۔

صدماتی واقعات کی مثالیں

قدرتی آفت، آگ / دھماکہ، سنگین حادثہ، زہریلے مادے سے متاثر ہونا، جسمانی حملہ، ہتھیار سے حملہ، جنسی حملہ یا ناپسندیدہ جنسی تجربہ، جنگ / جنگی علاقے سے متاثر ہونا، قید، جان لیوا بیماری یا چوٹ، شدید انسانی تکلیف، کسی قریبی کی اچانک پر تشدد یا غیر متوقع موت، ان کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو پہنچنے والا سنگین نقصان، چوٹ یا موت، یا کوئی بھی دوسرا بہت دباؤ والا تجربہ۔

ب۔ طرز عمل کی معذوریات (Behavioral Disabilities)

طرز عمل کی معذوریات ان بچوں میں پہچانی جاتی ہیں جن کا طرز عمل انھیں تعلیمی ماحول میں کامیابی سے کام کرنے سے روکتا ہے، یا تو خود کو یا ان کے ہم عمروں کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور انھیں عمومی تعلیمی پروگرام میں مکمل طور پر حصہ لینے سے روکتا ہے۔ طرز عمل کی معذوریوں والے بچے ایسے طرز عمل میں ملوث ہوتے ہیں جو جماعت کی کارکردگی میں خلل ڈالتا ہے اور / یا خود اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ طرز عمل کی معذوریوں کے دو زمرے ہیں:

1. مخالفانہ سرکش عارضہ (Oppositional Defiant Disorder)

2. طرز عمل کا عارضہ (Conduct Disorder)

الف۔ مخالفانہ سرکش عارضہ (Oppositional Defiant Disorder)

اس کی خصوصیت انتہائی عدم تعمیل، منفی پن اور تعاون یا ہدایات پر عمل کرنے کی عدم آمادگی ہے۔ اس حالت والے بچے پر تشدد یا جارح نہیں ہوتے؛ وہ محض بالغوں یا ہم عمروں کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

ٹائپولوجی تین اقسام پر مشتمل ہے:

• محرک پر منحصر (Stimulus Dependent ODD) ODD،

• ادراکی بوجھ (Cognitive Overload ODD) ODD اور

• خوف زدہ (Fearful ODD) ODD۔

محرک پر منحصر قسم کے ODD والے نوجوانوں میں نمایاں طور پر خراب توجہ کی کمی / ہائپر ایکٹیویٹی عارضہ (ADHD) ہوتا ہے اور متعدد ماحول میں ODD طرز عمل ہوتے ہیں۔ جب ADHD کا علاج کیا جاتا ہے تو مخالفت بہتر ہو جاتی ہے (Connor, Steeber & McBurnett, 2010)۔

دوسرا گروپ ادراکی بوجھ ODD، سیکھنے، زبان اور سماجی عمل کاری کی مشکلات سے جدوجہد کرتا ہے جو ADHD سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور عام طور پر سیکھنے کی معذوری اور غیر مخصوص بے چینی کے عارضے کے معیارات پر پورا اترتا ہے۔ اس گروپ میں کم تقاضے کی حالتوں میں بھی ناقص ایگزیکٹو کارکردگی کی مہارتیں ہوتی ہیں اور ان کی مخالفت تبدیلی کے خلاف مزاحمت سے آگے کسی واضح وجہ کے بغیر ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں ناقص سماجی نقطہ نظر لینے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور وہ سماجی طور پر عجیب ہوتے ہیں۔ ان چیلنجنگ نوجوانوں کو بے چینی اور توجہ کو نشانہ بنانے والے کثیر طریقے، مرحلہ وار علاج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر اور اسکول میں معاونت کی ہدایت کے لیے نفسیاتی تعلیمی جانچ کے بغیر کامیابی محدود ہوتی ہے۔ ان میں تمام اقسام کی مخالفانہ علامات کی اعلیٰ سطح ہوگی۔ آخر میں، خوف زدہ قسم انتہائی بیدار اور دباؤ کے لیے رد عمل والے بچوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو بہت سے سیاق و سباق میں اچھا کر سکتے ہیں، لیکن جب نقصان یا شرمندگی کا خطرہ ہو تو ODD علامات کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، عام طور پر دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ۔ اکثر ان بچوں کی صدمے اور اختیار پر عدم اعتماد کی تاریخ ہوتی ہے؛ درحقیقت ان کے طرز عمل بے چینی / مبہم لگاؤ کے پروفائل کی عکاسی کرتے ہیں۔

ب۔ طرز عمل کا عارضہ (Conduct Disorder)

یہ کہیں زیادہ شدید ہے۔ اس عارضے کی خصوصیت جارحیت، تشدد، اور خود اور دوسروں کو پہنچایا گیا نقصان ہے۔ طرز عمل کا عارضہ طرز عمل اور جذباتی مسائل کا ایک گروپ ہے جو عام طور پر بچپن یا نوجوانی میں

شروع ہوتا ہے۔ اس عارضے والے بچوں اور نوجوانوں کو قوانین پر عمل کرنے اور سماجی طور پر قابل قبول انداز میں برتاؤ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہ جارحانہ، تباہ کن اور دھوکے باز طرز عمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ بالغ اور دوسرے بچے انہیں ذہنی بیماری والے کے بجائے "برا" یا مجرم سمجھ سکتے ہیں۔

طرز عمل کے عارضے کی اقسام

طرز عمل کے عارضے کی تین اقسام ہیں۔ ان کی درجہ بندی اس عمر کے مطابق کی گئی ہے جس میں عارضے کی علامات پہلی بار ظاہر ہوتی ہیں:

• بچپن کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب طرز عمل کے عارضے کی علامات 10 سال کی عمر سے پہلے ظاہر ہوں۔

• نوجوانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب طرز عمل کے عارضے کی علامات نوجوانی کے سالوں میں ظاہر ہوں۔

• غیر مخصوص آغاز کا مطلب ہے کہ وہ عمر معلوم نہیں جس میں طرز عمل کا عارضہ پہلی بار ہوا۔

طرز عمل کے عارضے کی علامات

جن بچوں کو طرز عمل کا عارضہ ہوتا ہے انہیں اکثر قابو کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ قوانین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنے اعمال کے نتائج پر غور کیے بغیر تسلسل سے کام کرتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کے احساسات کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ آپ کے بچے کو طرز عمل کا عارضہ ہو سکتا ہے اگر وہ مستقل طور پر درج ذیل طرز عمل میں سے ایک یا زیادہ کا مظاہرہ کریں:

- جارحانہ طرز عمل
- دھوکے باز طرز عمل
- تباہ کن طرز عمل
- قوانین کی خلاف ورزی

جارحانہ طرز عمل میں شامل ہو سکتا ہے:

- دوسروں کو ڈرانا یا انہیں تنگ کرنا
- جان بوجھ کر لوگوں یا جانوروں کو جسمانی نقصان پہنچانا

• عصمت دری کا ارتکاب

• ہتھیار کا استعمال

دھوکے باز طرز عمل میں شامل ہو سکتا ہے:

• جھوٹ بولنا

• چوری کرنا

• جعل سازی

قوانین کی خلاف ورزی میں شامل ہو سکتا ہے:

• اسکول سے غیر حاضری

• گھر سے بھاگ جانا

• نشیات اور الکحل کا استعمال

• بہت کم عمر میں جنسی طرز عمل

مزید برآں، طرز عمل کے عارضے کی علامات ہلکی، درمیانی یا شدید ہو سکتی ہیں۔ طرز عمل کے عارضے والے طلبہ کو عام طور پر خصوصی تعلیمی جماعتوں میں پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک ان کا طرز عمل اتنا بہتر نہ ہو جائے کہ عمومی تعلیمی آبادی سے رابطے کی اجازت ملے۔

3.2.2 طرز عمل کی خصوصیات (Characteristics of Behaviour)

جذباتی اور طرز عمل کی خرابیوں والے بچے اور نوجوان تمام معذوری گروپوں میں سب سے کم شناخت شدہ اور کم خدمت یافتہ سمجھے جاتے ہیں (Forness & Kavale, 2001; Gresham, 2005, 2007; Merrell & Walker, 2004)۔ کم شناخت کا مسئلہ ان کے اساتذہ، منتظمین اور ہم عمروں کے لیے نمایاں چیلنجز کا سبب بنتا ہے۔ جب تک اساتذہ وجوہات اور مسئلے سے نمٹنے کی مناسب اسالیب کو نہیں سمجھتے، جماعت میں ایسے بچے اساتذہ کے لیے خلل اور دباؤ کا مسلسل ذریعہ ہوتے ہیں۔

جذباتی طرز عمل کی خرابیوں والے طلبہ سے نمٹنے کے روایتی اسالیب بنیادی طور پر طرز عمل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسی آبادی کے لیے تعلیمی منصوبے کا بنیادی جزو طرز عمل ہے، تعلیمیات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس مقصد کے لیے کثیر جہتی معاونت شامل کی جانی ہے۔ Lewis, Hudson, Richter

(2004) and Johnson کہتے ہیں: "جماعت میں مشاہدہ کردہ زیادہ تر خلل انداز طرز عمل سبق کے تقاضوں اور طلبہ کی حصولیابی کی سطحوں کے درمیان رابطے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔"

3.2.3 جذباتی اور طرز عمل کی خرابیوں والے طلبہ کو پڑھانے کے اسالیب

دیگر حالات کی طرح، جذباتی اور طرز عمل کی خرابیوں والے طلبہ کو مثبت، منظم ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو نشوونما کی حمایت کرے، خود اعتمادی کو فروغ دے، اور مطلوبہ طرز عمل کو انعام دے۔

قواعد اور معمولات (Rules and Routines)

بچوں میں اچھے طرز عمل کی حوصلہ افزائی اور نشوونما کے لیے قواعد قائم کیے جانے چاہئیں اور اساتذہ کو ان پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ بہت سادہ اور سیدھی زبان میں لکھے جانے چاہئیں جو طلبہ کے لیے قابل فہم ہو۔

قواعد کا الفاظ مثبت ہونے چاہئیں: "اپنی اور دوسروں کی عزت کرو" "کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ" سے بہتر قاعدہ ہے۔ اسے سادہ رکھیں۔

قواعد توڑنے کے نتائج بھی اسکول کے سال کے آغاز میں قائم کیے جانے چاہئیں، اور جب بھی قواعد ٹوٹیں تو مستقل اور مضبوطی سے لاگو کیے جائیں۔ نتائج دیتے وقت طالب علم کو پرسکون، واضح انداز میں فیڈبک دیں۔ اس طرح طالب علم سمجھتا ہے کہ نتیجہ کیوں ضروری ہے۔

جب قواعد ٹوٹیں تو جذباتی طور پر رد عمل سے بچنے کی کوشش کریں۔ جذباتی رد عمل طالب علم کو منفی توجہ دیتا ہے، جسے بہت سے بچے بہت فائدہ مند پاتے ہیں۔ پرسکون اور لا تعلق رہیں، مضبوط لیکن مہربان رہیں۔ اس توازن کو حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن مثبت نتائج کے لیے انتہائی اہم ہے۔

معمولات جماعت کے انتظام کے لیے بہت اہم ہیں۔ جذباتی اور طرز عمل کی خرابیوں والے طلبہ تبدیلیوں اور غیر متوقع تبدیلی سے جدوجہد کرتے ہیں۔ دن کی سرگرمیوں کے بصری شیڈول پر نظر ڈالنا دن شروع کرنے کا مؤثر طریقہ ہے، اور طلبہ کو مستحکم محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔

3.2.4 مثبت طرز عمل کی حمایت کے لیے تعلیمی مضمرات اور مداخلتی تکنیکیں

جذباتی اور طرز عمل کی خرابیوں والے طلبہ کو اکثر خصوصی تعلیمی ماحول میں ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا طرز عمل عمومی تعلیمی جماعت کے لیے بہت زیادہ غیر موافق ہوتا ہے۔ زیادہ مثبت، موافق طرز عمل کی طرف نشوونما کی رہنمائی اور حمایت کے لیے چند خیالات یہ ہیں:

• **ٹوکن اکانومی (Token Economy)** - طلبہ مثبت طرز عمل کی ہر مثال پر پوائنٹس یا ٹوکن کماتے ہیں۔ پھر یہ ٹوکن ٹوکن اسٹور پر انعامات خریدنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ٹوکن اکانومی کے مؤثر ہونے کے لیے مثبت طرز عمل کو مستقل طور پر انعام دینا ضروری ہے، اور ٹوکن اسٹور کی اشیاء طالب علم کے لیے واقعی حوصلہ افزا ہونی چاہئیں۔ اس میں کافی تیاری اور تنظیم درکار ہوتی ہے، لیکن یہ کافی مؤثر ثابت ہوا ہے۔

• **جماعت کا طرز عمل چارٹ (Classroom Behavior Chart)** - ایک چارٹ جو جماعت کے ہر طالب علم کے طرز عمل کی سطح کو بصری طور پر ظاہر کرتا ہے۔ جو طلبہ مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ چارٹ پر اوپر بڑھتے ہیں؛ جو منفی طرز عمل کرتے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں۔ اس سے ہر طالب علم جوابدہ بنتا ہے، اور آپ کو پیش رفت کی نگرانی اور انعام میں مدد ملتی ہے۔ یہ اس صورت میں کام نہیں کرے گا اگر مشکل طلبہ مستقل طور پر چارٹ کے نچلے حصے میں رہیں۔ مثبت پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کریں، اور انہیں حوصلہ مند رکھیں۔

• **لاٹری سسٹم (Lottery System)** - ٹوکن اکانومی کی طرح، جو طلبہ مثبت انداز میں برتاؤ کرتے ہیں انہیں ان کے نام والا ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ٹکٹ ایک جاریں رکھے جاتے ہیں، اور مفتے میں ایک یا دو بار آپ ایک نکالتے ہیں۔ لاٹری کا فاتح انعام سے نوازا جاتا ہے۔

• **مثبت ہم عمر جائزہ (Positive Peer Review)** - طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم عمروں کو دیکھیں، اور مثبت طرز عمل کی نشاندہی کریں۔ مثبت طرز عمل کرنے والے طالب علم اور نشاندہی کرنے والے طالب علم دونوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ "چغلی" کے بالکل برعکس ہے، اور جماعت میں ٹیم ورک اور سماجی معاونت کا احساس پیدا کرتا ہے۔

جذباتی اور طرز عمل کی خرابیوں والے بچوں کو پڑھانا انتہائی چیلنجنگ ہے۔ یاد رکھیں: مثبت طرز عمل کو فروغ دینا اور انعام دینا منفی طرز عمل کو ختم کرنے کی کوشش سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ سزا اور منفی نتائج طاقت کی کشمکش کا سبب بنتے ہیں، جو مسئلہ طرز عمل کو صرف بگاڑتے ہیں۔ ایسے جذباتی طور پر آزمانے والے طرز عمل کے سامنے مثبت رہنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمت نہ ہاریں۔ آپ کا اثر ان طلبہ کے لیے دنیا بھر کا فرق پیدا کر سکتا ہے جو ایک ناقابل یقین حد تک مشکل حالت سے جدوجہد کر رہے ہیں۔

3.2.5 چیلنجز اور مسائل (Challenges and Issues)

استاد کے نقطہ نظر سے، نفسیاتی امراض متعدد وجوہات کی بنا پر گہرا چیلنج پیش کرتے ہیں۔ ایک تو اسکول اسپتال نہیں ہیں، اور اساتذہ سے ان امراض کا "علاج" کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ جو طلبہ ان چیلنجوں سے جدوجہد کرتے ہیں وہ اکثر علاج سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ادویات لے رہے ہو سکتے ہیں۔ ادویات لوگوں کو غیر متوقع طریقوں سے متاثر کر سکتی ہیں اور، کیونکہ طبی معلومات خفیہ ہوتی ہیں، اساتذہ کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ طلبہ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہے ہیں۔ اس سے بعض طرز عمل کا مناسب جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید برآں، ان حالات سے متاثرہ طلبہ محض تعلیمی اور طرز عمل کی توقعات پر پورا اترنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ ایسے کیسز میں طلبہ کو کسی نہ کسی طرح کی خصوصی تعلیمی مداخلت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں خصوصی تعلیمی جماعت میں منتقل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

3.3 خود احتسابی سوالات

1. جسمانی معذوری کی تعریف کریں اور ان کے اسباب کیا ہیں؟
2. او سیو جینیٹکس امپرفیکٹ کی اقسام کے درمیان فرق کریں۔
3. عضلاتی ڈسٹروفی کے اسباب کیا ہیں؟
4. اعصابی-ہڈیوں کی معذوری کی مثالوں کے ساتھ تعریف کریں۔ جسمانی تقسیم مریضوں کے جسم کے حصوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟
5. دماغی فالج کی درجہ بندی حرکی افعال پر کیسے کی جاتی ہے؟
6. ہتھوں کی ٹون کی مختلف اقسام لکھیں؟
7. سپائنا بائفڈا کی مختلف اقسام پر لکھیں؟
8. پولیو کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟
9. فالج کے اسباب پر بحث کریں۔
10. جسمانی معذوریوں والے خصوصی بچوں کی کثرت سے درکار تعلیمی ضروریات کیا ہیں؟
11. جسمانی معذوری والے طلبہ کے لیے تدریسی اسالیب کیا ہیں؟
12. جذباتی اور طرز عمل کی خرابیاں کیا ہیں؟
13. جذباتی اور طرز عمل کے لیے زمرے کیا ہیں؟
14. بے چینی کی تعریف کریں۔ بے چینی کی عام علامات پر بحث کریں۔

15. بے چینی کے عارضے کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟
16. کھانے کے امراض کی اقسام کی وضاحت کریں۔
17. وسواسی-اجباری عارضے کا سبب کیا ہے؟
18. اعصابی-اوراکی امراض کیا ہیں؟
19. طرز عمل کی معذوریاں کیا ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟
20. طرز عمل کے عارضے کی اقسام اور علامات پر بحث کریں۔
21. مثبت طرز عمل کی حمایت کے لیے تدریس کی حکمت عملی بتائیں۔
22. جسمانی معذوریوں والے خصوصی بچوں کے مسائل اور چیلنجز پر بحث کریں۔

3.4 حوالہ جات

- Abbs, S., Roberts, R.G., Mathew, C.G., Bentley, D.R., and Bobrow, M. (1990).
Accurate assessment of intragenic recombination frequency within the
.Duchenne muscular dystrophy gene. Genomics 7:602-606
- Brown, W. H., Odom, S. L., & McConnell, S. R. (2008). Social competence of
.young children, risk, disability, and intervention. Baltimore, MD: Paul H
.Brookes
- /Connor DF, Steeber J, McBurnett K. A review of attention deficit
hyperactivity disorder complicated by symptoms of oppositional defiant
disorder or conduct disorder. Journal of Developmental and Behavioural
Pediatrics. 2010;31:427-440.[PubMed]
- /Connor, Steeber&McBurnett, 2010. A review of attention-deficit
hyperactivity disorder complicated by symptoms of oppositional defiant
.disorder or conduct disorder
- DiGennaro et al., 2005, 2007. levels of problem behavior are associated
.with high levels of treatment integrity

- Eriksson, Lilly, Granlund, Mats, & Welunder, Jonas. (2007). Participation •
in everyday school activities for children with and without disabilities
.Childhood, 18, 485-502
- Gresham, 2005, 2007. Deconstructing a Definition: Social Maladjustment •
versus Emotional Disturbance and Moving the EBD Field Forward Kenneth
.W
- & Holtz, Kristin, & Tessman, Greta. (2006). Journal of developmental •
physical disabilities. Childhood, 531-542
- Jillian Pizzi, (2008). Rivier Academic Journal, Volume 4, Number 1, Spring •
.Challenges of Children With Physical Disabilities, 2008
- , Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB, Linzer M, Hahn SR, deGruy FV 3rd •
.Brody D Archives of Family Medicine, Physical symptoms in primary care
, Predictors of psychiatric disorders and functional impairment. Sep. 1994
[774-779:(9)3
- Lewis, T.J., Hudson, S., Richter, M., & Johnson, N. (2004). Scientifically •
supported practices in emotional and behavioral disorders: A pro-proposed
.approach and brief review of current practices
- Sandall, S., Schwartz, I., & Joseph, G. (2001). A building blocks model for •
.effective instruction in inclusive early intervention settings
- Skodol AE, Pagano ME, Bender DS, et al. Stability of functional impairment •
-in patients with schizotypal, borderline, avoidant, or obsessive
:compulsive personality disorder over two years. Psychol Med, 2005; 35(3)
.51-443
- Steven R. Forness and Kenneth A. Kavale. Education and Treatment of •
Children
- Wolery, M., Ault, M., & Doyle, P.M. (1992). Teaching students with •
moderate and severe disabilities: Use of response prompting strategies

Wolery, M. and Wilbers, J. S. (1994) Introduction to the inclusion of young •
children with special needs in early childhood programs. In M. Wolery and
J. S. Wilbers (eds), Including Children with Special Needs in Early
Childhood Programs, pp. 1–22. Washington, DC: National Association for
.the Education of Young Children

یونٹ 4: غیر معمولیات کی اقسام - III

تعارف

یہ باب الگ الگ حصوں میں مواصلاتی عوارض (communication disorders) اور مخصوص سیکھنے کی معذوریوں (specific learning disabilities) والے غیر معمولی بچوں کا منظم جائزہ پیش کرتا ہے۔ مواصلاتی عوارض اور سیکھنے کی معذوریاں جن کا افراد/بچے تجربہ کر سکتے ہیں، ان کی وضاحت ان افراد/بچوں کے لیے خصوصی تعلیمی مداخلتوں (educational interventions) کے حوالے سے کی گئی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رابطہ (communication) ایک ایسا نظام ہے جس کے بہت سے باہمی تعلقات ہیں۔ مواصلاتی عمل کے کسی ایک پہلو میں مسئلہ اکثر اس سے متعلق بہت سے دیگر عملوں کو متاثر کرتا ہے۔ دیگر تعلیمی شعبوں میں بچوں کی ترقی براہ راست ان کی تقریری اور لسانی اہلیت اور کارکردگی سے جڑی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ضرورت ہے کہ زبان کے عوارض والے بچوں کی جلد از جلد شناخت کی جائے اور انہیں وہ مداخلتیں فراہم کی جائیں جو اسکول کی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہیں۔

سیکھنے کی معذوری (LD) ایک عمومی اصطلاح ہے جو سیکھنے کے مخصوص مسائل کو بیان کرتی ہے۔ LD عوارض کا ایک گروہ ہے جو لوگوں کی اس صلاحیت کو متاثر کرتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں اس کی تشریح کر سکیں یا دماغ کے مختلف حصوں سے حاصل ہونے والی معلومات کو آپس میں جوڑ سکیں۔ یہ حدود کئی طرح ظاہر ہو سکتی ہیں: بولی اور تحریری زبان، ہم آہنگی، خود پر قابو، یا توجہ سے متعلق مخصوص مشکلات کی صورت میں۔ ایسی مشکلات اسکول کے کام تک پھیل جاتی ہیں اور پڑھنا، لکھنا یا ریاضی سیکھنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ سیکھنے کی معذوریاں ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی مہارتیں یہ ہیں: پڑھنا، لکھنا، سننا، بولنا، استدلال کرنا اور ریاضی کرنا۔ اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ مخصوص سیکھنے کی معذوریاں طلبہ کے ساتھ بالغ عمر تک رہتی ہیں اور زندگی بھر ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس لیے طلبہ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس معذوری کی نوعیت کے ساتھ ساتھ ان حکمت عملیوں کو بھی سمجھیں جنہیں وہ کلاس روم میں ایسی صورت حال کا سامنا کرنے پر استعمال کر سکتے ہیں۔

سیکھنے کے نتائج

یونٹ پڑھنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

1. تقریر، زبان اور رابطے (speech, language and communication) میں فرق کرنا۔

2. زبان کی صورت، مواد اور استعمال (language form, content, and use) کے بارے میں جاننا۔
3. رابطے کے اہم عملوں اور ان نظاموں کے بارے میں سیکھنا جو تقریر اور زبان کی نشوونما کی بنیاد ہیں۔
4. نشوونما کے چار اہم ادوار: بچپن (infancy)، اسکول سے پہلے کے سال، اسکول کے سال اور بالغ عمر کے دوران زبان کی نشوونما میں ہونے والی اہم تبدیلیوں کے بارے میں سیکھنا۔
5. اسکول کی عمر کے بچوں میں زبان کے عوارض کی نوعیت اور نتائج کو سمجھنا۔
6. زبان کی نشوونما کے ان پہلوؤں کے بارے میں سیکھنا جو پرائمری اور سیکنڈری جماعتوں میں زبان کے عوارض والے اسکول کی عمر کے بچوں کے لیے خاص طور پر مشکل ہیں۔
7. سیکھنے کی معذوری کے تصور اور اس کے ممکنہ اسباب کو سمجھنا۔
8. » سیکھنے کی معذوریاں« (learning disabilities)، »سیکھنے میں دشواریاں« (learning difficulties) اور »ذہنی معذوریاں« (intellectual disabilities) کی اصطلاحات میں فرق کرنا۔
9. سیکھنے کی معذوری والے فرد کی خصوصیات کے بارے میں جاننا۔
10. گہری (profound)، شدید (severe)، معتدل (moderate) اور ہلکی (mild) سیکھنے کی معذوری میں فرق جاننا۔
11. سیکھنے کی معذوریوں والے بچوں کے لیے درکار ممکنہ تعلیمی تطبیقات (educational adaptations) کے بارے میں بصیرت حاصل کرنا۔

4.1 قسم 5: مواصلاتی عوارض (Communication Disorders)

4.1.1 انسانی رابطے کا معمول کا عمل اور زبان کی نشوونما

رابطہ، تقریر اور زبان

رابطہ (communication) بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان معنی کا کوئی بھی تبادلہ ہے۔ یہ بظاہر سادہ تبادلہ اس لیے اہم ہے کہ یہ بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات اور احساسات بانٹتے ہیں، اپنی شناخت کا اظہار کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، روایات منتقل کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں وغیرہ۔ کچھ رابطہ ارادی ہوتا ہے اور کچھ غیر ارادی، جیسے جب آپ کا دوست آپ کے چہرے کے تاثرات یا آپ کی جسمانی زبان کی تشریح کرتا ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ زیادہ تر وقت معنی کا تبادلہ ایک ضابطے (code) کے ذریعے ہوتا ہے جسے زبان کہتے ہیں۔ زبان کی بہترین تعریف یہ

ہے کہ یہ علامتوں کا ایک معیاری مجموعہ اور ان علامتوں کو الفاظ، جملوں اور نصوص میں جوڑنے کا علم ہے تاکہ خیالات اور احساسات پہنچائے جاسکیں۔ زبان لکھی یا اشاروں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ بولی جاتی ہے۔ زبان اور تقریر میں فرق کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ یاد رکھنا ہے کہ زبان وہ ہے جو آپ کہتے ہیں (یعنی الفاظ اور جملوں کے معانی) اور تقریر یہ ہے کہ آپ اسے کیسے کہتے ہیں (یعنی وہ آوازیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں)۔

4.1.1.1 گفتار کے بنیادی اجزا

گفتار کی تیاری (speech production) دو اہم اجزا پر منحصر ہے: فونیمز (phonemes) اور سیلابز (syllables)۔

فونیمز

زبانوں میں آوازوں کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں: حروفِ صحیح (consonants) اور حروفِ علت (vowels)۔ حروفِ صحیح اور حروفِ علت اپنی پیداوار کے بنیادی طریقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ حروفِ علت صوتی نالی (vocal tract) میں کسی رکاوٹ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، جبکہ حروفِ صحیح صوتی نالی میں نمایاں رکاوٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ حروفِ صحیح ادائیگی کے طریقے (manner of articulation) اور مقام ادائیگی (place of articulation) کو تبدیل کر کے یا آوازکاری (voicing) کے ذریعہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ طریقہ ادائیگی سے مراد وہ مختلف طریقے ہیں جن سے مقرر منہ کے خول (oral cavity) میں ہوا کے بہاؤ کو مختلف قسم کی رکاوٹوں سے روک سکتا ہے۔ گفتار کی آوازوں میں تبدیلی کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ منہ کے خول میں مختلف مقامات پر رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ اسے مقام ادائیگی کہا جاتا ہے۔

سیلابز

سیلابز گفتار کی وہ اکائیاں ہیں جو حروفِ صحیح اور حروفِ علت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ حروفِ علت مرکزی جزو یا مرکزہ ہیں جس کے گرد باقی سیلاب تعمیر ہوتا ہے۔ ایک سیلاب ایک ہی حرفِ علت پر مشتمل ہو سکتا ہے، حالانکہ سیلابز میں عموماً حروفِ صحیح اور حروفِ علت کے مرکبات ہوتے ہیں۔ سب سے عام اور پیدا کرنے میں آسان مرکب ایک حرفِ صحیح اور ایک حرفِ علت کا ہے (مثلاً ba، si)، لیکن سیلاب کی پیچیدگی حرفِ علت سے پہلے (مثلاً ri، tri، stri) یا اس کے بعد (یعنی am، amp) حروفِ صحیح شامل کر کے بڑھائی جاسکتی ہے۔ مسلسل گفتار کی تیاری میں آوازوں کے لہجے (pitch)، زور (stress)، شدت (intensity) اور مدت (duration) میں تبدیلی کو پراسوڈی (prosody) کہتے ہیں۔ گرتا ہوا لہجہ اور شدت بیانات سے

وابستہ ہیں، جبکہ اٹھتا ہوا لہجہ سوالیہ صورتوں سے وابستہ ہے۔ زور کے نمونے کچھ الفاظ کے متعدد معانی میں فرق کرتے ہیں۔

4.1.1.2 زبان کے بنیادی اجزا

زبان کو اکثر تین باہمی متعلقہ اجزا والی خصوصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے: مواد (content)، صورت (form) اور استعمال (use)۔ مواد سے مراد زبان کا معنی ہے، صورت سے مراد زبان کی ساخت ہے، اور استعمال سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مقرر مختلف صورتوں میں سے ان کا انتخاب کرتے ہیں جو مواصلاتی سیاق و سباق کے لیے بہترین ہوں۔ کسی بھی جملے کے لیے زبان کے تینوں اجزا کا باہمی تعامل درکار ہوتا ہے۔

زبان کا مواد

زبان کا مواد زبان کا وہ جزو ہے جو معنی سے متعلق ہے۔ مقرر اشیا اور افعال کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی ملکیت یا سبب اور نتیجے جیسے تعلقات کے بارے میں خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ معانی ایک لفظ سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ دوسری باریہ معانی الفاظ کے گروہوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ اشیا، خیالات، احساسات، واقعات اور ان مظاہر کے درمیان تعلقات کی لسانی نمائندگی کو معانیات (semantics) کہتے ہیں۔ بچے ایک لغت (lexicon) تیار کرتے ہیں، جو الفاظ کی ایک ذہنی لغت ہوتی ہے۔ لفظ سیکھنا زندگی بھر کا عمل ہے، بنیادی طور پر اس لیے کہ ایک زبان بنانے والے الفاظ بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہر وقت نئے الفاظ شامل ہو رہے ہیں۔ لفظ سیکھنے کو اور بھی مشکل بنانے والی بات یہ ہے کہ اکثر الفاظ کے متعدد معانی ہوتے ہیں۔

زبان کی صورت

زبان کی صورت، یا زبان کی ساخت، تین لسانی نظاموں پر مشتمل ہے: صوتیات (phonology)، صورتیات (morphology) اور نحویات (syntax)۔ ہم نے صوتیات کا تصور اس وقت متعارف کرایا تھا جب ہم تقریر کی آوازوں کے بارے میں لکھنے پر بات کر رہے تھے۔ صوتیات ان آوازوں کا مطالعہ ہے جنہیں ہم الفاظ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر /r/، /b/ اور /l/ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی آوازیں بھی ہیں۔ فونیم گفتار کی سب سے چھوٹی معنوی اکائی ہے۔ صورتیات کا تعلق الفاظ کی اندرونی تنظیم سے ہے۔ مورفیم (morpheme) سب سے چھوٹی گرامری اکائی ہے جس کا معنی ہوتا ہے۔ لفظ bird ایک مورفیم ہے۔ اسے ایسے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا جن کا اپنے طور پر کوئی معنی ہو۔ bird آزاد مورفیم (free morpheme) کی مثال ہے کیونکہ یہ اکیلا لفظ کے طور پر گھڑا ہو سکتا ہے۔ پابند

مورفیمز (bound morphemes) بھی ہوتے ہیں، جو انگریزی میں گرامری ٹیگ یا علامتیں ہیں۔ پابند مورفیم کی مثال birds میں آخری s- ہے، جو گرامری معنی شامل کرتا ہے۔ اس صورت میں s- جمع کی علامت ہے، یعنی ایک سے زیادہ bird ہیں۔ نحویات سے مراد الفاظ کی ترتیب کو منظم کرنے کے لسانی روایات ہیں۔ بنیادی طور پر نحویات گرامر کی رسمی اصطلاح ہے اور الفاظ کی ترتیب کے اصول مختلف زبانوں کے لیے مختلف ہیں۔ ایسے جملے جو غیر گرامری ہوں، پھر بھی معنی دے سکتے ہیں۔

زبان کا استعمال

پیچیدہ خیالات کے اظہار کے لیے الفاظ کو جملوں میں جوڑا جاتا ہے۔ زبان کا استعمال زبان کے مقاصد اور ان ذرائع سے متعلق ہے جن سے ہم الفاظ اور جملوں کے متبادل مرکبات میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ سماجی لسانی روایات ہوتی ہیں جنہیں عملی لسانیات (pragmatics) کہتے ہیں، جو ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ کس سے کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے اور کب کہنا ہے۔ ہم الفاظ کے مختلف مجموعے منتخب کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارے معانی کو ان سامعین تک بہترین طریقے سے پہنچائیں گے جن سے ہم مخاطب ہیں۔

موثر زبان کے لیے مواد (معانیات)، صورت (صوتیات، صورتیات، نحویات) اور استعمال (عملی لسانیات) کا باہمی تعامل درکار ہوتا ہے۔ مقرر کچھ کہنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسے کہنے کے لیے بہترین الفاظ (مواد) اور ان الفاظ کو جملوں (صورت) میں ڈالتے ہیں جو بولنے کی صورتحال کی نوعیت (استعمال) کو دیکھتے ہوئے ان کے مقصد (استعمال) کو پورا کریں۔ اسی طرح سامعین الفاظ (مواد) اور جملوں (صورت) کی تشریح اس علم کے حوالے سے کرتے ہیں جو انہیں بولی جانے والی زبان (مواد اور صورت) اور جس صورتحال میں وہ ہیں (استعمال) کے بارے میں پہلے سے حاصل ہے۔

شکل 1: مواصلاتی عمل

شکل 1 ان بنیادی عملوں کو ظاہر کرتی ہے جو رابطے میں شامل ہیں۔ زبان کی تیاری میں، بھیجنے والے اپنے خیالات کو کسی زبان کے ضابطے کی صورت میں کوڈ کرتے ہیں۔ یہ ضابطہ عموماً بولایا لکھا جاتا ہے، لیکن یہ اشاروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تقریر میں، جو زبان کے اظہار کا سب سے عام ذریعہ ہے، وہ آوازیں، الفاظ اور جملے جو مقرر کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان پٹھوں کو احکامات بھیج کر بنائے جاتے ہیں جو تنفس (بنیادی طور پر ڈیافراجم)، صوت سازی (بنیادی طور پر حنجرہ) اور ادائیگی (بنیادی طور پر زبان، ہونٹ اور جبڑے) کے ذمہ دار ہیں۔ بولی گئی آوازوں کے تسلسل صوتی لہروں کی صورت میں منہ کے خول سے نکلتے ہیں۔

سننے اور سمجھنے میں، صوتی لہریں وصول کنندہ کے کان میں داخل ہوتی ہیں، جہاں وہ برقی تحریکوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ تحریکیں دماغ تک پہنچائی جاتی ہیں، جہاں انہیں تقریر کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور پھر الفاظ اور جملوں میں ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔ سامعین الفاظ اور جملوں کی تشریح الفاظ کے معانی کی ان کی سمجھ کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان الفاظ کے تعلق سے جو بولے گئے تھے اور بولنے کے سیاق و سباق سے۔

سرگرمی:

اپنی جماعت کے دو طلبہ کے درمیان غیر رسمی رابطے کی ایک مختصر ریکارڈنگ بنائیں اور اسے دوبارہ سن کر اس کے مواد کو لکھ لیں۔ پھر مواصلاتی نمونے کے فونیز، مورفیز، نحویات، معانیات اور عملی لسانیاتی عناصر کی الگ الگ فہرستیں تیار کریں۔

تجویز کردہ اضافی مطالعہ

.Bloom, L., & Lahey, M. (1978). Language development and language disorders
.New York: John Wiley & Sons

4.1.1.2 تقریر اور زبان کی نشوونما

جب تک اکثر بچے 3 یا 4 سال کے ہوتے ہیں، وہ بنیادی پیغامات کو سمجھنے اور پیدا کرنے کے لیے زبان کے مواد، صورت اور استعمال کو یکجا کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ 9 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اکثر بچے کافی پیچیدہ پیغامات کو سمجھنے اور اظہار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ رابطے کی صلاحیت بالغ عمر میں بھی بدلتی رہتی ہے، جہاں یہ تقریباً 50 سال کی عمر میں مستحکم ہو جاتی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں، سماعت کے نقصان اور ذہنی افعال کے ضائع ہونے کے نتیجے میں رابطے کی مہارتیں اکثر کم ہو جاتی ہیں۔ مواصلاتی عوارض والے بچوں اور بالغوں کی مدد کے لیے، آپ کو یہ تعین کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ ان کی رابطے کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ ان مہارتوں کے لیے تقریر اور زبان کی نشوونما میں مضبوط بنیاد درکار ہے۔ غیر معمولی نشوونما کی شناخت کے لیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معمول کی نشوونما کیا ہے۔

انفرادی اختلافات

آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رابطے کی نشوونما کی رفتار میں کافی فرق ہوتا ہے۔ یعنی کچھ بچے دوسروں سے تیزی سے زبان سیکھتے ہیں، اور کچھ بالغوں کی مہارتیں دوسروں سے تیزی سے کم ہوتی ہیں۔ زبان کی نشوونما کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ بچے خطرہ مول لینے والے ہوتے ہیں؛ وہ مشکل الفاظ کہنے کی کوشش کریں گے جو ان کے لیے پیدا کرنا مشکل ہوں، چاہے الفاظ صحیح طور پر ادا نہ ہوں۔ دوسرے

بچے اسے الفاظ پیدا نہ کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے کہنا مشکل ہوں، جب تک انہیں یقین نہ ہو کہ وہ انہیں صحیح کہہ سکتے ہیں۔ کچھ بچے دو الفاظ کے جملے پیدا کرنا شروع کرنے سے پہلے بہت سے اسم (50 یا زیادہ) سیکھ لیتے ہیں؛ دوسرے بچے 50 الفاظ کے ذخیرے سے پہلے ہی سماجی جملے (مثلاً see you، thank you، ya later، hi daddy) سیکھ اور استعمال کر لیتے ہیں۔ آخر میں، رابطے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ بچے اور بالغ نسبتاً کم گو ہوتے ہیں؛ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ نہیں کہتے۔ دوسرے بچے اور بالغ کافی سماجی ہوتے ہیں؛ وہ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ کہتے ہیں! نتیجتاً یہ تعین کرنا مشکل، بلکہ ناممکن ہے کہ ”معمول“ کیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ زبان کی نشوونما میں کسی خاص نشوونما کی عمر میں بالکل کیا ہوتا ہے۔ چونکہ اتنا زیادہ انفرادی فرق ہوتا ہے، ہم معمول کی نشوونما کے بجائے معمولی (typical) نشوونما کی بات کرتے ہیں، اور ہم جدول 1 میں دی گئی تقریر اور زبان کے رویوں کی پہلی ظاہری شکل کے لیے عمری حدیں فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ بچوں کو نشوونما کی مشکلات ہوتی ہیں جو انہیں بعد کی زندگی میں سماجی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ مشکلات کے نمایاں خطرے میں ڈالتی ہیں۔ باخبر استاد جانتا ہے کہ زبان کی نشوونما کب معمولی حد سے اتنی باہر ہو کہ اس کے منفی سماجی، تعلیمی یا پیشہ ورانہ نتائج نکل سکیں۔

جدول 1: تقریر اور زبان کی نشوونما کے بنیادی سنگ میل اور ان کی پہلی ظاہری شکل کی معمولی عمری حد

تقریر اور زبان کے سنگ میل	پہلی ظاہری شکل کی عمری حد
سادہ الفاظ سمجھنا (mommy، daddy، dog)	6-8 ماہ
دہرائی گئی ببلنگ (ba-ba)	6-8 ماہ
متنوع ببلنگ (ba-do-ke-ga-do)	6-8 ماہ
پہلا لفظ	10-14 ماہ
دو الفاظ کے جملے	16-20 ماہ
پہلے گرامری مورفمز	1;10-2;2 سال
کئی الفاظ کے جملے	2;2-6;2 سال
جملوں کے مرکبات جو واقعات بیان کرتے ہیں	3;2-6;3 سال
ناواقف سامعین کے ذریعے سمجھا جانا (95 فیصد حروف صحیح بالعموم کی طرح ادا کیے گئے)	3;10-4;2 سال

5;0-5;8 سال	بولے گئے الفاظ میں ابتدائی آوازوں کی شناخت
6;0-6;6 سال	الفاظ کی رمز کشائی
8-10 سال	پیچیدہ کہانیاں سننا
11-13 سال	تحریری کہانیاں بولی گئی کہانیوں سے زیادہ پیچیدہ
14-15 سال	متعدد ذرائع سے معلومات کو تحقیقی مقالات میں جوڑنا
15-20 سال	ذاتی بولنے اور لکھنے کے انداز کو بہتر بنانا
21-24 سال	پیشے سے متعلق مخصوص الفاظ کا استعمال
45-47 سال	ناموں اور مواد کے الفاظ کو یاد رکھنے میں مسلسل دشواری

حاشیہ: بچوں کی عمروں کو سال؛ مہینے کے رواج سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی 10;1 سے مراد عمر ہے، 1 سال، 10 ماہ۔

4.1.2 تقریر، آواز اور زبان کے عوارض

اصطلاح مواصلاتی عارضہ (communication disorder) کبھی خرابی (impairment) کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور کبھی معذوری (disability) کے مترادف کے طور پر۔ مواصلاتی عارضے سے مراد کوئی بھی مواصلاتی ساخت یا فعل ہے جو نمایاں حد تک کم ہو گیا ہو۔ بد قسمتی سے، مواصلاتی عوارض والے بہت سے لوگ مواصلاتی معذوریوں اور رکاوٹوں کا تجربہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ لازمی نہیں ہے۔

مواصلاتی اختلافات

کچھ لوگ مرکزی دھارے کی ثقافت سے مختلف طریقوں سے رابطہ کرتے ہیں۔

ہم اصطلاح مواصلاتی اختلاف (communication difference) سے مراد رابطے کی وہ صلاحیتیں لیتے ہیں جو مرکزی دھارے کی ثقافت میں عموماً پائی جانے والی صلاحیتوں سے مختلف ہوں، اگرچہ خرابی کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ مثال کے طور پر، جب اسکول شروع کرتے ہیں تو وہ بچے جنہوں نے اپنی زندگی کے زیادہ تر حصے میں پنجابی یا پشتو بولی ہو، اپنے یک لسانی اردو بولنے والے ہم جماعتوں کی طرح رابطہ نہیں کریں گے۔ وہ بچے جو بغیر کسی مشکل کے پنجابی یا پشتو وغیرہ سیکھتے ہیں، انہیں کوئی مواصلاتی عارضہ نہیں ہوتا۔ بد قسمتی سے، ان بچوں کے مواصلاتی اختلافات اسکول کے ماحول میں وقتاً فوقتاً سماجی اور تعلیمی نقصانات میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ان بچوں کو دوسری زبان کے طور پر اردو سیکھنے میں اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مواصلاتی عوارض عموماً تقریری عوارض، لسانی عوارض اور سماعتی عوارض میں درجہ بند کیے جاتے ہیں۔ عارضہ کب

واقع ہوتا ہے یہ بھی ایک اہم غور ہے۔ نشوونما کی عوارض، جیسے تقریر اور زبان کی نشوونما میں تاخیر، فرد کی پختگی کے ابتدائی دور میں واقع ہوتے ہیں لیکن بالغ عمر تک جاری رہ سکتے ہیں۔ حاصل شدہ عوارض، جیسے کسی حادثے کے بعد دماغی صدمے کے نتیجے میں تقریر اور زبان کے عوارض، رابطے کی مہارتیں مکمل طور پر نشوونما پا جانے کے بعد واقع ہوتے ہیں۔

4.1.2.1 تقریری عوارض

تقریری عوارض گفتار کی تیاری کے عمل میں خلل کا نتیجہ ہیں۔ یہ عمل حرکی حرکات کی پروگرامنگ سے شروع ہوتا ہے اور اس صوتی سگنل پر ختم ہوتا ہے جو آواز کو سامع تک پہنچاتا ہے۔ تاریخی رواج کے مطابق، تقریری عوارض کو تقریر کی تیاری کے اس پہلو (تلفظ، روانی، آواز وغیرہ) کی بنیاد پر درجہ بند کیا جاتا ہے جو متاثر ہو۔

تلفظ اور صوتیاتی عوارض

تلفظ اور صوتیاتی عوارض (articulation and phonological disorders) والے افراد کو تقریر کی آوازوں کی تیاری میں مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل جسمانی ساختوں، جسمانی افعال اور سیکھنے میں انحراف کا نتیجہ ہیں۔ جب مسئلے کے بارے میں خیال کیا جائے کہ اس کا تعلق اس طریقے سے ہے جس سے آوازیں دماغ میں نمائندگی پاتی ہیں، تو اسے عموماً صوتیاتی عارضہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ ایک انتہا پر کم سے کم ہو سکتا ہے (ایک یا دو تقریری آوازوں، جیسے /s/ یا /r/ کی تیاری میں مداخلت) یا شدید، جو تقریر کو ناقابل فہم بنا دے۔ اس زمرے میں نشوونما کی تقریری عوارض، بچوں میں اعصابی عضلاتی تقریری عوارض، اور پھٹے تالو (cleft palate) جیسی چہرے اور منہ کی بے قاعدگیوں کے نتیجے میں تلفظ کے عوارض شامل ہیں۔ تقریباً 10 فیصد پری اسکول اور اسکول کی عمر کے بچوں میں تلفظ یا صوتیاتی عوارض پائے جاتے ہیں (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 2007)۔

روانی کے عوارض

روانی کا عارضہ (fluency disorder) بولنے کے بہاؤ میں ایک غیر معمولی خلل ہے۔ روانی کے عوارض والے افراد کی تال اور رفتار غیر معمولی ہوتی ہے اور آوازوں اور سیلابز کی غیر معمولی تعداد میں تکرار ہوتی ہے۔ ان کی روانی میں خلل اکثر ضرورت سے زیادہ تناؤ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ان الفاظ کو پیدا کرنے کے لیے واضح طور پر جدوجہد کر سکتے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ سب سے عام روانی کا عارضہ ہکلاہٹ (stuttering) ہے۔ تقریباً 1 فیصد عام آبادی ہکلاتی ہے، لیکن تمام بالغوں میں سے 5 فیصد تک رپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی وقت ہکلاہٹ کا تجربہ کیا۔

آواز کے عوارض

آواز کے عوارض کے زمرے کو عموماً دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: صوت سازی (phonation) اور گونج (resonation)۔

صوتی عوارض (phonatory disorders) صوتی تاروں کے ارتعاش میں بے قاعدگیوں کا نتیجہ ہیں جو بلند آوازی، لہجے یا معیار (مثلاً سانس بھری، کھردری یا بھری ہوئی آواز) میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ تقریر کی آوازوں کی تیاری کے دوران ناک اور منہ کے درمیان کھلے حصے کو بند کرنے کے مسائل کو گونج کے عوارض (resonance disorders) کہتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ امریکہ کی کل آبادی کے 3 فیصد سے 9 فیصد کے درمیان کسی نہ کسی قسم کا آواز کا عارضہ ہے (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 2007)۔

4.1.2.2 لسانی عوارض

زبان سے مراد وہ الفاظ اور جملے ہیں جو اشیا، خیالات اور احساسات کی نمائندگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لسانی عارضہ (language disorder) پیغامات کو سمجھنے یا پیدا کرنے میں ایک نمایاں کمی ہے۔ لسانی عوارض کی تین اہم اقسام ہیں: نشوونما (یا فعلی) لسانی عوارض جو بچپن میں واقع ہوتے ہیں، حاصل شدہ لسانی عوارض جو بچپن میں ہو سکتے ہیں لیکن اکثر بڑی عمر کے بالغوں میں ہوتے ہیں، اور ڈیمینشیا (dementia)، جو تقریباً ہمیشہ بڑی عمر کے بالغوں میں ہوتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ امریکہ میں 6 سے 8 ملین افراد کے درمیان کسی نہ کسی قسم کا لسانی عارضہ ہے (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 2007)۔

زبان میں تاخیر

پری اسکول کے سالوں کے دوران، کچھ بچوں کی زبان کی نشوونما میں تاخیر ہوتی ہے جو کسی معلوم سبب سے وابستہ نہیں ہوتی۔ یعنی بچوں کو زبان استعمال کرنے اور سمجھنے میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے مشکلات ہوتی ہیں۔ ان بچوں کے الفاظ کم، جملے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی عمر کے اکثر دوسرے بچوں کی طرح زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ تقریباً نصف بچے جنہیں 2 سال کی عمر میں ابتدائی زبان میں نمایاں تاخیر ہوتی ہے (یعنی 50 الفاظ سے کم الفاظ)، 5 سال کی عمر تک پہنچنے پر زبان کی نشوونما میں تیزی آئے گی جو انہیں اپنے ہم عمر ساتھیوں کے برابر کر دے گی (Paul, Hernandez, Taylor, & Johnson, 1996)۔

نشوونمائی لسانی عارضہ

کچھ بچوں کی زبان کی سمجھ اور/یا تیاری میں خرابی ہوتی ہے جو سماجی میل جول اور تعلیمی کامیابی میں نمایاں مداخلت کرتی ہے۔ ان بچوں کو مختلف مسائل ہو سکتے ہیں جن میں وہ جملے بنانے میں دشواری جو وہ کہنا چاہتے ہیں، غیر معمولی تعداد میں گرامری غلطیاں، ان الفاظ کو سوچنے میں دشواریاں جو وہ جانتے ہیں جب انہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور/یا زبان کے سماجی استعمال میں دشواریاں (وہ غلط وقت پر غلط بات کہتے ہیں) شامل ہیں۔ زبان میں تاخیر کی طرح، لسانی عارضہ کسی مخصوص سبب سے وابستہ نہیں ہوتا۔ جب تک بچے اسکول سے پہلے کے آخری اور اسکول کی عمر کے ابتدائی سالوں میں نہ ہوں، زبان کی تاخیر اور لسانی عارضے میں فرق کرنا مشکل ہے۔ لسانی عارضے کو زبان کی تاخیر سے اس وقت ممتاز کیا جاسکتا ہے جب خرابی 5 سال کی عمر سے آگے برقرار رہے اور بچے اپنے ساتھیوں کے برابر نہ ہو سکیں۔ تمام بچوں کے 6 فیصد سے 8 فیصد کے درمیان لسانی عوارض ہیں۔

حاصل شدہ لسانی عوارض

حاصل شدہ لسانی عوارض دماغی زخموں (brain lesions) کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو دماغ کو نقصان کے مخصوص علاقے ہیں۔ دماغ کو تکلیف دہ چوٹ کے نتیجے میں علمی اور لسانی خلل کا ایک سنڈروم پیدا ہوتا ہے۔ چوٹ سے وابستہ رابطے کے خسارے بنیادی طور پر یادداشت، واقفیت اور تنظیم سے متعلق علمی عملوں کی خرابی کا نتیجہ ہیں اور ان میں تقریر اور زبان کے فعل کے مقابلے میں رابطے میں زیادہ واضح مسائل شامل ہیں۔ دماغی صدمے کے زیادہ تر کیسز موٹر گاڑیوں کے حادثات کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہر سال تقریباً 7 ملین نئے کیسز ہوتے ہیں۔

سماعتی عوارض

سماعتی عوارض (hearing disorders) والے لوگوں کی آوازوں کا پتہ لگانے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے۔ یہ کمی اس لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے کہ آوازیں سننے سے پہلے انہیں کتنا بلند پیش کرنا ضروری ہے۔ سماعت سنی جانے والی آوازوں کے لہجے کی سطح کے حوالے سے بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ افراد کم تعدد والی آوازیں جیسے باس گٹار کے سروں کو اس سے بہتر سن سکتے ہیں کہ وہ اونچی تعدد والی آوازیں جیسے چھوٹی کھنٹی سن سکیں۔ دوسرے افراد کسی بھی تعدد پر آوازیں اچھی طرح نہیں سنتے۔ ASHA (ASHA 2000) کے مطابق، مواصلاتی عارضے والے اندازاً 46 ملین شہریوں میں سے 28 ملین سے زیادہ کو کسی نہ کسی قسم کا سماعتی عارضہ ہے۔ سماعت کا نقصان رابطے پر بڑا یا چھوٹا اثر ڈال سکتا ہے، یہ نقصان کی حد اور متاثر ہونے والی آوازوں کی قسم پر منحصر ہے۔ ہلکی سماعت کے نقصان والے لوگ جو صرف اونچی لہجے والی آوازیں سننے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، bath جیسے الفاظ کی آخری آوازیں سننے سے محروم رہیں گے،

لیکن وہ زیادہ تر دیگر آوازیں اتنی اچھی طرح سنیں گے کہ عموماً کھوئے ہوئے حصے پورے کر سکیں۔ تاہم، سماعت کے نقصان والے لوگ جو گفتگو کی تقریر کی سطح پر پیدا ہونے والی اونچی اور نچلی لہجے والی آوازیں سننے کی ان کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، رابطے میں نمایاں نقصان میں ہوں گے۔

دیگر اہم عوامل جو اس حد کو متاثر کرتے ہیں کہ سماعت کا نقصان رابطے پر کتنا اثر ڈالتا ہے، ان میں یہ شامل ہے کہ آیا سماعت کا نقصان یک طرفہ (ایک کان) ہے یا دو طرفہ (دونوں کان)، کس قسم کی تقویت (amplification) فراہم کی گئی ہے، فرد کو تقویت حاصل کیے کتنا عرصہ ہوا ہے، اور فرد اور اس کے خاندان کے ارکان کے رویے۔ سماعت کے نقصان والے شخص کی عمر بھی اس حد میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ سماعت کا نقصان رابطے پر کتنا اثر ڈالتا ہے۔ پیدائش سے موجود ایک معتدل سماعت کا نقصان 40 سال کی عمر میں ہونے والے ایک معتدل سماعت کے نقصان سے کہیں زیادہ مسئلہ خیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی سماعت رابطے کی نشوونما کے لیے نہایت اہم ہے۔ جو بچے اچھی طرح نہیں سنتے، انہیں ان سے بولی جانے والی زبان کو سمجھنے، تقریر کی آوازیں واضح طور پر پیدا کرنا سیکھنے، اور پیچیدہ خیالات کے اظہار کے لیے ضروری الفاظ اور جملوں کی ساخت تیار کرنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ سماعت کے نقصان کی جلد تشخیص بالکل ضروری ہے تاکہ بچے جلد از جلد مداخلت حاصل کر سکیں۔ کچھ بچے سماعتی آلے (hearing aid) لگوانے سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جتنی جلدی انہیں مناسب تقویت ملے گی، تقریر اور زبان کی نشوونما کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ دوسرے بچے تقویت کے باوجود زیادہ نہیں سن پاتے۔ ان بچوں کو زبان کی نشوونما کے لیے اشاروں کی زبان (sign language) یا خصوصی تقریری تربیت سے متعارف کرانا ضروری ہے۔

تجویز کردہ مطالعہ

Bishop, D. V. M. (1997). Uncommon understanding: Development and disorders of language comprehension in children. Hove, England: Psychology Press/Erlbaum (UK), Taylor & Francis

Semel, E., Wiig, E., & Secord, W. (1996). Clinical evaluation of language fundamentals (3rd ed.). San Antonio, TX: Psychological Corporation

4.1.3 کلاس روم میں لسانی تنوع اور علاجی تدریس

تمام اسکول کی عمر کے بچوں میں سے تقریباً 7 فیصد کو زبان سیکھنے اور استعمال کرنے میں غیر معمولی مشکلات ہوتی ہیں، اور ہر سال 1 ملین سے زیادہ بچے سرکاری اسکولوں میں زبان کی مداخلتی خدمات حاصل کرتے ہیں (U.S. Department of Education, 2005)۔ اسکول کی عمر کے بچوں میں زبان کے عوارض کے

متعدد اسباب ہیں جن میں ذہنی اور علمی خرابیاں، معلومات کی پروسیسنگ میں مسائل (توجہ، ادراک اور یادداشت میں خسارے)، سماعت کا نقصان، جذباتی عوارض اور نظر انداز شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ زبان کے عوارض کے زیادہ تر کیسز میں، بچے کی زبان سیکھنے کی مشکلات کے سبب یا اسباب معلوم نہیں ہوتے۔

لسانی عوارض

بہت سے پری اسکول کی عمر کے بچوں کی زبان سیکھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت میں نمایاں حدود ہوتی ہیں۔ زبان کی صورت (صوریات اور نحویات)، مواد (لغت کا حجم اور معنوی تعلقات) اور/یا استعمال (عملی لسانیات اور سماجی میل جول) کے شعبوں میں ان بچوں کی نشوونما ان کے ہم عمر ساتھیوں سے پیچھے رہتی ہے۔ ان میں سے کچھ بچے ابتدائی مداخلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زبان کی نشوونما میں تیزی آتی ہے جو انہیں 5 سال کی عمر تک اپنے ہم عمر ساتھیوں جیسی زبان کی مہارتیں تیار کرنے کے قابل بناتی ہے (Paul, Hernandez, Taylor, & Johnson, 1996)۔ تاہم، یہی دیر سے بولنے والے بچے جو 5 سال کی عمر تک برابر ہو جاتے ہیں، اکثر اپنے نو عمر سالوں تک زبان اور پڑھنے کی کم مہارتیں رکھتے ہیں (Rescorla, 2002)۔ وہ بچے جن کے لسانی عوارض زیادہ شدید ہیں اور جو ابتدائی عمر میں بہتر نہیں ہوتے، انہیں اکثر ایلیمنٹری اسکول کے سالوں کے دوران سماجی اور تعلیمی زبان میں نمایاں مشکلات ہوتی ہیں (Aram & Hall, 1989; Paul, Murray, Clancy, & Andrews, 1997)۔ اکثر، یہی بچے سیکنڈری جماعتوں (Bishop, 1997; Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase, & Kaplan, 1998) اور یہاں تک کہ بالغ عمر (Records, Tomblin, & Buckwalter, 1995) میں بھی سماجی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ مشکلات ظاہر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے، ماہرین کو زبان کے عوارض والے بچوں کی جلد از جلد شناخت کرنے اور انہیں وہ مداخلتیں فراہم کرنے کی اپنی کوششوں میں مستعد ہونے کی ضرورت ہے جن کی انہیں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ بچوں کو لسانی عارضے والا تب تشخیص کیا جاتا ہے جب انہیں زبان کی صورت، مواد اور استعمال میں مشکلات ہوں جو ان کی عمری عمر کے لحاظ سے غیر متوقع ہوں۔ یعنی وہ زبان کو سمجھنے یا پیدا کرنے میں اپنے ہم عمر دیگر بچوں سے نمایاں طور پر کمزور ہوں۔ معالجین یہ تعین بچوں کی کارکردگی کا ان کے ہم عمر بچوں کے معیارات سے موازنہ کر کے معیاری ٹیسٹوں پر کرتے ہیں۔ وہ یہ تعین گفتگو اور کہانی کے زبان کے نمونوں میں زبان کی سطح اور صورت، مواد اور استعمال کی غلطیوں کے نمونوں کا تجزیہ کر کے بھی کرتے ہیں۔

بچے کی زبان کی صلاحیتوں کا اسی عمر کے عموماً کامیاب بچوں کی صلاحیتوں سے موازنہ کرنا عمری حوالہ جاتی تشخیص (chronological age referencing) کہلاتا ہے۔ یعنی کسی خاص عمر کے لیے متوقع زبان کی صلاحیت وہ حوالہ ہے جس پر لسانی عارضے کے تعین کی بنیاد ہوتی ہے۔

4.1.3.1 اسکول کی عمر کے سالوں کے دوران زبان کی نشوونما کے شعبے

الف۔ پرائمری جماعتیں

زبان کی صورت، مواد اور استعمال کے بہت سے پہلو اسکول کی عمر کے سالوں کے دوران بھی نشوونما پاتے رہتے ہیں۔ پرائمری جماعتوں کے دوران زبان کی نشوونما کے تین اہم پہلو ہیں جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

i۔ پیچیدہ جملے

اکثر بچے اسکول کی عمر کے سالوں کے دوران زیادہ پیچیدہ جملے اور پیچیدہ جملوں کی زیادہ اقسام استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ بچوں کے پاس بات کرنے کے لیے زیادہ پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں، انہیں پیچیدہ زبان کی مختلف اقسام پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے خیالات کا اظہار کر سکیں۔

بچے ان نحوی آلات کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں جو «خواندہ» زبان کے لیے درکار ہیں، اور وہ دریافت کرتے ہیں کہ ان پیچیدہ ساختوں کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ بد قسمتی سے، پیچیدہ جملے زبان کے عوارض والے بہت سے بچوں کے لیے غیر معمولی مشکلات پیش کرتے ہیں، اور یہ مشکلات خاص طور پر اس وقت واضح ہوتی ہیں جب بچے پڑھ اور لکھ رہے ہوتے ہیں (Gillam & Carlile, 1997; Gillam & Johnston, 1992)۔ اکثر، زبان کے عوارض والے بچے پیچیدہ جملے پیدا کرتے وقت زیادہ الجھاوٹیں (mazes) استعمال کرتے ہیں۔ الجھاوٹ (maze) ایک جملے کی تکرار، غلط شروعات یا دوبارہ تشکیل ہے۔ یہ زبان کے عوارض والے بہت سے اسکول کی عمر کے بچوں کے لیے غیر معمولی مسائل نہیں ہیں۔

ii۔ قصہ گوئی

قصہ گوئی (narration) اسکول کی عمر کے سالوں کے دوران زبان کی نشوونما کا ایک اہم پہلو ہے۔ بچے ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں کے بارے میں کہانیاں سنا کر سماجی میل جول کرتے ہیں، وہ واقعات کو یاد رکھنے کے لیے کہانیوں کو ذہنی اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہانیاں پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں۔ بچوں کی کہانیاں پرائمری جماعتوں کے دوران لمبی اور زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ تفصیلی اقساط بنانا سیکھتے ہیں۔ وہ اپنی کہانیوں میں متعدد اقساط کو بننے کی صلاحیت بھی تیار کرتے ہیں۔ اگر زبان کے عوارض والے بچوں کو پیچیدہ جملے بنانے میں دشواری ہو تو یہ حیران کن نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں جملوں کے گروہوں کو کہانیوں میں جوڑنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ زبان کے عوارض والے بچوں کی قصہ گوئی کی صلاحیتوں کے مطالعات نے دکھایا ہے کہ وہ معمول کے مطابق چھوٹی کہانیاں سناتے ہیں جن میں کہانی کے

گرامر کے عناصر کم اور جو معمولی نشوونما پانے والے بچوں کی کہانیوں سے کم مربوط ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، قصہ گوئی میں دشواریاں سماجی میل جول اور خواندگی کی نشوونما میں مداخلت کرتی ہیں۔

iii- خواندگی

پڑھنا سیکھنا شاید پرائمری جماعت کے سالوں کے دوران سب سے اہم کامیابی ہے۔ بچوں کو کنڈرگارٹن اور پہلی جماعت میں الفاظ کی رمز کشائی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ دوسری جماعت میں تعلیم عموماً رمز کشائی کی مہارتوں کو زیادہ خود کار بنانے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے۔ تیسری جماعت سے شروع ہو کر، تعلیم کا بنیادی زور پڑھنے کو سیکھنے کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت میں بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، پڑھنا اور لکھنا زبان کے کام ہیں، اور زبان کے عوارض والے بہت سے اسکول کی عمر کے بچوں کو خواندگی سیکھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ پڑھنا دو اجزاء پر مشتمل ہے: زبان کی سمجھ اور لفظ کی شناخت۔ جن بچوں کو زبان کی سمجھ میں دشواری ہوتی ہے، انہیں زبانی زبان اور تحریری زبان دونوں کو سمجھنے میں مسائل ہونے کا امکان ہے۔ زبان اور پڑھنے کی سمجھ کے درمیان تعلق کو الٹ انداز میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ یعنی جن بچوں میں پڑھنے کی سمجھ کا خسارہ ہوتا ہے، انہیں زبان کی سمجھ میں دشواری ہونے کا امکان ہے (Catts, Adlof, & Weismer, 2006)۔ پڑھنے کی سمجھ میں دشواری والے بچے کبھی کبھی الفاظ کی رمز کشائی اور شناخت اچھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان الفاظ کے انفرادی یا اجتماعی معنی کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف، وہ بچے جن کی زبان کی سمجھ معقول حد تک اچھی ہے، لیکن لفظ کی شناخت خراب ہے۔ لفظ کی شناخت کے دو اہم ذیلی مہارتیں ہیں: ذہنی تحریری تصویروں (MGRs) کی نشوونما، اور لفظ کی رمز کشائی۔ MGRs (جنہیں بصری یا ذہنی املائی تصویریں بھی کہا جاتا ہے) قارئین کو الفاظ کی تقریباً فوری شناخت کرنے کی اجازت دیتی ہیں بغیر رمز کشائی یا «انہیں آواز دے کر پڑھنے» کی ضرورت کے۔ رواں قاری پڑھتے وقت زیادہ تر وقت MGRs استعمال کرتے ہیں۔ صرف جب کوئی نیا یا غیر عام لفظ پیش کیا جائے تو رواں قاری کو رمز کشائی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ MGRs کا استعمال اکثر «ایک نظر میں لفظ پڑھنا» (sight word reading) کہلاتا ہے۔

اگرچہ الفاظ کی تیزی سے شناخت کرنے کی صلاحیت پڑھنے کی ایک انتہائی اہم مہارت ہے، الفاظ کی رمز کشائی کی صلاحیت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ بچے اپنی زبان کے بارے میں اس وقت سوچنا شروع کرتے ہیں جب وہ کنڈرگارٹن میں داخل ہوتے ہیں۔ اس صلاحیت کو میٹا لسانی شعور (metalinguistic awareness) کہتے ہیں۔ رمز کشائی، یا حرف۔ آواز کے مرکبات کے «ضابطے کو توڑنے» کی صلاحیت، میٹا لسانی شعور کے ایک پہلو کی متقاضی ہے جسے صوتیاتی شعور (phonological awareness) کہتے ہیں۔ صوتیاتی شعور الفاظ کی فونیم ساخت کی شناخت کی صلاحیت ہے۔

صوتیاتی شعور پڑھنے کی نشوونما میں انتہائی اہم ثابت ہوا ہے، خاص طور پر رمز کشائی کی لفظ سیکھنے کی مہارت کے لیے۔ بد قسمتی سے، زبان کے عوارض والے بہت سے بچوں کو صوتیاتی شعور میں دشواریاں ہوتی ہیں (Gillon, 2005)۔

ب۔ سیکنڈری جماعتیں

سیکنڈری جماعتوں میں موجود بچوں کے لیے توجہ مخصوص مضامین سے وابستہ الفاظ (مثلاً جیومیٹری، عالمی تاریخ یا حیاتیات)، وضاحتی نصوص (کسی چیز کو سکھانے یا وضاحت کرنے کے لیے گفتگو) کی سمجھ اور تیاری، اور/یا سیکھنے کے لیے میٹا علمی حکمت عملیوں (metacognitive strategies) پر ہوتی ہے۔

i۔ مضمون سے متعلق مخصوص الفاظ

جیسا کہ باب 2 میں ذکر کیا گیا، اسکول کی عمر کے سالوں کے دوران بچوں کے الفاظ ڈرامائی طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ اس بڑھوتری کا زیادہ تر حصہ ریاضی، سماجی علوم اور سائنس جیسے مضامین میں مضمون سے متعلق مخصوص الفاظ کے حصول سے متعلق ہے۔ زبان کے عوارض والے بہت سے طلبہ کو مضمون سے متعلق مخصوص الفاظ کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور یہ دشواری اسکول کی ناکامی میں حصہ ڈالتی ہے۔ اس لیے استاد اکثر ان بچوں کو وہ الفاظ حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے جن کی انہیں اپنے کورسز میں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔

ii۔ وضاحتی نصوص

نو عمر بحث اور قائل کرنے کے بیانی روایات میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ ان مہارتوں کے لیے انہیں افراد، حقائق اور تاریخوں کے بارے میں معلومات پیش کرنا اور مخصوص تفصیلات، عمومی باتیں اور نتائج فراہم کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کو گفتگو کی انہی صورتوں کا سامنا ہوتا ہے، جنہیں وضاحتی نصوص (expository texts) کہتے ہیں، اپنی تعلیمی نصابی کتابوں میں۔ زبان کے عوارض والے طلبہ کو اکثر ان وضاحتی نصوص کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے جو انہیں اپنے کورسز کے لیے پڑھنے ہوتے ہیں (Gillam & St. Clair, 2007)۔ وہ اپنی سائنس یا تاریخ کی نصابی کتابوں میں ظاہر کیے گئے سبب اور نتیجے کے تعلقات کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہیں ان وضاحتی نصوص کو بنانے میں بھی دشواریاں ہوتی ہیں جو جماعت کے لیے تفویض کردہ کام مکمل کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں جیسے کتاب کی رپورٹیں، مضامین اور ٹرم پیپرز۔ یہ دشواریاں اسکول کی ناکامی میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔

iii۔ میٹا علمی حکمت عملیاں

نوعمر اسکول کے مضامین سیکھنے کے لیے حکمت عملیاں استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ ایلیمنٹری اسکول کے سالوں کے دوران، اساتذہ طلبہ کی مدد کرتے ہیں جب وہ پڑھنے، لکھنے اور ریاضی کے حساب کی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں۔ مڈل اور ہائی اسکول کے سالوں کے دوران، تعلیمی سیکھنے میں خود انحصاری کی زیادہ توقع ہوتی ہے۔ تعلیمی طور پر کامیاب ہونے کے لیے، نوعمر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت سے باہر مکمل کیے گئے تفویض کردہ کاموں سے علم کیسے حاصل کرنا، ذخیرہ کرنا، یاد رکھنا اور استعمال کرنا ہے۔

میٹا علمی حکمت عملیاں (metacognitive strategies) وہ کوشش طلب عمل ہیں جو طلبہ مخصوص سیکھنے کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، طلبہ ان اقتباسات کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں جو وہ مکمل طور پر نہیں سمجھتے، اضافی نوٹس لے سکتے ہیں، اپنے نوٹس کو بلند آوازیں کہہ کر یاد کر سکتے ہیں، یا اپنے مشقی ٹیسٹ خود بنا سکتے ہیں۔ زبان کے عوارض والے نوعمر اکثر ان کوشش طلب سیکھنے کی حکمت عملیوں کو لاگو کرنے میں ناکارہ پن یا یہاں تک کہ ہچکچاہٹ ظاہر کرتے ہیں۔

4.1.3.2 کلاس روم کے اساتذہ کے لیے متبادل حکمت عملیاں

1. استاد کے سوالات کو آسان بنائیں۔
2. استاد کی ہدایات کو مختصر کریں۔
3. بچے سے استاد کی ہدایات دہرانے کا مطالبہ کریں۔
4. بچے کو خیالات کو منظم کرنے کے لیے اضافی وقت دیں۔
5. لفظ کی بازیابی میں بچے کی مدد کے لیے اشارے دیں۔
6. سوالات اور ہدایات کی زیادہ تفصیل سے وضاحت کریں۔
7. بچے کے بیانات دہرائیں، انہیں مکمل بنانے کے لیے گرامری علامتیں شامل کریں۔
8. ایسے سوالات پوچھیں جو بچے کو اپنے جوابات کی زیادہ تفصیل سے وضاحت کرنے کی ترغیب دیں۔
9. تصورات کی زیادہ تفصیل سے وضاحت کریں۔
10. بچے کی کسی بھی زبانی پیداوار پر مثبت رد عمل دیں۔
11. بچے کی مدد کے لیے ایک «ساتھی» (buddy) فراہم کریں جب وہ الجھن میں ہو۔
12. بچے کو دکھائیں کہ مدد اور/یا وضاحت کیسے مانگنی ہے۔
13. وضاحتی زبان کے استعمال پر چھوٹی مشقیں (mini lessons) فراہم کریں۔

14. ایسے سوالات پوچھیں جو بچے کو نئی اور پہلے سکھائی گئی معلومات کے درمیان تعلق بنانے کی ترغیب دیں۔

15. بچے کو ان کہانیوں اور وضاحتی نصوص کے معنوی نقشے (semantic maps) بنانا سکھائیں جو وہ پڑھتا ہے۔

16. ہدایات دیتے یا تصورات کی وضاحت کرتے وقت تصویریں اور اشیا استعمال کریں۔

4.1.3.3 مداخلتی اصول

Gillam اور van Kleeck (1996) تجویز کرتے ہیں کہ مداخلت بنیادی طور پر عملی طور پر متعلقہ صورتحوالوں میں زبان کے سماجی-تعالی اور تعلیمی استعمالوں پر مرکوز ہونی چاہیے۔ بہت سی مداخلتی سرگرمیاں یادداشت اور زبان دونوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نئے اساتذہ کو سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور انعقاد کرتے وقت درج ذیل زبان کی مداخلت کے اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔

توجہ کو فروغ دیں

مختلف قسم کے لسانی عوارض والے افراد توجہ میں دشواریاں ظاہر کرتے ہیں۔ سیکھنے والے معلومات کو زیادہ تیزی سے پروسیس کرتے ہیں جب انہوں نے طویل مدتی یادداشت میں متعلقہ معلومات کو فعال کر لیا ہو۔ دوم، زبان کا سیکھنا اس وقت بہتر ہوتا ہے جب سیکھنے والے انتخابی طور پر سب سے اہم معلومات پر توجہ دیں۔ اساتذہ نوعمروں میں تیاری کی توجہ کو یہ وضاحت کر کے درمیانی کر سکتے ہیں کہ وہ کس پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ کیوں اہم ہے۔ اساتذہ مداخلتی نمونوں کو حتی الامکان واضح بنا کر اور خلل کو محدود کر کے انتخابی توجہ کو درمیانی کر سکتے ہیں۔

واضح اور آہستہ بولیں

تقریر کا ادراک اور علمی پروسیسنگ کی رفتار زبان سیکھنے میں حصہ ڈالتی ہے۔ نشوونما لسانی عوارض والے کچھ بچوں کو تیزی سے پیدا کی گئی تقریر کو سمجھنے اور سمجھنے میں دشواریاں ہوتی ہیں۔ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ جب اساتذہ اپنی تقریر کی رفتار کم کرتے ہیں، تو وہ سیکھنے والوں کو پروسیسنگ، انکوڈنگ، ذخیرہ اور بازیابی کے لیے زیادہ وقت فراہم کرتے ہیں۔

سیکھنے والے سے واقف موضوعات یا تصورات کے گردشگر میوں کی منصوبہ بندی کریں

زیادہ پیشگی علم سیکھنے والوں کو نئی معلومات پر زیادہ توجہ سے دھیان دینے کے قابل بناتا ہے، جو بہتر زبان سیکھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ جو اساتذہ زبان کی نئی صورتیں یا نئے مواصلاتی افعال سکھانا چاہتے ہیں، انہیں سیکھنے والے کے پیشگی علم کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔

سیکھنے والوں کو نیا علم منظم کرنے میں مدد دیں

سیکھنے والے اس وقت کہیں زیادہ معلومات یاد رکھ سکتے ہیں جب انہوں نے اپنے علم کو معنوی طور پر منظم کیا ہو۔ مثال کے طور پر، لوگ 20 بے ترتیب پیش کیے گئے حروف یاد رکھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن وہ آسانی سے 60 یا 80 حروف یاد رکھ سکتے ہیں جب حروف ان الفاظ کا حصہ ہوں جو جملے بناتے ہیں۔ اسی منطق کی پیروی کرتے ہوئے، سیکھنے والوں کو نیا علم ان طریقوں سے منظم کرنے میں مدد دینا سمجھ میں آتا ہے جو یاد رکھنے میں سہولت دیں۔ وضاحتی نصوص سے جملوں اور پیراگرافوں کی دوبارہ لفظ بندی (paraphrasing) کی مشق ایلمینٹری جماعتوں میں سیکھنے والوں کو نئی معلومات کو منظم کرنے کے لیے اپنے پیشگی علم، الفاظ اور زبان کی ساختوں کو استعمال کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ نوعمروں کو سیکھنے کی حکمت عملیاں سکھائی جاسکتی ہیں جو انہیں اپنی نصابی کتابوں میں موجود معلومات کو منظم اور یاد رکھنے میں مدد دیتی ہیں (Gillam, 2007)۔

سیکھنے والوں کو برقرار رکھنے کے اشارے فراہم کریں

اساتذہ کو جو وہ پڑھا رہے ہیں اور سیکھنے والوں کے علم اور توقعات کے درمیان پل بنانے کی ضرورت ہے۔ سیکھنے والے معالج کے سوالات، خلاصوں، ڈرائنگز اور تصویروں کو یاد رکھنے کے اشاروں کے طور پر اندرونی بنا سکتے ہیں۔ معالجین، والدین یا اساتذہ کے فراہم کردہ یاد رکھنے کے اشارے طاقتور ہو سکتے ہیں۔ جو بچے زبان کی مداخلتی سرگرمیوں کے دوران برقرار رکھنے کے اشارے حاصل کرتے ہیں، وہ ان بچوں سے زیادہ سیکھتے ہیں جو اضافی اشارے حاصل نہیں کرتے۔

تجویز کردہ مطالعات

Gillam, R. B., McFadden, T., & van Kleeck, A. (1995). Improving the narrative abilities of children with language disorders: Whole language and language skills approaches. In M. Fey, J. Windsor, & J. Reichle (Eds.), Communication intervention for school-age children (pp. 145–182). Baltimore, MD: Brookes

-Van Kleeck, A., Gillam, R., & McFadden, T. U. (1998). A study of classroom based phonological awareness training for preschoolers with speech and/or language disorders. American Journal of Speech-Language Pathology, 7, 66.
77.

4.2 قسم 6: مخصوص سیکھنے کی معذوریوں (Specific Learning Disabilities)

سیکھنے کی معذوریوں والے لوگ عموماً اوسط یا اوسط سے زیادہ ذہانت کے ہوتے ہیں، اور ایک یا دو شعبوں میں جدوجہد کرتے ہیں جہاں انہیں علاجی تعلیمی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکھنے کی معذوریوں، تعریف کے مطابق، کا مطلب ہے کہ کسی خاص شعبے (پڑھنا، ریاضی، بصری/سماعی پروسیسنگ وغیرہ) میں کسی شخص کی مہارتیں اس شخص کی مجموعی آئی کیو (IQ) کو دیکھ کر توقع سے کم ہیں۔

Kass اور Maddux (2005) نے سیکھنے کی معذوری کی تعریف یوں کی: سیکھنے کی معذوری (ڈس سمبولیا) پڑھنے، لکھنے، حساب کرنے، سننے، استدلال کرنے، بات کرنے یا سماجی مہارتوں میں علامتوں کے حصول اور استعمال میں انتہائی انحراف سے نمایاں ہوتی ہے؛ یہ انحراف نشوونمائی افعال میں نمایاں خرابیوں اور ماحولیاتی حالات کے درمیان تعامل کی وجہ سے ہے جو فرد کو ان خرابیوں کے لیے کمزور بناتے ہیں۔ اگر علامتوں سے نمٹنے میں انتہائی انحراف نازک عمری حد کے اندر نوٹ کیا جائے تو نشوونمائی علاجی تدریس کافی ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا انحراف نازک عمری حد کے اندر درست نہ کیا جائے تو خصوصی علاج کے طریقے درکار ہیں۔

سیکھنے کی معذوری (LD) ایک مستقل حالت ہے جو اس طریقے کو متاثر کرتی ہے جس سے کم از کم اوسط ذہانت والے افراد معلومات حاصل کرتے، برقرار رکھتے اور اظہار کرتے ہیں۔ پڑھنے کی سمجھ، املا، تحریری اظہار، ریاضی کے حساب اور مسئلہ حل کرنے میں خسارے عموماً ظاہر ہوتے ہیں۔ کم عام تنظیم کی مہارتوں، وقت کے انتظام اور سماجی مہارتوں میں مسائل ہیں۔ سیکھنے کی معذوری غیر مستقل ہوتی ہے اور کسی ایک مخصوص تعلیمی شعبے، جیسے غیر ملکی زبان، میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ یا پوس کن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک نظر نہ آنے والی یا پوشیدہ معذوری ہے۔ اس طرح ایک نمایاں سیکھنے کی معذوری اس وقت موجود ہوتی ہے جب کسی دی گئی صلاحیت میں فرد کی اصل کارکردگی یا کامیابی اس کی اصل صلاحیت یا استعداد سے کہیں کم پائی جائے۔

جب بچے کو سیکھنے کی معذوری ہو تو وہ درج ذیل خصوصیات ظاہر کر سکتا ہے:

- حروفِ تہجی، قافیہ والے الفاظ سیکھنے، یا حروف کو ان کی آوازوں سے ملانے میں دشواری ہونا
- بلند آواز میں پڑھتے وقت بہت سی غلطیاں کرنا، اور اکثر دہرانا اور رکنا
- جو کچھ وہ پڑھتا ہے اسے نہ سمجھنا
- املا میں واقعی دشواری ہونا
- بہت گندی لکھائی ہونا یا پنسل عجیب طرح سے پکڑنا
- لکھنے میں خیالات کے اظہار کے لیے جدوجہد کرنا
- دیر سے زبان سیکھنا اور محدود الفاظ ہونا
- ان آوازوں کو یاد رکھنے میں دشواری ہونا جو حروف بناتے ہیں، یا الفاظ کے درمیان معمولی فرق سننے میں
- لطیفوں، مزاحیہ سٹرپس اور طنز کو سمجھنے میں دشواری ہونا
- ہدایات پر عمل کرنے میں دشواری ہونا
- الفاظ غلط ادا کرنا یا ایسا غلط لفظ استعمال کرنا جو ملتا جلتا لگے
- جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے اسے منظم کرنے میں دشواری ہونا یا لکھنے یا گفتگو کے لیے درکار لفظ نہ سوچ سکرنا
- گفتگو کے سماجی اصولوں پر عمل نہ کرنا، جیسے باری لینا، اور سامع کے بہت قریب کھڑا ہونا
- ریاضی کی علامتوں کو الجھانا اور اعداد غلط پڑھنا
- کہانی کو ترتیب سے دہرانے کے قابل نہ ہونا (پہلے، پھر، اس کے بعد کیا ہوا)
- یہ نہ جانتا کہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے یا وہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے
- سیکھنے کے مسائل بیان کرتے وقت، تعلیم، کمیونٹی اور حکومتی شعبے دو فریم ورک سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے میں دشواریوں کا فریم ورک اور سیکھنے کی معذوری کا فریم ورک ہیں۔

سیکھنے میں دشواریوں کا فریم ورک

سیکھنے میں دشواری (learning difficulty) ایک غیر زمرہ بند تعریف ہے، جس میں وہ سب شامل ہیں جنہیں ایک یا زیادہ بنیادی تعلیمی مہارتیں سیکھنے میں دشواریاں ہیں۔ سیکھنے میں دشواریوں کو گہری تعلیمی مداخلت کے لیے جوابدہ سمجھا جاتا ہے۔ موثر تعلیمی مداخلت بنیادی تعلیمی مہارتوں جیسے پڑھنا اور لکھنا میں بہتری لانے کی، اور فرد کی تعلیمی کامیابی کی سطحوں میں بہتری کا نتیجہ دے گی۔ سیکھنے میں دشواریوں کو معذوری

کے امتیازی سلوک کے قانون (Disability Discrimination Act) اور ریاستی معذوری کے قانون کے تحت معذوریوں کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جسمانی، جذباتی یا ماحولیاتی اسباب سے پیدا ہونے والی سیکھنے میں دشواریاں قانون کے تحت شامل نہیں ہیں کیونکہ انہیں بنیادی عوارض یا خرابیاں نہیں سمجھا جاتا (Puplick, 1995)۔

سیکھنے کی معذوری کا فریم ورک

سیکھنے کی معذوری (learning disability) تشخیص پر مبنی ایک زمرہ بند تعریف ہے۔ نیشنل ہیلتھ اینڈ میڈیکل ریسرچ کونسل کا اندازہ ہے کہ آبادی کے 2 سے 4 فیصد کو سیکھنے کی معذوریاں ہیں۔ سیکھنے کی معذوریاں زندگی بھر رہنے والی اور وسیع ہوتی ہیں، اور گہری تعلیمی مداخلت کا آسانی سے جواب نہیں دیتیں۔ گہری تعلیمی مداخلت اکیلے سیکھنے میں دشواریوں والے افراد کی مدد کرے گی، لیکن سیکھنے کی معذوریوں والے افراد کے لیے کم سے کم نتائج دے گی۔ تعلیمی ایڈجسٹمنٹس اور سہولتیں (accommodations)، اور انفرادی سیکھنے کی حکمت عملیاں ضروری ہیں تاکہ سیکھنے کی معذوریوں والے افراد اپنی صلاحیت کی سطح پر کامیابی حاصل کر سکیں۔

ذہنی معذوری

ذہنی معذوری (intellectual disability) ایک معذوری ہے جو ذہنی فعل (استدلال، سیکھنا، مسئلہ حل کرنا) اور انطباقی رویے دونوں میں نمایاں حدود سے نمایاں ہوتی ہے، جو روزمرہ کے سماجی اور عملی مہارتوں کی ایک حد کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ معذوری 18 سال کی عمر سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ ذہنی معذوری یا عمومی سیکھنے کی معذوری، جسے ذہنی پسماندگی (mental retardation) بھی کہا جاتا ہے، ایک عمومی اعصابی نشوونما کی عارضہ ہے جو نمایاں طور پر خراب ذہنی اور انطباقی فعل سے نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی تعریف 70 سے کم آئی کیو اسکور کے ساتھ ساتھ دو یا زیادہ انطباقی رویوں میں خساروں سے کی جاتی ہے جو روزمرہ کی عمومی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔

4.2.1 سیکھنے کی معذوریوں کی اقسام

ایک عمومی سیکھنے کی معذوری سرحدی ہلکی (borderline mild)، ہلکی (mild)، معتدل (moderate)، سے شدید/گہری (severe/profound) تک ہو سکتی ہے۔ عمومی سیکھنے کی معذوریوں والے بچوں کو اسی عمر کے دیگر بچوں کی نسبت سیکھنے، سمجھنے اور کام کرنے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی بھر سیکھنا اور ترقی کرنا جاری رکھ سکتے ہیں لیکن دیگر بچوں کی نسبت سست رفتار سے۔ سرحدی ہلکی یا ہلکی عمومی

سیکھنے کی معذوری والے بچے کی سیکھنے کی صلاحیتیں اور ضروریات معتدل یا شدید/گہری سیکھنے کی معذوری والے بچے سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔

ہلکی عمومی سیکھنے کی معذوریوں والے بچے دیگر بچوں کی نسبت سست رفتار سے پختہ ہوتے ہیں اور بعض مہارتیں تیار کرتے ہیں۔ انہیں تقریر اور زبان، تصورات تیار کرنے میں دشواریاں ہو سکتی ہیں، اور بعد میں پڑھنے، لکھنے، حساب اور سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ انہیں اسکول کی زندگی کے مطابق ڈھلنے میں دشواری ہو سکتی ہے اور وہ نامناسب یا جسے ناپختہ رویہ سمجھا جا سکتا ہے، کے آثار دکھا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی جماعت کا استاد وہ پہلا شخص ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کو نوٹ کرے۔

معتدل عمومی سیکھنے کی معذوریوں والے بچے نشوونمائی سنگ میل، جیسے چلنا، بولنا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ تک پہنچنے میں نمایاں تاخیر دکھاتے ہیں۔ ان کی سیکھنے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسکول کے نصاب کو ڈھالنے کی ضرورت ہوگی۔

شدید/گہری عمومی سیکھنے کی معذوریوں والے بچے نشوونمائی سنگ میل تک پہنچنے میں بہت نمایاں تاخیر دکھاتے ہیں۔ اپنے اور اپنے گرد کی دنیا کے بارے میں ان کی بنیادی آگہی اور سمجھ ان کی معذوری کی سطح سے محدود ہوتی ہے۔ اس سطح کی مشکل والے بچے اپنی بنیادی ضروریات جیسے نقل و حرکت، رابطہ، کھانا کھلانے اور بیت الخلا میں اپنی زندگی بھر دوسروں پر انحصار کر سکتے ہیں۔

اضافی معذوریاں

عمومی سیکھنے کی معذوریوں والے بچوں کو کبھی کبھی اضافی معذوریاں یا حالات (متعدد معذوریاں) بھی ہو سکتے ہیں جیسے آٹزم اسپیکٹرم عوارض (autism spectrum disorders)، طبی حالات، جسمانی اور/یا حسی معذوریاں اور جذباتی/رویے کی مشکلات۔

تشخیص شدہ سنڈرومز

تشخیص شدہ سنڈروم والے بچوں کو بھی عمومی سیکھنے کی معذوری ہو سکتی ہے۔ سنڈرومز کی ایک وسیع حد جن سے وابستہ سیکھنے کی معذوریاں ہو سکتی ہیں، ان میں شامل ہیں: ڈاؤن سنڈروم (Down syndrome)، فریجائل ایکس سنڈروم (Fragile X syndrome)، پراڈر-ولی سنڈروم (Prader-Willi syndrome)، ریٹ سنڈروم (Rett syndrome)، ٹرنر سنڈروم (Turner syndrome) اور ولیمز سنڈروم (Williams syndrome)۔

4.2.1.1 سیکھنے کی معذوریوں کی عام اقسام

ڈسلیکسیا (Dyslexia) - پڑھنے میں دشواری

• پڑھنے، لکھنے، املا، بولنے میں مسائل

ڈس کیلکولیا (Dyscalculia) - ریاضی میں دشواری

• ریاضی کے مسائل کرنے، وقت سمجھنے، پیسے استعمال کرنے میں مسائل

ڈس گرافیا (Dysgraphia) - لکھنے میں دشواری

• لکھائی، املا، خیالات کو منظم کرنے میں مسائل

ڈس پرائکسیا (Dyspraxia) (حسی انضمام کا عارضہ) - باریک حرکی مہارتوں میں دشواری

• آنکھ اور ہاتھ کی ہم آہنگی، توازن، ہاتھ کی مہارت میں مسائل

ڈس فیزیا / افیزیا (Dysphasia/Aphasia) - زبان میں دشواری

• بولی گئی زبان کو سمجھنے میں مسائل، پڑھنے کی کمزور سمجھ

سماعی پروسیسنگ کا عارضہ - آوازوں کے درمیان فرق سننے میں دشواری

• پڑھنے، سمجھنے، زبان میں مسائل

بصری پروسیسنگ کا عارضہ - بصری معلومات کی تشریح میں دشواری

• پڑھنے، ریاضی، نقشوں، چارٹوں، علامتوں، تصویروں میں مسائل

توجہ کا خسارہ عارضہ (ADD)/توجہ کا خسارہ اور زیادہ فعالیت کا عارضہ (ADHD) سختی سے سیکھنے کی معذوریاں نہیں ہیں، لیکن اکثر سیکھنے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، خاص طور پر کلاس روم کی صورتحال میں۔ ADD/ADHD والے بچے بے توجہ، زیادہ فعال اور جذباتی ہو سکتے ہیں یا توجہ دینے اور اپنے رویے پر قابو پانے میں دشواری رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ LD نہیں ہے، دونوں عوارض کو عموماً بچے کی توجہ مرکوز کرنے، پرسکون رہنے اور چوکنا رہنے میں مدد کے لیے اضافی سیکھنے کی مدد اور متبادل تدریسی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

4.2.2 اسباب، تشخیص اور جائزے کی تکنیکیں

الف - اسباب

سیکھنے کی معذوریوں کے اسباب اچھی طرح سمجھے نہیں جاتے، اور کبھی کبھی سیکھنے کی معذوری کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا۔ تاہم، اعصابی خرابیوں کے کچھ اسباب میں شامل ہیں:

وراثت اور جینیات

سیکھنے کی معذوریاں اکثر خاندان میں چلتی ہیں۔ سیکھنے کی معذوریوں والے بچوں کے والدین یا دیگر رشتہ داروں کو بھی اسی طرح کی مشکلات ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ کچھ بچوں میں خود بخود تغیرات (یعنی کسی بھی والدین میں موجود نہیں) ہوتے ہیں جو نشوونما کی عوارض کا سبب بن سکتے ہیں جن میں سیکھنے کی معذوریاں شامل ہیں۔ ایک مطالعے کا اندازہ تھا کہ تقریباً 300 میں سے ایک بچے میں ایسے خود بخود تغیرات تھے، مثلاً CDK13 جین میں خرابی جو متاثرہ بچوں میں سیکھنے اور رابطے کی مشکلات سے وابستہ ہے۔

حمل اور پیدائش کے دوران مسائل

سیکھنے کی معذوریاں نشوونما پاتے دماغ میں بے قاعدگیوں، بیماری یا چوٹ، حمل کے دوران الکحل یا نشیات کے سامنے آنے، کم پیدائشی وزن، آکسیجن کی کمی، یا وقت سے پہلے یا طویل زچگی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔

پیدائش کے بعد حادثات

سیکھنے کی معذوریاں سر کی چوٹوں، غذائیت کی کمی، یا زہریلے سامنے آنے (جیسے بھاری دھاتیں یا کیڑے مار ادویات) کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔

مختصراً، سیکھنے کی معذوری والدین کے عوامل، پیدائشی صدمے، نشوونما کی بے قاعدگیوں، ماحولیاتی محرومی، نفسیاتی یا بوسی اور ناکامی کے تجربات اور ناکافی تدریس کا نتیجہ ہو سکتی ہے، چند نام لینے کے لیے۔

LDs کسی بھی عمر میں دریافت ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً تین سے تیرہ سال کی عمر کے درمیان تشخیص کی جاتی ہیں۔ علامات مختلف ہوتی ہیں اور بچے کی عمر پر منحصر ہوتی ہیں۔ ابتدائی بچپن میں، بچوں کو الفاظ ادا کرنے اور قافیہ بنانے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پانچ سے نو سال کی عمر کے درمیان، انہیں املا، وقت بتانے اور تسلسل یاد رکھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ابتدائی نو عمر سالوں میں ان کی مشکلات پڑھنے کی سمجھ، لکھائی یا تنظیم کی مہارتوں میں ہو سکتی ہیں۔

ب۔ تشخیص اور جائزہ

سیکھنے کی معذوری کی شناخت کے لیے چار معیار استعمال کیے جاتے ہیں: (1) فرد کو معمول کی کامیابی کی استعداد دکھانی چاہیے، (2) فرد کو عمر اور جماعت کے لیے نمایاں طور پر کم کامیابی دکھانی چاہیے، (3) فرد کو سیکھنے کی معذوری سے عموماً وابستہ رویے کی خصوصیات دکھانی چاہئیں، اور (4) فرد کو عمر سے متعلق مراحل کے اندر سیکھنے کی معذوری کی نشاندہی کرنے والے جزوی خسارے دکھانے چاہئیں۔ فرد کو سیکھنے کی معذوری والا شناخت کرنے کے لیے چاروں معیار پورے ہونے چاہئیں۔

معیار I: معمول کی کامیابی کی توقع

عموماً، سیکھنے کی معذوریوں کی تعریفیں دیگر معذوریوں کے ساتھ ذہنی پسماندگی کو خارج کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ذہنی صلاحیت میں کوئی اوورلیپ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکن ایسوسی ایشن آن مینٹل ریٹارڈیشن نمایاں طور پر کم ذہنی فعل کی تعریف انفرادی طور پر دیے گئے ذہانت کے ٹیسٹ پر تقریباً 70 سے 75 آئی کیو کے طور پر کرتی ہے۔ اگرچہ معمول کی ذہانت کی حد 90 سے 100 آئی کیو کے درمیان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ معمول کی کامیابی کی توقع کے لیے کٹ۔ آف وہیں سے شروع ہونا چاہیے جہاں پسماندگی ختم ہوتی ہے۔ تقریباً، 75 آئی کیو۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر درست ہے، کیونکہ حاصل کردہ آئی کیو کی بہتری میں تدریس اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے (Kirk, 1958)۔ معمول کی کامیابی کی بہترین پیشگوئی انفرادی زبانی ذہانت کے ٹیسٹوں جیسے سٹینفورڈ بینے اسکیل اور ویکسلر اسکیل فار چلڈرن کے زبانی یا مکمل اسکیل اسکورز سے کی جاتی ہے۔

معیار II: کم کامیابی

اسی عمر اور جماعت کے دوسروں سے موازنہ کرنے پر، سیکھنے کی معذوریوں والے طلبہ نصاب کے کچھ پہلوؤں میں نمایاں طور پر پیچھے ہوتے ہیں۔ چونکہ معذوری علامتوں کے حصول اور استعمال میں ہے، تین آر (پڑھنا، لکھنا، حساب) سیکھنا عموماً خراب ہوتا ہے جب تک نازک دور کے دوران علاج شروع نہ کیا جائے۔ کم کامیابی کو معیاری یا معیار حوالہ جاتی ٹیسٹوں سے پایا جاسکتا ہے۔ سیکھنے کی معذوری عموماً اسکول کی کامیابی میں مشکلات کے ذریعے دریافت ہوتی ہے۔

معیار III: سیکھنے کی معذوریوں سے وابستہ رویے کی خصوصیات

ادب سیکھنے کی معذوریوں کی خصوصیات سے بھرا ہوا ہے جس میں والدین اور اساتذہ کے نوٹ کردہ رویے ہیں کہ کاموں پر توجہ مرکوز نہیں کرتے۔ سیکھنے کی معذوری کی کچھ واضح علامات استاد کو اشارہ کرتی ہیں کہ طالب علم کو جائزے کے لیے بھیجا جانا چاہیے۔ جب طالب علم مسلسل توجہ نہیں دیتا یا مسلسل بے توجہ

ہوتا ہے، تو استاد حیران ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے۔ جب یہ رویے کم کامیابی کے ساتھ ہوں، تو استاد کو تشخیصی درخواست شروع کرنی چاہیے۔ گھر، اسکول اور کمیونٹی میں واضح رویوں کے بارے میں سوالات کے جوابات کا ایک مجموعہ بہترین طور پر معمولی رویے کی خصوصیات کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر ہر حد میں تین یا چار سوالات کے جوابات اثبات میں ہوں، تو استاد کو سیکھنے کی معذوریوں کا شبہ کرنا چاہیے۔ ہر مرحلے کے لیے سوالات کا ایک مجموعہ ذیل میں ہے۔

حسی واقفیت (پیدائش سے 17 ماہ تک)۔ ماحول کا جواب دینے کی تیاری (کام کی ضرورت۔ توجہ دینا)

1. کیا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا؟
2. کیا بچے کو چار ماہ تک حرکت کرتے ہدف پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے؟
3. کیا بچہ تحریک کے لیے ضرورت سے زیادہ حساس معلوم ہوتا ہے؟
4. کیا بچے کو وقتاً فوقتاً کان کے انفیکشن ہوتے ہیں (جن کے نتیجے میں اکثر عارضی سماعت کا نقصان ہوتا ہے)؟
5. کیا بچہ توجہ کے لیے ضرورت سے زیادہ مطالبے کرتا ہے؟
6. کیا بچہ ماحول اور شیڈول کی باقاعدگی پر اصرار کرتا ہے (سختی یا تکرار)؟
7. کیا بچے کو تحریکات پر توجہ دینے میں دشواری ہوتی ہے؟

یادداشت (18 ماہ سے سات سال تک)۔ ماحول کی رٹہ نقل (کام کی ضرورت۔ لیبل لگانا)

1. کیا بچے کی ادائیگی خراب ہے یا وہ جارگن استعمال کرتا ہے؟
2. کیا بچے کو ایک یا زیادہ حسی چینلوں کے ذریعے توجہ دینے میں دشواری ہوتی ہے؟
3. کیا بچے کو مسلسل بالغ کی نگرانی یا ضرورت سے زیادہ نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے؟
4. کیا بچے کو معقول وقت تک ساکت بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے؟
5. کیا بچہ ناپختہ معلوم ہوتا ہے؟
6. کیا بچے کی کھیل کے میدان میں یا لکھنا سیکھتے وقت جھٹکے والی، غیر مربوط حرکتیں ہوتی ہیں؟
7. کیا بچے کو تین سال کی عمر تک نرسری کی نظمیں، گانے، کہانیاں اور سادہ جملے دہرانے میں دشواری ہوتی ہے؟

8. کیا بچہ کسی ایسی حالت کا علاج کروا رہا ہے جس کے لیے دوا یا خصوصی خوراک کی ضرورت ہو؟
9. کیا بچہ اجینیوں کے ساتھ مناسب احتیاط کی کمی دکھاتا ہے؛ یعنی بہت ڈرنے والا، بہت دوستانہ، بہت جوڑ توڑ کرنے والا؟
10. کیا بچے کو پانچ سال کی عمر تک ہدایات دہرانے میں دشواری ہوتی ہے؟
11. کیا بچے کو اسکول میں مناسب طریقوں سے برتاؤ کرنے کے استاد کی ہدایات کا جواب دینے میں دشواری ہوتی ہے؟
12. کیا بچے کو اس کے قریبی بالغوں کی مثال پر چلنے میں دشواری ہوتی ہے؟
13. کیا بچے کو والدین یا استاد کو کہانیاں پڑھتے سننے کے لیے ساکت بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے؟
14. کیا بچے کو حروف اور اعداد کے نام یاد رکھنے میں دشواری ہوتی ہے؟
15. کیا بچہ انفرادی علامتوں کو چھاپنے اور باتیں سے دائیں بڑھنے میں مسلسل الجھن ظاہر کرتا ہے؟
16. کیا بچے کو سادہ حسابی مرکبات یاد رکھنے میں دشواری ہوتی ہے؟

دوبارہ شناخت (آٹھ سے 11 سال تک)۔ معنوی اور ساختی معانی کی سمجھ (کام کی ضرورت۔ سمجھنا)

1. کیا بچے کو اب بھی توجہ دینے میں دشواری ہوتی ہے؟
2. کیا بچے کو یہ وضاحت کرنے میں دشواری ہوتی ہے کہ چیزیں کیسے ایک جیسی اور مختلف ہیں؟
3. کیا بچے کو ملتے جلتے نظر آنے والے الفاظ میں سے ایک خاص لفظ منتخب کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟
4. کیا بچے کو پڑھنے میں فونکس استعمال کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟
5. کیا بچہ نظم و ضبط کا مسئلہ ہے؟
6. کیا بچے کو آزادانہ طور پر کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟
7. کیا بچہ پڑھتے وقت الفاظ کا اندازہ لگاتا ہے؟
8. کیا بچے کو حسابی عمل مناسب طور پر استعمال کرنے میں دشواری ہوتی ہے (علامتوں، عددی تعلقات اور کہانی کے مسائل کو سمجھنا)؟
9. کیا بچے کو املا میں دشواری ہوتی ہے؟

10. کیا بچے کو کرسو لکھائی سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے (خاص طور پر ان اسٹروکس میں جہاں سمت الٹنی ہوتی ہے جیسے «p»، «a»، «c» وغیرہ)؟

11. کیا بچے کو زمانوں، سابقوں، لاحقوں اور سیلبلز کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے؟

12. کیا بچے کو دس سال کی عمر تک تحریری ہدایات پر عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟

13. کیا بچے کو دوست بنانے رکھنے میں دشواری ہوتی ہے؟

ترکیب (12 سے 13 سال تک)۔ ماحول کے لیے پہلے سیکھے گئے رد عمل کی خودکاری (کام کی ضرورت۔ یکجا کرنا)

1. کیا نوجوان کی زبانی اور تحریری مواد کا جواب دینے کی عادتیں خراب ہیں (یعنی کوئی جواب نہیں، ضرورت سے زیادہ غلطیاں، یا نامناسب جوابات)؟

2. کیا نوجوان غلطیوں سے بے خبر معلوم ہوتا ہے؟

3. کیا نوجوان کو غلطیاں درست کرنے میں دشواری ہوتی ہے جب ان کی نشاندہی کی جائے؟

4. کیا نوجوان کو وقت کی حد کے اندر کام مکمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟

5. کیا نوجوان کو املا سے لکھنے میں دشواری ہوتی ہے (حرکی تناؤ ظاہر کرنا)؟

6. کیا نوجوان کو دیے گئے کام کو مکمل کرنے کے لیے درکار وقت اور تسلسل کو منظم اور اندازہ لگانے میں دشواری ہوتی ہے؟

7. کیا نوجوان کو عموماً ساتھیوں سے تعلق قائم کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟

8. کیا نوجوان کو سماجی فیصلے میں غلطی کی تلافی کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟

9. کیا نوجوان کو دوسروں کے تئیں ذمہ داریاں نبھانے میں دشواری ہوتی ہے، چاہے زیادہ یا کم شمولیت کے معنی میں؟

رابطہ (14 سال اور اس سے زیادہ)۔ وہ عمل جس سے معنی وصول کیے جاتے ہیں اور دوسروں کو ظاہر کیے جاتے ہیں (کام کی ضرورت۔ اظہار کرنا)

1. کیا نوجوان کی رابطے کے اوزار (بولنا، لکھنا، اشارے اور پڑھنا) سیکھنے میں مسائل کی تاریخ رہی ہے؟

2. کیا نوجوان کو مواد کے معنی (خصوصی الفاظ) کی تشریح کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟

3. کیا نوجوان کو تمام اسکول کے مضامین میں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کی تشریح کی ذمہ داری لینے اور بتانے کے نتائج کے لیے دشواری ہوتی ہے؟
4. کیا نوجوان کو سماجی فیصلے کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟
5. کیا نوجوان چھپانے کی کوشش کرتا ہے یا معذوری کا سامنا کرنے سے انکار کرتا ہے؟
6. کیا نوجوان اکثر ان لوگوں کو مایوس کرتا ہے جو اس کی پرواہ کرتے ہیں؟
7. کیا نوجوان کو کسی خاص معاملے کے فوائد اور نقصانات پر بات کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟
8. کیا نوجوان اکثر منفی اثر کے سامنے جھک جاتا ہے؟
9. کیا نوجوان کو صورتحال کا جائزہ لینے میں دشواری ہوتی ہے، یعنی تفویض کردہ کام کرنے کے وقت کا اندازہ لگانا، اندازہ لگانا کہ مدد کی ضرورت ہے یا نہیں، مطالبات یا رد عمل میں غیر حقیقی ہونا، یا سماجی طور پر غیر حساس ہونا؟

معیار IV: پانچ نشوونمائی مراحل کے اندر جزوی خسارے

شکل 2: نشوونمائی مراحل اور سیکھنے کی معذوری کے نازک نقائص

شکل 2 میں دکھایا گیا انسان کا نشوونمائی نظریہ یہ فرض کرتا ہے کہ سیکھنے کی معذوریوں والوں میں عمر سے متعلق عام خسارے ہوتے ہیں۔ پانچ نشوونمائی مراحل یہ ہیں: (1) حسی واقفیت، پیدائش سے 17 ماہ تک، ماحول کا جواب دینے کے لیے انسان کی جسمانی یا فعلی تیاری ہے؛ (2) یادداشت، 18 ماہ سے سات سال تک، تحریکات کی نقل ہے جب وہ موجود نہ ہوں؛ (3) دوبارہ شناخت، آٹھ سے 11 سال تک، معنوی اور ساختی معانی کی اندرونی سازی اور ان میں لچک ہے؛ (4) ترکیب، 12 سے 13 سال تک، پہلے سیکھے گئے رد عمل کی عادت بنانا ہے؛ اور (5) رابطہ، 14 سال اور اس سے زیادہ، دوسرے کے معانی کی وصولی اور اپنے معانی کا دوسرے کو اظہار ہے۔

اگرچہ چار معیار (معمول کی کامیابی کی استعداد، کم کامیابی، رویے کی خصوصیات اور جزوی نشوونمائی خسارے) جائزے کا نظام بناتے ہیں، تمام نتائج کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ بدیہی، طبی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شناخت ہونے کے بعد، سیکھنے کی معذوریوں والے افراد کو علاج ملنا چاہیے۔

4.2.3 تدریس میں تطبیقات

تجرباتی تدریسی طریقہ بیان کرتے ہوئے، Cruickshank وغیرہ (1961) نے کہا کہ «ان بچوں کی پہلی ضرورت ایک سادہ، پرسکون ماحول ہے جہاں وہ آرام کر سکیں، اور سرگرمیوں کی ایسی ساخت جو اس طرح

ڈیزائن کی گئی ہو کہ وہ جان سکیں کہ ان سے کیا توقع ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے کی توقع کر سکتے ہیں۔ جن خرابیوں پر محققین نے توجہ مرکوز کی وہ تھیں: عضلاتی کنٹرول، آنکھ اور ہاتھ کی ہم آہنگی، صورت کا ادراک، شکل۔ پس منظر کے تعلقات، بائیں۔ دائیں بڑھنا، اور رویے کے رد عمل کا انضمام۔

خوش قسمتی سے ہر جدوجہد کے لیے بہت سی حکمت عملیاں ہیں جو مخصوص سیکھنے کی معذوری والے طالب علم کو ہو سکتی ہیں۔ ڈسلیکسیا جیسی چیزوں کے لیے بہت سی کتابیں اور یہاں تک کہ مکمل پروگرام موجود ہیں۔ پروسیسنگ کے عارضے والے طالب علم کے لیے نوٹس کی کاربن کاپیاں؛ بصری پروسیسنگ اور پڑھنے کی سمجھ میں جدوجہد کرنے والے طالب علم کے لیے ٹیپ پر کتابیں؛ ڈس گرافیا والے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کا استعمال وغیرہ۔ لیپ ٹاپ یا ورڈ پروسیسر کا استعمال معاون تکنالوجی کے آلے کی ایک عمدہ مثال ہے جو SLD والے طلبہ کو ان کی معذوری سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔

Rogan اور Lukens نے درج ذیل سفارشات پیش کی ہیں:

1. ابتدائی علمی نشوونما کے تمام پہلوؤں (ادراکی، بصری۔ حرکی، زبان، تصورات) کی فراہمی کرنے والے متوازن نصابوں کے ساتھ اچھے نشوونما کنڈرگارٹن۔ پرائمری پروگرام؛
2. کنڈرگارٹن کی سطح پر خصوصی نصابوں کے ساتھ لچکدار «پختگی» گروہ بندیوں کی بنیاد کے طور پر کنڈرگارٹن میں داخلے کے لیے تیاری کی جانچ کی توسیع؛
3. ان بچوں کے لیے عبوری یا توسیع شدہ تیاری کی جماعتیں جو پہلی جماعت کے لیے تیاری کی کمی ظاہر کرتے ہیں؛
4. غیر درجہ بندی لچکدار درجہ بندی پرائمری پروگرام جو بچے کو ایک سطح سے دوسری سطح پر اس کی ترقی یافتہ صلاحیت کے مطابق جانے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ عمری عمر کے بجائے تدریسی مطالبات سے نمٹ سکے؛ دوسری یا تیسری جماعت میں داخل ہونے والی عبوری جماعتیں اس اسکول کے لیے جزوی حل کے طور پر جو اپنی جماعت کی ساخت برقرار رکھتا ہے؛ عبوری جماعتوں میں مخصوص، غیر تکراری نصاب؛
5. ترجیحی سیکھنے کے طریقوں کے مطابق مہارتوں کی تدریس کے لیے جماعتوں کے اندر یا کئی جماعتوں کے اندر دوبارہ گروہ بندی، مثلاً پڑھنے میں بنیادی طور پر سماعتی زور (فونکس) یا بصری (ایک نظر میں لفظ پڑھنا) ان بچوں کے لیے جن کی ان شعبوں میں طاقتیں ہیں؛
6. بعد کی ایلیمینٹری جماعتوں میں (دوبارہ گروہ بندی کے ذریعے) ان بچوں کو بنیادی تعلیمی مہارتیں سکھانے کی فراہمی جو مختلف وجوہات (بیماری، غیر حاضری، ناپختگی، خاندانی نقل و حرکت) سے انہیں معمول کی عمر میں عبور نہیں کر سکے؛ دوسری اور تیسری جماعتوں سے آگے فونکس کی تدریس؛

7. سیکھنے کی معذوریوں والے بچوں کو انفرادی یا چھوٹے گروہ کی مدد کے لیے صلاحیتوں کی توسیع کے ذریعے موجودہ ماہرین کا استعمال؛ مثال کے طور پر، اصلاحی مطالعے کے معالجین (remedial reading therapists) اور تقریر کی اصلاح کے ماہرین کی تکنیکوں اور علم کی توسیع تاکہ معمولی دماغی خرابی والے بچوں کے ساتھ کام شامل ہو؛

8. خصوصی مہارتوں جیسے لائبریری حوالہ، مطالعے کے طریقے، مواد کی تنظیم کے لیے تعلیمی تجربہ گاہوں (learning laboratories) کی نشوونما، خاص طور پر اعلیٰ ایلیمنٹری اور ہائی اسکول کی سطحوں پر۔

مزید برآں سیکھنے میں دشواریوں کے طریقے کو بدلنے کے لیے درج ذیل تکنیکیں سختی اور تکرار (perseveration) کے نمونوں کو توڑنے میں مددگار پائی گئی ہیں:

1. عدد کے مرکبات جیسی چیزوں پر مشق معنوی خودکاری تیار کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اگر مختلف ڈرل تکنیکوں کے استعمال کے باوجود تکرار برقرار رہے، تو کچھ وقت کے لیے کوئی اور سرگرمی اختیار کرنا اور پھر بعد میں موضوع کی طرف لوٹنا بہتر ہے۔

2. کم توجہ کے دورانیے سے نمٹتے وقت مختصر تفویض کردہ کام دینا مددگار ہے۔ مثال کے طور پر: حسابی مسائل کی صرف اتنی تعداد جو بچہ سنبھال سکے اس کے کاغذ پر ڈالی جاتی ہے؛ اس طرح وہ پورا تفویض کردہ کام ختم کرنے کے قابل ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی توجہ کے دورانیے کی حد میں ہے۔

3. سیکھنے کے طریقے میں تمام حواس کا استعمال کریں۔ بچہ اپنے پورے جسم اور خود کو استعمال کر کے سیکھتا ہے۔

4. حرکی بے قابو پن (motor dis-inhibition) کو بچے کے فائدے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، سیکھنے کا ایسا مواد فراہم کر کے جس میں عضلاتی حرکت شامل ہو، جیسے اباکس اوپیگ بورڈز۔ (ص۔)

(148)

1.2.3.4 جائزے / تشخیص کے عمل کو ڈھالنا

سیکھنے کی معذوریوں (LDs) والا ہر طالب علم منفرد ہے، جیسے ان کی طاقتیں اور ضروریات ہیں؛ LDs کے تنوع کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ معلمین اپنے طلبہ کی خاص طاقتوں اور ضروریات کو جانیں تاکہ مناسب سہولتیں منتخب کر سکیں۔ یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ ہر طالب علم انہیں پیش کی گئی سہولتوں کا مختلف جواب دے گا۔

اسی طرح، ہر جائزہ مختلف ہے، اس لیے ایک تکنیک جو ایک تشخیص کے لیے موثر ہے وہ دوسرے کے لیے بہترین نہیں ہو سکتی۔ طالب علم کا IEP ان ماحولیاتی، تدریسی اور جائزے کی سہولتوں کی فہرست دے گا

جن تک طالب علم کو ہر وقت رسائی ہونی چاہیے۔ ایسا کہا جا رہا ہے، معلمین طالب علم کے IEP میں درج نہ ہونے والی دیگر سہولتی حکمت عملیاں نافذ کرنا چاہ سکتے ہیں؛ اگر یہ حکمت عملیاں موثر ثابت ہوں، تو انہیں بعد میں IEP میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ یہاں سہولتوں کی کچھ مثالیں ہیں جو جائزے کے دوران LDS والے طلبہ کی موثر مدد کر سکتی ہیں:

الف۔ پڑھنے میں دشواری والے طلبہ کے لیے

طالب علم ٹیکسٹ ٹو اسپچ تکنالوجی استعمال کر کے جائزے کے سوالات سن سکتا ہے۔ اگر طالب علم کو تکنالوجی تک رسائی نہ ہو تو کوئی سوالات بلند آواز میں پڑھ سکتا ہے۔

ب۔ لکھنے میں دشواری والے طلبہ کے لیے

طالب علم یہ کر سکتا ہے:

- کاتب (scribe) یا اسپچ ٹو ٹیکسٹ تکنالوجی تک رسائی حاصل کرنا؛
- اسپیل۔چیکر سافٹ ویئر استعمال کرنا؛
- املا میں مدد کے لیے، اور خیالات پیدا کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے لفظ کی پیشگوئی کا سافٹ ویئر استعمال کرنا؛
- قلم اور کاغذ کے علاوہ اپنی تعلیم ظاہر کرنے کا کوئی طریقہ استعمال کرنا؛
- ویڈیوز، ذہنی نقشے، مزاحیہ سٹرپس، برسٹل بورڈز، ماڈلز؛
- تشخیص زبانی طور پر مکمل کرنا، اور/یا
- تشخیص خالی جگہ پُر کریں طرز کے صفحے کے طور پر مکمل کرنا، تاکہ انہیں صرف وہ بنیادی معلومات شامل کرنی ہوں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

ج۔ اپنے خیالات اور وقت کو منظم کرنے میں دشواری والے طلبہ کے لیے

تشخیص کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں جو طالب علم متعدد مختلف جماعت کے ادوار میں مکمل کر سکے۔

- سوالات کو چھوٹے مراحل میں، اور درکار کام کے لیے منطقی ترتیب میں تقسیم کریں۔
- طلبہ کو اپنا وقت سنبھالنے میں مدد کے لیے الٹی گنتی کا ٹائمر استعمال کریں۔

د۔ یادداشت میں دشواری والے طلبہ کے لیے فراہم کریں:

- جائزے سے متعلق الفاظ کا ذخیرہ؛
- ریاضی کے جائزے سے متعلق فارمولوں کی فہرست؛
- ایک لغت (طلبہ کی طاقتوں کے لحاظ سے یا تو تصاویر کے ساتھ یا تحریری تعریفیں)، اور/یا
- حساب کے عمل (تقسیم، ضرب، زاویہ پیمما (protractor) استعمال کرنے کا طریقہ) کے لیے ایک حوالہ صفحہ۔

طلبہ کو آلات، جیسے ریاضی کے حساب کے لیے کیلکولیٹر تک رسائی کی اجازت دیں؛ طالب علم کو پھر بھی کاغذ پر اپنے جواب کی توجیہ کرنا ہوگی۔

مسئلہ حل کرنے کے لیے، طلبہ سے مسئلہ بلند آوازیں پڑھوائیں۔

ہم یہ کہہ کر نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ معلمین کی منتخب کردہ تکنیکوں سے LDs والے طلبہ کو تشخیص کے دوران اپنی تعلیم موثر طور پر ظاہر کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ تکنیکیں طلبہ کی طاقتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی کمزوریوں کے اثر کو کم سے کم کریں، تاکہ وہ اپنی سب سے بڑی استعداد حاصل کر سکیں۔

4.2.3.2 نصاب کے اندر علاجی تدریس

انفرادی تدریس کے تصور کا ایک خاص مفہوم ہے جب سیکھنے کی معذوریوں والے طلبہ کے انوکھے خساروں سے نمٹنے کی بات آتی ہے۔ معمول سے جتنے زیادہ انحراف ہوں، طریقوں اور مواد میں اتنی ہی زیادہ تطبیقات کرنی چاہئیں۔ سب سے پہلے یہ لازمی ہے کہ سیکھنے کی معذوریوں والے طلبہ کا استاد نشوونمائی نصاب کو جانے۔ یہ وہ معیار فراہم کرتا ہے جس کے خلاف علاجی تدریس کو پایا جاسکتا ہے۔ وہ روایتی علاج جن کے بارے میں سیکھنے کی معذوریوں والے طلبہ کے مستقبل کے اساتذہ نے سیکھا، فکر کے مختلف مکاتب کی عکاسی کرتے تھے، ہر ایک اپنی خاص واقفیت سے متعلق علاج پر بھاری زور کے ساتھ۔ ان مکاتب فکر کو یوں لیبل کیا جاسکتا ہے: طبی، عمل، رویائی، تعلیمی اور میٹا علمی طریقے۔ طبی اور طبی عمل کا طریقہ اس یونٹ کے دائرے سے باہر ہے۔ درج ذیل حصے دیگر تین طریقوں سے متعلق کچھ نمائندہ علاجوں کو مختصر آبیان کرتے ہیں۔

1- رویائی علاج کا طریقہ

رویائی علاجی تدریس کا طریقہ یہ فرض کرتا ہے کہ تدریس۔ سیکھنے کی صورتحال کا سب سے اہم پہلو اس صورتحال میں بچے کا اصل رویہ ہے۔ علاج براہ راست صورتحال کی شرائط کو اس طرح ترتیب دینے پر مرکوز ہے کہ بچے کا رویہ بدل جائے۔ رویے کی اصلاح، درست تدریس اور براہ راست تدریس رویائی اصولوں کے عملی اطلاق کی پیداوار ہیں۔

رویے کی اصلاح

رویے کی اصلاح (behavior modification) میں تقویت (reinforcement)، رد عمل کی ہیمنش اور اشارے کے اصول شامل ہیں، جس کے نتیجے میں مناسب رد عمل واقع ہوتے ہیں اور نامناسب رد عمل ختم ہو جاتے ہیں۔

درست تدریس

درست تدریس (precision teaching) کی زبان رویوں اور واقعات کی درست وضاحت پر زور دیتی ہے جو براہ راست قابل مشاہدہ اور قابل گنتی ہیں، اس طرح معنوی الجھن کو بہت کم کرتی ہے۔ درست تدریس کی زبان کی صورت استاد کی ان واقعات کی شناخت میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ماحول میں رویے کو متاثر کرنے کے سب سے زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ درست تدریس میں تین مراحل شامل ہیں: (1) پہلے کا مرحلہ: رویے اور اس کے ماحول کی نشاندہی، (2) دوران کا مرحلہ: مداخلت، اور (3) بعد کا مرحلہ: مداخلت کا خاتمہ۔

براہ راست تدریس

یہ طریقہ، رویے کی اصلاح اور درست تدریس کی طرح، انتہائی منظم تدریس، مناسب رد عمل کی تقویت، اور طالب علم کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ فرض کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، براہ راست تدریس کا تقاضا ہے کہ اساتذہ (1) واضح طور پر عمومی مسائل حل کرنے کی حکمت عملیاں سکھائیں، (2) چھوٹے گروہ کی تدریس فراہم کریں، (3) منظم طریقے سے غلطیاں درست کریں اور صحیح رد عمل کی تقویت کریں، (4) پہلے سیکھے گئے مواد کا مجموعی نظر ثانی فراہم کریں، اور (5) سیکھنے کے عمل کے ہر مرحلے میں مہارت پر اصرار کریں۔

2- تعلیمی علاج کا طریقہ:

تعلیمی طریقہ تعلیمی کاموں اور عملوں کے ساتھ ساتھ ان ماحولیاتی صورتحالوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو اسکول کی ناکامی کو جنم دیتی ہیں۔ علاجی طریقے اسکول کے مضامین کا براہ راست علاج کرتے ہیں اور اسکول کے

کام کے اندر غلطیوں کے تجزیے پر مبنی ہیں۔ چونکہ کم سے کم پابند ماحول ایک قانونی تقاضا ہے، نشوونمائی نصاب عموماً علاج کا انتخاب ہوتا ہے۔

موجودہ تعلیمی طریقے

سیکھنے کی معذوریوں میں موجودہ زیادہ تر نصابی کتابیں مداخلت کو تعلیمی مضامین کے مطابق منظم کرتی ہیں۔ پڑھنے کو عموماً سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے کیونکہ یہ سیکھنے کی معذوریوں میں خدمات کے لیے سب سے زیادہ عام طور پر بھیجا جانے والا معذوری معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، لکھنے، املا اور حساب میں تعلیمی مسائل نوٹ کیے جاتے ہیں۔

3۔ میٹا علمی علاج کا طریقہ

علاج کا ایک مقبول طریقہ میٹا علمی طریقہ ہے، جو عمل اور تعلیمی مداخلت کا مرکب ہے۔ میٹا علمی علاج کا تقاضا ہے کہ طالب علم اس عمل کے بارے میں سوچے جس سے وہ مضمون سیکھ سکتا ہے۔ طلبہ کو خود ہدایت (self-instruction) اور خود نگرانی (self-monitoring) کے ذریعے اپنی تعلیم کے بارے میں سوچنا سکھایا جاتا ہے۔ خود ہدایت سے مراد »خود زبانی ہدایات کا استعمال ہے جو کسی فرد کو مراحل کے ایک تسلسل سے گزارنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں جو مسئلے کے حل کا نتیجہ دیں گی«۔ خود نگرانی یہ جائزہ ہے کہ کسی نے کیا حاصل کیا ہے اور اس کارکردگی کی خود ریکارڈنگ۔

سیکھنے کی حکمت عملیوں کا مداخلتی نمونہ

یہ تصویری فریم ورک سیکھنے کی معذوریوں والے نوعمر کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ طلبہ کو مخصوص مواد کے بجائے سیکھنے کی تکنیکیں سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ طلبہ کو عمومی اور مخصوص دونوں سیکھنے کی حکمت عملیاں سکھائی جاتی ہیں۔ عمومی حکمت عملیاں »طالب علم کو مسئلے کی صورتحال کا جائزہ لینے، اس کی ضروریات کا تعین کرنے، اور اس کے حل کے لیے ایک مخصوص حکمت عملی منتخب کرنے کے قابل بناتی ہیں«۔ مخصوص حکمت عملیاں وہ ہیں جو مہارت کے شعبوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، طلبہ کو اپنے مقاصد طے کرنا اور ان کی نگرانی کرنا اور مہارتوں کو صورتحالوں میں عام کرنا سکھایا جاتا ہے۔

باہمی تدریس کا طریقہ کار

پڑھنے کی سمجھ کی تدریس کا ایک اور موجودہ مقبول طریقہ باہمی تدریس (reciprocal teaching) ہے جو »باہمی تعلیم کے گروہ میں« ہوئی اور نصوص کی سمجھ کے کام پر »سادہ ٹھوس حکمت عملیوں کو لاگو کرنے میں رہنمائی یافتہ مشق« کی خصوصیت رکھتی ہے۔ »ایک استاد اور طلبہ کا ایک گروہ باری باری اس نصوص کے

ایک حصے کے بارے میں بحث کی قیادت کرتے ہیں جسے وہ مشترکہ طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چار سرگرمیاں سمجھ کو فروغ دیتی ہیں: سوال پوچھنا، وضاحت کرنا، خلاصہ کرنا اور پیشگوئی کرنا۔ بحث کے رہنما کو سوال سے شروع کرنا چاہیے اور مواد کے خلاصے پر ختم کرنا چاہیے۔

4.3 خود احتسابی سوالات

1. ان اصطلاحات کے درمیان اہم فرق کیا ہے: فونیمز، سیلابلز اور مورفیمز؟
2. زبان کی صورت، زبان کے مواد اور زبان کے استعمال میں کون سے لسانی نظام شامل ہیں؟
3. آپ مواصلاتی عارضے اور مواصلاتی اختلاف میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟
4. آپ زبان کی تاخیر، نشوونما لسانی عارضے اور حاصل شدہ لسانی عارضے میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟
5. ہم یہ کیوں نہیں بتا سکتے کہ 3 سال اور 9 ماہ کی عمر میں بچے کی زبان کی صلاحیتیں کیا ہونی چاہئیں؟
6. کچھ ایسی آوازوں کی مثالیں کیا ہیں جو بچوں کے لیے کنڈرگارٹن میں داخل ہوتے وقت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟
7. تاخیر اور عارضے میں کیا فرق ہے؟
8. زبان کی تیاری اور سمجھ میں کیا فرق ہے؟
9. نشوونما کے چار اہم ادوار (بچپن، اسکول سے پہلے کے سال، اسکول کے سال اور بالغ عمر) میں سے ہر ایک کے دوران زبان کے ہر شعبے (مواد، صورت اور استعمال) میں ہونے والی ایک اہم نشوونما کا نام بتائیں۔
10. بچوں میں کچھ عام تقریری عوارض کیا ہیں؟
11. سیکھنے میں دشواری اور سیکھنے کی معذوری میں کیا فرق ہے؟
12. سیکھنے کی معذوری، لسانی عارضے اور ڈسلیکسیا میں کیا فرق ہے؟
13. سیکھنے کی معذوری کی تعریف کریں۔ سیکھنے کی معذوری والے بچے کون سی خصوصیات ظاہر کر سکتے ہیں؟
14. بچوں میں عام طور پر پائی جانے والی سیکھنے کی معذوریوں کی مختلف اقسام کیا ہیں؟
15. سیکھنے کی معذوریوں کے مختلف ممکنہ اسباب بیان کریں۔
16. کسی بھی سیکھنے کی معذوری کے لیے بچوں کی تشخیص اور جائزہ کرتے وقت کون سے معیار دیکھے جاتے ہیں؟

17. نصاب کے اندر علاجی تدریس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
18. سیکھنے کی معذوریوں والے بچوں کے لیے تدریس اور تشخیص کے عمل کو ڈھالنے کے لیے کون سے مختلف طریقے دستیاب ہیں؟

4.4 حوالہ جات

- Aram, D. M., & Hall, N. E. (1989). Longitudinal Follow-up of Children with Preschool Communication Disorders: Treatment Implications. School Psychology Review, 18(4), 487–501.
- .Carrow-Woolfolk, E. (2004). Comprehensive assessment of spoken language .Circle Pines, MN: American Guidance Service
- .Catts, H. W., & Kamhi, A. G. (1999). Language and reading disabilities .Needham Heights, MA: Allyn & Bacon
- Catts, H. W., Adlof, S. M., & Weismer, W. E. (2006). Language deficits in poor comprehenders: A case for the simple view of reading. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49, 278–293
- Falk-Ross, F. (2002). Classroom-based language and literacy intervention: A programs and case studies approach. Boston: Allyn & Bacon
- Gillam, R. B. (1995). Whole language principles at work in language intervention. In D. Tibbits (Ed.), Language intervention: Beyond the primary grades (pp. 219–256). Austin, TX: Pro-Ed
- Gillam, R. B., & Carlile, R. M. (1997). Oral reading and story retelling of students with specific language impairment. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 28, 30–42
- Gillam, R. B., & Johnston, J. R. (1992). Spoken and written language relationships in language/ learning-impaired and normally achieving

–school-age children. *Journal of Speech and Hearing Research*, 35(6), 1303–1315.

Gillam, S. L. (2007). Understanding and remediating text comprehension deficits in school-age children. In A. Kamhi, J. Masterson, & K. Apel (Eds.) *Clinical decision making in developmental language disorders* (pp. 267–284). Baltimore, MD: Brookes

Gillam, S. L., & St. Clair, K. (2007). Comprehension of expository text: Insights gained from think aloud data. Manuscript in preparation

Gillon, G. (2005). The efficacy of phonological awareness intervention for children with spoken language impairment. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 31, 126–141

Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading and reading disability. *Remedial and Special Education*, 7(1), 6–10

Halliday, M. A. K. (1975). *Learning how to mean*. London: Arnold

Jusczyk, P. W. (1997). *The discovery of spoken language*. Cambridge, MA: MIT Press

Lyon, R. (1995). Toward a definition of dyslexia. *Annals of Dyslexia*, 4, 3–30

Mayer, M. (1969). *Frog, where are you?* New York: Penguin Books

–Newcomer, P. L., & Hammill, D. D. (1997). *Test of Language Development – Primary* (3rd ed.). Austin, TX: Pro-Ed

Paul, R., Hernandez, R., Taylor, L., & Johnson, K. (1996). Narrative development in late talkers: Early school age. *Journal of Speech and Hearing Research*, 39, 1295–1303

Rescorla, L. (2002). Language and reading outcomes to age 9 in late-talking toddlers. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 45, 360–371

- Rescorla, L. (2005). Language and reading outcomes of late-talking toddlers at age 13. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 48, 1–14
- .Stothard, S. E., Snowling, M. J., Bishop, D. V. M., Chipchase, B. B., & Kaplan, C. A. (1998). Language- impaired preschoolers: A follow-up into adolescence .*Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 41, 407–418
- Waters, G., & Caplan, D. (2005). The relationship between age, processing ,speed, working memory capacity, and language comprehension. *Memory*, 13 .413–403

یونٹ 5: غیر معمولیات کی اقسام-IV

تعارف

عزیز طلبہ! اس یونٹ کا کام شروع کرتے ہوئے، میں آپ کو اس یونٹ کے مندرجات سے متعارف کرانا چاہتی ہوں۔ یہ یونٹ خاص ضروریات کی اس قسم پر مشتمل ہے جس کا تعلق ذہنی نشوونما سے ہے، عقل یا ادراک سے وابستہ وہ کمیاں جو اگر معیار کے مطابق نہ ہوں، ان کی شناخت کا عمل اور وہ مناسب موافقت یا سہولتیں جن کے لیے ایک استاد کو اپنی کلاس میں ایسے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ یونٹ ذہنی نشوونما کے پنڈولم کے دونوں انتہاؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک سرے پر وہ بچے ہیں جو اپنی علمی نشوونما کے لحاظ سے اپنی صلاحیتوں اور استعداد میں کمی رکھتے ہیں اور دوسرے سرے پر وہ بچے ہیں جو اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں عمومی کارکردگی کے معیار سے کہیں آگے ہیں۔ دونوں اقسام کو اپنی نفسیاتی، اخلاقی، سماجی اور تعلیمی نشوونما کے لیے خصوصی خدمات درکار ہیں۔ یونٹ اس حوالے سے ایک ہمہ گیر طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ یہ ان حوالوں سے آراستہ ہے جو اسے لکھتے وقت استعمال کیے گئے۔ یہ مزید مطالعے کی تجویز کرتا ہے اگر آپ کو ان موضوعات پر اپنی معلومات بڑھانے کی ضرورت ہو۔ یہ آپ کو یونٹ کے آخر میں سوالات دے کر اپنے موضوعات کی سمجھ کا خود احتساب کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔

اب آئیے شروع کرتے ہیں۔

سیکھنے کے نتائج

طلبہ کو قابل بنانے کے لیے کہ وہ:

1. مختلف درجہ بندی کے نظاموں کے ذریعے ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں کی درجہ بندی کو سمجھیں۔
2. ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں والے بچوں کی اسکریننگ اور شناخت کریں۔
3. ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں والے بچوں کے لیے مضمرات اور تدریسی طریقے سیکھیں۔
4. باصلاحیت (giftedness) کو سمجھیں اور ذہانت اور باصلاحیت میں فرق کر سکیں۔
5. متعدد ذہانتوں (multiple intelligences) کے تصور کو سمجھیں۔

6. گائیے کے باصلاحیت کے ماڈل (Gagne's Model of Giftedness) سے واقف ہوں اور اس کا موازنہ باصلاحیت بچوں کے شعبے میں کام کرنے والے ماہرین تعلیم کے وضع کردہ دیگر ماڈلوں سے کریں۔
7. ذہنی اور ترقیاتی طور پر کمزور اور باصلاحیت بچوں کے لیے استعمال ہونے والی تدریسی حکمت عملیاں سیکھیں اور نصاب میں ضروری موافقتیں کریں۔

5.1 قسم 7 - ذہنی اور ترقیاتی معذوریاں

ذہنی معذوری (intellectual disability) سے مراد عوارض کا وہ گروہ ہے جس کی خصوصیات محدود ذہنی استعداد اور تطبیقی رویوں (adaptive behaviors) میں دشواری ہے، جیسے پیسے کا انتظام، نظام الاوقات اور معمولات، یا سماجی روابط۔ ذہنی معذوری 18 سال کی عمر سے پہلے شروع ہوتی ہے اور جسمانی وجوہات، جیسے آٹزم یا دماغی فلج (cerebral palsy)، یا غیر جسمانی وجوہات، جیسے تحریک کی کمی اور بالغوں کی عدم جوابدہی، سے پیدا ہو سکتی ہے۔

ترقیاتی معذوری (developmental disability) ایک شدید، طویل مدتی معذوری ہے جو علمی صلاحیت، جسمانی افعال، یا دونوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ معذوریاں 22 سال کی عمر سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں اور تاحیات رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ اصطلاح "ترقیاتی معذوری" ذہنی معذوری کو اپنے اندر سموائے ہوئے ہے لیکن اس میں جسمانی معذوریاں بھی شامل ہیں۔ کچھ ترقیاتی معذوریاں محض جسمانی ہو سکتی ہیں، جیسے پیدائش سے اندھا پن۔ دیگر میں جسمانی اور ذہنی دونوں معذوریاں شامل ہوتی ہیں جو جینیاتی یا دیگر وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ڈاؤن سنڈروم (Down syndrome) اور جینیاتی الکحل سنڈروم (fetal alcohol syndrome)۔

Classification in Mental Retardation: Chapter 3. American Association on Mental Deficiency (AAMD), now American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) AUG, 28, 2014, Page 11 indicates that a "(developmental period" ends at age 18".

عمومی ذہنی کارکردگی کو عملی طور پر ان نتائج سے تعریف کیا جاتا ہے جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے ایک یا زیادہ انفرادی طور پر دیے گئے معیاری عمومی ذہانت کے ٹیسٹوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔

تطبیقی رویے (adaptive behavior) میں کمی، جس میں بات چیت، اپنی دیکھ بھال، سماجی اور جذباتی مہارتیں جیسی مہارتیں شامل ہیں، کو کسی فرد کی بلوغت، سیکھنے، ذاتی خود مختاری، اور/یا سماجی ذمہ داری کے معیارات کو پورا کرنے میں مؤثریت میں نمایاں حدود کے طور پر تعریف کیا جاتا ہے جو اس کی عمر کے درجے

اور ثقافتی گروہ کے لیے متوقع ہیں، جیسا کہ طبی تشخیص اور عام طور پر معیاری پیمانوں سے طے ہوتا ہے۔ ذہنی معذوریوں کو سیکھنے کی تین مختلف اقسام کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ ہیں:

1. تعلیمی سیکھنا (academic learning)،

2. تجرباتی سیکھنا (experiential learning)، اور

3. سماجی سیکھنا (social learning)

i. تعلیمی سیکھنے پر اثر: یہ علمی مہارتیں ہیں جن میں پڑھنا، لکھنا اور حساب شامل ہیں۔

ii. تجرباتی سیکھنے پر اثرات: اس قسم کا سیکھنا سبب اور اثر (cause and effect) کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی بچہ گرم پیٹر کو چھوئے۔ یہ تجربہ بچے کو پیٹر کو چھونے سے بچنا سکھاتا ہے۔ وہ ہمیشہ پیٹر کی موجودگی کو حرارت اور درد سے جوڑے گا۔ ذہنی معذوری والا بچہ اس تکلیف دہ تجربے سے نہیں سیکھتا۔ وہ پیٹر (سبب) کو اثر (درد) سے جوڑنے میں ناکام رہتا ہے۔

iii. سماجی سیکھنے پر اثرات: یہ سیکھنا سماجی حالات میں دوسرے لوگوں کا مشاہدہ کر کے ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر سماجی رسم و رواج اور اصول سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ ملانے یا گلے لگانے سے لوگوں کو سلام کرنا رواج ہے۔ سماجی سیکھنا ہمیں سماجی مہارتیں سیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ مہارتیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ مزید برآں، زندگی کی کامیابی کے لیے سماجی مہارتیں بہت اہم ہیں۔ ذہنی معذوری والے لوگ اپنے عام ہم عمر بچوں کے مقابلے میں اپنی سماجی مہارتوں میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔

اب آئیے پڑھتے ہیں کہ سیکھنے کا یہ عمل کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے

سیکھنے (learning) کو تجربے کے نتیجے میں رویے میں تبدیلی کے طور پر تعریف کیا جا سکتا ہے۔ یہ جسمانی اور ظاہر ہو سکتا ہے، یا اس میں پیچیدہ ذہنی یا رویہ جاتی تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں جو زیادہ لطیف طریقوں سے رویے کو متاثر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، سیکھنے کے تجربے کے نتیجے میں کسی فرد کا سمجھنے، سوچنے، محسوس کرنے اور کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ سیکھنا ہمارے عمل کرنے، سوچنے اور/یا اپنے بارے میں، دوسرے لوگوں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں محسوس کرنے کے طریقے میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ سیکھنا پیدا کرنے کے لیے دو بنیادی عمل شامل ہیں یعنی ادراک (perception) - ہم معلومات کس طرح حاصل کرتے ہیں اور پروسیسنگ (processing) - ہم ان معلومات سے کیسے نمٹتے ہیں۔ سیکھنے کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں حاصل کردہ علم کی اہمیت اور مطابقت کے ہمارے اپنے ادراک پر منحصر ہو کر مستقل

یا عارضی ہو سکتی ہیں۔ انفرادی سیکھنے کی استعداد محرک (stimulus)، تحریک (motivation) اور سیکھنے کے انداز پر منحصر ہوتی ہے۔

ذہنی معذوری والے لوگ دو اہم شعبوں میں نمایاں حدود کا تجربہ کرتے ہیں:

1. ذہنی کارکردگی (intellectual functioning) اور

2. تطبیقی رویہ (adaptive behavior)

ذہنی کارکردگی

ذہنی کارکردگی کا تعین بہت سے عوامل سے ہوتا ہے۔ تاہم، اس استعداد کا بنیادی ذریعہ ذہنی صلاحیت یا "ذہانت" ہے۔ ذہانت سے مراد استدلال کرنے، منصوبہ بندی کرنے، سوچنے اور بات چیت کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیتیں ہمیں مسائل حل کرنے، سیکھنے اور اچھا فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ ذہانت سے مراد عمومی ذہنی صلاحیت ہے۔ اس میں استدلال کرنے، منصوبہ بندی کرنے، مسائل حل کرنے، تجریدی سوچنے، پیچیدہ خیالات کو سمجھنے، تیزی سے سیکھنے اور تجربے سے سیکھنے کی صلاحیت شامل ہے۔

تطبیقی رویہ کیا ہے؟

تطبیقی رویہ تصوری، سماجی اور عملی مہارتوں کا مجموعہ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تطبیقی رویے میں نمایاں حدود کسی شخص کی روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور کسی خاص صورت حال یا ماحول کا جواب دینے کی اس کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔ معیاری ٹیسٹنگ کا مقصد درج ذیل مہارتوں کی پیمائش کرنا ہے:

• تصوری مہارتیں (conceptual skills): وصولی اور اظہاری زبان، پڑھنا اور لکھنا، پیسے کے تصورات، خود ہدایت۔

• سماجی مہارتیں (social skills): باہمی تعلقات، ذمہ داری، خود اعتمادی، اصولوں کی پیروی، قوانین کی اطاعت۔

• عملی مہارتیں (practical skills): روزمرہ کی زندگی کی ذاتی سرگرمیاں جیسے کھانا، لباس پہننا، حرکت اور بیت الخلا کا استعمال؛ روزمرہ کی زندگی کی آلاتی سرگرمیاں جیسے کھانا تیار کرنا، دوا لینا، ٹیلیفون استعمال کرنا، پیسے کا انتظام، نقل و حمل کا استعمال اور گھر کے کام کرنا؛ پیشہ ورانہ مہارتیں؛ محفوظ ماحول برقرار رکھنا۔

ایک شعبے میں نمایاں کمی انفرادی کارکردگی کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ یہ تطبیقی رویے میں عمومی کمی بن جاتی ہے (AAIDD, 2011)۔

تو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو یہ ہے:

ذہنی معذوری بچے کی 18 سال کی عمر سے پہلے کسی بھی وقت شروع ہوتی ہے اور اس کی خصوصیات دونوں میں مسائل ہیں:

- ذہنی کارکردگی یا ذہانت، جس میں سیکھنے، استدلال کرنے، مسئلہ حل کرنے اور دیگر مہارتوں کی صلاحیت شامل ہے؛ اور
- تطبیقی رویہ، جس میں روزمرہ کی سماجی اور زندگی کی مہارتیں شامل ہیں۔

ترقیاتی معذوریاں: اصطلاح "ترقیاتی معذوریاں" اکثر تاحیات معذوری کی ایک وسیع تر قسم ہے جو ذہنی، جسمانی یا دونوں ہو سکتی ہے۔ "IDD" وہ اصطلاح ہے جو اکثر ان حالات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں ذہنی معذوری اور دیگر معذوریاں موجود ہوں۔

Developmental Disabilities Act (Pub. L. 106-402) کے مطابق، ترقیاتی معذوری کی اصطلاح سے مراد ایک شدید، دائمی معذوری ہے جو:

1. ذہنی یا جسمانی خرابی یا ان خرابیوں کے مجموعے کی وجہ سے ہو۔
2. فرد کے 22 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے واقع ہو۔
3. غیر معینہ مدت تک جاری رہنے کا امکان ہو۔
4. بڑی زندگی کی سرگرمیوں کے درج ذیل شعبوں میں سے تین یا زیادہ میں نمایاں فعالی حدود پیدا کرے: (i) خود دیکھ بھال، (ii) وصولی اور اظہاری زبان، (iii) سیکھنا، (iv) حرکت، (v) خود ہدایت، (vi) آزاد زندگی گزارنے کی استعداد، اور (vii) معاشی خود کفالت؛ اور
5. فرد کی خصوصی، بین الضابطہ، یا عمومی خدمات، انفرادی حمایت، یا مدد کی دیگر صورتوں کے مجموعے اور تسلسل کی ضرورت کو ظاہر کرے جو تاحیات یا طویل مدتی ہوں اور انفرادی طور پر منصوبہ بند اور مربوط ہوں۔

6. ترقیاتی کمی سست، رکی ہوئی، یا نامکمل نشوونما سے ظاہر ہو سکتی ہے جو دماغی نقصان، مرکزی اعصابی نظام میں تنزلی کے عمل، یا نفسیاتی سماجی عوامل کی وجہ سے پہلے کی عام حالتوں سے پسپائی کے نتیجے میں ہو۔

ڈی ڈی (DD) کی تعریف AAIDD کی ذہنی معذوری کی تعریف سے کیسے موازنہ کرتی ہے؟

بڑے فرق شروع ہونے کی عمر، حدود کی شدت، اور اس حقیقت میں ہیں کہ ترقیاتی معذوری کی تعریف آئی کیو کی شرط کا حوالہ نہیں دیتی۔ ذہنی معذوری والے بہت سے افراد ترقیاتی معذوری کی تعریف پر بھی پورے اتریں گے۔ تاہم، اندازہ ہے کہ ذہنی معذوری والے کم از کم نصف افراد ڈی ڈی کی تعریف میں فعالی حد کی شرط کو پورا نہیں کریں گے۔ ذہنی معذوری میں عمومی ذہنی صلاحیتوں کی خرابیاں شامل ہیں جو تین دائروں، یا شعبوں میں تطبیقی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ دائرے طے کرتے ہیں کہ کوئی فرد روزمرہ کے کاموں سے کتنی اچھی طرح نمٹتا ہے:

ڈی ڈی کی تعریف بڑی زندگی کی سرگرمی کے تین یا زیادہ شعبوں میں نمایاں فعالی حدود کا تقاضا کرتی ہے۔ ذہنی معذوری کی تعریف تطبیقی رویے کے ایک شعبے میں نمایاں حدود کا تقاضا کرتی ہے۔

ترقیاتی معذوریوں والوں میں دماغی فالج، مرگی، ترقیاتی تاخیر، آٹزم اور آٹزم اسپیکٹرم عوارض، جنینی الکحل اسپیکٹرم عارضہ (یا FASD) یا سینکڑوں مخصوص سنڈروم اور اعصابی حالتوں میں سے کوئی بھی شامل ہے جو عمومی ذہنی کارکردگی یا ذہنی معذوری والے شخص کے تطبیقی رویے جیسی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔

5.1.1 درجہ بندی اور تشخیص

علمی خرابیاں (cognitive impairments) چار اقسام میں تقسیم کی گئی ہیں:

1. ہلکی (mild)

2. معتدل (moderate)

3. شدید (severe) اور

4. انتہائی شدید (profound)

قسم کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

ہلکی ذہنی معذوری

• آئی کیو 50 سے 70

• نشوونما کے تمام شعبوں میں معمول سے سست

• کوئی غیر معمولی جسمانی خصوصیات نہیں

• عملی زندگی کی مہارتیں سیکھنے کے قابل

• پڑھنے اور ریاضی کی مہارتیں جماعت 3 سے 6 کے درجے تک حاصل کر سکتا ہے

- سماجی طور پر گھل مل سکتا ہے
- روزمرہ کی زندگی میں کام کرتا ہے

معتدل ذہنی معذوری

• آئی کیو 35 سے 49

- نمایاں ترقیاتی تاخیر (یعنی تقریر، موٹر مہارتیں)
- خرابی کی جسمانی علامات ہو سکتی ہیں (یعنی موٹی زبان)
- بنیادی، سادہ طریقوں سے بات چیت کر سکتا ہے
- بنیادی صحت اور حفاظت کی مہارتیں سیکھنے کے قابل
- خود دیکھ بھال کی سرگرمیاں مکمل کر سکتا ہے
- قریبی، مانوس جگہوں پر اکیلے سفر کر سکتا ہے

معتدل ذہنی معذوری والے لوگوں میں بات چیت کی مناسب مہارتیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر پیچیدہ درجے پر بات چیت نہیں کر سکتے۔ انہیں سماجی حالات میں دشواری اور سماجی اشاروں اور فیصلے میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی دیکھ بھال خود کر سکتے ہیں، لیکن عام شخص سے زیادہ ہدایت اور حمایت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بہت سے آزاد حالات میں رہ سکتے ہیں، لیکن کچھ کو اب بھی گروپ ہوم کی حمایت درکار ہوتی ہے۔

شدید ذہنی معذوری

• آئی کیو 20 سے 34

- نشوونما میں کافی تاخیر
- تقریر کو سمجھتا ہے، لیکن بات چیت کی بہت کم صلاحیت
- روزمرہ کے معمولات سیکھنے کے قابل
- بہت سادہ خود دیکھ بھال سیکھ سکتا ہے
- سماجی حالات میں براہ راست نگرانی درکار

ذہنی معذوری کی تشخیص پانے والوں میں سے صرف تقریباً 3 یا 4 فیصد شدید قسم میں آتے ہیں۔ یہ لوگ صرف انتہائی بنیادی درجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ وہ تمام خود دیکھ بھال کی سرگرمیاں آزادانہ طور پر

انجام نہیں دے سکتے اور انہیں روزانہ نگرانی اور حمایت درکار ہوتی ہے۔ اس قسم کے زیادہ تر لوگ کامیابی سے آزاد زندگی نہیں گزار سکتے اور انہیں گروپ ہوم کی ترتیب میں رہنے کی ضرورت ہوگی۔

انتہائی شدید ذہنی معذوری

- آئی کیو 20 سے کم
- تمام شعبوں میں نمایاں ترقیاتی تاخیر
- واضح جسمانی اور پیدائشی غیر معمولیات
- قریبی نگرانی درکار
- خود دیکھ بھال کی سرگرمیوں میں مدد کے لیے معاون درکار
- جسمانی اور سماجی سرگرمیوں کا جواب دے سکتا ہے
- آزاد زندگی گزارنے کے قابل نہیں

انتہائی شدید ذہنی معذوری والے لوگوں کو چوبیس گھنٹے حمایت اور دیکھ بھال درکار ہوتی ہے۔ وہ روزمرہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں اور بات چیت کی انتہائی محدود صلاحیت رکھتے ہیں۔ اکثر، اس قسم کے لوگوں میں دیگر جسمانی حدود بھی ہوتی ہیں۔ ذہنی معذوری والے لوگوں میں سے تقریباً 1 سے 2 فیصد اس قسم میں آتے ہیں۔ تاہم، نئے DSM-V کے مطابق، شدید سماجی خرابی والا کوئی شخص (اتنا شدید کہ وہ مثلاً معتدل قسم میں آئے) ہلکی قسم میں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا آئی کیو 80 یا 85 ہے۔ تو DSM-V میں تبدیلیاں ذہنی صحت کے پیشہ ور افراد سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ روزمرہ کی زندگی کی مہارتوں اور سرگرمیوں کو انجام دینے کی شخص کی صلاحیت کے مقابلے میں آئی کیو اسکور کو تول کر خرابی کے درجے کا اندازہ لگائیں۔

رسمی اور غیر رسمی دونوں تشخیصی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ غیر رسمی ٹیسٹنگ مخصوص ترقیاتی سنگ میلوں کے حصول کا تعین کرنے کے لیے سب سے مفید ہو سکتی ہے۔ ذہنی معذوری کی تشخیص ذہانت اور تطبیقی رویے کے معیاری ٹیسٹوں کے استعمال سے کی جاتی ہے۔ ذہنی عوارض کے تشخیصی اور شماریاتی دستی (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) کے پانچویں ایڈیشن (DSM-5) میں ذہنی معذوری کی تشخیص کرتے وقت طبی تشخیص اور ذہانت کی معیاری ٹیسٹنگ دونوں کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، جس میں خرابی کی شدت تطبیقی کارکردگی پر مبنی ہو نہ کہ صرف آئی کیو ٹیسٹ اسکور پر۔ تشخیصی علمی صلاحیتوں اور عملی مہارتوں کی کمی کے اثرات پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو نمایاں معلومات فراہم کرتی ہے۔

ذہنی معذوری (ID، سابقہ mental retardation) کا پہلا اشارہ عام طور پر بچے کی جسمانی اور رویہ جاتی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک بار ذہنی معذوری کا شبہ ہونے کے بعد، رسمی تشخیص اور جائزہ شروع ہوتا ہے۔ تشخیص مکمل جسمانی معائنے سے شروع ہوتی ہے۔

آئی ڈی والے افراد کی تشخیص میں ترقیاتی شعبوں میں متنوع اور دور رس ضروریات کی وجہ سے متعدد پیشہ ور افراد شامل ہوتے ہیں۔ ٹیم ماڈل کثیر الضابطہ (multidisciplinary)، بین الضابطہ (interdisciplinary)، یا بین شعبہ جاتی (transdisciplinary) ہو سکتے ہیں۔

ایک مکمل تشخیص میں عام طور پر درج ذیل شامل ہوتے ہیں:

- جامع طبی معائنہ؛
- ممکنہ جینیاتی اور اعصابی ٹیسٹنگ؛
- سماجی اور خاندانی پس منظر؛
- تعلیمی پس منظر؛
- ذہنی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے نفسیاتی ٹیسٹنگ؛
- تطبیقی کارکردگی کی ٹیسٹنگ؛
- بنیادی دیکھ بھال کرنے والوں سے انٹرویو؛
- اساتذہ سے انٹرویو؛
- قدرتی ماحول میں بچے کے سماجی اور رویہ جاتی مشاہدات۔

تشخیص معیاری اور غیر رسمی آلات اور طریقہ کار سمیت متعدد پیمائشوں کے استعمال کے ذریعے ڈیٹا کا مجموعہ ہے۔ یہ پیمائشیں کسی انفرادی طالب علم کے بارے میں جامع مقداری اور کیفی ڈیٹا جمع کرتی ہیں۔ مسلسل پیش رفت کی نگرانی کے نتائج انفرادی اور کلاس روم کی تشخیص کے حصے کے طور پر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ تشخیصی ڈیٹا کے ان میں سے بہت سے ذرائع سے حاصل معلومات اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے استعمال کی جاسکتی ہیں کہ جامع تشخیص اور جائزہ درست طور پر ظاہر کرے کہ کوئی انفرادی طالب علم کیسے کارکردگی دکھا رہا ہے۔

تشخیص کے بعد جائزہ آتا ہے اور یہ تمام ڈیٹا ذرائع سے معلومات کو مربوط، تشریح اور خلاصہ کرتا ہے۔ جائزہ جامع تشخیصی ڈیٹا کو مربوط، تشریح اور خلاصہ کرنے کا عمل ہے، بشمول بالواسطہ اور پہلے سے موجود ذرائع۔ تشخیص اور جائزے کا بڑا مقصد ٹیم کے ارکان کو ڈیٹا استعمال کر کے طالب علم کی خوبیوں اور ضروریات کا پروفائل

بنانے کے قابل بنانا ہے۔ طالب علم کا پروفائل شناخت، اہلیت، خدات اور ہدایات کے بارے میں فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے۔ سیکھنے کی معذوریوں والے طلبہ کی درست تشخیص کے لیے جامع تشخیص اور جائزے کے طریقہ کار دونوں اہم ہیں۔

• تصویری دائرے (conceptual domain) میں زبان، پڑھنے، لکھنے، ریاضی، استدلال، علم اور یادداشت کی مہارتیں شامل ہیں۔

• سماجی دائرہ (social domain) ہمدردی، سماجی فیصلے، باہمی بات چیت کی مہارتوں، دوستی بنانے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت، اور اسی طرح کی استعدادوں سے مراد ہے۔

• عملی دائرہ (practical domain) ذاتی دیکھ بھال، ملازمت کی ذمہ داریوں، پیسے کے انتظام، تفریح، اور اسکول اور کام کے کاموں کو منظم کرنے جیسے شعبوں میں خود انتظام پر مرکوز ہے۔

5.1.2 ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں کے مضمرات

ذہنی معذوری والے بچوں کے سیکھنے کے عمل کی نشوونما ان کی عمر کے دیگر بچوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر سست رفتار اور نچلے درجے تک ہوتی ہے۔

ان بچوں میں اپنی علمی مہارتوں میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ یعنی ان کی سوچنے اور استدلال کرنے کی صلاحیت، نیز ان کی خود مختاری، سماجیات اور زبان کی مہارتیں، ان کی عمر کے دیگر بچوں کے مقابلے میں۔

ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں کا بہترین جائزہ پیشہ ور افراد لیتے ہیں۔ ایسے عوارض دیگر عوارض کے ساتھ ہم عارض (co-morbid) ہو سکتے ہیں۔ ذہنی معذوری کو دیکھنے کا ایک تعمیری طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی حمایتی ضروریات کے لحاظ سے تعریف کیا جائے۔ یہ طریقہ معذوری کے اثر کو ایسی چیز کے طور پر دیکھتا ہے جو مختلف ہوگی اور بیرونی عوامل سے بڑھائی یا کم کی جاسکتی ہے۔ ماحول اور حمایت کو شخص کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایڈجسٹ کرنے سے شخص کی استعداد بڑھ سکتی ہے اور معذوری کا اثر کم ہو سکتا ہے۔

تشخیصی طریقہ کار

وہ طریقہ کار جو جامع نہ ہوں، کچھ افراد کی معذوری کے حامل کے طور پر شناخت کا باعث بن سکتے ہیں جبکہ وہ نہیں ہیں، اور اس کے برعکس، کچھ افراد کو خارج کر سکتے ہیں جنہیں واقعی مخصوص سیکھنے کی معذوریاں ہیں۔ اگر کسی خطرے میں یا مشتبہ ڈی ڈی والے بچے کے لیے تشخیص یا اہلیت کا ابھی تعین نہ ہوا ہو تو رسمی ٹیسٹنگ درکار ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تشخیصی آلات، تکنیکیں، ڈیٹا ذرائع درکار ہیں۔

متبادل طور پر متحرک تشخیص (dynamic assessment) بھی بچے کی سیکھنے کی استعداد اور صلاحیتوں کی تشخیص کے لیے کی جاسکتی ہے۔ متحرک تشخیص ان مہارتوں کی شناخت کرتی ہے جو کسی انفرادی بچے کے

پاس ہیں نیز ان کی سیکھنے کی صلاحیت۔ متحرک تشخیصی طریقہ کار سیکھنے کے عمل پر زور دیتا ہے اور معائنہ کار کی سرمایہ کاری کی مقدار اور نوعیت کا حساب رکھتا ہے۔ یہ انتہائی تعالیٰ اور عمل پر مبنی ہے۔

انفرادی طلبہ کی جامع تشخیص کے لیے متعدد ڈیٹا ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصطلاح تشخیص تعلیمی ترتیبوں میں مختلف مقاصد کے لیے بہت سے مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوتی ہے بشمول انفرادی اور گروہی، معیاری اور غیر رسمی، اور تشکیلاتی اور خلاصہ جاتی۔ کچھ پیشہ ور افراد تشخیص کو وسیع طور پر استعمال کرتے ہیں جس میں تشخیص اور جائزہ دونوں شامل ہیں۔

سیکھنے کے انداز، سیکھنے کی استعداد

چھوٹے بچوں اور تطبیقی مہارتوں میں حدود رکھنے والے افراد کے لیے تدریسی طریقہ کار میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکچر یا مظاہرے کا روایتی طریقہ اتنا مددگار نہیں ہو سکتا جتنا شخص کو ہاتھوں سے مواد کے ساتھ مہارت کی مشق کرنے دینے کی حکمت عملی۔ طالب علم کی موجودہ مہارتوں اور خوبیوں کو استعمال کرنے اور انہیں مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے نئی مہارتوں سے تدریس شروع کرنے کے بجائے کامیابی کا تجربہ فراہم کیا جائے۔ اس سے ذہنی کمی والے بچے کی مدد ہوگی اگر اس مقصد کے لیے چھوٹے یا تقسیم شدہ سیشن لیے جائیں۔

شخصیت کی نشوونما

ذہنی معذوری والے لوگ زیادہ ناکامی، مسترد ہونے اور سماجی محرومی کا تجربہ کرتے ہیں جو شخصیت کی ایسی خصوصیات پیدا کرتی ہیں جو ان کی سیکھنے کی صلاحیت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اور انہیں افسردگی کا شکار بنا سکتی ہیں۔ سیکھنے کی معذوریوں والے طلبہ اپنی صلاحیت کے درجوں میں عدم توازن کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ کچھ چیزوں میں بہت اچھے ہیں، دوسری میں بہت خراب، اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے درمیان تناؤ ہے۔ یا یوسی سیکھنے کی معذوری والے طالب علم کی نمایاں علامت ہے۔ عام طور پر ایسے طلبہ یا تو ایک یا زیادہ تعلیمی شعبوں میں ناکام ہوں گے یا کامیاب ہونے کے لیے ضرورت سے زیادہ توانائی صرف کریں گے۔ نیز، وہ انتہائی غیر مستقل بھی ہوتے ہیں، ایک دن کوئی کام کرنے کے قابل اور اگلے دن ناقابل۔

5.1.3 تدریسی طریقہ کار

ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں والے طلبہ کو نصاب میں رعایتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد ایک ایسا سیکھنے کا ماحول قائم کرنا ہے جو طلبہ کو ان کے تعلیمی اہداف حاصل کرنے میں مدد دے۔ ایسے طلبہ کے لیے تعلیمی اہداف تعلیمات سے زیادہ اہم ہیں۔ ترقیاتی تاخیر والے طلبہ بے توجہی، جارحیت اور دوسروں کے ساتھ میل

جول نہ کر سکنے کی علامات ظاہر کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے تدریسی حکمت عملیاں ایسی ہونی چاہئیں جو ان کی خصوصی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کریں۔

سیکھنے کے کاموں کو چھوٹے مراحل میں توڑیں

ہر سیکھنے کا کام ایک وقت میں ایک قدم کے ساتھ متعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ طالب علم کو مغلوب ہونے سے بچاتا ہے۔ ایک بار طالب علم ایک قدم میں مہارت حاصل کر لے، اگلا قدم متعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ ایک ترقی پسند، مرحلہ وار سیکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ بہت سے سیکھنے کے ماڈلوں کی خصوصیت ہے۔ واحد فرق ترتیب وار مراحل کی تعداد اور سائز کا ہے۔

عملی مشق (Hands-On Practice)

طویل زبانی ہدایات یا روایتی لیکچرنگ ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں والے زیادہ تر طلبہ کے لیے زیادہ تر غیر مؤثر تدریسی طریقے ہیں۔ عام طور پر ایسے لوگ حرکی سیکھنے والے (kinesthetic learners) ہوتے ہیں یعنی وہ کسی کام کو "ہاتھوں سے" انجام دے کر بہترین سیکھتے ہیں۔ وہ اس وقت بہترین سیکھتے ہیں جب معلومات ٹھوس، مشاہدہ شدہ اور مشق شدہ ہوں۔

بصری اشارے اور ٹھوس تدریسی۔ سیکھنے کے معاونات کا استعمال

آئی ڈی والے لوگ ایسے سیکھنے کے ماحول میں بہترین کرتے ہیں جہاں بصری اور ٹھوس معاونات استعمال کیے جائیں۔ قدرتی ماحول میں حقیقی مواد یا اصل آلات کا استعمال ذہنی معذوری والے طلبہ کی مؤثر ہدایت کا ایک لازمی جزو ہے۔ مثال کے طور پر طلبہ کو بڑے اور چھوٹے کا تصور سکھاتے وقت اگر ایک ہی رنگ کے دو غبارے دکھائے جائیں جن کے بڑے اور چھوٹے سائز واضح طور پر مختلف ہوں اور انہیں محسوس کرنے دیا جائے تو ان پر دیر پا سیکھنے کے اثرات مرتب ہوں گے۔

فوری فیڈبک

کارکردگی پر براہ راست اور فوری فیڈبک کی فراہمی انہیں اپنے رویے اور استاد کے رد عمل کے درمیان تعلق بنانے کے قابل بناتی ہے۔ فیڈبک فراہم کرنے میں تاخیر سبب اور اثر کے درمیان تعلق بنانا مشکل بنا دیتی ہے۔ نتیجتاً، سیکھنے کا نکتہ چھوٹا ہو سکتا ہے۔

چھوٹے گروہوں میں تدریس یا انفرادی ہدایات

طلبہ چھوٹے گروہوں میں پڑھائے جانے پر بہترین سیکھتے ہیں۔

ایسی گروہ بندی کی صورتوں میں شامل ہیں:

- ہم عمر (peer) ٹیوشن
- مختلف عمر کی ٹیوشن
- چھوٹے سیکھنے کے گروہ
- مشترکہ گروہ بندی کی صورتیں
- کبھی کبھی گروپ لیڈر مقرر کرنا

براہ راست ہدایات

ذہنی کارکردگی اور تطبیقی رویے میں حدود کو مکمل طور پر پورا کرنے کے لیے، اساتذہ کو عمومی نصاب سے باہر متعدد مہارتوں کے شعبوں میں براہ راست ہدایت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مہارتیں نوعیت میں زیادہ فعال ہیں لیکن فرد کی مستقبل کی خود مختاری کے لیے بالکل ضروری ہیں۔ ذہنی معذوری والے طلبہ کو سکھانے کے لیے مفید حکمت عملیوں میں درج ذیل تکنیکیں شامل ہیں، لیکن انہی تک محدود نہیں:

معاون ٹیکنالوجی

کلاس روم میں ذہنی معذوری والے طلبہ کی حمایت کے لیے ڈیزائن کردہ متعدد موجودہ سافٹ ویئر پیکج موجود ہیں۔ خواندگی سافٹ ویئر میں ایک امید افزا طریقہ سیکھنے کے لیے عالمگیر ڈیزائن (universal design for learning) کے اصولوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ طریقہ ڈی کوڈنگ اور سمجھنے کے لیے براہ راست ہدایت کے ساتھ معنی کے لیے پڑھنے کو جوڑتا ہے۔ نیچے میں بننے والا سافٹ ویئر ایک آڈیو اور ویڈیو پر مبنی نصاب پر مشتمل ہے جسے استاد طالب علم کی مخصوص تعلیمی استعداد کو پورا کرنے کے لیے ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔

بالآخر، کوئی بھی سیکھنے والا سافٹ ویئر جو طالب علم کی دلچسپیوں کو پورا کرنے کے لیے مواد کو ڈھال سکتا ہے، ذہنی معذوری والے افراد کے ساتھ سیکھنے کی حمایت میں مفید ہو سکتا ہے، بشرطیکہ ہدایت کو فرد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈھالا جاسکے۔

5.2 قسم 8 - باصلاحیت اور ذہین

باصلاحیت (gifted) لوگ وہ ہیں جو علمی ذہانت، تخلیقی صلاحیت، فن، قیادت جیسے شعبوں میں اوسط سے اعلیٰ درجے کی استعداد اور صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ان کی کارکردگی کرتے ہیں اور انہیں خصوصی مداخلتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر انہی حالات میں دوسروں کو درکار نہیں ہوتیں (Renzulli 1978, 1984,

-(Renzulli & Reis, 1985, Gagne, 2003, 2008)

باصلاحیت بچے اور عام بچے کے درمیان حیاتیاتی فرق ہے۔ باصلاحیت بچے میں خلیوں کی پیداوار بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے جو سیناپٹک سرگرمی بھی بڑھاتی ہے۔ یہ سب مل کر سوچ کے عمل میں اضافہ کرتے ہیں۔ باصلاحیت بچے کے دماغ میں نیورون حیاتی کیمیائی طور پر زیادہ وافر معلوم ہوتے ہیں اور نتیجتاً، جو دماغی نمونے بنتے ہیں وہ زیادہ پیچیدہ سوچ کو پروسیس کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دماغ میں پری فرنٹل کورٹیکس (prefrontal cortex) کی سرگرمی زیادہ معلوم ہوتی ہے، جو بصیرت افزا اور بدیہی سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ باصلاحیت بچوں کے دماغ میں الفا لہر کی سرگرمی زیادہ ہوتی ہے۔ الفا دماغی لہریں خاموشی سے بہتے خیالات کے دوران، اور کچھ مراقبے کی حالتوں میں غالب ہوتی ہیں۔ الفا 'اب کی طاقت' ہے، یہاں ہونا، حال میں ہونا۔ الفا دماغ کی آرام کی حالت ہے۔ الفا لہریں مجموعی ذہنی ہم آہنگی، سکون، چوکسی، ذہن / جسم کے انضمام اور سیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ وہ نہ صرف عام بچے سے زیادہ تیزی سے الفا لہر کی سرگرمی حاصل کرتے ہیں، بلکہ اسے زیادہ دیر تک برقرار بھی رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ آرام دہ اور مرکوز سیکھنے کی اجازت دیتا ہے جس میں برقرار رکھنے اور انضمام کی صلاحیت زیادہ ہو۔ باصلاحیت بچے کی دماغی تالیں زیادہ کثرت سے وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور یہ ارتکاز، توجہ، تحقیق اور استفسار کی اجازت دیتی ہیں (Clark, 2012)۔

5.2.1 متعدد ذہانتوں کی تعریف

متعدد ذہانتوں (multiple intelligences) کا نظریہ 1983 میں ڈاکٹر ہوورڈ گارڈنر (Dr. Howard Gardner)، ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے پروفیسر، نے تیار کیا تھا۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ ذہانت کا روایتی تصور، جو آئی کیو ٹیسٹنگ پر مبنی ہے، بہت محدود ہے۔ متعدد ذہانتوں کا نظریہ ذہانت کو ایک واحد عمومی صلاحیت کے زیر اثر دیکھنے کے بجائے مخصوص (بنیادی طور پر حسی) 'طریقوں' (modalities) میں فرق کرتا ہے۔ متعدد ذہانتیں مختلف ذہنی صلاحیتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہوورڈ گارڈنر نے یہ ماڈل اپنی 1983 کی کتاب Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences میں پیش کیا۔

اس نظریے کے مطابق، "ہم سب زبان، منطقی-ریاضیاتی تجزیہ، مقامی نمائندگی، موسیقی سوچ اور مسائل حل کرنے یا چیزیں بنانے کے لیے جسم کے استعمال، دیگر افراد کی سمجھ اور اپنے آپ کی سمجھ کے ذریعے دنیا کو جاننے کے قابل ہیں۔ جہاں افراد مختلف ہیں وہ ان ذہانتوں کی طاقت میں ہے۔ نام نہاد ذہانتوں کا پروفائل - اور ان طریقوں میں جن میں ایسی ذہانتیں مختلف کام انجام دینے، متنوع مسائل حل کرنے اور مختلف شعبوں میں ترقی کرنے کے لیے بلائی اور جوڑی جاتی ہیں۔"

ذہانتیں یہ ہیں:

بصری-مقامی (Visual-Spatial) - جسمانی جگہ کے لحاظ سے سوچتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ کرنا، جگسا پزل کرنا، نقشے پڑھنا اور خیالات میں کھوئے رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں ڈرائنگ، زبانی اور جسمانی تصور کے ذریعے

سکھایا جا سکتا ہے۔ آلات میں ماڈل، گرافکس، چارٹ، تصاویر، ڈرائنگ، D-3 ماڈلنگ، ٹیلی ویژن، ملٹی میڈیا، تصویروں/چارٹ/گراف والے متون شامل ہیں۔

جسمانی-حرکی (Bodily-kinesthetic) - جسم کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسے رقص یا سرجن۔ جسمانی آگاہی کی گہری حس رکھتے ہیں۔ وہ حرکت، چیزیں بنانا، چھونا پسند کرتے ہیں۔ وہ جسمانی زبان کے ذریعے اچھی طرح بات چیت کرتے ہیں اور انہیں جسمانی سرگرمی، ہاتھوں سے سیکھنے اور اداکاری، کردار ادا کرنے کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے۔ آلات میں سامان اور حقیقی اشیاء شامل ہیں۔

موسیقی (Musical) - تال اور آواز کے لیے حساسیت ظاہر کرتے ہیں۔ وہ موسیقی سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماحول میں آوازوں کے لیے بھی حساس ہوتے ہیں۔ وہ پس منظر میں موسیقی کے ساتھ بہتر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہیں اسباق کو نغموں میں بدل کر، تال سے بول کر اور وقت کو تھپتھا کر سکھایا جا سکتا ہے۔ آلات میں موسیقی کے آلات، موسیقی، ریڈیو، سیڈیو، CD-ROM، ملٹی میڈیا شامل ہیں۔

باہمی (Interpersonal) - دوسروں کو سمجھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا۔ یہ طلبہ تعامل کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ ان کے بہت سے دوست ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمدردی، گلی کی سمجھ۔ انہیں گروہی سرگرمیوں، سیمیناروں اور مکالموں کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے۔ آلات میں ٹیلیفون، آڈیو کانفرنسنگ، انسٹرکٹر کی طرف سے وقت اور توجہ، ویڈیو کانفرنسنگ، تحریر، کمپیوٹر کانفرنسنگ، ای میل شامل ہیں۔

اندرونی (Intrapersonal) - اپنی دلچسپیوں، اہداف کو سمجھنا۔ یہ سیکھنے والے دوسروں سے دور رہتے ہیں۔ وہ اپنے اندرونی جذبات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں؛ ان میں دانائی، بصیرت اور تحریک، نیز مضبوط ارادہ، اعتماد اور رائے ہوتی ہے۔ انہیں آزاد مطالعے اور خود احتسابی کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے۔ آلات میں کتابیں، تخلیقی مواد، ڈائریاں، رازداری اور وقت شامل ہیں۔ وہ سیکھنے والوں میں سب سے آزاد ہیں۔

لسانی (Linguistic) - الفاظ کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا۔ ان سیکھنے والوں میں انتہائی ترقی یافتہ سماعتی مہارتیں ہوتی ہیں اور اکثر الفاظ میں سوچتے ہیں۔ وہ پڑھنا، الفاظ کے کھیل کھیلنا، نظمیں یا کہانیاں بنانا پسند کرتے ہیں۔ انہیں الفاظ کہنے اور دیکھنے کی ترغیب دے کر، مل کر کتابیں پڑھ کر سکھایا جا سکتا ہے۔ آلات میں کمپیوٹر، کھیل، ملٹی میڈیا، کتابیں، ٹیپ ریکارڈر اور لیکچر شامل ہیں۔

منطقی-ریاضیاتی (Logical-Mathematical) - استدلال، حساب۔ تصوری طور پر، تجربی طور پر سوچتے ہیں اور نمونوں اور تعلقات کو دیکھنے اور تلاش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ تجربہ کرنا، پزلیں حل کرنا اور کائناتی سوالات پوچھنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں منطقی کھیلوں، تحقیقات اور اسرار کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے۔ انہیں تفصیلات سے نمٹنے سے پہلے سیکھنے اور تصورات بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ (ماخوذ از: The

//:Distance Learning Technology Resource Guide," by Carla Lane, <https://www.gse.harvard.edu/faculty/howard-gardner>

5.2.2 تنوع کی شناخت اور رعایت

باصلاحیت لوگ مختلف خصوصیات اور صفات ظاہر کرتے ہیں۔ باصلاحیت متحرک ہے اور سماجی و معاشی درجے، عقیدے، رنگ یا نسل کی کسی شناخت کے بغیر ظاہر ہوتی ہے۔ شناخت کے لیے، پیشہ ور افراد کو مختلف شعبوں میں معلومات جمع کرنے کے طریقے تلاش کرنے چاہئیں۔ باصلاحیت کسی مخصوص دلچسپی یا قسم کے اندر ظاہر ہو سکتی ہے۔ ابتدائی شناخت باصلاحیت کو ہنر میں بدلنے کے امکانات رکھتی ہے۔ باصلاحیت طلبہ کی شناخت کے لیے ایک منظم، کثیر مرحلہ عمل کی پیروی کی جانی چاہیے جو ان طلبہ کی اسکریننگ کرے جنہیں عمومی تعلیمی پروگرام سے آگے خصوصی خدمات درکار ہیں۔

کسی بھی شناختی عمل میں:

- معلمین اور والدین باصلاحیت کی شناخت اور پرورش میں اہم ہیں۔
 - شواہد پر مبنی خصوصیات باصلاحیت کو پہچاننے اور سمجھنے کی رہنمائی ہیں۔
 - ہمیں ان عوامل سے ہوشیار رہنا چاہیے جو بچے کی صلاحیتوں کو چھپا سکتے ہیں، بشمول ہمارے عقائد۔
 - غیر رسمی شناخت ضروری ہے تاکہ رسمی شناخت ہونے کے لیے (ممکنہ) باصلاحیت کو پہچانا جائے۔
- (Kerry Hodge, 2013)

باصلاحیت کے مستقل اشارے

- "اچھی" سوچ - یعنی استدلال، تصوری سمجھ، تجریدی سوچ، مسئلہ حل کرنا، عمومیت؛
- سیکھنے میں آسانی یا رفتار - صرف ایک بار بتانے / دکھانے سے سیکھ سکتا ہے؛ غلطیوں کو سیکھنے کے مواقع کے طور پر دیکھنے میں تیز؛
- اعلیٰ درجے کی زبانی صلاحیتیں - ابتدائی / نفیس اظہاری زبان کی نشوونما، نفیس ذخیرہ الفاظ اور / یا پیچیدہ جملے (اگرچہ کچھ باصلاحیت بچے دراصل معمول سے بعد میں بولنا شروع کرتے ہیں، پھر تیزی سے ترقی کرتے ہیں)؛ اعلیٰ و صولی زبان جو مشاہدہ کی جا سکتی ہے (تصورات، ذخیرہ الفاظ، ہدایات اور سوالات کو سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیت)؛

- غیر معمولی یادداشت - یعنی مختصر نمائش کے بعد معلومات برقرار رکھ سکتا ہے؛ ابتدائی زندگی کے واقعات کو مکمل تفصیل سے یاد کر سکتا ہے؛ غیر معمولی ارتکاز یا توجہ کا دورانیہ - دلچسپی ہونے پر طویل توجہ کا دورانیہ؛ باصلاحیت کے اعلیٰ درجوں کے بچے ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیز پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں؛
- استقامت یا تحریک - یعنی زیادہ مقصد کی سمت اور تکمیل تک ثابت قدمی، سیکھنے کی بھوک؛
- وسیع دلچسپیاں اور علم - دلچسپیاں شدید اور چھوٹے بچوں کے لیے متوقع سے باہر ہو سکتی ہیں؛
- بڑے ساتھیوں کو ترجیح - عمر کے ساتھیوں کے بجائے بڑے بچوں / بالغوں کو ترجیح دیتا ہے، جو اعلیٰ زبان کے درجوں، کھیل میں پیچیدگی کی ترجیحات، دوستی کے پختہ نظریات کی عکاسی کر سکتا ہے؛
- گہرا مشاہدہ - تفصیل پر نظر؛ لطیف تبدیلیوں کو نوٹ کرتا ہے؛
- مقداری صلاحیت اور دلچسپیاں - اعداد میں دلچسپی اور مہارت؛ وقت، کیلکولیٹر، پیسے میں زیادہ دلچسپی؛
- غیر معمولی مقامی صلاحیت - پزلوں، نقشوں، خاکوں میں دلچسپی اور مہارت؛ جگہ اور سمت کا اعلیٰ حس؛
- علامتی نمائندگی کا ابتدائی استعمال - ابتدائی یا نفیس ڈرائنگ یا تحریر (باریک موٹر نشوونما پر منحصر)۔

باصلاحیت کے ممکنہ اشارے

- ابتدائی نشوونما - یعنی دیگر بچوں سے پہلے بیٹھنا اور چلنا شروع کرتا ہے؛ دیگر بچوں سے پہلے بولنا، پڑھنا، لکھنا یا اعداد استعمال کرنا شروع کرتا ہے؛
- شدید تجسس - شدید تجسس / دیگر بچوں سے گہرا علم ظاہر کرتا ہے؛ یعنی جاننے / تلاش کرنے کی ناقابل تسکین ضرورت؛
- مزاج کی وسیع رینج - یعنی کمال پسندی (خاص طور پر دلچسپی کے شعبے میں درستگی کی فکر)، حساسیت (آسانی سے دل دکھتا ہے، ہمدرد)، شدت، اخلاقی یا سماجی مسائل کی فکر؛
- اکثر تخیل اور تخلیقی صلاحیت ظاہر کرتا ہے - یعنی وہ چیزیں نہ کرنے کے لیے تخیلاتی طریقے تلاش کرتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا؛
- مزاح کا اعلیٰ حس رکھتا ہے - تقریر، سماجی تعاملات، فن یا کہانی سننے میں مزاحیہ ہے؛ لطیف، چٹکے بناتا ہے، یا الفاظ سے کھیلتا ہے (Kerry Hodge, 2013)۔

شناخت کے لیے آلہ

- والدین کے تبصرے / آراء - خاص طور پر باصلاحیت اور ذہین طلبہ کی ابتدائی شناخت میں۔
- آئی کیو ٹیسٹ (زبانی اور غیر زبانی)۔

- معیاری ٹیسٹ۔
 - اسکول کے ریکارڈ، کامیابی کے ٹیسٹ (مثلاً پڑھنا، ریاضی)۔
 - قصہ گو ریکارڈ۔ انٹرویو (والدین/بچہ/کیونٹی کے ارکان/پچھلے استاد/اسکول ماہر نفسیات)۔
 - شناختی چیک لسٹیں۔
 - درجہ بندی کے پیمانے۔
 - مترجم، ترجمان (ثقافتی اور لسانی طور پر متنوع پس منظر کے طلبہ کے لیے)۔
- تحفہ ترقیاتی عمل کے ذریعے ہنر میں تیار کیے جاتے ہیں۔ تحفوں کو ہنر میں پرورش اور تیار کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ ترقیاتی عمل کے چھ اہم عناصر ہیں:

1. افزودہ نصاب یا تربیتی پروگرام
 2. ایک واضح اور چیلنجنگ عمدگی کا ہدف
 3. منتخب رسائی کے معیار
 4. منظم اور باقاعدہ مشق
 5. پیش رفت کا باقاعدہ اور معروضی جائزہ
 6. ذاتی تیز رفتار (personalized accelerated pacing) (Gagné, 2008)۔
- باصلاحیت اور ذہین طلبہ اپنی صلاحیتوں کی نوعیت اور درجے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں؛ باصلاحیت اور ذہین طلبہ کا کوئی واحد ہم جنس گروہ نہیں ہے۔ باصلاحیت اور ذہین طلبہ:
- صلاحیتوں اور استعداد میں مختلف ہوتے ہیں - وہ ایک ہی شعبے میں یا مختلف شعبوں میں تحفے اور ہنر ظاہر کر سکتے ہیں؛ انہیں معذوری بھی ہو سکتی ہے
 - اپنے باصلاحیت کے درجے میں مختلف ہوتے ہیں - اس کا مطلب ہے کہ دو طلبہ جن کے پاس ایک ہی شعبے میں تحفے ہیں ان کی اس شعبے میں صلاحیتیں ضروری طور پر ایک جیسی نہیں ہوں گی
 - کامیابی میں مختلف ہوتے ہیں - اگرچہ تحفے رکھنا اکثر اعلیٰ کامیابی سے وابستہ ہے، کامیابی اعلیٰ صلاحیت والے طلبہ میں اور وقت کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے، اور کچھ باصلاحیت طلبہ کم کارکردگی دکھاتے ہیں اور اپنے تحفوں کو ہنر میں بدلنے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں

• ہمیشہ نظر آنے والے اور شناخت میں آسان نہیں ہوتے، اور ان کی نظر آنے کی صلاحیت ثقافتی اور لسانی پس منظر، جنس، زبان اور سیکھنے کی مشکلات، سماجی و معاشی حالات، مقام، اور ایسے نصاب میں عدم مشغولیت سے متاثر ہو سکتی ہے جو ان کی صلاحیتوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مزاج، شخصیت، تحریک اور رویے میں ذاتی خصوصیات کی تقریباً لا محدود رینج ظاہر کرتے ہیں۔ باصلاحیت افراد میں ہنر کا کوئی معیاری نمونہ موجود نہیں۔

شناخت - ہم بالکل کس کی شناخت کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کیسے تلاش کرنا چاہیے؟

- اسکولوں کو باصلاحیت اور ہنر کی اپنی تعریفیں بنانے، ڈھالنے یا اپنانے میں درج ذیل اصولوں پر غور کرنا چاہیے۔ اسکول پر بنی تعریف کو ضرورت ہے:
- کارکردگی اور صلاحیت دونوں کو تسلیم کرے؛
- تسلیم کرے کہ باصلاحیت اور ذہین طلبہ اپنی ہی عمر، ثقافت یا حالات کے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں غیر معمولیت ظاہر کرتے ہیں؛
- ایک کثیر زمرہ جاتی طریقہ کار کی عکاسی کرے جس میں خصوصی صلاحیتوں کی ایک صف شامل ہو؛
- کثیر الثقافتی اقدار، عقائد، رویوں اور رسم و رواج کو تسلیم کرے؛
- باصلاحیت اور ذہین طلبہ کے لیے مختلف تعلیمی مواقع فراہم کرے، بشمول سماجی اور جذباتی حمایت؛
- تسلیم کرے کہ باصلاحیت تمام سماجی گروہوں میں ثبوت رکھتی ہے، قطع نظر ثقافت، نسل، سماجی و معاشی حیثیت، جنس، یا معذوری (سیکھنے، جسمانی، یا رویہ جاتی)؛ اور
- تسلیم کرے کہ کوئی طالب علم ایک یا زیادہ شعبوں میں باصلاحیت ہو سکتا ہے۔ (Riley, Bevan)

(Brown, Bicknell, Carroll-Lind & Kearney, 2004, p.15)

5.2.3 گانے کا باصلاحیت کا ماڈل

گانے نے ایک ترقیاتی نظریہ ڈیزائن کیا ہے جس کا عنوان باصلاحیت اور ہنر کا متمایز ماڈل (Differentiated Model of Giftedness and Talent - DMGT) ہے (Gagne, 1985)۔ 1991, 1995, 1997, 2000, 2003, 2009) جس کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ کسی بھی شعبے میں "عمدگی" کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مضمون اس کے ماڈل کے اجزاء کو بیان کرتا ہے اور ان کے درمیان تعامل پر بھی بحث کرتا ہے۔ گانے کا بنیادی مفروضہ "نمایاں فطری صلاحیتوں" جنہیں وہ "استعداد" (aptitudes) کی اصطلاح دیتا ہے اور "مخصوص ماہر مہارتوں" جنہیں وہ "اہلیتیں" (competencies) کہتا ہے کے درمیان فرق کرنا ہے۔ اس کا ماڈل ان بنیادی تعمیری بلاکس کے اس عمل کو بیان کرنے پر مرکوز ہے جس سے وہ

گزرتے ہیں جب وہ منظم طریقے سے تیار شدہ صلاحیتوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر، وہ باصلاحیت کو خام استعداد اور ہنر کو تیار شدہ صلاحیت کے طور پر ممتاز کرتا ہے۔

یہ فرق اسکولوں کے لیے کچھ اہم مضمرات پیدا کرتا ہے جب وہ اپنے باصلاحیت اور ذہین طلبہ کی تعلیم کے لیے پالیسیاں اور طریقے ڈیزائن اور نافذ کرنے کے لیے درکار سمجھ بوجھ سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔

شیرون مینسفیلڈ (Sharon Mansfield) کا مضمون، TEACHERS AS TRANSFORMERS: WITHIN THE DIFFERENTIATED MODEL OF GIFTEDNESS AND TALENT اس حوالے سے مرکزی اہمیت کے مسائل پر بحث کرتا ہے، یعنی:

1. شناخت - ہم بالکل کس کی شناخت کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کیسے تلاش کرنا چاہیے؟
2. ہم باصلاحیت اور ذہین سیکھنے والوں کے تمام ذیلی گروہوں کے لیے مناسب طریقوں سے کیسے جواب دے سکتے ہیں؟
3. مساوات بمقابلہ عمدگی کی بحث - باصلاحیت تعلیم کے اہداف کیا ہیں؟ ان کی تکمیل کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں؟

اگرچہ شیرون مینسفیلڈ نیوزی لینڈ کے سیاق میں ماڈل پر بحث کرتی ہیں، لیکن اگر اس سے گزرا جائے تو اسے پاکستانی سیاق کے لیے بھی تجزیاتی طور پر حوالہ بنایا جاسکتا ہے۔

باصلاحیت اور ہنر کا متمایز ماڈل

باصلاحیت اور ہنر کا متمایز ماڈل (DMGT) چھ اجزاء پر مشتمل ہے، ہر ایک کو ایک شناختی مخفف دیا گیا ہے۔ جیسا کہ نیچے دیے گئے خاکے میں بیان کیا گیا ہے، (Gagne, 2009) اجزاء فطری صلاحیتوں یا تحفوں (G) سے اہلیتوں یا ہنر (T) تک کی پیش رفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پیش رفت ترقیاتی عمل (D) کے ذریعے سہولت پاتی ہے، جس کی یا تو مدد کی جاتی ہے یا رکاوٹ ڈالی جاتی ہے ان عوامل سے جنہیں گائیڈ اپریٹرک (catalysts) کے طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ انہیں ماحولیاتی (E) یا اندرونی ذاتی (I) میں گروہ بند کرتا ہے اور موقع (chance) کے جزو (C) کو بھی ایک ایسے عنصر کے طور پر شامل کرتا ہے جو ماڈل کے تمام معاون اجزاء پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ ماڈل وہ ہے جسے مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے جس میں نیچے دیا گیا خاکہ تازہ ترین ورژن ہے۔

GIFTEDNESS designates the possession and use of outstanding natural abilities, called aptitudes, in at least one ability domain, to a degree that places an individual at least among the top 10% of age peers

TALENT designates the outstanding mastery of systematically developed abilities, called competencies (knowledge and skills), in at least one field of human activity to a degree that places an individual at least among the top 10% of age peers who are or have been active in that field

(Gagne, 2009)

عمل (D)، جو یا تو اہلکاروں کی مدد یا رکاوٹ سے گزرتا ہے۔ وہ انہیں ماحولیاتی (E) یا اندرونی ذاتی (I) میں گروہ بند کرتا ہے اور موقع کے جزو (C) کو بھی ایک ایسے عنصر کے طور پر شامل کرتا ہے جو ماڈل کے تمام معاون اجزاء پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ ماڈل وہ ہے جسے مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے جس میں نیچے دیا گیا خاکہ تازہ ترین ورژن ہے۔

گانیہ (1995) نے "تعریفوں کی بہتات" کو نوٹ کیا اور اس پر بحث کی جس میں باصلاحیت اور ذہین کی اصطلاحات کے معنی پر بہت کم اتفاق تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ باصلاحیت اور ذہین بالکل کیا ہے اس پر ابہام باصلاحیت طلبہ کی خصوصی تعلیمی ضروریات کو آگے بڑھانے میں مددگار نہیں تھا۔ گانیہ نے تجویز کیا کہ دونوں اصطلاحات اکثر مترادف استعمال ہونے کے باوجود، ایک واضح اور مناسب فرق فائدہ مند طور پر کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ دونوں اصطلاحات انسانی صلاحیت کے اوسط سے اوپر کے درجے کو تعریف کرتی ہیں، اس نے دیکھا کہ ترقیاتی عمل کے آغاز اور اختتامی نکات کا حساب رکھنے کے لیے ایک مفید تمیز لگائی جا سکتی ہے جس سے انسانی صلاحیتیں گزرتی ہیں جب وہ بنیادی صلاحیت سے منظم طریقے سے تیار شدہ مہارتوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان فطری صلاحیتوں کی جینیاتی اصل کو تسلیم کرتے ہوئے، گانیہ نے اس اثر کو بھی تسلیم کیا جو ماحولیاتی تحریک، روزانہ استعمال نیز غیر رسمی اور رسمی تربیت ان کی نشوونما پر رکھتی ہے (Gagne, 1995)۔

باصلاحیت اور ہنر کا متمایز ماڈل

Gagne, 2009

اس نے ابتدائی طور پر چار "دائروں" (domains) کی شناخت کی، یعنی ذہنی، جسمانی، تخلیقی صلاحیت اور سماجی-جذباتی صلاحیتیں، بطور صلاحیت کے الگ شعبے جو ابتدائی عمر میں مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، معمول سے اتنی بڑی تفاوت کے ساتھ کہ کسی بھی بیرونی تدریس کی صورت سے اس کا حساب نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ بعد کے سالوں میں گانیہ نے اپنا ماڈل بہتر بنانا جاری رکھا ہے اور اب ایک اور اکی دائرہ شامل کرتا ہے، ساتھ ہی جسمانی دائرے میں تقسیم تاکہ عضلاتی اور موٹر کنٹرول سہولتوں میں فرق کیا جا سکے۔ اس نے تسلیم کیا کہ فطری صلاحیت کے شعبوں کے ساتھ جینیاتی طور پر طے شدہ مزاجی رجحانات یا شخصیتی خصوصیات تھیں

جیسے قوت ارادی، لچک اور اخلاقی رویہ اور کہ یہ، ماحولیاتی عوامل کے ساتھ، یعنی وہ جگہیں، لوگ اور تعلیمی عمل جن کا طالب علم سامنا کرتا ہے، مہارتوں کی نشوونما پر اثر ڈالیں گے۔

گانیہ غیر تیار شدہ فطری صلاحیتوں کو منظم طریقے سے تیار شدہ مہارتوں کے "اجزائی عناصر" سمجھتا ہے اور اس طرح ہنر کو ان مہارتوں کے طور پر تعریف کرتا ہے جو تیار ہوتی ہیں جب ان "تعمیراتی بلاکس" کو کسی خاص سیاق یا شعبے پر لگایا جاتا ہے (Gagne, 1995)۔

باصلاحیت اور ہنر کے تصور کو اس عینک سے دیکھنے کا ایک بہت اہم نتیجہ جو گانیہ پیش کرتا ہے وہ یہ مضمہ ہے کہ کوئی بچہ، فطری طور پر اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے کی وجہ سے، بہت ابتدائی عمر سے باصلاحیت کے طور پر پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ پختہ ہوتا ہے یہ صلاحیتیں نشوونما پائیں گی تاہم ایسی نشوونما کا رخ اس بات پر منحصر ہے کہ گانیہ اپنے ماڈل میں جنہیں "اوپریک" کے طور پر بیان کرتا ہے ان کا اثر، یعنی ماحولیاتی اور اندرونی ذاتی عوامل کے اثرات۔ وہ موقع کے عنصر کو بھی ترقیاتی عمل کے حتمی کامیاب یا بصورت دیگر نتیجے میں بااثر کے طور پر شامل کرتا ہے۔ کامیاب ترقیاتی عمل کا نتیجہ ان بنیادی صلاحیتوں کا غیر معمولی اہلیتوں یا ہنر میں پختہ ہونا ہے۔ اس طرح، کسی شخص کو باصلاحیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ اجاگر کیا جائے کہ اس میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں اور، جب وہ ان صلاحیتوں کو موافق طریقے سے تیار کر لے تو اسے باصلاحیت اور ذہین بیان کیا جا سکتا ہے، تاہم ذہین کے طور پر بیان کیے جانے کا لازمی طور پر باصلاحیت کو پیشگی شرط کے طور پر مضمہ ہے۔ ایک مزید مضمہ اس لیے یہ ہے کہ جبکہ ایسا بچہ ہمیشہ (غیر معمولی حادثے کو چھوڑ کر) باصلاحیت رہے گا، صرف جب کارکردگی کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے تو اسے ذہین بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ یہ ہمارے اسکولوں میں، اور زندگی میں، باصلاحیت کم کارکردگی کے عام مظہر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہمیں اسے سمجھنے اور اس طرح اس کا ازالہ کرنے کی سمت میں شروع کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے (Gagne, 2000)۔ یہ اس اہم سمجھ کی حمایت کرتا ہے کہ اگر، ناموافق اوپریک حالات کے ذریعے، بچے کی صلاحیتیں ہنر میں ظاہر ہونے میں ناکام رہیں، تو ان کے باصلاحیت کے بنیادی اجزاء غائب نہیں ہوتے اور اس لیے ان کی خصوصی تعلیمی ضروریات بھی نہیں؛ درحقیقت، انہیں مداخلت اور حمایت کی اور بھی زیادہ ضرورت ہونے کا امکان ہے۔

گانیہ کا باصلاحیت اور ہنر کا متمایز ماڈل اس اصول پر مبنی ہے کہ باصلاحیت فطری صلاحیتوں کی وضاحت کرتی ہے جو فرد کو اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں صلاحیت کی حد کے اوپر 10% میں رکھتی ہیں، جو پھر، اگر ترقیاتی عمل کے اندر بہترین حالات سے ملے تو، ہنر یا اہلیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو دوبارہ کارکردگی کے اوپر 10% میں رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ ماڈل اوپریاں کردہ پہلے دو اصولوں کو اچھی طرح پورا کرتا ہے۔

گانیہ کا ماڈل تصور کو وسعت دینے کی حمایت میں ایک مؤثر آلہ ہے جو تاریخی طور پر تنگ باصلاحیت کی پہچان سے بطور تعلیمی صلاحیت کی پیمائش، اس طرف جہاں فطری صلاحیت کے چھ الگ دائروں میں سے کسی میں

بھی غیر معمولی صلاحیتیں تسلیم کی جاتی ہیں، اور جہاں شناخت ان افراد کی طرف ہدف بنائی جاتی ہے جو استعداد یا فطری صلاحیتیں ظاہر کرتے ہیں، نیز وہ جنہوں نے انسانی سرگرمی کے کسی خاص شعبے میں مہارتیں تیار کی ہیں۔ باصلاحیت اور ذہین طلبہ کو متمایز پروگرام فراہم کیے جانے کی ضرورت کو بھی اسی طرح ایک ماحولیاتی اہپریرک عنصر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے جو تحفوں کے ہنرمیں تبدیلی کے عمل کی کامیابی یا بصورت دیگر پر اثر ڈالے گا۔

جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ باصلاحیت اور ہنر کا دائرہ صرف ذہنی استعداد سے کہیں وسیع رینج میں ہے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان اقسام کے اندر افراد کی شناخت کے لیے استعمال کیے گئے طریقے بھی اسی طرح وسیع رینج کے ہونے چاہئیں۔ مختلف پیمائشیں مختلف قدر کی معلومات دیں گی اس پر منحصر کہ بالکل وہ کیا ہے جس کا اندازہ لگانا مقصود ہے۔ باصلاحیت اور ہنر کے درمیان تمیز کے اپنے ماڈل کے مطابق، گانیے نے فطری صلاحیت یا باصلاحیت کے درجوں کا تعین کرنے کے لیے دستیاب تشخیص کی مختلف اقسام، اور ہنر کے شعبوں کے لیے نوٹ کیا، اگرچہ وہ نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ استعدادیں دوسروں سے زیادہ آسانی سے پائی جاتی ہیں (Gagne 1995)۔

شناختی عمل میں اس سوچ کو اپنانے سے حاصل کیا جانے والا ایک فائدہ اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے والے تعلیمی طلبہ کی شناخت کے عام لیکن کچھ حد تک سطحی عمل سے بچنا ہے جنہوں نے کامیابی سے تربیت اور مشق کے منظم پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ان باصلاحیت طلبہ کا حساب نہ رکھنا جو گانیے کے ماڈل کے کسی بھی اہپریرک پہلو کے ساتھ پروگرام میں تبدیلیوں اور/یا اضافی حمایت کی ضرورت میں ہیں تاکہ اپنی صلاحیت تک پہنچ سکیں۔ درحقیقت گانیے نے سابق گروہ کے طلبہ کو اپنا ایک مخفف دے دیا ہے - IGAT - جیسا کہ ذہنی طور پر باصلاحیت اور تعلیمی طور پر ذہین (intellectually gifted and academically talented) - اور خود نشاندہی کرتا ہے کہ یہ گروہ وہ ہے جسے موجودہ باصلاحیت اور ذہین تعلیمی فراہمیوں سے اکثر اور سب سے زیادہ ہدف بنایا جاتا ہے (Gagne, 1995)۔

اس سیکشن میں دیے گئے تین سوالات کو شیرون مینسفیلڈ نے نیوزی لینڈ کے تناظر میں حل کیا تھا، جو درج ذیل ہے:

ہم باصلاحیت اور ذہین سیکھنے والوں کے تمام ذیلی گروہوں کے لیے مناسب طریقوں سے کیسے جواب دے سکتے ہیں؟

باصلاحیت اور ذہین سیکھنے والے، عمومی طور پر ایک گروہ کے طور پر، متمایز تعلیمی مواقع کا تقاضا کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں بھی IGAT طلبہ کو فراہم کیا جانا عام ہے، لیکن اس میدان سے باہر جن کے تحفے اور ہنر ہیں انہیں کم۔ نیز اقلیتی گروہوں کی شناخت کا امکان کم ہے اور نتیجتاً انہیں مناسب پروگرام فراہم کیے جاتے

ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسکولوں کے لیے اصول کہ "تسلیم کرے کہ باصلاحیت تمام سماجی گروہوں میں ثبوت رکھتی ہے، قطع نظر ثقافت، نسل، سماجی و معاشی حیثیت، جنس، یا معذوری (سیکھنے، جسمانی، یا رویہ جاتی)" وہ ہے جس کا حساب جو بھی پروگرام نافذ کیا جائے اس کے اندر رکھا جانا چاہیے۔ (Riley, Bevan)

(Brown, Bicknell, Carroll-Lind & Kearney, 2004, pg. 10)

باصلاحیت اور ہنر کا متمایز ماڈل ان معیاروں کو پورا کرنے کے لیے ایک مناسب راستہ فراہم کرتا ہے۔

سب سے پہلے، یہ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں مدد کرتا ہے کہ باصلاحیت بچوں میں بنیادی خصوصیات پائی جائیں گی؛ یعنی وہ جو گائیڈ کے بیان کردہ فطری صلاحیتوں کے گروڈھ ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کم از کم جزوی طور پر جینیاتی طور پر عطا شدہ ہیں۔ یہ خصوصیات بہت ابتدائی عمر سے مشاہدہ کی جا سکتی ہیں اور بچے کو جن تمام سیکھنے کی حالتوں کا سامنا ہوتا ہے ان میں دیکھی جا سکتی ہیں، مثلاً جہاں بچہ نیا مواد سیکھتا ہے اور اپنے ہم عمر بچوں سے بہت تیزی سے مہارتوں میں مہارت حاصل کرتا ہے (Gagne, 2000)۔

تاہم یہاں سے، سفر کیے گئے راستے نمایاں طور پر متنوع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اظہار ک عوامل افراد کے ترقیاتی رخ کو متاثر کرتے ہیں۔ نیز فطری صلاحیتوں کے ملتے جلتے سیٹ والے بچے مختلف سمتوں کی پیروی کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنے تحفوں کو ممکنہ سمتوں کی وسیع رینج میں سے کسی کے حصول میں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک عنصر پر غور کرنا اور یہ کہ اسکول کس طرح زیادہ سے زیادہ فوائد اور/یا ان میں سے ہر ایک کے ذریعے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں، نمایاں ہو جاتا ہے۔ کچھ یقیناً دوسروں سے بہت زیادہ ترمیم کے لیے کھلے ہیں، تاہم زیادہ تر کو پروفائلنگ مشق کے حصے کے طور پر نوٹ کیا جا سکتا ہے اور مناسب پروگرامنگ پر غور کرتے وقت حساب میں رکھا جا سکتا ہے (Gagne, 1995)۔

گائیڈ نے "کیا فرق ڈالتا ہے؟" (Gagne, 2003) کا جواب دینے کی کوشش میں ہر جزو کی نسبتی اہمیت کو ترجیح دینے پر کام کیا ہے۔ دوبارہ، اس نے سببی اثرات کی اس درجہ بندی کو ہجے کرنے کے لیے ایک مخفف وضع کیا ہے - C.GIPE جو موقع (chance) کو سب سے اوپر اور ماحولیاتی اظہار کو نچلے درجے پر رکھتا ہے۔ وہ اہمیت جو وہ موقع پر رکھتا ہے دلچسپ ہے جب ہم غور کرتے ہیں کہ موقع وہ عنصر ہے جس پر، اپنی فطرت کے لحاظ سے، ہمارا بہت کم کنٹرول ہے۔ گائیڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہنر کی نشوونما کے عمل کے ہر دوسرے پہلو پر موقع کا نمایاں اثر ہے، ہماری زندگی کے دو سب سے نمایاں معاون عوامل میں موقع کے کردار کی وجہ سے؛ سب سے پہلے، ہماری جینیاتی ساخت کی بے ترتیب تقویض اور دوسرے، وہ خاندانی اور سماجی پس منظر جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں (Atkinson, 1978)۔

اہمیت کی درجہ بندی کو، تاہم، ان عوامل کی شناخت کے لحاظ سے مفید طور پر دیکھا جا سکتا ہے جن پر ہمارا اثر ہے اور جہاں بطور معلمین ہماری کوششیں بہترین ہدف بنائی جا سکتی ہیں تاکہ ہنر کی نشوونما کے عمل کو سب سے مؤثر طریقے سے سہولت دی جا سکے۔ جبکہ ہمارا بچے کو جینیاتی ساخت، یا ان کے خاندانی اور سماجی پس منظر کے لحاظ سے دیے گئے کارڈوں پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، ہم اس اعزازی پوزیشن میں ہیں کہ بہت سے سببی عوامل کی مثبت نشوونما کو سہولت دے سکیں۔ اور جبکہ ہم گانے کے ماڈل میں بیان کردہ فطری صلاحیتوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے، ہم یقینی بنا سکتے ہیں کہ بچے کی تعلیم میں ابتدائی طور پر ان کی شناخت کے لیے کیا تلاش کرنا ہے، تاکہ انہیں کھلنے کا دائرہ اور حوصلہ افزائی دی جا سکے۔ اپنی باصلاحیت اور ذہین پالیسیوں اور پروگراموں کو ڈیزائن کرتے وقت، ہم آگاہ ہو سکتے ہیں اور یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم باصلاحیت بچوں کی خصوصیات کو ذہین بچوں کی خصوصیات سے درست طور پر ممتاز کر رہے ہیں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ گانے کے ماڈل میں ہماری جگہ ایک ماحولیاتی اتریرک کی ہے، اور اس طرح ہم بچے کی فطری صلاحیتوں پر مثبت یا منفی اثر ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں جب انہیں "پروسیس" کیا جا رہا ہے۔

مثال کے طور پر، ہم بچے کی رواں استدلال کی صلاحیت کی نشوونما کو اس عمل کی مشق کی اجازت دے کر اور سیکھنے کے عمل میں اس کی جگہ کی توثیق کر کے متاثر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ زیادہ ترتیب وار اور منظم استدلال سے متصادم معلوم ہو۔ ہم زبانی مہارتوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ضرورت سے زیادہ اور قابل قبول "معیاروں" سے آگے معلوم ہوں۔ ہم تخیل اور اختراع کے شعبوں میں اعلیٰ صلاحیت کی قدر کر سکتے ہیں اور ان کے اطلاق اور نشوونما کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ تمام اہم لیکن زیادہ تر بے قابو موقع کے عنصر کے ساتھ، ہم اندرونی ذاتی عوامل جیسے خود مختاری، جذبہ، استقامت اور لچک کی نشوونما کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، تاکہ بچہ بہترین پوزیشن میں ہو کہ جب موقع آئے تو اسے پہچان سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے (Austin, 1978)۔

مساوات بمقابلہ عمدگی کی بحث - باصلاحیت تعلیم کے اہداف کیا ہیں؟ ان کی تکمیل کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں؟

نیوزی لینڈ کے اندر، جیسا کہ بین الاقوامی طور پر ہے، باصلاحیت تعلیم کو اس کے ضرورت کے دعوؤں میں کوئی درست جوہر رکھنے والے شعبے کے طور پر تسلیم کیے جانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ باصلاحیت طلبہ کی تعلیم کو زیادہ تر کم ترجیح کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو اس عقیدے سے غذا پاتی ہے کہ باصلاحیت اور ذہین طلبہ وہ کریم ہیں جنہیں پہلے سے فائدہ حاصل ہے، اور اس لیے باصلاحیت اور ذہین پروگراموں کو "اضافی" کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ عیش و عشرت کی اشیاء جو بجٹ میں کٹوتی کی ضرورت پر ہمیشہ سب سے پہلے جاتی ہیں۔

اس دلیل کے دو عام طور پر استعمال شدہ جواب ہیں، پہلا یہ کہ تمام طلبہ ایسی تعلیم کے مستحق ہیں جو انہیں مشغول کرے اور چیلنج کرے؛ وہ ذاتی عمدگی سیکھنے اور حاصل کرنے، اپنی صلاحیتوں اور ہنر کو تسلیم اور توثیق کرنے اور ان کی سیکھنے کی ضروریات کو پورا کرنے کے مستحق ہیں (MOE, 2007)۔ طلبہ کے ایک گروہ سے ضروری تعلیمی تبدیلیوں کو صرف اس لیے روکنا کہ ان کی صلاحیتیں اور ہنر انہیں زیادہ تر دیگر طلبہ سے اعلیٰ درجے پر رکھتے ہیں، ان سے توقع کرنا کہ وہ ایسے ماحول میں بوسیدہ ہو جائیں جو بہت کم مثبت تحریک فراہم کرتا ہے اور پھر بھی متحرک رہیں، اور ان سے توقع کرنا کہ وہ نامناسب نصاب کے باوجود کامیابی حاصل کریں، مختصر، غیر منصفانہ ہے۔

دوسرا تقاضا زیادہ معاشی پوزیشن سے آتا ہے۔ وہ جو باصلاحیت اور ذہین طلبہ کے لیے وسائل کی فراہمی کو قومی مستقبل میں سرمایہ کاری سمجھتا ہے، اور سب کے حتیٰ فائدے کے لیے نتیجے کے طور پر عمدگی کے حصول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

نیوزی لینڈ کی حکومت نے حالیہ سالوں میں باصلاحیت تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے اور اس کی اہمیت کے لیے اپنے استدلال میں مساوات اور عمدگی دونوں کو درست تسلیم کیا ہے (MOE, 2004)۔ تاہم، حالیہ تحقیق (Riley et al, 2004, ERO, 2008) نے ظاہر کیا ہے کہ جبکہ کچھ اسکولوں نے پالیسیاں اور طریقے ڈیزائن اور نافذ کرنے میں بہترین پیش رفت کی ہے، باصلاحیت اور ذہین طلبہ کی فراہمی میں اب بھی بڑے خلا ہیں، خاص طور پر پیشہ ورانہ نشوونما، حمایت اور اسکولوں کے لیے وسائل کی کمی، اور باصلاحیت اور ذہین طلبہ کے کم نمائندہ ذیلی گروہوں کی شمولیت کی کمی کے حوالے سے۔ باصلاحیت اور ہنر کی اقسام کی ایک رینج جن میں طلبہ کی شناخت اور فراہمی کی جاتی ہے اکثر نظر انداز کی جاتی ہے، مثلاً ثقافتی، روحانی اور جذباتی باصلاحیت، نیز باصلاحیت اور ذہین طلبہ کی سماجی اور جذباتی ضروریات (Riley et al, 2004)۔

تو گانیے کا باصلاحیت اور ہنر کا متمایز ماڈل اس موجودہ صورت حال میں کیسے بیٹھتا ہے؟

سب سے پہلے جیسا کہ پہلے کہا گیا، گانیے نے اپنا کام کسی بھی شعبے میں عمدگی کیسے پیدا ہوتی ہے کے ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس لیے، اگر ہمارا مقصد ایسے طلبہ پیدا کرنا ہے جو کسی بھی دیے گئے کیریئر میں اعلیٰ کارکردگی کے قابل ہوں، تو یہ ماڈل ہمیں تمام اجزاء بیان کرتا ہے جن کا ہمیں اس کے حصول میں حساب رکھنا ہے۔

گانیے (1995) نے "باصلاحیت تعلیم" کے عنوان کو درحقیقت غلط نام قرار دیا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایسے پروگراموں کا مقصد عام طور پر ان فطری صلاحیتوں کی نشوونما نہیں ہوتی جو باصلاحیت بچے اپنے رسمی تعلیمی عمل کے آغاز میں رکھتے ہیں۔ وہ اپنے ماڈل کے اندر تعریفوں کے لحاظ سے، موجودہ پروگراموں کے عام اہداف کے زیادہ درست وضاحت کنندہ کے طور پر "ہنر کی نشوونما" تجویز کرتا ہے۔

یہ یقیناً نیوزی لینڈ کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ باصلاحیت تعلیمی اقدامات کے اندر کچھ مخصوص ہنر عام طور پر ہدف بنائے جاتے ہیں، اور صلاحیت کے یہ شعبے دائرے میں محدود ہیں (MOE 2004)۔ اگر ہم صلاحیتوں کی وسیع رینج پر توجہ دیں جو DMGT میں اجاگر کی گئی ہیں، تو ہم باصلاحیت اور ذہین بچوں کی زیادہ تعداد کی شناخت اور فراہمی میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔

دوسرے، ہم باصلاحیت اور ذہین تعلیمی پروگراموں کے مقصد کے طور پر منصفانہ نتائج کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تجویز کہ ہنر کی نشوونما موجودہ پروگراموں کی زیادہ درست وضاحت ہو سکتی ہے یہ بھی مضمر کرتی ہے کہ عمدگی مقصد ہے۔ تاہم اگر ہم کامیاب نتائج کی قدر پر مساوی زور رکھیں جو زیادہ انفرادی اور ذاتی نقطہ نظر سے پرکھے گئے ہوں، تو ہمیں اپنی توجہ گائیڈ کی اہلیتوں سے حتمی نتیجے کے طور پر اور معاشرے کو حاصل موروٹی فائدے سے ہٹا کر، اور اسے آغاز کے نقطے سے نشوونما کی ضرورت کے ساتھ متوازن کرنا چاہیے۔ فطری صلاحیتیں۔ اس طرح، فراہمی میں شناخت شدہ خلا - صلاحیتوں کی تنگ رینج اور نیز باصلاحیت طلبہ کی خصوصی سماجی اور جذباتی ضروریات پر مناسب توجہ کی کمی - کو پورا کیا جاسکتا ہے۔ "تعمیراتی بلاکس" کی شناخت اور پھر ان پر اثر انداز ہونے والے ماحولیاتی اور بین شخصی عوامل کا حساب رکھنے میں، ہم بچے اور ان کی ضروریات کا زیادہ متوازن اور ہمہ گیر نظریہ بنا سکتے ہیں اور مناسب جواب دے سکتے ہیں۔ عمدگی کا مقصد مسترد نہیں کیا جاتا لیکن اس کا حصول باصلاحیت طلبہ کی وسیع رینج کے لیے زیادہ ممکن ہو جاتا ہے جس کے نتائج ان کے لیے ذاتی طور پر اور معاشرے کے لیے بھی بہتر ہوں۔

خلاصہ

گائیڈ کے باصلاحیت اور ہنر کے متمایز ماڈل میں فرق کا بڑا نکتہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ باصلاحیت اور ہنر کے تصورات کے درمیان ایک واضح فرق ہونا چاہیے اور ہے۔ یہ فرق وہ بنیاد ہے جس پر اس نے اس عمل کی وضاحت ڈیزائن کی ہے جس سے چھوٹے بچوں کے پاس موجود فطری صلاحیتیں یا تحفے اہلیتوں یا ہنر میں تبدیل ہوتے ہیں (یا نہیں)۔ یہ نیوزی لینڈ میں باصلاحیت اور ذہین تعلیم کے مطلوبہ اصولوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی فراہم کرتا ہے تاکہ کارکردگی (ہنر) اور صلاحیت (تحفے) دونوں کو تسلیم کیا جائے۔

گائیڈ کا DMGT واضح طور پر صلاحیت کے الگ دائروں اور ہنر کے شعبوں دونوں کو ممتاز کرتا ہے، اور باصلاحیت اور ذہین بچوں کو وہ بیان کرتا ہے جن کے تحفے یا ہنر انہیں اپنے ہم عمر بچوں کے صلاحیت کے لحاظ سے اوپر 10% میں رکھتے ہیں۔ اس کے ماڈل کا یہ پہلو نیوزی لینڈ کے اسکولوں کے لیے شرط کو پورا کرتا ہے کہ ان کی تعریفیں کثیر زمرہ جاتی ہوں اور ان بچوں کو تسلیم کریں جو اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں غیر معمولیت ظاہر کرتے ہیں۔

نیوزی لینڈ کے اندر اسکول پر بنی تعریفوں کے لیے کثیر الثقافتی اقدار، عقائد، رویوں اور رسم و رواج کو تسلیم کرنے کی شرط DMGT کے اندر پوری ہوتی ہے جس میں ثقافت خاص طور پر ماحولیاتی اہتپرک کے طور پر Mileu کے ذیلی عنوان کے تحت نوٹ کی گئی ہے، جس کے ذریعے اس کا، تمام دیگر اہتپرکوں کے ساتھ مشترکہ تعلق میں، ترقیاتی عمل پر براہ راست اثر ہوتا ہے، اور نتیجتاً نتیجہ خیز ہنر پر۔ اسی طرح، فراہمیاں پروگرامنگ کے اختیارات کی رینج کو بیان کرتی ہیں جو تحفوں کے ہنر میں کامیاب تبدیلی کے لیے ضروری ہیں، نیوزی لینڈ میں متمایز تعلیمی مواقع کی فراہمی کی شرط کی تسکین فراہم کرتی ہیں۔

گانیے نے ایک عام رجحان کی شناخت کی ہے جو نیوزی لینڈ کے سیاق میں تحقیق سے ثابت ہوا ہے، طلبہ کے ایک گروہ کی شناخت کی طرف جسے اس نے IGAT طلبہ (ذہنی طور پر باصلاحیت اور تعلیمی طور پر ذہین) کا نام دیا ہے۔ یہ اس طریقے میں "خلا" کو اجاگر کرتا ہے جس میں ہم اس وقت اپنے باصلاحیت اور ذہین طلبہ کی فراہمی کر رہے ہیں جسے DMGT اچھی طرح پورا کرنے کی پوزیشن میں ہے، سب سے پہلے فطری صلاحیتوں کی وسیع رینج کی ابتدائی شناخت فراہم کر کے اور پھر اہتپرک عوامل کی آگاہی اور مخصوص ہدف بندی جو ترقیاتی عمل کے ذریعے بہترین پیش رفت کے لیے درکار ہیں تاکہ ان صلاحیتوں کے اہلیتوں میں تبدیلی کو سہولت دی جاسکے۔

نیوزی لینڈ میں، باصلاحیت تعلیم بقا کے لیے ایک مشکل جنگ لڑتی ہے، اس کے باوجود کہ اس کے وجود کی حمایت میں بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ حالیہ تحقیق نے فراہمی میں ٹھوس خلا کو اجاگر کیا ہے اور ان کمیوں کی بہت سی وجوہات کی شناخت کی ہے۔ باصلاحیت اور ذہین سیکھنے والوں کی تعریف کے لیے رہنما ماڈل کے طور پر DMGT کا استعمال اور پھر ان کی ضروریات کا جواب اس طرح دینا جس سے کامیاب نتائج کے امکانات بڑھیں، یقیناً ایک قابل عمل حل ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے سادہ عمل نہیں ہے، لیکن پھر باصلاحیت اور ہنر کے تصور میں موجود تمام پیچیدگیوں کے ساتھ، کوئی توقع نہیں کرے گا کہ ایسا ہونا چاہیے! تاہم، یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ محققین کے پیش کردہ ہر رہنما اصول کے لیے، DMGT کے اندر سے ایک تسلی بخش طریقہ نکالا جاسکتا ہے جس سے اسے پورا کیا جاسکے۔ مزید برآں، DMGT کے اطلاق میں موجودہ فراہمی میں شناخت شدہ خلا کو دور کرنے کی صلاحیت ہے، اگر ضروری وسائل بشمول پیشہ ورانہ نشوونما اور حمایت کے ساتھ استعمال کیا جائے، تاکہ نیوزی لینڈ کے اساتذہ کو ہمارے باصلاحیت بچوں کے ترقیاتی عمل میں نمایاں مثبت اثرات کے طور پر اپنی جگہ لینے میں مدد ملے۔

5.3 تعلیمی مہارتوں، فعالی مہارتوں اور سماجی صلاحیتوں کے لیے تدریسی حکمت عملیاں

درج ذیل پیراگرافوں میں عمومی ہدایات دی گئی ہیں (ماخوذ از do2learn.com/CharacteristicsAndStrategies/DevelopmentalDelay_Strategies.html) ذہنی اور ترقیاتی تاخیر والے طلبہ کے اساتذہ کے لیے موثر تدریس کے لیے۔

جسمانی نشوونما

• جسمانی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اس وقت کے لیے کریں جب طالب علم میں سب سے زیادہ توانائی ہو۔

• سادہ، تفریحی رکاوٹ کورس فراہم کریں جنہیں طالب علم مکمل کرنے کے قابل ہو۔

• بچوں کے لیے ہاتھ سے پکڑے جانے والے آلات اور اشیاء استعمال کرنے کے روزانہ مواقع اور سرگرمیاں فراہم کریں۔

• باریک موٹر مہارتیں تیار کرنے کے لیے انگلیوں کے کھیل والے گانے استعمال کریں۔

• ایسا مواد استعمال کریں جیسے ڈرائنگ کاغذ کے نیچے نان سلپ میٹ، موٹے کریون، اور موٹے پنڈل والے پینٹ برش جو پکڑنے میں آسان ہوں۔

• بہت سی سرگرمیوں میں گانا اور رقص شامل کریں۔

• طالب علم کے ہاتھ میں اشیاء رکھیں تاکہ وہ پکڑے اور محسوس کرے۔

• طلبہ کو جھولنے اور مارنے کی مشق کرنے دیں۔

• کھاتے وقت، طالب علم کو گندگی کرنے دیں تاکہ کھلانے اور صفائی کی حرکات کی مشق کرے۔

• طلبہ کو بلاک، مٹی، کاغذ، پنسل، کریون، حفاظتی قینچی، پلے ڈو، اور جوڑ توڑ والی چیزیں استعمال کے لیے دیں۔

• روزانہ جسمانی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں، اور طلبہ کو باہر لے جا کر دوڑنے، چڑھنے اور کودنے دیں۔

• طلبہ کو بٹن لگانے اور کھولنے، کپڑوں کی زپ، اور دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی مشق کرائیں۔

• ایسی سرگرمیاں استعمال کریں جن میں کاٹنا، چکانا، ڈرائنگ اور لکھنا شامل ہو۔

• ڈرائنگ اور تحریر کے آلات کے ساتھ سرگرمیوں کا نمونہ بنائیں اور استعمال کریں۔

• کلاس روم میں بچوں کے سائز کی میزیں اور کرسیاں استعمال کریں۔

- فعال اور خاموش اوقات کے لیے ایک شیڈول رکھیں۔
- طلبہ کے ساتھ صحت مند کھانے کی عادات کا نمونہ بنائیں اور ان کے بارے میں بات کریں۔
- غذائیت سے بھرپور ناشتے اور کھانے فراہم کریں۔
- والدین کو صحت کے خدشات سے آگاہ کریں جو بچے کی نشوونما کو متاثر کر سکتے ہیں (نشوونما، سماعت، بصارت میں تبدیلیاں)۔
- والدین کو صحت، طبی اور دانتوں کے وسائل کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔
- بصری امتیاز کے کھیل استعمال کریں جیسے "I spy"۔
- "سننے والی سیر" کریں۔

علمی نشوونما

- اسباق بنانے کے لیے طالب علم کی ترجیحات اور دلچسپیوں کا استعمال کریں (والدین سے رائے لیں)۔
- طالب علم کو اپنی رفتار سے کام مکمل کرنے اور مہارتوں کی مشق کرنے کا وقت دیں۔
- مخصوص ہو کر کامیابی کے درجے کو تسلیم کریں۔
- تعریف اور فیڈبک دیتے وقت مخصوص رہیں۔
- کاموں کو چھوٹے مراحل میں توڑیں۔
- مراحل کا مظاہرہ کریں، اور پھر طالب علم سے مراحل دہرائیں، ایک وقت میں ایک۔
- جتنا ممکن ہو ٹھوس رہیں۔
- زبانی ہدایات دینے کے بجائے آپ کا مطلب کیا ہے اس کا مظاہرہ کریں۔
- زبانی طور پر نئی معلومات پیش کرتے وقت تصویر دکھائیں۔
- ہاتھوں سے مواد اور تجربات فراہم کریں۔
- چیزوں کے کام کرنے کے بارے میں معلومات شیئر کریں۔
- طالب علم کو ایک دوست کے ساتھ جوڑیں جو طالب علم کو راہ پر رکھنے میں مدد کر سکے۔
- کلاس روم کے معمولات کے ساتھ مستقل رہیں۔
- ایک معمول طے کریں تاکہ طالب علم جانے کہ کیا توقع کرنی ہے۔

- سرگرمیوں کا ایک بصری شیڈول فراہم کریں جسے طالب علم سمجھ سکے (تصاویر، آئیکن استعمال کرتے ہوئے)۔
- ایک بصری ٹائمر استعمال کریں تاکہ طالب علم جانے کہ کوئی سرگرمی کب ختم ہوگی اور وہ اگلے کام کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔
- عمر کے مطابق مواد استعمال کریں۔
- سمجھ کو یقینی بنانے کے لیے مختصر اور سادہ جملے استعمال کریں۔
- ہدایات یا ہدایات کو کثرت سے دہرائیں۔
- طالب علم سے پوچھیں کہ کیا مزید وضاحت ضروری ہے۔
- خلل اور منتقلی کو کم سے کم رکھیں۔
- جب بھی ضروری ہو مخصوص مہارتیں سکھائیں۔
- ایک حوصلہ افزا اور معاون سیکھنے کا ماحول فراہم کریں۔
- طالب علم کو متعدد یا پیچیدہ ہدایات سے مغلوب نہ کریں۔
- زیادہ آہستہ بولیں اور طالب علم کے لیے آپ کے الفاظ کو پروسیس کرنے کے لیے وقفہ چھوڑیں۔
- طالب علم سے براہ راست بات کریں۔
- واضح مختصر جملوں میں بولیں۔ ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں اور طالب علم کو جواب دینے کے لیے مناسب وقت فراہم کریں۔

بات چیت کی نشوونما

- جو آپ کہہ رہے ہیں اسے مضبوط کرنے کے لیے بڑی واضح تصاویر استعمال کریں۔
- آہستہ اور سوچ سمجھ کر بولیں۔
- طالب علم نے جو کہا ہے اسے دوبارہ بیان کریں۔
- بات چیت کے طریقوں کی اقسام واضح کریں جو طالب علم استعمال کر سکتا ہے۔
- غیر زبانی طلبہ کے لیے فعال بات چیت کے نظام کی شناخت اور قیام کریں۔
- بات چیت کی کوششوں کو مضبوط کریں (مثلاً ان کے اشارے، جزوی زبانی اظہار) جب طالب علم غیر زبانی یا ابھرتی ہوئی زبانی حالت میں ہو۔
- کمرے کے علاقوں کو الفاظ اور تصویروں سے لیبل کریں۔

- واقعات کی ترتیب سکھانے کے لیے ترتیب کارڈ استعمال کریں۔
- انگلیوں کے کھیل اور گانے استعمال کرتے وقت کٹھ پتلیاں / تصاویر بطور سہارا فراہم کریں۔
- طالب علم کے لیے مدد مانگنے کا طریقہ کار تیار کریں۔
- طالب علم سے براہ راست بات کریں۔
- ایک اچھا تقریری نمونہ بنیں۔
- کلاس روم میں آسان اور اچھی تعالیٰ بات چیت رکھیں۔
- اپنی کلاس کے بارے میں ایسیچ لینگویج پیٹھا لوجسٹ سے مشورہ کریں۔
- آگاہ رہیں کہ طلبہ کو بات چیت کی کسی اور صورت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- کلاس روم کی سرگرمیوں اور مباحثوں میں شرکت کی حوصلہ افزائی کریں۔
- کلاس روم میں قبولیت اور سمجھ کا نمونہ بنائیں۔
- مدد اور مثبت تقویت فراہم کریں جب طالب علم بڑھتی ہوئی خود مختاری کے ساتھ کچھ کرنے کی صلاحیت ظاہر کرے۔
- ایسے اشارے استعمال کریں جو سمجھ کی حمایت کریں۔
- درست تقریری نمونوں کا نمونہ بنائیں اور تقریری مشکلات کو درست کرنے سے گریز کریں۔
- طالب علم کے بولتے وقت صبر کریں، کیونکہ جلدی کرنے سے مایوسی ہو سکتی ہے۔
- تعالیٰ بات چیت پر توجہ مرکوز کریں۔
- فعال سننے کا استعمال کریں۔
- طالب علم کی دلچسپیوں کو تقریر میں شامل کریں۔
- کہانی کی کتاب کا اشتراک استعمال کریں جس میں طالب علم کو کہانی پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور جوابات حاصل کیے جاتے ہیں (مواد کے بارے میں مناسب تبصروں پر تعریف دی جاتی ہے)۔

سماجی اور جذباتی نشوونما

- طالب علم کو والدین سے الگ ہونے میں مدد کے لیے حکمت عملیاں استعمال کریں۔
- الوداع کہنے میں ایک معمول طے کریں (جیسے پڑھنے کے لیے کتاب تلاش کرنا)۔
- طالب علم کی کوششوں کی قدر کریں اور تسلیم کریں۔

- طلبہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب کھیلنے کے مواقع فراہم کریں۔
- طلبہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست بات چیت کے مواقع فراہم کریں۔
- بچے کے سماجی طور پر ثالثی شدہ تقویت دہندگان کے ذخیرے کو بڑھانے کے لیے کام کریں (مثلاً گد گدی، چھپن چھپائی، پیچھا و غیرہ)۔
- کھیل کے استعمال کے ذریعے جذبات کو تلاش کریں۔
- طلبہ کو عمر کے مطابق طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا سکھائیں۔
- کھیل کی سرگرمیاں فراہم کریں جن میں اشتراک کی ضرورت نہ ہو جیسے فن کے منصوبے، موسیقی بنانا (طلبہ کا اپنا آلہ)، اور ریت یا پانی کا کھیل۔
- طلبہ سے کہیں کہ وہ تصور کریں کہ ان کا رویہ دوسروں کو کیسے متاثر کر سکتا ہے۔
- طلبہ سے کلاس کے طلبہ کے ساتھ "دوست کتاب" بنوائیں۔
- طالب علم جو کر رہا ہے اس پر تبصرہ کریں اور بیان کریں (مخصوص رہیں)۔
- تنازع سے نمٹنے وقت، جو ہوا اس کی وضاحت جتنے کم الفاظ میں ممکن ہو کریں اور پرسکون، غصے والی نہیں آواز استعمال کریں۔
- طالب علم کے رویے کے نتائج کی نشاندہی کریں۔
- طلبہ کے ساتھ بہتر انتخاب پر غور و فکر کریں۔
- جذبات اور تجربات کو بیان کرنے کے لیے زبان استعمال کریں۔
- طالب علم کے جذبات کو الفاظ میں ڈھالیں۔
- جذبات کے بارے میں کتابیں پڑھیں۔
- حدود اور اصولوں کی اپنی وجوہات ایسی زبان میں بیان کریں جو طلبہ سمجھ سکیں۔
- تعاون میں شامل فوائد کا نمونہ بنائیں۔
- جب ممکن ہو قدرتی نتائج استعمال کریں تاکہ کسی اصول، درخواست یا حد میں شامل سبب اور اثر کو مضبوط کیا جاسکے۔
- طلبہ کو اہم لوگوں اور چیزوں کے لیے الفاظ سکھائیں۔

تطبیقی رویہ / فعالی مہارتیں

- روزمرہ کی زندگی اور خود دیکھ بھال سے متعلق زندگی کی مہارتیں واضح طور پر سکھائیں۔

- ہر مہارت کو مراحل میں توڑیں۔
- ہر مرحلے کو ظاہر کرنے کے لیے تصویروں / آئیکن کے ساتھ بصری شیڈول استعمال کریں۔
- ایسے تجربات کی منصوبہ بندی کریں جو بچے کی دنیا سے متعلق ہوں۔
- مہارتوں کو دیگر ترتیبات پر لگانے کے طریقے تلاش کریں (فیلڈ ٹرپ)۔
- خلل اور حد سے زیادہ تحریک کے امکان کو کم سے کم کریں۔
- ذاتی حفظان صحت کی عادات سکھائیں اور ان کا نمونہ بنائیں جیسے ہاتھ دھونا، چھینکنے یا کھانسنے پر منہ اور ناک ڈھانپنا، اور دانتوں کی دیکھ بھال۔
- ذاتی دیکھ بھال اور خود مدد کی مہارتوں کی مشق کے طریقے تلاش کریں (کلاس روم میں مراکز استعمال کرتے ہوئے)۔
- طلبہ کو مدد مانگنے، خود کھانے، لباس پہننے، ہاتھ دھونے، بیت الخلا استعمال کرنے، اور ذاتی اشیاء تلاش کرنے کی مشق کے مواقع فراہم کریں۔
- ایسا مواد فراہم کریں جو خود دیکھ بھال کی حمایت کرے جیسے بچوں کے سائز کا سنک، بیت الخلا، کوٹ ریک، اور ٹوٹھ برش۔
- بس کی حفاظت، کھیل کے میدان کی حفاظت، گروہ کے ساتھ رہنے، اور کلاس روم میں حفاظت کے لیے اصول اور طریقے سکھائیں اور ان کا نمونہ بنائیں۔
- طلبہ کو سکھائیں کہ پوچھے جانے پر ذاتی شناختی معلومات فراہم کریں۔
- ممکنہ طور پر خطرناک حالات سے نمٹنے کے طریقہ کار سکھائیں اور ان کا نمونہ بنائیں، بشمول آگ، شدید موسم، اور اجنبی۔

5.4 خود احتسابی سوالات

1. ذہنی معذوری سے کیا مراد ہے؟
2. ترقیاتی معذوری کی تعریف کریں؟
3. ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں کے درمیان مثالوں کے ساتھ فرق کریں۔
4. ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟
5. ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں کی تعریف میں AAIDD نے کیا کردار ادا کیا ہے؟
6. ترقیاتی معذوریوں والے لوگوں کو کن صحت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟

7. ترقیاتی معذوریوں والے لوگوں کو کن تعلیمی حمایتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟
8. ترقیاتی معذوری (DD) والے افراد کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی حکمت عملیاں کیا ہیں؟
9. ترقیاتی معذوری والے بچوں کو تعلیم دینے کا مقصد لکھیں۔
10. ذہنی اور ترقیاتی معذوریوں والے بچوں کے لیے تدریسی - سیکھنے کے عمل کے متوقع نتائج کیا ہیں؟
11. یہ کیسے جائزہ لیا جاسکتا ہے کہ آیا کلاس روم طلبہ کی خصوصی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لیس ہے؟
12. خصوصی تعلیم کے طلبہ کی ابتدائی شناخت اتنی اہم کیوں ہے؟
13. والدین اور اساتذہ خصوصی تعلیم کے طلبہ کے لیے سیکھنے کی پیش رفت کیسے ماپتے ہیں؟
14. گائیڈ کے باصلاحیت کے ماڈل کی مخصوص خصوصیات کیا ہیں؟
15. گائیڈ اور ریزولی کے باصلاحیت کے ماڈلوں میں کیا فرق ہے؟
16. فطری صلاحیتوں کو اہلیتوں کے طور پر تیز کرنے میں ماحولیاتی عوامل کے کردار کا تجزیہ کریں۔
17. باصلاحیت طلبہ کو کلاس روم میں کن مختلف طریقوں سے خدمات فراہم کی جاتی ہیں؟
18. باصلاحیت طلبہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے استاد کو کس قسم کی تربیت درکار ہے؟
19. باصلاحیت اور ذہین طلبہ کیسے سیکھتے ہیں، سیکھنے کی خصوصیات اور یہ کلاس روم میں کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔
20. آپ باصلاحیت اور ذہین طلبہ کو ایسا فنڈیک کیسے دیں گے جو ہم عمر موازنوں سے بچے، جو وہ جانتے ہیں اسے ہدف بنائے اور جو کھلے سوالات کے ذریعے مزید سیکھنے کو چیلنج کرے۔
21. آپ باصلاحیت اور ذہین طلبہ کے والدین کو کیسے مشورہ اور رہنمائی دیں گے۔
22. وضاحت کریں، باصلاحیت طلبہ اپنے سوچنے کے عمل میں کیسے مختلف ہیں۔ ثبوت کہ وہ تیز سوچتے ہیں، زیادہ گہرائی میں، ایک وقت میں بڑے مراحل میں۔ کیا وہ جو جانتے ہیں اسے زیادہ آسانی سے بدل سکتے ہیں؟
23. ذہنی اور ترقیاتی طور پر تاخیر والے بچوں میں تعلیمی مہارتیں تیار کرنے کے لیے استاد کے لیے مناسب حکمت عملیاں کیا ہیں؟
24. ذہنی اور ترقیاتی تاخیر والے بچے اپنی جسمانی نشوونما میں کیسے متاثر ہوتے ہیں؟
25. فعالی مہارتیں کیا ہیں؟
26. ذہنی طور پر کمزور بچوں میں فعالی مہارتیں کیسے تیار کی جاتی ہیں؟

5.5 حوالہ جات

- Atkinson, J.W. (1978). Motivational determinants of intellectual performance and cumulative achievement. In J.W. Atkinson & J.O. Raynor (Eds.) .Personality, motivation, and achievement. (pp. 221-242). New York: Wiley
- Austin, J.H. (1978). Chase, chance, and creativity. New York: Columbia University Press
- Clark, Barbara, (2012), Growing Up Gifted: Developing the Potential of Children at School and at Home. (8th Edition; April 2012, Pearson)
- Gagne, F. (1985). Giftedness and talent: Reexamining a reexamination of the definitions. Gifted Child Quarterly, 29, 103-112
- Gagne, F. (1991). Toward a differentiated model of giftedness and talent. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (pp. 65-80) .Boston: Allyn and Bacon
- Gagne, F. (1995). From giftedness to talent: a developmental model and its impact on the language of the field. Roeper Review, 18(2), 103-111
- Gagne, F. (1997). Critique of Morelock's (1996) definitions of giftedness and talent [a]. Roeper Review, 20(2), 76
- Gagne, F. (2000) A differentiated model of giftedness and talent. Year 2000 :update. [Online] Retrieved from the World Wide Web June 16, 2009 from http://www.eric.ed.gov.ezproxy.massey.ac.nz/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/bf/70.pdf
- Gagné, F., 2003, transforming gifts into talents: e DMGT as a developmental theory. In N. Colangelo & G.A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (3rd ed., pp. 60-74). Boston: Allyn & Bacon

Gagné, F. (2008) Building gifts into talents: Overview of the DMGT. Keynote address, 10th Asia-Pacific Conference for Giftedness, Asia-Pacific Federation .of the World Council for Gifted and Talented Children, Singapore, 14-17 July

Gross, M., MacLeod, B., Drummond, D. & Merrick, C., 2001, Gifted Students in .Primary Schools: Differentiating the Curriculum, GERRIC, University of NSW

Gross, M., MacLeod, B. & Pretorius, M., 2001, Gifted Students in Secondary Schools: Differentiating the Curriculum (2nd edition), GERRIC, University of .NSW

Kerry Hodge Macquarie University Special Education Centre 2013 (for :references beyond those) you can email at
kerry.hodge@speced.sed.mq.edu.au

.MacLean, P.(1978).A mind of three minds: Educating the triune brain

Ministry of Education. (2000). Gifted and talented students: meeting their needs in New Zealand

Renzulli, J.S. (1978). What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. Phi .Delta Kappan, 60(3), 180-184, 261

Renzulli, J.S., & Reis, S.M. (1985). The school wide enrichment model: A :comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center, CT
.Creative Learning Press

Renzulli, J. S. & Reis S.M., (1985), The Schoolwide Enrichment Model: A :comprehensive plan for educational excellence: Mansfield Center, CT
Creative Learning Press

Renzulli, J. S., (1986). The Three Ring conception of Giftedness: A developmental Model of creative productivity. In R.J. Sterberg & J.E. Davidson Conception of Giftedness (pp. 332-357). New York; Cambridge ,(Eds)
.University Press

Renzulli, J.S. (1994). Schools for talent development: A practical plan for total school improvement. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press

Renzulli, J.S., Gentry M. & Reis S.M., (2004), A time and Place for authentic learning and Educational Leadership, 62 (1), 73-77

,Thompson, R., Berger, T. and Berry, S. (1980). An introduction to the anatomy physiology, and chemistry of the brain. In M. Wittrock, (Ed.) The brain and psychology, New York: Academic

یونٹ 6: خصوصی بچوں کی جلد شناخت، جائزہ اور جلد مداخلت

تعارف

ہر بچہ منفرد ہوتا ہے اور اس کی اپنی قوتیں اور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ان کی نشوونما کچھ مقررہ مراحل کے مطابق آگے بڑھتی ہے، لیکن اس کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ کچھ بچے کچھ شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھا سکتے ہیں لیکن دیگر شعبوں میں ان میں کمی ہو سکتی ہے۔ تاہم، اگر بچے ایک (یا زیادہ) نشوونمائی شعبے میں نمایاں مسائل یا مشکلات ظاہر کریں، اور ان کی کارکردگی ان کی عمر کے دیگر بچوں کے مقابلے میں نمایاں فرق دکھائے، تو بچوں کو پیشہ ورانہ جائزے کے لیے بھیجنا مناسب ہے، کیونکہ یہ مسائل خرابی میں بدل سکتے ہیں اگر ان کا جلد عمر میں پتہ نہ چلایا جائے اور شناخت نہ کی جائے، جیسا کہ تصویر 1 میں دکھایا گیا ہے۔

تصویر: 1

بچپن کے ابتدائی سال کسی بھی بچے کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سال نمایاں نشوونما کے لیے بے پناہ موقع فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کے برعکس کمزوری اور نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ بچوں کو ابتدائی سالوں میں جو تجربات اور مواقع فراہم کیے جاتے ہیں وہ مستقبل کے سیکھنے اور نشوونما کی بنیادیں رکھتے ہیں، اور تعلیمی کامیابی، تعلقات سازی، صحت اور بہبود جیسے عوامل کو متاثر کرتے ہیں۔ ابتدائی سال ماہرین اور خاندانوں کے لیے ایک منفرد موقع ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی مدد کریں اور بچوں کے نشوونمائی رجحانات پر مثبت اثر ڈالیں۔

حالیہ برسوں میں معذوری اور نشوونمائی تاخیر والے بچوں کے لیے جلد شناخت اور مداخلت کے فوائد کے بارے میں مضبوط شواہد کی بنیاد سامنے آئی ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام طلبہ سیکھ سکتے اور سیکھیں گے اور انہیں تعلیم کا حق حاصل ہے۔ لیکن بچے مختلف رفتار اور مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں جبکہ مختلف شعبوں میں علم اور مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، طلبہ کے تنوع پس منظر ان علم، مہارتوں اور رویوں میں تغیر کا باعث بنتے ہیں جو وہ اسکول لاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم ایک شراکت ہے جو گھر، اسکول اور کمیونٹی کے درمیان مشترکہ ذمہ داری کی عکاسی کرتی ہے۔ گھر اور اسکول کے درمیان موثر ابلاغی عمل قائم کرنا اس سیکھنے کے پروگرام کی تشکیل کے لیے نہایت اہم ہے جو طالب علم کی ضروریات کے لیے بہترین ہو اور طالب علم کی قوتوں سے فائدہ اٹھائے۔ مختلف صلاحیتوں والے طلبہ کی کامیابی کو فروغ دینے کے لیے تمام شراکت داروں کو مل کر ضروریات پر مبنی

منصوبہ بنانے کی مشترکہ کوشش کرنی چاہیے۔ طالب علم کے کیریئر میں جتنی جلدی ممکن ہو سیکھنے کے مسائل کی نشاندہی کرنا اور مداخلت کرنا اس کی تعلیمی کامیابی کے لیے نہایت اہم ہے۔

ابتدائی بچپن کی مداخلت وہ تمام تجربات اور مواقع پر مشتمل ہوتی ہے جو معذوری والے شیر خوار اور چھوٹے بچوں کو ان کے والدین اور دیگر بنیادی نگہداشت کنندگان (بشمول خدمت فراہم کنندگان) کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں جن کا مقصد بچوں میں رویائی صلاحیت حاصل کرنے اور استعمال کرنے کو فروغ دینا ہے تاکہ لوگوں اور اشیاء کے ساتھ ان کے مثبت سماجی تعاملات کو تشکیل دیا جائے اور متاثر کیا جائے۔ بچے کی جتنی جلدی نشوونمائی تاخیر یا معذوری کی شناخت ہو، اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ وہ ان کی ضروریات کے مطابق حکمت عملیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جلد مداخلت کی حکمت عملیوں کی کامیابی نہ صرف خاندانوں کی مدد کرتی ہے کہ ان کے بچے کے لیے اضافی مدد فراہم کی جائے، بلکہ بعد کے برسوں میں اسکولوں اور کمیونٹیز کے اخراجات بھی کم کرتی ہے جب بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں۔ تاہم جلد شناخت صرف ابتدائی سالوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہایت اہم ہے کہ بچوں کی ضروریات کی جتنی جلدی ممکن ہو شناخت کی جائے، اور جتنے زیادہ بچوں کی اسکول شروع کرنے سے پہلے شناخت ہو، اتنا ہی بہتر ہے۔ تاہم، بہت سے بچے اس جال سے نکل جاتے ہیں۔

اس وقت، ہم جانتے ہیں کہ کچھ تعلیمی خصوصی ضروریات والے بچوں کی شناخت میں اضافہ ہوا ہے، یہ اتنا بڑا اضافہ نہیں ہے جتنا دیگر خصوصی تعلیمی ضروریات والوں کے لیے اور بہت سے بچے اب بھی چھوٹ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم توقع کریں گے کہ تمام بچوں میں سے 5-7 فیصد کو مخصوص تقریر، زبان اور ابلاغ کی ضروریات ہوں گی۔ تاہم، ہم جانتے ہیں کہ پرائمری اسکول اپنی آبادی کا صرف 2.3 فیصد بطور بنیادی SLCN شناخت کرتے ہیں، اور سیکنڈری اسکول تشویشناک حد تک 0.7 فیصد شناخت کرتے ہیں۔ اس طرح، اسکولنگ کے ہر مرحلے پر ان شاگردوں کی شناخت جاری رکھنے کے مواقع ہیں جن کی SLCN ان کے نتائج کو متاثر کرنے کا امکان رکھتی ہے۔ اس طرح، اگر SLCN (مخصوص تقریر اور زبان ابلاغ کی ضروریات) والے بچوں کی ابتدائی سالوں میں شناخت ہو جائے اور صحیح جلد مداخلت ہو، تو بچے بہتر پیش رفت کرتے ہیں، طویل مدتی اثرات کم ہو جاتے ہیں اور بہت سے بچے تو مکمل طور پر برابر بھی آسکتے ہیں۔ جلد مداخلت بچے یا نوجوان کی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہو سکتی ہے۔ جلد مداخلت مربوط خدمات کا ایک نظام ہے جو بچے کی عمر کے مطابق نشوونما اور ترقی کو فروغ دیتا ہے اور اہم ابتدائی سالوں کے دوران خاندانوں کی مدد کرتا ہے۔ جلد مداخلت بچوں، خاندانوں اور کمیونٹیز کی زندگیاں بدلنے کی ایک قوت ہے، خاص طور پر سب سے زیادہ محروم طبقات کی۔ آج پالیسی اور عمل کے لحاظ سے اس کی اہمیت اتنی ہی اس کی معاشی دانشمندی کی وجہ سے ہے، جتنی سماجی اور ذاتی فوائد کی وجہ سے جو پیدا کر سکتی ہے۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد طلبہ یہ کر سکیں گے:

1. جلد پتہ لگانے، شناخت اور مداخلت کی اہمیت کو سمجھنا۔
2. جلد مداخلت کا خاکہ بیان کرنا، خدمات بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیسے ڈھالی جاتی ہیں۔
3. خصوصی ضروریات والے بچوں کی شناخت کے لیے استعمال ہونے والے مختلف جائزہ آلات کا موازنہ اور تجزیہ کرنا۔
4. جلد شناخت، جائزہ اور مداخلت سے متعلق مختلف تحقیقی نتائج کا تنقیدی جائزہ لینا۔
5. جلد شناخت، جائزہ اور مداخلت کے عمل میں والدین کی شمولیت کی اہمیت بیان کرنا۔

6.1 مداخلت کے بنیادی مفروضات اور اصول

معذوری، اس کی شناخت، مداخلت اور شمولیت کے بارے میں آگاہی تاریخ یا ارتقا میں نسبتاً نئے تصورات ہیں اور پوری دنیا اب بھی مزید تلاش میں ہے، شواہد تلاش کر رہی ہے یا تحقیق کر رہی ہے۔ یہ تصورات ابھی دانت نکالنے کے مرحلے میں ہیں۔ آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے سربراہ، جیسے اسکول کا پرنسپل یا پالیسی ساز، یا بانی ڈائریکٹر یہ فرض کرے کہ خصوصی ضروریات والے بچوں کو 'ماہرین' کے پاس بھیجا جانا چاہیے اور صرف 'خصوصی تربیت' یا 'غیر معمولی طاقت' والے لوگ انہیں پڑھا سکتے ہیں، تو یہ مفروضات خطرناک بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جن سے بھی بات کریں گے، انہیں یہ ذاتی رائے سچ یا پالیسی کی صورت میں منقل کریں گے۔ نیز، چونکہ یہ وہ شخص ہے جو 'تعلیم یافتہ' تجربہ کار' ہے اور 'بہتر' جاننے والا سمجھا جاتا ہے، لوگ ایسی معلومات کو منہ کے بل قبول کر لیتے ہیں۔

والدین اور ڈاکٹر دونوں بھی مفروضات کے بارے میں بہت سے معاملات میں قصور وار ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ حقیقت کا ان کا ورژن حتمی سچ ہے، حالانکہ نئی تحقیق یا شواہد انہیں غلط ثابت کرتے ہیں۔ ان کا بیانیہ زیادہ تر بدلا نہیں رہتا۔ ایک والدین یا نئے والدین کی حیثیت سے، اگر آپ ایسی سوچ پر سوال نہیں اٹھاتے، تو آپ اپنے بچے کی صلاحیت پر سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ آپ اسے کبھی اس حد سے آگے نہیں دھکیلیں گے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ حاصل کر سکتا ہے کیونکہ آپ 'نااہلیت' کا مفروضہ رکھے ہوئے ہیں جو زیادہ تر اس زمانے کا رائج بیانیہ تھا۔ اگر کوئی پچھلی چند ہائیوں میں اسی طرح کی معذوریوں والے لوگوں کی کامیابیوں کی بنیاد پر بچے کی نااہلیتوں پر یقین کرنے کی طرف لے جایا جائے، تو اسے اس پر بحث اور سوال کرنا چاہیے کیونکہ ایک مقبول بیانیہ اس سے زیادہ اہم ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔

جلد مداخلت کیا ہے؟

جلد مداخلت خدمات کا ایک نظام ہے جو نشوونمائی تاخیر یا معذوری والے شیر خوار اور چھوٹے بچوں کی مدد کرتا ہے۔ جلد مداخلت اہل شیر خوار اور چھوٹے بچوں کو بنیادی اور بالکل نئی مہارتیں سیکھنے میں مدد پر مرکوز ہوتی ہے جو عام طور پر زندگی کے پہلے تین سالوں کے دوران پیدا ہوتی ہیں، جیسے:

- جسمانی (پہنچنا، پلٹنا، رینگنا اور چلنا)؛
- علمی (سوچنا، سیکھنا، مسائل حل کرنا)؛
- ابلاغ (بات کرنا، سننا، سمجھنا)؛
- سماجی / جذباتی (کھیلنا، محفوظ اور خوش محسوس کرنا)؛ اور
- خود مدد (کھانا، کپڑے پہننا)۔

جلد مداخلت کی خدمات کی مثالیں

اگر کسی شیر خوار یا چھوٹے بچے کو ان نشوونمائی شعبوں میں سے ایک یا زیادہ میں معذوری یا نشوونمائی تاخیر ہے، تو اس بچے کے جلد مداخلت کی خدمات کے اہل ہونے کا امکان ہے۔ وہ خدمات بچے کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈھالی جائیں گی اور ان میں شامل ہو سکتا ہے:

- معاون ٹیکنالوجی (وہ آلات جن کی بچے کو ضرورت ہو سکتی ہے)
- سماعت کی خدمات یا آڈیالوجی
- تقریر اور زبان کی خدمات
- خاندان کے لیے مشاورت اور تربیت
- طبی خدمات
- نرسنگ خدمات
- غذائیت کی خدمات
- پیشہ ورانہ تھراپی
- جسمانی تھراپی
- نفسیاتی خدمات

بچے کے خاندان کی ضروریات اور ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے بھی خدمات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ خاندان کی رہنمائی والی خدمات کا مقصد خاندان کے افراد کو اپنے بچے کی خصوصی ضروریات کو سمجھنے اور اس کی نشوونما کو بڑھانے کے طریقے میں مدد کرنا ہے۔

معذور افراد کے تعلیمی قانون ((Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) اس کا تقاضا کرتا ہے۔ عین طور پر IDEA کا حصہ C۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کبھی جلد مداخلت کو حصہ C کہا جاتا سنیں گے۔

بچپن کے سالوں میں جلد مداخلت 0-6 سال کی عمر کے بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس عرصے کے دوران، نشوونما خرابیوں کی جلد شناخت کے لیے تین بڑے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا موقع اسپتال میں پیدا ہوتا ہے جب پیدائشی نقائص والے شیر خوار بچوں کا پتہ چلتا ہے اور مداخلت فوراً شروع کر دی جاتی ہے۔ دوسرا موقع تب ہوتا ہے جب بچوں میں تقریر اور زبان کی نشوونما میں تاخیر ظاہر ہوتی ہے جو عام طور پر زندگی کے دوسرے سال میں ظاہر ہوتی ہے اور تیسرا پری اسکول میں پیدا ہوتا ہے جب بچوں کے کھیل کے رویے ساتھیوں کو شامل کرنے کے لیے پھیل رہے ہوتے ہیں۔ پری اسکول اساتذہ کو جلد مداخلت کی ٹیم کا حصہ سمجھا جانا چاہیے، جو کلاس روم کے قدرتی ماحول کے لیے بنائی گئی سرگرمیوں کے ذریعے کسی تھراپسٹ کے پروگرام کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ نے اپنا پہلا قدم اٹھایا تھا؟ امکان ہے کہ آپ کو یاد نہیں۔ ابتدائی بچپن ایک دھندلا سا منظر ہے: ہماری ابتدائی یادیں صرف تقریباً 3 سال کی عمر تک جاتی ہیں۔ جب آپ اس پر غور کرتے ہیں، تو ابتدائی سالوں میں نشوونما اور ترقی ایک معجزہ ہے۔ زندگی کے پہلے تین سالوں میں، دماغ کی 90 فیصد نشوونما مکمل ہو جاتی ہے۔ چھ سال کی عمر تک، ہم نے چلنا، بات کرنا، خود کھانا کھانا، کھیل میں دوستوں کے ساتھ شامل ہونا، تجسس کا مظاہرہ کرنا اور جذبات کا اظہار کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے۔

جلد مداخلت یہ فرض کرتی ہے کہ جتنی جلدی خدمات اور مدد فراہم کی جائیں، اتنا ہی بہتر ہے۔ مداخلت کے زیادہ موثر ہونے کا امکان ہے اگر یہ بچے کی زندگی میں جلد یا ان عوامل کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جو ان کی نشوونما کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ نیز، بہت جلدی مدد اس امکان کو بڑھا سکتی ہے کہ خطرے میں پڑا خاندان تعلیم اور صحت جیسی بنیادی خدمات سے جڑنے یا دوبارہ جڑنے کے قابل ہو۔ یہ ایک کھلے سوال کی طرف لے جاتا ہے، جلدی کتنی جلدی ہے؟ موجودہ ٹیکنالوجی کچھ عارضوں کے لیے اسے تصور سے پہلے ہی ممکن بناتی ہے۔ ایسی دو خرابیاں fragile X syndrome اور tay-sachs disease ہیں۔ بیماری کے حامل افراد کی خون کے ٹیسٹ سے شناخت کی جا سکتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی اسکریننگ اور پیدائش کے بعد کے ٹیسٹ بھی دستیاب ہیں۔

خطرہ ایک شمار یاتی تصور ہے جو کہتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی حالت ہونے کا امکان ہے۔ جب خطرہ تفویض کیا جاتا ہے تو یہ اکثر نسبتی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ گروپ کی حیثیت یا کارکردگی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ نسبتی خطرے کی بنیاد پر علاج کا پروگرام قائم کرنا کامیاب ہونے کے لیے مقدر ہے کیونکہ زیادہ تر بچے یہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ خطرے میں ہیں۔ اس لیے، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ علاج کی حکمت عملیوں نے کسی ایسی چیز کا علاج کیا ہے جو موجود نہیں ہے۔

خطرے کی رجسٹریاں بچوں کو خطرے میں شناخت کرتی ہیں جب وہ دلچسپی کی خرابی کی خصوصیات ظاہر کرتے ہیں۔ زیادہ تر تاریخی خطرہ ان بچوں کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہیں تشخیص کی تصدیق کے لیے جائزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خطرے کے عوامل کو کچھ صورتوں میں کم پیدائشی وزن یا قبل از وقت پیدائش کے طور پر آسانی سے شناخت کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی خطرے کی رجسٹریاں مشکل ثابت ہوتی ہیں کیونکہ کچھ خطرے کے عوامل کی تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کچھ عوامل کی درجہ بندی کی صلاحیتیں کمزور ہو سکتی ہیں (حساسیت اور مخصوصیت) یا کچھ خطرے کے عوامل اپنا اثر براہ راست نہیں ڈالتے، مثال کے طور پر کم سماجی و معاشی حالت نشوونمائی معذوری سے منسلک ہے، لیکن وہ طریقہ کار جس سے یہ نشوونمائی معذوری کا باعث بنتی ہے ابھی تک متعین نہیں ہوا۔ اس لیے کارکردگی پر قائم خطرے کی رجسٹریاں ان بچوں کی بہتر درجہ بندی کرنے کا امکان زیادہ رکھتی ہیں جو نشوونمائی معذوریوں کے خطرے میں ہیں کیونکہ کارکردگی پر مبنی درجہ بندی تاریخی خطرے سے تفویض کردہ خطرے سے زیادہ مخصوص ہوتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ ابتدائی کوشش درکار ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی بڑی تعداد کو ان کی کارکردگی کے جائزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کارکردگی کی بنیاد پر خطرہ تفویض کرنا اسکریننگ کی بنیاد ہے۔ یہ تشخیصی عمل کا پہلا قدم ہے۔ اسکریننگ سے تشخیص نہیں ہوتی؛ علاج شروع کرنے سے پہلے تصدیقی ٹیسٹ درکار ہوتا ہے۔ اسکریننگ اس صورت میں جائز ہے اگر حالت کو جلد تشخیص اور علاج سے فائدہ ہوگا اور لاگت فائدہ کا تناسب مثبت ہو۔ نشوونمائی سنگ میلوں کا موازنہ عام طور پر نشوونما پانے والے بچے سے کیا جاتا ہے جیسے مائیں اپنے بچوں کے بات کرنے اور چلنے کا موازنہ کرتی تھیں۔ کچھ اسکریننگ آلات ذیل میں مذکور ہیں جو American Academy of Pediatrics نے تجویز کیے ہیں۔

عمومی نشوونمائی اسکریننگ آلات

• Ages and Stages Questionnaires

• Battles Developmental Inventory Screening Tool, 2nd ed

• Bayley Infant Neurodevelopmental Screener

• Brigance Screens-II

Child Development Inventory •

Child Development Review-Parent Questionnaire •

Denver-II Developmental Screening Test •

Infant Development Inventory •

Parents' Evaluation of Developmental Status •

زبان اور علمی اسکریننگ آلات

The Capute Scales •

Communication and Symbolic Behaviour Scales-Developmental Profile •

Early Language Milestone Scale •

حرکت اسکریننگ آلات

Early Motor Pattern Profile •

Motor Quotient •

آٹزم اسکریننگ آلات

Communication and Symbolic Behavior Scales-Developmental Pro •

Early Language Milestone Scale •

حرکت اسکریننگ آلات

Early Motor Pattern Profile •

Motor Quotient •

آٹزم اسکریننگ آلات

The Checklist Autism in Toddlers •

Modified Checklist for Autism in Toddlers •

Pervasive Developmental Disorders Screening Test-II •

Primary Care Screener .1

Developmental Clinic Screener .2

Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds •

Social Communication Questionnaire •

ماخذ: AAP Council on Children with Disabilities et al., 2006.

ابتدائی بچپن کے معلمین اضافی ضروریات والے بچوں اور ان کے خاندانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ خدمت فراہم کنندگان اکثر ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کی خصوصی ضروریات کی شناخت ہو چکی ہوتی ہے۔ خصوصی ضروریات والے بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر وہ بچے اور اس کی خصوصی ضرورت کو سمجھیں اور اس کے سیکھنے اور نشوونما کی مدد کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ ان کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خصوصی ضروریات والے بچے پہلے بچے ہیں۔ ان کی وہی ضروریات ہیں جو تمام بچوں کی ہوتی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں وہ جسمانی طور پر آرام دہ، محبت یافتہ اور محفوظ محسوس کریں؛ کھیلنے اور سیکھنے کے موقع؛ ایسے لوگ جو ان کی پرواہ کریں؛ اور ایسی سرگرمیاں جو انہیں کامیاب ہونے دیں۔ خصوصی ضروریات والے بچے اکثر عام طور پر نشوونما پانے والے بچوں سے اتنے مختلف نہیں ہوتے۔ انہیں کچھ مہارتیں سیکھنے اور ان کی مشق کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہو سکتا ہے۔ انہیں اپنی عمر کے گروپ کے لیے عام مہارتیں حاصل کرنے کے لیے زیادہ تعریف اور حوصلہ افزائی درکار ہو سکتی ہے۔ انہیں کچھ سرگرمیوں میں کامیاب ہونے میں مدد کے لیے مخصوص ایڈاپٹیشنز درکار ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے، بہت سے طریقوں سے ان بچوں میں دیگر بچوں کے ساتھ بہت کچھ مشترک ہوتا ہے۔ بچوں کی نگہداشت کے بہت سے پیشہ ور افراد اور بچوں کے حامی اس نکتے پر زور دیتے ہیں کہ "بچے پہلے" والی زبان استعمال کی جائے، "خصوصی ضروریات والا بچہ" کہنے کے بجائے "خصوصی ضروریات والا بچہ"۔ یعنی "a child with special needs" کہا جائے بجائے "a special needs child" کے۔

جب خصوصی ضروریات والے بچوں کے ساتھ کام کیا جائے، تو بچوں کی نگہداشت فراہم کنندگان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ اور ہر معذوری منفرد ہے۔ بصری خرابی والا بچہ رویائی چیلنجز والے بچے سے مختلف ضروریات رکھتا ہے۔ جسمانی معذوری والا 2 سالہ بچہ اسی قسم کی معذوری والے 4 سالہ بچے سے مختلف صلاحیتیں اور چیلنجز رکھتا ہے۔ کچھ بچوں میں ایک سے زیادہ قسم کی معذوری ہوتی ہے۔ ہر معذوری کے چیلنجز کی شدت بھی ہر بچے کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ جلد شناخت اور مداخلت کام کرتی ہے۔ بچوں،

خاندانوں اور ابتدائی بچپن کی ترتیبات کے لیے بہترین نتائج فراہم کرتی ہے۔ جائزے کے عمل میں انفرادی منصوبہ بندی کا استعمال اس جائزے میں زیر بحث دائرہ اختیاروں میں، اور بہت سے یورپی دائرہ اختیاروں میں جلد مداخلت میں شمولیتی عمل کا ایک اہم جزو ہے۔

جائزے میں تجویز کردہ طریقے

جائزے میں تجویز کردہ طریقے درج ذیل ہیں:

- پیشہ ور افراد اور خاندان جائزے کی منصوبہ بندی اور نفاذ میں تعاون کرتے ہیں۔
- جائزہ انفرادی ہوتا ہے اور بچے اور خاندان کے لیے مناسب ہوتا ہے۔
- جائزہ مداخلت کے لیے مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔
- پیشہ ور افراد احترام اور مفید طریقوں سے معلومات شیئر کرتے ہیں۔

ادب میں شناخت کردہ دیگر اہم اصولوں میں چھوٹے بچوں کا جائزہ لیتے وقت متعدد پیمائشوں اور متعدد ذرائع کی ضرورت، نشوونمائی مناسبت، اور بچے کو ثقافتی تناظر میں سرایت شدہ اہلیت کے فریم ورک سے دیکھنا شامل ہے۔ جائزے کے لیے سیکھنے کی کہانیوں کے نقطہ نظر کے استعمال پر تحقیق شناخت کرتی ہے کہ یہ والدین اور ابتدائی بچپن کے معلمین کو عمل میں زیادہ مکمل طور پر حصہ لینے کے لیے با اختیار بنا سکتا ہے، خاص طور پر چونکہ وہ پہلے سے ہی جائزے کے اس نقطہ نظر سے واقف ہیں، اور استعمال کی گئی زبان عمل میں زیادہ مکمل طور پر شامل ہے، خاص طور پر چونکہ وہ پہلے سے ہی جائزے کے اس نقطہ نظر سے واقف ہیں، اور استعمال کی گئی زبان زیادہ شمولیتی ہے، جس سے "ماہر" ماڈل کم ہوتا ہے۔

سیکھنے کی کہانیوں کا نقطہ نظر ٹیم کے دیگر ارکان کے نقطہ نظر کے بڑھتے ہوئے علم، ایک مشترکہ زبان اور ٹیم کے ارکان کے درمیان مدد کے ماحول کے ذریعے ٹیم کے تعلقات کو بڑھانے اور مضبوط کرنے میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے۔

تمام بچے شمولیتی عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تعاون اور بین ایجنسی کام نہایت اہم ہے۔ والدین، ترتیبات اور سرکاری ایجنسیاں۔ وہ مدد اور وسائل جو قابل رسائی اور بروقت ہوں شمولیتی عمل کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ابتدائی بچپن کے پیشہ ور افراد کا بچے اور خاندان کے ساتھ ایک منفرد غیر مسئلہ مرکوز تعلق ہوتا ہے اور پورے بچے کو سمجھنے میں ان کا قیمتی حصہ ہوتا ہے۔

جلد مداخلت میں شامل کرنے کی اہم خصوصیات

اگرچہ موثر جلد مداخلت کے پروگراموں کی اہم خصوصیات کا تعین کرنے کی بہت کم کوششیں ہوئی ہیں، کچھ عوامل ہیں جو زیادہ تر مطالعات میں موجود ہیں جو سب سے زیادہ تاثیر کی رپورٹ دیتے ہیں۔ ان پروگرام کی خصوصیات میں شامل ہیں: (a) مداخلت کے وقت بچے کی عمر؛ (b) والدین کی شمولیت؛ اور (c) پروگرام ماڈل کی شدت اور/یا ساخت کی مقدار۔

• بہت سے مطالعات اور ادبی جائزے رپورٹ کرتے ہیں کہ مداخلت جتنی جلدی ہو، اتنی ہی موثر ہوتی ہے۔ سیدائش پر یا معذوری یا زیادہ خطرے کے عوامل کی تشخیص کے فوراً بعد مداخلت سے نشوونمائی فوائد زیادہ ہوتے ہیں اور مسائل پیدا ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔

• والدین کی اپنے بچے کے علاج میں شمولیت بھی اہم ہے۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ معذور اور ذہین دونوں پری اسکول عمر کے بچوں کے والدین کو اپنے بچے کی خصوصی ضروریات سے نمٹنے کے لیے ضروری مدد اور مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاندانی مداخلت کے نتائج میں شامل ہیں: (a) والدین کی بچے کا پروگرام گھر میں نافذ کرنے کی صلاحیت؛ اور (b) کم تناؤ جو خاندان کی صحت کو سہولت دیتا ہے۔ یہ دونوں عوامل بچے کے ساتھ پروگرام کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔

6.2 جلد شناخت، جلد جائزہ اور جلد مداخلت پر تحقیق کا جائزہ

نظر اندازی کے اثرات جلد شروع ہوتے ہیں اور بچے کی پوری زندگی حتیٰ کہ جوانی تک رہتے ہیں۔ جلد مداخلت کرنے والے کے لیے، اعصابی نشوونما کے یہ ابتدائی سال دلچسپ اور عاجز کرنے والے بھی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ خاندانوں کے ساتھ فعال طور پر شراکت کی جائے تاکہ ان بچوں کی مدد کی جائے جن کے نشوونمائی نمونے خراب، متاثر یا تاخیر یافتہ ہیں۔ وسیع تر معنوں میں، ہم میں سے ہر ایک بچے کی زندگی میں جلد مداخلت کرنے والا ہے۔ اس کے لیے صرف اچھی مشاہداتی مہارتیں اور نشوونمائی اہداف اور سنگ میلوں کی گہری سمجھ درکار ہے۔

فطرت ہمیشہ ایسے چیلنجز پیش کرتی ہے جو ہمیں معمول اور نشوونما کے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک چیلنج جینیاتی عارضوں والے بچوں کی ضروریات کا جواب دینے کے قابل ہونا ہے۔ آج، Prader-Willi Syndrome، Cri-du-chat، Rubinstein-Taybi Syndrome، mitochondrial diseases جیسے نایاب جینیاتی عارضوں سے تشخیص شدہ بچوں کے لیے معلومات اور والدین کی مدد کے نیٹ ورکس کی دولت موجود ہے، جن کی پیدائش پر شناخت ہوتی ہے۔ ابتدائی سال والدین

کے لیے غم، مایوسی اور غصے سے نمٹنے کی جدوجہد پیش کرتے ہیں۔ جب مائیں گھر میں تحریک کے پروگرام شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہوتیں، تو وہ کبھی کبھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔

اس شعبے کے بہت سے محققین نے autism spectrum disorder کے بارے میں دستاویز کیا ہے، ان بچوں کی مثالیں جنہوں نے اپنی علامات کو اس حد تک ختم کر دیا ہے کہ افراد عام حد میں آتے ہیں اور تقریباً نصف بالآخر خصوصی مدد کی ضرورت کے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ تاہم، جلد مداخلت کے بغیر یہ امکان نہیں ہے۔ زیادہ تر والدین اور پیشہ ور افراد کا مقصد ان علامات کو کم کرنا ہے جو بچے کی تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہونے اور ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو منفی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ جلد مداخلت بہتر طویل مدتی نتائج کے امکان کو بڑھاتی ہے۔

Hart and Risley 1992 کے مطابق، نشوونما کی رجحانات پری اسکول کے سالوں تک اچھی طرح قائم ہو جاتے ہیں، اور جلد پتہ لگانے اور مداخلت کے ممکنہ مثبت نتائج میں تاخیر ایسی چیز نہیں ہے جو کسی بچے یا خاندان کو نہ دی جائے، اور بالآخر معاشرے پر مثبت اثر ڈالے گی۔

RTI (response to intervention) پر تحقیق ہمیں مداخلت کو تبدیل، ترمیم، بند یا جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسا کہ Lovaas (1987) نے دکھایا، اگر بچہ مداخلت کا جواب دے رہا ہے، تو بڑی "خوراک" کے نیچے میں بچہ اپنے ہم عمروں سے ناقابل تمیز ہو سکتا ہے۔ جلد پتہ لگانے اور مداخلت کا ممکنہ مثبت نتیجہ ایسی چیز نہیں ہے جو کسی بچے یا خاندان کو نہ دی جائے، اور بالآخر معاشرے پر مثبت اثر ڈالے گا۔

حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر بنیادی سماجی شعبے کا علاج کیا جائے تو ہم آہنگی کی بیماری (co-morbidity) کم ہو سکتی ہے۔ Reed, (2002) - متبادل طور پر، غلط یا تشخیص کی کمی کی وجہ سے ان علامات کے لیے مداخلت فراہم نہ کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ بنیادی علامات کو حل کرنے کی جلد مداخلت کی تکنیکیں کسی بھی مسئلے کی ثانوی علامات کو روک سکتی ہیں اور بعد کی زندگی میں زیادہ ٹھوس اور مہنگی مداخلتوں کی ضرورت کو کم کر سکتی ہیں۔

Munro review جلد شناخت اور جلد مدد کی اہمیت، مضمرات برائے معاشرہ۔ جلد نقصان کے لیے سماجی نگہداشت، تعلیم، صحت، رہائش، پولیس اور دیگر خدمات سے مزید مدد درکار ہوتی ہے۔ فرد - زندگی کے مواقع میں کمی۔ شواہد بتاتے ہیں کہ "جن بچوں کی علمی اور رویائی خصوصیات ان کے ابتدائی سالوں میں کمزور طور پر نشوونما پاتی ہیں انہیں اسکول کے نظام میں کامیاب ہونے میں دشواری ہوتی ہے" اور کہ "تحقیق نے دستاویز کیا ہے کہ جلد مداخلت ایسے بچوں کی کامیابی میں حصہ ڈالنے والا ایک اہم عامل ہے۔"

جلد مداخلت کیوں؟

غیر معمولی بچے کے ساتھ جلد مداخلت کرنے کی تین بنیادی وجوہات ہیں: بچے کی نشوونما کو بڑھانا، خاندان کو مدد اور معاونت فراہم کرنا، اور بچے اور خاندان کے معاشرے کے لیے فائدے کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔

بچے کی نشوونما کی تحقیق نے قائم کیا ہے کہ انسانی سیکھنے اور نشوونما کی رفتار پری اسکول کے سالوں میں سب سے تیز ہوتی ہے۔ مداخلت کا وقت خاص طور پر اہم ہو جاتا ہے جب بچے کو زیادہ سے زیادہ تیاری کی حالت کے دوران سیکھنے کا موقع چھوٹنے کا خطرہ ہو۔ اگر سب سے زیادہ سکھانے کے قابل لمحات یا سب سے زیادہ تیاری کے مراحل سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو بچے کو بعد میں کوئی خاص مہارت سیکھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔

جلد مداخلت کی خدمات غیر معمولی شیر خوار یا چھوٹے بچے کے والدین اور بہن بھائیوں پر بھی نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔ نوجوان غیر معمولی بچے کا خاندان اکثر مایوسی، سماجی تنہائی، اضافی تناؤ، مایوسی اور بے بسی محسوس کرتا ہے۔ غیر معمولی بچے کی موجودگی کا مرکب تناؤ خاندان کی بہبود کو متاثر کر سکتا ہے اور بچے کی نشوونما میں مداخلت کر سکتا ہے۔ معذور بچوں کے خاندانوں میں طلاق اور خودکشی کے زیادہ واقعات پائے جاتے ہیں، اور معذور بچے کے ساتھ غیر معذور بچے کے مقابلے میں بدسلوکی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جلد مداخلت کے نتیجے میں والدین کے اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں بہتر رویے، اپنے بچے کو سکھانے کے لیے بہتر معلومات اور مہارتیں، اور تفریح اور ملازمت کے لیے زیادہ فارغ وقت ہو سکتا ہے۔ ذہن پری اسکولرز کے والدین کو بھی جلدی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بچے کو درکار معاون اور پرورش کرنے والا ماحول بہتر طور پر فراہم کر سکیں۔

جلدی مداخلت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ معاشرہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرے گا۔ بچے کے بڑھے ہوئے نشوونما اور تعلیمی فوائد اور سماجی اداروں پر کم انحصار، خاندان کی غیر معمولی بچے کی موجودگی سے نمٹنے کی بڑھی ہوئی صلاحیت، اور شاید بچے کی ملازمت کے لیے بڑھی ہوئی اہلیت، سب معاشری اور سماجی فوائد فراہم کرتے ہیں۔

کیا جلد مداخلت واقعی موثر ہے؟

تقریباً 50 سال کی تحقیق کے بعد، شواہد موجود ہیں - مقداری (اعداد و شمار پر مبنی) اور معیاری (والدین اور اساتذہ کی رپورٹیں) دونوں - کہ جلد مداخلت بچے کے لیے نشوونما اور تعلیمی فوائد بڑھاتی ہے، خاندان کے کام کو بہتر بناتی ہے، اور معاشرے کے لیے طویل مدتی فوائد حاصل کرتی ہے۔ جلد مداخلت کے نتیجے میں بچے کے بارے میں دکھایا گیا ہے: (a) بعد کی زندگی میں کم خصوصی تعلیم اور دیگر بحالی کی خدمات کی ضرورت: (b)

گریڈ میں کم بار روکا جانا؛ اور (c) کچھ صورتوں میں مداخلت کے برسوں بعد غیر معذور ہم جماعتوں سے ناقابل تمیز ہونا۔

محروم اور ذہین پری اسکول عمر کے بچے بھی جلد مداخلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ Ypsilanti Perry Preschool Project میں حصہ لینے والے محروم بچوں کے طول البلد اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے 19 سال کی عمر میں نمایاں فوائد برقرار رکھے تھے۔ یہ بچے اسکولنگ کے لیے زیادہ پر عزم تھے اور ان میں سے زیادہ نے ہائی اسکول مکمل کیا اور ان بچوں کے مقابلے میں پوسٹ سیکنڈری پروگراموں اور ملازمت میں گئے جو پری اسکول نہیں گئے۔ انہوں نے تمام گریڈ کی سطحوں پر پڑھنے، حسابی اور زبان کی کامیابی کے ٹیسٹوں میں زیادہ نمبر حاصل کیے؛ ہائی اسکول کے اختتام تک خصوصی تعلیمی خدمات کی ضرورت میں 50 فیصد کمی دکھائی؛ اور اسکول سے باہر کم سماج دشمن یا مجرمانہ رویے دکھائے۔ کہ ذہین بچے میں کم کارکردگی کو جلد شناخت اور مناسب پروگرامنگ سے روکا جاسکتا ہے۔

یہاں کچھ ایسے بہت سے چیلنجز ہیں جو معذوری والے نوجوان بچوں کی جلد شناخت میں موجود ہیں، جن کی شناخت مختلف مطالعات کے نتائج کے ذریعے کی گئی ہے۔

• روک تھام / مداخلت کی خدمات کی ضرورت والے بہت سے بچوں کی ان کے ابتدائی بچپن کے سالوں میں شناخت نہیں ہوتی۔

بہت سی جگہوں پر Child Find کی کوششیں موجود نہیں ہیں۔ اگر Child Find کا نظام موجود ہے، تو اکثر اس کے اثر کی نگرانی میں بہت کم جوابدہی بنی ہوتی ہے۔

عوامی آگاہی کے اقدامات اکثر غیر موثر اور / یا غیر موجود ہوتے ہیں۔

بہت سے علاقوں میں خدمات تک رسائی ایک حد ہے۔

ریفرلز اور خدمت کی ہم آہنگی اکثر بکھری ہوئی ہوتی ہے اور / یا بچے کے خاندان کے لیے ان میں گزرنا مشکل ہوتا ہے۔

مستقل اور جامع نشوونمائی رویائی اسکریننگ کی کمی واضح ہے۔ نشوونمائی خدشات والے بچوں کی شناخت کے لیے، اسکریننگ جائزے کو بہتر ریفرل اور عوامی آگاہی کے طریقہ کار اور پالیسیوں کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق پر مبنی نشوونمائی اسکریننگ آلات کے استعمال کی سفارش کی جاتی ہے۔ ایک بار جب بچے کی جلد مداخلت کی مدد اور خدمات کی ضرورت کے طور پر شناخت ہو جاتی ہے، تو مناسب جائزے کے طریقوں اور کارکردگی کی نگرانی کا استعمال یہ تعین کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ بچہ کتنی پیش رفت

کر رہا ہے۔ یہ خصوصی شمارہ اہم تحقیق، طریقوں اور ماڈلوں کو اجاگر کرتا ہے جو خطرے میں یا تاخیر/ معذوری والے نوجوان بچوں کی جلد شناخت اور جائزے میں مدد کے لیے جاری ہیں۔

جلد جائزے پر تحقیق

Lee, Bagnato, and Pretti-Frontzcak اپنے مطالعے میں افادیت اور جواز پر روایتی اور مستند جائزے کے طریقوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ان کے نتائج بچے کی نشوونما کے مشاہدے اور سمجھنے کے لیے مستند طریقے تلاش کرنے والے ماہرین پر لاگو ہوتے ہیں۔ نتائج عالمی پیمانے پر جائزے کے طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے مضمرات رکھتے ہیں۔

نوجوان بچوں کی نشوونما کے مشاہدے اور نگرانی کے لیے استعمال ہونے والے جائزے کی توثیق کے لیے ایک معیاری مطالعہ کیا گیا۔ Macy, Bricker, Dionne, Grisham-Brown, Johnson, Slentz, Waddell, Behm, and Shrestha بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ماہر پینل Assessment, and Programming System for Infants and Children (AEPS™) کے تیسرے ایڈیشن کی خصوصیات کی تحقیق کے لیے استعمال کیا گیا۔

Bricker, Squires, Franz, and Xie والدین کے تعاون کے ذریعے نوجوان بچوں کی شناخت کے لیے استعمال ہونے والے بہترین طریقوں کو شامل کرنے کی حکمت عملیوں کے ساتھ جلد شناخت کے لیے ایک تصوراتی فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ مصنفین بتاتے ہیں کہ عملی ترتیبات میں اس فریم ورک کو کس طرح استعمال کیا جاسکتا ہے اس کی ٹھوس مثالیں vignettes دیتے ہیں۔ Steed and Banerjee سماجی جذباتی اور رویائی مسائل والے نوجوان بچوں کی جلد شناخت کے لیے ایک تصوراتی فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ جذباتی مشکلات اور چیلنجنگ رویوں والے نوجوان بچوں کی جلد پتہ لگانے کی کوششوں میں مدد کے لیے ایک منسلک نظام فراہم کیا گیا ہے۔ نوجوان بچوں اور خاندانوں کے ساتھ کام کرنے والے ماہرین مربوط اور ہم آہنگ جلد پتہ لگانے کے طریقے شامل کر سکتے ہیں تاکہ وسائل کو موثر طریقے سے استعمال کیا جائے۔

Yockelson, Linder, and Asman کا لکھا مضمون جلد شناخت کے عمل میں استعمال ہونے والے طریقوں پر مرکوز ہے۔ مصنفین دکھاتے ہیں کہ اسکریننگ جائزے بچوں اور ان کے نوجوان والدین کی منفرد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس طرح استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ان کے کراس سیکٹر تعاون میں مثالیں پیش کی گئی ہیں جو دنیا بھر میں عملی کمیونٹیز میں لاگو کی جاسکتی ہیں۔ Horiguchi and Akiyama ٹوکیو، جاپان میں اپنی بچوں کے جائزے کی یونٹ میں کیا گیا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے تاخیر/ معذوری کی جلد شناخت سے متعلق اخراجات کا جائزہ لیا۔ ان کے مطالعے کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ بچے کی تشخیص کی

بنیاد پر مختلف اخراجات پائے گئے۔ جلد شناخت اور وسائل کے استعمال کے لیے ان کلینک مشاورتی نظام کے لیے مضمرات پائے گئے۔

Keilty, Blasco, and Acar ابتدائی بچپن میں نشوونما اور رویائی اسکریننگ، اہلیت کے جائزے اور پروگرام کی منصوبہ بندی کو مطلع کرنے کے لیے ایگزیکٹو فنکشن (EF) کا ایک ماڈل پیش کرتے ہیں۔ ان کا مضمون اسکول کی کامیابی کے لیے EF کی اہمیت پر زور دیتا ہے، نیز ابتدائی بچپن میں EF کی پیمائش کی حدود (مثلاً EF کا جائزہ لینے کے لیے پیمائشوں کی کمی) پر۔ EF ماڈل جلد مداخلت کے جائزے کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ Haglund, Dahlgren, Källén, Gustafsson and Råstam نے Observation Scale for Autism (OSA) نامی پیمائش کی سائیکومیٹرک خصوصیات کا جائزہ لیا تاکہ Autism Spectrum Disorders (ASD) کے جلد اشاروں کی اسکریننگ کی جاسکے۔ سویڈن میں ASD، Down syndrome اور عام نشوونما والے نوجوان بچوں نے مطالعے میں حصہ لیا۔ ان کے مطالعے کے نتائج تین سال سے کم عمر کے بچوں میں ASD کی جلد شناخت کے لیے OSA کے استعمال کے لیے مضمرات رکھتے ہیں۔ Tzouridadou, Vouyoukas, and Anagnostopoulou نے تھیسالونیکی، یونان میں ایک شمولیتی کنڈرگارٹن ترتیب میں RtI (response to intervention) کے استعمال کو جلد شناخت کی ایک شکل کے طور پر دریافت کیا۔ Aristotle University کے محققین اور انڈرگریجویٹ طلبہ نے RtI نافذ کرنے کے لیے کنڈرگارٹن اساتذہ کے ساتھ کام کیا۔ یونانی جلد شناخت کے نمونے کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ Busillo-Aguayo, Murawski, and Weiner لاس اینجلس، کیلیفورنیا میں مشکل سے پہنچنے والے بچوں اور خاندانوں کو تلاش کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ایک جدید موبائل اسکریننگ وین بیان کرتے ہیں۔ ان کے اسکریننگ منصوبے کے نتائج رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ان کی تحقیق کم آمدنی والے اور متنوع شہری علاقوں میں Child Find پروگراموں کے لیے مضمرات رکھتی ہے۔ اس خصوصی شمارے کے یہ مضامین طریقوں، جائزے کے طریقوں اور جلد پتہ لگانے کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشہ ور افراد ان مضامین کے کچھ ماڈلوں / فریم ورکس، تجاویز یا نتائج کا استعمال کر کے جلد شناخت کی کوششوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نوجوان بچے اور ان کے خاندان ایک موثر نظام سے فائدہ اٹھائیں گے جو بچے کی نشوونما کے بارے میں خدشات کا فوری اور درست جواب دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔

تحقیق کے اہم نتائج

جلد مداخلت کی حکمت عملیوں کی تاثیر اور نسبتی لاگت تاثیر پر مزید تحقیق کی واضح ضرورت کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن کئی خصوصیات بیان کردہ کامیاب مثالوں میں سے متعدد کے لیے مشترک کے طور پر ابھرتی ہیں۔ یہ ان میں منعکس ہیں۔ جہاں ممکن ہو، ان سنہرے دھاگوں کو ایک ساتھ لینے کی ضرورت ہے، جب وہ نظامی تبدیلی کے لیے ایک مربوط حکمت عملی بناتے ہیں۔

پانچ سنہرے دھاگے زندگی کی بہترین شروعات

اب چند سال پہلے سے بھی زیادہ معلوم ہے کہ بچے کی ابتدائی نشوونما، بشمول پیدائش سے پہلے، کس حد تک ان کی مستقبل کی زندگی کی بنیاد رکھتی ہے۔ لیکن اس علم کا بہت کم حصہ منظم طریقے سے لاگو کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ تمام بچے بہترین شروعات کریں؛ بہت کچھ اب بھی اس چیز پر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے اکثر پیدائش کا حادثہ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر والدین ابتدائی دماغی نشوونما کو فروغ دینے والی شرائط سے بڑی حد تک ناواقف ہیں اور افرادی قوت کے کچھ ارکان اس سے کم جانتے ہیں جتنا وہ جان سکتے ہیں۔

اہم پیغام

• اب اس بات کے مجبور کن شواہد موجود ہیں کہ بچے کو ابتدائی سالوں (رحم سے شروع ہو کر) جو کچھ تجربہ ہوتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، جسے قومی اور مقامی دونوں سطحوں پر پالیسی اور عمل میں منعکس کرنے کی ضرورت ہے۔

• بچوں کے مراکز اضافی ضروریات والے بچوں، خاندانوں اور کمیونٹیز کی مدد کے تسلسل کے 'مرکز' میں ہیں، لیکن انہیں ایک موثر رسائی کی حکمت عملی درکار ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ مداخلتیں کمیونٹی کے سب سے کمزور طبقات کو ہدف بنائیں اور ان کی مدد کریں۔

• دودھ پلانے کے نمایاں فوائد واضح طور پر بیان کیے جانے کے باوجود، انگلینڈ میں دودھ پلانے کی شرحیں یورپ میں سب سے کم ہیں۔ نمایاں بہتری حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے موثر مقامی اقدامات، جیسے Blackpool میں، درکار ہیں۔

• انگلینڈ میں Baby Friendly Hospital Initiative کے تحت تسلیم شدہ اسپتالوں کے موجودہ کم تناسب (10 میں سے 1 سے کم) کو ڈرامائی طور پر بڑھانے کے لیے تکمیلی اقدام درکار ہے، یہ معیارات کا ایک سیٹ ہے جو UNICEF اور WHO (World Health Organisation) نے دودھ پلانے کو فروغ دینے کے لیے تیار کیا ہے۔

• ساتھیوں کی مدد کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے: کمیونٹی کے رضاکار (بشمول مقامی والدین) جو پیشہ ور افراد کے ساتھ کام کرنے کی تربیت یافتہ ہوں، لیکن جن کے اسی طرح کے زندگی کے تجربات قابل رسائی کے فرق کو پورا کریں۔

زندگی کے لیے زبان

ابلاغ کرنے کی صلاحیت ایک ضروری زندگی کی مہارت ہے جو بچے کی مستقبل کی نشوونما کی بنیاد رکھتی ہے، لیکن عام طور پر سمجھے جانے سے زیادہ بچے جدوجہد کرتے ہیں۔ پھر بھی زبان اور ابلاغ کی مہارتوں کی اہمیت اور نوجوان بچوں کے لیے زبان سے بھرپور ماحول کی تخلیق کے بارے میں آگاہی عام طور پر ناکافی رہتی ہے۔ نہ صرف بہت سے والدین کے ساتھ، بلکہ پالیسی سازوں، خدمات کے کمیشنرز اور خدمت فراہم کنندگان میں بھی۔ عملی مثالیں اسے بہتر بنانے کے لیے متعدد نقطہ نظریات بیان کرتی ہیں اور یہ حوصلہ افزا ہے کہ زبان کی مشکلات کا ایک بڑا تناسب صحیح مدد سے ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ کچھ کے لیے لگتا ہے کہ یہ 1/25 سال کی عمر تک کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے ابتدائی سالوں کے عملے اور پرائمری اساتذہ ان ضروریات کو پورا کرنے میں اعتماد کی کمی کی رپورٹ دیتے ہیں۔

اہم پیغام

متاثرہ بچوں کا پیمانہ کافی ہے: 10 فیصد تک بچوں کو طویل مدتی، مستقل ابلاغی معذوری ہوتی ہے، اور سماجی طور پر محروم علاقوں میں تقریباً 50 فیصد کو اسکول میں داخلے پر نمایاں زبان کی تاخیر ہوتی ہے۔ ابلاغی مشکلات اور کم کامیابی، ذہنی صحت کے مسائل، ناقص ملازمت یا تربیت کے امکانات اور نوجوانوں کے جرم کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔

• چونکہ قومی اور مقامی سطح پر پالیسی سازوں اور کمیشنرز میں، اور کبھی کبھی والدین اور خاندانوں میں بھی، ناکافی سمجھ ہے، زبان اور ابلاغ کی مہارتوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھانا اور زبان سے بھرپور ماحول بنانا فوری طور پر ضروری ہے۔

• صحیح مدد سے، زبان کی تاخیر والے بہت سے بچے اپنے ہم عمروں کے برابر آجاتے ہیں، اور وہ جن کی پری اسکول تاریخ مستقل عارضوں کی ہو جو 1/25 سال کی عمر تک حل ہو سکتے ہیں (جو ایک اہم عمر لگتی ہے)۔ مستقل عارضوں کو بہتر بنانے اور سماجی محرومی سے منسلک مشکلات کے حل کو تیز کرنے کے لیے ابتدائی سالوں میں موثر مدد یا مداخلت نہایت اہم ہے۔

• ایک ہنرمند اور پر اعتماد افرادی قوت اہم ہے، جس میں ابتدائی عمر میں ابلاغی مسائل کی شناخت کرنے اور عارضی اور مستقل مشکلات میں فرق کرنے کی صلاحیت ہو تاکہ مناسب مداخلتیں کی جاسکیں۔ پھر بھی بہت سے ابتدائی سالوں کے عملے ان بچوں کی مدد کے لیے ناکافی طور پر لیس محسوس کرتے ہیں اور 60 فیصد سے زیادہ پرائمری اساتذہ میں بچوں کی زبان کی ضروریات کو پورا کرنے کی اپنی صلاحیت پر اعتماد کی کمی ہے۔

• موثر مقامی عمل کی خصوصیت ایک بڑے پیمانے کا تربیتی پروگرام اور معلومات کا پھیلاؤ تھا تاکہ عملے اور والدین دونوں کو جلد مداخلت اور مدد کو کامیابی سے ہدف بنانے میں لیس کیا جائے، جس کے نتیجے میں بچوں کے سیکھنے اور کامیابی، ماہرین کے اعتماد اور والدین کی رائے میں نمایاں بہتری آئی۔ دیگر اہم خصوصیات میں اعداد و شمار کا موثر استعمال، نہ صرف پیش رفت کو ٹریک کرنے کے لیے، ماہر عملے کے علم کو شیئر کر کے صلاحیت بنانا، اور مضبوط والدین کی شمولیت شامل تھی۔

والدین کی شمولیت

ہم جانتے ہیں کہ بچے کی ابتدائی نشوونما سے لے کر ان کی آزادی حاصل کرنے تک۔ بشمول زبان اور ابلاغ کی مہارتوں کا اہم حصول۔ کامیاب نتائج کے لیے اچھی والدیت کتنی اہم ہے۔ لیکن، پھر بھی، والدیت کی مدد کے لیے ہمارا قومی نقطہ نظر منظم نہیں ہے، جس کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے بچے اور نوجوان ایسے مسائل کا تجربہ کرتے ہیں جو بڑی حد تک قابل بچاؤ ہیں، اور جو ان کی زندگیوں کو۔ اور ان کے والدین اور خاندانوں کی زندگیوں کو۔ خراب کرتے ہیں، اکثر زیادہ سنگین حالات میں بڑھتے ہیں جن کے لیے مہنگی مداخلت درکار ہو سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ موثر مداخلت کا انحصار نہ صرف ان کے والدین، اور کبھی کبھی وسیع خاندان کو شامل کرنے کی حقیقت پر ہے، بلکہ ایسا کرنے کے طریقے پر بھی ہے۔ اس اشاعت کی مثالیں بار بار والدین کو ایک باہمی نقطہ نظر میں شامل کرنے کی اہمیت ظاہر کرتی ہیں، ان کی قوتوں پر تعمیر کرتی ہیں اور ان کے خیالات اور تجربات کو مد نظر رکھتی ہیں۔ وہ ان مسائل کو تسلیم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہیں جن کا خاندان خود اکثر سامنا کرتے ہیں اور ایسی حکمت عملیاں تیار کرنے کی جو اعتماد اور صلاحیت بنائیں تاکہ والدین اس اہم کردار کو صحیح طور پر پورا کر سکیں جو وہ ادا کرتے ہیں۔ وہ رسائی کے کام کے اہم حصے کو واضح کرتی ہیں جو اکثر ان خاندانوں سے رابطہ کرنے میں ہوتا ہے جو ورنہ خدمات سے محروم رہ جائیں گے، لیکن جنہیں اکثر عالمگیر یا ماہر (ہدف شدہ) فراہمی دونوں میں کامیابی سے کھینچا جاسکتا ہے۔ کئی مثالوں کی ایک اہم خصوصیت ساتھیوں کی مدد کا استعمال ہے: کمیونٹی کے رضاکار جو پیشہ ور افراد کے ساتھ کام کرنے کی تربیت یافتہ ہیں، لیکن جن کے اسی طرح کے زندگی کے تجربات قابل رسائی کے فرق کو پورا کرتے ہیں جو اکثر مدد کے حصول کو روکتا ہے۔ کسی حد تک، یہ پہلے Narrowing the Gap guidance میں شناخت کردہ مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے، کہ بہت سے پیشہ ور افراد اب بھی والدین کے ساتھ کام کرنے میں اعتماد کی کمی رکھتے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے ناکافی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ تر والدین کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور والدیت کی مدد کو 'معمول بنانا' اس کے فوائد کی رسائی کو بہت بڑھا دے گا۔

اہم پیغام

والدین بچوں پر سب سے نمایاں اثر ڈالتے ہیں، اور والدیت ان کی مستقبل کی زندگیوں کے لیے گہرے نتائج رکھتی ہے، اس لیے والدین کو یہ قائل کرنا ضروری ہے کہ ان کے بچے کی نشوونما میں مشغول ہونا فرق ڈال سکتا ہے، اور ان کی موجودہ قوتوں پر مثبت طور پر تعمیر کرنا اور انہیں فیصلوں میں فعال طور پر شامل کرنا۔ محرومی اچھی والدیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن خواندگی اور حسابی مہارت اور اعتماد کی کم سطح رکاوٹیں ہیں، اور خود اور اک والدین کی تبدیلی کی تحریک میں حصہ ڈالتا ہے۔ اس لیے ایسے والدین کو مدد کی خدمات سے مشغول ہونے پر قائل کرنا خاص طور پر اہم ہے یہ یقین دلا کر کہ وہ اپنے بچوں کے لیے حقیقی اور دیرپا فوائد لا سکتے ہیں۔

- چونکہ زیادہ تر والدین کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور موثر والدیت کی مدد والدیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے؛ منظم والدیت کی مدد پورے UK میں پھیلائی جانی چاہیے۔
- والدیت کے لیے پورے معاشرے کے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے: والدیت کو ایک ایسے معاملے کے طور پر منایا جانا چاہیے جہاں اعلیٰ معیار حاصل کرنا ہر ایک کے مفاد میں ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ سماجی طور پر قابل قبول ہو کہ وہ تسلیم کریں کہ وہ سیکھنے کے قابل ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ایک نجی معاملہ ہو جس میں مداخلت نہیں کی جانی چاہیے۔

ہوشیار کام، بہتر خدمات

قیادت کا معیار اس بات کا تعین کرنے میں اہم ہوگا کہ جلد مداخلت کی طرف زور کی تبدیلی کتنی دور ہے، اور یہ کتنی موثر ہوگی۔ مقصد کی وضاحت، اور بہتری لانے کا عزم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صحیح کام ہے۔ کمیشننگ نایاب عوامی وسائل کے استعمال کے بارے میں فیصلے کرنے کا ایک مضبوط، قابل اعتماد اور معروضی طریقہ فراہم کرتی ہے تاکہ ان کا بچوں اور خاندانوں کی زندگیوں پر زیادہ سے زیادہ مثبت اثر ہو۔ موثر کمیشننگ اس اسٹریٹجک سمجھ سے شروع ہوتی ہے کہ پورا نظام کیسے کام کرتا ہے اور کل وسائل کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ کامیابی کی ایک لہجہ یہ سمجھنا ہے کہ جلد مداخلت کے لیے تمام سطحوں پر نظام کی نئی سمت درکار ہے۔ بچوں اور خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شراکت میں کام کرنے والی ایجنسیوں کی اہمیت خدمت کی ترقی اور فراہمی کے نقطہ نظر میں حالیہ تبدیلیوں کے مرکز میں ہے۔ موثر جلد مداخلت کی بہت سی مثالیں واضح طور پر ایسے عمل سمیٹا ہوتی ہیں، یا تو بچوں اور خاندانوں کے ساتھ کام کرنے والی کثیر الضابطہ ٹیموں کی صورت میں۔ اکثر (common assessment framework) CAF کا استعمال کرتے ہوئے یہ تعین کرنے کے لیے کیا اقدام کیا جائے۔ یا، کچھ صورتوں میں، انتہائی تربیت یافتہ پیشہ ور افراد کے ایک گروپ کے ذریعے جو دیگر شعبوں کے ساتھیوں کی ضرورت کی شناخت میں مدد کرتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے مشترکہ نقطہ نظر کو سہولت دیتے ہیں۔ تمام ترتیبات میں عملے کو جلد مداخلت کے

اصولوں کی بڑھی ہوئی سمجھ، یہ کہ وہ جلد مشکلات کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں، یہ کہ انہیں کیسے جواب دینا چاہیے، اور دوسروں کے کردار کی سمجھ ہونی چاہیے۔ کچھ مداخلتیں، خاص طور پر وہ جن میں رسائی یا انتہائی مدد شامل ہے، عمل میں تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہیں تاکہ خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 'معمول' کے اوقات سے باہر خدمات پیش کی جا سکیں۔ ان میں اکثر دیگر ایجنسیوں کے ساتھیوں کے ساتھ قریبی طور پر کام کرنے والے ماہر عملہ شامل ہوتے ہیں، جس میں ایک لیڈیپشہ ور یا کلیدی کارکن مستقل مدد فراہم کرتا ہے۔ کچھ بچوں اور خاندانوں کے تجربہ کردہ مسائل ایک ہی مداخلت کا جواب دیں گے، دوسروں کو طویل مدتی مدد درکار ہوگی؛ کچھ پیچیدہ ہوں گے اور نسلوں کو بھی پار کر سکتے ہیں۔ اس لیے، یہ ضروری ہے کہ مدد کا ایک تسلسل دستیاب ہو جس میں کسی خاص وقت پر مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایسی فراہمی کو بنانا اور برقرار رکھنا اعلیٰ سطح کے بین ایجنسی تعاون کے ساتھ ساتھ خاندانوں کے ساتھ اچھے ابلاغ کی ضرورت رکھتا ہے۔

اہم پیغام

جب وسائل نایاب ہوں، اور افرادی قوت دباؤ محسوس کرے، تو موجودہ صورتحال کا دفاع کرنے (یا کم از کم اس سے چمٹے رہنے) کا رجحان ہوتا ہے جو جدت اور تبدیلی کو نافذ کرنا مشکل بنا سکتا ہے؛ لیکن صرف مختلف طریقے سے کام کر کے ہی بہتر نتائج حاصل کیے جائیں گے۔ پوری نظام کی تبدیلی فراہم کرنے میں پُر جوش اور بصیرت والی قیادت، موثر مشترکہ کمیشننگ کے ساتھ مل کر، اس لیے اہم ہے۔

• موثر کمیشننگ اس بات کے شواہد کو لاگو کرتی ہے کہ مقامی لوگوں کے لیے نتائج کو بہتر بنانے کے لیے کیا کام کرتا ہے اور جیسے جیسے بجٹ محدود ہوں گے یہ تیزی سے اہم ہوتی جائے گی۔ یہ نایاب عوامی وسائل کے استعمال کے بارے میں فیصلے کرنے کا ایک مضبوط، قابل اعتماد اور معروضی طریقہ فراہم کرتی ہے تاکہ ان کا بچوں اور خاندانوں کی زندگیوں پر زیادہ سے زیادہ مثبت اثر ہو۔

• چونکہ کچھ بچوں اور خاندانوں کو جاری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کی ضروریات 'جلد' مداخلت سے کافی حد تک پوری ہو سکتی ہیں تاکہ بعد کی مداخلتوں کو روکا جاسکے، خدمات کا ایک تسلسل درکار ہے تاکہ کسی خاص مقام پر مخصوص ضروریات سے ملنے کے لیے سب سے مناسب مداخلت کی شناخت کی جا سکے۔

• بین ایجنسی کام میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ موثر مربوط کام کی اہم خصوصیات جنہیں ہر جگہ موجود ہونے کی ضرورت ہے ان میں مشترکہ وژن رکھنا، ضروریات کی واضح سمجھ اور خلا کی شناخت، بچوں، نوجوانوں اور خاندانوں کے لیے نتائج کو بہتر بنانے پر تیز توجہ، عملے اور خاندانوں کو بتائے گئے واضح اور مستقل پیغامات، اور ایک بنیادی مربوط افرادی قوت کی ترقی کی حکمت

عملی شامل ہیں۔ اعتماد، مضبوط تعلقات بنانے اور، بالآخر، تمام ایجنسیوں سے خریداری حاصل کرنے کے لیے وقت لگانے کی ضرورت ہے۔

• CAF (Common Assessment Framework) عمل کے بارے میں عدم مطابقتوں اور الجھن کو دور کرنے کے لیے، اسے بچوں کی اضافی ضروریات کے لیے جائزے کرنے کے لیے معیاری آلے کے طور پر تیار کیا جانا چاہیے، اور ایک عمل کو تیار کرنے اور اس پر اتفاق کرنے کے لیے جس کے ذریعے ایجنسیاں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔

• شواہد بتاتے ہیں کہ ہر قسم کی ترتیبات میں پیشہ ور افراد میں والدین اور خاندانوں کے ساتھ براہ راست کام کرنے میں اعتماد اور تجربے کی کمی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ محروم ہوں۔ والدین کے ساتھ موثر طور پر مشغول ہونے کے لیے افرادی قوت کی مہارتوں اور صلاحیت کو ترقی دینے میں مسلسل سرمایہ کاری ضروری ہے۔

علم ہی طاقت ہے

بہت سے لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہم اکثر اس اعداد و شمار کا موثر استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو ہم پہلے سے جمع کرتے ہیں، چھوڑیں منظم طریقے سے جمع کرنا اور استعمال کرنا جو ہمیں حقیقی پیش رفت کرنے میں مدد کرے گا۔ موجودہ اعداد و شمار، اچھی طرح استعمال اور پوچھ کچھ کیے گئے، اکثر ضروریات کو پہلے اجاگر کریں گے۔ اور صحیح سوالات پوچھنا اکثر مداخلت کی زیادہ موثر شکلوں کی طرف لے جائے گا۔ Special Education Needs and Disability کے حالیہ Ofsted جائزے نے مشاہدہ کیا کہ، "جو چیز مستقل طور پر اچھی طرح کام کرتی تھی وہ انفرادی بچوں اور نوجوانوں کی پیش رفت کی سخت نگرانی تھی، جس میں فوری مداخلت اور اس کے اثر کا مکمل جائزہ تھا" (p 6)۔ یہ بچوں کی پیش رفت، یا اس کی کمی ہے جو اکثر کسی مسئلے کے وجود کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگرچہ اس اشاعت کی عملی مثالیں اعداد و شمار کو موثر طریقے سے استعمال ہوتے دکھاتی ہیں، بین الاقوامی مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہمیں دیگر ممالک سے کتنا کچھ سیکھنا ہے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ تمام سطحوں پر عملہ معروضی طور پر اپنے کام کی قدر کو پہچاننے کے قابل ہو، اور اپنے عمل کی پیمائش اور سوال دونوں کو اس کے اثر کا جائزہ لینے والے معروضی معیارات کے خلاف کرے۔

اہم پیغام

شواہد بتاتے ہیں کہ اعداد و شمار کا استعمال ایک نظامی کمزوری ہے۔ مختصراً، اگر ہم یہ ظاہر کرنے کے لیے شواہد فراہم نہیں کر سکتے کہ مداخلت کا مثبت اثر ہو رہا ہے، تو ہم اس کی فنڈنگ کا جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں؟

شواہد کو عمل کے لازمی حصے کے طور پر اور جدت کی مدد کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہم اس شعبے میں بین الاقوامی تجربے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔

- بین الاقوامی تحقیق بتاتی ہے کہ سب سے کامیاب پروگرام مشترک خصوصیات شیئر کرتے ہیں: وہ مخصوص آبادیوں کو ہدف بناتے ہیں؛ وہ انتہائی ہوتے ہیں؛ وہ رویے پر مرکوز ہوتے ہیں؛ وہ والدین اور بچوں دونوں کو شامل کرتے ہیں؛ اور وہ پروگرام کے وفادار رہتے ہیں۔
- موثر مقامی عمل کی خصوصیت مقصد کی وضاحت ہے؛ مداخلتیں ایک جامع شواہد کی بنیاد سے مطلع ہوتی ہیں؛ مقامی ضروریات کا واضح تجزیہ ہوتا ہے، بشمول بچوں، خاندانوں اور ماہرین کی رائے؛ اور، اہم طور پر، نتائج پر اثر کی پیمائش کے لیے اس کے نفاذ کے بعد اہم مراحل پر مداخلت کو ٹریک کرنے کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے۔

- بچوں کی خدمات کے اندر کافی تجزیاتی صلاحیت کو افرادی قوت کی ترقی کی ترجیح کے طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے (قومی اور مقامی دونوں سطحوں پر)۔

سرمایہ کاری کہاں بہتر ہے؟

جب وسائل نایاب ہوں، تو ترجیحات کو واضح طور پر قائم کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں وہاں مختص کرنا خاص طور پر اہم ہے جہاں نمایاں اثر اور سرمایہ کاری سے اچھی قیمت حاصل کرنے کا اعتماد ہو۔ بیان کردہ کچھ مثالیں آبادی کے گروپوں میں ضرورت کے مخصوص شعبوں پر ہدف شدہ توجہ کے ذریعے اثر حاصل کرتی ہیں، دیگر مخصوص گروپوں کو ہدف بناتی ہیں اور وسیع تر فوائد حاصل کرتی ہیں۔ دونوں نقطہ نظر بہترین قیمت فراہم کر سکتے ہیں۔

اہم پیغام

• کفایت شعاری کے وقت جلد مداخلت میں سرمایہ کاری کو کم کرنے کے لالچ کی مزاحمت کی جانی چاہیے، کیونکہ قلیل مدتی مالی فوائد طویل مدتی اخراجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ چیلنج اس لیے نہیں ہے کہ جلد مداخلت پر خرچ برقرار رکھا جائے یا نہیں، بلکہ یہ معلوم کرنا ہے کہ پہلے سے سرمایہ کاری کیے گئے پیسے سے بہتر قیمت کیسے حاصل کی جائے۔

• تحقیق کا طاقتور مجموعہ (ملک اور بیرون ملک) جو ظاہر کرتا ہے کہ بچے کو ابتدائی سالوں (رحم سے شروع ہو کر) جو کچھ تجربہ ہوتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، اس شعبے میں سرمایہ کاری کو ترجیح دینے کے لیے ایک مجبور کن دلیل بناتا ہے۔

• عام طور پر، ہدف شدہ نقطہ نظر عالمگیر نقطہ نظر سے زیادہ لاگت موثر سمجھے جاتے ہیں۔ پھر بھی اس بات کا تعین کرنے کے لیے بہت کم تقابلی شواہد ہیں کہ کون سا نقطہ نظر سب سے زیادہ 'لاگت موثر' ہو سکتا ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ ایک یا دوسرے کا سوال ہونے کا امکان نہیں ہے۔ جو درکار ہے وہ مداخلتوں کی ایک رینج ہے جو ضرورت کی مختلف سطحوں پر مدد فراہم کرنے کے قابل ہو۔

• خرچ کو بچوں کے مراکز اور ابتدائی سالوں (خاص طور پر دودھ پلانے کے اقدامات اور Nurse Family Partnership)؛ تقریر، زبان اور ابلاغ کی ضروریات؛ والدیت کے پروگراموں؛ ہدف شدہ خاندانی مدد؛ اور نگہداشت کے کنارے پر نوجوانوں پر ترجیح دی جانی چاہیے۔

• تجویز کردہ مداخلتوں میں سے تین — Nurse Family Partnership، Incredible Years اور Multi-Systemic Therapy — ان 11 'Blueprint' پروگراموں میں شامل ہیں جن کی Center for the Study and Prevention of Violence at the University of Colorado نے شناخت کی ہے جو 800 جلد مداخلت کے پروگراموں کے جائزے کے حصے کے طور پر تاثیر کے اعلیٰ معیارات پر پورا اترتے ہیں۔

• OECD کی تجویز کہ بچوں پر خرچ کو اس طرح سمجھا جائے جیسے یہ ایک سرمایہ کاری کا پورٹ فولیو ہو، اور بچوں کی بہبود کو واقعی بہتر بنانے کو یقینی بنانے کے لیے جائزے، دوبارہ مختص اور مزید جائزے کے مسلسل تکرار والے عمل سے گزارا جائے، اس قوم کے لیے ایک مشکل لیکن ضروری چیلنج پیش کرتی ہے۔ خاص طور پر بین الاقوامی تجربے سے سیکھنا ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کے لیے انمول ہو سکتا ہے، اگرچہ، بالآخر، بچوں، خاندانوں اور، درحقیقت، ملک کی طویل مدتی خوشحالی کے بہترین مفاد میں قومی اور مقامی سطح پر مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔

6.3 ابتدائی مداخلتوں کے ماڈلز

ہر بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نشوونما پا کر اپنی بہترین صلاحیت تک پہنچے۔ وہ چھوٹے بچے جن میں تاخیر یا معذوری کی علامات ظاہر ہوں، انہیں ایک مؤثر نظام کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں جلد از جلد شناخت کر سکے تاکہ روک تھام اور/یا ابتدائی مداخلت جلد از جلد شروع ہو سکے۔ دنیا بھر کی کمیونٹیز کو نظام میں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے۔ تحقیق نے ابتدائی مداخلت کاروں میں نمایاں قوتوں کو پایا ہے۔ ابتدائی مداخلت کے نتائج کا ایک مضبوط پیشگو پرانٹری سروس پرووائیڈر کا خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔

بچوں کی نشوونما اور سماجی و جذباتی بہبود پر نمایاں اثر ڈالنے کے لیے والدین کو ابتدائی مداخلتی خدمات میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ والدین کی معاونت، تعلیم، تربیت، خاندانی نیٹ ورکس کی مضبوطی، ہم عمر معاونت وغیرہ جیسی مداخلتیں والدین کے خود اعتمادی اور مہارتوں کو بنانے، والدین کی طویل مدتی روزگار کی صلاحیت بہتر بنانے اور بچوں کی بہبود اور نشوونما کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ روک تھام اور ابتدائی مداخلت کا نظریہ یہ ہے کہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی والدین اور خاندانوں کی معاونت کی جائے۔ صرف اسی طرح ہم خاندانوں کے بکھراؤ، خراب ذہنی صحت اور سماجی اخراج سے وابستہ بھاری طویل مدتی اخراجات سے بچ سکتے ہیں۔

ابتدائی مداخلت کے شعبے کے لیے آگے کا ایک اہم چیلنج یہ سمجھنا ہے کہ مختلف نشوونما کی ضروریات والے بچوں کے لیے مختلف اپروچز کے نسبتی اثرات کیا ہیں۔ ابتدائی مداخلت میں والدین کی تعلیم و تربیت کے کردار کے بارے میں لٹریچر میں بحث موجود ہے۔ ایک طرف، والدین والدین کی تعلیم چاہتے نظر آتے ہیں، اور مطالعات ماں اور بچے کے تعاملات اور ابتدائی مداخلت کی مؤثریت کے درمیان تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری طرف، اس بات کی تشویش ہے کہ والدین کی تعلیم گھر کی فطرت بدل سکتی ہے، اسے قدرتی ماحول سے غیر قدرتی ماحول میں بدل سکتی ہے، اور خاندانی تعلقات میں خلل ڈال سکتی ہے۔ ایک میٹا تجزیے میں پایا گیا کہ براہ راست تعلیمی تجربات حاصل کرنے والے بچوں نے ان پروگراموں کے بچوں کے مقابلے میں بڑے اور زیادہ دیر پا فوائد ظاہر کیے جو درمیانی راستوں پر انحصار کرتے تھے، جیسے والدین کی تربیت۔

ایک اور درمیانی رائے یہ ہے کہ والدین کی تعلیم والدین کی معاونت کی ایک خاص قسم ہو۔ والدین کی ضروری متعدد اقسام میں سے ایک۔ اور پیشہ ور افراد کے خاندانوں کے ساتھ تعاملات میں معاونت کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی زور دیا جانا چاہیے، جب اسے والدین کی ترجیح کے طور پر شناخت کیا جائے۔

معاونت کا ماڈل

پورٹج بچوں اور خاندانوں کے لیے معاونت کا ایک ماڈل ہے جسے گھر اور ابتدائی سالوں کی ترتیبات دونوں میں ڈھال کر مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پورٹج خصوصی ضروریات والے پری اسکول بچوں اور ان کے خاندانوں کے لیے گھر جا کر تعلیمی خدمت فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔

پورٹج کے مقاصد ہیں:

- خاندانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا تاکہ وہ اپنے اور اپنے چھوٹے بچوں کے لیے معیار زندگی اور تجربہ بہتر بنائیں، جس میں وہ مل کر سیکھ سکیں، مل کر کھیل سکیں، حصہ لے سکیں اور اپنی کمیونٹی میں اپنی ہی حیثیت سے شامل ہو سکیں؛

- چھوٹے بچوں اور ان کے خاندانوں کو درپیش معذور بنانے والی رکاوٹوں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا؛

- بچوں کے لیے شمولیتی خدمات کی قومی اور مقامی ترقی کی معاونت کرنا۔

اصل پورٹج ماڈل کے مخصوص اجزاء میں بچے کا جائزہ شامل تھا، جس کے لیے رسمی معیاری آلات اور غیر رسمی نصابی جائزے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس جائزے کی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے، گھر کا استاد اور والدین سکھائی جانے والی مہارتوں اور رویوں کا تعین کرتے ہیں۔ عموماً، ہر ہفتہ وار گھریلو ملاقات کے دوران تین سے پانچ مخصوص رویے منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کام کرتا ہے۔ ایسا خاندان جس کے بچے میں معذوری کا شبہ ہو، اسے ایسے پروگرام میں بھیجا جاتا ہے جو پورٹج ماڈل استعمال کرتا ہے۔ مثلاً جاپان میں، خاندان کو Japan Portage Association (JPA) میں بھیجا جاتا ہے۔ والدین بچے کو جائزے کے لیے JPA میں لاتے ہیں۔ اگر JPA یہ طے کرے کہ بچے میں ذہنی معذوری ہے تو وہ خاندان کو پورٹج کٹ استعمال کرنے کی سفارش کرے گا۔ پورٹج کٹ ایک ایکٹیوٹی کارڈ فائل ہے جو پیدائش سے چھ سال کی عمر تک کے 580 نشوونما کی ترتیب والے رویوں پر مشتمل ہے، پانچ شعبوں میں: سماجی سازی (Socialization)، خود مدد (Self-Help)، زبان (Language)، ادراک (Cognition) اور حرکت (Motor)۔ والدین کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے بچے کی نشوونما میں مدد کے لیے یہ کارڈز کیسے استعمال کریں۔ والدین بچے کی پیش رفت کا حساب رکھنے کے لیے ایک چیک لسٹ رکھتے ہیں۔ JPA کے معاملے میں، بحالی کا کارکن کبھی گھر نہیں جاتا، بلکہ کلائنٹس ہمیشہ JPA میں آتے ہیں۔ اس صورت میں پورٹج ادارے پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ CBR کے ایک آلے کے طور پر پورٹج کے بارے میں تنازعے میں حصہ ڈالتا ہے۔ See

.CBRNEWS No. 10, January 1992

تاہم، ادارتی بحالی کے برعکس، تھیراپی گھر میں ہوتی ہے جبکہ بچہ کمیونٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ڈھل رہا ہوتا ہے۔

ایک زمانے میں ابتدائی مداخلت کا شعبہ اس طرح منظم تھا جیسے پیشہ ورانہ معاونت (مثلاً تھیراپی کے سیشنز) کے بارے میں ہو جو براہ راست بچے کے نتائج کی طرف لے جاتی ہے۔

شکل 3: اثر کا خاکہ

بد قسمتی سے، شاید، اس سے نشوونمائی کے رجحانات پر بڑے اثرات مرتب نہیں ہوئے (Dunst, 1985)۔ تاہم، نگہداشت کرنے والے بچوں کی نشوونما پر بہت اثر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر مفتے بچے کے ساتھ کئی گھنٹے گزارتے ہیں۔ ہم بدلے میں نگہداشت کرنے والوں کی اہلیت اور اعتماد پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ بالغ لوگ مختصر وقت میں سیکھ سکتے ہیں اور اسے عام کر سکتے ہیں۔ لہذا، بچے کے نتائج تک پہنچنے کا ہمارا بہترین راستہ نگہداشت کرنے والوں کے ذریعے ہے۔ خاص طور پر گھریلو ملاقاتوں کے حوالے سے، گھریلو ملاقاتوں کے درمیان ہونے والے خاندان اور بچے کے تعاملات اور سیکھنے کے دیگر مواقع ہی ہیں جو بچے کے سیکھنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ مؤثر گھریلو ملاقاتیں ماڈل کے اجزاء میں سے ایک ہیں۔ مندرجہ ذیل جدول ہر جزو کو اس کی متعلقہ مخصوص مشق کے ساتھ ظاہر کرتا ہے:

جدول 1: ماڈل کے اجزاء

ایکو میپ

متعدد ضروریات مل کر اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ خاندانوں کے ساتھ ایکو میپ تیار کیے جائیں تاکہ خاندان میں ہماری دلچسپی ظاہر ہو، نہ صرف بچے میں۔ ہم خاندان کو بچے کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن بچہ ایک خاندان میں رہتا ہے، کسی خلا میں نہیں۔ خاندان کے ساتھ دوستانہ، دلچسپی والا تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ اس لیے انٹیک ملاقاتوں کے دوران یا خاندان سے تعارف کے کسی ابتدائی موقع پر ایکو میپ تیار کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔

شکل 4

سب سے پہلے جن لوگوں کا تعین کیا جاتا ہے وہ بچے کے ساتھ رہنے والے ہیں، انہیں درمیانی خانے میں رکھا جاتا ہے اور خاندان کے اندرونی تعلقات کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا۔ لہذا، عام طور پر ماں کے خاندان، باپ کے خاندان، محلے اور خاندانی دوستوں، ماں کے دوستوں اور باپ کے دوستوں کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ درمیانی معاونتوں میں عبادت کے دوست اور کام کے دوست شامل

ہیں۔ رسمی معاونتوں میں ڈاکٹرز، اساتذہ، تھیراپسٹس اور مالیاتی ادارے شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایجنٹ کی طرف سے فراہم کردہ معاونت کی تقریبی مقدار کا تعین کرنے کے لیے، ایسے سوالات پوچھے جاسکتے ہیں:

• "آپ ان سے کتنی بار ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں؟"

• "آپ کا ان کے ساتھ کیسا رویہ / تعلق ہے؟"

• "اگر آپ کے کسی بچے کے ساتھ کوئی اچھی بات ہوئی تو آپ کسے کال کریں گے؟"

لکیریوں کی موٹائی معاونت کی تین سطحیں ظاہر کرتی ہے۔ سب سے موٹی لکیریں بہت معاونت کرنے والے ایجنٹس کو ظاہر کرتی ہیں، قدرے پتلی لکیریں معتدل معاونت کرنے والے ایجنٹس کو ظاہر کرتی ہیں، اور سب سے پتلی لکیریں ان ایجنٹس کو ظاہر کرتی ہیں جو موجود تو ہیں لیکن زیادہ اضافی معاونت فراہم نہیں کرتے۔ ہم دباؤ کے ذرائع کو ظاہر کرنے کے لیے نقطہ دار لکیریں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہی جگہ ٹھوس اور نقطہ دار دونوں لکیریں ہونا ممکن ہے۔ مثال کے ایکو میپ میں دادا اور دادی کو دیکھیں، جہاں انہوں نے Michelle کی بچوں کی دیکھ بھال کی (کافی زیادہ معاونت) لیکن Sarah کی ساس نے اسے یہ بھی بتایا کہ اسے Michelle کی پرورش کیسے کرنی چاہیے (دباؤ)۔ ایکو میپ خاندانی ماحولیات کو سمجھنے کا ایک قیمتی طریقہ ہے۔

روٹینز پر مبنی انٹرویو

روٹینز پر مبنی جائزے کی ضروریات، جس کی اہم مشق انٹرویو ہے، بہت سی ہیں۔ فنکشنل اہداف یا نتائج پیدا کرنے کے لیے ایک طریقے کی ضرورت ہے۔ جنہیں ہدف رویے بھی کہا جاتا ہے۔ فنکشنل بچے کے نتائج وہ ہیں جو شرکت یا مصروفیت کی ضروریات، آزادی کی ضروریات اور سماجی تعلقات کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ نتائج کو اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ کافی ہوں مگر اتنا مخصوص بھی کہ کارآمد ہوں۔ حکمت عملیوں کی ضرورت ہے جو براہ راست فنکشن کے مسئلے کو نشانہ بنائیں (یعنی پہلے سکھائیں)۔ آخر میں، خاندان کے علاوہ نگہداشت کرنے والوں (مثلاً اساتذہ) کو بھی IFSP میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ روٹینز پر مبنی انٹرویو (RBI) ان ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ RBI دو ماڈلز کے ذریعے ارتقا پذیر ہوا: EINE کے لیے اس وقت بیان کردہ ماڈل اور انفرادی شمولیت (Individualizing Inclusion) ماڈل۔ مؤخر الذکر تین اجزاء پر مشتمل ہے: (a) RBI کے ذریعے فنکشنل مداخلتی منصوبہ بندی، (b) کلاس روم کی روٹینز میں ضم شدہ تھیراپی اور مشاورتی خصوصی تعلیم، اور (c) سرایت شدہ مداخلتیں۔

لہذا RBI گھر اور کلاس روم پر مبنی دونوں مداخلتوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ماڈل میں، روٹینز وہ سرگرمیاں نہیں ہیں جو پیشہ ور خاندان کے ساتھ مل کر ترتیب دیتا ہے۔ بلکہ، یہ قدرتی طور پر ہونے والی سرگرمیاں ہیں جو کسی باقاعدگی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان میں نگہداشت کے واقعات اور فارغ وقت گزارنے

کے اوقات دونوں شامل ہیں۔ اگرچہ ہمیں مسلسل یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک اچھا RBI روزمرہ کے واقعات کی فہرست سے کہیں زیادہ معلومات پیدا کرے گا، یہ سچ ہے کہ سب کچھ روٹینز میں نہیں ہوتا۔ اس لیے، انٹرویو کے وقت، ہم پہلے خاندان کی اہم تشویشوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انٹرویو کے آخر میں، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اور بات ہے جس پر گفتگو کی جائے۔ RBI جیسا کہ ہم نے اس کی تعریف کی ہے، سب سے پہلے Family-Centered Intervention Planning میں بیان کیا گیا تھا:

روٹینز پر مبنی اپروچ

پانچ مراحل کی وضاحت کی گئی تھی:

1. انٹرویو کے لیے خاندان اور عملے کی تیاری؛
2. روٹینز پر مبنی انٹرویو خود؛
3. خاندان کی طرف سے نتائج کا انتخاب؛
4. خاندان کی آراء کے ساتھ پیشہ ور افراد کی طرف سے مقاصد اور حکمت عملیوں کا تحریر کرنا؛
5. بعد کے مہینوں میں جائزہ۔

انٹرویو کی تیاری صرف یہ پوچھنے پر مشتمل ہے کہ خاندان اور بچوں کی دیکھ بھال کا کوئی بھی عملہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں اور واقعات کے بارے میں سوچے اور غور کرے کہ ان "روٹینز" میں سے ہر ایک میں بچہ کتنی اچھی طرح کام کرتا ہے۔ انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ منصوبہ بندی کے اجلاس کی ساخت روٹینز پر مشتمل ہوگی۔ جو لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کتاب میں فارم دستیاب ہیں! تیاری کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہاں کون ہوگا اور انٹرویو کہاں ہوگا۔ خاندان کو آزاد انتخاب یا انتخابوں کی ایک وسیع فہرست دی جانی چاہیے۔ انٹرویو خود اس سے شروع ہوتا ہے کہ خاندان پہلے اپنی روٹینز کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں۔ یہ خاندانوں کے نقطہ نظر کا احترام کرنے کے لیے بنیاد رکھتا ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال کا عملہ دوسرے نمبر پر "کلاس روم" کی روٹینز کے بارے میں رپورٹ دیتا ہے، اگر ٹیم اتنی خوش قسمت ہو کہ ایک ہی اجلاس میں خاندان اور بچوں کی دیکھ بھال کے عملے دونوں کا انٹرویو کر سکے۔ ایک یا دو افراد انٹرویو کر سکتے ہیں؛ نوٹس لینے کے لیے دوسرے شخص کا ہونا مفید ہوتا ہے؛ شاید روٹینز میں بچے کے کام کرنے کی رپورٹوں کی بنیاد پر ایک نشوونما آہ اسکور کرے؛ بچوں کو مصروف رکھے؛ اور سوالات پوچھنے میں مدد کرے۔ کوئی بھی سوال روٹینز کی گفتگو کے دوران پوچھا جانا چاہیے؛ ماہرین کے پاس ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا جب وہ اپنی شعبے سے متعلق تمام سوالات پوچھیں۔ پیشہ ور افراد مشورہ دینے سے گریز کرتے ہیں، تاکہ وہ ماہر نہ بن جائیں اور سننے کے توازن کو نہ بدلیں۔ کیونکہ ایک بار خاندان کو مشورہ ملنا شروع ہو جائے تو وہ اپنی روٹینز کے دوران کیا ہوتا ہے اس

کے بارے میں اعتماد سے کھل کر بتانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ہر روٹین کے لیے، انٹرویو لینے والا بالواسطہ طور پر چھ سوالات پوچھتا ہے:

1. باقی سب کیا کرتے ہیں؟ گھر کی روٹینز کے لیے، اس کا مطلب خاندان کے دیگر افراد ہیں؛ کلاس روم کی روٹینز کے لیے، اس کا مطلب دیگر بچے ہیں۔

2. بچہ کیا کرتا ہے؟

3. مزید خاص طور پر، اس کی مصروفیت کیسی ہے۔ بچہ روٹین میں کیسے اور کتنا حصہ لیتا ہے؟

4. اس کی آزادی کیسی ہے۔ بچہ خود سے کتنا کچھ کر سکتا ہے؟

5. اس کے سماجی تعلقات کیسے ہیں۔ بچہ دوسروں کے ساتھ کیسے بات چیت کرتا ہے اور کیسے مل جلتا ہے؟

6. نگہداشت کرنے والا روٹین سے کتنا مطمئن ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اگر چاہا جائے تو انٹرویو لینے والا اس مطمئن ہونے کا اسکوور بھی حاصل کر سکتا ہے۔

RBI دیگر طریقوں کے مقابلے میں زیادہ فنکشنل نتائج کی طرف لے جاتا ہے، خاص طور پر اس نیک نیتی والے سوال سے بہتر: "آپ کی تشویشیں کیا ہیں؟" وہ سوال عام طور پر چلنے اور بولنے کے بارے میں دو مبہم بیانات دیتا ہے۔ دوسرا عام طریقہ کسی ٹیسٹ یا نصاب سے ناکام آئمز کا انتخاب کرنا ہے، جن کا بچے اور خاندان کی زندگی میں بہت کم معنی ہو سکتا ہے۔

6 سے 10 نتائج پیدا کر کے، RBI بہت سے IFSPs سے زیادہ مخصوص ہوتا ہے اور خاندانی سطح کے زیادہ نتائج رکھتا ہے۔ یہاں RBI سے ایک حقیقی فہرست دی گئی ہے:

نوٹس کے اصل الفاظ	نتیجے میں بیان کردہ صورت
1. باہر اور اندر چیزوں پر چلنا (مثلاً سیرھیاں چڑھنا)	Elliott حرکت کے ساتھ تین آلات پر ہر ایک پر 5 منٹ کھیلے گا تاکہ وہ زیادہ حصہ لے۔
2. باہر کی ساخت (Texture)	Elliott سینڈ باکس میں کھیلے گا یا گھاس پر 10 منٹ لگاتار 3 بار چلے گا تاکہ وہ زیادہ حصہ لے۔
3. زیادہ کیوں نہیں کھاتا؟	خاندان ایک اہل پیشہ ور سے معلوم کرے گا کہ Elliott اتنا زیادہ کیوں نہیں کھاتا جتنا وہ کھاتا ہے۔
4. متنوع غذائیں کھانا	Elliott خاندان اور غذائی ماہر کی طرف سے مناسب قراردی گئی متوازن خوراک کھائے گا تاکہ وہ صحت مند رہے۔
5. کھانا اٹھانا	

Elliott انگلیوں سے کھانے کے لیے باریک چٹکی (pincer) گرفت استعمال کرے گا تاکہ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کھا سکے۔	
Mary کے پاس 7 سرگرمیاں ہوں گی جو وہ Elliott یا Katie کو چرچ کے دوران مصروف رکھنے کے لیے دے سکتی ہے تاکہ Mary کے لیے چرچ میں شرکت آسان ہو۔	6. چرچ کو آسان بنانا
Elliott کھانے، کپڑے پہننے یا فارغ وقت میں پیش کی گئی دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرے گا، روزانہ 5 دن تک، تاکہ فنکشنل ابلاغ شروع ہو۔	7. انتخاب کرنا

ایکو میپ اور RBI میں اس کا مقام کہاں ہے؟ یہ ایک "مقامی سوال" ہے جس کا مطلب ہے کہ ابتدائی مداخلت کاروں یا پروگراموں کو یہ فیصلہ اپنے نظاموں کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ زیادہ تر نظاموں میں ایک عمل ہوتا ہے جس میں ریفرل، انٹیک ملاقات، کثیر الشعبہ جاتی جائزہ اور IFSP کی تکمیل شامل ہوتی ہے۔ لہذا پیشہ ور افراد کو یہ پوچھنا ہوگا کہ کون، کب، کیا کرتا ہے۔ ان بچوں کے لیے جوابات مختلف ہو سکتے ہیں جو نظام میں قائم شدہ حالات کے ساتھ داخل ہوتے ہیں (جنہیں اس لیے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ انہیں کثیر الشعبہ جاتی جائزے کی ضرورت ہوتی ہے)، واضح تاخیروں کے ساتھ (جو اس لیے یقینی طور پر تاخیروں کے اہلیت کے معیار پر پورے اتریں گے)، اور مشتبہ تاخیروں کے ساتھ (جنہیں RBI پر آگے بڑھنے سے پہلے شاید اہل قرار دیا جانا چاہیے)۔

جب ہم RBI کے سیکشن کا اختتام کرتے ہیں تو ہمیں اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے درکار چار اصول بیان کرنے چاہئیں: 1. بچے پر اثر باقاعدہ نگہداشت کرنے والے ڈالتے ہیں، اور پیشہ ور افراد خاندان پر اثر ڈال سکتے ہیں؛ 2. بچے دن بھر سیکھتے ہیں؛ 3. بچے کے لیے تمام مداخلت پیشہ ور افراد کی ملاقاتوں کے درمیان ہوتی ہے؛ اور 4. بچے کو زیادہ سے زیادہ مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ خدمات کی نہیں۔

شکل 5

اس آخری فرق کو واضح کرنے کے لیے، مداخلت بچے کو فراہم کیے گئے سیکھنے کے موقع ہیں اور یہ قدرتی طور پر ان لوگوں سے آتے ہیں جو بچے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جیسے والدین، خاندان کے دیگر افراد اور بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے۔ خدمات پیشہ ورانہ معاونتیں ہیں، جو وقفے وقفے سے (مثلاً ہفتہ وار) مختصر (مثلاً 30 سے 60 منٹ) دورانیوں کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بحث کی گئی، ابتدائی مداخلت اس یقین پر قائم تھی کہ پیشہ ورانہ معاونتیں براہ راست بچے کے نتائج کی طرف لے جائیں گی۔ نوٹ کریں کہ کلاس روم تدریس کی صورت میں پیشہ ورانہ معاونتیں اب بھی براہ راست بچے کے نتائج کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لیکن، گھر کی ترتیبات میں، بچے کے نتائج پر اثر کا راستہ نگہداشت کرنے والے کی اہلیت - ان کا جاننا کہ کیا کرنا ہے - اور اعتماد کے ذریعے ہے۔

یہ ماڈل ٹرانس ڈسپلنری گھریلو ملاقاتوں کو نگہداشت کرنے والے کی اہلیت اور اعتماد حاصل کرنے کے بہترین اپروچ کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اگلے سیکشن میں بیان کیا جائے گا۔ اس ماڈل کے مطابق، مفتے میں کلاس رومز (مثلاً بچوں کی دیکھ بھال کی ترتیبات) میں کافی وقت گزارنے والے بچوں کے لیے، پیشہ ورانہ معاونتیں ضم شدہ خدمات کے ذریعے بہترین فراہم کی جاتی ہیں، جنہیں اس مضمون کے باہمی مشاورت (Collaborative Consultation) سیکشن میں بیان کیا جائے گا۔ ضم شدہ تھیراپی اور خصوصی ہدایت سرایت شدہ مداخلتوں کی طرف لے جاتی ہیں، جو بچے کے مثبت نتائج پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ لہذا یہ ماڈل ظاہر کرتا ہے کہ پیشہ ورانہ معاونتیں ان بالغوں کے ساتھ کام کرنے میں سب سے مؤثر طریقے سے استعمال ہوتی ہیں جو بچے کی زندگی میں فرق لاسکتے ہیں۔

پرائمری سروس پرووائیڈر اپروچ

EINE ماڈل میں، ایک پیشہ ور خاندان کو ہفتہ وار معاونت فراہم کرتا ہے، جس کی پشت پناہی دیگر پیشہ ور افراد کی ٹیم کرتی ہے جو پرائمری سروس پرووائیڈر کے ساتھ مشترکہ گھریلو ملاقاتوں کے ذریعے بچے اور خاندان کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ مشترکہ گھریلو ملاقاتوں کی شدت بچے، خاندان اور پرائمری سروس پرووائیڈر کی ضروریات پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے کچھ مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں مختلف پیشہ ور افراد براہ راست بچے اور خاندان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور شاذ و نادر ہی ایک دوسرے سے ابلاغ کرتے ہیں۔

پہلا، ملٹی ڈسپلنری اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے لیے مداخلتیں گھریلو ملاقاتوں کے دوران ہوتی ہیں، ملاقاتوں کے درمیان نہیں۔ دوسرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کو مظاہرے کی بھاری خوراکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان تمام ملاقاتوں کے لیے ایک عام توجیہ ہے۔ تیسرا، یہ بچے کے کام کرنے کو شعبوں سے متعلق دائروں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے باریک حرکت کے لیے OT، موٹی حرکت کے لیے PT اور ابلاغ کے لیے اسپیج لینگویج تھیراپی۔ چوتھا، اس کے لیے خاندان کا بہت وقت درکار ہوتا ہے، جسے "موقع کی قیمت" (opportunity cost) کہا جاتا ہے۔ جسے پروگرام خدمات کی لاگت کی بات کرتے وقت شاذ و نادر ہی مد نظر رکھتے ہیں۔ پانچواں، یہ کم دستیاب وسائل کو نامناسب طریقے سے مختص کرتا ہے، جب زیادہ تر بچے ایک مہینے یا ایک مفتے میں بھی متعدد فراہم کنندگان کی طرف سے متعدد ملاقاتیں حاصل کرتے ہیں۔

ٹرانس ڈسپلنری اپروچ، جو PSP کا ہم معنی ہے، اس لیے درکار ہے کیونکہ (a) ہمیں ایک ایسے طریقے کی ضرورت ہے جو اس بات پر زور دے کہ بچے واقعی کیسے سیکھتے ہیں، (b) ہمیں ایک ایسے منصوبے کی ضرورت ہے جو خاندان کی فنکشنل ضروریات کے گرد متحد ہو، (c) ہمیں خاندانوں کے پرائمری سروس پرووائیڈر کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے سے فائدہ اٹھانا ہے، (d) ہمیں ماہرین کو جتنا ممکن ہو مؤثر طریقے

سے استعمال کرنا ہے، اور (e) ہمیں اپنے محدود وسائل کو انتہائی مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ پرائمری سروس پرووائیڈر (PSP) ایروچ PSP کے ساتھ اکیلے کام کرتا ہے، جو زیادہ تر گھریلو ملاقاتیں کرتا ہے، کبھی کبھار کسی ساتھی - کسی دوسری خدمت کی نمائندگی کرنے والے ٹیم ممبر - کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ بہترین کام کرتا ہے اگر IFSP تیار کرنے کے لیے RBI استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ نتائج کی حتمی فہرست کسی خدمت کی توجیہ سے نہیں بلکہ خاندان کی ترجیحات سے چلتی ہے۔ ایک جنرلسٹ جیسے استاد یا بچے کی نشوونما کا پیشہ ور یا ایک ماہر جیسے OT، PT یا اسپیشیالنگوئج پیٹھالوجسٹ PSP ہو سکتا ہے۔ جب جنرلسٹس اور ماہرین کا امتزاج استعمال کیا جاتا ہے، جو اکثر صورت ہوگی؛ جنرلسٹس اپنا زیادہ تر وقت اپنی کیس لوڈ والی فیملیز پر گزاریں گے، دوسروں کی فیملیز کے ساتھ کبھی کبھار مشاورت کرتے ہوئے۔ دوسری طرف، ماہرین اپنا زیادہ تر وقت مشاورت میں گزاریں گے لیکن چند فیملیز کے لیے PSP ہوں گے۔

یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ٹیم میں سے کون کسی خاص خاندان کا PSP ہو، ٹیم کم از کم تین عوامل پر غور کر سکتی ہے۔ پہلا، وہ جغرافیہ پر غور کر سکتے ہیں، خاندان کو ایسے PSP کو دے کر جو پہلے سے اس علاقے میں فیملیز کو دیکھ رہا ہو۔ دوسرا، وہ کیس لوڈ کے سائز پر غور کر سکتے ہیں، خاندان کو ایسے ٹیم ممبر کو دے کر جس کے پاس نسبتاً کم کیسز ہوں۔ تیسرا، وہ PSP کی دلچسپی یا مہارت کے ملاپ پر غور کر سکتے ہیں۔ ابتدائی مداخلتی پروگراموں میں PSPs کو فیملیز سے ملانا ہو سکتا ہے لیکن ان ریاستوں میں یہ مشکل ہے جو وینڈر ایروچ استعمال کرتی ہیں، جہاں انفرادی فراہم کنندگان کو Part C کی فیملیز کی خدمت کے لیے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں، فراہم کنندگان اس بارے میں انتہائی فکر مند ہوتے ہیں کہ کاروبار کسے ملتا ہے؛ درحقیقت، وہ اس تشویش کی وجہ سے ایروچ کو پڑی سے اتار سکتے ہیں۔ PSP ایروچ شک کرنے والوں سے خالی نہیں ہے؛ درحقیقت، کچھ لوگ اس سے خوفزدہ ہیں! تاہم، جیسا کہ Oscar Wilde نے کہا تھا، "امید کی بنیاد محض دہشت ہے۔" اور Helen Keller نے کہا تھا، "کسی مایوس شخص نے کبھی ستاروں کا راز دریافت نہیں کیا، یا کسی غیر نقشہ شدہ زمین کی طرف سفر نہیں کیا، یا انسانی روح کے لیے کوئی نیا دروازہ نہیں کھولا۔" لہذا، ایک بار ماہرین اپنی دہشت سے نکل کر پر امید، نہ کہ مایوس، ہو جائیں گے تو وہ اس ایروچ کے اثر کو دیکھیں گے۔

یہ ایروچ پہلے بیان کردہ اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے کہ تمام مداخلت ماہرین کی ملاقاتوں کے درمیان ہوتی ہے (تجھی بچے سیکھتے ہیں)، کہ تھیراپی اور ہدایت گالف کے اسباق نہیں ہیں (چھوٹے بچے مرکوز آزمائشوں کو پروسیس نہیں کر سکتے اور مہارتیں مؤثر طریقے سے منتقل نہیں کر سکتے)، اور باقاعدہ نگہداشت کرنے والوں (نہ کہ بچے کے ساتھ براہ راست کام کرنے والے ماہرین) کو اہداف کا مالک ہونا چاہیے۔

معاونت پر مبنی گھریلو ملاقاتیں

بہت سی گھریلو ملاقاتیں کلینک پر مبنی ماڈل سے زیادہ کچھ نہیں ہیں جسے ڈرائنگ روم کے فرش پر لاپھینکا گیا ہو۔ بہت سی میں کھلونوں کا تھیلا شامل ہوتا ہے۔ بہت سی نشوونما پانے والے بچوں اور ان کے خاندانوں کی پیچیدہ، باہم مربوط ضروریات کو نظر انداز کرتی ہیں۔ ایک متبادل اس نقطہ نظر پر مبنی ہے کہ معاونت ہی خدمات کے اہداف ہیں۔ خاندان پر مرکوز گھر پر مبنی ابتدائی مداخلت کی بنیاد کے طور پر معاونت کی تین اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے: جذباتی، مادی اور معلوماتی۔ خاندان پر مرکوز خدمت فراہم کرنے والوں کے ایک مطالعے میں پانچ خصوصیات کی نشاندہی کی گئی: مثبتیت، جواب دہی، پورے خاندان کی طرف رجحان، دوستانہ رویہ اور حساسیت۔ یہ خصوصیات یہ طے کرتی ہیں کہ خاندانوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے اور ان سے کس بارے میں بات کی جائے۔ انہیں جذباتی معاونت کا خلاصہ سمجھا جاسکتا ہے۔

مادی معاونت دو عمومی زمروں پر مشتمل ہے:

1. آلات اور مواد اور

2. مالی معاونت۔

معلوماتی معاونت معلومات کی ان چار اقسام پر مشتمل ہے جو زیادہ تر خاندان چاہتے ہیں:

1. بچے کی نشوونما،

2. بچے کی معذوری،

3. خدمات اور وسائل، اور

4. بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔

6.4 کثیر الشعبہ جاتی اپروچ کا تصور اور اہمیت

چھوٹے بچوں کی نشوونما کا بروقت اور وقفہ وقفہ سے جائزہ اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ نشوونما کی معذوریوں کی شناخت اور علاج ان کے ظہور کے ابتدائی ترین موقع پر کیا جائے اور نشوونما کی صلاحیت کے ضیاع کو روکا جائے۔ یہ نشوونما کی خطرے کے عوامل کی نشاندہی کرنے اور موثر پیشگی رہنمائی کو نشانہ بنانے میں بھی مدد کر سکتا ہے تاکہ والدین کو بہترین نشوونما کی نتائج کو فروغ دینے کی حکمت عملیاں فراہم کی جائیں۔ نیورو نشوونما کی تاخیر کی درست ابتدائی شناخت اور انتظام مختلف سطحوں پر کئی پیشہ ور افراد کے لیے منفرد چیلنجز پیش کرتا ہے، لیکن یہ بچوں اور ان کے خاندانوں کی بہبود کے لیے نہایت اہم ہے اور ان کے درست جائزے اور انتظام کے لیے ایک مرکزی پیشگی شرط ہے۔ کلینیشنز کو والدین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ابتدائی مداخلتی

پروگراموں میں حصہ لیں، کیونکہ اعلیٰ معیار کے مادری تعالیٰ رویے نشوونمائی میں تاخیر والے بچوں میں بہتر نشوونمائی نتائج سے منسلک جانے جاتے ہیں۔

ابتدائی نشاندہی کا ایک عام اپروچ بہترین مداخلت اور ثانوی معذوریوں کی حد بندی کو یقینی بنانا ہے، جو نشوونمائی نگرانی (developmental surveillance) ہے۔ نگرانی پروگرام کے حصے کے طور پر اسکریننگ مختلف مقررہ اوقات اور مختلف مقامات پر ہوتی ہے، جن میں ڈیلیوری پوائنٹس، تسلیم شدہ پیشہ ور افراد کی گھریلو ملاقاتیں، خصوصی بچوں کے مراکز اور اسکول شامل ہیں۔ برطانیہ میں، پیدائش سے 5 سال کی عمر تک کا ہر بچہ Healthy Child Programme (HCP) سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو انگلینڈ میں بچوں کی صحت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے روک تھامی اور صحت کے فروغ کی حکمت عملیوں کو شامل کرتا ہے۔ HCP کے بنیادی کاموں میں سے ایک معذوری اور نشوونمائی تاخیر کو پہچاننا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ بچوں کو ماہر خدمات کے لیے مناسب ریفرل ملے، اور خاندانوں کو وسیع تر معاونت کی خدمات کی طرف رہنمائی کی جائے۔ یہ اسکریننگ ٹیسٹوں اور نشوونمائی نگرانی، نشوونما کا جائزہ لینے، سماجی اور جذباتی خطرے کے عوامل کی نشاندہی کرنے، ان خاندانوں کو اضافی جاری معاونت فراہم کرنے جنہیں جذباتی اور سماجی معاونت کی ضرورت ہے اور ان بچوں کو جنہیں خراب نتائج کا خطرہ ہے، کے لیے ایک انمول موقع فراہم کرتا ہے۔

نشوونمائی جائزے کے پروگرام مختلف قسم کے پیشہ ور افراد کی شمولیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایک کثیر الشعبہ جاتی ٹیم کا حصہ ہیں، جن میں سے ہر ایک بچوں اور ان کے خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مناسب طور پر ہنرمند اور تیار ہے۔ کثیر الشعبہ جاتی اور بین پیشہ ورانہ اپروچ کو بچپن کی بہت سی صورتحوالوں کے انتظام میں مؤثر دستاویز کیا گیا ہے، جو صحت مند بچے کی نگرانی سے لے کر اندرون مریض ذہنی صحت کی دیکھ بھال تک پھیلی ہوئی ہیں۔

پرائمری کیئر اعلیٰ معیار کی نشوونمائی نگرانی کی تربیت اور فروغ کے لیے وسیع مواقع کا ایک منفرد شعبہ فراہم کرتی ہے۔ نشوونمائی یا نیورو رویے کے ماہرین اطفال وہ سرکردہ پیشہ ور افراد ہیں جو نیورو نشوونمائی عوارض والے بچوں اور نوجوانوں کی دیکھ بھال اور انتظام میں شامل ہیں۔ جائزہ، تحقیق اور خاندان سے مشاورت، ایک کثیر الشعبہ جاتی ٹیم کے تعاون سے، ماہرین اطفال کی بنیادی ذمہ داری کا حصہ ہیں، جن میں بچے اور خاندان کی ضروریات کا سوچا سمجھا جائزہ بھی شامل ہے۔ نیورو رویے کے ماہرین اطفال (NBP) ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جنہیں حیاتیاتی اصل کے مسائل ہیں، جو ثابت نہ بھی ہوں تو فرض کیے جاتے ہیں، جو بچے کی نشوونما اور/یا رویے پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس میں نہ صرف انفرادی بچے بلکہ ان کے سماجی نظام اور سیاق، کثیر الشعبہ جاتی خدمات بشمول جسمانی اور ذہنی صحت، سماجی اور انصافی خدمات کی شمولیت کا ایک پیچیدہ تعامل شامل ہے۔

بچے سے بچے کے درمیان نشوونما کی سنگ میل کے وقت میں وسیع فرق ہوتا ہے، لیکن ہر بچہ اپنے ہی انداز کے مطابق مسلسل نشوونما پاتا ہے۔ مخصوص نشوونما کی عوارض جیسے ڈسلیکسیا، توجہ کی کمی کی پیش فعالی کا عارضہ، آٹزم سپیکٹرم عارضہ اور سماعت کی پروسیسنگ کے عوارض (APD) اکثر زبان، خواندگی اور توجہ کی خرابیوں کے ساتھ مل کر ہوتے ہیں۔ ہر بچے کو تشخیص اور انتظام کے لیے اکثر کثیر پیشہ ورانہ اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ بچوں کو معاونت اور مداخلت کی سب سے مناسب حد تک رسائی حاصل ہو۔ پیشہ ور افراد کی بہت سی کیٹگریز اکثر شامل ہوتی ہیں، جن میں تھیراپسٹس (اسپیچ اور لینگویج، آکیوپیشنل تھیراپسٹس)، نفسیات اور ذہنی صحت کے پیشہ ور افراد، ماہرین اطفال، نرسز سمیت پرائمری کیئر کے پیشہ ور افراد، سماجی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد، متعلقہ صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد (مثلاً آڈیالوجی/ویسٹیبولو آڈیٹری)، ایجوکیشنل سائنس لوجسٹ سمیت تعلیمی عمل، ابتدائی سالوں کے پریکٹیشنرز اور نرسری نرسز شامل ہیں۔

اسپیچ اور لینگویج کی تاخیر زیادہ تر آبادیوں میں پری اسکول بچوں میں سب سے عام نیورو نشوونما کی عوارض (NDD) میں سے ایک ہے۔ اسپیچ اور لینگویج کی تاخیر والے بچے کے لیے آؤٹ پیشنٹ مشاورت اکثر کثیر الشعبہ جاتی اپروچ کی متقاضی ہوتی ہے اور اس میں منظم تاریخ، معائنہ اور متعلقہ ہدف بنائی گئی تحقیقات شامل ہونی چاہئیں جس کا مقصد یہ شناخت کرنا ہو کہ تاخیر بنیادی نوعیت کی ہے یا ثانوی، تاخیر کی درست تشخیص تک پہنچنا اور مناسب علاج کو ممکن بنانا۔ اس کے لیے بچے کے والدین کا مکمل تعاون بھی درکار ہوتا ہے۔ پری اسکول نیورو نشوونما کی عوارض اکثر متعدد باہم مربوط شعبوں کو متاثر کرتے ہیں اور ہم راض یا ہم وقت معذوریوں اکثر مستثنیٰ کی بجائے معمول ہوتی ہیں۔ لہذا بین الشعبہ جاتی ٹیموں کے اندر مؤثر اور جامع خدمات اور کارکردگی کی ضرورت اکثر انتہائی اہم ہوتی ہے۔ آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر (ASD) ان دیگر عام اور نمایاں طور پر معذور بنانے والے نیورو رویے کے عوارض میں سے ایک ہے جو پری اسکول کی عمر سے ظاہر ہوتے ہیں۔

ایک ہی بچوں میں توجہ کی کمی کے عارضے (ADHD) اور ASD کی علامات کا امتزاج عام ہے اور متعدد اور لپنگ ہم راضیاں رپورٹ کی گئی ہیں۔ مشترکہ علامات والے بچوں کا IQ کا اوسط کم، آٹزم کی علامات کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور وہ پری اسکول کی عمر میں بہت جلد ظاہر ہوتے ہیں۔ مشتبہ ASD والے بچوں کے زیادہ تر والدین اور اساتذہ کو بچے کی نشوونما کے بارے میں پہلی تشویش بچے کی دوسری سالگرہ سے پہلے ہوتی ہے۔ ASD والے بچوں میں بہتر طویل مدتی نتائج کا تعلق والدین کی جلد تشویش، ماہرین کو جلد ریفرلز اور جلد اور زیادہ شدید مداخلتوں سے رہا ہے۔ Otolaryngologist سمیت جراحی کے پیشہ ور افراد ASD، آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر (APD) اور ڈاؤن سنڈروم جیسے ND عوارض والے افراد کے کثیر الشعبہ جاتی انتظام میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ان مریضوں میں کان کی بیماریوں کی زیادہ شرح کی وجہ سے۔ ASD کے مریضوں

میں گہری سینسوری نیورل سماعت کی کمی، درمیانی کان کے انفیکشن اور کوکلیٹر اعصاب اور برین اسٹیم سماعتی راستوں کی غیر معمولیات کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ ASD کے مریض میں سماعتی معلومات کی تشریح اور پروسیسنگ کے طریقے میں کوریٹکل اور برین اسٹیم نیورو نشوونمائی غیر معمولیات موجود ہوتی ہیں۔ ابتدائی مداخلت روایتی طور پر کثیر الشعبہ جاتی اپروچ سے بین الشعبہ جاتی اور ٹرانس ڈسپلنری مشق کی طرف بڑھی ہے۔ ایک بین الشعبہ جاتی ماڈل وہ ہے جہاں ٹیم کے اراکین اپنے اپنے نقطہ نظر استعمال کرتے ہیں، بچوں کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن پھر اپنی دریافتوں پر بحث کرتے ہیں اور باہمی طور پر فیصلوں تک پہنچتے ہیں۔ ایک ٹرانس ڈسپلنری ماڈل ٹیم میں شامل ابتدائی مداخلت کے پیشہ ور افراد سے ضم شدہ مداخلتیں فراہم کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک شخص، ٹیم ممبرز کے تعاون سے، بچے کے انفرادی منصوبے کے نفاذ کی بنیادی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ٹیم ممبرز کے درمیان "اہلیتوں کا تبادلہ" عام طور پر کردار کی رہائی (role release) کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔

ٹرانس ڈسپلنری ماڈل کے فوائد میں یہ حقیقت شامل ہے کہ یہ خاندانی نظاموں میں کم مداخلت کرتا ہے، اور ٹیم ممبرز کے درمیان بڑھتے ہوئے ابلاغ اور مداخلتی منصوبے کے نفاذ میں مستقل مزاجی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

ابتدائی نشاندہی کی توجیہ یہ ہے کہ یہ بچے کے بہتر نتائج کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ یہ:

1. بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور نظر اندازی کو روکنے میں مدد کرتی ہے
2. بدسلوکی اور نظر اندازی کے اثرات کو کم کرتی ہے
3. والدین کی مہارتوں کو بہتر بناتی ہے
4. خاندانوں کو مضبوط بناتی ہے
5. بچے کی نشوونمائی، سماجی اور تعلیمی حاصلات کو بہتر بناتی ہے؛
6. خصوصی تعلیم، بحالی اور صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات کی مستقبل کی لاگتوں کو کم کرتی ہے؛
7. تنہائی، دباؤ اور مایوسی کے جذبات کو کم کرتی ہے جو خاندان محسوس کر سکتے ہیں؛
8. مثبت رویے کی حکمت عملیوں اور مداخلتوں کے استعمال سے رویوں کو کم کرنے اور ختم کرنے میں مدد کرتی ہے؛
9. معذوری والے بچوں کو بڑے ہو کر پیداواری، آزاد افراد بننے میں مدد کرتی ہے
10. تکنیکی آلات، مشاورت اور خاندانی تربیت میں معاونت۔

بہت سے معاملات میں، ابتدائی مداخلت کے پیشہ ور افراد مداخلت فراہم کرنے کے لیے ابتدائی بچپن کی تعلیم کے عملے کے ساتھ بھی قریبی تعاون کریں گے۔ تاہم، ابتدائی مداخلت کے پیشہ ور افراد کو بچوں اور اساتذہ دونوں کے ساتھ اپنے تعاملات میں "ماہر" کا کردار اپنانے سے ابتدائی بچپن کے اساتذہ کو خارج کرنے کے امکان سے آگاہ رہنا چاہیے۔ مؤثر تعاون کے لیے ابتدائی مداخلت کے پیشہ ور افراد، ابتدائی بچپن کی تعلیم کے اساتذہ اور والدین (یا دیگر نگہداشت کرنے والوں) کے درمیان مثبت تعلقات کا قیام درکار ہے۔

بین الشعبہ جاتی ماڈلز کے کلیدی اصول یہ ہیں کہ:

1. ٹیمیں، بشمول خاندان کے افراد، فیصلے کرتی ہیں اور مل کر کام کرتی ہیں

2. پیشہ ور افراد شعبہ جاتی حدود کو عبور کرتے ہیں

3. مداخلت فنکشن پر مرکوز ہے، خدمات پر نہیں

نشوونمائی تاخیروں کے جائزے کے لیے بین الشعبہ جاتی اپروچ اور ہمہ جہت ضم شدہ خدمات والے کثیر الشعبہ جاتی ٹیمیں متعدد ممالک میں قائم کی گئی ہیں، جن میں بھارت، فن لینڈ، سویڈن اور برطانیہ شامل ہیں۔ یہ اپروچ تمام بچوں کے لیے ایک صحت مند متحرک مستقبل کو یقینی بناتا ہے۔ کثیر الشعبہ جاتی پیشہ ورانہ ٹیم (MDT) اپروچز پہلے سے ہی ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور دیگر دائمی بیماریوں جیسے کینسر کی فراہمی کے لیے معیاری طریقہ کار ہیں، جن میں صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد، پالیسی ساز اور مریضوں کے نمائندے شامل ہیں۔

ضم شدہ کام کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ کوئی بچہ خدمات کے درمیان خلا میں نہ گرے، اور بڑھتے ہوئے سخت احتساب کی ثقافت میں متعدد خدمات کی طرف سے کام کی دوہرائی کو کم کیا جائے۔ کئی آلات لازمی قرار دیے گئے جنہوں نے بظاہر ضم شدہ کام کو آسان بنایا، جیسے 'lead'، 'common assessment framework'، 'professional' کا کردار، تمام خدمات کے لیے دستیاب معلومات کا ڈیٹابیس جسے 'contact point' کہا جاتا ہے اور 'information sharing' کے پروٹوکول۔

پری اسکول نشوونمائی نگرانی کے پروگراموں کو مؤثر ہونے کے لیے ہمہ جہت طور پر منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ بین پیشہ ورانہ تعاون کامیاب نشوونمائی مداخلتی تھیراپیوں کا ایک اہم پہلو ہے۔

6.5 خود احتسابی سوالات

مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1. ابتدائی نشاندہی اور جائزے کی تعریف کریں۔

2. ابتدائی مداخلتی نظام میں کون سی مختلف خدمات شامل ہیں؟
3. ابتدائی نشاندہی اور مداخلت کے کیا فوائد ہیں؟ تحقیقی نتائج کا بھی حوالہ دیں۔
4. The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) کے حصہ C کا مختصر خاکہ بیان کریں۔
5. موجودہ ٹیکنالوجی خصوصی بچوں کو تلاش کرنے میں کس طرح مددگار ہے، اور خصوصی ضروریات کو کتنی جلد شناخت کیا جاسکتا ہے؟
6. رسک رجسٹریوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور رسک رجسٹری کے ذریعے خصوصی ضروریات کی شناخت کیسے کی جاسکتی ہے؟
7. American Academy of Pediatrics کی طرف سے تجویز کردہ کچھ جائزے کے آلات بیان کریں۔
8. یہ کیا ہیں؟ RTI، ECOMAP، RBI اور Parenting shops۔
9. نظام میں تبدیلی کے لیے ایک مربوط حکمت عملی تیار کرنے کے لیے اکٹھے کیے گئے پانچ سنہری دھاگوں کو بیان کریں۔
10. ابتدائی مداخلت کے لیے کثیر الشعبہ جاتی اپروچ کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں۔

6.6 ویب لنکس

گہرے مطالعے کے لیے درج ذیل ویب سائٹس دیکھیں۔

- http://www.floridahealth.gov/alternatesites/cms-kids/providers/early_steps/training/documents/early_intervention.pdf
- <http://www.parentcenterhub.org/ei-overview>
- <http://teachersofindia.org/en/article/special-needs-identification-and-intervention-early-childhood-years>
- <http://www.family-friendly-fun.com/special-needs/early-intervention.htm>
- https://www.educationcounts.govt.nz/publications/special_education

22575

• [/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538781](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538781)

یونٹ 7: معذوری کے بارے میں رویہ: فرد، خاندان اور برادری

تحریر: Dr. Tanzila Nabeel

نظر ثانی: Dr. Shaista Majid

تعارف

رویہ ایک میلان ہے جو لوگوں، اشیاء، واقعات، سرگرمیوں، خیالات یا آپ کے ماحول میں تقریباً ہر چیز کے مثبت یا منفی جائزے پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ہماری آراء اور عقائد کو شامل کرتا ہے یا ان سے قریب سے متعلق ہوتا ہے اور ہمارے تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔ چونکہ رویے اکثر کسی نہ کسی طرح دوسروں کے ساتھ تعامل سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے یہ شناختی اور سماجی نفسیات کے درمیان ایک اہم ربط کی نمائندگی کرتے ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ تجربے کے فعل کے طور پر رویے تبدیل ہوں گے۔

رویوں کی ساخت

Saul McLeod (2009) کے مطابق، رویوں کی ساخت کو تین اجزاء کے لحاظ سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

عاطفی جز (Affective component): اس میں کسی شے کے بارے میں شخص کے احساسات / جذبات شامل ہیں جو مثبت، غیر جانبدار یا منفی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر: "مجھے سانپوں سے ڈر لگتا ہے۔"

طرز عمل کا جز (behavioral یا conative component): یعنی وہ طریقہ جس سے رویہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ طرز عمل کا جز کسی شے کی طرف مخصوص طریقے سے برتاؤ کرنے کے شخص کے رجحانات پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر: "اگر مجھے سانپ نظر آئے تو میں چیخوں گا۔"

شناختی جز (Cognitive component): اس میں کسی شے کے بارے میں شخص کے عقیدے اور معلومات شامل ہیں۔ مثال کے طور پر: "میرا عقیدہ ہے کہ سانپ خطرناک ہیں۔"

یہ ماڈل رویوں کے ABC ماڈل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تینوں اجزاء عام طور پر آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ تاہم، اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ رویے کے شناختی اور عاطفی اجزاء ہمیشہ طرز عمل سے مطابقت نہیں رکھتے۔

رویوں کے افعال

رویے فرد کے لیے افعال انجام دے سکتے ہیں۔ (Daniel Katz (1960) نے چار فعلیاتی شعبے بیان کیے ہیں:

• علم (Knowledge)

رویے زندگی کے لیے معنی (علم) فراہم کرتے ہیں۔ علم کا فعل ہماری اس ضرورت سے متعلق ہے کہ دنیا ہم آہنگ اور نسبتاً مستحکم ہو۔ اس سے ہم یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے کا امکان ہے، اور اس طرح ہمیں اختیار کا احساس ملتا ہے۔ رویے ہمارے تجربے کو منظم و ساختہ بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کے رویے کو جاننا ہمیں اس کے طرز عمل کی پیش گوئی میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ جاننا کہ کوئی شخص مذہبی ہے، ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے میں بہت پابند ہوگا۔

• خود/انانیت اظہاری (Self / Ego-expressive)

جن رویوں کا ہم اظہار کرتے ہیں وہ یہ بتانے میں مدد دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں اچھا محسوس کرا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی شناخت کا دعویٰ کیا ہے۔ رویوں کا خود اظہار غیر زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے رویے ہماری شناخت کا حصہ ہیں اور ہمارے احساسات، عقائد اور اقدار کے اظہار کے ذریعے ہمیں آگاہ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔

• ہم آہنگ کنندہ (Adaptive)

اگر کوئی شخص سماجی طور پر قابل قبول رویے رکھتا ہے اور/یا ان کا اظہار کرتا ہے، تو دوسرے لوگ اسے منظوری اور سماجی قبولیت سے نوازیں گے۔ مثال کے طور پر، جب لوگ اپنے افسروں یا اساتذہ کی چاپلوسی کرتے ہیں (اور اس پر یقین رکھتے ہیں) یا خاموش رہتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رویہ غیر مقبول ہے۔ پھر بھی، اظہار غیر زبانی ہو سکتا ہے۔ تو رویے ایک سماجی گروہ کا حصہ ہونے سے متعلق ہیں اور ہم آہنگ کنندہ فعل ہمیں سماجی گروہ میں گھلنے ملنے میں مدد دیتا ہے۔ لوگ ایسے دوسروں کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے رویوں میں شریک ہوں، اور ان لوگوں جیسے رویے اختیار کر لیتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔

• انانیت دفاعی فعل (The ego-defensive function)

اس سے مراد ایسے رویے رکھنا ہے جو ہماری خود اعتمادی کی حفاظت کرتے ہیں یا ان اعمال کا جواز پیش کرتے ہیں جن سے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، جن لوگوں کا فخر شکست کے بعد مجروح ہوا ہو وہ دفاعی رویہ اپنا لیتے ہیں۔ اس فعل میں نفسیاتی رنگ ہے۔ مثال کے طور پر، اپنے

بارے میں مثبت رویوں کا حفاظتی فعل ہوتا ہے (یعنی انانیت دفاعی کردار) جو ہماری خود شناسی کو محفوظ رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔

فعلیاتی نقطہ نظر کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ رویے کسی شخص کو اس کی اپنی اندرونی ضروریات (اظہار، دفاع) اور بیرونی دنیا (ہم آہنگ کنندہ اور علم) کے درمیان ثالثی کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کے مقاصد یہ ہیں کہ طلبہ یہ کرنے کے قابل ہوں؛

1. مثبت اور منفی کے درمیان فرق کریں جن سے متعلقہ رویے پیدا ہوتے ہیں۔
2. مثبت اور منفی رویوں کی بنیادی حرکیات کو جانیں۔
3. معذوروں کی سماجی نفسیات کو سمجھیں اور اسے لوگوں اور ارد گرد کے ماحول کے رویوں سے جوڑیں۔
4. گوفمین کے اسٹلما کے نظریے کو سمجھیں۔
5. معذور افراد کی شناختی اور سماجی خصوصیات کو جانیں۔
6. خاندان پر معذوریوں کے اثرات اور برادری میں اس کے سماجی تعلقات کو جوڑیں۔

7.1 مثبت اور منفی رویے

ہم میں سے ہر ایک مختلف جسمانی، حیاتیاتی اور ذہنی حصوں سے بنا ہے۔ ہمارا جسمانی جسم اور اس کے اعضا، عضلات وغیرہ ہیں؛ احساسات، جذبات اور احساسات کے ساتھ حیاتیاتی وجود؛ اور خیالات، یادوں، استدلالی قوت، عقائد وغیرہ کے ساتھ ذہنی حصہ۔ کہیں ہمارے جذبات اور ہماری سوچ کی پروسیسنگ کے درمیان ہمارے رویے پڑے ہیں۔ اپنے، دوسروں اور خود زندگی کے بارے میں ہمارے جذباتی ادراک۔

کہا جاسکتا ہے کہ رویہ ایک نفسیاتی میلان ہے جس کا اظہار کسی مخصوص وجود کو پسند یا ناپسند کی کچھ ڈگری کے ساتھ جانچ کر کیا جاتا ہے (Eagly & Chaiken, 1993, p. 1)۔ یہ دوسرے لوگوں، حالات، واقعات، اشیاء، مقامات، مظاہر یا وجود کے لیے رکھے گئے نقطہ نظر کے سوا کچھ نہیں۔ بنیادی طور پر رویے کے تین اجزا ہیں یعنی جذباتی، شناختی اور طرز عمل، جو بالترتیب احساسات، معلومات یا سوچ کی پروسیسنگ، اور عمل کے راستے سے متعلق ہیں۔

انسان ہونے کے ناطے ہمارے مختلف قسم کے رویے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ مثبت رویہ اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کا پر امید نقطہ نظر ہے۔

جب اصلاحی اقدامات کی ضرورت والی مشکلات کا سامنا ہو تو متبادل راستے یا دیگر آپشن تلاش کرنے کے لیے وسائل کا بھرپور استعمال اور عزم نمایاں اوصاف ہیں۔ جبکہ منفی رویہ کسی شخص کی مایوسانہ ذہنیت ہے جو اہم مسائل کو سنبھالنے کے قابل نہیں کیونکہ وہ آسانی سے ہار مان لیتا ہے اور دستیاب ذرائع تلاش کرنے کی زحمت نہیں کرتا جو کسی مسئلے یا مشکل کے حل کی طرف لے جاتے ہیں۔

یہ بنیادی طور پر ایک جائزاتی بیان جیسا ہے جو زیر بحث معاملے کے لیے پسند یا ناپسند کی ڈگری کے لحاظ سے یا تو مثبت یا منفی ہوتا ہے، مثلاً جب میرے اپنے کام یا ساتھیوں کے بارے میں اچھے احساسات ہوں تو میرا رویہ مثبت ہوتا ہے۔ جب میں ان کاموں کو کرنے سے ہچکچاؤں جو ضروری ہیں، یا مخصوص افراد کے تئیں دشمنی ظاہر کروں، تو میرا رویہ منفی ہوتا ہے۔ انسان کے طور پر ہم ہر وقت کچھ سوچ رہے، محسوس کر رہے یا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین چیزیں عقائد سے مضبوط اور طرز عمل کے ذریعے ظاہر ہونے والے رویوں کی نشوونما کی بنیاد بناتی ہیں۔ عقائد وہ نمائندگی کرتے ہیں جو ہم نے تجربے کے ذریعے سیکھا یا جانا ہے اور طرز عمل اس کی نمائندگی کرتا ہے جو ہم اس مخصوص وجود کے بارے میں سوچتے ہیں۔

مثبت اور منفی رویے رکھنے والے لوگوں کے درمیان فرق

مثبت رویے والے لوگ	منفی رویے والے لوگ
کہیں گے "میں کر سکتا ہوں"۔	کہیں گے "میں نہیں کر سکتا"۔
مسئلے کے حل پر توجہ دیتے ہیں	مصیبت میں رہتے ہیں
دوسروں کی خامیوں پر توجہ دیتے ہیں۔	دوسرے لوگوں کی خامیوں پر توجہ دیتے ہیں
دوسروں میں صرف مثبت چیزیں پائیں گے۔	کسی سے بھی شکایت پائیں گے
ہمیشہ مواقع دیکھتے ہیں۔	صرف حدود دیکھتے ہیں

سرگرمی

پیارے طلبہ! آئیے ان طریقوں کے لیے کچھ ذہنی طوفان (brainstorming) کریں جن سے ہم خود کو منفیت سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اس باب کے اگلے حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے،

مرحلہ 1: اپنے رویے کا جائزہ لیں

اپنی آنکھیں بند کریں اور توجہ دیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف کیسے ردِ عمل ظاہر کرتے ہیں؟ (لوگوں، چیزوں اور ماحول کے تئیں اپنے ردِ عمل کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائیں۔

مرحلہ 2: تجزیہ

اپنے بارے میں اپنے نتائج کو اچھا/برا، صحیح/غلط، قابل قبول/نا قابل قبول، مثبت/منفی میں تقسیم کریں۔

مرحلہ 3: نتیجہ

اب خود کو اپنے ذہنی رجحان کے بارے میں رکھیں کہ کیا
الف۔ آپ اپنے ماحول کو مثبت طور پر لیتے ہیں یا منفی طور پر۔
ب۔ آپ کی سوچ کی پروسیسنگ کا کتنا تناسب مثبت کی طرف مائل ہے اور کتنا منفی کی طرف مائل ہے۔
اب آئیے منفیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم درج ذیل رہنما اصول استعمال کر سکتے ہیں:

منفیت سے خود کو بچانے کے 10 طریقے

1. دوسرے لوگوں کی منفیت کو زیادہ ذاتی نہ لیں،
 2. اپنا وقت جتنا ممکن ہو مثبت لوگوں کے ساتھ گزاریں،
 3. دوسروں کو دکھائیں کہ اگر آپ مثبت سوچیں تو کامیاب ہونا ممکن ہے۔ اپنے خوابوں کو دوسروں کے منفی اثر سے بچائیں،
 4. اپنی سوچ کو کنٹرول کریں۔ کوئی آپ کے ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور آپ کے پاس اپنا خواب تخلیق کرنے کی طاقت ہے،
 5. ہمیشہ موجودہ مسائل کے حل پر توجہ مرکوز رکھیں،
 6. لوگوں سے دل سے بات کریں۔ انہیں تعریفیں دیں۔ بہترین بنیں جو آپ ہو سکتے ہیں، اس طرح آپ ان میں مثبت رویہ جگائیں گے،
 7. ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حمایت کریں،
 8. یاد رکھیں کہ زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ہے،
 9. خود کو آج جو ہو رہا ہے اس پر مرکوز رکھیں اور اپنی توانائی ان چیزوں پر ضائع نہ کریں جو گزر چکی ہیں،
 10. منفیت سے دور رہیں، اس طرح آپ زندگی میں مثبت چیزوں کے لیے جگہ چھوڑیں گے۔
- "یہ نہ بھولیں کہ زندگی ایک پاگل سواری ہے۔ ڈرائیونگ کے اصول سیکھیں اور موڑوں اور تنگ سڑکوں پر تیز رفتار سے گاڑی نہ چلائیں۔"

ثبت اور منفی رویے

رویہ ذہن کی ایک حالت ہے جس میں عقائد اور احساسات شامل ہیں جو ہمارے طرز عمل اور ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

ثبت رویہ لوگوں کو بہت پر امید ذہنی حالت میں رہنے کے قابل بناتا ہے۔ مثبت رویہ فکروں اور منفی سوچ سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ مثبت رویہ زندگی میں تعمیری تبدیلیاں لاتا ہے۔ مثبت رویے کے ساتھ کوئی زندگی کا روشن پہلو دیکھتا ہے۔ مثبت ذہنیت والا شخص منفی واقعات کو ایک واقعہ قرار دے کر نظر انداز کرنے اور مستقبل میں ان برے واقعات سے بچنے کے لیے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع لینے کے قابل ہوتا ہے۔

ثبت رویہ درج ذیل طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے

- مثبت سوچ۔
- تعمیری سوچ۔
- تخلیقی سوچ۔
- پر امید پن۔
- کام کرنے اور اہداف حاصل کرنے کے لیے تحریک اور توانائی۔
- خوشی کا رویہ۔

ثبت سوچ

"Psychology Today" میگزین کی ایڈیٹر ان چیف Hara Estroff Marano رپورٹ کرتی ہیں کہ اوسط شخص روزانہ 25,000 سے 50,000 خیالات پیدا کرتا ہے۔ 1952ء میں Norman Vincent Peale کی کتاب "The Power of Positive Thinking" سے شروع ہو کر، اس خیال کے گرد سوچ کا ایک بڑا مکتب پروان چڑھا ہے کہ خوشی اور ناخوشی بڑی حد تک خیالات کے ضمنی نتائج ہیں اور "منفی سوچ" مختلف نفسیاتی و جسمانی عوارض کا باعث بنتی ہے۔ ان مفکرین کے مطابق علاج یہ ہے کہ صحت، سکون، بہبود کے بڑھے ہوئے احساس اور کام و گھر میں بڑھی ہوئی ذاتی موثریت حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات پر اختیار کی مشق کی جائے۔

ثبت رویہ پیدا کرنا

اگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے آپ عادی ہوں تو مثبت رویے کی عادت پیدا کرنے میں تھوڑا وقت اور محنت لگ سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ منفی سوچ رکھ رہے ہوں تو خود کو پکڑیں اور جواب میں

ایک نیا مثبت اسکرپٹ بنائیں۔ Dr. Ronald کے Midwest Center for Stress and Anxiety Rubenzer تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کے ذریعے برے تناؤ کو اچھے تناؤ میں بدل سکتے ہیں۔ "تناؤ زدہ" محسوس کرنے کے بجائے، صورت حال کو نشوونما اور کامیابی کے ایک دلچسپ موقع میں بدل دیں۔ مثبت رویے کی طاقت سیکھنا آپ کی زندگی کو زیادہ قابل انتظام اور اطمینان بخش بنا سکتا ہے۔

منفی سوچ

رویے کسی مخصوص مسئلے کے بارے میں خیالات کے منظم مجموعے ہیں۔ مثبت سوچنے کے لیے آپ کو منفی سوچ کے بعض نمونے ختم کرنے کی ضرورت ہے جن میں تقریباً ہر کوئی کم از کم کبھی نہ کبھی ملوث ہوتا ہے۔ ان میں منفی سوچ کی چار بڑی اقسام شامل ہیں:

• فلٹرنگ (Filtering)،

• ذاتی بنانا (Personalizing)،

• تباہ کاری سوچ (Catastrophizing) اور

• قطبیت پسندی (Polarizing)۔

فلٹرنگ سے مراد پیچیدہ منظر ناموں کے حوصلہ افزا پہلوؤں کو نفسیاتی طور پر چھان کر الگ کرنا ہے۔ ذاتی بنانے کا مطلب ہے ہر بار جب کچھ برا ہو تو خود کو خودکار طور پر مورد الزام ٹھہرانا۔ تباہ کاری سوچ کسی بھی صورت حال میں بدترین ممکنہ نتیجے کی توقع ہے، اور قطبیت پسندی ایک قسم کی سیاہ و سفید سوچ ہے جو ناکامی کو کمال سے کم کسی بھی نتیجے کے طور پر بیان کرتی ہے۔

نیچے کیا ہے؟

منفی رویہ مختلف وجوہات سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی یہ ناپسندیدہ اور ناپسندیدہ حالات کے جواب میں ظاہر ہوتا ہے جو شخص کے لیے قابل قبول نہیں یا اس کے قابو سے باہر ہیں۔ بے قابو حالات ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے سرکشی کے طرز عمل کو جنم دیتے ہیں۔ کبھی والدین کے غیر ضروری انضباطی اصول بچوں میں ایسے احساسات پیدا کرتے ہیں۔

مثبت ذہنی فریم آپ کی کئی طریقوں سے مدد کر سکتا ہے، جیسے

• کامیابی کی توقع رکھنا کہ ناکامی کی۔

• آپ کو متاثر کن محسوس کرانا۔

- اگر آپ کو راستے میں رکاوٹوں کا سامنا ہو تو ہار نہ ماننے کی طاقت دیتا ہے۔
- یہ آپ کو ناکامی اور مشکلات کو بھیس میں نعمتوں کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔
- خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا۔
- آپ کو خود اعتمادی اور اعتماد ظاہر کرنے کے قابل بناتا ہے۔
- آپ مشکلات پر دھرنے کے بجائے حل تلاش کرتے ہیں۔
- آپ موقع دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔
- یہ آپ کو اہداف حاصل کرنے اور کامیابی پانے میں مدد دیتا ہے۔
- یہ آپ کی زندگی میں مزید خوشی لاتا ہے۔
- یہ مزید توانائی پیدا کرتا ہے۔
- مثبت رویہ آپ کی صلاحیتوں پر آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور روشن مستقبل کی امید لاتا ہے۔
- آپ خود کو اور دوسروں کو متاثر اور حوصلہ افزائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
- آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کم رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔
- آپ لوگوں سے زیادہ عزت اور محبت پاتے ہیں۔
- زندگی آپ پر مسکراتی ہے۔

منفی رویہ کہتا ہے: آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

مثبت رویہ کہتا ہے: آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔

مثبت رویہ عقیدہ اور عزم پیدا کرتا ہے۔ کوئی زندگی کی رکاوٹوں اور مشکلات کو اعتماد اور عزم کے ساتھ سنبھال سکتا ہے۔ مثبت رویہ خیالات اور اعمال کو مثبت انداز میں پروان چڑھاتا ہے۔ جب ہم دوسرے لوگوں سے تعامل کرتے ہیں تو ہم اپنا رویہ نشر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دوسروں سے رجوع کرتے ہیں اس کا ہمارے تعلق پر بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ مثبت رویہ خود اعتمادی کے بنیادی اجزاء میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اپنی خود اعتمادی سے جدوجہد کرتے ہیں۔ مثبت رویہ پیدا کرنا آپ کی زندگی میں ہر چیز کو مثبت بنانے کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے مثبت لوگوں سے وابستہ ہونا، خود کو مثبت حالات میں رکھنا اور مثبت چیزوں سے گھیر لینا۔ آپ کو منفیت سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ آپ کو ہر چیز کے بارے میں مثبت ہونا شروع کرنا ہوگا۔ آپ اپنی سڑک کو مثبت سے پختہ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو مثبت نتائج کی طرف لے جائے گی۔

ثبت رو پیدا کرنے کے مراحل

1. خود سے کہیں "آپ بدل سکتے ہیں":

جب کوئی چیز یقین کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں ابھرتی ہے۔ اپنی زندگی کے تبدیلی کے تین عظیم ترین لمحات لکھیں جنہوں نے آپ کو آج کا وہ شخص بنایا ہے جو آپ بننا پسند کرتے ہیں۔ اپنے رویے کو ڈھالنے اور مثبت رہنے کی ترغیب کے لیے اپنی فہرست اپنے ہاتھ روم میں یا اپنی میز کے اوپر لٹکائیں۔

2. ماحول بدلیں:

نیا ماحول آپ کے نقطہ نظر کو بہتر کے لیے بدل سکتا ہے۔ اگر آپ پھنس گئے ہیں تو اپنے دماغ کو نئے ماحول سے روشناس کرائیں۔ جسمانی طور پر کسی اور جگہ جائیں، یا کہیں اور پڑھیں یا دیکھیں۔ تاکہ رویے کی مثبت تبدیلی حاصل ہو۔

3. خود کو دوبارہ توانائی بخشیں

کم توانائیاں کم حوصلے کا اظہار کرتی ہیں۔ توانائیوں کو تازہ دم کرنے کی ضرورت ہے۔ دماغ نیند کی کمی کو مرکزی اعصابی نظام کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایک رات کی نیند چھوٹنے سے آپ 59 فیصد کم مثبت الفاظ یاد رکھ سکتے ہیں، جس سے آپ منفی پر ضرورت سے زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی طرح آرام یافتہ اور ابھی کھائے پیے ہوں گے تو قیمتی تفصیلات، معلومات اور امکانات کی وسیع رینج دیکھنا آسان ہوگا۔

4. مثبت اور منفی کی حد بندی

تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ چاہے صورتِ حال کتنی ہی مایوس کن نظر آئے اس میں ہمیشہ امید کی کرن ہوتی ہے۔ کیوں نہ اس سے مثبت نکالا جائے۔ مثال کے طور پر ایسی صورتِ حال کے بارے میں سوچیں جو آپ کو پسند نہیں، پھر وہاں سے کم از کم تین مثبت چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقینی طور پر ان کے ساتھ آئیں گے۔

5. صحیح لوگوں سے بات کرنا

مسلسل ہم خیال لوگوں سے بات کرنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی نقطہ نظر بار بار سنیں، جو مسئلہ حل کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ مثبت رویہ حاصل کرنے کے لیے مسئلے کے تمام پہلوؤں کو پہچاننے کے لیے مختلف نقطہ ہائے نظر تلاش کریں۔

6. اپنے تناؤ کو راستہ دیں

تناؤ ہر بری صورتِ حال کو بدتر بناتا ہے۔ تناؤ کے دوران خارج ہونے والے ہارمونز یادداشت اور استدلالی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ خود کو تناؤ کے مثبت پہلوؤں کے بارے میں سوچنا سکھانا دراصل

کارکردگی کے ساتھ ساتھ جسمانی و ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تناؤ کو زیادہ پر اعتماد انداز میں ہدایت کرنے کا مقصد رکھیں۔

7.2 رویہ اور معذوروں کی سماجی نفسیات

سماجی نفسیات مطالعہ کرتی ہے کہ لوگ معاشرے کے سیاق میں کیسے عمل کرتے، سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے طرز عمل، خیالات اور احساسات کیسے بدلتے ہیں۔ اس لیے سماجی ماہرین نفسیات ان عوامل سے نمٹتے ہیں جو ہمیں دوسروں کی موجودگی میں مخصوص طریقے سے برتاؤ کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان حالات کو دیکھتے ہیں جن کے تحت مخصوص طرز عمل / اعمال اور احساسات واقع ہوتے ہیں۔ سماجی نفسیات کا تعلق اس طریقے سے ہے جس سے یہ احساسات، خیالات، عقائد، ارادے اور اہداف تعمیر کیے جاتے ہیں اور یہ نفسیاتی عوامل بدلے میں دوسروں کے ساتھ ہمارے تعاملات کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔

Baron, Byrne & Suls (1989) سماجی نفسیات کی تعریف یوں کرتے ہیں....

"وہ سائنسی شعبہ جو سماجی حالات میں انفرادی طرز عمل کی نوعیت اور اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے" (ص 6)۔ اس لیے یہ انسانی طرز عمل کو دوسرے لوگوں اور اس سماجی سیاق سے متاثر ہو کر دیکھتا ہے جس میں یہ واقع ہوتا ہے۔ سماجی نفسیات نفسیات (جس کا زور فرد پر ہے) کے مفاد کو سماجیات (جس کا زور سماجی ڈھانچوں پر ہے) سے جوڑتی ہے۔

سماجی نفسیات تین عمومی طریقوں سے ذہنوں، گروہوں اور طرز عمل کے درمیان پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلا، اس کا مقصد بیان کرنا ہے کہ افراد کے خیالات، احساسات اور طرز عمل دوسروں کی حقیقی، خیالی یا مضمحل موجودگی سے کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں سماجی ادراک، سماجی تعامل اور سماجی اثر (بشمول اعتماد، طاقت اور قائل کرنا) جیسے شعبے شامل ہیں۔ اس شعبے میں اس بات میں گہری دلچسپی ہے کہ ادراک اور خیالات، نیز سماجی اشارے، انفرادی طرز عمل کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ دوسرا، سماجی نفسیات اس اثر کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے جو انفرادی ادراک اور طرز عمل کا گروہوں کے طرز عمل پر ہوتا ہے۔ اس میں گروہی پیداواریت اور فیصلہ سازی جیسے شعبوں پر تحقیق شامل ہے۔ تیسرا، سماجی نفسیات طرز عمل کی وجودیات کے طور پر گروہوں کی حرکیات کی وضاحت کرتی ہے۔ اس شعبے میں تحقیق ان تعلقات کی جانچ کرتی ہے جو ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ ہے، اور/یا ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر جو اثر ہے۔ سماجی نفسیات کے اندر توجہ کے بعض موضوعات ذیل میں درج ہیں:

• انتساب (attribution)

- قائل کرنا (persuasion)
- تعصب (prejudice)
- سماجی ادراک (social perception)
- ہم آہنگی (conformity)
- سماجی اثر (social influence)
- گروہی حرکیات (group dynamics)
- باہمی کشش (interpersonal attraction)

معذوری سے ہم آہنگ ہونے کے مراحل

معذوری سے ہم آہنگ ہونے کے مراحل میں چار بنیادی مراحل شامل ہیں۔ ان مراحل میں صدمہ، انکار، غصہ / افسردگی اور ہم آہنگی / قبولیت شامل ہیں۔ لوگ ان مراحل سے اپنی رفتار سے گزرتے ہیں۔

• صدمہ

صدمے میں جذباتی اور جسمانی بے حسی دونوں کی حالت شامل ہے جو چند گھنٹوں سے کئی دنوں تک رہ سکتی ہے۔

• انکار

انکار تین ہفتوں سے دو ماہ تک کہیں بھی رہ سکتا ہے اور یہ ایک دفاعی میکانزم ہے جو نئی معذوری کے مضمرات کو جو شخص نے تجربہ کی ہے بتدریج متعارف کرانے کی اجازت دیتا ہے۔ انکار صرف تب مسئلہ بنتا ہے جب وہ شخص کی زندگی، علاج کی شکلوں یا بحالی کی کوششوں میں مداخلت کرے۔

• غصہ / افسردگی

غصہ اور افسردگی نقصان اور شخص کے سماجی سلوک و حیثیت میں تبدیلی کے ردِ عمل ہیں۔ شخص اس مرحلے کے دوران مختلف جذبات کا تجربہ کر سکتا ہے اور اپنے جسمانی تصور، فعل، مستقبل کی توقعات، یا کھوئے گئے کسی فعل پر مبنی سابقہ اطمینان میں تبدیلیوں پر سوگ منا سکتا ہے۔

• ہم آہنگی / قبولیت

ہم آہنگی اور قبولیت کے مرحلے کا مطلب ہے کہ شخص نے معذوری کو اس کی حقیقت پسندانہ صلاحیتوں اور حدود کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ شخص معذوری کی شکلوں کا تجربہ کرنے والے دوسروں کے ساتھ تعاملات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے۔

معذوری کے بارے میں رویہ

معذوری سے وابستہ جذباتی پہلو کئی بار شخص کے نتیجے کا تعین کرنے میں ایک بڑا عنصر ہوتے ہیں۔ کئی لوگ جسمانی معذوری سے ہم آہنگ ہونے کے چار سے زیادہ مراحل کا تجربہ کرتے ہیں؛ درحقیقت - لوگ بارہ تک مراحل کا تجربہ کر سکتے ہیں جن میں شامل ہیں:

- صدمہ
- بے چینی
- سودے بازی
- انکار
- سوگ
- افسردگی
- کنارہ کشی
- اندرونی غصہ
- بیرونی جارحیت
- اعتراف
- قبولیت
- ہم آہنگی

معذور اور غیر معذور لوگوں کے درمیان رابطے کی کمی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں: معذور لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے موقع کی کمی، یا معذوروں کے ساتھ گھلنے ملنے کے بارے میں غیر معذور لوگوں میں خوف اور بے چینی۔ معذور اور غیر معذور کے درمیان رابطے کی یہ کمی، چاہے موقع کی کمی کے ذریعے ہو یا انتخاب کے ذریعے، معذور اور غیر معذور لوگوں کے درمیان منفی تعلق کو بڑھا سکتی ہے۔

نفسیاتی تحقیق تجویز کرتی ہے کہ دوسرے گروہوں جیسے نسلی اقلیتوں کے تئیں تعصب کو کم کرنے کا ایک طریقہ پڑوسیوں، کام کے ساتھیوں، دوستوں یا ہم جماعتوں کی صورت میں دوسرے گروہوں کے ارکان سے رابطہ ہے۔ درحقیقت نفسیاتی تحقیق یہ تجویز کرتی ہے کہ اگر معذور بچوں کو یہ مواقع نہ دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں سماجی نشوونما میں طویل مدتی تاخیر ہو سکتی ہے۔ تاہم، شمولیت کے مثبت اثرات کے بارے میں شواہد ملے جاتے ہیں۔ شمولیت ہمیشہ معذوروں کے بارے میں غیر معذور بچوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی کی طرف

نہیں لے جاتی۔ مزید برآں، شمولیت مرکزی دھارے کے اسکولوں میں جانے والے معذور بچوں کے خود تصور اور جذباتی تحفظ کے لیے منفی نتائج رکھتی دکھائی گئی ہے۔ نیز، شمولیت کا ہمیشہ شمولیت مطلب نہیں ہوتا۔ اکثر شمولیت صرف لفظوں میں ہوتی ہے، عمل میں نہیں۔ معذور بچے اکثر غیر معذور بچوں جیسی ہی جماعتوں میں جاتے ہیں، انہی کھیل کے میدانوں میں کھیلتے ہیں اور انہی کھانے کے ہالوں میں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ہم عمر انہیں ایک طرح کے اختیاری اخراج میں خارج رکھتے ہیں۔ دونوں گروہوں کے درمیان بہت کم حقیقی تعامل ہو سکتا ہے، جو 'شامل' بچوں میں تنہائی اور بے چینی کے احساسات کا باعث بن سکتا ہے۔

7.3 لیبلنگ

یہ ایک اصطلاح ہے جو ان مخصوص خصوصیات کی بنیاد پر لوگوں کو بیان یا درجہ بندی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو وہ رکھتے ہیں۔ لیبلنگ (labelling) ایسے بیان کنندگان تخلیق کرنے کا عمل ہے تاکہ ان افراد کی نشاندہی کی جائے جو معمول سے مختلف ہیں۔ معمول ایک وسیع نسبتی اصطلاح ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح دوسروں سے مختلف ہے۔

معذوری سے متعلق لیبلنگ

کئی لوگ کسی شخص کو بیان کرنے کے لیے معذوری سے متعلق لیبل استعمال کرتے ہیں۔ کسی فرد کی نشاندہی کے لیے استعمال ہونے والی بنیادی صفت کے طور پر معذوری استعمال نہیں کی جانی چاہیے، جیسے 'میری جماعت میں خود رو طالب علم'۔ معذوری کسی بھی فرد کی سب سے اہم بیان کنندہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ پہلے شخص پر توجہ دی جائے نہ کہ معذوری پر۔ افراد کو ان کی معذوری سے بیان کرنا، گویا معذوری شخص کی مکمل وجود پر مشتمل ہے، اکثر لوگوں کو الگ تھلگ یا الگ کر دیتا ہے اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی انسانیت کو تسلیم کرنے میں ناکام رہتا ہے جو معذوری سے کہیں آگے جاتی ہے۔ "بیان کنندگان کی نوعیت اور انہیں کیسے استعمال کیا جاتا ہے اکثر معذور افراد کے بارے میں منفی مضمرات اخذ کرتا ہے۔

تین بالکل مختلف قسم کے اسٹگما (stigma) کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جسم کی مکروہ چیزیں ہیں۔ مختلف جسمانی بگاڑ۔ اگلے انفرادی کردار کے داغ ہیں جنہیں کمزور ارادے، غلبہ پسند یا غیر فطری جذبات، دھوکے باز اور سخت عقائد، اور بے ایمانی کے طور پر سمجھا جاتا ہے، یہ مثال کے طور پر ذہنی عارضے، قید، نشے، شراب نوشی، بے روزگاری، خودکشی کی کوششوں اور بنیاد پرست سیاسی رویے کے معلوم ریکارڈ سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ آخر میں نسل، قوم اور مذہب کے قبائلی اسٹگما ہیں، یہ وہ اسٹگما ہیں جو نسل در نسل منتقل ہو سکتے ہیں اور خاندان کے تمام ارکان کو یکساں آلودہ کر سکتے ہیں۔

تاہم، اسٹگما کی ان تمام مختلف مثالوں میں، بشمول وہ جن کا یونانیوں نے خیال کیا تھا، وہی سماجیاتی خصوصیات پائی جاتی ہیں: ایک فرد جو عام سماجی میل جول میں آسانی سے قبول کیا جا سکتا تھا ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے جو توجہ پر خود کو مسلط کر سکتی ہے اور جن سے وہ ملتا ہے انہیں اس سے دور کر سکتی ہے، اس دعوے کو توڑتے ہوئے جو اس کی دیگر صفات کا ہم پر ہے۔ وہ ایک اسٹگما رکھتا ہے، ہماری توقع سے ایک ناپسندیدہ مختلف پن۔ ہم اور وہ جو زیر بحث مخصوص توقعات سے منفی طور پر نہیں ملے، انہیں نارملز کہیں گے۔

اسٹگما والے شخص کے بارے میں ہم نارملز کے جو رویے ہیں اور اس کے حوالے سے اعمال، وہ معروف ہیں، کیونکہ یہ ردِ عمل وہی ہیں جنہیں نرم کرنے اور بہتر بنانے کے لیے خیر خواہانہ سماجی عمل وضع کیا گیا ہے۔ تعریف کے لحاظ سے، یقیناً، ہم مانتے ہیں کہ اسٹگما والا شخص بالکل انسان نہیں ہے۔ اس مفروضے پر ہم امتیاز کی اقسام برتتے ہیں، جن کے ذریعے ہم موثر طور پر، اگرچہ اکثر بے سوچے، اس کے زندگی کے موقع کم کر دیتے ہیں۔ ہم ایک اسٹگما نظریہ تعمیر کرتے ہیں، ایک نظریہ جو اس کی کمتری کی وضاحت کرے اور اس خطرے کا حساب دے جو وہ نمائندگی کرتا ہے، کبھی کبھی دیگر اختلافات جیسے سماجی طبقے کی بنیاد پر دشمنی کا جو اڑپیش کرتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں مخصوص اسٹگما اصطلاحات جیسے لنگڑا، اندھا، احمق استعارے اور تصور کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، عام طور پر اصل معنی کے بارے میں سوچے بغیر۔ ہم اصل ایک کی بنیاد پر وسیع رینج کی خامیوں کا الزام لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ مطلوبہ لیکن ناپسندیدہ صفات کا الزام لگاتے ہیں، اکثر مافوق الفطرت رنگ کی، جیسے "چھٹی حس" یا "سمجھ":

لیبلنگ ہمیشہ تشویش کا باعث نہیں ہوتی، اور یہ اکثر بہت مفید ہوتی ہے۔ "دوستانہ"، "دھوکے باز"، "لذیذ" اور "نقصان دہ" جیسے لیبلوں کی مدد کے بغیر ان معلومات کو فہرست میں لانا ناممکن ہو گا جن پر ہم اپنی زندگیوں کے دوران عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہچاننا ضروری ہے کہ جن لوگوں کو ہم "کالے"، "سفید"، "امیر"، "غریب"، "ہوشیار" اور "سادہ" کے طور پر لیبل کرتے ہیں، وہ محض اس لیے کالے تر، سفید تر، امیر تر، غریب تر، ہوشیار تر اور سادہ تر نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں ایسا لیبل کیا ہے۔

لیبلنگ کے اثرات

لیبلنگ معمولی لگ سکتی ہے لیکن اس کے اثرات دیرپا اور کبھی کبھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لیبلنگ لیبل شدہ شخص کے لیے درج ذیل کا باعث بن سکتی ہے خاص طور پر جب یہ خصوصی ضروریات والے طلبہ پر ہو۔

کم خود اعتمادی
طلبہ کو لیبل کرنا سیکھی ہوئی بے بسی کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ طلبہ محسوس کر سکتے ہیں کہ چونکہ انہیں لیبل

کیا گیا ہے وہ بس اچھا نہیں کر سکتے یا وہ بے وقوف ہیں۔ یہ طالب علم کی خود اعتمادی کو بھی بہت کم کر سکتا ہے۔

کم توقعات اور تحریک

لیبلنگ طالب علم کے لیے دوسروں کی کم توقعات اور طالب علم میں کم تحریک کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ بالغ، بشمول اساتذہ اور والدین، سوچ سکتے ہیں کہ طالب علم وہ نہیں کر سکتا جو درکار ہے اور اپنی توقعات کم کر سکتے ہیں۔ اگر اساتذہ اور والدین طالب علم کی صلاحیت پر یقین نہیں رکھتے، تو طالب علم بھی نہیں رکھے گا۔ یہ ایک شیطانی چکر پیداکر سکتا ہے، جو بالآخر طالب علم کو ناکامی کے لیے تیار کرتا ہے۔

ہم عمر مسائل

جو طالب علم لیبل شدہ ہے وہ ہم عمر مسائل کا تجربہ کر سکتا ہے۔ طالب علم کا سیکھنے میں معذور ہونے پر مذاق اڑایا جاسکتا ہے۔ یہ دوست بنانے میں مشکل پیدا کر سکتا ہے اور دھونس کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ طالب علم پھر اسکول کی ترتیب میں بہت الگ تھلگ اور کنارہ کش ہو سکتا ہے اور اسکول چھوڑنا شروع کر سکتا ہے۔

7.4 گوفین کا اسٹگما کا نظریہ

یونانیوں نے، جو بظاہر بصری امداد پر مضبوط تھے، اسٹگما کی اصطلاح جسمانی علامات کے حوالے سے شروع کی جو علامت کنندہ کی اخلاقی حیثیت کے بارے میں کچھ غیر معمولی اور برا ظاہر کرنے کے لیے وضع کی گئی تھیں۔ علامات جسم میں کاٹی یا جلانی جاتی تھیں اور اشتہار دیتی تھیں کہ حامل غلام، مجرم یا غدار ہے۔ ایک داغدار شخص، رسمی طور پر ناپاک، جس سے بچا جائے، خاص طور پر عوامی مقامات پر۔

اسٹگما کسی شخص کی سماجی ناپسندیدگی ہے کیونکہ اس کی ایک مخصوص خصوصیت ہے جو سماجی اصولوں سے اس کے انحراف کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ معاشرے کا ایک ذلیل کرنے والا رویہ ہے جس کی وجہ سے شخص معاشرے کے مرکزی دھارے میں ہونے سے بدنام کیا جاتا ہے۔ حاشیہ پر دھکیلنے کی وجہ سے اسٹگما زدہ شخص کی عزت اور خود اعتمادی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد کو سماجی قبولیت نہیں ہوتی اور وہ مسلسل اپنی سماجی شناختوں کو ہم آہنگ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔

امریکی ماہر سماجیات Erving Goffman کی اسٹگما پر کتاب 1963ء میں شائع ہوئی۔

درج ذیل پیرا گراف Ashley Crossman کے مضمون سے لیے گئے ہیں جو 02 مارچ 2017ء کو اپ ڈیٹ ہوا تھا

Erving Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity Goffman کی 1963ء میں لکھی گئی کتاب ہے جو اسٹگما کے خیال اور اسٹگما زدہ شخص ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ ان لوگوں کی دنیا میں ایک جھلک ہے جنہیں معاشرہ غیر معمولی سمجھتا ہے۔ اسٹگما زدہ لوگ وہ ہیں جنہیں مکمل سماجی قبولیت نہیں ہوتی اور وہ مسلسل اپنی سماجی شناختوں کو ہم آہنگ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں: جسمانی طور پر بگڑے ہوئے لوگ، ذہنی مریض، نشے کے عادی، طوائفیں وغیرہ۔

Goffman خود نوشتوں اور کیس اسٹڈیز پر وسیع طور پر انحصار کرتا ہے تاکہ اسٹگما زدہ افراد کے اپنے بارے میں احساسات اور "نارمل" لوگوں سے ان کے تعلقات کا تجزیہ کرے۔ وہ ان حکمت عملیوں کی اقسام کو دیکھتا ہے جو اسٹگما زدہ افراد دوسروں کی مسترد کرنے سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے بارے میں پیچیدہ تصورات جو وہ دوسروں کو پیش کرتے ہیں۔

اسٹگما کی تین اقسام

کتاب کے پہلے باب میں، Goffman اسٹگما کی تین اقسام کی نشاندہی کرتا ہے: کرداری اوصاف کا اسٹگما، جسمانی اسٹگما اور گروہی شناخت کا اسٹگما۔ کرداری اوصاف کا اسٹگما "انفرادی کردار کے داغ ہیں جنہیں کمزور ارادے، غلبہ پسند یا غیر فطری جذبات، دھوکے باز اور سخت عقائد، اور بے ایمانی کے طور پر سمجھا جاتا ہے، یہ مثال کے طور پر ذہنی عارضے، قید، نشے، شراب نوشی، ہم جنس پرستی، بے روزگاری، خودکشی کی کوششوں اور بنیاد پرست سیاسی رویے کے معلوم ریکارڈ سے اخذ کیے جاتے ہیں۔"

جسمانی اسٹگما جسم کی جسمانی بگاڑوں سے مراد ہے، جبکہ گروہی شناخت کا اسٹگما ایک ایسا اسٹگما ہے جو کسی مخصوص نسل، قوم، مذہب وغیرہ سے ہونے سے آتا ہے۔

یہ اسٹگما نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں اور خاندان کے تمام ارکان کو آلودہ کرتے ہیں۔ ان تمام قسم کے اسٹگما میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں وہی سماجیاتی خصوصیات ہیں: "ایک فرد جو عام سماجی میل جول میں آسانی سے قبول کیا جاسکتا تھا ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے جو توجہ پر خود کو مسلط کر سکتی ہے اور جن سے وہ ملتا ہے انہیں اس سے دور کر سکتی ہے، اس دعوے کو توڑتے ہوئے جو اس کی دیگر صفات کا ہم پر ہے۔" جب Goffman "ہم" کا حوالہ دیتا ہے، تو وہ غیر اسٹگما زدہ کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے، جسے وہ "نارملز" کہتا ہے۔

اسٹگما کے ردِ عمل

Goffman متعدد ردِ عمل پر بحث کرتا ہے جو اسٹگما زدہ لوگ اپنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، وہ پلاسٹک سرجری کروا سکتے ہیں، تاہم پھر بھی ان کے اس شخص کے طور پر بے نقاب ہونے کا خطرہ رہتا ہے جو پہلے

اسٹگما زدہ تھا۔ وہ اپنے اسٹگما کی تلافی کے لیے خصوصی کوششیں بھی کر سکتے ہیں، جیسے جسم کے کسی اور حصے یا متاثر کن مہارت کی طرف توجہ مبذول کرانا۔ وہ اپنی کامیابی کی کمی کے بہانے کے طور پر بھی اپنا اسٹگما استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسے سیکھنے کے تجربے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، یا وہ اسے "نارملز" پر تنقید کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم، چھپانا مزید تنہائی، افسردگی اور بے چینی کا باعث بن سکتا ہے اور جب وہ عوام میں باہر جاتے ہیں تو وہ بدلے میں زیادہ خود شعور محسوس کر سکتے ہیں اور غصے یا دیگر منفی جذبات ظاہر کرنے سے ڈر سکتے ہیں۔

اسٹگما زدہ افراد حمایت اور مقابلے کے لیے دوسرے اسٹگما زدہ لوگوں یا ہمدرد دوسروں کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ تعلق کا احساس محسوس کرنے کے لیے خود امدادی گروہ، کلب، قومی انجمنیں یا دیگر گروہ بنایا ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنی کانفرنسیں یا رسالے بھی تیار کر سکتے ہیں۔

اسٹگما کی علامات

کتاب کے باب دو میں Goffman "اسٹگما کی علامات" کے کردار پر بحث کرتا ہے۔ علامات معلوماتی کنٹرول کا حصہ ہیں۔ وہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

مثال کے طور پر، شادی کی انگوٹھی ایک علامت ہے جو دوسروں کو دکھاتی ہے کہ کوئی شادی شدہ ہے۔ اسٹگما کی علامات اسی طرح کی ہیں۔ جلد کا رنگ ایک اسٹگما کی علامت ہے، جیسے سماعت کی امداد، چھڑی، منڈاسر یا وہیل چیئر۔

اسٹگما زدہ لوگ اکثر علامات کو "غیر شناخت کنندگان" کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ "نارمل" کے طور پر گزرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی ناخواندہ شخص 'ذہین' چشمے پہنے ہوئے ہے، تو وہ ناخواندہ شخص کے طور پر گزرنے کی کوشش کر رہا ہو سکتا ہے؛ یا، ایک ہم جنس پرست شخص جو 'عجیب لطیف' سناٹا ہے وہ غیر جنس پرست شخص کے طور پر گزرنے کی کوشش کر رہا ہو سکتا ہے۔ تاہم، یہ چھپانے کی کوششیں بھی مسئلہ خیز ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی اسٹگما زدہ شخص اپنا اسٹگما چھپانے یا "نارمل" کے طور پر گزرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے قریبی تعلقات سے بچنا پڑتا ہے، اور گزرنے والا خود حقارت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انہیں مسلسل چوکس رہنے اور اسٹگما کی علامات کے لیے اپنے گھروں یا جسموں کی ہمیشہ جانچ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔

نارملز کو سنبھالنے کے اصول

اس کتاب کے باب تین میں، Goffman ان اصولوں پر بحث کرتا ہے جن کی اسٹگما زدہ لوگ "نارملز" کو سنبھالتے وقت پیروی کرتے ہیں۔

1. کسی کو یہ فرض کرنا چاہیے کہ "نارملز" بدینتی کے بجائے ناواقف ہیں۔
2. طنز یا توہین کا کوئی جواب درکار نہیں، اور اسٹگما زدہ کو یا تو نظر انداز کرنا چاہیے یا صبر سے جرم اور اس کے پیچھے خیالات کی تردید کرنی چاہیے۔
3. اسٹگما زدہ کو برف توڑ کر اور مزاح یا یہاں تک کہ خود مذاق کا استعمال کر کے تناؤ کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
4. اسٹگما زدہ کو "نارملز" کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے گویا وہ اعزازی عقلمند ہیں۔
5. اسٹگما زدہ کو انکشاف کے آداب کی پیروی کرنی چاہیے مثال کے طور پر معذوری کو سنجیدہ گفتگو کے موضوع کے طور پر استعمال کر کے۔
6. اسٹگما زدہ کو گفتگو کے دوران دانشمندانہ توقف استعمال کرنے چاہئیں تاکہ کہی گئی کسی بات پر صدمے سے بحالی کی اجازت ہو۔
7. اسٹگما زدہ کو دخل انداز سوالات کی اجازت دینی چاہیے اور مدد کیے جانے پر راضی ہونا چاہیے۔
8. اسٹگما زدہ کو "نارملز" کو آسانی پر رکھنے کے لیے خود کو "نارمل" سمجھنا چاہیے۔

انحراف

کتاب کے آخری دو ابواب میں، Goffman اسٹگما کی بنیادی سماجی افعال پر بحث کرتا ہے، جیسے سماجی کنٹرول، نیز وہ مضمرات جو اسٹگما کے انحراف کے نظریات کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر، اسٹگما اور انحراف معاشرے میں فعلیاتی اور قابل قبول ہو سکتے ہیں اگر وہ حدود و سرحدوں کے اندر ہوں۔ (Nicki Lisa Cole, Ph.D. کی طرف سے اپ ڈیٹ کیا گیا)

7.5 خاندان اور برادری میں معذور افراد

خاندانی زندگی بدل جاتی ہے، اکثر بڑے طریقوں سے۔ کسی معذور یا خصوصی ضروریات والے خاندانی رکن کی دیکھ بھال خاندان میں تناؤ لاتی ہے۔ یہ خاندانی نظام اور خاندانی کردار بدل دیتی ہے۔ یہ خاندانی ذمہ داریاں بدل دیتی ہے۔ کون معذوری کی خصوصی ضروریات کی دیکھ بھال کرے گا۔ خاندانی تعلقات اور خاندانی نمونے سب بدل جاتے ہیں۔ جب کوئی خاندانی رکن روزانہ دیکھ بھال کا منتقاضی ہونا شروع کرتا ہے، تو

صورت حال اور اس کے ساتھ لائے گئے تناؤ سے نمٹنے کے پہلے قدم کے طور پر اکثر "آزمائے ہوئے اور سچے" خاندانی کردار استعمال کیے جاتے ہیں۔

دیگر روایتی خاندانی رواج بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ خصوصی ضروریات والے اس رکن کی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص کو مستقل کردار اور ذمہ داری دی جاتی ہے۔ بھائی، بہنیں، بچے اور خاندان کے دیگر ارکان بیماری سے ڈر سکتے ہیں، یا دیکھ بھال وصول کنندہ کے ارد گرد بے چین محسوس کر سکتے ہیں۔ بعض اس میں "مداخلت" نہیں کرنا چاہیں گے جو آپ نے پہلے ہی منصوبہ بنایا یا فیصلہ کیا ہے۔ خاندانی ارکان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کیسے بانٹی جائے۔ کاموں کو تقسیم کرنے کے کئی طریقے ہیں: مخصوص ضرورت کے لحاظ سے، وقت کے وقفے کے لحاظ سے، خدمت فراہم کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے۔ ضروریات اور ذمہ داریوں کے لیے ایک تحریری چارٹ تیار کیا جاسکتا ہے۔ ہر شخص کو ایک مخصوص دیکھ بھال کی ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری سونپنا ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے کا ایک موثر طریقہ ہو سکتا ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ خاندان پر معذوری کے اثرات، اور معذور شخص پر خاندان کے اثرات کے بارے میں سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی کچھلے 30 سالوں میں خاندانی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے استعمال ہونے والے ماڈلوں کی بڑھی ہوئی نفاست کی وجہ سے آتی ہے۔ دیگر عوامل نے اس وسیع تر نقطہ نظر میں حصہ ڈالا ہے:

- دیکھ بھال کے ادارہ جاتی ماڈلوں سے دوری
- معاشرے میں معذور افراد کے حقوق اور قدر کا اعتراف
- عام طور پر خاندانی ڈھانچے میں تبدیلیاں
- بالغ عمر تک معاونت فراہم کرنے میں خاندانی دیکھ بھال کی اہمیت کا اعتراف۔

تاریخی تناظر

معذوری والے بچے کی پیدائش کو خاندان کے لیے ایک المیہ سمجھا جاتا تھا، حل یا موافقت کی امید کے بغیر، ایک ایسا نظریہ جو بچے، ماں اور خاندان کو داغدار کرتا تھا۔ اس سیاق میں، ادارہ جاتی دیکھ بھال کو بچے کو خاندان کو معذور کرنے سے روکنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے نظریات اب ناقابل قبول ہیں، لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ خاندانی کارکردگی میں ابتدائی تحقیق موافقت کے پیتھالوجیکل ماڈل پر مبنی تھی، اور یہ کہ زچگی نفسیاتی ردِ عمل کو خاندانی کارکردگی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پیدائش کی المناک نوعیت کے پیش نظر خاندان یا

معاشرے کے اندر تخفیف یا ثالثی کرنے والے عوامل کو متعلقہ محسوس نہیں کیا جاتا تھا، اس طرح ان مثبت موافقتوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا جو خاندانوں نے کیں۔

خاندانی نظامی نظریے کی نشوونما

1970ء کی دہائی میں، انفرادی پیتھالوجی کے ماڈلوں سے دور ہو کر خاندانی تحقیق خاندانی نظامی نظریے کی نشوونما کے ساتھ منتقل ہوئی۔ خاندان کو تعاملات کا ایک مجموعہ سمجھا جاتا تھا، خاندان کے ارکان کے درمیان اور وسیع تر معاشرے کے ساتھ دونوں۔ اس نے توجہ کو تعالیٰ، اور بعد میں زیادہ پیچیدہ، خاندانی کارکردگی کے ماڈل کی طرف بدل دیا۔

اس نے معذوری کے سلسلے میں خاندانی زندگی کے چکر اور جادہ انفرادی پیتھالوجی ماڈل کے برعکس وقت کے ساتھ تبدیلیوں کے بارے میں خیالات کی نشوونما کی بھی اجازت دی۔ خاندانی نظامی نظریے کے ابتدائی اطلاقات کو تاہم تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ یہ فرض کیا جاتا تھا کہ خاندان کے اندر غیر فعال ابلاغ آئزم اور شیروفرینیا جیسی حالتوں کا سبب تھا۔

تحقیق تناؤ، مقابلے کے میکانزم (coping mechanisms)، معاونتی نیٹ ورکس، بہن بھائیوں، خاندان کے دیگر ارکان اور معذور بالغوں کے خاندانوں پر اثرات جیسے شعبوں میں پروان چڑھی۔ تحقیق اب خاندانی غیر فعلیت کو دیکھنے سے دور ہو گئی ہے اور تیزی سے ان کامیاب، وسائل سے بھرپور طریقوں کو تسلیم کرتی ہے جن سے خاندان موافقت کرتے اور دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں۔

معذوری کی نوعیت کے اثرات

ان کا مختلف نتائج کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم اور آئزم جیسے تشخیصی گروہوں کے درمیان موازنہ کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ طریقہ کار میں فرق نتائج تک پہنچنا مشکل بناتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابلاغی مشکلات اور طرز عمل کی مشکلات جیسے عوامل - مخصوص تشخیصی گروہوں کے بجائے - تناؤ کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ جسمانی دیکھ بھال فراہم کرنا طرز عمل کی مشکلات والے شخص کی معاونت سے کم تناؤ والا ہو سکتا ہے۔ معذور شخص والے اور بغیر والے خاندانوں کے درمیان موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ معذور شخص والے خاندانوں میں تناؤ کی ڈگری زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس سے کم جتنا فرض کیا گیا تھا۔ تناؤ کی سطحوں میں فرق صرف معذور شخص کے بجائے متغیرات کی ایک رینج سے مربوط تھا۔

مقابلہ

تناؤ پر تحقیق کے تکرار کے طور پر مقابلے کے میکانزم پر جو کام کیا گیا ہے۔ یہ میکانزم متعدد شکلیں لیتے ہیں لیکن دو اہم شعبوں میں جمع ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔

مسئلہ مرکوز مقابلہ اس طرز عمل سے متعلق ہے جس کا مقصد تناؤ پیدا کرنے والے واقعے کے اثر کو کم کرنا یا اسے بدلنا ہے۔ یہ بنیادی طور پر شناختی اور طرز عمل کی حکمت عملیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

جذبہ مرکوز مقابلہ تناؤ سے پیدا ہونے والے احساسات کو منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جذباتی توازن پیدا یا برقرار رکھنے کا مقصد رکھتا ہے۔

اگرچہ دونوں مقابلے کے میکانزم کبھی کبھی درکار ہو سکتے ہیں، وہ خاندان جو بنیادی طور پر مسئلہ مرکوز مقابلہ استعمال کرتے ہیں ان میں تناؤ کی سطحیں کم ہوتی ہیں۔

حدود

تناؤ ماڈل کی حد یہ ہے کہ یہ غیر فعلیت پر توجہ مرکوز کرتا ہے بجائے اس کے کہ خاندان پیچیدہ مطالبات اور وسائل کی رینج کے ساتھ کیسے موافقت کرتے یا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اس احساس نے ذہنی معذوری والے شخص کے خاندان کے لیے مثبت پہلوؤں، اور ان انعامات و اطمینان پر تحقیق کو تحریک دی ہے جو یہ لا سکتا ہے۔

انعامات اور اطمینان

صرف خاندانی تناؤ کی نشاندہی خاندان پر معذوری کے اثرات کی مکمل تصویر نہیں دیتی۔ محققین نے تسلیم کیا ہے کہ دیکھ بھال کرنے والے کردار کا تعلق اپنے انعامات کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کے مستفید اور مجموعی طور پر خاندان کے لیے فوائد سے ہے۔ انعامات خاندان پر تناؤ کو کم کرنے کے لیے مقابلے کے میکانزم سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور ان مثبت فوائد سے وابستہ ہیں جو معذور شخص نے خاندان کو دیے ہیں۔ محققین نے بنیادی موضوعات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے (شکل 1)۔

انعامات کے تصور کا مطلب یہ نہیں کہ خاندان تناؤ کا تجربہ نہیں کرتے اور کچھ شواہد ہیں کہ تناؤ اور انعامات کے پھیلاؤ کے درمیان تعلق ہے۔ یہ مضر کہ مشکلات پر قابو پانا انعام کا ایک بڑا ذریعہ ہے دیکھ بھال کرنے والوں کے انٹرویوز میں ایک بار بار آنے والا موضوع ہے۔

ایکو کلچرل ماڈل

اس ماڈل کی اہمیت، جو (Bonfenbrenner 1979) کے تیار کردہ 'سماجی ماحولیات' ماڈل سے ماخوذ ہے، یہ ہے کہ یہ تجویز کرتا ہے کہ افراد اور خاندان تنہائی میں نہیں بلکہ معاشرے کے اندر وسیع تر تعلقات کے سیاق میں موجود ہیں۔ کسی فرد یا خاندان کی کارکردگی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ وسیع تر سیاق سے کیسے تعلق رکھتے ہیں، جو ان پر اثر ڈالتا ہے، اور وہ وسیع تر سیاق کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ایسے تعلقات کی مثالوں میں کام کی

جگہ کی لچک شامل ہے، جو کام اور دیکھ بھال کی ذمہ داریوں میں توازن کو آسان بنا سکتی ہے، اور یہ کہ خصوصی ذہنی معذوری کی خدمات اپنے خاندان کے ساتھ رہنے والے ذہنی معذور شخص کی کیسے معاونت کرتی ہیں۔

موافقتیں: ایکو کلچرل ماڈل تجویز کرتا ہے کہ خاندان خاندانی زندگی کا ایک بامعنی اور روزمرہ معمول تخلیق کرتے ہیں۔ اس معمول کو تخلیق کرنے کے لیے خاندانوں کو ان پر ڈالے گئے اکثر متضاد دباؤ کا مختلف طریقوں سے جواب دینا ہوگا۔ ان جوابات کو 'موافقتیں' (accommodations) کہا جاتا ہے۔ موافقتیں نہ صرف خاندان کے اندر بلکہ وسیع تر سماجی سیاق کے اندر ہیں، خاندان ایک ایکو کلچرل 'طاق' بناتا ہے۔ تصور کی اہمیت یہ ہے کہ یہ خاندانوں کے طرز عمل کو ہم آہنگ کنندہ سمجھتا ہے۔ خاندان سے باہر کے پہلوؤں پر زور دے کر یہ خاندانی موافقت پر خدمات اور معاشرے کے اثرات کی کھوج کی اجازت دیتا ہے۔

موافقت کا عمل تمام خاندانوں میں مشترک ہے، اور ذہنی معذوری والے شخص کے خاندانوں کے سلسلے میں مخصوص موافقتی متغیرات کی نشاندہی کی گئی ہے:

- خاندانی گزر بسر اور مالی بنیاد
- صحت یا تعلیمی خدمات تک رسائی
- گھر اور برادری کی حفاظت و سہولت
- خاندان کے لیے گھریلو کاموں اور چھوٹے موٹے کاموں کا بوجھ
- دیکھ بھال کے کام
- سماجی کاری
- ازدواجی کردار کے تعلقات
- سماجی معاونت
- باپ کا کردار
- معلومات اور مشورے کے ذرائع۔

سماجی ماحولیاتی ماڈل

معذور بچے کا والدین صحت کی دیکھ بھال یا اسکولوں تک رسائی بہتر بنانے کے لیے ملازمت بدل سکتا ہے اور یہاں تک کہ خاندانی گھر منتقل کر سکتا ہے۔ بہن بھائی گھریلو کام سنبھال سکتے ہیں اور خاندان نئے سماجی معاونتی نیٹ ورک چھوڑ یا بنا سکتے ہیں، وکالت کے گروہوں میں شامل ہو سکتے ہیں یا دیگر دیکھ بھال کرنے

والوں سے روابط بنا سکتے ہیں۔ وہ جو موافقتیں کرتے ہیں وہ ان پر دستیاب ایکو کلچرل رکاوٹوں/وسائل پر منحصر ہوتی ہیں۔

ذہنی معذوری والے افراد کے خاندان عام طور پر کئی موافقتیں کرتے ہیں، جو خاندانی معمول کو برقرار رکھنے کے لیے وقت کے ساتھ شدت اور تعدد میں بدلتی ہیں۔ خدمات کے لیے اس کے اہم مضمرات ہیں، جو اکثر موافقتوں کی تعداد اور شدت بڑھا دیتی ہیں جو خاندانوں کو کرنی ہوں گی؛ مثال کے طور پر، گھر میں طرز عمل کی مداخلتیں کافی مقدار میں موافقت شامل کر سکتی ہیں۔ ایکو کلچرل ماڈل خاندانی زندگی کے دیگر پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتا ہے جنہیں دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کے علاوہ برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس تحقیق کا مجموعی اثر خاندانوں کی موافقتوں کی نفاست کو ظاہر کرنا رہا ہے اور مستقبل کی دیکھ بھال کی مطالبات کے لیے جو وہ تیاری موافقتیں کرتے ہیں۔ اکثر سالوں پہلے۔ جو ان پر ڈالے جاسکتے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔

(یہ مضمون پہلی بار Psychiatry؛ جلد 9:2، ستمبر 2003ء میں شائع ہوا اور Medicine Publishing Company کی مہربان اجازت سے دوبارہ شائع کیا گیا)۔

اثرات

دیکھ بھال کی ذمہ داریاں اس شخص کے لیے بدلے یا ترک کیے گئے کیریئر کے منصوبوں کا باعث بن سکتی ہیں جس نے یہ ذمہ داری لی یا دی گئی ہے۔ خاندان کی خواتین ارکان کے دیکھ بھال کے کردار لینے کا زیادہ امکان ہے اور اس طرح اپنے کام کے کردار ترک یا بدل دیتی ہیں۔

دیکھ بھال اور امداد فراہم کرنے کا روزمرہ دباؤ تھکن اور تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے، خاندانی ارکان کی جسمانی اور جذباتی توانائی کو متاثر کرتا ہے۔ جذباتی دباؤ پیدا کرنے والے مسائل کا ایک پورا مجموعہ ہے، بشمول فکر، شرمندگی، بے چینی، غصہ، اور معذوری کے سبب کے بارے میں غیر یقینی، مستقبل کے بارے میں، خاندان کے دیگر ارکان کی ضروریات کے بارے میں، اس بارے میں کہ آیا کوئی کافی امداد فراہم کر رہا ہے، وغیرہ۔ معذور شخص کے فعل کے نقصان پر سوگ آغاز کے وقت تجربہ کیا جاتا ہے، اور اکثر شخص کی زندگی کے دیگر مراحل میں بار بار۔

معذوری خاندان کے وقت، توانائی اور پیسے کے وسائل کا غیر متناسب حصہ کھا سکتی ہے، تاکہ دیگر انفرادی اور خاندانی ضروریات پوری نہ ہوں۔ خاندان اکثر "ایک دن ایک وقت میں" چینے کی بات کرتے ہیں۔ خاندان کی طرز زندگی اور تفریحی سرگرمیاں بدل جاتی ہیں۔ مستقبل کے لیے خاندان کے خواب اور منصوبے ترک کیے جاسکتے ہیں۔

دوست، پڑوسی اور برادری کے لوگ معذوری پر گریز، توہین آمیز تبصرے یا نظروں، یا معذور افراد اور ان کے خاندانوں کو خارج کرنے کی کھلی کوششوں سے منفی ردِ عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔

معذوریاں کئی ابعاد کے ساتھ مختلف ہوتی ہیں، بشمول معذوری کی ڈگری اور قسم (حسی، حرکی یا شناختی)؛ معذوری کی نمایاں پن کی ڈگری؛ چاہے حالت کا رخ مستقل، دوبارہ آنے والا یا ترقی پذیر ہو؛ شخص کی تشخیص یا متوقع عمر؛ دریا دیگر علامات کی مقدار جو تجربہ کی جاتی ہے؛ اور درکار دیکھ بھال یا علاج کی مقدار۔

خاندان کو بڑھتی ہوئی دیکھ بھال کی مطالبات، انحصار کی ڈگری اور کون سا رہنے کا انتظام بہتر ہے کے بارے میں غیر یقینی، نیز مسلسل نقصان پر سوگ کا سامنا ہے۔

ان خاندانوں کو بڑھتے ہوئے دباؤ سے مسلسل دوبارہ ہم آہنگ ہونا ہوتا ہے اور بیرونی وسائل تلاش کرنے اور استعمال کرنے کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔

عام آبادی کے مقابلے میں معذوریوں والے خاندانوں کی خصوصیت غربت زیادہ کثرت سے ہوتی ہے۔ نسلی اور اقلیتی گھرانوں، واحد والدین والے خاندانوں اور متعدد معذور ارکان والے گھرانوں میں معاشی تنگی زیادہ واضح ہے۔ غربت صحت اور زندگی کے معیار کا ایک بڑا سماجی تعین کنندہ ہے۔

ایک خصوصی شمارے میں تعارف: خاندانوں اور معذوریوں پر خصوصی شمارہ

بقلم Heather Dillaway، WAYNE STATE UNIVERSITY و Jennifer Haskin

جلد 17، شمارہ 1، 2013ء، صفحات i-iv

مستقل ربط: <http://hdl.handle.net/2027/spo.4919087.0017.101>

معذور ارکان والے خاندانی رویوں اور نمونوں پر شمارے میں شائع ہونے والے مقالے۔ (شمارے میں شائع ہونے والے مقالوں کے اقتباسات...)

(2002) Shildrick اور دیگر معذوری کے علماء تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں "معذوری" کو "نقص" کے طور پر سوچنا چاہیے۔ یعنی، وسیع طور پر بیان کیا گیا، معذوری عام طور پر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کی اپنی سماجی دنیا اور تعلقات میں چلنے یا معاشرے میں مکمل طور پر حصہ لینے کی صلاحیت میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ یہ نقص یا رکاوٹ جسمانی، شناختی یا جذباتی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر ہم معذوری کے بارے میں پہلے اور سب سے پہلے جسمانی جسم سے متعلق سوچتے ہیں لیکن معذوری کے علماء ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شناختی اور/یا ذہنی معذوریاں افراد کو اتنا ہی متاثر کرتی ہیں جتنا کوئی جسمانی نقص کر سکتا ہے۔

جب معذور افراد کی صحت کی دیکھ بھال، معاوضہ شدہ کام یا نقل و حرکت میں رکاوٹیں ہوں، تو اکثر خاندانی ارکان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کمی پوری کریں۔ جب معذور افراد معاشرے میں اپنی شرکت کی کسی بھی

شکل میں رکاوٹوں یا پابندیوں کا تجربہ کرتے ہیں، یا اپنی روزمرہ زندگی گزارنے میں کوئی بھی مشکل، تو وہ اپنی مایوسیوں خاندانی ارکان پر نکال بھی سکتے ہیں یا ان احساسات کو ان کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ اس طرح، خاندان ان رکاوٹوں اور پابندیوں کے نتائج سے نمٹتے ہیں جن کا معذور افراد سامنا کر سکتے ہیں۔

برادری

خاندان اکثر رپورٹ کرتے ہیں کہ معذور شخص ان کے لیے بڑا بوجھ نہیں ہے۔ بوجھ برادری کے ان لوگوں سے نمٹنے سے آتا ہے جن کے رویے اور طرز عمل معذور فرد اور اس کے خاندان کے بارے میں فیصلہ کن، داغدار کرنے والے اور مسترد کرنے والے ہیں (Knoll 1992; Turnbull et al. 1993)۔ خاندانی ارکان رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ منفی رویے اور طرز عمل اکثر ان کے دوستوں، رشتہ داروں اور خدمت فراہم کنندگان کے ساتھ ساتھ اجنبیوں کی خصوصیت ہیں (Patterson and Leonard 1994)۔

جب معذور بچے اسکولی ماحول میں جاتے ہیں جہاں وہ اساتذہ اور ہم عمروں سے تعامل کرتے ہیں، تو انہیں کاموں میں مہارت حاصل کرنے اور سماجی مہارتوں و صلاحیتوں کی نشوونما میں مشکلات کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اسکولوں کو حکم ہے کہ معذور بچوں کے لیے کم سے کم پابندی والے ماحول میں خصوصی تعلیمی پروگرام فراہم کریں اور انضمام کو زیادہ سے زیادہ کریں، پھر بھی اسکول یہ کتنے موثر طریقے سے کرتے ہیں اس میں کافی تغیر ہے۔ رکاوٹوں میں خصوصی تعلیم کے لیے ناکافی مالی اعانت؛ ناکافی تربیت یافتہ اسکولی عملہ؛ اور، بہت اکثر، دیگر بچوں اور عملے کی رویاتی رکاوٹیں شامل ہیں جو معذور طلبہ کے لیے مکمل شمولیت کو متاثر کرتی ہیں۔ معذور بچوں کے والدین اپنے بچوں کے تعلیمی حقوق یقینی بنانے میں اضافی چیلنجوں کا ایک پورا مجموعہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں، اسکولوں اور دیگر خدمت فراہم کنندگان سے تنازعہ خاندانوں کے لیے دباؤ کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے (Walker and Singer 1993)۔ دیگر صورتوں میں، اسکولی پروگرام خاندانوں کے لیے ایک بڑا وسیلہ ہیں۔

عام آبادی کے مقابلے میں معذوریوں والے خاندانوں کی خصوصیت غربت زیادہ کثرت سے ہوتی ہے۔ نسلی اور اقلیتی گھرانوں، واحد والدین والے خاندانوں اور متعدد معذور ارکان والے گھرانوں میں معاشی تنگی زیادہ واضح ہے۔ غربت صحت اور زندگی کے معیار کا ایک بڑا سماجی تعین کنندہ ہے۔

7.6 خود احتسابی سوالات

1. رویے کے اجزا کیا ہیں؟
2. رویے کے افعال لکھیں؟
3. مثبت اور منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں؟

4. ان عوامل کی وضاحت کریں جو مثبت اور منفی سوچ کی نشوونما کو تیز کرتے ہیں؟
5. اسٹگما شخص کی خصوصیات کو کیسے بیان کرتا ہے؟
6. منفی رویے کو مثبت میں کیسے بدلا جاسکتا ہے؟
7. لیبل کون سی تصاویر یا احساسات پیدا کرتے ہیں؟

7.7 حوالہ جات

- Baron, R. A., Byrne, D., & Suls, J. (1989). Attitudes: Evaluating the Social •
, World. Baron et al, Social Psychology. 3rd edn. MA: Allyn and Bacon
.79-101
- :Eagly and Chaiken, (1993). The Psychology of Attitudes, Fort Worth, TX •
.Harcourt Brace Jovanovich
- :Hogg, M., & Vaughan, G. (2005). Social Psychology (4th edition). London •
Prentice-Hall
- How to cite this article: McLeod, S. A. (2009). Simply Psychology; . Retrieved •
/February 2012, from <http://www.simplypsychology.org/24attitudes.html>
- Barnes C, Mercer G, Shakespeare T. Exploring Disability: A Sociological •
.Introduction. London: Polity Press, 1999
- :Bonfenbrenner U. The Ecology of Human Development. Cambridge, MA •
.Harvard University Press, 1979
- Gallimore R, Weisner T S, Bernheimer L P, Guthrie D, Nihira K. Family •
responses to young children with developmental delays: accommodation
:activity in ecological and cultural context. Am J Ment Retard 1993; 98
.185-206
- Glidden L M, Kiphart M J, Willoughby J C Bush B A. Family Functioning •
when Rearing children with developmental disabilities. In: Turnbull A P et

- al., eds. Cognitive Coping, Families and Disability: Participatory Research
.in Action. Baltimore, MD: Paul H Brookes, 1993
- Grant G, Ramcharan P, McGrath M, Nolan M, Keady J. Rewards and •
gratifications among family caregivers: towards a refined model of caring
.and coping. J Intellect Disabil Res 1998; 42: 58-71
- :Hill R. Genetic features of families under stress. Social Casework 1958; 49 •
.139-50
- Kazak A E. Families with physically handicapped children: social ecology •
.and family systems. Fam Process 1986; 25: 265-81
- Nolan M, Grant G, Keady J. Understanding Family Care: A •
Multidimensional Model of Caring and Coping. Buckingham: Open
.University Press, 1996
- Olshansky S. Chronic sorrow: a response to having a mentally defective •
.child. Social Casework 1962; 43: 190-3
- Seligman M, Darling R B. Ordinary Families, Special Children: A Systems •
.Approach to Childhood Disability. New York: Guilford, 1989
- Shearn J, Todd S, Parental work: an account of the day-to-day activities of •
:parents of adults with learning disabilities. J Intellect Disabil Res 1997; 41
.285-301
- Stainton T, Besser H. The positive impact of children with an intellectual •
.disability on the family. J Intellect Dev Disabil 1998; 23: 55-70

یونٹ 8: اسکول میں خصوصی ضروریات کی تنظیم و انتظام

مصنفہ: Dr. Hina Noor – نظر ثانی: Dr. Zahid Majeed

تعارف

J.B. Sears کے مطابق تنظیم «کام کرنے کی ایک مشین» ہے۔ یہ بنیادی طور پر افراد، مواد، خیالات، تصورات، علامات، فارم، اصولوں یا قواعد کے مجموعے پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ یا زیادہ تر ان کے امتزاج پر۔ یہ مشین خود کار بھی چل سکتی ہے، یا اس کا عمل انسانی فیصلے اور مرضی کے تابع بھی ہو سکتا ہے۔

انتظام ایک فن بھی ہے اور ایک سائنس بھی؛ یہ فن اس لیے ہے کہ اس میں مہارتوں کا اطلاق شامل ہوتا ہے، اور سائنس اس لیے کہ یہ تجربات اور مشاہدے کے ذریعے تیار کردہ منظم علم کا مجموعہ ہے۔ اسکول کا انتظام اسکول کو ترقی کی طرف لے جانے کا ایک عمل ہے۔ نہ صرف انسانی وسائل، جسمانی وسائل، اصولوں اور تصورات کے بہترین استعمال سے، جو اسکول کے تمام مقاصد حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں، بلکہ ان سب کے درمیان مناسب ہم آہنگی اور مطابقت سے بھی۔

اسکول کے تنظیمی ڈھانچے طلبہ کی تعلیم کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر تعلیمی سطح پر، اسکول کا تنظیمی نمونہ اس انداز پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے جس میں طلبہ اور اساتذہ آپس میں میل جول رکھتے ہیں۔ یہ تمام اسکول بھر کے ڈھانچے اس طرح ڈیزائن کیے جانے چاہئیں کہ اساتذہ اور طلبہ کی لچک کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، گہرائی سے پڑھانے اور سیکھنے کی حوصلہ افزائی ہو، اور زیادہ سے زیادہ مختلف وسائل کو مربوط کیا جائے۔

خصوصی اسکول ایسا اسکول ہے جو ان طلبہ کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے جنہیں شدید سیکھنے کی دشواریوں، جسمانی معذوریوں یا رویے کے مسائل کی وجہ سے خصوصی تعلیمی ضروریات ہوتی ہیں۔ خصوصی اسکول خصوصی طور پر ڈیزائن، عملے سے لیس اور وسائل سے آراستہ ہو سکتے ہیں تاکہ اضافی ضروریات والے بچوں کو مناسب خصوصی تعلیم فراہم کی جاسکے۔ خصوصی اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ عموماً مین اسٹریم (مرکزی دھارے کے) اسکولوں کی کسی کلاس میں نہیں جاتے۔ خصوصی تعلیم کے انتظامی ڈھانچے کا بنیادی مقصد اسکولوں میں ایسے ماحولیاتی حالات فراہم کرنا اور برقرار رکھنا ہے جو خصوصی ضروریات والے بچوں کی نشوونما اور سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوں۔ ہر خصوصی تعلیمی پروگرام اس طرح تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ ہر انفرادی طالب علم کی منفرد ضروریات کو پورا کرے۔ خصوصی اساتذہ خدمات کی ایک سلسلہ وار لائن فراہم کرتے ہیں، جس میں خصوصی ضروریات والے طلبہ کو ان کی انفرادی ضروریات کی بنیاد پر

مختلف درجوں کی مدد ملتی ہے۔ خصوصی تعلیمی پروگراموں کو انفرادی نوعیت کا ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی طالب علم میں ضروریات کے منفرد امتزاج کو پورا کر سکیں۔

تمام بچوں کی طرح، غیر معمولی خصوصیات والے بچوں کو بھی ماحولیاتی استحکام، جذباتی پرورش اور سماجی قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر معمولی خصوصیات والے بچوں کو خصوصی تعلیم فراہم کرنے کے فیصلے ان کے گھر، اسکول اور کمیونٹی کے تعلقات، ان کی ذاتی ترجیحات، اور خود تصور پر اثرات کے علاوہ دیگر درست تعلیمی پہلوؤں پر غور کے بعد کیے جانے چاہئیں۔ تمام بچوں، نوجوانوں اور جوان بالغوں کے لیے ابتدائی مداخلت، تعلیمی اور پیشہ ورانہ پروگراموں کے آپشنز اور تجربات کی بھرپور اقسام موجود ہونی چاہئیں۔ ان پروگراموں اور تجربات تک رسائی انفرادی تعلیمی ضرورت اور مطلوبہ نتائج کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ مزید یہ کہ طلبہ اور ان کے خاندان یا سرپرست، منصوبہ بندی کی ٹیم کے ارکان کے طور پر، پلیسمنٹ، نصابی آپشن اور حاصل کیے جانے والے اخراجی دستاویز کی سفارش کر سکتے ہیں۔ غیر معمولی خصوصیات والے بچوں کی کیریئر کی صلاحیتیں محفوظ کام سے لے کر مسابقتی کام اور رہائشی انتظامات تک ہو سکتی ہیں۔ غیر معمولی خصوصیات والے بچوں کو کیریئر تعلیمی تجربات کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی وسیع رینج کی صلاحیتوں، ضروریات اور دلچسپیوں کو زیادہ سے زیادہ حد تک پروان چڑھائیں۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد، آپ یہ سمجھنے کے قابل ہوں گے:

1. اسکول کی تنظیم اور انتظام میں شامل عمل کے مقاصد۔
2. کلاس روم کے عمل کے لیے مربوط سرگرمیوں کے نظام کے تقاضے۔
3. اسکول میں شامل عمل کے لیے معیاری اشاریہ۔
4. استاد/ادارے کے سربراہ کے طور پر درکار مختلف منصوبوں اور تنظیمی مہارتوں کا استعمال۔
5. پیشہ ورانہ ترقی، وابستگی، صلاحیتوں، رویوں، اسکول کے ترقیاتی منصوبے، جسمانی اور انسانی وسائل کے انتظام، وقت کے انتظام اور کمیونٹی تعلقات میں رہنمائی کی ذمہ داریاں۔
6. متبادل تعلیم کی ضروریات اور اسے نصاب میں ضم کرنا۔
7. متنوع اور مؤثر کلاس روم انتظامی مہارتیں۔
8. مسلسل اور جامع جائزے کے لیے مختلف اوزار اور تکنیکوں کی ضرورت۔

8.1 خصوصی تعلیمی ضروریات

» خصوصی ضروریات « ایک وسیع اصطلاح ہے۔ خصوصی تعلیمی ضروریات کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: «کسی شخص کی مستقل جسمانی، حسی، ذہنی صحت یا سیکھنے کی معذوری، یا کسی بھی ایسی کیفیت کی وجہ سے تعلیم میں حصہ لینے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت میں رکاوٹ، جس کے نتیجے میں وہ شخص اس حالت کے بغیر والے شخص سے مختلف انداز میں سیکھتا ہے۔» خصوصی تعلیمی ضروریات معذوری کے چار مختلف شعبوں سے پیدا ہو سکتی ہیں:

- جسمانی
- حسی
- ذہنی صحت
- سیکھنے کی معذوری

یا کسی بھی ایسی کیفیت سے جس کے نتیجے میں بچہ اس کیفیت کے بغیر والے بچے سے مختلف انداز میں سیکھے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایک بچہ معذور ہو سکتا ہے لیکن اس معذوری سے کوئی ایسی خصوصی تعلیمی ضروریات پیدا نہ ہوتی ہوں جن کے لیے اسکول میں اضافی مدد درکار ہو۔

کسی بچے یا نوجوان کو خصوصی تعلیمی ضروریات (SEN) ہوتی ہیں اگر اسے سیکھنے کی دشواریاں یا معذوریوں ہوں جو اس کے لیے اسی عمر کے بیشتر دوسرے بچوں اور نوجوانوں کے مقابلے میں سیکھنا مشکل بنا دیں۔ تو خصوصی تعلیمی ضروریات کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بچے یا نوجوان کو:

• سیکھنے کی دشواریاں ہوں۔ ابتدائی سالوں کے سیٹ اپ، اسکول یا کالج میں بنیادی مہارتیں حاصل کرنے میں

• سماجی، جذباتی یا ذہنی صحت کی دشواریاں ہوں۔ دوست بنانے یا بڑوں سے تعلقات رکھنے میں، یا ابتدائی سالوں کے سیٹ اپ، اسکول یا کالج میں مناسب رویہ اختیار کرنے میں

• سیکھنے کی مخصوص دشواری ہو۔ پڑھنے، لکھنے، عددی کام یا معلومات سمجھنے میں

• حسی یا جسمانی ضروریات ہوں۔ جیسے سماعت کی خرابی، بصارت کی خرابی یا جسمانی دشواریاں جو ابتدائی سالوں کے سیٹ اپ، اسکول یا کالج میں ان پر اثر ڈال سکتی ہوں

• رابطے کے مسائل ہوں۔ خود کو ظاہر کرنے یا دوسروں کی بات سمجھنے میں

• طبی یا صحت کی حالتیں ہوں۔ جو بچے یا نوجوان کی ترقی کو سست کر سکتی ہیں اور/یا جن کا علاج اس کی تعلیم پر اثر ڈالے۔

خصوصی تعلیمی ضروریات والے بچے سب سے پہلے بچے ہیں اور ان میں اسی عمر کے دوسرے بچوں سے بہت کچھ مشترک ہے۔ بچے کی نشوونما کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جو پورے بچے کو بناتے ہیں، جن میں شخصیت، رابطہ کرنے کی صلاحیت (زبانی اور غیر زبانی)، لچک اور طاقت، زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اس کی قدر کرنے کی صلاحیت، اور سیکھنے کی خواہش شامل ہے۔ ہر بچے کی انفرادی طاقتیں، شخصیت اور تجربات ہوتے ہیں، اس لیے مخصوص معذوریاں انفرادی بچوں پر مختلف انداز میں اثر ڈالیں گی۔ بچے کی خصوصی تعلیمی ضرورت پورے بچے کی تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ خصوصی تعلیم کی تعریف اس طرح کی کئی ہے: کوئی بھی تعلیمی فراہمی جو خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو، اور وہ فراہمی سے اضافی یا مختلف ہو جو عموماً عام کلاسوں میں اسی عمر کے طلبہ کے لیے کی جاتی ہے۔

8.2 خصوصی تعلیم کے لیے نصابی ڈیزائن

نصاب ان تمام سیکھنے کے تجربات پر مشتمل ہوتا ہے جو اسکول نے اپنے طلبہ کے لیے اسکول کے تعلیمی مقاصد اور اہداف کو فروغ دینے کے پروگرام کے طور پر ڈیزائن کیے یا جن کی حوصلہ افزائی کی ہو۔ اس میں تدریس و تعلم کا مواد، ساخت اور عمل شامل ہیں، جو اسکول اپنے تعلیمی مقاصد اور اقدار کے مطابق فراہم کرتا ہے۔

خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کے لیے تعلیم کے وسیع مقاصد میں شامل ہیں:

- ایک مناسب، وسیع اور متوازن نصاب تک رسائی کے ذریعے طالب علم کو ایک منفرد فرد کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بھرپور زندگی گزارنے کے قابل بنانا
- ایسی تعلیمی مدد فراہم کر کے جو اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے، طالب علم کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ خود مختار انداز میں کام کرنے کے قابل بنانا۔

طالب علم کا ماحول اس کی تعلیم میں ایک طاقتور عنصر ہے۔ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے؛ اور وہ مہارتیں اور علم جو تمام طلبہ اسکول لے کر آتے ہیں ان کی مستقبل کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اگر طالب علم کو اپنی تعلیم کا مکمل فائدہ حاصل کرنا ہے تو گھر اور اسکول کے درمیان قریبی تعاون ضروری ہے۔

یہاں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے نصاب کیسے ڈیزائن کیا جائے، جس میں طالب علم کے گروپ کی متعدد ضروریات کو پورا کرنے اور طلبہ کی ضروریات اور اسکول /

عملے کی دستیابی کے درمیان توازن تلاش کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ ان بچوں کے لیے نصاب ڈیزائن کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ طلبہ کی کچھ بنیادی ضروریات چند سادہ زمروں میں آتی ہیں:

جسمانی ضروریات - اس میں کھانے میں مدد، کھانے پینے کی مہارتیں، جسمانی حرکت، مجموعی اور باریک موٹر مہارتوں کی نشوونما، کھیل کھیلنا، اندرونی یا بیرونی جسمانی ماحول میں کام کرنا، اور واش روم کی مدد کی ضرورت شامل ہو سکتی ہے۔

علمی ضروریات - اس میں سوچنے کے عمل کی نشوونما شامل ہو سکتی ہے جیسے تنقیدی سوچ، استدلال، فیصلہ کرنا اور فیصلے کرنا اور انتخاب کرنا (آپ کے طلبہ اور ان کی ذہنی معذوری کی سطح کے لحاظ سے مختلف سطحوں کے ساتھ)۔

جذباتی ضروریات - اس میں جذبات بیان کرنے کے لیے خود کو ظاہر کرنے کی صلاحیت، جذبات پر مبنی زبان کا استعمال، چہرے کے تاثرات اور اشاروں کے ذریعے خیالات اور احساسات ظاہر کرنا وغیرہ شامل ہو سکتا ہے۔

سماجی ضروریات - اس میں دوسروں سے میل جول، دوستی بنانا، واضح سماجی اظہار، سوالات پوچھنا اور جواب دینا، باری باری بات کرنا اور گروپ کی صورت حال میں دوسروں کی بات سننا شامل ہو سکتا ہے۔

رابطے کی ضروریات - چونکہ رابطہ ایک نہایت اہم اور وسیع موضوع ہے، اس لیے بہت سے دیگر شعبوں میں بھی رابطے کی کچھ جھلک موجود ہے۔ رابطے کی ضروریات میں شامل ہو سکتے ہیں: ہاں/نہ میں جواب دینا، قابل اعتماد رابطے کا نظام استعمال کرنا (جیسے رابطہ بورڈ، اشارہ، سائن لینگویج یا وائس آؤٹ پٹ ڈیوائس)، اسکول کے ماحول سے باہر دوسروں سے میل جول، اور اسکول اور عوام میں مناسب انداز میں خیالات کا اظہار اور اشتراک۔

خود مختاری کی ضروریات - اس میں عوامی نقل و حمل استعمال کرنا، سامان منظم کرنا، کسی کام کے لیے درست اوزار اور آلات نکالنا، ضرورت پڑنے پر دوسروں کی مدد کرنا، پہل کرنا، قیادت دکھانا، غیر متوقع واقعات سے نمٹنا، اور روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں کی ذمہ داری لینا شامل ہو سکتا ہے۔

توازن تلاش کرنا

یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے نصاب کو متوازن رکھیں تاکہ طلبہ کی کامیابی کے لیے درکار تمام اہم شعبوں پر توجہ دی جائے، اور تاکہ طالب علم کے انفرادی تعلیمی منصوبے (Individualized Education Plan - IEP) کے اہداف پر کام کیا جاسکے اور امید ہے کہ وہ پورے بھی ہوں۔ رہنمائی کے طور پر، جب آپ خصوصی طلبہ کے لیے نصاب ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں تو اوپر دی گئی فہرست سے سرگرمیوں کی اقسام کا

امتزاز ہر دن اور ہر مہفتے بکھرا ہوا ہو۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ طلبہ سیکھنے کے تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں (جیسے خصوصی تعلیم سے متعلق خواندگی اور حسابی ضروریات کو پورا کرنا)، اور وہ اپنا سارا وقت کسی ایک پر نہیں لگا رہے جبکہ دوسروں کو نظر انداز کر رہے ہوں۔ کچھ طلبہ کے لیے، ہر دن کا آغاز ایک قابل پیشگوئی انداز میں کرنا (جیسے صبح کے سلام کا دائرہ اور پھر ایک حرکت کی سرگرمی) ہر دن رابطے کی ضرورت اور پھر مجموعی موثر جسمانی ضرورت کو مستقل طور پر پورا کرنے کا موقع دیتا ہے۔

مختلف پیشہ ور افراد، جیسے ماہرین نفسیات، اسپیشل اور لینگویج تھراپسٹ، نرسیں، آکیوپیشنل تھراپسٹ، فزیو تھراپسٹ وغیرہ کے ساتھ ساتھ نگہداشت کرنے والوں کا بھی خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کی تعلیم اور انتظام میں ایک دوسرے سے جڑا اور باہم منحصر کردار ہے۔ طلبہ کو اکثر ہیلتھ بورڈز، رضا کارانہ تنظیموں، مذہبی اداروں، اور تربیت اور روزگار کی ایجنسیوں جیسی ایجنسیوں سے مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہ رہنما خطوط اساتذہ اور اسکولوں کو کلیدی مہارتوں اور علم اور نصاب کے مواد کے درمیان اہم اور لچکدار تعلقات قائم کرنے کے قابل بنائیں گے۔

فراہمی میں لچک

طالب علم جو نصاب تجربہ کرے گا وہ عمر اور نشوونما کے مرحلے دونوں کے لیے گنجائش رکھے گا۔ تاہم، اگر اسے سب سے موثر انداز میں پیش کرنا ہے تو لچک کی ضرورت ہے۔ اس میں مین اسٹریم تعلیم یا خصوصی تعلیم میں مکمل وقتی نصابی تجربے کی گنجائش ہونی چاہیے، بلکہ جہاں مناسب ہو وہاں دونوں میں جزوقتی تجربے کے امتزاج کی بھی۔ اس میں ان عملی باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا جو ان طلبہ کے لیے گروپ اور انفرادی دونوں تجربات فراہم کرنے میں شامل ہیں جن کی متعدد اور پیچیدہ ضروریات ہو سکتی ہیں۔

خاص طور پر، وہ تعاون پر مبنی اور گروپ کام جو ہم عمر سیکھنے (peer learning) کی حوصلہ افزائی کرے، بہت اہم ہے۔ طلبہ کو بتدریج اپنی تعلیم پر قابو پانا اور اس کی ذمہ داری لینا شروع کرنی چاہیے۔ خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کو انتخاب اور فیصلے کرنے کے قابل بنایا جانا چاہیے، اور یہ صرف ایک قبول کرنے والے ماحول کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے جو ہم عمر سیکھنے اور گروپ تعامل کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے تنوع اور انفرادیت کا جشن منائے۔

پورے اسکول کے نقطہ نظر

خصوصی ضروریات والے انفرادی طالب علم کو الگ تھلگ علاج کرنے کے بجائے، مجموعی طور پر کلاس یا گروپ کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور ان سیکھنے کے مواقع کی نشاندہی کرنا ضروری ہے جو تمام بچوں کے لیے موجود ہیں۔ منصوبہ بندی کے پورے اسکول کے نقطہ نظر طلبہ کے لیے دستیاب تعلیمی مواقع کو زیادہ سے زیادہ

بڑھا سکتے ہیں۔ یہ مواقع سیکھنے کی ضرورت کی بنیاد پر ہونے چاہئیں، سیکھنے کی دشواری کی بنیاد پر نہیں، اور جہاں مناسب ہو طالب علم کو ان ضروریات کی نشاندہی میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اساتذہ، والدین اور دیگر پیشہ ور افراد کو شامل کرنے والے لچکدار کثیر شعبہ جاتی اور بین شعبہ جاتی نقطہ نظر کو طالب علم کو تعلیمی عمل کے مرکز میں رکھنا چاہیے۔ جہاں تمام طلبہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کر رہے ہوں، عمر سے متعلق اور صلاحیت سے متعلق حصول کی سطحیں حقیقت بن جاتی ہیں، اور نصاب پر مبنی جائزہ بامعنی ہو جاتا ہے۔

خصوصی ضروریات والے بچوں کے لیے نصابی ڈیزائن کی ساخت میں شامل ہے:

- عام سیکھنے کی معذوریوں والے طلبہ کی تعلیم کے وسیع اصول اور مقاصد
- حقیقت پسندانہ، وقت سے منسلک اہداف کی نشاندہی
- انفرادی تعلیمی پروگراموں کا استعمال
- متنوع جائزی اوزاروں کا استعمال
- مہارتوں کے شعبوں میں نشوونما کی لائنیں، مختصر مثالوں کے ساتھ جو واضح کرتی ہیں کہ انھیں کیسے پروان چڑھایا جاسکتا ہے
- جہاں مناسب ہو وہاں پر انٹرمی اور پوسٹ پر انٹرمی دونوں سطحوں پر قومی نصاب سے نئے مواد اور ربط کے نکات
- پورے اسکول اور کلاس روم کی منصوبہ بندی کے نقطہ نظر جو اسکولوں اور اساتذہ کو خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کے لیے مناسب تعلیمی پالیسی تیار کرنے اور نافذ کرنے میں سہولت فراہم کریں گے
- خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کی تعلیم میں کثیر شعبہ جاتی نقطہ نظر کی ایک ریتخ۔
- ان لوگوں کے لیے جنہیں زیادہ خصوصی فراہمی درکار ہے، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ تجربے کے شعبوں کی مناسب ساخت کو ایک فریم ورک کے طور پر حوالہ دیا جاسکتا ہے۔

8.3 پلیسمنٹ اور انتظام

خصوصی ضروریات والے بچوں کے لیے دستیاب مختلف پلیسمنٹ آپشنز ذیل میں تعلیمی خدمات کے ایک تسلسل کی شکل میں دکھائے گئے ہیں، جو کم از کم سے لے کر مکمل اضافی مدد کی ضرورت تک ہیں۔

- ریگولر کلاس (Regular Class) میں وہ طلبہ شامل ہوتے ہیں جو اپنا زیادہ تر تعلیمی پروگرام ایک باقاعدہ کلاس روم میں حاصل کرتے ہیں اور اسکول کے دن کے 21 فیصد سے کم وقت کے لیے باقاعدہ کلاس روم سے باہر خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات حاصل کرتے ہیں۔
- ریسورس روم (Resource Room) میں وہ طلبہ شامل ہوتے ہیں جو اسکول کے دن کے کم از کم 21 فیصد لیکن 60 فیصد سے زیادہ نہ ہونے والے وقت کے لیے باقاعدہ کلاس روم سے باہر خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات حاصل کرتے ہیں۔
- علیحدہ کلاس (Separate Class) میں وہ طلبہ شامل ہوتے ہیں جو اسکول کے دن کے 60 فیصد سے زیادہ وقت کے لیے باقاعدہ کلاس روم سے باہر خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات حاصل کرتے ہیں۔
- علیحدہ اسکول (Separate School) میں وہ طلبہ شامل ہوتے ہیں جو معذوری والے طلبہ کے لیے علیحدہ ڈے اسکولوں میں خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات حاصل کرتے ہیں۔
- رہائشی سہولت (Residential Facility) میں وہ طلبہ شامل ہوتے ہیں جو سرکاری خرچ پر سرکاری یا نجی رہائشی سہولت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
- گھر / اسپتال کا ماحول (Home/Hospital Environment) میں وہ طلبہ شامل ہوتے ہیں جو اسپتال یا گھر میں رہنے والے پروگراموں میں رکھے جاتے ہیں اور خصوصی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

8.3.1 رہائشی اسکول / ڈے اسکول

بعض صورتوں میں، جب جاگنے کے تمام اوقات میں نگہداشت، ہدایات اور مداخلتوں کے تسلسل تک رسائی کی ضرورت ہو، تو یہ رہائشی اسکول کو ایک مناسب آپشن کے طور پر درکار ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ خاندانوں کو ان ضروریات کی فراہمی کے دباؤ میں بکھرنے سے بھی بچا سکتا ہے جب وسائل دستیاب نہ ہوں۔ رہائشی اسکول پلیسمنٹ کی بنیادی خصوصیات اور فوائد درج ذیل ہیں:

تسلسل کا سلسلہ: رہائشی اسکول کا ماحول اور اس کا عملہ منفرد طور پر اس قابل ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو تعلیمی موقع تک رسائی اور 24 گھنٹے سیکھی ہوئی مہارتوں کی مشق کا موقع دے۔ پیشہ ور عملہ اور اساتذہ آپ کے بچے کے دن کے تمام جاگنے کے اوقات میں مدد اور تقویت فراہم کرتے ہیں۔ وہی اشارے اور اشارتیں استعمال کی جاتی ہیں چاہے آپ کا بچہ کلاس میں ہو، کینٹین میں، تفریحی سرگرمیوں میں مصروف ہو یا

رہائش گاہ میں۔ کچھ اسکول والدین کو بھی تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ چھٹیوں اور وقفوں کے دوران گھر پر ان اشاروں کو جاری رکھ سکیں۔ چوبیس گھنٹے نرسنگ کیئر، جہاں دستیاب اور مناسب ہو، رہائشی اسکول کے نگہداشت کے تسلسل کا ایک اہم پہلو بھی ہے۔

محفوظ طریقے سے مشق کا موقع۔ اور لچک سیکھنا: رہائشی اسکول میں کنٹرول شدہ ماحول میں محفوظ طریقے سے مہارتوں کی مشق کے موقع اسکول کے اوقات سے پہلے اور بعد میں قدرتی ماحول میں مشق کے موقع میں بہہ جاتے ہیں۔ ایک بار پھر، پیشہ ور عملہ اور اساتذہ اسکول میں سیکھی ہوئی مہارتوں کی حمایت اور تقویت کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے کو یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ وہ بڑے آس پاس کی کمیونٹی میں کیسے لاگو ہوتی ہیں۔

اس کا اپنا ہم عمر گروپ: رہائشی اسکول کا ماحول خصوصی ضروریات والے بچوں کو اسکول کے دوران اور بعد میں ہم عمر گروپ کے تعامل کے موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اسکول کے دوران اور بعد میں ہم عمروں کے ساتھ تفریح کے لیے مزید وقت بھی دیتا ہے، ہر بچے کو اہم سماجی مہارتیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ تفریحی وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے بہت سے مواقع دیتا ہے۔ ایک اکثر نظر انداز کی جانے والی صلاحیت جو اس کی زندگی کے معیار کے لیے نہایت اہم ہے۔

زندگی بھر سیکھنا: نشوونما کی معذوریات اور دیگر خصوصی ضروریات بچے کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کر سکتی ہیں، جو کلاس روم سے کہیں آگے ہیں۔ خود کی دیکھ بھال، خود اعتمادی، باہمی تعلقات، پیشہ ورانہ مہارتیں، اور بہت سی دیگر اہم زندگی کی مہارتیں وہ شعبے ہیں جن پر توجہ دینی ضروری ہے۔ رہائشی اسکول کے پروگرام پورے بچے کو تعلیم دینے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ تعلیمی، سماجی، پیشہ ورانہ اور مزید۔ تاکہ وہ زندگی کو جتنا ممکن ہو بھرپور طریقے سے جی سکے۔

مسلسل سماجی تعامل: طلبہ ہمیشہ اپنے ہم عمروں کے ارد گرد ہوتے ہیں: کلاس میں، غیر نصابی سرگرمیوں میں اور اپنی رہائشی انتظامات میں۔ اس طرح، انھیں رسمی کلاس کے وقت سے باہر خود ہونے اور اپنی انفرادیت ظاہر کرنے کے بہت سے مواقع ملتے ہیں۔ یہ سماجی میل جول خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ ان میں اعتماد یا رابطے کی مہارتوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ رہنا انھیں ڈے اسکول کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ محسوس کرا سکتا ہے۔

اپنا خیال خود رکھنا: بہت سے والدین اپنے بچوں کو لاڈ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے یا کم از کم ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں زیادہ تر چیزیں سنبھالی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس، بورڈنگ اسکول میں، خصوصی ضروریات والے بچے خود مختاری سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر، اسے کھانا پکانا یا صفائی کرنی پڑ سکتی ہے۔ واقعی، کم عمری میں، آپ کا بچہ خود مختار اور محفوظ دونوں انداز میں رہ سکتا ہے۔

قربت: خصوصی ضروریات والے طلبہ کو اکثر کلاس سے باہر اضافی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ڈے اسکول بھیجتے ہیں، خاص طور پر ایسے اسکول جو آپ کے گھر سے قریب نہیں، تو آپ کو اسے صبح جلدی چھوڑنے یا اوقات کے بعد لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ بورڈنگ اسکول میں، آپ کا بچہ کیمپس کے قریب، اگر نہیں تو کیمپس میں ہی رہے گا۔ اس لیے، مدد مانگنا، جو خصوصی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے، ہمیشہ آسان اور ممکن رہے گا۔

غیر نصابی سرگرمیاں: اسکول کے بعد یا پہلے کے پروگرام سماجی میل جول اور کسی خاص مہارت کو نکھارنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ ایسی ہمہ جہت تعلیم خصوصی ضروریات والے بچے کا اعتماد بڑھانے اور اسکول کو زیادہ خوشگوار اور کم دباؤ والا بنانے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔

ان تمام مثبت اثرات کے باوجود جن کی وجہ سے رہائشی اسکول منتخب کیے جاتے ہیں، بچے کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

خاندان، دوستوں اور گھر سے دور پرورش: کسی بھی رہائشی اسکول کے ماحول کی طرح، آپ کا بچہ اپنے خاندان سے دور رہتے ہوئے بہت سے سنگ میل عبور کرے گا اور بہت سے معیارات حاصل کرے گا۔ اگرچہ بہت سے خاندان محسوس کرتے ہیں کہ رہائشی اسکول کا تجربہ درحقیقت خاندان کے ہر فرد کے درمیان تعلقات کو مالا مال اور بہتر بناتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بچہ اتنا اکثر اپنے گھر کی کمیونٹی میں نہیں ہوگا۔

غیر معذور ہم عمروں کے ساتھ کم انضمام: اس کا اپنا ہم عمر گروپ ہونے کا قدرتی مطلب غیر معذور ہم عمروں کے ارد گرد کم وقت گزارنا ہے۔ کچھ بچوں کے لیے، غیر معذور ہم عمروں کے ساتھ انضمام حوصلہ شکن ہو سکتا ہے، جبکہ دوسروں کے لیے یہ نہ صرف مناسب ہے بلکہ تجویز کردہ بھی ہے۔ ہم عمر گروپ بچے کی اپنی پوری صلاحیت دریافت کرنے اور اسے تلاش کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس طرح رہائشی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے خود اعتمادی اور خود سے توقعات پر اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔

ان فوائد اور چیلنجز کو ذہن میں رکھیں، پھر بھی ان بچوں کے لیے رہائشی اسکولوں کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا جن کے لیے رہائشی اسکول ہی واحد آپشن ہیں۔

8.3.2 سفر کرنے والا استاد / پیر پیپٹیک ٹیچر

سفر کرنے والے اساتذہ (Itinerant teachers) عموماً اہل اسکول اساتذہ ہوتے ہیں جنہوں نے خصوصی بچوں کی تعلیم میں کچھ رسمی تربیت حاصل کی ہوتی ہے۔ یہ اساتذہ مقامی مین اسٹریم اسکولوں اور کمیونٹیوں میں گھومتے ہیں تاکہ خصوصی ضروریات والے بچوں، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کو مشورہ، وسائل

اور مدد فراہم کر سکیں۔ سفر کرنے والے اساتذہ کے پروگرام سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ شراکت میں قائم کیے جاسکتے ہیں۔

سفر کرنے والا استاد عام طور پر ایک مکمل وقتی کوآرڈینیٹر کی ہدایت میں کام کرتا ہے۔ سفر کرنے والے اساتذہ معذوری والے طلبہ کو خدمات فراہم کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ روایتی کلاس روم اساتذہ کے طور پر کام کرنے کے بجائے، سفر کرنے والے اپنے کس لوڈ کے بچوں سے مختلف ماحولوں میں ملتے ہیں جن میں گھر، ابتدائی بچپن کے مراکز، اسکول، کمیونٹی پر بنی پروگرام، اور اسپتال شامل ہیں۔ وہ اپنے انفرادی تعلیمی منصوبوں (Individual Education Plans - IEP) میں اہداف اور مقاصد کے مطابق خصوصی ضروریات والے بچوں کو براہ راست خدمات اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ تعلیمی مہارتیں، رابطے کی مہارتیں، علمی نشوونما، سماجی نشوونما، مطابقتی مہارتیں، موثر مہارتیں، اور رویے کی مدد کچھ ایسے زمرے ہیں جن پر توجہ دی جاتی ہے۔ وہ طالب علم کے بنیادی استادیانگہداشت کرنے والے کو مشاورتی خدمات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

ایک سند یافتہ خصوصی تعلیمی استاد بچوں کو براہ راست خدمات اور مدد فراہم کرتا ہے، اور والدین اور ابتدائی بچپن کے پیشہ ور افراد کو مشورہ دیتا ہے۔ سند یافتہ خصوصی تعلیمی استاد اہداف اور علاجی حکمت عملیوں کے ساتھ ایک تحریری رپورٹ فراہم کرتا ہے، جو کلاس روم میں بچے کی خود مختاری کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے۔ خصوصی تعلیم کے سفر کرنے والے استاد کی خدمات بچے کی ضروریات کے مطابق انفرادی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور ان میں شامل ہو سکتے ہیں:

- علاجی مداخلتوں کے ذریعے بچے کو براہ راست مدد۔
- بچے کے انفرادی تعلیمی پروگرام کا نفاذ
- بچے کے رویے کے انتظام کے پروگرام کا نفاذ، ہم آہنگی اور نگرانی۔
- نرسری اسکول کے ڈائریکٹرز اور اساتذہ کے ساتھ تعاون۔
- کمیٹی برائے پری اسکول خصوصی تعلیم کے اجلاسوں میں شرکت؛
- بچے کے تعلیمی پروگرام کی اساتذہ، تھراپسٹوں اور والدین کے ساتھ ہم آہنگی
- والدین کے لیے اپنے بچے کی تعلیم میں شراکت کے مواقع۔

معذوری والے بچوں کے وہ اساتذہ جو پیر پیٹنٹنگ اساتذہ کے طور پر ملازم ہوتے ہیں، بہت سے کردار نبھاتے ہیں۔ موثر ہونے کے لیے ایسے اساتذہ کو تربیت یافتہ، تجربہ کار ہونا چاہیے اور اپنے فرائض انجام دینے کے

لیے مناسب وقت ہونا چاہیے۔ پیر پیڈیٹنگ استاد کو استاد، مشیر، کونسلر، سفارت کار، سیکھنے والا، ٹیکنیشن اور مینیجر ہونا چاہیے۔

بطور استاد

پیر پیڈیٹنگ اساتذہ پری اسکول کی عمر سے لے کر کالج کی عمر تک کے بچوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ انھیں مختلف ماحولوں میں کام کرنا ہوگا جن میں وسائل کی مختلف سطحیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ پیر پیڈیٹنگ اساتذہ کے پاس بچوں کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کرنے کے لیے مختلف تدریسی حکمت عملیوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ حکمت عملیاں اس وقت سب سے مؤثر ہوتی ہیں جب وہ عملی تدریسی صورتحال میں جمی اور تیار کی گئی ہوں۔ دوسرے لوگوں کے گھروں میں، پری اسکول کے بچوں کے ساتھ کام کرنا تدریس کی ایک عوامی شکل ہے؛ اگر تدریس اعلیٰ معیار پر نہ کی گئی اور والدین اپنے پیر پیڈیٹنگ استاد پر اعتماد کھو بیٹھیں، تو عام طور پر تدریسی پیشے کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔

بطور مشیر

والدین کو دیے جانے والے مشورے خرابی (IMPAIRMENT) یا معذوری کے اثرات کو منظم کرنے کی سمجھ اور تجربے پر مبنی ہونے چاہئیں۔ اس سمجھ اور تجربے کے بغیر، یہ ممکن ہے کہ دیا گیا مشورہ صورتحال کے لیے مناسب نہ ہو۔ اس لیے تربیت یافتہ سفر کرنے والا پیر پیڈیٹنگ استاد بہترین پوزیشن میں ہوتا ہے کہ والدین اور مین اسٹریم اساتذہ میں ان نتائج کی حقیقت پسندانہ سمجھ قائم کی جائے۔

بطور کونسلر

خصوصی ضروریات والے بچوں کی مدد کرنے والے تمام بالغ خود شک کے لمحات کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ سماجی اور جذباتی نشوونما کے لیے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اکثر ان بالغوں کی مدد کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ انھیں ماضی میں مشکلات کا سامنا رہا ہوگا اور وہ کونسلنگ کرتے وقت اس تجربے کو استعمال کر سکیں گے۔ مین اسٹریم اسکولوں میں پڑھنے والے بچے خصوصی اسکولوں میں پڑھنے والے اپنے ہم عمروں کے مقابلے میں سماجی تعاملات کے زیادہ سامنے ہوتے ہیں۔ اس لیے غلط فہمی کا زیادہ موقع ہوتا ہے۔ پیر پیڈیٹنگ اساتذہ، اپنی حاصل کردہ تربیت کی وجہ سے، ان بچوں کو سماجی غلط فہمیاں سمجھانے کے قابل ہوتے ہیں اور خصوصی ضروریات والے بچوں کو مین اسٹریم اسکولوں میں کامیاب انضمام میں نمایاں حصہ ڈال سکتے ہیں۔

بطور سفارت کار

اپنے اداروں میں دیگر پیشہ ور افراد کے ساتھ کام کرنے میں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پیر پیپٹیک استاد مین اسٹریم اساتذہ پر عائد پابندیوں سے آگاہ ہو اور ایسے مشورے دینے کی پوزیشن میں ہو جنہیں کامیابی سے لاگو کیا جاسکے۔ پیر پیپٹیک استاد کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ کون سا مشورہ دینا ہے اور کب۔

بطور سیکھنے والا

یہ ضروری ہے کہ سفر کرنے والا پیر پیپٹیک استاد موجودہ تبدیلیوں سے باخبر رہے اگر اسے خصوصی ضروریات والے بچوں اور نوجوانوں کی ضروریات پوری کرنی ہیں۔ خطرہ ہے کہ ان بچوں اور نوجوانوں کی سیکھنے کی ضروریات کی مناسب تربیت اور تجربے کے بغیر، جدتوں کو ایسے انداز میں اپنایا جاسکتا ہے جو نامناسب ہوں۔ سیکھنے والے کے طور پر سفر کرنے والا استاد اپنی تربیت اور تجربے کو بچے کے فائدے کے لیے جدتوں کا جائزہ لینے اور انہیں لاگو کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔

بطور ٹیکنیشن

خصوصی ضروریات والے کچھ بچے امدادی ٹیکنالوجی سے لیس ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سامان بچے کے لیے قیمتی ہونا ہے تو اسے مناسب ہونا چاہیے اور اعلیٰ معیار پر برقرار رکھا جانا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے استاد کے پاس کافی تکنیکی علم ہونا چاہیے جسے باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کیا جائے۔ اگر نامناسب فیصلوں سے بچنا ہے تو یہ مہارت ضروری ہے۔

بطور مینیجر

چونکہ پیر پیپٹیک استاد کا کردار وسیع ہے اور اسے آزادانہ کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس معذوری کے اساتذہ کے طور پر تربیت یافتہ اور تجربہ کار ہوں جس سے وہ بنیادی طور پر نمٹ رہے ہیں۔ جہاں ایسا ہو، والدین، اسکولوں اور بہروں (Deaf) کے اساتذہ کو مینیجر کی سفارشات اور فیصلوں پر زیادہ اعتماد ہوگا۔ مین اسٹریم اسکول کے ساتھ تشبیہ پر واپس جائیں تو یہ امکان نہیں کہ والدین کسی ایسے استاد کی سفارشات پر اعتماد کریں جنہیں وہ تدریس میں تجربہ کار نہ جانتے ہوں۔ اسی طرح سماعت سے محروم بچوں کے والدین اور مین اسٹریم اساتذہ تربیت یافتہ اساتذہ کی رہنمائی کے حقدار ہیں اور ان تک ان کی باقاعدہ اور براہ راست رسائی ہونی چاہیے۔

8.3.3 خصوصی تعلیم کے مشیر

خصوصی ضروریات والے تمام طلبہ کے لیے مفت، مناسب، عوامی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے، تعلیمی مشیر درج ذیل کے لیے ضروری ہیں:

1. خصوصی ضروریات والے تمام طلبہ کی تعلیمی بہبود کو متاثر کرنے والے مناسب قوانین، ضوابط اور پروگرام معیارات کی تشکیل اور نفاذ کے وکیل کے طور پر کام کرنا۔
2. مقامی، علاقائی اور رہائشی تعلیمی پروگراموں میں اساتذہ اور متعلقہ خدمات فراہم کرنے والوں کو قیادت فراہم کرنا اور مقامی منتظمین کے سامنے ان عملے کے وکیل کے طور پر کام کرنا؛
3. خصوصی تعلیم کے شعبے میں سند یافتہ مقامی اساتذہ اور سند یافتہ ماہرین کی تکنیکی مہارت کی سطح بڑھانے کے لیے پیشہ ورانہ ترقی کا مسلسل پروگرام فراہم کرنا جو طالب علم کے لیے مخصوص ہدایات، مواد کو ڈھالنے، ضروری سامان منگوانے، سفری تربیت فراہم کرنے وغیرہ کے ذمہ دار ہیں؛
4. مقامی اسکول ڈسٹرکٹ کے عملے اور رہائشی اسکول کے عملے کو مشیر کے طور پر کام کرنا اور دستیاب وسائل پر رہنمائی فراہم کرنا جب وہ مناسب طریقے سے ڈیزائن کردہ پروگرام جائزے اور بہتری کے طریقے انجام دیتے ہیں؛
5. منظم چائلڈ فائینڈ منصوبے ڈیزائن اور ان کا انتظام کرنا جو خصوصی تعلیمی خدمات کی ضرورت والے طلبہ کی مؤثر طور پر نشاندہی کریں گے، بشمول ریاستی سطح کے اسکریننگ پروگراموں کو رہنمائی فراہم کرنا؛
6. مردم شماری کے اعداد و شمار کے تجزیہ کار کے طور پر کام کرنا تاکہ کم سے کم پابندی والے ماحول میں خصوصی ضروریات والے تمام شناخت شدہ طلبہ کی خدمت کے لیے مناسب پروگرام ماڈلز کے تسلسل کے قیام کی سفارش اور نفاذ کیا جاسکے؛
7. یقینی بنانا کہ ریاست بھر میں خصوصی تعلیم کی فراہمی کے نظام کی حمایت کے لیے مناسب وفاقی، ریاستی / صوبائی اور مقامی فنڈنگ پروگرام فراہم کیے جائیں؛
8. کم سے کم پابندی والے اور سب سے مناسب ماحول میں خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے خصوصی تعلیمی ہدایات، مواد اور سامان کے جامع فراہمی کے نظام کی ترقی اور دیکھ بھال کے وکیل کے طور پر کام کرنا؛
9. یقینی بنانا کہ خصوصی تعلیم کی فراہمی کے نظام کے اندر ضرورت کے مطابق مناسب متعلقہ خدمات فراہم کی جائیں؛

10. عوامی رابطے کے نظام ڈیزائن اور ان کا انتظام کرنا جو تمام پروگراموں اور خدمات کو واضح طور پر بیان کریں جو خصوصی ضروریات والے طلبہ کو مفت، مناسب، عوامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر ضروری ہو سکتی ہیں؛

11. بین ایجنسی اور طبی کمیونٹی کے تعاون کو فروغ دینا تاکہ مجموعی تعلیمی نظام کے ساتھ مل کر خصوصی ضروریات والے طلبہ کو دیگر ضروری سماجی، پیشہ ورانہ، بحالی اور طبی خدمات کی ہموار فراہمی یقینی بنائی جا سکے؛

12. ریاستی / صوبائی اور قومی ایجنسیوں کو مناسب پروگراموں، خدمات اور ٹیکنالوجی کی طویل مدتی ترقی میں معلوماتی چینل کے طور پر کام کرنا؛

13. خصوصی ضروریات والے طلبہ کو تعلیم دینے اور / یا اورینٹیشن اور موبیلٹی کے شعبوں میں موجودہ عملہ تیاری پروگراموں کے وکیل کے طور پر کام کرنا یا ایسے پروگرام قائم کرنے کے لیے کام کرنا؛

14. اعلیٰ تعلیمی اداروں کو خصوصی طالب علم کے اساتذہ اور سند یافتہ اورینٹیشن اور موبیلٹی ماہرین کے لیے درکار تیار ہوتی صلاحیتوں کے بارے میں مشورہ دینا؛ اور

15. خدمت کی فراہمی کے نمونوں کی یکسانیت یقینی بنانے، تازہ ترین پالیسی، نصابی، تکنیکی اور پروگرامی ترقیات سے باخبر رہنے، اور ریاستی / صوبائی سطح کے اقدامات پر تعاون کے لیے قومی پیشہ ورانہ تنظیموں اور صارفین کے گروپوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ برقرار رکھنا؛

ان کاموں کو انجام دینے، اور رہنماؤں کے طور پر مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے، خصوصی تعلیم کے مشیر کے پاس خصوصی ضروریات والے طلبہ کی عمومی اور خصوصی تعلیمی ضروریات کا علم، سمجھ اور تجربہ ہونا چاہیے، بشمول وہ سیکھنے والے جو تحفہ یافتہ (Gifted)، خطرے میں (at-risk) اور / یا جن کی اضافی معذوریاں ہیں، اور انتظام اور مشاورت میں مہارت ہونی چاہیے۔ درج ذیل صلاحیتیں ضروری سمجھی جاتی ہیں:

1. طلبہ کے لیے مناسب خصوصی تعلیم کی خدمت کی فراہمی کا نظام ڈیزائن اور نافذ کرنے کی صلاحیت؛

2. ان طلبہ کے ساتھ کام کرنے والے سند یافتہ اساتذہ کی نگرانی، وکالت، ہم آہنگی اور مدد کرنے کی صلاحیت؛

3. ان طلبہ کی تعلیمی اور مطابقتی مہارت کی ضروریات کا جائزہ لینے، کام کی ذمہ داریوں کی ترجیحات کا تعین کرنے، اور وقت اور وسائل کا انتظام کرنے کی مہارت؛

4. فنڈز حاصل کرنے اور مالی معاملات کا انتظام کرنے کی صلاحیت؛

5. مناسب خدمت کی فراہمی کے نظام قائم کرنے کے لیے تبدیلی کے ایجنٹ کی مہارتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت؛

6. مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کی منصوبہ بندی اور نفاذ کی صلاحیت؛

7. دیگر پیشہ ور افراد جیسے مقامی اور ریاستی / صوبائی تعلیمی افسران، تدریسی مواد مرکز کے عملے، قانون سازوں، کالج / یونیورسٹی کے عملے، رہائشی اسکول کے عملے، والدین، اور کمیونٹی رضاکاروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت؛

8. با معنی مسئلہ حل کرنے میں مصروف ہونے کی صلاحیت؛

9. سیاسی رابطوں، اسکول اصلاحات، اور ریاستی / صوبائی اقدام کے نظام کا تجزیہ اور استعمال کرنے کی مہارت؛

10. وکالت کے کردار میں کام کرنے کی صلاحیت تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تمام طلبہ ریاستی / صوبائی سطح کے تعلیمی اقدامات میں شامل ہوں؛

11. تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تحقیقی مہارتوں کو لاگو کرنے کی صلاحیت؛

12. طلبہ اور ان کے تعلیمی پروگراموں کے لیے مناسب جائزے کے طریقہ کار کا انتخاب اور انتظام کرنے کی صلاحیت؛ اور

13. سہولت کاری اور مشاورت میں مہارت۔

تاکہ خرابی یا معذوری والے بچوں اور نوجوانوں، بشمول وہ جو تحفہ یافتہ، خطرے میں اور / یا جن کی اضافی معذوریاں ہیں، کو مستقل اعلیٰ معیار کی مفت، مناسب، عوامی تعلیم یقینی ہو، ریاستی / صوبائی محکمہ جات تعلیم کو کم از کم ایک مکمل وقتی تعلیمی مشیر برقرار رکھنا چاہیے جو خصوصی ضروریات والے طلبہ کی تعلیم میں خاص طور پر تربیت یافتہ اور تجربہ کار ہو۔

8.3.4 ریسورس روم

ریسورس روم اسکول میں ایک علیحدہ، اصلاحی کلاس روم ہوتا ہے جہاں تعلیمی معذوری والے طلبہ کو انفرادی طور پر یا گروپوں میں براہ راست، خصوصی ہدایات اور تعلیمی اصلاح اور ہوم ورک اور متعلقہ اسائنمنٹس میں مدد دی جاتی ہے۔ ریسورس روم وہ سیکھنے کی جگہیں ہیں جہاں خصوصی تعلیمی استاد معذوری کی شناخت والے طلبہ کو پڑھاتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ ان کلاس روموں میں خصوصی تعلیمی اساتذہ اور بعض اوقات پیرا پروفیشنلز عملے میں ہوتے ہیں۔ کسی مخصوص وقت پر ریسورس روم میں طلبہ کی تعداد مختلف ہوتی ہے، لیکن

عام طور پر فی انسٹرکٹر زیادہ سے زیادہ پانچ طلبہ ہوتے ہیں۔ مین اسٹریمنگ اور شمولیتی تعلیم میں عموماً خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے یہ سروس شامل ہوتی ہے۔

یہ طلبہ دن کے ایک حصے کے لیے انفرادی یا گروپ ماحول میں خصوصی ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ انفرادی ضروریات ریسورس رومز میں طالب علم کے انفرادی تعلیمی پروگرام (Individualized Education Program - IEP) کے مطابق پوری کی جاتی ہیں۔ اس قسم کی مدد حاصل کرنے والا طالب علم ریسورس روم میں کچھ وقت گزارے گا، جسے دن کے «باقاعدہ تعلیمی ماحول سے ہٹانے/نکالنے» والے حصے کے طور پر کہا جاتا ہے، اور کچھ وقت باقاعدہ کلاس روم میں ترامیم اور/یا سہولتوں کے ساتھ، جن میں ان کے غیر معذور ہم عمروں کے ساتھ خصوصی ہدایات شامل ہو سکتی ہیں۔ باقاعدہ تعلیمی ماحول میں خصوصی تعلیم کی مدد «شمولیت کے ماڈل» کا حصہ ہے۔

اکثر، ایک بچہ ماحولوں کے امتزاج میں خدمات حاصل کر سکتا ہے، مثال کے طور پر، جب ایک بچہ دن کے ایک حصے میں باقاعدہ تعلیمی کلاس روم میں پڑھتا ہے، اور بعض مضامین کے لیے خصوصی تعلیمی کلاس روم میں۔ کچھ طلبہ دن کے ایک حصے کے لیے باقاعدہ تعلیمی کلاس روم سے باہر ہونے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر تعلیمی مضامین کے لیے جہاں طالب علم کو باقاعدہ تعلیمی کلاس روم میں فراہم کی جانے والی سے زیادہ مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ طلبہ دن کے اس فیصد کے لیے ریسورس روم یا اکیڈمک سپورٹ کلاس روم میں پڑھ سکتے ہیں جو IEP ٹیم ضروری سمجھے اور باقی دن باقاعدہ تعلیمی کلاس روم میں پڑھیں۔ خدمات اور مدد ضرورت کے مطابق دونوں ماحولوں میں طالب علم کی پیروی کریں گی۔ ریسورس روم یا اکیڈمک سپورٹ کلاس روم کا استاد ایسے طلبہ کے ساتھ کام کرنے کی خصوصی تربیت رکھے گا جنہیں زیادہ خصوصی سہولتوں، ترامیم یا مطابقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقاعدہ تعلیمی ماحول کا استاد عام طور پر ایسی خصوصی تربیت نہیں رکھتا جو پیچیدہ مدد کی ضروریات والے طلبہ کے لیے درکار ہوتی ہے۔

ریسورس روم میں خصوصی تعلیمی انسٹرکٹر IEP کے ذریعے لازمی کردہ مخصوص اہداف اور اصلاحی عمومی تعلیمی نصاب پر توجہ دیتے ہیں۔ کچھ پروگرام ایگزیکٹو مہارتوں کی نشوونما پر زور دیتے ہیں، بشمول ہوم ورک مکمل کرنا اور رویہ۔ انفرادی ضروریات کے لحاظ سے، طلبہ عام طور پر ہفتے میں تین سے پانچ بار روزانہ تقریباً 45 منٹ ریسورس رومز میں پڑھتے ہیں۔ کچھ تحقیق نے تجویز کیا ہے کہ یہ کلاس روم زبان پر مبنی سیکھنے کی معذوریوں والے طلبہ، جیسے ڈسلیکسیا (dyslexia)، کے لیے خاص فائدہ مند ہیں۔ دیگر تحقیق نے اشارہ کیا ہے کہ ریسورس روم کلاس روم میں وقت گزارنے سے طلبہ بصری موٹر ادراک، حسابیات، ہجے اور مجموعی خود ادراک میں ترقی دکھاتے ہیں۔ ان خدمات کو استعمال کرنے والے طلبہ کو عموماً شامل سمجھا جاتا ہے۔ الگ تھلگ یا مین اسٹریم شدہ نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ دیگر کلاسوں میں پڑھتے ہیں، خاص طور پر ثانوی سطح پر۔ کم از کم ایک تحقیق نے تجویز کیا ہے کہ ریسورس رومز میں سیکھنے کی معذوری والے طلبہ کی

اپنی تعلیمی کامیابی کے بارے میں زیادہ توقعات ہوتی ہیں جب وہ کلاس میں ہوتے ہیں۔ یہ ریسورس روم کے استاد سے واقفیت، چھوٹے گروپ کی براہ راست ہدایات یا کسی ایسے شعبے میں اعتماد کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس میں وہ آرام دہ ہیں۔ محققین کا ماننا ہے کہ واضح ہدایات جو کاموں کو چھوٹے حصوں میں توڑتی ہیں، سیکھنے کی معذوری والے طلبہ کے لیے سیکھنے کا ایک اہم اوزار ہیں۔ طلبہ اکثر بنیادی تصورات کی «دوبارہ تدریس» سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ابتدائی طور پر عمومی تعلیمی کلاس روم میں پڑھانے گئے اور ریسورس رومز میں چھوٹے گروپ کے تدریسی ماڈل کے ذریعے مضبوط کیے گئے، جو تعلیمی معذوریوں کی کثیر اقسام والے طلبہ میں کامیابی کا باعث دکھایا گیا ہے۔

8.4 خصوصی تعلیم کے استاد کی صلاحیتیں

خصوصی تعلیمی استاد درج ذیل شعبوں میں علم اور/یا صلاحیتیں ظاہر کرے گا:

1. سیکھنے والے کی نشوونما اور انفرادی سیکھنے کے فرق

• غیر معمولی خصوصیات والے افراد کی تعلیم پر زبان، ثقافت اور خاندانی پس منظر کے اثرات کو سمجھنے کی صلاحیت۔

• غیر معمولی خصوصیات والے افراد کی ضروریات کا جواب دینے کے لیے انسانی نشوونما اور انفرادی فرق کی سمجھ کو استعمال کرنے کی صلاحیت۔

2. سیکھنے کا ماحول

• عمومی اساتذہ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ تعاون کے ذریعے محفوظ، شمولیتی، ثقافتی طور پر جواب دہ سیکھنے کے ماحول بنانے کی صلاحیت تاکہ غیر معمولی خصوصیات والے افراد کو با معنی سیکھنے کی سرگرمیوں اور سماجی تعاملات میں مصروف کیا جاسکے۔

• غیر معمولی خصوصیات والے افراد کو مختلف ماحولوں میں ڈھلنا سکھانے کے لیے حوصلہ افزا اور تدریسی مداخلتیں استعمال کرنے کی صلاحیت۔

• بحران میں غیر معمولی خصوصیات والے افراد کے ساتھ محفوظ اور مناسب انداز میں مداخلت کرنے کا علم۔

3. نصابی مواد کا علم

- پڑھائے جانے والے مواد کے شعبوں کے مرکزی تصورات، شعبے کی ساخت، اور تحقیق کے اوزار کو سمجھنے کی صلاحیت، اور اس علم کو منظم کرنا، بین شعبہ جاتی مہارتیں ضم کرنا، اور غیر معمولی خصوصیات والے افراد کے لیے بامعنی سیکھنے کی ترقی تیار کرنا۔
- نصابی مواد کے شعبوں میں پڑھانے کے لیے عمومی اور خصوصی مواد کے علم کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت تاکہ غیر معمولی خصوصیات والے افراد کی تعلیم کو انفرادی بنایا جاسکے۔
- غیر معمولی خصوصیات والے افراد کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے عمومی اور خصوصی نصاب میں ترمیم کرنے کی صلاحیت۔
- غیر معمولی خصوصیات والے سیکھنے والوں کے لیے لینگویج آرٹس / خواندگی کا علم، بشمول پڑھانا سکھانا، خواندگی کے جائزے اور مداخلت کا استعمال، ادب پڑھانا، مربوط لینگویج آرٹس پڑھانا وغیرہ۔
- غیر معمولی خصوصیات والے سیکھنے والوں کے لیے ریاضی کا علم، بشمول ریاضیاتی عمل، عددی سمجھ اور گنتی، الجبری تصورات، جیومیٹری اور پیمائش، ڈیٹا کی تنظیم اور انتظام وغیرہ۔
- غیر معمولی خصوصیات والے سیکھنے والوں کے لیے سائنس کا علم، مثلاً:
 - جسمانی، حیاتیاتی، اور زمین / خلائی سائنس کے بنیادی تصورات کو سمجھنا اور استعمال کرتا ہے
 - سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے کلیدی تصورات کو سمجھنا اور نمونہ بناتا ہے وغیرہ
- غیر معمولی خصوصیات والے سیکھنے والوں کے لیے سماجی سائنس کا علم، جس کا مقصد ایسے سیکھنے کے ماحول بنانا ہے جو سماجی تعامل، سیکھنے میں فعال مشغولیت، اور خود حوصلہ افزائی کی حوصلہ افزائی کریں۔
- ذہنی اور جذباتی صحت، خوراک، مشق، نشیات کی تعلیم، جنسیت، بیماریوں اور حفاظتی تصورات کا علم، جیسا کہ وہ زندگی کے معیار اور طوالت سے متعلق ہیں۔
- غیر معمولی خصوصیات والے سیکھنے والوں کے لیے جسمانی تعلیم کا علم۔

4. جائزہ

- تکنیکی طور پر درست رسمی اور غیر رسمی جائزے منتخب اور استعمال کرنے کی صلاحیت جو تعصب کو کم سے کم کریں۔

- میپائش کے اصولوں اور طریقوں کے علم کو استعمال کر کے جائزے کے نتائج کی تشریح کرنے اور غیر معمولی خصوصیات والے افراد کے لیے تعلیمی فیصلوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت۔
- ساتھیوں اور خاندانوں کے ساتھ تعاون میں، غیر معمولی خصوصیات والے افراد کے بارے میں فیصلے کرنے میں متعدد اقسام کی جائزے کی معلومات استعمال کرنے کی صلاحیت۔
- غیر معمولی خصوصیات والے افراد کو معیاری تعلیم اور کارکردگی کی طرف کام کرنے میں مصروف کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے رائے فراہم کرنے کی صلاحیت
- قانونی / قومی رہنما خطوط پر عمل کرنے کی صلاحیت۔

5. تدریسی منصوبہ بندی اور حکمت عملیاں

- غیر معمولی خصوصیات والے فرد کے لیے سیکھنے کے تجربات کے انتخاب، تیاری اور مطابقت میں فرد کی صلاحیتوں، دلچسپیوں، سیکھنے کے ماحول، اور ثقافتی اور لسانی عوامل پر غور کرنے کی صلاحیت۔
- غیر معمولی خصوصیات والے افراد کے لیے تدریسی جائزے، منصوبہ بندی اور فراہمی کی حمایت میں ٹیکنالوجیز استعمال کرنے کی صلاحیت۔
- غیر معمولی خصوصیات والے افراد کے رابطے اور سیکھنے کی حمایت کے لیے اضافی اور متبادل رابطے کے نظام اور مختلف امدادی ٹیکنالوجیز کا علم۔
- غیر معمولی خصوصیات والے افراد کی زبان کی نشوونما اور رابطے کی مہارتوں کو بڑھانے کے لیے حکمت عملیاں استعمال کرنے کی صلاحیت۔
- افراد، خاندانوں اور ٹیموں کے ساتھ تعاون میں، وسیع رینج کے ماحول اور مختلف سیکھنے کے تجربات میں غیر معمولی خصوصیات والے افراد کے لیے مختلف تعلیمی اور منتقلی کے منصوبے تیار اور نافذ کرنے کی صلاحیت۔
- مہارت تک پڑھانے اور سیکھنے کی عمومیت کو فروغ دینے کی صلاحیت۔
- غیر معمولی خصوصیات والے افراد کو بین شعبہ جاتی علم اور مہارتیں جیسے تنقیدی سوچ / مسئلہ حل کرنا سکھانے کی صلاحیت۔

6. پیشہ ورانہ تعلیم اور اخلاقی عمل

- تدریس کی رہنمائی کے لیے پیشہ ورانہ اخلاقی اصولوں اور پیشہ ورانہ عمل کے معیارات کا استعمال۔
- سمجھنا کہ بنیادی علم اور موجودہ مسائل پیشہ ورانہ عمل کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔

- سمجھنا کہ تنوع خاندانوں، ثقافتوں اور اسکولوں کا حصہ ہے، اور یہ کہ پیچیدہ انسانی مسائل خصوصی تعلیمی خدمات کی فراہمی کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں۔
- زندگی بھر سیکھنے کی اہمیت کو سمجھنا اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور سیکھنے کی کمیونیٹیوں میں حصہ لینا۔
- وکالت اور رہنمائی جیسی سرگرمیوں میں مصروف ہو کر پیشے کو آگے بڑھانا۔
- والدین، یوٹرز، رضاکاروں وغیرہ کو رہنمائی اور ہدایت فراہم کرنا۔

7. تعاون

- مؤثر تعاون کے نظریے اور عناصر کو استعمال کرنے کی صلاحیت۔
- ساتھیوں کے لیے تعاون پر مبنی وسائل کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت۔
- وسیع رینج کے ماحول اور تعاون کاروں میں غیر معمولی خصوصیات والے افراد کی بہبود کو فروغ دینے کے لیے تعاون کو استعمال کرنے کی صلاحیت۔

8.5 کلاس روم کی تنظیم و انتظام

کلاس روم کی تنظیم جسمانی ماحول پر توجہ دیتی ہے۔ مؤثر اساتذہ ایک محفوظ کلاس روم کا ماحول منظم کرتے ہیں۔ وہ طلبہ کی تعلیم کو بہتر بنانے اور توجہ ہٹانے والی چیزوں کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی سے فرنیچر، سیکھنے کے مراکز، اور مواد رکھتے ہیں۔

کلاس روم کا انتظام »وہ اقدامات اور حکمت عملیاں ہیں جو اساتذہ کلاس رومز میں نظم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں«۔ مؤثر اساتذہ اصول، طریقہ کار، اور معمولات بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ طلبہ سیکھنے میں فعال طور پر مصروف ہیں۔ جوہر ہیں، وہ انتظام کو طلبہ کے رویے کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے تعمیری انداز میں متاثر اور ہدایت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہدایات کا مرحلہ طے کیا جاسکے۔

کلاس روم کا ماحول اس کے آپریشن کے لیے قائم کردہ رہنما خطوط، اس کے استعمال کنندگان، اور اس کے جسمانی عناصر سے متاثر ہوتا ہے۔ اساتذہ کا درجہ حرارت اور رسنے والی چھتوں جیسے مسائل پر اکثر بہت کم کنٹرول ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کلاس رومز کے آپریشن پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ مؤثر اساتذہ کلاس روم کا ماہرانہ انتظام اور تنظیم کرتے ہیں اور اپنے طلبہ سے مثبت اور پیداواری انداز میں حصہ ڈالنے کی توقع رکھتے ہیں۔ کلاس روم کے ماحول پر احتیاط سے توجہ دینا عقلمندی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ طلبہ کی تعلیم پر اتنا ہی اثر ڈال

سکتا ہے جتنا طلبہ کی استعداد۔ مؤثر اساتذہ سال کے آغاز میں اور خاص طور پر اسکول کے پہلے دن کلاس روم کے انتظام، کلاس روم کی تنظیم، اور طلبہ کے رویے کی توقعات قائم کرنے میں وقت لیتے ہیں۔

8.5.1 کلاس روم کی تنظیم

کلاس روم کا انتظام اور تنظیم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اصول اور معمولات طلبہ کے رویے کو متاثر کرتے ہیں، کلاس روم کی تنظیم کلاس روم کے جسمانی عناصر کو متاثر کرتی ہے، اسے اپنے استعمال کنندگان کے لیے زیادہ پیداواری ماحول بناتی ہے۔ کلاس روم کا ماحول کیسے منظم کیا گیا ہے اس سے اس میں موجود رویہ متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، فولڈرز کو رنگ کوڈ کرنا، لیب کے سامان کے لیے مقررہ مقامات قائم کرنا، غیر حاضر رہنے کے بعد چھوٹ گیا کام اٹھانے کے لیے طلبہ کے لیے فولڈر رکھنا، نئے طلبہ کے ساتھ اشتراک کے لیے «Back to School Night» آئٹمز کی اضافی کاپیاں رکھنا، اور دیگر کلاس روم کے سامان کے لیے مخصوص جگہیں مقرر کرنا جیسے سادہ اقدامات کلاس روم کی تنظیم پر، اور نتیجتاً طلبہ کی تعلیم پر، نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ کار اور ان جیسے بے شمار طریقے سادہ معاملات ہیں، پھر بھی وہ ایک ہموار چلنے والے کلاس روم کے لیے ضروری اجزاء ہو سکتے ہیں۔

کلاس روم کی تنظیم ایک کمرے میں اس وقت بھی واضح ہوتی ہے جب کوئی موجود نہ ہو۔ فرنیچر کی ترتیب، مواد کی جگہ، نمائشیں، اور مقررہ عناصر سب تنظیم کا حصہ ہیں۔ مؤثر اساتذہ کمرے کو طلبہ کے کام سے سجاتے ہیں، وہ فرنیچر کو مناسب انداز میں تعامل کو فروغ دینے کے لیے ترتیب دیتے ہیں، اور ان کے پاس کام کرنے کے لیے آرام دہ علاقے ہوتے ہیں۔ وہ کمرے کی ترتیب میں طلبہ کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہیل چیئرز کے چلنے کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں؛ ایسے راستے بناتے ہیں تاکہ طلبہ دوسروں کو کم سے کم خلل دے کر مواد، پنسل شارپنر، اور کچرے دان تک رسائی حاصل کر سکیں؛ اور اس طرح منظم کرتے ہیں کہ استاد طلبہ کی ترقی کی نگرانی کے لیے کمرے میں آزادانہ گھوم سکے۔

اساتذہ رویے کے مشاہدہ کار ہوتے ہیں اور کلاس روم کی تال کو سمجھتے ہیں۔ پنسل شارپنر کے قریب مواد رکھنا اچھا خیال معلوم ہو سکتا ہے، جب تک کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ سبق کے آغاز میں یہ علاقہ کچھ طلبہ کے اپنے گروپ کے لیے مواد حاصل کرنے اور دوسروں کے پنسل شارپنر استعمال کرنے کے انتظار سے بھیڑا ہو سکتا ہے۔ تاہم، پنسل شارپنر اور کچرے دان ایک اچھی جوڑی ہو سکتے ہیں اگر پنسل شارپنر باقاعدگی سے ٹوٹتا ہے، اپنا مواد فرش پر گراتا ہے؛ اس طرح چھیلن کچرے دان میں گرتی ہیں۔ مؤثر اساتذہ ان چھوٹی تفصیلات کے بارے میں سوچتے ہیں جو کلاس روم میں دستیاب جگہ کے استعمال کو بہتر بناتی ہیں، ساتھ ہی بڑے مسائل کے بارے میں بھی۔

ذیل میں چند تنظیمی نکات کی فہرست ہے جن کے بارے میں ایک مؤثر استاد سوچ سکتا ہے۔

مواد

- اگر طلبہ عام طور پر ایک ہی گروپ میں کام کرتے ہیں، تو ہر گروپ کو ایک کنٹینر دیں (ڈش ب، ٹوکریاں، اور ٹرے اچھی طرح کام کرتے ہیں) جسے وہ ہر سرگرمی کے لیے ایک رکن بھیج کر لائے اور واپس کر سکیں۔ اس سے طلبہ کو عام سامان کا اچھا خیال رکھنے کی ترغیب ملتی ہے۔
- قینچی، ٹیپ، اسٹیپلر، ہول پنچ، کیلکولیٹر، رولر، اور دیگر عام طور پر درکار اشیاء ایک عام جگہ پر رکھیں جہاں طلبہ خود رسائی حاصل کر سکیں۔
- پنسل شارپنر کے قریب تیز کی گئی پنسلوں کا ایک ڈبہ رکھیں۔ اگر کلاس کے دوران لیڈ ٹوٹ جائے، تو طالب علم پنسل ڈبے میں رکھ سکتا ہے اور ایک تیز پنسل لے سکتا ہے۔ زیادہ مناسب وقت پر (مثلاً سبق کے اختتام پر) طالب علم ادھار لی گئی پنسل واپس کر سکتا ہے اور جو چھوڑی تھی اسے تیز کر سکتا ہے۔ اشارہ: استاد کو ابتدائی پنسلیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، کیونکہ پنسلیں اکثر فرش پر مل جاتی ہیں جب وہ کسی دوسرے ڈیسک کے نیچے لٹھک جاتی ہیں۔ بس اپنے چوکیدار کو بتائیں کہ ملنے والی پنسلیں طلبہ کے استعمال کے لیے کہاں رکھی جا سکتی ہیں۔
- ان طلبہ کے لیے اضافی اسکول کا سامان ہاتھ پر رکھیں جو بھول جاتے ہیں یا جن کا اپنا ختم ہو جاتا ہے۔ نیز، یہ اس وقت مددگار ہوتا ہے جب کلاس میں کوئی نیا طالب علم آئے جس کے پاس تمام ضروری سامان نہ ہو۔
- ضروری سامان کے ساتھ نمبر والے ورک اسٹیشن قائم کریں اور طلبہ کو مماثل ورک گروپس میں تفویض کریں۔ یہ اس وقت اچھی طرح کام کرتا ہے جب طلبہ کو سامان اپنے ڈیسک پر لانے کے بجائے سامان کے پاس جانا پڑے (مثلاً سائنس لیب)۔

کلاس روم کی نمائشیں

- «جاری کام» کے لیے ایک بورڈ رکھیں جہاں طلبہ وہ کام لگا سکیں جس پر وہ اپنے ہم عمروں سے تعمیری تنقید چاہتے ہیں۔ طلبہ اس بورڈ کو ہمیشہ بدلتا ہوا رکھتے ہیں۔
- دیواروں پر نمائش کے لیے طلبہ کے بنائے ہوئے اور کمرشل مصنوعات کا امتزاج استعمال کریں۔ ایک آرٹ پورٹ فولیو پوسٹرز کو چٹا رکھنے کے لیے اچھا کام کرتا ہے اور پوسٹر بورڈ کو مختلف یونٹس کے عنوانات کے ساتھ ٹیب کیا جا سکتا ہے، تاکہ استاد نمائش کے لیے مناسب نیا مواد نکال سکے۔

کام کی تفویض

- مکمل شدہ کام کے لیے کلیکشن ٹرے قائم کریں جن پر ابتدائی کلاس رومز کے لیے مضمون یا ثانوی کلاس رومز کے لیے پیریڈ کا لیبل لگایا گیا ہو۔
- کلاس اسائنمنٹس کے لیے شناخت شدہ ڈبوں کے ساتھ وال آرگنائزر بنائیں تاکہ طلبہ دیر سے آنے یا غیر حاضری کے بعد چھوٹ گیا کام اٹھا سکیں۔

سبق کا منصوبہ

- ثانوی سطح پر جب مختصر وقفوں سے الگ متعدد تیاریاں ہوں، تو دیوار پر لگا پلاسٹک فائل فولڈر ہو لڈر مددگار ہو سکتا ہے تاکہ استاد ضروری فولڈر نکال سکے۔
- منصوبے ایک ہانڈر میں رکھیں جس میں مختلف مضامین پیریڈز کے لیے ڈیوائڈر صفحات ہوں۔ ہینڈ آؤٹس اور ٹرانسپیرینسیز کی کاپیاں رکھنے کے لیے پلاسٹک پیج پروٹیکٹر استعمال کریں (اس بات کو یقینی بنائیں کہ «کرسل کلیر» آستینیں ہوں ورنہ ٹرانسپیرینسی کو آستین سے نکالنا پڑے گا)۔
- سبق کے منصوبوں کو الیکٹرانک طور پر منظم کریں۔ اگر کمرہ PowerPoint پرزنٹیشنز کے لیے مانیٹر سے لیس ہے، تو پہلی سلائیڈ عنوان کی نشاندہی کے لیے اور دوسری سلائیڈ اہداف کے لیے استعمال کریں؛ اس سے نہ صرف طلبہ منظم ہوتے ہیں بلکہ استاد کو بھی یاد رہتا ہے۔

ہنگامی طریقہ کار

- کمرے میں آگ اور ٹورنیڈو کی معلومات لگائیں۔ ٹورنیڈو اور فائر ڈرلز/ہنگامی صورتحال کے لیے کلاس روم سے نکلنے وقت کہاں جانا ہے اس کے لیبل والے نقشے شامل کریں۔
- قریب ترین فائر ایکسٹنگوئشر اور فائر الارم پل کی جگہ جانیں۔
- طلبہ کو تربیت دیں کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔
- آفس کال بٹن کو واضح طور پر لیبل کریں تاکہ متبادل اساتذہ ہنگامی صورتحال میں اسے فوری شناخت کر سکیں۔
- اپنے گریڈ بک میں ان تمام طلبہ کی فہرست رکھیں جنہیں طبی توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- جانیں کہ کیا کرنا ہے، مثال کے طور پر ذیابیطس، مکھی کے ڈنک، مرگی کے دورے وغیرہ۔ مناسب طور پر، متبادل اساتذہ کو خبردار کریں۔

• اگر مخصوص استعمال کے کلاس روم میں ہیں، جیسے سائنس، تو جانیں کہ آئی واش اسٹیشن اور شاؤر کیسے چلانا ہے، کمرے میں ہنگامی شٹ آف والوز کہاں ہیں، اور حفاظتی سامان کہاں رکھا گیا ہے۔

شیڈول

- دن کے بنیادی بہاؤ کے ساتھ ایک پوسٹر دکھائیں (مثلاً ثانوی اسکول میں گھنٹی کی تبدیلیاں یا ابتدائی اسکول میں جب پڑھنا، ریاضی، ریسورس کلاسیں، لہجہ، سائنس، سماجی علوم وغیرہ ہوتے ہیں)۔
- طلبہ کے لیے روزانہ کا ایجنڈا لکھیں تاکہ وہ دن کے مقصد، سرگرمیوں اور ہوم ورک کے حوالے سے کیا توقع رکھنی ہے جان سکیں۔ اسی جگہ باقاعدہ روزانہ شیڈول میں کسی تبدیلی کو نوٹ کریں۔
- ہفتہ وار اسائنمنٹس کی فہرست اور ممکنہ وسائل کے ہائپر لنکس کے ساتھ ایک ویب پیج بنائیں۔

سرگرمی 1 (Activity 1)

کلاس روم کی ترتیب کے بارے میں غور و فکر کے ممکنہ پہلوؤں میں گہری بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہدایات کے مطابق نیچے دی گئی جدولیں بھریں:

1. کلاس روم میں حرکت پذیر فرنیچر / اشیاء کی فہرست بنائیں۔ اضافی اشیاء کے لیے جگہ فراہم کی گئی ہے۔

○ طلبہ کے ڈیسک کرسیوں سمیت

○ استاد کا ڈیسک کرسی سمیت

○ اوور ہیڈ پروجیکٹر

○ کمپیوٹر (ز)

○ فائل کیبنٹ

○ ورک ٹیبل (ز)

○ کتابوں کی الماریاں

2. فراہم کردہ جگہ میں کلاس روم کے مقررہ عناصر کا خاکہ بنائیں۔ اگر کمرہ مستطیل نہیں ہے، تو کلاس روم کی جگہ کی عکاسی کے لیے علاقوں کو سایہ دار کریں۔ اپنے خاکے میں شامل کریں:

◦ دروازے

◦ کھڑکیاں

◦ چاک بورڈز / واٹ بورڈز

◦ نصب شدہ ٹی وی مانیٹرز

◦ کمپیوٹر اسٹیشنز

◦ کتابوں کی الماریاں

◦ اسٹوریج کینٹنس

◦ لیب اسٹیشنز

◦ سنکس

◦ پنسل شارپنر

3. طے کریں کہ کمرہ بنیادی طور پر کیسے استعمال ہوگا (مثلاً لیکچر، بحث، گروپ کام)۔

4. اہم راستوں یا ان جگہوں کو دکھانے کے لیے نقطے دار لائنیں استعمال کریں جو کھلی رہنی چاہئیں۔

5. فرنیچر کا سب سے بڑا گروپ طلبہ کے ڈیسک اور کرسیاں ہیں۔ انھیں لے آؤٹ پر پہلے رکھیں۔ انھیں ضرورت کے مطابق ڈایا گرام پر بعد میں منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر کلاس رومز میں سب سے بڑا علاقہ گھیرتے ہیں۔

6. دیگر فرنیچر اشیاء کا خاکہ بنائیں۔

8.5.2 کلاس روم کا انتظام

مؤثر اساتذہ مرکوز اور پرورش کرنے والے کلاس روم بناتے ہیں جن کے نتیجے میں طلبہ کی تعلیم بڑھتی ہے۔ یہ اساتذہ طلبہ کے ساتھ اصول اور طریقہ کار پڑھاتے اور ان کی مشق کراتے ہیں، طلبہ کی ضروریات کا اندازہ لگاتے ہیں، نئے طلبہ کو واقف کرانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، اور طلبہ کو واضح ہدایات دیتے ہیں۔ وہ کلاس روم میں حفاظت اور پیداواری تعامل کو یقینی بنانے کے لیے کم سے کم اصول استعمال کرتے ہیں، اور ہموار چلنے والے کلاس روم کو برقرار رکھنے کے لیے معمولات پر انحصار کرتے ہیں۔ درحقیقت، یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ کلاس روم انتظامی مہارتیں استاد کے لیے کلاس روم میں کچھ بھی کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ بعض پہلوؤں

میں، کلاس روم کا انتظام ترکیب میں نمک کی طرح ہے؛ جب یہ موجود ہو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ غائب ہو تو کھانے والے اسے مانگیں گے۔

اصول

عملی طور پر ہر وہ چیز جس میں لوگوں کے درمیان تعامل شامل ہو، اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ Webster's dictionary اصول کی تعریف «ایک مقررہ اصول جو رویہ کا تعین کرتا ہے» کے طور پر کرتی ہے۔ تاہم، اصول رویے کے لیے حدود قائم کرتے ہیں، اور ان کے نفاذ میں مستقل مزاجی مؤثر کلاس روم انتظام کے لیے ضروری ہے۔ مؤثر اساتذہ کے پاس کم سے کم کلاس روم اصول ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، محفوظ ماحول برقرار رکھنا ہے، اور سیکھنے میں حصہ لینا ہے کی توقعات پر مرکوز ہوتے ہیں۔ یہ اساتذہ اصولوں کی واضح وضاحت دیتے ہیں، اصولوں کا نمونہ پیش کرتے ہیں، طلبہ کے ساتھ توقعات کی مشق کراتے ہیں، اور طلبہ کو توقعات پر پورا اترنے میں کامیاب ہونے کے مواقع دیتے ہیں۔ کلاس روم کو چلانے والے اصولوں کی کوئی جادوئی تعداد نہیں ہے؛ بلکہ منصفانہ، معقول، قابل نفاذ، اور مستقل طور پر لاگو کردہ اصولوں کا واضح قیام کلاس رومز میں فرق ڈالتا ہے۔ ایسے چار معیار ہیں جو کسی اصول کو فہرست میں رہنے کے لیے پورا کرنے ضروری ہیں۔ اصول درج ذیل تمام کا حامل ہونا چاہیے:

1. واضح طور پر بیان کردہ تاکہ طلبہ جانیں کہ ان سے کیا توقع ہے۔
2. معقول تاکہ طلبہ حقیقت میں اس پر عمل کر سکیں۔
3. قابل نفاذ اس طرح کہ Mandrel کسی بھی خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے وقت اور محنت لگائے گا۔ اگر وہ محنت کرنے کو تیار نہیں، تو آئٹم بہت معمولی ہو سکتا ہے یا کوئی بہتر حل ہو سکتا ہے۔
4. عمومی تاکہ اصول ایک مخصوص بدکرداری کے بجائے کئی رویوں کو مخاطب کرے۔

مؤثر اساتذہ کو کلاس روم کی تال اور طلبہ کی ہم آہنگی کا احساس ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ جانتے ہیں کہ مسئلہ روکنے کے لیے مداخلت کب درکار ہو سکتی ہے۔ اکثر، اساتذہ مسئلے کو روکنے کے لیے غیر زبانی اشارے، قربت، اور دوبارہ ہدایت استعمال کرتے ہیں۔ یہ تکنیکیں عموماً ہدایات کی رفتار کو جاری رکھنے اور طالب علم کو دوبارہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتی ہیں؛ تاہم، ایسے اوقات ہوتے ہیں جب مضبوط مداخلت ضروری ہوتی ہے۔ جب کوئی اصول ٹوٹتا ہے، تو ایک مؤثر استاد مسئلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مؤثر اساتذہ کئی طریقوں سے رد عمل دیتے ہیں، بشمول درج ذیل: مثبت تقویت جو مطلوبہ رویے کی طرف اشارہ کرے، نتائج جو منفی رویے کو سزا دیں، تقویت اور نتائج کا امتزاج، یا رویے کا بالواسطہ جواب اس طرح کہ طالب علم کو یاد دلایا جائے کہ اصول کیوں اہم ہے۔ ایک مؤثر استاد جو کام نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کی اصول کی خلاف ورزی پر پوری کلاس سے رد عمل ظاہر کرے۔

سرگرمی 2 (Activity 2)

آپ اپنی کلاس میں عام طور پر جن اصولوں کو نافذ کرتے ہیں ان کی فہرست لکھیں اور درج ذیل جدول کی مدد سے ان کی موثریت کا تجزیہ کریں۔

کلاس روم اصولوں کے معیار

مجازہ اصول	واضح طور پر بیان کردہ	معقول	قابل نفاذ	عمومی	ثبت انداز میں بیان کردہ

معمولات

اگرچہ وہ اصولوں سے زیادہ لچکدار ہیں، معمولات یا طریقہ کار چیزیں کرنے کے مخصوص طریقے ہیں جو، زیادہ تر حصے میں، دن یا سال کے دوران بہت کم تبدیل ہوتے ہیں۔ کلاس روم کو مؤثر اور مؤثر طریقے سے چلنے کے لیے عموماً بہت سے معمولات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، معمولات میں عام طور پر شامل ہیں کہ کلاس روم میں کیسے داخل اور خارج ہونا ہے، حاضری کیسے لینی ہے، لہجہ کا انتخاب کیسے ظاہر کرنا ہے، مواد کیسے محفوظ کرنا ہے، کچر کیسے ٹھکانے لگانا ہے، کام پر لیبل کیسے لگانا ہے، اسائنمنٹس کیسے جمع کرانی ہیں، تدریسی سرگرمیوں کے دوران یا درمیان منتقلی کیسے کرنی ہے، ڈرلز اور اصل ہنگامی صورتحال کے دوران حفاظت تک کیسے پہنچنا ہے، اور ایک سرگرمی یا مقام سے دوسرے میں کیسے تبدیل ہونا ہے۔ جوہر میں، معمولات کلاس روم کے ماحول کو شکل دیتے ہیں۔

مؤثر اساتذہ روزانہ کے کاموں کے لیے معمولات کا استعمال اپنے غیر مؤثر ہم منصبوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ اسکول کے سال کے آغاز میں معمولات سکھانے میں وقت لگاتے ہیں۔ ایسے معمولات قائم اور مشق کر کے جنہیں بہت کم نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اساتذہ یقینی بناتے ہیں کہ کلاس روم کی توجہ زیادہ مربع طور پر ہدایات پر ہو۔ مؤثر اساتذہ اکثر طلبہ کو قابل قبول رویے کی یاد دہانی کے لیے اشارے فراہم کرتے ہیں، اور مؤثر اساتذہ مثبت کلاس روم ماحول کو منظم اور برقرار رکھنے میں اچھے ہوتے ہیں۔ درج ذیل عام طور پر واقع ہونے والے مظاہر کی ایک چھوٹی فہرست ہے جن کے بارے میں ایک مؤثر استاد ہمیشہ پہلے سے منصوبہ بندی اور تیاری کرتا ہے۔

عام کلاس روم واقعات

حاضری	صبح کا کام
-------	------------

لنچ کی گنتی	چھوٹا ہوا کام
کام جمع کرنا	دوپہر کی رخصتی
کام واپس کرنا	طلبہ کو بٹھانا
سامان تقسیم کرنا	سرگرمیاں تبدیل کرنا
سامان واپس کرنا	جب آپ اپنا کام ختم کر لیں تو کیا کرنا ہے
خصوصی کلاسوں کی طرف چلنا (PE، آرٹ، موسیقی، لائبریری، کمپیوٹرز)	ڈرلز: آگ، ٹورنیڈو، لاک ڈاؤن

معمولات کا قیام لچک کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، استاد طلبہ کے ساتھ یہ مشق نہ کرے کہ اگر کوئی نیا طالب علم کلاس میں شامل ہو تو کیا ہونا چاہیے، لیکن کلاس روم کے مہمانوں کے استقبال کے لیے استعمال ہونے والے معمول کو اپنا سکتا ہے۔ مزید برآں، معمولات طلبہ کو کلاس روم میں اپنے رویے اور سیکھنے کے لیے زیادہ ذمہ دار بننے کی طاقت دیتے ہیں۔ جب کلاس روم انتظامی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو استاد کے پاس موثر، منصفانہ اور مستقل انداز میں تشویش سے نمٹنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اس طرح، قائم شدہ طریقہ کار کا نتیجہ پڑھانے اور سیکھنے کے لیے زیادہ وقت ہے۔

سرگرمی 3 (Activity 3)

قریب کے کسی خصوصی اسکول کے تدریس و تعلم کے ماحول کا مشاہدہ کریں اور درج ذیل اشاریوں کی مدد سے انتظامی مہارتوں کا جائزہ لیں۔ ہر آئٹم کے سامنے «ہاں» یا «نہیں» لکھیں۔

اشاریے	ہاں / نہیں
1. کلاس روم کے داخلے اور اخراج کے دروازے الگ ہیں	
2. سیکھنے کے لیے کم از کم 35 منٹ مختص کیے گئے ہیں (40 منٹ میں سے)	
3. کلاس روم میں ہر سرگرمی پر صرف ہونے والا وقت سب کے لیے برابر ہے۔	
4. تدریس و تعلم کے عمل کے وسائل اچھی طرح استعمال ہوتے ہیں۔	
5. سیکھنے کی سرگرمیوں / عمل میں شاگردوں کی اچھی شمولیت ہے	
6. سبق کی منصوبہ بندی پر کافی وقت صرف ہوتا ہے۔	
7. خصوصی صلاحیتوں والے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔	
8. استاد نے شاگردوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے وقت مختص کیا ہے۔	

9.	طلبہ کی تعلیم کا جائزہ لینے کا انتظام کیا گیا ہے۔
10.	تمام سرگرمیوں کے لیے وقت مختص کیا گیا ہے۔
11.	پورے سبق میں طلبہ کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے سرگرمیاں منصوبہ بندی کی گئی ہیں۔
12.	طلبہ کے متوقع نتائج کی کارکردگی کو واضح اور بیان کرنے کا انتظام ہے۔
13.	کلاس کے تمام بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیاں منصوبہ بندی کی گئی ہیں۔
14.	سیکھنے اور کارکردگی میں طلبہ کے فوائد اور دشواریوں کی نشاندہی کا انتظام کیا گیا ہے۔
15.	طلبہ کی ترقی کے جائزے کا تجزیہ کرنے کے لیے مختلف تکنیکیں منصوبہ بندی کی گئی ہیں۔
16.	تدریس و تعلم اور استعمال شدہ مواد کی موثریت کا جائزہ لینے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
17.	فالو اپ سرگرمیوں اور دیگر متعلقہ امور کے لیے کافی انتظام ہے۔
18.	عمل کے دوران جدتوں کے بعد تبدیلی کے لیے منصوبہ لچکدار ہے۔
19.	عمل کے دوران مسلسل جائزے اور رائے کا انتظام ہے۔
20.	منصوبہ مناسب اقدامات سے کسی بھی بے نظمی سے نمٹنے کی اجازت دیتا ہے۔

8.6 منتقلی اور پیشہ ورانہ بحالی کی خدمات

منتقلی کے منصوبہ بندی پروگراموں کا مقصد خصوصی تعلیمی طلبہ کو معاشرے کے ایک معاون رکن کے طور پر تیار کرنا ہے۔ منتقلی کی خدمات کا مطلب معذوری والے طالب علم کے لیے سرگرمیوں کا ایک مربوط مجموعہ ہے، جو نتائج پر مبنی عمل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جو اسکول سے اسکول کے بعد کی سرگرمیوں کی طرف نقل و حرکت کو فروغ دیتا ہے، بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں، پوسٹ سیکنڈری تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، مربوط مسابقتی روزگار (بشمول حمایت یافتہ روزگار)، مسلسل اور بالغ تعلیم، بالغ خدمات، خود مختار زندگی، یا کمیونٹی کی شرکت۔ سرگرمیوں کا مربوط مجموعہ انفرادی طالب علم کی ضروریات پر مبنی ہونا چاہیے، طالب علم کی ترجیحات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ منتقلی کی خدمات انفرادی بنیاد پر تعلیمی، پیشہ ورانہ، اور کام کے تجربے کے پروگراموں میں ضم کی جاتی ہیں۔

پیشہ ورانہ بحالی کا پروگرام کوئی بھی ضروری مدد اور تربیت فراہم کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ معذوری والے افراد بمعنی روزگار حاصل اور برقرار رکھ سکیں۔ پیشہ ورانہ بحالی کی خدمات عموماً منتقلی کے عمل کے حصے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، اگرچہ وہ دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ پیشہ ورانہ بحالی معذوری والے لوگوں کو کیریئر کے اہداف پورے کرنے میں مدد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، ابتدائی سطح سے لے کر پیشہ ورانہ

سطح تک۔ یہ معذوری والے لوگوں کو نوکریاں دلانے میں مدد کرتی ہے، چاہے وہ شخص معذوری کے ساتھ پیدا ہوا ہو، معذوری پیدا ہوئی ہو یا کام کرتے ہوئے معذوری والا شخص بنا ہو۔
منتقلی اور پیشہ ورانہ بحالی کی خدمات میں درج ذیل شعبوں میں سرگرمیاں شامل ہوں گی:

1. ہدایات

2. متعلقہ خدمات

3. کمیونٹی کے تجربات

4. روزگار اور اسکول کے بعد بالغ زندگی کے دیگر مقاصد کی ترقی

5. روزمرہ زندگی کی مہارتوں کا حصول (جب مناسب ہو)

6. فعال پیشہ ورانہ جائزہ

معذوری والے ہر طالب علم کے لیے Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) کے تحت تیار کردہ انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) میں منتقلی کی خدمات کے تقاضوں کو مخاطب کرنا چاہیے اور اس میں شامل ہے:

1. تربیت، تعلیم، روزگار، اور جہاں مناسب ہو، خود مختار زندگی کی مہارتوں سے متعلق عمر کے مناسب منتقلی کے جائزوں کی بنیاد پر مناسب قابل پیمائش پوسٹ سیکنڈری اہداف؛ اور

2. ان اہداف تک پہنچنے میں معذوری والے طالب علم کی مدد کے لیے درکار منتقلی کی خدمات (بشمول مطالعے کے کورسز)۔

3. طالب علم کی انفرادی ضروریات کی بنیاد پر عمر کے مناسب منتقلی کے جائزے جو مناسب قابل پیمائش پوسٹ سیکنڈری اہداف کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوں۔

اسکول کے بعد کی سرگرمیوں کے لیے درکار پوسٹ سیکنڈری تعلیم اور تربیتی خدمات سے متعلق پوسٹ سیکنڈری اہداف کا تعین کرنے میں والدین اور طالب علم کی رائے بھی نہایت اہم ہے، بشمول خود مختار زندگی اور روزگار۔ معذوری والے طلبہ اور ان کے والدین کو منتقلی کی خدمات کی رینج اور مقامی سطح پر ان خدمات تک رسائی کے طریقے کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اسکول کو طالب علم اور ان کے والدین دونوں کو دیگر خدمات کی ضرورت اور دستیابی کے بارے میں بات چیت میں مکمل طور پر مصروف ہونے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بشمول پیشہ ورانہ بحالی کی خدمات اور مدد کے لیے درخواست اور اہلیت، تاکہ مناسب طور پر ایجنسیوں اور بالغ خدمات کے ساتھ رسمی رابطے یقینی بنائے جاسکیں۔

»پری ایمپلائمنٹ منتقلی کی خدمات« ملازمت کی تلاش میں ابتدائی آغاز کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور معذوری والے طلبہ کو ان کی کیریئر کی دلچسپیوں کی نشاندہی میں مدد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ ان خدمات میں شامل ہیں:

- ملازمت کی تلاش کی کونسلنگ؛
- کام پر مبنی سیکھنے کے تجربات، جن میں اسکول کے اندر یا اسکول کے بعد کے موقع، یا روایتی اسکول کے ماحول سے باہر تجربہ (بشمول انٹرن شپ) شامل ہو سکتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ حد تک مربوط ماحول میں فراہم کیے جائیں؛
- اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جامع منتقلی یا پوسٹ سیکنڈری تعلیمی پروگراموں میں داخلے کے مواقع پر کونسلنگ؛
- کام کی جگہ کی تیاری کی تربیت تاکہ سماجی مہارتیں اور خود مختار زندگی پروان چڑھیں؛ اور
- خود وکالت میں ہدایات۔

طالب علم یا نوجوان کی انفرادی ضروریات کے لحاظ سے پیشہ ورانہ بحالی کی خدمات میں شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں:

- اہل عملے کے ذریعے اہلیت اور VR ضروریات کا تعین کرنے کے لیے جائزہ، بشمول، اگر مناسب ہو، بحالی ٹیکنالوجی میں ماہر عملے کے ذریعے جائزہ؛
- کونسلنگ اور رہنمائی، بشمول معلوماتی اور معاون خدمات تاکہ فرد کو باخبر انتخاب کرنے میں مدد ملے۔
- دیگر ایجنسیوں سے درکار خدمات حاصل کرنے کے لیے ریفرل اور دیگر خدمات
- ملازمت سے متعلق خدمات، بشمول ملازمت کی تلاش اور پلیسمنٹ میں مدد، ملازمت برقرار رکھنے کی خدمات، فالو اپ خدمات، اور فالو الونگ خدمات؛
- معذوری والے طلبہ کے لیے منتقلی کی خدمات، جو IPE میں شناخت شدہ روزگار کے نتیجے کے حصول میں سہولت فراہم کرتی ہیں؛
- سب سے اہم معذوریوں والے افراد کے لیے حمایت یافتہ روزگار کی خدمات؛ اور
- معذوری والے فرد کے خاندان کے لیے خدمات جو فرد کو روزگار کا نتیجہ حاصل کرنے میں مدد کے لیے ضروری ہیں۔

پیشہ ورانہ بحالی کی ایجنسیاں کیس بہ کیس کی بنیاد پر معذوری والے طلبہ اور نوجوانوں کو کمیونٹی پر مبنی کام کے تجربات اور ملازمت پر تربیت کی مختلف خدمات فراہم کرتی ہیں۔ پیشہ ورانہ بحالی کا کونسلر اور معذوری والا

طالب علم یا نوجوان ایک مخصوص پیشہ ورانہ ہدف کی نشاندہی کرے گا تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ آیا کمیونٹی پر مبنی کام کا تجربہ طالب علم یا معذوری والے نوجوان کے لیے مسابقتی مربوط روزگار یا حمایت یافتہ روزگار میں روزگار کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری سروس ہے۔ «مسابقتی مربوط روزگار» وہ روزگار ہے جس میں غیر معذور افراد کو ادا کی جانے والی اجرت کے برابر آمدنی ہو، ایسے ماحول میں جو انہیں غیر معذور افراد کے ساتھ تعامل کی اجازت دے۔ «حمایت یافتہ روزگار» مسابقتی مربوط روزگار یا مربوط کام کے ماحول میں روزگار ہے جس میں سب سے اہم معذوریوں والے افراد قلیل مدتی بنیاد پر مسابقتی مربوط روزگار کی طرف کام کر رہے ہیں، جبکہ ان افراد کو روزگار میں مدد اور برقرار رکھنے کے لیے مسلسل معاون خدمات حاصل کر رہے ہیں۔

کمیونٹی پر مبنی کام کے تجربات معذوری والے طالب علم یا نوجوان کو مخصوص پیشہ ورانہ ہدف سے متعلق ممکنہ کیریئر، ممکنہ کام کی جگہ کے ماحول اور تقاضوں، اور کام کے دیگر پہلوؤں کو تلاش کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ تجربات طالب علم کو کسی خاص ملازمت کی مہارت کا پہلے ہاتھ کا علم حاصل کرنے، یا روزمرہ روزگار کی ثقافت سیکھنے کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ تجربات پیشہ ورانہ تربیت یا تعلیمی پروگراموں کی جگہ یا ان کی تکمیل کے طور پر، یا ایک خود مختار سروس کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔ کمیونٹی پر مبنی کام کے تجربات کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے، پیشہ ورانہ بحالی کی ایجنسیوں کے عام طور پر آجروں اور معذوری والے طالب علم یا نوجوان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں جو تربیتی مقاصد، فراہم کی جانے والی خدمات، ٹائم لائنز، اور کامیاب کمیونٹی پر مبنی کام کے تجربے کے لیے ضروری مالی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ہم یہ کہہ کر اختتام کرتے ہیں کہ پوسٹ سیکنڈری تعلیم اسکول کے بعد کے سب سے اہم اہداف میں سے ایک ہے؛ اور تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ یہ معذوری والے بیشتر طلبہ کا بنیادی ہدف ہے۔ چونکہ معذوری والے طلبہ سیکنڈری اسکول سے پوسٹ سیکنڈری تعلیم، تربیت اور روزگار کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس لیے یہ نہایت اہم ہے کہ وہ تعلیمی اور مالی طور پر تیار ہوں۔ پیشہ ورانہ بحالی کے پروگرام کی مدد سے، پوسٹ سیکنڈری آپشنز میں دو اور چار سالہ کالجز اور یونیورسٹیاں، ٹریڈ اور پیشہ ورانہ اسکول، بلوغت تعلیمی پروگرام، اور مسابقتی مربوط روزگار یا حمایت یافتہ روزگار میں روزگار کے نتائج شامل ہیں۔

8.7 خود احتسابی سوالات

1. خصوصی تعلیمی ضروریات کی تعریف کریں۔ طلبہ کی ایسی ضروریات پوری کرنے کے لیے اساتذہ کے پاس کون سے مختلف آپشنز دستیاب ہیں؟
2. مناسب مثالوں کی مدد سے اسکول کی تنظیم اور انتظام کے تصور کی وضاحت کریں۔
3. کلاس روم کا انتظام تدریس و تعلم کے عمل کو کیسے سہولت فراہم کر سکتا ہے؟

4. خصوصی ضروریات والے ہر فرد کی ضروریات کے مطابق کون سے مختلف پلیسمنٹ آپشنز دستیاب ہیں؟
5. سفر کرنے والا استاد خصوصی اسکولوں میں تربیت یافتہ پیشہ ور افراد کی کمی کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟
6. عام اسکولوں کے مقابلے میں خصوصی اسکولوں میں ہدایات، تدریس اور جائزے کی منصوبہ بندی کیسے مختلف ہو سکتی ہے؟
7. خصوصی تعلیم کا مشیر خصوصی ضروریات والے بچوں کو مختلف معاون خدمات کی فراہمی کی ہدایت کے لیے کون سی خصوصیات رکھتا ہے؟
8. نصابی منصوبہ بندی، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کی تنظیم کے اصول وقت کے انتظام کے تصور سے کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟
9. استاد کی جانب سے کلاس روم انتظام کی مختلف تکنیکوں کے ہنرمند استعمال کا آپ کیسے جائزہ لیں گے؟
10. خصوصی تعلیم کے انتظام کی روشنی میں اساتذہ کے کردار اور ذمہ داریوں کی وضاحت کریں۔
11. خصوصی ضروریات والے بچوں کو منتقلی کی خدمات کیسے منصوبہ بندی اور فراہم کی جاتی ہیں؟
12. مناسب مثالوں کی مدد سے «پیشہ ورانہ بحالی» کی اصطلاح سے وابستہ مختلف تصورات کی وضاحت کریں۔

یونٹ 9: خصوصی تعلیم میں موجودہ رجحانات اور مسائل

تعارف

خصوصی تعلیم کا بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ معذور افراد (PWDs) کو معاشرے میں خود مختار اور پُر اعتماد فرد بنائے۔ ایک خصوصی فرد کو پیدائش سے لے کر اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بچے کے والدین اور بچے سے متعلق تمام افراد بچے کی خاطر اس چیلنج کو قبول کر لیں اور اس کا سامنا کریں تو وہ اسے خود کفیل فرد بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں بہت سے عوامل شامل ہو سکتے ہیں۔

بچے کا صحیح جائزہ (Assessment) کامیابی کی کنجی ہے۔ جب جائزہ درست ہو جائے تو والدین کے پاس اپنے بچے کے لیے واضح سمت اور منصوبہ ہوتا ہے۔ خصوصی تعلیم معذور افراد کو ان کی بنیادی ضروریات کے بارے میں آگاہ ہونے کے مواقع فراہم کرتی ہے اور یہ سکھاتی ہے کہ وہ کس طرح ہمارے معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے خاندان اور قوم کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد طالب علم مندرجہ ذیل نکات کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا:

1. شناخت، تشخیص، جائزے اور تقرری کے درمیان فرق کرنا
2. علیحدگی (Segregation)، انضمام (Integration) اور شمولیتی تعلیم (Inclusive Education) کے درمیان امتیاز کرنا
3. خصوصی تعلیم اور عام تعلیم کے درمیان فرق پہچاننا
4. خصوصی اور عام نصاب کے درمیان تفریق کرنا
5. نصاب میں مطابقت (Adaptation) کے درمیان فرق واضح کرنا
6. انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) کا کردار

9.1 شناخت، تشخیص، جائزے اور تقرری میں مسائل

معذوری کی شناخت معذور افراد کی بحالی کا بنیادی عنصر ہے۔ اگر معذوری کی سطح ابتدائی طور پر تشخیص ہو جائے تو خصوصی ضرورتوں والے بچوں کے لیے بحالی کے عمل کو بہتر بنانا اور اس سے نمٹنا آسان ہو جاتا

ہے۔ معذوری کی سطح کے بارے میں درست جائزہ بچے کی صحیح سمت میں تقرری کی سمت متعین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کی شناخت یا تشخیص بصارت سے محروم بچے کے طور پر ہو جائے تو اسے بصارت سے محروم بچوں کے خصوصی سکول بھیجا جاسکتا ہے۔ مزید برآں اسے سکول میں سیکھنے کے عمل کے لیے بریل، بڑے حروف والی کتابوں یا دیگر معاون آلات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

معذوری والے طلبہ کی شناخت اور جائزے کے دو بنیادی مقاصد یہ ہیں: یہ معلوم کرنا کہ آیا وہ خصوصی تعلیم کی خدمات کے اہل ہیں یا نہیں، اور اگر وہ اہل ہیں تو یہ متعین کرنا کہ وہ خدمات کیا ہوں گی۔ خصوصی تعلیم کی خدمات کے اہل ہونے کے لیے دو نتائج درکار ہیں: پہلا، طالب علم کو وفاقی قانون "معذور افراد کی تعلیم کا قانون" (IDEA) میں تسلیم شدہ تیرہ معذوریوں میں سے کم از کم ایک کے معیار پر پورا اترنا چاہیے، اور دوسرا، طالب علم کو مناسب تعلیم حاصل کرنے کے لیے خصوصی تعلیم اور/یا متعلقہ خدمات کی ضرورت ہونی چاہیے۔ یہ درست ہے کہ بعض طلبہ خصوصی تعلیم اور/یا متعلقہ خدمات کے اہل ہوتے ہیں لیکن انہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ دیگر طلبہ کو ان خدمات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ وفاقی یا ریاستی درجہ بندی کے معیار کے مطابق اہل نہیں ہوتے۔ اگر معذوری کی تشخیص اور خصوصی تعلیم کی ضرورت کی تصدیق ہو جائے تو طالب علم کو تعلیمی کارکردگی بہتر بنانے اور موقع بڑھانے کے لیے بنائے گئے انفرادی پروگرام کے اہم حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ حقوق قانونی تقاضوں کی کئی سطحوں کے ذریعے قائم ہوتے ہیں جو وفاقی اور ریاستی قوانین، وفاقی ضوابط، ریاستی قوانین، اور ریاستی اور وفاقی عدالتی مقدمات پر مبنی ہیں۔

چھوٹے معذور بچوں کے خاندان اپنے بچوں کی ابتدائی نشوونما میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں مدد، سمجھ بوجھ اور مفید معلومات حاصل ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں (Dash, 2006)۔ یہ معلومات پیدائش سے یا جیسے ہی معذوری ظاہر ہو، دستیاب ہونی چاہیں۔ درکار مدد پیشہ ورانہ اور ذاتی دونوں طرح کی ہے۔ بچوں کی صحت اور تعلیمی ضروریات خاص طور پر زندگی کے ابتدائی نشوونما میں مرحلے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ اس لیے معذور افراد کی مدد کرنے والی تنظیموں اور دیگر تربیتی مراکز کی معاونت کے لیے ابتدائی مداخلت (Early Intervention) کا پروگرام بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بچے ابتدائی مداخلت کے پروگرام میں شمولیت کے اہل تب ہوتے ہیں جب وہ یا تو ریاست کی خودکار اہل شرائط کی فہرست میں ہوں یا کسی ماہر کے جائزے کے بعد۔ زیادہ تر دائرہ اختیار میں، کیونکہ یہ جینیاتی حالت ہوتی ہے، اس لیے یہ خودکار طور پر بچے کو خدمات کا اہل بنا دیتی ہے۔ پروگرام بچے کی خوبیوں کی مدد اور بچے کی کمزوریوں کو بہتر بنانے کے لیے علاج فراہم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں خدمات آپ کے گھر پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ دیگر علاقوں میں مرکز جانا ضروری ہو سکتا ہے۔ ایک جامع ابتدائی مداخلت پروگرام نشوونما کے پانچ شعبوں کو خطاب کرتا ہے، جس میں ہر بچے کی مخصوص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مخصوص خدمات تیار کی جاتی ہیں: علمی نشوونما: بچہ کیسے سوچتا/سیکھتا ہے؛ جسمانی نشوونما، بشمول بینائی اور

سماعت: عام طور پر جسمانی علاج شامل ہوتا ہے؛ زبان، گفتگو اور مواصلات؛ سماجی جذباتی نشوونما؛ اور مطابقتی / خود مدد مہارتوں کی نشوونما (UNESCO, 2009)۔ بچپن کے ابتدائی سال مہارتوں یا قابلیتوں میں سرمایہ کاری کا ایک اہم موقع پیش کرتے ہیں جو بچوں کو جوانی میں بہبود کی راہ پر ڈال سکتی ہے۔ گزشتہ دہائی میں بہت سی حالیہ مطالعات طویل مدتی تعلیمی اور معاشی کامیابی کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی اور سماجی مہارتوں میں ابتدائی انسانی سرمایہ کاری کی اہمیت پر مرکوز رہی ہیں (Reynolds, Rolnick and Temple, 2014)۔ خصوصی تعلیمی ضروریات والے بچوں کی ابتدائی شناخت اور مداخلت بالکل کلیدی ہے: مسئلے کی جتنی جلدی شناخت ہوگی، مداخلت کے نتائج اتنے ہی بہتر ہوں گے۔ چونکہ سیکھنا ایک مجموعی عمل ہے، اس لیے ابتدائی دور میں پائی جانے والی مشکلات اگر نظر انداز کر دی جائیں تو بچے کی باقی زندگی پر زنجیر وار اثر ڈال سکتی ہیں۔ جیسا کہ Reynolds, Rolnick and Temple (2014) نے مقرر کیا ہے، ابتدائی شناخت اور مداخلت عام طور پر جذباتی، ذہنی، طرز عمل اور ذہنی صحت کے خدشات کو ان کے ظاہر ہونے کی ابتدائی عمر میں تلاش کرنے سے متعلق ہے۔ یہ مسائل بچپن کے ابتدائی دور میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور اگر علاج نہ کیا جائے تو بتدریج بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ لہذا، مذکورہ مسائل کی جلد شناخت بچوں کو سکول کے اندر اور باہر کامیاب مستقبل کے تجربے کے لیے درکار مدد حاصل کرنے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ ان ابتدائی علامات کو جاننا جو چھوٹے بچوں کو سیکھنے کی معذوریوں کے خطرے میں ڈالتی ہیں اور معمول کی نشوونما کی سنگ میلوں کو سمجھنا ابتدائی تشخیص اور مداخلت میں مدد دیتا ہے۔ آج کی تاریخ تک، ابتدائی مداخلت کو ان بچوں میں طویل مدتی نتائج کو متاثر کرنے والا سب سے اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ اطفال کے ڈاکٹروں اور والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور دیگر معلمین بھی ابتدائی شناخت میں کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں ضرور کرنا چاہیے۔

جائزہ اور تقرری کے پیشہ ور افراد، جو طلبہ کے جائزے کے بارے میں مستقل بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں، انہیں ابتدائی بچپن کے جائزے کے میدان میں چلنا مشکل لگ سکتا ہے (Yell, 2006)۔ یہ کافی نہیں کہ صرف پرانی جماعتوں میں استعمال ہونے والے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ابتدائی مواد کا جائزہ لیا جائے، یا ان اوزاروں اور مقاصد کے بارے میں فیصلے کیے جائیں جو پرانے طلبہ کو ذہن میں رکھ کر کیے گئے تھے اور انہیں چھوٹے بچوں تک بڑھا دیا جائے۔ اس کے بجائے، ابتدائی بچپن کے جائزے کے لیے پیشہ ورانہ معیارات اور رہنما اصولوں کا آغاز اس اہم حقیقت پر توجہ سے ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچے مسلسل اور تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، تعلیمی طور پر بھی اور دیگر شعبوں کی وسیع رینج میں بھی۔ جو سیاق ابتدائی سیکھنے والوں کے لیے جائزے کے فیصلوں کو مطلع کرتا ہے وہ پرانے طلبہ کے سیاق سے کیفیتی طور پر مختلف ہے۔ ملک بھر میں؛ سکول ڈسٹرکٹس معیاری پیمائشوں، بنائے گئے گروہی انتظامی پیمائشوں، اور کھلے اختتام والے ذہنی طور پر اسکور شدہ ٹیسٹوں میں سے انتخاب کر رہے ہیں تاکہ سکول یا استاد کی جواب دہی اور طالب علم کی تقرری کے بارے میں فیصلے کیے جا سکیں۔ یہ ٹیسٹ جواب دہی کے نظام کا حصہ ہیں جو ہر ریاست میں

مختلف طریقے سے بنائے گئے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ طلبہ کی سیکھنے کا عمل وقوع پذیر ہوا ہے، جس سے گھانا بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ بہت سے معاملات میں، ٹیسٹ کے نتائج اور ان کے ساتھ منسلک نتائج نہ تو والدین اور نہ ہی پالیسی سازوں کو واضح طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ اکثر جواب دہی کا نظام بنانے کی کوشش میں، بچے کی نشوونمائی سطح کھوئی ہوئی لگتی ہے۔ جائزے کے نظام کس لیے استعمال ہوتے ہیں اور اچھی طرح بنائے گئے جائزے کے نظام کو کس چیز پر غور کرنا چاہیے؟ جائزے کے نظام میں مختلف اقسام یا مقاصد کے لیے مختلف آلات شامل ہونے چاہیں؛ جائزے کے بنیادی مقصد کو واضح کرنا، یہ متعین کرنا کہ کیا پیمائش کی جائے، ڈیٹا جمع کرنے کے طریقہ کار قائم کرنا، اور ڈیٹا کے ذرائع کا انتخاب (بچے کا کام، معیاری ٹیسٹ، استاد کی رپورٹ، اور والدین کی رپورٹ) سب جائزے کے عمل کے اجزاء ہیں۔ تاہم، نقصان دہ یا مشکوک جائزے پر مبنی فیصلوں سے تحفظ کے لیے حفاظتی تدابیر ہونی چاہیں، جس میں نتائج کے استعمال کو والدین کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ (Robbins (2011 کے مطابق، انفرادی بچوں کا جائزہ فی الحال استعمال ہوتا ہے:

- بامعنی نشوونمائی کامیابیوں پر پیش رفت کا تعین کرنے کے لیے
- تقرری یا ترقی کے لیے
- خصوصی ضروریات، سیکھنے اور تدریسی مسائل کا پتہ لگانے کے لیے
- نصاب اور تدریسی فیصلوں میں مدد کے لیے
- بچے کو اپنی پیش رفت کا جائزہ لینے میں مدد کے لیے
- سیکھنے کو بڑھانے کے لیے
- پروگراموں کی تشخیص کے لیے
- رجحانات کی نگرانی کے لیے، اور
- "ہائی اسٹیکس" جواب دہی کے لیے

جائزوں سے بچوں کو تعلیمی پروگراموں کے معیار کو بہتر بنا کر یا بچوں کو براہ راست خدمات فراہم کر کے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اسے مخصوص مقصد سے جڑا ہونا چاہیے اور اس مقصد کے لیے معتبر، منصفانہ اور قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ جائزے کی پالیسیاں بناتے وقت، پالیسی سازوں کو غور کرنا چاہیے کہ بچوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ اعتمادیت اور صداقت بڑھتی ہے، اور ڈیٹا جمع کرنے کا طریقہ اور مواد ڈیٹا جمع کرنے کے کسی بھی منتخب طریقے کے ذریعے عمر کے مطابق ہونا چاہیے (پری سکولر کے لیے موزوں)۔ جائزے کے نتائج کے مناسب طریقوں کا تعین کرتے وقت اور ان کے معنی کی تشریح میں زبان کی نشوونما کے ساتھ ساتھ خصوصی سیکھنے کی ضروریات پر غور کرنا انتہائی اہم ہے۔ بچے کی سیکھنے کی ضروریات کی واضح تصویر پیش کرنے کے لیے متعدد

ذرائع سے شواہد کی کلید ہے۔ اس کا مطلب ہے بچے کے کام کے پورٹ فولیو کے ساتھ والدین اور اساتذہ کی رپورٹوں سے معلومات جمع کرنا (Banta, Jones & Black, 2009)۔ ان جائزوں کو پھر بھی غیر رسمی طریقوں کے ساتھ متوازن رکھنا چاہیے جیسے براہ راست مشاہدات جن میں کام اور ڈرائنگ کے نمونے دیکھنا، بچے کے بارے میں دیگر بالغوں سے پوچھنا، اور بچے سے زبانی یا تحریری طور پر سوالات پوچھنا شامل ہے جو انتہائی اہم ہے۔

9.2 علیحدگی بمقابلہ انضمام بمقابلہ شمولیتی تعلیم

علیحدگی (Segregation)

معذور افراد کا قانون (IDEA) اس بات کو شامل کرتا ہے کہ معذوری والے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ ممکنہ سطح پر تعلیم دی جائے جو ان طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے اپنائی گئی ہے جنہیں کوئی معذوری نہیں۔ تاہم، ہمارے حلقے کے اندر طلبہ کی ایک قابل ذکر تعداد علیحدہ سکولوں کی کلاسوں میں الگ تھلگ رہتی ہے، جہاں عمومی تعلیمی کلاس روم کے ساتھ ساتھ سکولی سرگرمیوں میں تعلیمی اور سماجی پہلوؤں کے لحاظ سے اپنی شرکت ظاہر کرنے کے بہت محدود یا تقریباً کوئی موقع پیش نہیں کیے جاتے۔

وہ وقت تھا جب خصوصی ضرورتوں والے بچوں کو سکولی سرگرمیوں میں مکمل طور پر حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی جیسا کہ دیگر عام بچے کرتے تھے۔ ان خصوصی ضرورتوں والے بچوں کو ان کی نسل، رنگ، جنس اور معذوری کی بنیاد پر الگ کیا جا رہا تھا۔ ان کے پاس تعلیمی یا سماجی شرکت کے ایسے کام انجام دینے کے بہت کم مواقع تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بچے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ انہیں خاندانوں اور معاشرے پر بوجھ سمجھتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ خیالات بدل گئے اور خصوصی ضرورتوں والے بچے معاشرے کے فعال رکن بن گئے اور انہوں نے ہر کام میں اپنی قابلیت ثابت کی، چاہے وہ تعلیمی ہو یا سماجی۔

آج کل تدریس کا یہ طریقہ ناپسند کیا جاتا ہے اور انصاف کے خلاف اور امتیازی سلوک سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں خصوصی بچوں کو خصوصی سکولوں کے بجائے خصوصی کلاس یا وسائل والے کمرے (resource room) میں پڑھایا جا رہا ہے۔ (Meyer (1988 کے مطابق صرف 10 فیصد طلبہ خصوصی سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ باقی خصوصی ضرورتوں والے بچے خصوصی کلاس یا وسائل والے کمرے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

یہ سوال اٹھتا ہے کہ نئی مطابقتوں کے باوجود وہ بچے کون ہیں جو صرف خصوصی تعلیمی نظام میں سیکھنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کی وجہ کیا ہے؟ (Laberman (1992 وضاحت کرتا ہے کہ یہ وہ خصوصی طلبہ ہیں جو اپنے لیے ایک مخصوص پروگرام چاہتے ہیں جو عام سکولی نظام سے مختلف ہو۔

والدین خصوصی سکول کیوں چنتے ہیں؟

انضمام کے رجحان کے باوجود بھی بہت سے والدین اپنے خصوصی بچوں کے لیے الگ سکول چاہتے ہیں۔ انضمام کا تصور ترقی پذیر ممالک میں ابھی تک جڑ نہیں پکڑ سکا، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی۔ پاکستان میں زیادہ تر والدین انتخاب کرتے ہیں اور اپنے خصوصی بچوں کو خصوصی سکولوں میں بھیجنا بہتر محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں عام تعلیمی نظام میں بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ خصوصی سکولوں یا خصوصی تعلیمی اداروں کے حق میں کچھ وجوہات مندرجہ ذیل ہیں:

• مطابقتی سہولتیں / خدمات

• کم لاگت

• معماری ماحول

• نصاب

• انفرادی تعلیمی پروگرام

• استاد اور طلبہ کے درمیان تناسب

• سماجی وابستگی

خصوصی سکولوں کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

• مخصوص زمرے کے مطابق

• مصنوعی ماحول

• عام لوگوں سے علیحدگی

• محدود نصاب

• معمولی معذوری والے طلبہ کے لیے نقصان

انضمام (Integration)

مربوط تعلیم کا مطلب ہے خصوصی یا غیر معمولی بچوں کو عمومی تعلیم فراہم کرنے والے تعلیمی ادارے میں لے جانا تاکہ وہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ پڑھیں لیکن ان کے پاس کوئی اضافی اوزار، آلات، ساز و سامان اور تدریسی عملہ نہ ہو۔ مربوط تعلیم میں معذوری کا طبی ماڈل اپنایا جاتا ہے جو بچے کو ایک مسئلہ کے طور پر دیکھتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ بچے کو بدلنا چاہیے یا اس کی بحالی کی جائے تاکہ وہ نظام کے لیے موزوں بن سکے۔

ایک رپورٹ تسمانیہ (1983) میں شائع ہوئی جس میں مقامی سکولوں میں تمام طلبہ کے تعلیم کے حق کو قبول کیا گیا لیکن ساتھ ہی خصوصی سکولوں کا وجود بھی لازمی سمجھا گیا ان لوگوں کے لیے جو عام سکولوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگرچہ ہر خصوصی بچے کا قانونی حق ہے کہ وہ عام سکول میں تعلیم حاصل کرے لیکن اضافی اقدامات کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ سکول انتظامیہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ خصوصی بچوں کی ضروریات کے مطابق ایسی سہولتیں فراہم کرے اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے وسائل فراہم کرے۔

معذوری والا بچہ کلاس روم میں اس طرح ضم کیا جاتا ہے کہ وہ اسی مواد کے ساتھ کام کرے (اگرچہ ضروری نہیں کہ مہارت کی اسی سطح سیکھنے کی توقع ہو)۔ انضمام کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں:

• جسمانی انضمام

• سماجی انضمام

• تدریسی انضمام

ابتدائی طور پر انضمام خصوصی ضرورتوں والے بچوں کو عام کلاس روم میں شامل کرنے کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا لیکن ان دیگر مواد کے بغیر جو خصوصی بچوں کے لیے درکار تھا۔ ان تمام خصوصی ضرورتوں والے بچوں سے کامیاب نتائج حاصل کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ ان کی ضروریات پوری نہیں کی گئیں۔ بہر حال انضمام کی تین اقسام تھیں۔ سب سے پہلے وہ عام بچوں کے ساتھ جسمانی طور پر ان کی نسل، رنگ، جنس اور معذوری کے ساتھ ضم کیے گئے۔ دوسرے وہ معاشرے میں سماجی طور پر ضم کیے گئے۔ انہیں پارٹیوں اور مختلف تقریبات جیسے تہواروں اور میلوں میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ والدین اور رشتہ دار اپنے بچوں کو بغیر کسی امتیاز کے معاشرے میں لے جاتے تھے۔ تیسرے وہ سکولوں میں تدریسی طور پر ضم کیے گئے۔ خصوصی بچوں کو مختلف سطحوں پر داخلے دیے گئے اور وہ کلاسوں کا حصہ تھے اور انہیں کلاس میں مکمل طور پر کارکردگی دکھانے کی اجازت تھی۔

شمولیتی تعلیم (Inclusive Education)

شمولیتی تعلیم ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر فرد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے عمل میں اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ساتھ ادارتی برادری کے دیگر اراکین کی حمایت حاصل کرے۔

شمولیتی تعلیم کو ایک ایسے سیکھنے کے ماحول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو تمام طلبہ کی ذاتی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ نشوونما کو فروغ دیتا ہے قطع نظر جنس، عقیدے، مذہب، نسل، قومیت، ثقافت، طبقے، معذوری، سیکھنے کے انداز اور زبان کے۔

شمولیتی تعلیم ہر فرد کو عزت اور اعتماد کے جذبات پیدا کرنے کی اجازت دیتی ہے اور فرد اپنی صلاحیتوں کو مساوی مواقع اور تعلیم کے حقوق کے ساتھ اپنی معذوری، نسل، رنگ، مذہب، سماجی، ثقافتی، نسلی یا معاشی اختلافات سے قطع نظر پیدا کرنے کے لیے محفوظ ہے۔ اس کا مقصد صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ فراہم کرنا اور مکمل صلاحیت کو خطاب کرنا ہے۔

شمولیتی تعلیم کے بنیادی عناصر

1. مطابقت (Adaptation)

سکول کے نصاب، جسمانی اور سماجی ماحول میں۔

2. مشاورت (Consultation)

سکول کے انتظامی اور تدریسی عملے، والدین، عمومی تعلیم کے استاد، خصوصی تعلیم کے استاد اور وسائل کے استاد کے ساتھ۔

3. تعاون (Collaboration)

سکول انتظامیہ اور انتظام، والدین اور پیشہ ور افراد۔

سرگرمی

اپنے علاقے کا دورہ کریں اور علیحدگی، انضمام اور شمولیتی تعلیم کے نظام والے سکول تلاش کریں۔ ایسے اداروں کی فہرست بنائیں اور ان اداروں کا جسمانی طور پر دورہ کرنے کے بعد ہر قسم پر نوٹ لکھیں۔

9.3 خصوصی تعلیم بمقابلہ عام تعلیم

خصوصی تعلیم کا بنیادی مقصد ان خصوصی بچوں کو فراہم کرنا ہے جنہیں معذوری ہو سکتی ہے جو انہیں روایتی تعلیمی طریقوں سے مکمل فوائد حاصل کرنے سے روک سکتی ہے۔ یہ انہیں خصوصی تدریس اور مداخلت پیش کرتی ہے جو انہیں اپنی تعلیم کے عمل سے مستفید ہونے کے قابل بنانے کے لیے درکار ہے۔

عام تعلیم کی اصطلاح اکثر ان بچوں کے تعلیمی تجربے کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو عام طور پر ترقی کر رہے ہیں۔ اس نصاب کے لیے وقف مواد معیارات کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے؛ "Common Core State Standards" ان میں سے ایک ہے۔

عام اور خصوصی تعلیم کے درمیان فرق

کچھ طلبہ ایسے پائے جاتے ہیں جنہیں ان لوگوں کے مقابلے میں غیر معمولی خصوصی توجہ کے ساتھ برتاؤ کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں عام قرار دیا جاتا ہے۔ عام طور پر انہیں کم ذہین یا حتیٰ کہ غیر معمولی طلبہ کہا جاتا ہے۔

بعض لوگوں کا یہ رویہ غیر مہذب اور سخت ہے۔ ایسے بچوں کو خصوصی طلبہ کہنا کہیں بہتر ہے۔ یہ خصوصی طلبہ ظاہری طور پر عام بچوں جیسے نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان کی خصوصی ضروریات ہوتی ہیں۔ خصوصی بچوں کو سیکھنے میں مسائل یا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں یا انہیں مواصلات کی سرگرمی میں کارکردگی دکھانا مشکل لگ سکتا ہے۔ بعض خصوصی طلبہ میں طرز عمل یا جذبات کی خرابی ہو سکتی ہے جبکہ دیگر کو جسمانی معذوری کا سامنا ہو سکتا ہے جو انہیں عام مطالعے والوں کی طرح سیکھنے سے روکتی ہے۔ ان خصوصی ضروریات کی وجہ سے، تعلیم کی ایک مخصوص قسم بنانا ضروری ہے جو اس قسم کے افراد کے لیے موزوں ہو۔ خصوصی تعلیم۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ خصوصی تعلیم عام تعلیم سے کیسے مختلف ہے؟

خصوصی تعلیم عام تعلیم سے کافی مختلف رویہ استعمال کرتی ہے، اگرچہ کچھ شعبے ایک جیسے ہیں۔ عام تعلیم میں تعلیمی حکام کے مقرر کردہ معیاری نصاب کو معیاری تدریسی طریقوں سے پیش کرنا شامل ہے۔ عام تعلیم میں عام کلاس روم کا ماحول شامل ہوتا ہے، جس میں اساتذہ مجموعی طور پر کلاس کی ضروریات کو خطاب کرتے ہیں۔ عام تعلیم کے اساتذہ طلبہ کے درمیان اختلافات سے قطع نظر طریقہ کار اور تدریسی طریقے نافذ کرتے ہیں۔

خصوصی تعلیم ظاہر ہے عام تعلیم کے برعکس ہے۔ خصوصی تعلیم میں ایسا خصوصی نصاب استعمال ہوتا ہے جو کسی خاص خصوصی قسم کے طالب علم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی خصوصی طالب علم کی خدمت کے لیے استعمال ہونے والے طریقہ کار اور تدریسی طریقے ان سے مختلف ہیں جو کسی دوسرے طالب علم پر نافذ کیے جاتے ہیں۔ خصوصی تعلیم میں طلبہ کی انفرادی ضروریات اور اختلافات کو خاص طور پر خطاب کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے، مختلف تدریسی طریقے، سیکھنے کے مواد اور معاون سازوسامان استعمال کیے جاتے ہیں۔ لہذا، ایک عام کلاس روم کا ماحول اور سیٹ اپ وہ نہیں ہے جو خصوصی تعلیم کا استاد استعمال کرتا ہے۔ انہیں مخصوص سیٹ اپ والے خصوصی وسائل کے کمرے کی مدد لینی پڑتی ہے۔

خصوصی تعلیم بمقابلہ عام تعلیم

خصوصی تعلیم کا بنیادی مقصد معذوری والے غیر معمولی بچوں کو فراہم کرنا ہے جو انہیں روایتی تعلیمی طریقوں سے مکمل طور پر مستفید ہونے سے روکتی ہے، خصوصی تدریس اور مداخلت کے ساتھ جو انہیں اپنی تعلیم سے مستفید ہونے کے قابل بنانے کے لیے کافی ہو۔

یہ ایک عام لیکن غلط تصور ہے کہ خصوصی تعلیم محض عام تعلیم کا بدلا ہوا نسخہ ہے۔ سوچنے کا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ درحقیقت، خصوصی تعلیم مختلف طریقوں سے تعلیم کے روایتی طریقے سے زیادہ مرکب اور مکمل ہے۔

خصوصی تعلیم اور عام تعلیم کے درمیان فرق مندرجہ ذیل ہیں:

- دونوں نظام کافی مختلف تدریسی طریقے استعمال کرتے ہیں، اور
- اضافی ماہرین (خصوصی اساتذہ، گفتگو کے معالج، پیشہ ورانہ معالج، جسمانی معالج، معاون، سماجی کارکنان وغیرہ) استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ خصوصی مہارتیں شناخت شدہ بچوں کی خصوصی ضروریات سے ملانی جاتی ہیں۔

خصوصی تعلیم میں شدید، انفرادی تدریسی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر خصوصی تعلیم کے طلبہ روایتی تعلیمی مواد کے شعبوں جیسے پڑھنا، لکھنا، ریاضی، سماجی علوم اور سائنس پر کام کریں گے۔ روایتی تعلیمی مواد کے علاوہ، بہت سے غیر معمولی طلبہ فعال نصاب (functional curriculum) سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ فعال نصاب طلبہ کو بنیادی روزمرہ زندگی کی مہارتیں سیکھنے میں مدد دینے کے لیے بنایا گیا ہے جو انہوں نے خود نہیں سیکھی ہیں جیسے بیت الخلا کا استعمال، کھانا، صاف ستھرائی، پیسوں کا استعمال، فارم پُر کرنا، بنیادی ضروریات کا اظہار، اور استاد یا باس کی دی گئی ہدایات پر عمل کرنا۔ فعال نصاب طلبہ کو آزادانہ زندگی کے لیے درکار بنیادی مہارتیں سکھاتا ہے۔

روایتی اور فعال نصاب بچہ بہ بچہ بہتر کیے جاتے ہیں، جیسا کہ خصوصی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے جو انفرادی بچوں کی مدد کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی سیکھنے میں رکاوٹوں کا انتظام کریں یا ان پر قابو پائیں۔ مداخلتی خدمات سکول میں وصول کی جاتی ہیں۔ ان خدمات میں جسمانی علاج (PT)، پیشہ ورانہ علاج (OT)، گفتگو اور زبان کا علاج، اور دیگر خدمات شامل ہیں۔ ان خدمات کے چھ مختلف مقاصد ہیں: (1) معمولی مسائل کو معذوری میں بدلنے سے روکنے میں مدد، (2) معذوری کے اثرات کو روکنا جو بدتر ہو سکتے ہیں، (3) معذوری سے متعلق مسائل حل کرنا، یا (4) طلبہ کو اپنی معذوری کے بارے میں سوچے بغیر بعض کام مکمل کرنے کے حوالے سے تعلیم دینا۔

مثال کے طور پر، نفسیاتی اور دیگر ماہرین بچے کو بدتمیزی کے طرز عمل کم کرنے، اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنا سیکھنے، اور اپنی توانائی سیکھنے پر مرکوز کرنے میں مدد کے لیے طرز عمل کا منصوبہ بنانے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ طرز عمل کا منصوبہ تحریری طور پر ایک منصوبہ ہے جو واضح کرتا ہے کہ طالب علم کو کون سے مثبت طرز عمل ظاہر کرنے چاہیں، جیسے بروقت کام مکمل کرنا، یا گروہی سرگرمیوں کے دوران دیگر طلبہ کے ساتھ کھلونے بانٹنا۔ طرز عمل کا منصوبہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سکول کا عملہ طلبہ کو ان موزوں طرز عمل کی نقل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے کون سے اوزار استعمال کر سکتا ہے۔ بعض سکول کا عملہ اور خاندان سمجھتے ہیں کہ طرز عمل کے منصوبے بنیادی طور پر طالب علم کے بدسلوکی کے لیے منصوبہ بند نتائج بنانے چاہیں، لیکن یہ سزا پر مبنی منصوبے اکثر وہ مکمل فوائد حاصل نہیں کرتے جو ایک زیادہ شمولیتی طرز عمل

کا منصوبہ پیش کر سکتا ہے۔ عام تعلیم اور خصوصی تعلیم دونوں کے بچے طرز عمل کے منصوبوں سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر، خصوصی ضروریات والے بچوں کو زیادہ تفصیلی منصوبے کی ضرورت ہوگی۔

مشق

س: خصوصی اور عام تعلیم کے درمیان بنیادی امتیاز کیا ہے؟

سرگرمی

خصوصی تعلیم کے ادارے اور عام تعلیم کے ادارے کا دورہ طے کریں، کم از کم ایک ایک۔ ان کے اساتذہ سے ملیں اور بڑے فرق لکھیں۔ آپ کو لازمی طور پر اداروں کے نام نمایاں کرنے چاہیں۔

9.4 خصوصی نصاب بمقابلہ عام نصاب

عام تعلیمی نصاب (جب کانگریس نے 1997 میں معذور افراد کی تعلیم کے قانون (IDEA) میں ترامیم منظور کیں، تو انہوں نے واضح کیا کہ معذوری والے بچے عام تعلیمی نصاب میں ترقی کریں گے۔ یہ تمام طلبہ بشمول معذوری والوں کے لیے سیکھنے کے نتائج کی حمایت کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔

بعض سکولوں کو بدلنا پڑا۔ وہ بڑی معذوری والے بچوں کو عام نصاب سے کیسے روشناس کرائیں؟ جواب یہ ہے کہ انہیں تدریسی تکنیکوں میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اور کچھ نئے انداز سے سوچنا ہوگا۔

ذہن میں رکھنے کے لیے بنیادی مقاصد: نصاب کی معقولیت کیا ہے اور طالب علم کے لیے نصاب کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ استاد کو بچے کے وژن کے حوالے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تعلیم کے نتائج ہمیشہ نصاب کی توجہ کا مرکز ہونے چاہیں۔

مثال کے طور پر، معذوری والا طالب علم ریاضی کی کلاس میں ضرب کے جدولوں کے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے ضرب کے حقائق کی معلومات برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اگر طالب علم اپنا ضرب یاد کرنے میں ناکام رہے تو کیا ہوگا؟ کیا اسے صرف تقسیم نہیں سکھائی جائے گی؟ وہ کیلکولیٹر استعمال کر کے تقسیم کا تصور سیکھنا جاری رکھ سکتا تھا۔ یہ مثال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اگر کیلکولیٹر استعمال کیا جائے تو طالب علم پھر بھی عام تعلیمی نصاب میں ترقی ظاہر کرتا ہے۔

ایک اور مثال میں، ہم ایک ایسے طالب علم کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے سابقہ اور لاحقے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس کی معذوری سیکھنے کے اس عمل میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے۔ اس صورت میں طالب علم کو اسم اور فعل سیکھنا جاری رکھنا چاہیے اور جملے کی ساخت بھی۔ جب طالب علم آخر کار پڑھنا شروع کرے گا تو استاد کو پچھلا کام دہرانا نہیں پڑے گا۔

طالب علم کی معذوری کی شدت سے قطع نظر، نصاب کو طالب علم کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ اس عمل کے نتیجے پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ اسے ترجیح دی جانی چاہیے کہ یہ نصاب طالب علم کی ضروریات کو پورا کرے تاکہ بالغوں کی دنیا میں اس کا وجود ہو۔

تمام طلبہ سیکھ سکتے ہیں! ہمیں طلبہ کی خوبیوں کو بڑھانا چاہیے۔ متنوع سیکھنے والے درحقیقت وسائل ہیں اور انہیں کلاس روم کے لیے خسارہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تمام طلبہ کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہمیں تخلیقی ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انہیں معاوضتی مہارتیں بھی سکھانی چاہیں اور تمام طلبہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موزوں جگہ اور مطابقت فراہم کرنی چاہیے۔ ان مقاصد کے لیے، سکولوں اور والدین کو چاہیے:

- اعلیٰ سطحوں پر حاصل کرنے کے عمل میں خصوصی طلبہ کو چیلنج کرنا
- معذوری والے طلبہ کی عام تعلیمی نصاب تک رسائی اور اس میں مشغولیت کو یقینی بنانا
- والدین کے کردار کو مضبوط کرنا اور سکولوں اور خاندانوں کے درمیان شراکت داری کی پرورش کرنا
- معذوری والے طلبہ کے سیکھنے میں جواب دہی کو یقینی بنانا ان کے ریاستی اور مقامی تشخیصی پروگراموں میں شمولیت کے ذریعے

عام نصاب تک رسائی، موثر تدریسی طریقوں، اور بلند معیارات کے ذریعے، بہت سے خصوصی تعلیم کے طلبہ اپنی تعلیمی کارکردگی بہتر کریں گے۔ یہ معذوری والے طلبہ کے بارے میں لوگوں کے نقطہ نظر کو بدل دے گا کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔" (McIntire-)

عام تعلیمی نصاب تک رسائی

- عام تعلیمی نصاب تک رسائی، وہی معیارات، وہی جانچ (مطابقت کے ساتھ یا بغیر) نئے قانون کی بنیاد ہے۔ یہ سب کے لیے سوچ میں تبدیلی ہے۔
- عام تعلیمی نصاب تک رسائی کو عام تعلیم تک رسائی کے ساتھ گڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں، معذوری والے بچوں کو عام تعلیمی ماحول تک رسائی حاصل تھی اور وہ کلاس روم میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن کلاس کی تدریس میں نہیں۔

• مزید برآں، عام نصاب، توقعات، اور مواد تک رسائی کسی بھی ماحول میں ہو سکتی ہے۔ مداخلتی ماہرین طلبہ کی ضروریات کے مطابق مختلف ماحولوں میں تدریس پیش کرتے ہیں، بشمول خصوصی کلاسیں۔

• سوچ میں تبدیلی یہ ہے کہ بنیاد عام تعلیمی نصاب ہے۔ جو ہر کوئی حاصل کرتا ہے۔ پھر، IEP اس خصوصی تدریس کو خطاب کرتا ہے جو بچے کو عام نصاب تک رسائی حاصل کرنے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے۔

• نظامی طور پر، قانون بلاشبہ ریاستوں اور سکول ڈسٹرکٹس کو معذوری والے بچوں کے لیے مرکب شعبوں میں جواب دہ ہونا درکار کرتا ہے۔ اعلیٰ معیارات، ریاستی سطح کی جانچ، اور گریجویٹیشن۔

سرگرمی

دونوں اقسام کے کم از کم دو ماہرین سے بات چیت کے بعد خصوصی تعلیم کے نصاب اور عام تعلیم کے نصاب کے درمیان بڑے فرقوں کی فہرست بنائیں۔

9.5 نصاب، تدریس اور تشخیص میں مطابقتیں

خصوصی ضرورتوں والے بچے ایک جیسی اقسام کے نہیں ہوتے۔ ان کی مختلف خصوصیات اور ذہانت کی سطحیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے عام تعلیمی نظام کے نصاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ جسمانی معذور، بصارت سے محروم اور سماعت سے محروم طلبہ وہی نصاب پڑھتے ہیں جو عام تعلیم کے طلبہ کے پاس ہے لیکن ان کے لیے نصاب میں مطابقت لازمی ہے۔ اس لیے بچوں کی معذوری کے مطابق بہت سی مطابقتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سائنس، انگریزی اور ریاضی میں منتخب موضوعات شامل یا خارج کیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر سماعت سے محروم اور جسمانی معذور بچوں کے نصاب میں مطابقتیں ہوتی ہیں جبکہ بصارت سے محروم طلبہ وہی نصاب پڑھتے ہیں اور انہیں اپنے امتحانات کے لیے لکھنے والے (writer) کی اجازت ہوتی ہے۔ مزید برآں ذہنی چیلنج والے طلبہ اپنی معذوری کی شدت کے مطابق IEP پر عمل کرتے ہیں۔

عام تعلیمی نصاب میں استعمال کی جانے والی مطابقتیں اور تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:

کام کا حجم۔ سیکھنے والے سے توقع کی جانے والی اشیاء کی تعداد کو مطابق بنائیں جو اسے علم حاصل کرنا ہے یا مکمل کرنا ہے

• ٹیسٹ جوابات کے لیے اسکین شیٹس کی مشق کو کم یا محدود کریں

• مقرر کردہ کاموں کے لیے اشیاء کی تعداد کم کریں

• نقل کرنے کی مقدار کم کریں

• مشکلات کی تعداد کم کریں

- کسی بھی مقرر وقت میں متعارف کرائے گئے تصورات اور توقعات کی تعداد کم کریں
 - ایک وقت میں طالب علم کو سکھائی جانے والی اصطلاحات کی تعداد کم کریں
 - زیادہ کام سے بچنے کے لیے دیگر اساتذہ کے ساتھ کاموں کو مربوط کریں
 - کاموں کا حجم کم کریں
 - گھر کے کام کے طور پر کام کم کریں، یا والدین کے ذریعے کاموں میں دباؤ سے بچنے کے لیے تبدیلی کی جانی چاہیے
 - طلبہ کو ہر باب سے دو سے تین تصورات / خیالات سیکھنے چاہیں
 - کسی بھی مقرر وقت میں دیے گئے تصورات / خیالات کی تعداد کو کم سے کم کریں
- وقت - سیکھنے، کام مکمل کرنے، یا جانچ کے لیے مختص اور اجازت شدہ وقت کو مطابق بنائیں**

- کام مکمل کرنے کے لیے انفرادی ٹائم لائن بنائیں
- سیکھنے والے کو کام گھر لے جانے کی اجازت دیں۔ کام مکمل کرنے کے لیے کلاس میں یا کلاس سے باہر اضافی وقت دیں
- اصل تدریس سے پہلے سبق کے عمومی خیال کے ساتھ کام پر اضافی وقت دیں
- ٹیسٹ کے لیے بار بار دہرائیں
- حتمی ٹیسٹ سے ایک یا دو دن پہلے پری ٹیسٹ دے کر تیاری کے لیے اضافی وقت دیں
- ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت دیں
- پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت دیں
- سیکھنے والے کو مختصر وقفے لینے دیں

مدد - مخصوص سیکھنے والے کے ساتھ ذاتی مدد کی مقدار بڑھائیں

- سبق کے دوران بار بار سمجھ کی جانچ کریں
- ہم جماعت دوست، استاد کے معاون، ہم جماعت ٹیوٹر، یا کراس ایج ٹیوٹر مقرر کریں
- ٹیسٹ اونچی آواز میں پڑھیں
- اجتماعی کہانی لکھنے یا خلاصہ ایک ساتھ لکھنے اور / یا ایک دوسرے کو سننے کے لیے گروہ استعمال کریں

- ایسا ہم جماعت ٹیوٹر مقرر کریں جس کی ریاضی کی مہارتیں تیز ہوں
- چھوٹے گروہوں میں تعاون پر مبنی کام فراہم کریں
- پروجیکٹس کے لیے، ٹیسٹ کے لیے پڑھنے کے لیے یا ایک دوسرے کے کام کی پروف ریڈنگ اور درستگی کے لیے ہم جماعت ٹیوٹر یا طلبہ کے جوڑے استعمال کریں
- طلبہ کو جوڑوں یا چھوٹے گروہوں میں ٹیسٹ دینے کی اجازت دیں
- طالب علم کو ہم جماعت یا بالغ کو ٹیسٹ کے جوابات بول کر لکھوانے کی اجازت دیں
- خود تشخیصی کانفرنسیں فراہم کریں
- پریزنٹیشن سے نوٹس نقل کریں تاکہ وہ طالب علم جو اچھی طرح لکھ یا سن نہیں سکتا، پڑھنے کے لیے نوٹس حاصل کر سکے
- ایک طالب علم کو لکھوائیں جبکہ لکھنے میں مشکلات والا طالب علم جوابات بول کر لکھوائے
- ہم جماعت کو طالب علم کے کام کی پروف ریڈنگ کروائیں تاکہ پیشگی تحریری سرگرمیوں میں مدد ملے
- والدین سے کہیں کہ گھر پر اپنے بچے کے لیے اضافی مشق فراہم کریں
- طالب علم کے لیے گھر کے کام کے مقاصد واضح کریں اور اس کے مطابق مطابقتیں کریں
- سیکھنے والوں کو کلاس میں گھر کا کام شروع کرنے دیں تاکہ معلوم ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے
- مطالعاتی پیکٹ تیار کریں تاکہ طالب علم گھر پر مدد حاصل کر سکے
- طلبہ کے درمیان مدد کی حوصلہ افزائی کریں (مثلاً، طلبہ کو سکھائیں کہ جب انہیں مدد کی ضرورت ہو تو "مجھ سے پہلے تین سے پوچھیں"، اپنے ہم جماعتوں سے پوچھیں کہ معذوری والے ان کے ہم جماعت کسی سرگرمی میں کس طرح مکمل طور پر حصہ لے سکتے ہیں)

مشکل - مہارت کی سطح، مسئلے کی قسم، یا سیکھنے والا کام کے قریب کیسے آسکتا ہے
اس کے اصولوں کو مطابق بنائیں

- ریاضی کے مسائل حل کرنے کے لیے کیلکولیٹر کے استعمال کی اجازت دیں
- خالی جگہوں والا خاکہ تیار کریں؛ طالب علم معلومات ملنے کے ساتھ خالی جگہیں پُر کرے
- ہفتہ وار ذخیرہ الفاظ، سبجے کے الفاظ، اسم کی اقسام وغیرہ کے لیے ورڈ بینک (3x5 فائل باکسز) قائم کریں - انہیں بعد میں دیگر کام جیسے تخلیقی تحریری کاموں کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- طلبہ کو جوابات تلاش کرنے میں مدد کے لیے صفحہ نمبر اور پیراگراف فراہم کریں

- لیکچر کے دوران حوالے کے لیے ہینڈ آؤٹس کو نمبر دیں
- الفاظ کو محدود کر کے اور مراحل اور صفحے کو نمبر دے کر تحریری ہدایات کو آسان بنائیں
- طلبہ کے لیے ہائی لائٹر فراہم کریں جو وہ سال بھر کلاس روم میں استعمال کریں
- طلبہ کو اہم معلومات کو ہائی لائٹ یا خط کشیدہ کرنے میں مدد کریں
- ٹیسٹوں کے لیے بار بار دہرائیں
- سیکھنے والوں کے لیے گھر پر دہرانے کے لیے کلیدی تصورات اور ذخیرۃ الفاظ کے ساتھ مطالعاتی رہنما پیشگی فراہم کریں
- جب A، B، C، D جوابات والا ٹیسٹ دیں تو بڑے حروف استعمال کریں اور طلبہ سے کہیں کہ b، d کے الٹے سے بچنے کے لیے بڑے حروف استعمال کریں
- ٹیسٹوں اور کوئز پر "مذکورہ بالا تمام" اور "مذکورہ بالا میں سے کوئی نہیں" کے انتخاب ختم کریں
- طلبہ کو علم ظاہر کرنے کے لیے ٹیسٹوں کے علاوہ یا ان کے ساتھ اختیارات کا مینیو فراہم کریں
- صحیح غلط سوالات میں دہرے منفی استعمال سے گریز کریں
- متبادل ٹیسٹ دیں
- شکل مختلف کریں (مثلاً، صحیح غلط، متعدد انتخاب، مختصر جوابات، مظاہرتی ٹیسٹ، ملاپ یا مضمون کے سوالات)
- طلبہ کو جانچ کے لیے انتخاب دیں
- طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ لکھنے کا وہ طریقہ چنیں جو انہیں سب سے آرام دہ لگے
- طلبہ سے ہدایات واپس دہرانے کو کہیں
- کام کی ہدایات کو آسان بنائیں
- سیکھنے والے کی ضروریات کے مطابق اصول بدلیں
- طلبہ کو پڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے اعلیٰ دلچسپی والی کم سطح کی کتابیں استعمال کریں
- ایسے پروجیکٹ مقرر کریں جو طلبہ کو تخلیقی ہونے دیں (شیڈو باکسز، کٹھ پتلیاں، ویڈیوز، ٹیپ پر خلاصے، رول پلے وغیرہ)
- طلبہ کو ٹیسٹ یا زیادہ مشکل پروجیکٹ جیسے تخلیقی تحریر کی جگہ اضافی کتابیں پڑھنے کی اجازت دیں
- طلبہ کو سرگرمیاں مختلف کرنے کے مواقع فراہم کریں بجائے اس کے کہ وہ پورا عرصہ پڑھیں

- سیکھنے والوں کو کام چننے دیں (مثلاً، طاق یا جفت سوالات)
- گھر کا کام کلاس میں پڑھائی گئی چیز سے متعلق بنائیں

سرگرمی

پاکستان میں خصوصی تعلیمی نظام میں کس قسم کی مطابقتیں استعمال ہو رہی ہیں؟ انہیں ہر معذوری کے مطابق الگ الگ درج کریں۔

9.6 انفرادی تعلیمی پروگرام

انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) ایک دستاویز ہے جو پبلک سکول کے ہر بچے کے لیے بنائی جاتی ہے جسے خصوصی تعلیم کی ضرورت ہو۔ ٹیم کی کوشش کے ذریعے، IEP بنایا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

ایک IEP ہے...

- ایک تحریری منصوبہ جو خصوصی تعلیمی پروگرام اور/یا خدمات کے بارے میں بتاتا ہے جو کسی خاص طالب علم کے لیے درکار ہیں، جو طالب علم کی خوبیوں اور ضروریات کے مکمل جائزے پر مبنی ہے۔ یعنی وہ خوبیاں اور ضروریات جو طالب علم کی سیکھنے اور سیکھا ہوا ظاہر کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں؛
- طالب علم کو اس کی سیکھنے کی توقعات حاصل کرنے میں مدد کے لیے درکار مخصوص رہائشوں (accommodations) کا ریکارڈ، طالب علم کی شناخت شدہ سیکھنے کی خوبیوں اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے؛
- ایک عملی دستاویز جو سیکھنے کی توقعات کی نشاندہی کرتی ہے جو کسی مخصوص مضمون یا کورس میں عمر کے مطابق جماعت کی سطح کی توقعات سے تبدیل شدہ ہیں، جیسا کہ وزارت تعلیم کے نصابی پالیسی دستاویزات میں بیان کیا گیا ہے؛
- ایک عملی دستاویز جو متبادل توقعات کی نشاندہی کرتی ہے، اگر درکار ہوں، ایسے پروگرام کے شعبوں میں جو اونٹاریو نصاب میں نمائندگی نہیں رکھتے؛ مخصوص علم اور مہارتوں کا ریکارڈ جن کا جائزہ لیا جائے گا اور طالب علم کی تبدیل شدہ اور/یا متبادل توقعات کی کامیابی کی رپورٹنگ کے مقصد کے لیے ان کی تشخیص کی جائے گی؛

- طالب علم، طالب علم کے والدین، اور ہر اس شخص کے لیے جو ابھی کا آلہ جس کی منصوبہ کے تحت ذمہ داریاں ہیں کہ وہ طالب علم کی مدد کرے مقرر کردہ مقاصد اور سیکھنے کی توقعات کو پورا کرنے میں جب طالب علم اوٹاریو نصاب سے گزرتا ہے؛
- ہر وہ چیز کی تفصیل جو طالب علم کو پڑھائی جانے گی؛
- عام کلاس روم کی تدریس میں استعمال ہونے والی تمام تدریسی حکمت عملیوں کی فہرست؛
- ایک دستاویز جو تمام سیکھنے کی توقعات کو ریکارڈ کرتی ہے، بشمول وہ جو عام جماعت کی سطح کے نصابی توقعات سے تبدیل شدہ نہیں ہیں؛
- روزانہ کا سبق منصوبہ۔

ایک IEP درکار ہوتا ہے جب ...

- سکول کا پرنسپل یہ متعین کرے کہ طالب علم کی کامیابی کا جائزہ تبدیل شدہ توقعات کی بنیاد پر لیا جائے گا؛ اور/یا
- طالب علم کو تدریسی یا تشخیصی مقاصد کے لیے باقاعدگی سے رہائشوں کی ضرورت ہو۔

IEP میں شامل کی جانے والی اہم معلومات

- وہ خوبیاں اور ضروریات جو طالب علم کی سیکھنے سے متعلق ہیں۔ اگر طالب علم کو رسمی طور پر غیر معمولی کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، تو IEP میں وہ خوبیاں اور ضروریات شامل ہونی چاہیں جو IPRC سے موصول فیصلے کے بیان میں شناخت کی گئی ہیں۔
- متعلقہ تشخیصی ڈیٹا جو غیر معمولیت کی شناخت کی حمایت کرتا ہے یا وہ وجوہات جو خصوصی تعلیمی پروگراموں اور خدمات کی ضرورت کو جنم دیتی ہیں
- طالب علم کو سکول آنے کے قابل بنانے کے لیے درکار کوئی بھی خصوصی صحت کی معاون خدمات
- تمام مضامین / کورسز کی فہرست جن میں طالب علم کو تبدیل شدہ توقعات اور/یا رہائشوں کی ضرورت ہے، اور تمام متبادل پروگرام
- ان رہائشوں کی فہرست جو طالب علم کو سیکھنے اور سیکھا ہوا ظاہر کرنے میں مدد کے لیے درکار ہیں
- ہر تبدیل شدہ مضمون یا کورس اور/یا متبادل پروگرام کے شعبے میں طالب علم کی موجودہ کامیابی کی سطح
- ہر پورٹنگ مدت کے لیے سالانہ پروگرام کے مقاصد اور سیکھنے کی توقعات، ہر مضمون یا کورس میں جن میں تبدیل شدہ توقعات درکار ہیں اور/یا ہر متبادل پروگرام کے شعبے میں

• تشخیص کے طریقے جو طالب علم کی تبدیل شدہ یا متبادل توقعات کی کامیابی کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کیے جائیں گے

• والدین کو طالب علم کی پیش رفت کی رپورٹنگ کے طریقے کی واضح نشاندہی (یعنی صوبائی رپورٹ کارڈ پر اور/یا متبادل رپورٹ میں) اور وہ تاریخیں جن پر رپورٹس جاری کی جائیں گی

• IEP کی تیاری اور اس کے بعد کے جائزوں کے دوران والدین اور طالب علم (اگر طالب علم 16 سال یا اس سے بڑا ہے) کے ساتھ مشاورت کی دستاویزات، اور سکول کے عملے کی طرف سے سیکھنے کی توقعات کے جائزے اور اپ ڈیٹ کا ریکارڈ

• منتقلی کا منصوبہ (اگر درکار ہو)

9.7 سرگرمی

کسی بھی معذوری کے خصوصی تعلیم کے استاد سے ملیں۔ اس کے ساتھ بات چیت کریں اور خصوصی ضرورتوں والے بچے کے لیے کم از کم ایک IEP بنائیں اور پھر اس کے نتائج کا مشاہدہ کریں۔ کیا یہ بچے کے لیے مددگار تھا؟

9.8 خود احتسابی سوالات

1. علیحدگی کو اپنے الفاظ میں واضح کریں۔
2. انضمام اور اس کی اقسام کی مختصر وضاحت کریں۔
3. شمولیتی تعلیم پر بحث کریں اور شمولیتی تعلیم کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟
4. خصوصی تعلیم کے نصاب اور عام تعلیم کے نصاب کے درمیان امتیاز کریں۔
5. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خصوصی بچوں کے لیے نصاب کی مطابقت ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات کے ساتھ حمایت کریں۔
6. خصوصی ضرورتوں والے بچوں کے لیے کی گئی کچھ مطابقتیں لکھیں۔
7. IEP کیا ہے اور ہم اسے کیوں بناتے ہیں؟
8. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ IEP خصوصی ضرورتوں والے بچوں کی تدریس کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے؟

9.9 حوالہ جات

- Berkson, Gershon. (1993). Children with Handicaps: A Review of Behavioral Research, New Jersey Hove and London, Lawrence Erlbaum Associates
- Butler, D. L. & Sllborm, M. (2013). Barriers to adopting technology for teaching and learning Educause Quarterly. November 2002. 21-28
- Haring, Norris G. and McCormick Linda, (1986). Exceptional Children in Youth, Charles E. Merrill Publishing Company, Columbus
- :HORNE, MARCIA D. (1985) Attitudes Toward Handicapped Students Professional, Peer and Parent Reactions New Jersey London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Kirk, Samuel A, (1972) Educating Exceptional Children, Houghton Mifflin Company, Boston
- Paul M.A. Baker & Nathan W.M. (2008). Wireless Technologies and Accessibility for People with Disabilities: Findings form a Policy Research Instrument, Assistive Technology: The Official Journal of RESNA, 2:3 .DOI: 10.1080/713662196, 149-156
- ,.Thomas David, (1982). The Experience of Handicap, Methuen & Co. Ltd .London
- ,World Health Organization, Disability Prevention and Rehabilitation .World Health Organization, Geneva
- Yousafzai Fazal-e-Rabbi, A Study of the Education of Educationally Subnormal Children in UK and Its Implementation for Pakistan
- Zais, Mick. (2011). Standards for Evaluation and Eligibility Determination Office of Exceptional Children: South Carolina, State Department. (SEED) .of Education

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Introduction to Special Education" (کورس کوڈ 8631) سے تیار کیا گیا ہے۔

اردو ترجمہ: طاہر ڈوگر (Dogar Books)

یہ کتاب Dogar Books سے مفت ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے۔ مزید مفت اردو کتب کے لیے:

dogarshaib267.github.io/dogar-books — واٹس ایپ: 03038962177